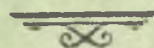


И. В. Стрельчук

КЛИНИКА
и
ЛЕЧЕНИЕ
НАРКОМАНИЙ



Медгиз - 1956

Профессор И. В. СТРЕЛЬЧУК

КЛИНИКА И ЛЕЧЕНИЕ НАРКОМАНИЙ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МЕДГИЗ — 1956 — МОСКВА

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

Третье издание «Клиники и лечения наркоманий» значительно переработано и дополнено. В него внесено все то ценное, новое, что достигнуто за последние годы как советскими, так и зарубежными учеными в области изучения клиники, патофизиологии высшей нервной деятельности и терапии наркоманий.

Состоявшаяся в 1950 г. объединенная научная сессия Академии наук СССР и Академии медицинских наук СССР, посвященная проблемам физиологического учения акад. И. П. Павлова, а затем в 1951 г. объединенное заседание расширенного Президиума АМН СССР и пленума правления Всесоюзного общества невропатологов и психиатров поставили перед советскими психиатрами ряд важнейших задач, направленных на широкое развертывание исследований, развивающих учение И. П. Павлова, в частности, на экспериментальное изучение важнейших проблем психиатрии и разработку новых эффективных методов лечения.

Хотя эта важнейшая задача и учитывалась автором при переработке настоящей монографии, но впереди предстоит еще большая и длительная работа по перестройке наркологии на основах учения И. П. Павлова.

В своей работе мы уделили особое внимание терапии наркоманий, которая в настоящее время не исходит из голого эмпиризма, а опирается на учение о нервизме. В своей работе мы еще вынуждены пользоваться многочисленными психологическими исследованиями, посвященными наркоманиям, ясно отдавая себе отчет, что эти данные носят чисто описательный характер и не вскрывают сущности нервных механизмов. Однако и эти данные могут быть правильно поняты в свете учения И. П. Павлова. И. П. Павлов резко критиковал субъективно-психологические понятия и ставил своей задачей «наложить психологический узор на физиологическую канву».

Постепенно, по мере накопления экспериментального фактического материала по изучению нейродинамики наркоманий, можно будет вскрыть нервные механизмы, лежащие в основе симптомов и синдромов различных наркоманий. Эта актуальная задача должна быть решена в течение ближайших лет, что даст возможность разработать еще более эффективную, патогенетически обоснованную терапию наркоманий.

1956 г.

Автор

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Первое издание «Клиники и терапии наркоманий», вышедшее в 1940 г., полностью разошлось в короткий срок. Второе издание существенно переработано и дополнено. Заново написаны разделы о течении и психопатологии рецидивов хронического алкоголизма, прогнозе и катамнезе, лечении хронического алкоголизма путем выработки эмоционально-отрицательной и рвотной реакции на алкоголь при помощи апоморфина, эметина и других рвотных средств, о хроническом алкогольном галлюцинозе, остром отравлении препаратами барбитуровой кислоты и др.

В данной работе приведено все то новое в клинике и лечении наркоманий, что, по нашему мнению, представляет интерес для врачей, проводящих лечение наркоманов.

1949 г.

Автор

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Предлагаемая вниманию читателя работа посвящена клинике и терапии наркоманий. В существующей отечественной медицинской литературе нет специального руководства по наркоманиям. Между тем в таком руководстве ощущается определенная потребность, так как с алкогольными заболеваниями и в меньшей мере с другими наркоманиями приходится иметь дело значительному кругу врачей. Клинику наркоманий далеко нельзя еще считать изученной. Это еще в большей степени касается терапии наркоманий, хотя в этой области накоплен

опыт, требующий соответствующего освещения и подытоживания.

В этой работе автор не претендует на разрешение всех поднятых вопросов, но стремится осветить их в соответствии с данными современной науки и достижениями советской медицины.

Работа в основном рассчитана на врачей, не имеющих специальной психиатрической подготовки, и ставит перед собой задачу ознакомить их с клиникой и особенно с методикой лечения наркоманов. В качестве материала для этой работы, наряду с имеющейся литературой, использован практический опыт Московской областной невро-психиатрической клиники и Московской лечебницы для острого алкоголизма.

Редакция:

Заслуженный деятель науки
проф. М. О. Гуревич,
проф. Е. К. Краснушкин,
доцент И. А. Бергер

1940 г.

Глава I

ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ

Острое отравление алкоголем наблюдается в легкой, средней и тяжелой степени. Особенно опасно тяжелое опьянение, от которого в дореволюционной России умирало ежегодно свыше шести тысяч человек. Степень отравления зависит от количества и качества принятого алкоголя, а также от индивидуальной динамической реакции на него организма, которая может изменяться в зависимости от возрастных, психогенных и физиогенных факторов. Индивидуальная чувствительность к алкоголю колеблется в широких пределах. Выносливость к алкоголю не всегда одинакова даже у одного и того же лица: в одних случаях большие дозы алкоголя переносятся сравнительно хорошо, в других — опьянение наступает от небольшого количества алкоголя.

Истожающие факторы понижают выносливость организма к алкоголю. Невыносливость к нему может наступить после тяжелых нервных и инфекционных заболеваний, у психически больных, после контузий и ранений головного мозга, у больных эпилепсией, у психопатов, истерических субъектов, у лиц, страдающих тяжелой формой хронического алкоголизма, и т. п. Нами экспериментально установлено, что одним из факторов, способствующих появлению непереносимости к алкоголю, является замедленное окисление алкоголя в крови, а также повышенная чувствительность к нему головного мозга, вызванная длительной интоксикацией спиртными напитками.

До сих пор нет достаточно четкого критерия для определения понятия опьянения. Опьяневшим следует считать лицо, принявшее алкоголь в таком количестве, которое вызывает комплекс кратковременных нарушений высшей нервной деятельности различной интенсивности, изменяющих нормальные реакции на окружающую внешнюю среду, вследствие чего возникает известная опасность как для самого опьяневшего, так и для окружающих.

В последнее время предпринимались попытки установить закономерность между концентрацией алкоголя в крови и степенью опьянения. Например, Флеминг (Fleming) выделял пять степеней опьянения:

1. Концентрация алкоголя меньше 100 мг⁰/о в крови — под-клиническая степень без психических нарушений.

2. 100—200 мг⁰/о — степень раздражения с потерей самоконтроля и ослаблением силы воли.

3. Приблизительно 300 мг⁰/о — степень странностей с потерей способности концентрации и ослаблением активности.

4. Приблизительно 400 мг⁰/о — состояние отупения с общей апатией, вялостью при наличии бледной окраски кожных покровов, сужения зрачков.

5. До 500 мг⁰/о — степень тяжелого опьянения, коматозное состояние.

Однако крайняя условность данного деления, грубая схематичность, недостаточно четкие критерии клинических проявлений разных степеней опьянения не соответствуют реальной действительности. Флеминг совершенно игнорирует типологические особенности, характер реагирования человека на алкоголь, возрастные и половые особенности и т. д., а поэтому его концепция хотя, и интересна, но требует значительных коррективов. В. В. Закусов считает, что при концентрации алкоголя в крови в 0,02—0,04⁰/о наблюдаются отчетливые признаки опьянения, при 0,05—0,1⁰/о — тяжелое опьянение, а концентрация свыше 0,2⁰/о опасна для жизни.

Изучая влияние различных доз алкоголя на здоровых людей и на лиц, страдающих алкоголизмом, мы не могли отметить постоянного соответствия между концентрацией алкоголя в крови и тяжестью психопатологической картины. Известный интерес как с медицинской, так и с судебно-медицинской точки зрения представляет вопрос, какое количество алкоголя может выпить за один день здоровый человек среднего веса.

Ньюмен (Neuman, 1949) полагал, что это количество составляет максимум 1,137 л 100° алкоголя. Однако эта гипотеза нуждается в проверке. Мы сами наблюдали больных, которые употребляли алкоголь в большом количестве—2—3 л 40° водки в сутки, хотя такие дозы могут выпиваться лишь в редких случаях и привычными к нему людьми, в организме которых постоянно поддерживается высокая концентрация алкоголя.

Процесс окисления алкоголя зависит от концентрации его в организме; естественно, что при высокой концентрации алкоголя на известный срок повышается обмен алкоголя. Поэтому при рассмотрении вопроса о максимально возможном потреблении алкоголя человеком следует принимать во внимание значительные индивидуальные различия в показателях обмена и окисления алкоголя.

При этом всегда следует помнить о том, что у лиц, дли-

тельное время злоупотреблявших спиртными напитками, окисление алкоголя вначале постепенно усиливается, а затем выносливость к нему понижается, и они пьянеют от сравнительно малых доз; так, например, если раньше они могли свободно в течение суток выпивать от 0,5 до 3 л 40° водки, то с течением времени выносливость к спиртным напиткам у них падала и они пьянели под влиянием 150—300 г 40° алкоголя. Особенно с большой осторожностью следует подходить к высказываниям Бирстекера (Beerstecher), который полагает, что максимальное количество 100° алкоголя, которое человек может выпить за один день, равно 2,274 л и даже больше. Мы считаем, что доза 100° алкоголя в 2,274 л (это составляет приблизительно 32 г алкоголя на 1 кг веса среднего человека) является безусловно смертельной. К своим выводам автор приходит, основываясь на отдельных наблюдениях, когда люди, злоупотреблявшие спиртными напитками и привычные к ним, могли выпить значительно больше, чем 1,137 л 100° алкоголя. Мы со своей стороны также наблюдали такие случаи, однако не считаем возможным усматривать в этом какую-либо закономерность, как это делает Бирстекер. Основываясь на своих экспериментальных данных, этот автор считает, что если токсическая доза 100° алкоголя для крыс равна 7,4 г на 1 кг веса, то для человека оно будет в 4 раза больше. Разумеется, с таким мнением согласиться нельзя, ибо у крыс выносливость к наркотикам весьма велика, например, они без всякого ущерба переносят 1 г барбитала на 1 кг веса, для человека же это количество превышает в 10 раз смертельную дозу. Что касается особенностей влияния алкоголя на нервную систему, то экспериментальными исследованиями, например, Крепелина, Ашаффенбурга доказано, что уже 30—50 г алкоголя оказывают вредное воздействие на психические функции: ассоциации замедляются и носят поверхностный характер, что приводит к снижению интеллектуальных способностей человека, длящемуся от нескольких часов до 1—2 дней. Возбудимость представлений после кратковременного, быстро проходящего минимального облегчения замедляется. При выполнении таких заданий, как счет, устный и письменный, или описание картинок с фиксацией внимания на ряде событий и т. п., дозы алкоголя в 20—50 г удлиняют время реакции, снижают темп работы и увеличивают количество ошибок.

Нередко испытуемые заявляют, что малые дозы алкоголя помогают им скорее выполнить работу, но это не соответствует действительности: число ошибок увеличивается, работа производится небрежно, невнимательно. Правда, в отдельных случаях после принятия небольших доз алкоголя вначале на очень короткий срок наблюдается некоторое улучшение работы, например, при стрельбе (Крепелин) или при устном счете. Это объясняется устранением торможения, чувства страха, неуве-

ренности, робости. Отмечено также, что при тяжелой физической работе, например, у землекопов, каменщиков, грузчиков, малые дозы алкоголя могут вызывать вначале повышение работоспособности, с последующим ее снижением.

Лишь автоматическая, легко выполняемая, механическая работа, требующая незначительного умственного напряжения и внимания, в связи с приемом небольших доз алкоголя нарушается мало или почти не нарушается. При выполнении более сложных заданий — таких, как нанизывание бус, расстановка булавок на доске, печатание на пишущей машинке, вдевание в иглолку нитки, — отрицательное влияние алкоголя сказывается сильнее. Уже после приема 20—50 г алкоголя работа производится хуже — с большим числом ошибок, медленнее и пр.

Чем тоньше, точнее и сложнее работа, тем меньшая доза алкоголя вызывает ее нарушение и тем больше она тормозится. Это относится также и к чисто умственному труду, особенно к творческой работе. Великий немецкий поэт Гете еще в 1870 г. писал в своем дневнике, что его творческая фантазия и работоспособность особенно повышались в те дни, когда он не пил вина. «Человечество могло бы достигнуть невероятных успехов, если бы оно было более трезвым», — заключает Гете.

При опьянении легко возникает субъективное чувство повышенного настроения, повышенного чувства собственного достоинства при ослаблении критики. Поэтому многие считают, что их работа выполняется быстрее и лучше после употребления алкоголя. Этим же объясняется и та высокая оценка, которой у некоторых людей пользуется алкоголь как стимулирующее и укрепляющее средство.

Вследствие упомянутых свойств алкоголя состояние легкого опьянения может приводить к авариям, браку продукции, несчастным случаям и т. п. Особенно опасно даже легкое опьянение у водителей транспорта, так как вследствие замедленной реакции на окружающую среду оно часто приводит к различным нарушениям, несчастным случаям и пр.

Изученный нами материал Московского пункта экспертизы опьянения за 1939—1947 гг. показал, что из 4422 шоферов, направленных на экспертизу, 49,6% находились в состоянии опьянения. При этом у большинства из них было лишь легкое опьянение. Тем не менее они нарушали правила уличного движения и совершали аварии, причем нередко с человеческими жертвами. В этом же отношении известный интерес представляет сообщение Дижона, который отмечает, что, согласно анкете французского Министерства внутренних дел, количество несчастных случаев на транспорте в 1952 г. по сравнению с 1951 г. повысилось на 60%. Общее число раненых при этом было 50 869, а убитых 3919. Главная причина аварий — злоупотребление алкогольными напитками.

В 1951 г. страховыми обществами во Франции было зарегистрировано 900 000 заявлений о несчастных случаях на транспорте, причем было убито 4583 человека, из них (по данным французской медицинской академии) 59,2% в момент смерти были под влиянием алкоголя (т. е. приняли небольшое количество алкоголя), а 29,5% — в состоянии опьянения. По данным Статистического управления Германской федеральной республики, в 1950 г. на транспорте зарегистрировано 182 095 несчастных случаев, главной причиной которых было несоблюдение правил уличного движения и влияние алкоголя; только в Мюнхене в 1950 г. произошло 9670 несчастных случаев на транспорте, при которых было убито 217 человек и ранено 5442.

Вышеприведенные данные указывают на необходимость решительной борьбы с пьянством среди водителей транспорта. Следует твердо помнить, что лица в состоянии легкого опьянения не могут выполнять работу на производстве, связанную с управлением сложными станками, машинами и механизмами. Появление таких лиц на производстве приводит к авариям, несчастным случаям, браку продукции и т. п.

Мы изучали совместно с Н. А. Гавриловой изменение биотоков мозга под влиянием различных доз алкоголя.

Была обследована группа здоровых людей в возрасте от 22 до 53 лет (5 мужчин и 4 женщины). Исследуемые не имели влечения к алкоголю и не злоупотребляли спиртными напитками.

Доза принятого ими алкоголя была индивидуально различная и варьировалась в зависимости от реакции на нее организма. Наименьшая доза, которую мы давали, была 25 г чистого 96° спирта, разведенного равным количеством воды, т. е. исследуемый получал 50 г водки крепостью 48°. Наибольшая доза равнялась 125 г чистого алкоголя (250 г водки). В ряде случаев вся намеченная доза алкоголя давалась сразу или же исследуемый получал ее в три приема (например, 25 г, через 30 минут еще 50 г и затем еще 50 г).

Запись биотоков коры головного мозга производилась при помощи двухканального усилителя, собранного по двухтактной схеме, с пропусканием частот от 1 Hz. Регистрирующим прибором служил восьмишлейфный осциллограф. Исследуемый находился в темной экранированной камере, биотоки отводились при помощи серебряных пластинчатых электродов, расположенных на коже головы. Отведение было монополярным. Индифферентный электрод помещался на мочке уха с ипсилатеральной стороны. Во время записи биотоков исследуемый лежал.

Обследования проводились по методу «кривых реактивности» М. Н. Ливанова.

Прежде чем приступить к работе, каждого исследуемого подвергали предварительному обследованию, во время которого запись биотоков не делалась с целью угашения ориентиро-

вочной реакции на обстановку камеры, в которой проводилось испытание.

Обследование начиналось со съемки электроэнцефалограмм до приема испытуемым алкоголя. Биотоки записывались с симметричных участков обоих полушарий. Мы пользовались лобными, височными и затылочными отведениями.

После того как была проведена серия таких записей, обследуемый получал алкоголь, и через 20 минут делались повторные записи.

В тех случаях, когда алкоголь давался дробными дозами, съемка электроэнцефалограммы производилась через 20 минут после приема очередной дозы. Таким путем нам удалось установить определенные закономерности в изменении биотоков коры головного мозга под влиянием различных доз алкоголя, которые являются общими для всех наших обследуемых.

Электроэнцефалограммы обследованных 9 человек до принятия алкоголя представляли собой различные варианты нормы, без наличия в них каких бы то ни было патологических отклонений.

Реактивность коры на внешние раздражения (прерывистые, ритмические, световые мелькания), как правило, средняя.

Прежде всего было установлено, что изменения, наступающие под влиянием алкоголя и регистрируемые в электроэнцефалограммах, зависели от количества принятого алкоголя. Но на разных обследуемых одна и та же доза оказывала различное воздействие.

Принятая нами минимальная доза — 25 г 96° спирта (50 г 48° водки) — вызвала изменения в электроэнцефалограммах 7 человек; не было изменений по сравнению с фоновыми записями у 2 человек.

Интересно, что, несмотря на наличие электроэнцефалографических изменений, субъективные ощущения (в виде легкого повышения настроения, небольшого головокружения, чувства теплоты тела) имели место только у 3 обследуемых.

Дача дозы алкоголя в 50 г (и выше) вызвала изменения в электроэнцефалограммах всех испытуемых.

Изменения биотоков, наступающие в коре мозга после принятия алкоголя, сводились к следующему.

После принятия сравнительно небольших доз, которые были индивидуально различными и колебались в пределах от 25 до 50 г 96° алкоголя, как правило, наступало повышение интенсивности электрической активности коры головного мозга (под интенсивностью электрической активности мы понимаем, как это общепринято, величину амплитуд электрических колебаний). Амплитуды колебаний увеличивались в среднем на 15—20 mV. Как правило, имело место изменение характера альфа-ритма. Нужно отметить, что под влиянием небольших доз алкоголя альфа-ритм во всех случаях становился более

выраженным. Увеличивалась его амплитуда и частота (на 1—3 колебания в секунду), в ряде наблюдений он становился сплошным, а в тех случаях, когда альфа-ритма не было в фоновых записях, он появлялся после принятия уже 25 г алкоголя (рис. 1).

У 4 обследуемых, как правило, после принятия малой дозы алкоголя появлялись частые колебания, идущие в ритме 25—35 в секунду, что, по нашему мнению, частично можно рассматривать как результат повышения возбудимости нервных элементов коры.

Реактивность коры на световые раздражения по сравнению с фоном почти всегда (у 7 обследуемых из девяти) улучшалась; возбудимость коры повышалась.

Если до принятия алкоголя «пороговые изменения» (первые изменения в биотоках) отмечались на 7—8-й секунде действия раздражителя, то после принятия его они наступали на 4—5-й секунде.

При повышении дозы 96° алкоголя до 75—125 г, а в 2 случаях до 150 г (300 г водки) электроэнцефалографическая картина изменялась у всех обследуемых: наступало снижение интенсивности электрической активности, ослабление реактивности на внешние раздражители, а у некоторых из них в биотоках коры мозга возникали патологические колебания.

Клиническое состояние обследуемых в это время всегда характеризовалось наличием изменений самочувствия и сопровождалось изменениями в нервно-психической сфере. У них отмечался шум в голове, тяжесть или, наоборот, легкость в теле, беспричинное веселье, смех, многоречивость, шаловливость. К своему поведению они относились без должной критики.

Иногда имело место учащение пульса на 6—20 ударов в минуту и дыхания на 2—4 в минуту (6 человек), иногда, наоборот — замедление дыхания и пульса.

У части обследуемых имела место гиперемия кожных покровов, в особенности лица, с инъецированием склер, у других — побледнение лица.

Соответственно состоянию изменялась и картина биотоков мозга.

Прежде всего интенсивность электрической активности коры обычно понижалась. Если до дачи алкоголя в записях биотоков альфа-ритм отсутствовал, а при небольшой дозе он появлялся, то теперь, при повышении дозы алкоголя, он вновь исчезал. Появлялись медленные колебания (в ритме 3—4 в секунду) невысокой амплитуды; они были довольно регулярными, встречались во всех областях и были более выраженными в тех случаях, когда доза алкоголя была выше.

Реактивность коры на раздражения понижалась, кривые принимали более однообразный вид. В части случаев определить возбудимость коры в связи с ее низкой реактивностью не

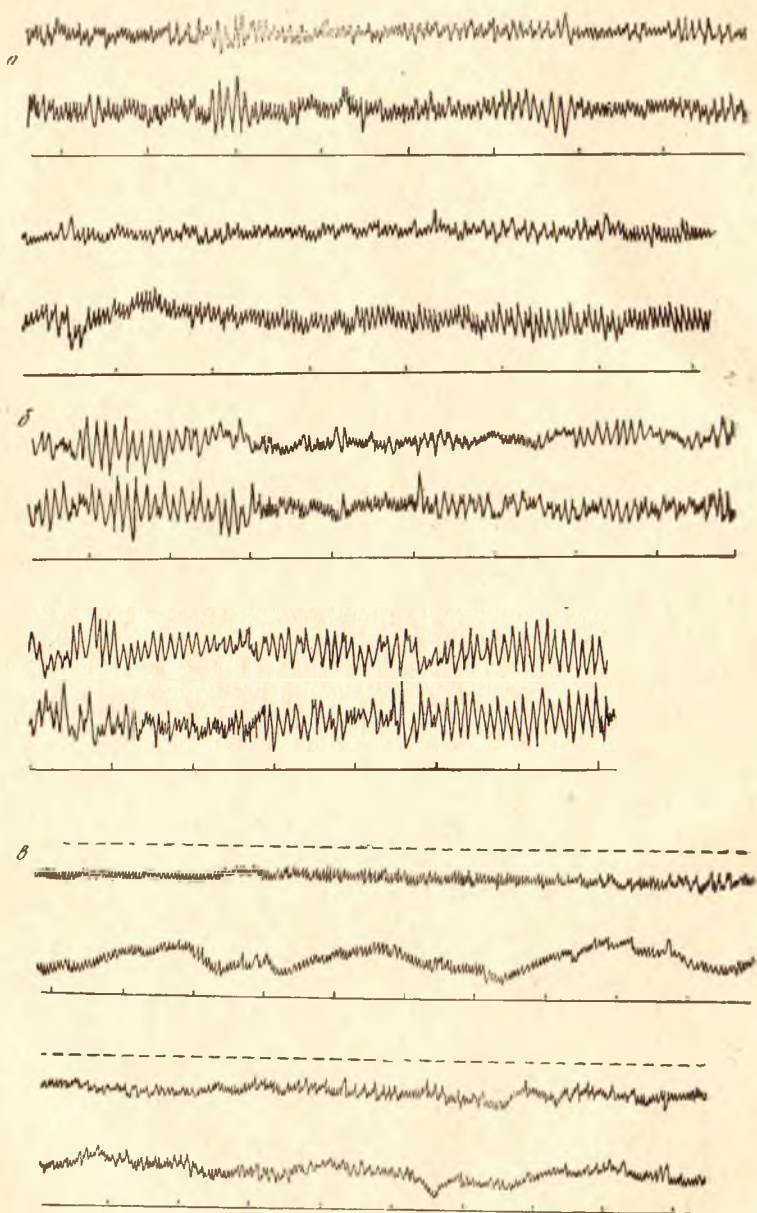


Рис. 1.

а—электроэнцефалограмма здорового человека, снятая с затылочных областей до принятия алкоголя: вверх—с правой, вниз—с левой; штрихи внизу—отметка времени (один штрих в 1 секунду); б—тоже после принятия 25 г алкоголя; видно увеличение амплитуды альфа-ритма и его большая регулярность по сравнению с фоном; в—электроэнцефалограмма с затылочных областей правого (вверху) и левого (внизу) полушария после принятия 100 г 96° этилового спирта; в левом полушарии имеется ритм, отражающий частоту дыхания.

удавалось; в тех же случаях, когда «пороговые» изменения все же можно было отметить, они наступали позже, чем до принятия алкоголя, на 2—5 секунд. У некоторых обследуемых отмечалось удлинение последствий.

При еще большем повышении доз алкоголя, когда наступает клиническая картина опьянения с последующим сном, изменения в электроэнцефалограммах принимают еще более выраженный характер.

Наблюдалось дальнейшее снижение интенсивности электрической активности, снижение реактивности коры. В 3 случаях налицо был ритм, отражающий частоту сердечных сокращений, что, может быть, можно трактовать как облегченную иррадиацию в кору подкорковых ритмов, наступающего вследствие нарушений правильного взаимодействия между корой и подкоркой.

В одном случае в электроэнцефалограмме обследуемого после принятия 300 г 40° водки имел место дыхательный ритм. На наличие в коре мозга таких ритмов, отражающих частоту дыхания или пульса, указывает ряд авторов, работающих как с животными, так и с человеком. В частности, указание на наличие колебаний, отражающих ритм дыхания и пульса в биотоках коры мозга человека, мы находим в исследовании Ю. Г. Григорьева.

Для иллюстрации вышеизложенного приведем в качестве примера два наблюдения.

Обследуемый Г., 30 лет, практически здоров. Инфекционных заболеваний, ранений в голову, контузий не было. Влечения к алкоголю не испытывает. Обследовался в лаборатории 4 раза.

При первом и втором обследовании получал алкоголь дробными дозами (в общем количестве 150 мл чистого этилового спирта), при третьем обследовании — сразу 100 мл 96° этилового спирта.

27/III 1954 г. до принятия алкоголя электроэнцефалограмма характеризуется средней интенсивностью биотоков и средней реактивностью на световые раздражения.

Соответственные участки коры правого и левого полушарий работают синхронно и симметрично. В лобных и затылочной областях альфа-ритм встречается отдельными веретенами. Патологических отклонений нет. Через 20 минут после принятия 25 г алкоголя отмечается небольшое повышение интенсивности биотоков, незначительное улучшение реактивности и усиление альфа-ритма; он становится более регулярным, почти сплошным (однако нормально подавляясь от световых раздражений). Патологических колебаний после принятия данной дозы не появилось.

Со стороны клинического состояния изменений в самочувствии не наступило, пульс участился с 80 до 86 в минуту, дыхание не изменилось (16 в минуту).

После принятия еще 75 г алкоголя через 20 минут отмечено снижение реактивности коры на внешние раздражения; альфа-ритм утратил четкость, встречался нерегулярно, местами амплитуда его понизилась.

Появились патологические знаки в виде медленных колебаний, следующих в ритме 1—2 в секунду.

Клинически отмечались явления эйфории, головокружение, побледнение кожных покровов, пульс 86 ударов в минуту, дыхание — 12 в минуту. В другом обследовании, проведенном 3/IV 1954 г., после принятия

сразу 75 г алкоголя, отмечается ослабление реактивности коры на внешние раздражения и нерегулярный дыхательный ритм (особенно в левом полушарии).

При этом наблюдалось состояние огьянения, пульс 90 ударов в минуту, дыхание нерегулярное, 20 в минуту.

Обследуемая Л-а, 22 лет, практически здорова. Тяжелых инфекций, ранений в голову, контузий не имела. Алкоголь не употребляет. Обследование биотоков проводилось три раза. До принятия алкоголя отмечается средняя интенсивность биотоков, хорошо выраженный альфа-ритм, патологических отклонений нет.

Реактивность на световые раздражения средняя. Работа соответственных участков коры правого и левого полушарий синхронна и симметрична. Через 20 секунд после принятия 25 г 96° алкоголя состояние исследуемой, по ее высказыванию, было приятным. Она испытывала «легкость, радость, блаженство, все казалось прекрасным»; пульс 96 ударов в минуту вместо 80 до принятия алкоголя, дыхание 20 в минуту. В коре наблюдалось резкое увеличение интенсивности биотоков, в то же время реактивность значительно снижалась.

После добавочного принятия еще 50 г 96° алкоголя через 20 минут обследуемая сонлива, жалуется на тошноту, затем наступает рвота, пульс 100 ударов в минуту, дыхание 20 в минуту, бледна. Интенсивность корковой активности снижается, реактивность на свет становится очень слабой (рис. 2 см. стр. 18—19).

Вышеприведенные данные наглядно свидетельствуют о нарушениях электрической активности мозга под влиянием вышеуказанных доз алкоголя.

Средние дозы алкоголя не только снижают работоспособность, но и уменьшают желание работать (импульс к труду). В результате длительной интоксикации у больных, страдающих тяжелой формой алкоголизма, пропадает импульс к труду, они становятся неспособными к систематической работе, опускаются, переходят на иждивение семьи, пропивают вещи, нередко ведут асоциальный образ жизни, часто попадают в психиатрические больницы.

Что касается чувства усталости при упомянутых выше работах, то, по нашим наблюдениям, после приема малых доз 96° алкоголя (25—30 г) работа кажется легкой и нетрудной, после приема средних доз (50—100 г) и больших она вскоре начинает казаться нецелесообразной. Появляется желание прилечь, подремать, т. е. возникает чувство, аналогичное усталости, которое, если продолжать давать алкоголь, увеличивается настолько, что приводит, в конце концов, ко сну. Неутомленный человек после приема умеренных доз алкоголя устает раньше, чем человек, не принимавший алкоголя, а утомленный вначале хотя также субъективно ощущает оживление, но не вследствие устранения усталости, а в результате торможения коры головного мозга и связанной с этим положительной индукции подкорки.

Активное и пассивное внимание под влиянием малых и средних доз 96° алкоголя (30—50 г) нарушается. Обследуемые под влиянием алкоголя делают больше ошибок и работают медленнее и менее уверенно. Алкоголь влияет на память глав-

ным образом вследствие затруднения образования новых условных связей, их хрупкости, непрочности (Синкевич, Стрельчук). Установлено, что выученные после приема средних доз алкоголя стихи сохраняются в памяти более короткий срок, чем заученные в обычное время. Особенно сильно страдает память в состоянии сильного опьянения, после которого обнаруживаются пробелы памяти или полная амнезия в отношении всего того, что было пережито и сделано в состоянии сильного опьянения. Аффективная сфера возбуждается алкоголем. У некоторых людей безусловные реакции, например, пищевая, половая, оборонительная, под влиянием малых и средних доз алкоголя обычно повышаются, а у других половая реакция, наоборот, угнетается. В большинстве случаев алкоголь вначале создает повышенное настроение, чувство довольства, эйфорию. Объективно это выражается веселым выражением лица, радостным взглядом, блеском глаз, оживленной мимикой, многогоречивым разговором, смехом. Опьяневший становится веселым, развязным, склонен шутить, завязывать дружеские отношения с мало знакомыми людьми. Затем он становится не критичным, бестактным, начинает кричать, петь, шуметь, не считаясь с окружающими. Поступки его импульсивны, необдуманны. В заключение он впадает в тупую апатию.

Психопатологическая картина, вызываемая алкогольным опьянением, у многих лиц напоминает гипоманиакальное возбуждение. Одной из основных причин алкогольной эйфории является возбуждение подкорки — старейшей в филогенетическом отношении части мозга, в то время как нормальная работа более молодых и более чувствительных областей коры головного мозга сильно нарушается вследствие развития в них торможения.

И. П. Павлов в своей статье «Пробная экскурсия физиолога в область психиатрии», пишет:

«Наконец, сюда же, в эту группу всяческих вариаций центрального торможения, нужно отнести и симптом шаловливости, дурашливости, наблюдаемой в особенности у гебефреников, а также вспышки возбуждения с характером агрессивности, которые встречаются среди уже указанных симптомов у других шизофреников. Все эти явления очень напоминают картину обыкновенного начального алкогольного опьянения...».

«...В этих случаях имеются все основания понимать дело так, что они есть результат начинающегося общего торможения больших полушарий, в силу чего ближайшая подкорка не только освобождается от постоянного контроля, постоянного торможения со стороны полушарий при бодром состоянии, а даже на основании механизма положительной индукции приводится в возбужденное хаотическое состояние со всеми ее центрами. Отсюда при алкогольном наркозе то беспричинная и необычная шаловливость и веселость, то излишняя чувствительность и слезы, то гневность».

У некоторых людей алкоголь вызывает грусть. Тяжелые думы овладевают пьяным. Он вспоминает о пережитых неудачах, измене, болезнях, несчастьях и т. п. Его все трогает, все

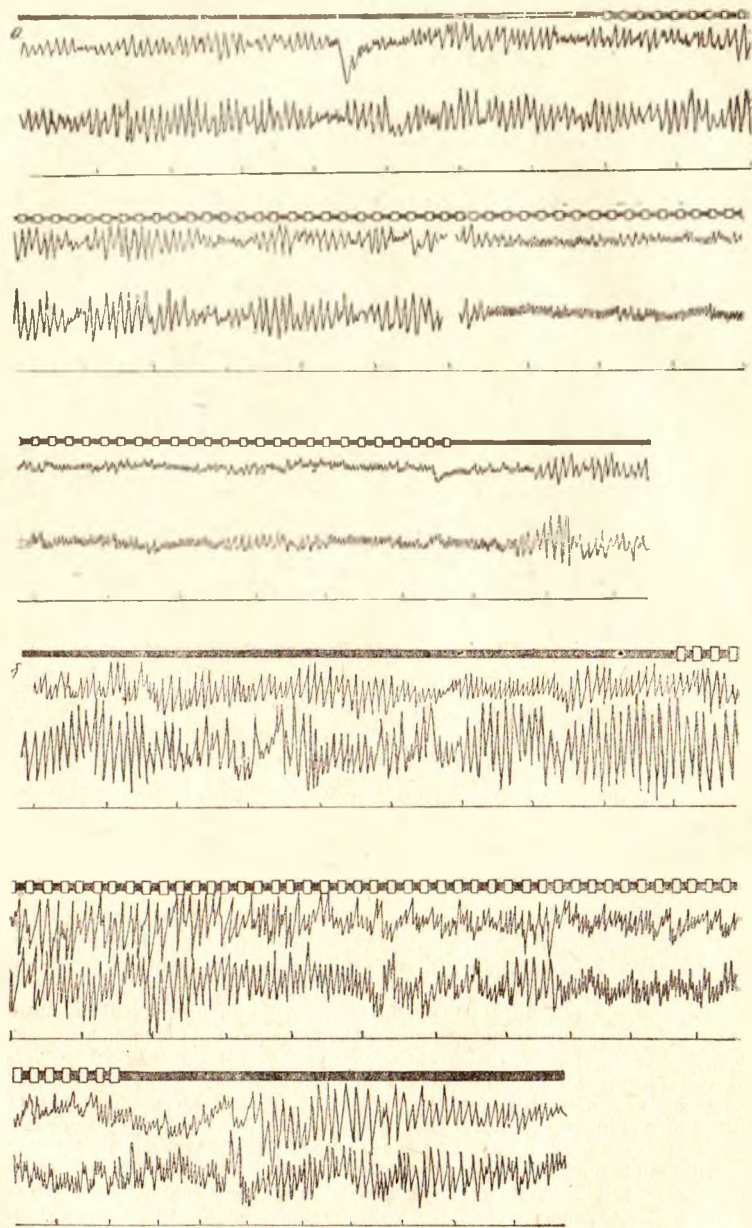


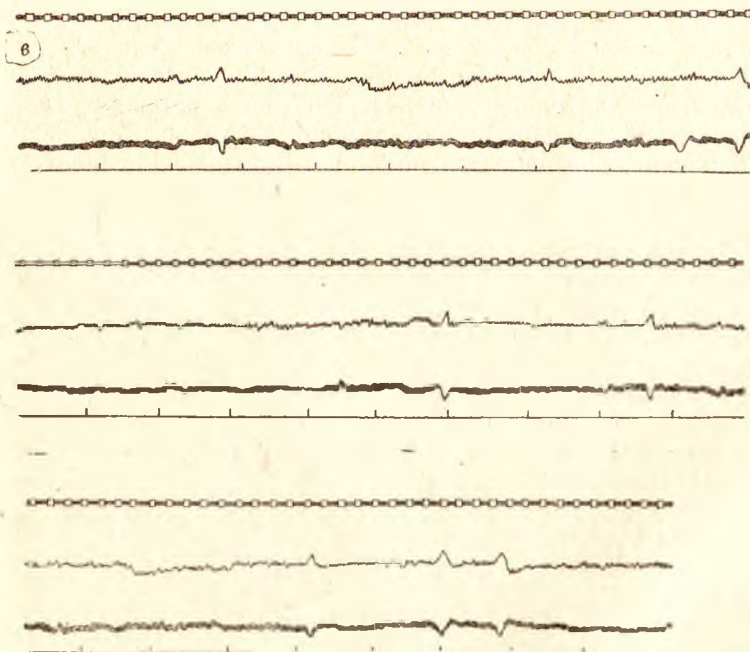
Рис. 2.

a — электроэнцефалограмма с затылочных областей исследуемой Л. до введения раздражения средняя, отчетливое подавление альфа-ритма на сильные раздражения 20 секунд после принятия внутрь 25 г алкоголя; резкое увеличение электрической активности после принятия еще 50 г алкоголя; видны отдельные

пугает. Смелый и хладнокровный в трезвом состоянии, в опьянении он становится трусливым. Он стонет и плачет, как ребенок, по самому пустому подчас нелепому поводу. Некоторые люди в состоянии опьянения делаются задорными, раздражительными, не терпят никаких возражений, выскивают и даже выдумывают повод для ссоры и драки. В таких случаях выпивка редко проходит без скандала.

Иногда алкоголь сразу вызывает отупение, индифферентное отношение к окружающему. Такие люди спокойны, мало контактны; стадия возбуждения у них отсутствует, наркотическая же фаза наступает медленно. Нет сомнений, что особенность опьянения зависит от типа высшей нервной деятельности человека.

Алкоголь, принятый в больших дозах, вызывает более глубокие нарушения. Восприятие внешних впечатлений затрудняется и замедляется, точность их понижается. Переработка воспринятого нарушается. Внимание и память нарушается еще в большей степени, чем под влиянием малых и средних доз. Ассоциативные процессы качественно расстраиваются, критика ослабевает. Опьяневший человек лишается способности внима-



ния алкоголя; виден четкий альфа-ритм: реактивность на внешние (световые) явления и его восстановление через 1 секунду последствия; б — то же через часовой активности, ослабление реактивности; а — то же через 20 секунд ные острые волны. Энцефалограмма бедна колебаниями.

тельно выслушивать других, следить за правильностью своей речи, контролировать свое поведение. Он самоуверен, беззаботен, суждение его ослаблено, но речь оживленна. Он болтлив, хвастлив. Опьяневшему кажется, что его способности улучшаются и действия облегчаются, что он может найти быстрое и правильное решение любого вопроса. Все заботы, сомнения, препятствия исчезают — все можно преодолеть. Он чувствует прилив сил. Настроение делается то безудержно веселым, то плаксивым, то гневным. Обычно в состоянии опьянения, как мы уже отмечали, выявляются и заостряются индивидуальные черты характера: люди веселые громко говорят, острят, поют, пляшут, грустные — впадают еще в большую грусть, плачут, раскаиваются в чем-то, просят у всех извинения. Люди раздражительные, несдержанные, грубые становятся еще более грубыми и циничными, придирчивыми, склонными к аффективному возбуждению и агрессии. Отдельные лица, несмотря на тяжесть опьянения, сохраняют полный контроль за своим поведением и внешне ведут себя правильно.

Иногда, наоборот, грубые люди в пьяном виде становятся мягкими, ласковыми, склонными к нежным излипаниям; спокойные делаются агрессивными, раздражительными; грустные — веселыми, подвижными.

Нравственное чувство у пьяного человека ослабевает, он теряет стыд. Непристойные замечания, циничные шутки — обычное явление для опьяневших. Нередко появляется сексуальное возбуждение, заводятся эротические разговоры. Наносятся оскорбления, совершаются поступки, нарушающие общественную безопасность. Пьяный плохо разбирается в том, что ему говорят, что вокруг него происходит. Отвлекаемость повышается. Иногда отмечается пробуждение низменных склонностей и страстей. Опьяневший не в состоянии сдерживаться, утрачивает способность самоконтроля. Он возмущается, если ему указывают, что он пьян. Такое возбуждение постепенно сменяется состоянием угнетения. Сознание затемняется, но ориентировка сохраняется в течение почти всего периода опьянения. Умственные способности ослабевают, появляется сонливость. Речь становится неправильной, лепечущей. Мало-помалу опьяневший успокаивается и крепко засыпает.

Наряду с нарушениями высшей нервной деятельности, при опьянении появляется ряд вегетативно-висцеральных и соматических изменений. Вскоре после приема алкоголя по всему телу разливается приятная теплота. На щеках появляется румянец. Глаза приобретают особый блеск. В большинстве случаев зрачки в начальном периоде опьянения расширяются, а в состоянии алкогольного наркоза — суживаются. Пульс, вначале полный и учащенный, впоследствии становится слабым и замедленным. Субъективно приятное чувство теплоты,

ощущаемое в начале опьянения, зависит от расширения кожных сосудов и от прилива крови к периферии.

В дальнейшем при опьянении температура тела постепенно понижается на 1—2°, а нередко и больше вследствие значительной потери тепла в окружающую среду, поэтому опьяневшие замерзают скорее, чем трезвые. Дыхание в начале опьянения учащается, но с нарастанием опьянения делается редким и более глубоким. Походка по мере нарастания опьянения становится неуверенной, атактической, движения рук неkoordinированными. Пьяный не может сохранять вертикальное положение, он спотыкается и падает. В начале или в конце опьянения нередко наблюдается рвота. Известно, что некоторые реакции организма носят защитный характер. При рвотной реакции, наступающей после приема больших количеств спиртных напитков, алкоголь удаляется из желудка и его дальнейшее всасывание в кровь прекращается, что приводит к ослаблению алкогольной интоксикации.

З. Л. Синкевич, изучившая влияние различных доз алкоголя на взаимодействие сигнальных систем, установила, что рвота при экспериментальном применении больших доз алкоголя имеет место у здоровых людей, а также в легких степенях алкоголизма.

Исследование корковой динамики при этом показало, что у здоровых лиц, у которых после приема больших доз алкоголя наступает рвота, корковая динамика перед этим дает либо очень незначительные изменения, либо этих изменений не наблюдается. Рвотная реакция является защитным механизмом, преграждающим доступ токсического воздействия алкоголя на корковые клетки больших полушарий головного мозга. С течением времени вследствие длительного отравления алкоголем эта защитная реакция ослабевает, а затем исчезает, поэтому алкоголь, не встречая препятствия (в виде рвотного акта) к всасыванию в организм, оказывает токсическое воздействие на корковые клетки, вследствие чего нарушения корковой динамики носят более выраженный характер.

После приема очень больших количеств алкоголя наступают еще более тяжелые расстройства. Терморегуляция нарушается вследствие начинающегося паралича терморегулирующих центров, температура тела понижается еще больше, работа сердца ослабевает. Постепенно наступает паралич сосудодвигательного и дыхательного центров. Дыхание становится поверхностным, замедленным, хрипящим. Кожа вначале принимает красноватую окраску, впоследствии сменяющуюся резкой бледностью. Иногда появляется цианоз, что служит весьма неблагоприятным симптомом. Постепенно нарастает состояние глубокого наркоза с полной потерей сознания, утратой рефлексов, произвольных движений, чувствительности, с повышением мышечного тонуса. Наконец, при явлениях

резкого упадка сердечной деятельности может наступить смерть от отека легких, паралича дыхания и сердца.

Алкоголь выводится из организма при помощи легких и почек в количестве от 2 до 10%, основная же его часть подвергается окислению.

Прекращение действия алкоголя на организм во многом зависит от индивидуальной реакции на алкоголь и от степени опьянения. Некоторые последствия даже умеренного опьянения могут оставаться в течение 24—36 часов. У многих людей после алкогольного опьянения отмечается подавленное настроение, головная боль, головокружение, физическая слабость, неприятный вкус во рту, потеря аппетита, жажда, боли в животе, тошнота, а нередко и рвота, потеря интереса к труду и даже полная невозможность приняться за работу.

Известный интерес представляют данные о влиянии алкоголя на больных шизофренией.

Некоторые авторы, вводя при шизофрении 48° алкоголь (50—75 мл), пришли к выводу, что у части больных он способствует временному расторможению психики, делая их более доступными и разговорчивыми. Н. В. Канторович и С. К. Константинович, вводя внутривенно 20° алкоголь в количестве от 100 до 500 мл больным кататонической и гебефрено-кататонической формой шизофрении, отмечали, что временно он устраняет основные кататонические симптомы (мутизм, оцепенение, негативизм); у больных возникает эмоциональный контакт, мышление и речь приобретают более связный характер. Данные явления носят кратковременный характер и проходят с прекращением действия алкоголя.

ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОПЬЯНЕНИЕ

Патологическое опьянение представляет собой вызванный алкоголем кратковременный острый, abortивно протекающий психоз, длящийся от нескольких минут до одного часа, но не свыше суток. Название «патологическое опьянение» неудачно, ибо всякое опьянение является патологическим состоянием. Вносились предложения называть патологическое опьянение сложным опьянением, патологической алкогольной реакцией, эпилептиформным опьянением (Крепелин), психотическим опьянением (М. И. Затуловский), но все эти названия не прижились в психиатрической практике. Мы считаем целесообразным такое опьянение называть острым алкогольным abortивным психозом.

Этиология. Патологическое опьянение у здоровых лиц отмечается редко, чаще всего оно наблюдается при эпилепсии, психопатиях, неврозах, олигофрении, у лиц, перенесших травму черепа, страдающих хроническим алкоголизмом и т. д.

Способствующими и провоцирующими моментами могут служить сильные волнения, испуг, страх, гнев, ссора, ревность,

тяжелые потрясения, переутомление, половые эксцессы, истощающие факторы, жара, пребывание в плохо вентилируемом помещении, беременность, климактерический период у женщины и т. п.

Клиническая картина патологического опьянения. Патологическое опьянение обычно возникает внезапно, без всяких предвестников; иногда ему предшествует кратковременный (15—30 минут) сон или судорожные приступы. Количество и качество алкоголя не играют существенной роли, так как патологическое опьянение может наступить даже после приема небольших его доз.

Клиническая картина патологического опьянения выражается в тяжелом помрачении сознания; ориентировка в окружающем теряется.

Аффективная сфера болезненно изменяется, у больного появляется аффект страха, гнева, ярости. Страх бывает то безотчетным, то вытекает из различных опасений.

Эйфории, свойственной начальному периоду обычного опьянения, не бывает. Часто появляются иллюзии, зрительные и слуховые галлюцинации. Больному мерещатся различные звери, чудовища, птицы, насекомые, пресмыкающиеся, уроды и т. п. Он слышит шепот, брань, угрозы; ему кажется, что за ним следят, подкрадываются к нему, обвиняют его в тяжелых преступлениях, нападают на него. Своих друзей больной принимает за врагов и начинает от них яростно защищаться. Им овладевает дикая злоба. Иногда на первый план выступают бредовые идеи отношения и преследования. Обычно помрачение сознания достигает глубоких степеней. В большинстве случаев отмечается полная амнезия периода опьянения, и лишь у части больных сохраняются отрывочные воспоминания о нем. Почти всегда наблюдается двигательное возбуждение. Атаксия отсутствует. Поведение обычно адекватно переживаемому аффекту. Отмечается склонность к агрессивным поступкам. Больной ругается, кричит, вступает в драку, наносит оскорбления словом и действием, пускает в ход ножи, оружие, совершает преступления, которые поражают своей жестокостью. Нередко под влиянием устрашающих аффектов он наносит себе повреждения, совершает попытки к самоубийству, нападению, обнаруживая при этом большую ловкость и способность преодолевать препятствия. В тяжелых случаях патологического опьянения возбуждение достигает крайних степеней.

Патологическое опьянение заканчивается продолжительным сном. Просыпаясь, больной не помнит, что с ним произошло в состоянии опьянения.

Описано много различных форм патологического опьянения. Н. В. Канторович и И. А. Осовский предлагали делить алкогольное опьянение на группы в соответствии с психопато-

логическими синдромами. И. Н. Введенский на основании большого количества случаев экспертизы сводит клиническую картину патологического опьянения к двум основным типам — эпилептоидному и параноидному, или галлюцинаторно-бредовому. Эпилептоидный тип опьянения Введенский разделяет на два варианта: первый характеризуется явлениями резкого психомоторного возбуждения, беспорядочной агрессией, тяжелым расстройством сознания и полной амнезией; при втором варианте наблюдается сумеречное состояние сознания и автоматические действия, которые напоминают эпилептическое сумеречное состояние и трудно от него отличимы.

При параноидной форме патологического опьянения И. Н. Введенский обнаруживал в большинстве случаев влияние предшествовавших психогенных факторов. М. И. Затуловский считает, что патологическое опьянение «представляет собой скорее единое однотипное, однородное, маловариабильное психотическое состояние», характеризуя его как «острое аффективно-бредовое сумеречное состояние». С такой постановкой вопроса никак нельзя согласиться. В клинике существуют разнообразные формы патологического опьянения, и хотя нередко отмечается, что один синдром переходит в другой и разграничение различных форм патологического опьянения представляет большую трудность, тем не менее изучать и классифицировать различные синдромы патологического опьянения необходимо.

В практике чаще всего встречаются следующие формы патологического опьянения: эпилептоидная — с психомоторным возбуждением, затемнением сознания, агрессивными и разрушительными действиями и последующим сном; делирантная — с обильными зрительными и в меньшей степени слуховыми галлюцинациями, безогчетным страхом, изменением представления об окружающей обстановке, потерей ориентировки, волнообразным нарушением сознания, причудливыми делириозными переживаниями и т. п.; параноидная, или галлюцинаторно-бредовая — с наплывом слуховых галлюцинаций, носящих характер оскорблений и угроз, бредом отношения преследования и т. п.; маниакальная — с бурной веселостью, речевым и двигательным возбуждением, отвлекаемостью внимания, экзальтацией, расторможенностью, склонностью к дурашливости; депрессивная, которая характеризуется подавленным настроением, тоской, злобой, слезами, ипохондрическими жалобами, стремлением наносить себе различные повреждения, попытками к самоубийству; истерическая — выражающаяся в расторможенности эмоций, эгоцентризме, истерическом поведении, приступах смеха, плача, истерических припадках, сновидных переживаниях, в сумеречных состояниях сознания. Сумеречные состояния сопровождаются резко выраженным

аффектом тревоги, страха, моторным возбуждением, агрессивностью, тенденцией к разрушительным действиям.

С. Г. Жислин описал у больных, страдающих алкоголизмом с шизофреническим отягощением, патологическое опьянение, которое протекает в виде шизофренического синдрома, исчезающего с прекращением опьянения. Крепелин относит к патологическому опьянению такие случаи, когда под влиянием алкоголя появляется страсть к бессмысленным поджогам, извращаются половые инстинкты, что приводит к эксгибиционизму, гомосексуальным актам, половым насилиям, вплоть до похотливых убийств. Патологическое опьянение заканчивается по-разному. Обычно после совершения насильственных актов больной успокаивается и наступает длительный глубокий сон. В части случаев последующего угнетения и сна может не наблюдаться.

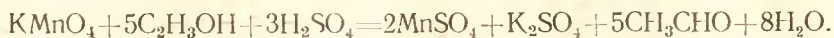
Симптомы нарушения нервной системы выражаются в виде вялой реакции зрачков на свет или неподвижности зрачков.

Диагностика алкогольного опьянения. Диагностика алкогольного опьянения не представляет затруднений, тем не менее встречаются ошибки. Иногда в больницу доставляют людей якобы пьяных, тогда как на самом деле у них обнаруживается инсульт, травма черепа, уремия, кома, тяжелое отравление и т. п. В каждом таком случае диагноз нужно ставить с большой осторожностью.

В тех случаях, когда диагностика алкогольного опьянения преследует цели экспертизы, наряду с тщательным исследованием больного (состояние сознания, обманы чувств, бред, аффективная сфера, пульс, тонкие движения, речь, походка, почерк, состояние зрачков, анамнез и т. п.), весьма ценную услугу оказывает определение алкоголя в выдыхаемом воздухе и в крови (реакция А. М. Рапопорта, Видмарка и др. или же реакция с двухромовокислым калием).

Реакция А. М. Рапопорта. В две пробирки наливают по 2 мл дистиллированной воды. В пробирку, предназначенную для проведения опыта, вставляют длинную стеклянную трубочку с таким расчетом, чтобы один ее конец был погружен в воду. Затем исследуемому предлагают дуть в эту трубку в течение 15 секунд. Если в выдыхаемом воздухе содержится алкоголь, он поглощается водой. После этого в опытную и контрольную пробирку добавляют 15—25 капель химически чистой серной кислоты. Серную кислоту следует добавлять осторожно, по стенке пробирки, так как при соединении H_2SO_4 с водой происходит термическая реакция. Затем в обе пробирки добавляют по 1—2 капли 0,5% раствора марганцовокислого калия. В присутствии алкоголя марганцовокислый калий обесцвечивается, содержимое же контрольной пробир-

ки остается светлорозовым. Реакция происходит в основном по следующему типу:



Марганец переходит из семивалентного в двухвалентный. Спирт окисляется в ацетальдегид. Вода получается в результате окисления. Необходимо учитывать, что ацетон, хлоралгидрат, *Adonis vernalis*, эфир способны давать положительную реакцию А. М. Рапопорта.

Прежде чем проводить реакцию А. М. Рапопорта, необходимо, чтобы исследуемый прополоскал рот кипяченой водой.

Модификация реакции А. М. Рапопорта С. Л. Архангеловой. Необходимы реактивы: раствор двуххромовокислого калия (19,6 : 1000) и концентрированная серная кислота. В пробирку наливают 2 мл воды и вставляют в нее тонкую стеклянную трубочку с таким расчетом, чтобы один конец ее погружался в воду. Исследуемый делает в пробирку 40 выдохов. 2 мл воды наливают в другую пробирку для контроля. Добавляют по 25 капель серной кислоты и 2—3 капли двуххромовокислого калия. Желтая окраска при наличии алкоголя переходит в зеленую вследствие восстановления $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ в соль окиси хрома.

Опьянение и вменяемость. Наблюдающаяся в начальной степени опьянения эйфория, приподнятое настроение, расторможенность, ослабление высших регуляторных механизмов, развязность, тенденция к грубым, циничным замечаниям, громкий разговор, бестактность часто приводит к нарушению общественного порядка. Вследствие аффективного возбуждения, повышенной обидчивости, невозможности себя сдерживать, ослабления критики и контроля за своим поведением опьяневшие часто вступают в конфликт с окружающими, цинично ругаются, наносят оскорбление словом и действием, вступают в драку, допускают эксцессы, нередко совершают преступления сексуального и другого характера. Алкогольное опьянение — частый спутник правонарушения, квалифицируемого как хулиганство. Преступления, совершаемые в состоянии патологического опьянения, более серьезны и поражают своей бессмысленностью и чудовищной дикостью (нанесение тяжелых увечий, убийство, поджоги и т. п.). По материалам Института судебной психиатрии имени В. Сербского, патологическое опьянение наблюдалось в среднем у 0,4—0,7% всех исследуемых. Советское законодательство не освобождает совершившего преступление в состоянии опьянения от наказания. Этим охраняются интересы общества, ибо в противном случае нельзя было бы наказать ряд преступников. Патологическое опьянение по советским законам может быть принято во внимание при решении вопроса о вменяемости.

Лечение. При остром отравлении спиртными напитками из желудка удаляют алкоголь (если наличие такового еще можно предполагать), чтобы прекратить дальнейшее его всасывание в кровь. Для этой цели, если бессознательное состояние еще не наступило, желудок промывают, удаляя из него алкоголь, применяют рвотные средства или вызывают рвоту искусственным путем, раздражая корень языка пальцами или шпателем, обернутым в марлю или вату. Предварительно отравившемуся можно дать три-четыре стакана воды, после чего вызвать рвоту (искусственное промывание). Не рекомендуется прибегать к таким рвотным средствам, как сернокислая медь, сернокислый цинк и т. п., потому что при сильных степенях опьянения вследствие наркотизирующего влияния алкоголя эти средства не вызывают рвоту, а, оставаясь в желудке и всасываясь, способствуют добавочной интоксикации. Для вызывания рвоты даже в тяжелых случаях опьянения пользуются солянокислым апоморфином, который возбуждает рвотный центр в продолговатом мозгу.

Применяется апоморфин в виде подкожных инъекций по 0,25—0,50 мл 1% раствора. Противопоказаниями к применению апоморфина являются: низкое кровяное давление, общее истощение, кахексия, так как в подобных случаях апоморфин может вызвать коллапс. Кроме того, апоморфин противопоказан при тяжелых степенях опьянения, когда больные находятся в коматозном состоянии, а также в состоянии глубокого наркоза, особенно при комбинации морфинного отравления с алкогольным.

П. П. Овчаренко и Л. С. Неймер, применявшие в практике наркоприемников 1% апоморфин в дозах 0,3—0,5 мл, отмечают, что он оказывает рвотное действие в 83% случаев, независимо от тяжести опьянения. По данным этих авторов, эффект наступал через 7 минут. Применение апоморфина было безуспешным лишь в 8 из 30 случаев тяжелого отравления алкоголем.

Однако мы решительно высказываемся против применения больших доз апоморфина, превышающих максимальные дозы, приводимые в Государственной фармакопее. Оптимальной дозой при остром отравлении алкоголем является 0,003—0,005 г апоморфина, введенного подкожно.

Rp. Apomorphini hydrochlorici sterilisatæ 1% 10,0
DS. По 0,3—0,5 мл для подкожных инъекций

Параллельно с вызыванием рвоты рекомендуется удалить катетером мочу или предложить больному помочиться, так как доказано, что алкоголь, содержащийся в моче, способен диффундировать обратно в кровь.

При наличии коматозного состояния вводят внутривенно 10% коразол по 1—3 мл, причем вливания можно повторять

через 1—2 часа. С. Я. Арбузов на основе своих экспериментальных исследований на животных рекомендует внутривенное введение смеси фенамина и коразола как выраженных антагонистов наркотиков. Подкожно или внутривенно вводят стрихнин по 0,001—0,003 г, растирают тело камфорным маслом. В случае сильного прилива крови к голове иногда целесообразно бывает поставить пиявки за уши. При угрозе смерти назначают венесекцию с выпусканьем до 200 мл крови, после чего рекомендуется вводить подкожно физиологический раствор (300—400 мл). Если наблюдается падение сердечной деятельности, вводят подкожно камфору, кофеин, адреналин и т. п. При явлениях асфиксии прибегают к вдыханию кислорода, искусственному дыханию. Прекрасным средством для возбуждения дыхательного центра служит цититон и лобелин. Лобелин вводят подкожно по 1 мл в виде 1% раствора. Если возникает угроза паралича дыхания, лобелин можно вводить внутривенно, начиная с 0,003; при этом нужно соблюдать осторожность и вводить его медленно.

Rp. Lobelini hydrochlorici 1%
in amp. 1,0
DS. По 0,5—1 мл подкожно

Особенно большая осторожность требуется при назначении лобелина больным алкоголизмом при наличии тяжелых поражений сердечно-сосудистой системы ввиду угнетающего действия этого препарата на сердечную мышцу и нервно-мышечный аппарат сердца, приводящего к падению кровяного давления. В таких случаях одновременно с лобелином нужно вводить адреналин, который повышает кровяное давление. Наряду с лобелином, для возбуждения дыхания применяют его заменитель — цититон, однако к нему не рекомендуется прибегать при гипертонии, выраженном артериосклерозе, при отеке легких и кровотечениях из крупных сосудов ввиду его свойства повышать кровяное давление.

Rp. Cytitoni 1,0¹
D. t. d. N. 6 in amp.
S. По 1 мл в вену (взрослому)

Фенамин, первитин и в меньшей степени другие симпатомиметические вещества (адреналин, атропин) снижают концентрацию алкоголя в крови вследствие замедленного всасывания последнего в кровь из желудочно-кишечного тракта после введения этих веществ. Опытами на животных доказано, что всасывание алкоголя из кишок, куда предварительно вводился фенамин, равнялось 2,89%, тогда как без фенамина это всасывание повышалось до 55,2%.

¹ 0,15% раствор цитизина

При остром отравлении алкоголем с успехом применяют внутривенное введение 50 мл 50% глюкозы и 15 ИЕ инсулина, что ускоряет падение концентрации спирта в крови. Предполагают, что падению концентрации спирта способствует одновременное окисление глюкозы.

При алкогольной коме применяют также вдыхание смеси 90% кислорода и 10% углекислоты. Таким путем, по Рабиновичу и Зелезник, достигается быстрое падение содержания алкоголя в крови. Этот метод основывается на быстром выделении алкоголя вследствие усиленного дыхания и ускоренного его сгорания в организме, а также на возбуждении углекислым газом дыхательного центра.

Ввиду падения температуры тела при отравлении алкоголем больной должен находиться в теплой комнате. Его нужно хорошо укрыть, к ногам и рукам приложить грелки; при этом нужно соблюдать осторожность, чтобы не вызвать ожогов, так как при отравлении алкоголем больные не реагируют на боль. Мы наблюдали трудно заживающие ожоги в результате неосторожного применения грелок.

Внутрь можно давать нашатырный спирт по 5—10 капель в рюмку воды для возбуждения сердечной деятельности, сосудодвигательного и дыхательного центра. Правильное и своевременное применение упомянутых выше средств при тяжелом отравлении алкоголем во всех случаях дает положительные результаты. При патологическом опьянении мы с успехом применяли инсулин по 10—20 ИЕ с одновременным введением глюкозы и назначением снотворных средств.

Применяется также смесь проф. Краснушкина по следующей прописи:

Rp. *Natrii bromati*

Chlorali hydrati aa 15,0

T-rae Valerianae simplex 20,0

Pantoponi 0,1

Luminali 0,5

Adonileni 5,0

Aq. destill. 500,0

MDS. По 50—100 мл в клизме или по 2—3 столовые ложки внутрь

Для купирования резкого возбуждения вводят подкожно 1% солянокислый апоморфин по 0,3—0,5 мл, который вызывает тошноту, рвоту и приводит к быстрому исчезновению возбуждения, а иногда вызывает сон. Применение таких наркотиков, как пантопон, морфин, мы считаем нецелесообразным.

За больными должен быть установлен тщательный надзор, так как некоторые из них, особенно страдающие алкоголизмом с патологическим опьянением, тяжелыми формами психопатии, склонны к агрессивным поступкам, попыткам к самоубийству и другим асоциальным действиям, что может легко произойти при недостаточном надзоре. В некоторых случаях при тя-

желом отравлении алкоголем больного удастся привести в сознание, надавливая на ветки тройничного нерва.

Последствия отравления алкоголем (головная боль, слабость, головокружение, плохой вкус во рту, тошнота, потеря аппетита) не требуют особой терапии и проходят без врачебного вмешательства, однако при тяжелых явлениях можно рекомендовать крепкий кофе, препараты кофеина, фенамин, крепкий чай с лимоном, цитраль, первитин и др. От применения фенамина и первитина следует воздержаться лишь у больных гипертонией и у стариков.

ОТРАВЛЕНИЕ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ

Отравление метиловым спиртом встречается редко, причем главным образом у лиц, злоупотребляющих суррогатами алкоголя, так как метиловый алкоголь применяется вместе с пиридиновыми основаниями для денатурирования спирта. Известны массовые отравления метиловым алкоголем у лиц, ошибочно принявших вместо этилового метиловый спирт.

Метиловый спирт является одним из наиболее токсичных спиртов. Жафруа и Серво (Jafroi и Serveau) установили в опытах на собаках и кроликах, что 9 мл 100% метилового спирта у собак и 10,9 мл у кроликов вызывали тяжелое отравление. При сопоставлении с действием этилового спирта оказалось, что метиловый алкоголь вызывает явления отравления гораздо позже, чем этиловый. В то время как этиловый спирт вызывает кому через 5—6 минут, метиловый спирт тот же результат дает через 15 или 30 минут. Однако явления отравления метиловым алкоголем носят более длительный характер. Например, если состояние отравления этиловым спиртом длилось всего 6 часов, то у животных, отравленных метиловым алкоголем, симптомы отравления обычно удерживаются не менее 3 дней. Выведение метилового алкоголя с мочой происходит значительно медленнее, чем выделение этилового спирта. Экспериментальное отравление метиловым алкоголем у животных давало следующую картину: нарушение деятельности центральной нервной системы, выражавшееся в виде зрительных галлюцинаций, судорожных феноменов, в параличах, нарушении рефлексов и чувствительности, в расстройствах в виде спонтанного нистагма, мидриаза, в нарушении теплорегуляции, быстром и резком снижении температуры у собак до 19°, у кроликов до 18°, в нарушении дыхания, ускорении его ритма и амплитуды с последующим уменьшением, граничащим с остановкой дыхания, причем сердце продолжало еще функционировать в течение 10—15 минут. Сердечная деятельность вначале замедлялась, а затем ускорялась, появлялись аритмия и наконец деятельность сердца прекращалась. Отмечалось расстройство пищеварительного тракта, гиперемия пи-

шевода, желудка и кишечника с кровоизлияниями и изъязвлениями.

Характерно, что картина хронического отравления метиловым алкоголем при даче его в небольшом количестве наступала гораздо быстрее, чем в случае приема этилового алкоголя. У собак она выражалась в моторном возбуждении, за которым следовала адинамия, а затем параплегия. Никлю вводил внутривенно 20% метиловый алкоголь животным. При этом понадобилось до 2 мл на 1 кг веса чистого метилового спирта, чтобы вызвать смерть животных, в то время, как при подобного рода внутривенных введениях этилового спирта эта доза увеличивалась до 7 мл. Метиловый алкоголь обладает кумулятивным свойством, он не так быстро окисляется и выводится из организма, как этиловый алкоголь.

Отравляющее действие метилового алкоголя обуславливается его медленным сгоранием в организме, а также вредным действием на ткани высвобождающегося при этом активизированного кислорода.

В организме человека метиловый алкоголь превращается в муравьиную кислоту, которая обнаруживается в моче отравленных. Отравление метиловым алкоголем почти всегда протекает остро и реже подостро. Хронических случаев отравления метиловым алкоголем не наблюдается вследствие крайне ядовитого его действия на организм. В течение первых суток после принятия метилового алкоголя появляются сильные головные боли, слабость, боли в животе, тошнота, рвота, снижается острота зрения, больные видят, как в тумане, и вскоре окончательно слепнут. Иногда они пробуждаются после тяжелого опьянения в состоянии полной слепоты. Нередко появляются тяжелые расстройства со стороны сердца. В начале опьянение метиловым алкоголем бывает выражено в умеренных степенях, а затем на 3—4-й день наступает состояние возбуждения, оглушенность, развивается тяжелое расстройство со стороны органов кровообращения и дыхания. Нередко наблюдаются судороги. Смерть наступает от паралича дыхания. От отравления метиловым спиртом погибает от 50 до 60% отравленных.

Специфичным для отравления метиловым алкоголем является поражение зрительного нерва. Соски зрительного нерва вначале гиперемированы, а затем, через 3 недели, начинается их атрофия. Даже небольшие дозы (7—10 мл) метилового алкоголя могут вызвать слепоту. Индивидуальная выносливость к метиловому алкоголю колеблется в широких пределах. Описаны случаи, когда большие дозы метилового алкоголя переносились без особого ущерба для здоровья.

Патологическая анатомия. При вскрытии обнаруживают резкую гиперемию мозга и его оболочек, а в тяжелых случаях отек мозга. Очень часто имеет место крово-

излияние в продолговатый мозг. Характерны изменения зрительного нерва.

Лечение. С. Я. Арбузов изучал на кроликах действие фенамина, коразола и их смесей по отношению к смертельным дозам метилового и этилового спирта и этиленгликоля (антифриза).

С. Я. Арбузов наглядно показал, что многократное введение фенамина и коразола — антагонистов наркотиков может купировать развивающееся отравление этиловым и метиловым спиртом и этиленгликолем, а также предупредить гибель животных. При всех вышеуказанных отравлениях наилучший терапевтический эффект был достигнут С. Я. Арбузовым при внутривенном введении фенамина, а при отравлении метиловым и этиловым спиртом — при введении смеси фенамина и коразола.

С. Я. Арбузов на основе своих экспериментальных данных горячо рекомендует антагонисты наркотиков — фенамин, коразол при отравлении метиловым и этиловым алкоголем у людей. Основываясь на личных наблюдениях, мы должны подтвердить благотворное действие фенамина и коразола на людей при остром отравлении как этиловым, так и метиловым алкоголем. Антидота метилового алкоголя пока не имеется. Лечение сводится к немедленному удалению из организма метилового алкоголя, который обычно удерживается в организме значительно дольше, чем этиловый алкоголь. Для этой цели промывают желудок и кишечник. Внутривенно вводят глюкозу с аскорбиновой кислотой или метиленовой синькой, производят люмбальную пункцию, повышают диурез, делают кровопускание и др. Весьма полезны фенамин или первитин, которые задерживают всасывание метилового алкоголя из желудочно-кишечного тракта в кровь. Во всех случаях отравления метиловым алкоголем внутривенно вводят 10—20% коразол по 1—3 мл.

Глава II

ХРОНИЧЕСКИЙ АЛКОГОЛИЗМ

Хронический алкоголизм был известен еще в глубокой древности. Гиппократ считал, что пьянство есть не что иное, как умышленное и самовольно вызванное сумасшествие. Хронический алкоголизм впервые подробно описан Магнусом Гусом в 1852 г.

С. С. Корсаков под хроническим алкоголизмом подразумевает совокупность расстройств, вызванных повторным, чаще всего долговременным употреблением спиртных напитков.

Крепелин считал хроническим алкоголизмом такое состояние, при котором алкоголь поступает в организм в то время, когда он не освободился еще от действия предыдущей дозы.

Ф. Е. Рыбаков рассматривал хронический алкоголизм как совокупность расстройств психических и физических, вызванных долговременным злоупотреблением алкогольными напитками.

Бонгеффер (Bonhoeffer) подчеркивал, что хронический алкоголизм есть не что иное, как патологическое влечение к алкоголю, причем яд поступает в организм тогда, когда еще действует предыдущая доза; но это не просто сумма однократных отравлений, а вторичная аутоинтоксикация, новое качество.

Е. Блейлер (E. Bleuler) указывал, что алкоголиком нужно считать всякого, кто употреблением алкоголя причиняет ущерб себе, своей семье, причем не удастся ему это втолковать или же у него нет силы воли исправиться.

По мнению Жислина, хронические алкоголики — это лица, испытывающие потребность в опохмелении, и лишение алкоголя вызывает у них синдром похмелья.

Как видно из всего изложенного содержание, вкладываемое Крепелином, Бонгеффером и Блейлером в понятие «хронический алкоголизм» расплывчато и недостаточно четко сформулировано. Более конкретно определение хронического алкоголизма, предложенное Жислиным; однако и оно не может

нас удовлетворить, потому что встречается немало хронических алкоголиков, не испытывающих потребности в опохмелении, у которых абстинентные явления не выражены или носят рудиментарный характер.

Хроническими алкоголиками следует считать лиц, испытывающих болезненное влечение к алкоголю, у которых вследствие длительного злоупотребления спиртными напитками появляются психические и соматические расстройства различной интенсивности, вначале обратимые, имеющие функциональный характер, но постепенно переходящие в необратимые органические расстройства.

Хронический алкоголизм отличается процессуальным течением. Наблюдаются случаи с благоприятным течением, излечимые и трудно излечимые, а также рецидивы болезни.

Известный интерес представляют проведенные нами экспериментальные исследования в отношении продолжительности действия средних доз алкоголя на психическую деятельность.

Исследуемые выпивали натошак в один прием 80—100 г чистого алкоголя, после чего через определенный промежуток времени подвергались ряду исследований: проверялась их ассоциативная деятельность, заучивались наизусть стихотворения, цифры, проводились счетные операции, вдевание нитки в иголку и т. п.

На основании многочисленных исследований мы установили, что 80—100 мл чистого этилового алкоголя, принятые натошак, отрицательно влияют на психические функции в течение 12—24 часов, а иногда даже 48 часов, в зависимости от индивидуальных свойств личности, тонкости и сложности испытания.

Позднее действие алкоголя субъективно ощущается по-разному, в зависимости от количества принятого напитка и от индивидуальных свойств исследуемого. Некоторые лица после приема 80 г алкоголя не отмечали снижения работоспособности, другие, принявшие 40 г алкоголя, указывали, что работоспособность нарушается на 5 часов. Некоторые лица, испытавшие влияние средних доз алкоголя лично на себе, отмечали его отрицательное действие в течение 18—36 часов. Они ощущали затруднение во время занятий и снижение работоспособности при специальных экспериментальных исследованиях. Если средняя доза алкоголя в 80—100 г принималась не сразу, а в течение некоторого времени, в 2—3 приема, то это на результатах наблюдений существенно не отражалось: сила и продолжительность действия алкоголя в обоих случаях были почти одинаковы. Решающим является общее количество выпитого алкоголя.

Срок отрицательного действия алкоголя несколько сокращается лишь тогда, когда после приема алкоголя съедают что-

либо или принимают его не натошак. Принятая пища ослабляет действие алкоголя.

Если учесть, что 80—100 г чистого алкоголя обычно действуют 24 часа и больше, то лица, выпивающие ежедневно по 0,5 л виноградного вина крепостью 16° или 1,5—2 л пива, или 200 г 40° водки, находятся в состоянии хронической алкогольной интоксикации. Вследствие создающегося привыкания уже через несколько недель регулярного потребления спиртных напитков отрицательное влияние алкоголя снижается. Вначале отмечается незначительное повышение окисления алкоголя в крови и более быстрое освобождение от него организма, хотя при определении алкоголя в крови у привыкших и не привыкших к нему значительной разницы не обнаруживается. Наряду с этим, длительное потребление алкоголя притупляет чувствительность к нему мозга. Однако необходимо помнить, что у всех алкоголиков рано или поздно в конце концов наступает невыносимость к алкоголю и они пьянеют от доз, которые раньше не вызывали у них даже легкого опьянения. Такая невыносимость к алкоголю может быть объяснена резким снижением защитных реакций организма, нарушением обмена веществ, недостаточным окислением алкоголя вследствие нарушения функциональной способности печени, что подтверждается наличием уробилиногена в моче и изменением сахарной кривой после сахарной нагрузки, повышенном билирубин в крови и т. д. Одновременно с этим отмечается повышенная чувствительность мозга к алкоголю, вызванная длительной алкогольной интоксикацией.

Клиническая картина. В легких случаях хронического алкоголизма больные имеют здоровый, свежий вид. Подкожножировая клетчатка у них хорошо развита. Иногда отмечается значительная тучность (главным образом при длительном употреблении пива); лицо алкоголика становится одутло-



Рис. 3. Одутловатость лица у больного хроническим алкоголизмом.

Клиническая картина. В легких случаях хронического алкоголизма больные имеют здоровый, свежий вид. Подкожножировая клетчатка у них хорошо развита. Иногда отмечается значительная тучность (главным образом при длительном употреблении пива); лицо алкоголика становится одутло-

ватым (см. рис. 3). Эту стадию многие авторы определяют как стадию ложной упитанности.

В тяжелых случаях алкоголизма один внешний вид больного часто указывает на его заболевание. Кожные сосуды на лице, особенно вены на носу и щеках, расширяются, вследствие чего кожа приобретает красновато-цианотичный оттенок. Иногда при этом наступает истощение, достигающее значительной степени, — развивается так называемая алкогольная кахексия. Пищеварение нарушается.

Наши исследования 105 алкоголиков, проведенные совместно с Прядко, показали, что у 95% больных имелся гастрит, из них у 19% — ахилия, у 52% — кислый катарр желудка, у 20% — острый гастрит, у 4% — другие желудочные заболевания; лишь у 5% больных не было обнаружено желудочных заболеваний; у 33% больных отмечались запоры, у 11% — поносы, у 5% — то запоры, то поносы; у 51% больных патологических явлений со стороны кишечника не отмечалось. Аппетит у алкоголиков понижен или отсутствует. Обычно в периоды обострения алкоголизма они едят мало. Язык сильно обложен. Наряду с этим, отмечается раздражение миндалин и гортани. Голос становится хриплым.

При хроническом алкоголизме наблюдаются сердечно-сосудистые изменения, выраженные в различной степени, которые в значительной мере коррелируют с тяжестью заболевания. Большинство фармакологов, патофизиологов, морфологов и терапевтов справедливо считает, что алкоголь является одним из наиболее сильно действующих средств, вызывающих тяжелые нарушения в сердечно-сосудистой системе (Н. П. Кравков, А. А. Кулябко, Ю. П. Лауденбах, А. П. Зиверт, П. Г. Бондарев, Н. И. Кульбин и др.).

При патологоанатомическом исследовании находили значительное отложение жира в области сердца, жировое перерождение сердечной мышцы, кровоизлияния в мышечную ткань (Н. И. Кульбин), скопление жировых капель в лимфатических щелях.

Ю. П. Лауденбах и А. П. Зиверт экспериментально показали на изолированном сердце кошки, что сердечная деятельность под влиянием алкоголя постепенно учащается. При промывании сердца нормальной питательной жидкостью деятельность его вскоре восстанавливалась. П. Г. Бондарев с экспериментальной целью вводил алкоголь кроликам и констатировал, что смерть у них произошла в результате паралича сердца. При исследовании нервных узлов и мышцы сердца найдено следующее: инфильтрация узлов и сердечной мышцы круглыми и веретенообразными элементами, кровеносные сосуды расширены, гиперемированы, в узлах и окружающих тканях имеются обширные кровоизлияния. При хроническом отравлении встречается инфильтрация тканей сердца круглыми и вер-

тенообразными элементами соединительной ткани в виде тяжей, распад отдельных мышечных волокон, утолщение стенок сосудов, жировое перерождение интимы.

К. О. Окмянский на основании своих работ пришел к выводу, что при остром отравлении алкоголем деятельность сердца у собаки и кролика ухудшается, что выражается в слабости и аритмии пульса, его учащении. Имеются изменения в первом аппарате сердца, выражающиеся в вакуольном перерождении нервных клеток.

Исследования А. А. Кулябко, Н. П. Кравкова, Багирова, Бока указывают на угнетающее действие алкоголя на изолированное сердце животных. В концентрациях 1 : 100 алкоголь вызывает резкое уменьшение амплитуды сердца. Большие дозы действуют парализующе на моторные ганглии и сердечную мышцу (Н. П. Кравков). Остановка сердца происходит в диастоле при пропускании через него сильных концентраций алкоголя (1 : 25) в течение 15 минут. Начальное ускорение ритма сердца под влиянием больших доз алкоголя сменяется замедлением ритма и, наконец, полным параличом сердца.

Некоторые ученые-патологоанатомы, советские (И. В. Давыдовский, А. П. Майсюк) и французские, склонны преуменьшать токсическое действие алкоголя, умаляя его значение в преждевременном развитии артериосклероза у людей, злоупотребляющих спиртными напитками. Утверждения этих авторов не подтверждаются ни клиническим изучением алкоголиков, ни экспериментальными исследованиями на животных.

При отравлении алкоголем у людей наблюдается изменение ритма сердца, учащение пульса, расширение периферических сосудов, расстройство терморегуляции и т. д. Хроническая же алкогольная интоксикация приводит к серьезным дистрофическим изменениям в сердечно-сосудистой системе, которые по тяжести патологических нарушений у разных людей выражены в различной степени, в зависимости от типологических особенностей и выносливости к алкоголю (Н. О. Богин, И. В. Стрельчук, О. П. Скорнякова). Многие больные, страдающие алкоголизмом, жалуются (даже в молодом возрасте) на неприятные ощущения в области сердца, на чувство сжимающей боли, одышку при физическом напряжении. Объективно у них наблюдается приглушение тонов сердца. При рентгеноскопии нередко отмечается вялая пульсация сердца, расширение и уплотнение аорты и т. д. (Н. О. Богин, О. П. Скорнякова). Нередко развивается тахикардия, которая сохраняется еще много дней после прекращения потребления алкоголя.

В состоянии опьянения отмечается напряжение тонов сердца, иногда систолический шум, объясняемый ослаблением митральных клапанов сердца. Эти явления нестойки и проходят через некоторое время по прекращении действия алкоголя.

У большинства больных алкоголиков сердце изменено и увеличено (рис. 5). При атеросклеротических изменениях, которые обычно наблюдаются после 40 лет и бывают довольно ярко выражены у больных хроническим алкоголизмом, клиническая картина со стороны сердечно-сосудистой системы нередко дополняется повышением кровяного давления, значительным акцентом на втором тоне аорты, ригидностью лучевых артерий. Миокардиодистрофия (рис. 4) выражена более резко у алкоголиков с повышенным питанием и в меньшей степени у лиц с ослабленным питанием (Н. О. Богин, И. В. Стрельчук, О. П. Скорнякова).

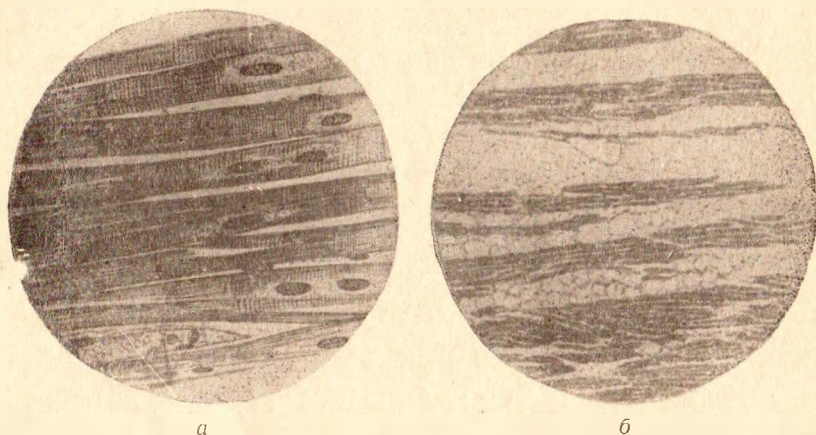


Рис. 4.

а — микроскопическое строение мышцы сердца в норме; б — жировая инфильтрация миокарда при алкоголизме.

Как видно из вышеизложенного, при хроническом алкоголизме поражается в основном сердечная мышца (миокардиодистрофия), а также сосуды (атеросклероз). При появлении симптомов атероматоза аорты и прочих кровеносных сосудов, как при повышенном, так и при нормальном кровяном давлении, поражение сердца идет по линии атеросклероза и определяется как миокардиосклероз. Иногда приходится наблюдать стойкие поражения нервного аппарата сердца, сопровождающиеся тахикардией, реже полным и глубоким нарушением ритма сердца. Декомпенсация со стороны сосудистой системы выражается в увеличении печени, отеках, одышке, явлениях апносемии и после соответствующего лечения обычно проходит, что может свидетельствовать о том, что резервные силы со стороны сердечно-сосудистой системы, несмотря на хроническое отравление алкоголем, еще могут быть сохранены в достаточной степени.

Крепелин считает алкоголь одним из важных факторов в развитии артериосклероза мозга. Из всех больных артериоскле-

розом мозга, которых пришлось наблюдать Крепелину, 71,5% оказались мужчинами, причем 47% из них были алкоголиками. И. В. Давыдовский, напротив, не видит в алкоголе фактора, вызывающего артериосклероз. Однако следует иметь в виду, что у многих алкоголиков наблюдается описанная М. О. Гуревичем вазопатическая церебрастения, в основе которой лежит нарушение сосудистой иннервации. Синдром вазопатической церебрастении выражается в сосудистых измене-

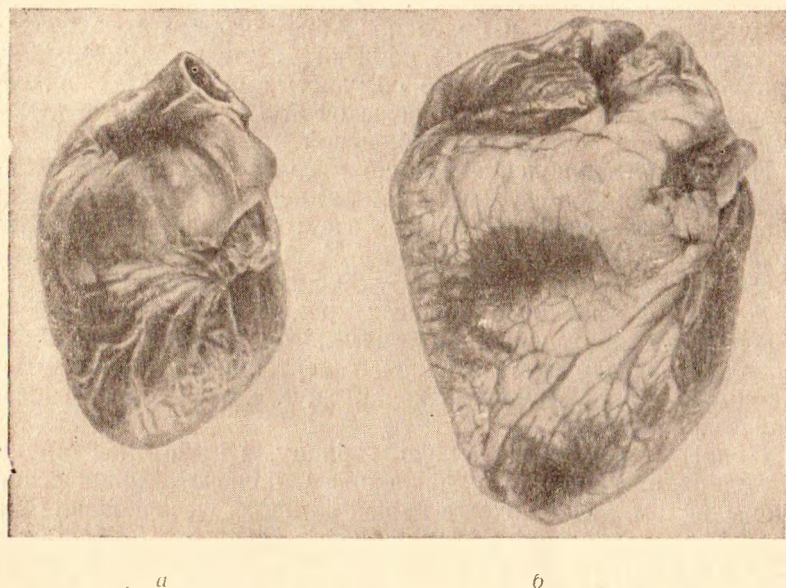


Рис. 5.

а — сердце в норме; б — сердце, болезненно измененное при хроническом алкоголизме.

ниях в виде лабильности вазомоторов, приливов крови к голове, головных болей, головокружения, неустойчивости при закрытых глазах, а зачастую в повышении кровяного давления, держащегося в умеренных границах. Наряду с этим, отмечается повышенная утомляемость, ослабление памяти, быстрая истощаемость, нетерпеливость, слабодушие. Вазопатическая церебрастения сходна с артериосклерозом головного мозга, однако она является обратимым синдромом. Все указанные явления после лишения больных алкоголя и соответствующего лечения смягчаются или исчезают совсем, что указывает на отсутствие здесь органической основы.

Концепция М. О. Гуревича о вазопатической церебрастении отчасти разрешает те противоречия, которые до сих пор существуют между клиницистами, указывающими на развитие ран-

него артериосклероза у алкоголиков, и некоторыми патологоанатомами, подчеркивающими, что артериосклероз мозга у алкоголиков встречается не так часто. Вазопатическая церебрастения дает клиническую картину, сходную с таковой начальной формы артериосклероза мозга, но трудно обнаруживается существующими патологоанатомическими методами исследования. Вследствие наличия клинических симптомов, сходных с начальными степенями артериосклероза мозга, многие клиницисты неправильно истолковывают ее как ранний склероз сосудов мозга.

Однако в среднем и более пожилом возрасте у алкоголиков, потребляющих спиртные напитки в течение многих лет, появляются уже необратимые сосудистые расстройства в виде атеросклероза мозга, гипертонической болезни, которые в молодом возрасте составляют небольшой процент.

По нашим наблюдениям, количество сосудистых заболеваний у алкоголиков значительно возрастает в соответствии с повышением возрастных показателей: в возрасте 30—35 лет эти заболевания встречаются в 2—3% случаев, 40—45 лет — в 15%, 50—55 лет — в 25%, 56—59 лет — в 39%.

У 18—20% из числа больных хроническим алкоголизмом наблюдается повышение артериального давления, носящее вначале характер транзиторной гипертонии, которая затем принимает более устойчивый характер, т. е. переходит в гипертоническую болезнь.

Приведем нижеследующую таблицу, из которой видны колебания артериального давления у больных хроническим алкоголизмом, лечившихся в нашей клинике. Исследования артериального давления проводились терапевтом клиники И. О. Богиним.

Возраст в годах	Число обследованных больных хроническим алкоголизмом	Нормальные колебания артериального давления в этом возрасте	% больных, у которых обнаружена гипертония	Средняя величина артериального давления в мм ртутного столба
18—29	40	100/70 — 130/80	2,5	170/95
30—35	82	110/80 — 140/90	2,4	180/100
36—39	86	115/75 — 145/85	9,3	185/105
40—45	98	120/80 — 145/95	15,3	200/110
50—55	59	120/90 — 150/95	25,4	225/125
60—70	7	130/100 — 160/100	42,8	280/165

Как видно из приведенной таблицы, количество заболеваний гипертонией у больных хроническим алкоголизмом неуклонно возрастает в связи с повышением возрастных показателей и одновременным увеличением как систолического, так и диастолического кровяного давления, что несомненно имеет прямую связь с развитием атеросклеротических процессов.

Больные-алкоголики, у которых наблюдалось повышение кровяного давления, испытывали боли в голове, давление в области висков и затылочной области, одышку. Сердце у них обычно было увеличено в размерах, аорта расширена, тоны сердца напряжены. Отмечался значительный акцент на втором тоне аорты. Лучевые артерии на ощупь всегда ригидны. Нередко отмечается заметная пульсация лучевых и височных артерий.

При резко выраженной сосудистой гипертонии и при исследовании глазного дна отмечалась извилистость кровеносных сосудов, а иногда явления папиллоретинита. Следует отметить, что большинство исследованных злоупотребляло также курением табака, к которому они питали не меньшее пристрастие, чем к алкоголю. Почти все больные, у которых хронический алкоголизм осложнялся гипертонической болезнью, продолжали работать. Следует отметить, что при воздержании от алкоголя, а также при соответствующем лечении в случаях даже очень высокого кровяного давления к концу курса терапии наступало значительное снижение кровяного давления, а в части случаев, где имела место только транзиторная гипертония, оно нормализовалось.

Можно всегда установить известную взаимосвязь между алкогольной интоксикацией и гипертонией. Одним из профилактических мероприятий при гипертонии является полное воздержание от алкоголя.

Значительные нарушения под влиянием алкогольной интоксикации наблюдаются со стороны печени, на что обращали внимание еще старые клиницисты. А. Л. Мясников, Е. М. Тареев, Вильям Ослер и др. считают алкоголь одной из причин, вызывающей заболевания печени. Нарушения вначале носят функциональный характер и обратимы, если больные воздерживаются от дальнейших приемов алкоголя (Бинсвангер, И. В. Стрельчук, К. Полиш и др.). Если же больные продолжают злоупотреблять алкоголем, наступают органические, уже труднообратимые и необратимые изменения в печени. Обычно хроническое отравление алкоголем вначале вызывает острый алкогольный гепатит, клинически выражающийся в некотором увеличении печени вследствие гиперемии, воспалительной инфильтрации в мезенхимных образованиях и жировой инфильтрации в паренхиме печени.

Острый алкогольный гепатит может постепенно перейти в хронический и закончиться циррозом печени. Вследствие длительного воздействия алкоголя на печеночные клетки образуются реактивно-воспалительные инфильтраты с последующей организацией соединительной ткани, которая имеет большую склонность к сморщиванию и рубцеванию. В результате этого развивается цирроз печени, который в основном сводится к следующему: а) прогрессивное уменьшение объема печени

вследствие атрофии паренхимы и сморщивания мезенхимы; б) застойные явления в воротной вене со всеми вытекающими из этого последствиями. При этом постепенно у больного может развиваться общее резкое исхудание; желтуха присоединяется очень редко. Продолжительность заболевания — 2—3 года. Смерть наступает при явлениях печеночной недостаточности (кома).

На вскрытии печень алкоголиков плотна, полнокровна (рис. 7), хрустит при разрезе.

Микроскопически при этом наблюдается резкая гиперемия капилляров. В печеночных клетках определяется мутное на-

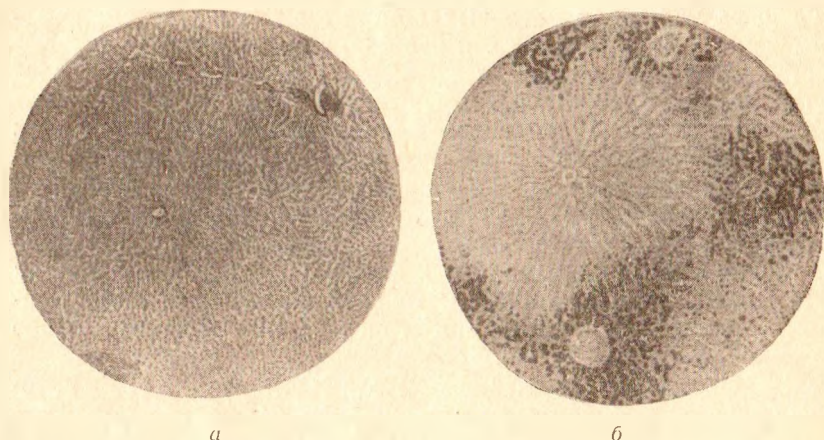


Рис. 6.

а — микроскопическое строение нормальной печени; б — очаговая жировая инфильтрация печени при алкоголизме.

бухание, зернистость, вакуоли, пигментация, жировая инфильтрация (рис. 6); местами имеется атрофия с новообразованием соединительной ткани вокруг измененных печеночных клеток. В местах схождения долек сильная инфильтрация соединительнотканными элементами. В общем наблюдается картина лобулярного интерстициального гепатита. А. П. Майсюк находила у 95% алкоголиков выраженную жировую инфильтрацию печени. У всех без исключения обнаруживалось резкое атипическое строение печеночных долек и атрофия клеток, грубые дистрофические и некротические процессы, представляющие собой первую стадию цирроза печени (рис. 8).

Почти во всех случаях хронического алкоголизма в той или иной степени нарушается функция печени. Углеводный обмен изменяется, повышается гипергликемический индекс в ответ на сахарную нагрузку; ослаблена реакция на введение адреналина; наблюдается патологическая реакция в ответ на двойную нагрузку глюкозой. Эти патологические нарушения

функции печени идут параллельно с повышением белкового и водно-солевого обмена, выражающегося в ряде патологических моментов. Укажем на главные из них по линии водно-солевого обмена, непосредственно зависящие от работы печени. Здесь мы находим следующие нарушения: а) задержку хлористого натрия в тканях; б) гидрофильность самих тканей; в) нарушение барьерной функции печени, которое играет значительную роль при хроническом алкоголизме. Под влиянием алкоголя нарушается ресинтез молочной кислоты: у здоровых людей, по Меергофу, $\frac{1}{6}$ — $\frac{1}{3}$ часть образованной молочной кислоты сгорает, окисляется до углекислоты и воды, а основная часть подвергается ресинтезу в гликоген. Но у больных хроническим алкоголизмом ресинтезу подвергается только около половины всей образованной молочной кислоты. Вследствие снижения щелочного резерва повышается ацидоз крови. Ввиду потери печенью способности окислять молочную кислоту, последняя задерживается в крови. Содержание билирубина повышено свыше чем у 50% исследованных нами больных хроническим алкоголизмом, содержание холестерина понижено и колебалось в пределах от 80 до 120 мг%; все это явно свидетельствует о наличии функциональной недостаточности печени.

По излечении алкоголизма эти расстройства хотя полностью и не проходят, так как полная реституция печени не достигается, однако в основном работа ее восстанавливается.

Клинически заболевание печени у больных хроническим алкоголизмом проявляется в следующем: наблюдается гидрофильность тканей, выражающаяся в отечности, особенно лица, а иногда и конечностей, при отсутствии явлений декомпенсации сердца. При исследовании печень всегда болезненна, более или менее увеличена. Склеры обычно имеют желтушную окраску. Наблюдалось вздутие кишечника и метеоризм, которые являются постоянными спутниками заболевания печени и служат прямым подтверждением нарушения резорбтивной способности ее при алкоголизме. Чем тяжелее форма алкоголизма, тем резче выражены все эти явления. У ряда больных тяжелыми формами хронического алкоголизма, поступающих на стационарное лечение, отмечается синдром, соответствующий острому гепатиту, что клинически проявляется в потере аппетита, тошноте, рвоте, диспептических явлениях, болезненных ощущениях в подложечной области и в области правого подреберья.

Объективно при этом отмечается резко обложенный язык, увеличение и болезненность печени, субиктеричная окраска склер, уробилин и следы белка в моче, нередко субфебрильная температура. Молочно-растительная диета, применение в качестве слабительного сернокислой магнезии обычно в течение нескольких дней снимают острые явления; но увеличение пе-

чени еще остается долгое время. При хроническом алкоголизме вследствие изменений печени резко расстраивается обмен веществ. Нейтрализующая функция печени ослабевает. Организм алкоголика наводняется токсическими недоокисленными продуктами — наступает ацидотический сдвиг.

Относительно поражения почек у алкоголиков взгляды расходятся. При вскрытиях находят гипертрофированную почку в 2—13% случаев. Серьезные изменения в последнее время находили со стороны желез внутренней секреции, в частности, обнаруживали атрофию коры надпочечников, атрофию инсулярного аппарата поджелудочной железы, изменения в половых железах, жировое перерождение и запустение тканей в яичниках.

А. А. Богомолец считал алкоголь одним из факторов, способствующих развитию рака. Отмечается причинная связь хронического алкоголизма и пеллагры, которая развивается у алкоголиков в результате расстройства питания, обеднения организма витаминами, нарушения обмена веществ и т. п.

Алкоголь является также одним из важных факторов, вызывающих невриты.

А. Б. Коленко, исследовавший 1100 алкоголиков, находил у них изменения глазного дна в виде гиперемии соска зрительного нерва и небольшого расширения сосудов. В более поздних стадиях отмечалось побледнение височных половин соска зрительного нерва и даже атрофия его (до 12%).

У алкоголиков отмечается пониженная сопротивляемость к инфекциям. Нам неоднократно приходилось наблюдать, как грипп, занесенный кем-либо в больницу, вызывал среди находящихся в ней больных массовые заболевания с затяжным течением.

Одним из характерных признаков хронического алкоголизма является дрожание пальцев рук, которое особенно ясно выражено по утрам, до опохмеления. В тяжелых случаях дрожание бывает настолько сильным, что больной не может выполнять свою работу, если она связана с тонкими и точными движениями (часовщики и др.). Такие алкоголики вместо того, чтобы прекратить употребление алкоголя, перед работой принимают его, после чего дрожание на некоторое время проходит. Некоторые больные могут усилием воли несколько подавлять его. Однако этот симптом не имеет специфического значения, так как он нередко встречается и при неврозах.

Алкоголики обычно выглядят старше своих лет. Преждевременное одряхление — частый спутник алкоголизма. Специалистами, работающими по проблеме старости, установлен ряд изменений, наступающих в организме человека по мере его постарения. Изменения эти — нервно-психические, биохимические и морфологические. Большой интерес представляют исследования А. Ламаша, Давот и Делялод (А. Lamache,

Davost и Delalaude), которые тщательно исследовали 297 алкоголиков в возрасте от 20 до 45 лет. Из них 201 выглядели определенно старше своего возраста по внешнему виду. Уже внешний облик больных говорит о преждевременном одряхлении организма: землистый цвет кожи, потеря ею эластичности, ломкость ногтей, преждевременные морщины и пр. Со стороны сердечно-сосудистой системы отмечается артериосклероз, который особенно часто обнаруживается при исследовании глазного дна. Заметно понижается основной обмен с уменьшением количества мочевины в крови и холестерина.

Электрокардиограмма, измерение жизненной емкости легких и двигательных функций также определению указывали на преждевременное, не по возрасту, постарение у всех обследованных. Одним из характерных объективных признаков эти авторы считают удлинение скрытого времени реакции на различные раздражители — зрительные, слуховые и тактильные.

Впрочем, иногда алкоголики выглядят моложе своих лет. В таких случаях они бывают инфантильны как по телосложению, так и по психическому складу.

Среди многих наблюдаемых нами больных у 28% мы находили расстройство половой деятельности, чаще ејасulatio ргаесох или полную импотенцию. В период опьянения иногда бывает некоторое возбуждение полового чувства, но с последующим понижением в абстинентные промежутки. Половое влечение обычно повышено и держится долго даже у лиц с угашенной потенцией.

Больные хроническим алкоголизмом нередко жалуются на парестетические ощущения, рвущие, тупые боли в разных частях тела, преимущественно в нижних конечностях. При этом нередко встречаются явления выраженного полиневрита. Отмечается болезненность нервных стволов; имеются изменения кожной чувствительности, сухожильных рефлексов, реакция перерождения мышц и др.

Проводимые А. Н. Зиминим исследования показывают, что со стороны нервной системы при хроническом алкоголизме чаще всего бывают изменения невритического, полиневритического характера и со стороны вегетативной нервной системы.

Одновременно с соматическими расстройствами у алкоголиков наблюдается ряд психических изменений. Последние развиваются постепенно и в значительной мере в зависимости от типологических особенностей больного, количества, качества и характера потребления алкоголя. Экспериментально доказано, что в один час окисляется не свыше 10 мл алкоголя. Следовательно, лица, потребляющие ежедневно 250 мл 96° этилового спирта, непрерывно находятся под вредным воздействием алкоголя и продуктов его окисления (ацетальдегид,

уксусная, муравьиная кислота, метилглиоксаль и т. д.), которые, быть может, оказывают еще более пагубное влияние на организм, чем алкоголь.

Изменения со стороны психической деятельности обычно обнаруживались методами экспериментально-психологического исследования.

Следует сказать, что указанные методы носят описательный характер и пользование субъективно-психологической системой понятий не дает возможности вскрыть нервные механизмы этих нарушений. Многовековое пользование системой субъективно-психологических понятий показало полную ее несостоятельность, так как на основе этой системы понятий не было установлено закономерностей и психология оказалась дисциплиной, не сумевшей вскрыть внутренние законы тех явлений, которые она изучает.

Вместе с тем с нашей точки зрения было бы неправильно совершенно игнорировать результаты исследований, накопленные экспериментальной психологией. И в настоящее время в своей работе мы вынуждены пользоваться материалом многочисленных экспериментальных психологических исследований по алкоголизму. Но отметим, что экспериментальные психологические работы в области алкоголизма правильно могут быть поняты лишь в свете учения И. П. Павлова.

В настоящее время медицина уже приближается к постепенному раскрытию нервных механизмов все большего и большего своеобразия реакций, присущих данной категории больных. Мы считаем нужным представить некоторые факты психологического исследования, полагая, что читатели, вооруженные данными изучения физиологии и патофизиологии высшей нервной деятельности человека, подойдут к рассмотрению этих материалов с позиций павловского учения и внесут свой вклад в отношении правильной интерпретации этих материалов и рационального их использования.

Экспериментально-психологическими исследованиями обнаружено, что даже в легких случаях хронического алкоголизма имеется снижение интеллектуальных функций. Восприятие внешних впечатлений носит поверхностный характер. Память в отношении прошлых событий и наблюдательность значительно ослабевают. Способность запоминания также ослаблена, главным образом страдает репродукция. Это можно объяснить тем, что у больных хроническим алкоголизмом нарушается способность приобретать новый опыт.

Новые условные связи замыкаются с трудом, они непрочны, отличаются хрупкостью. Задания выполняются небрежно, что объясняется понижением сосредоточенности. Концентрация внимания при выполнении сложного задания ниже, чем у здоровых. Продуктивность работы также меньше, чем в норме, вследствие быстрой функциональной истощаемости

корковых клеток. Среднее время реакции при исследовании свободных ассоциаций замедлено. При исследовании ассоциаций на абстрактные понятия скрытый период ответной речевой реакции больше, чем у здоровых лиц. Исследование при помощи ассоциативного эксперимента обнаруживает поверхностную однотонность, стереотипность ответов; преобладают ответы, в которые включаются слова: «есть», «бывает», ответы в рифму, эхолалические, созвучные, многословные ответы (В. С. Светлов, З. Л. Синкевич, И. В. Стрельчук). Все это можно объяснить торможением более молодых и более сложных речевых реакций, приобретенных на более поздних ступенях онтогенетического развития и растормаживанием более старых речевых реакций. Больные быстро утомляются вследствие повышенной истощаемости корковых клеток и очень легко развивающегося у них запредельного торможения. Они часто не в состоянии разобраться в сложных вопросах. Алкоголики могут логично рассуждать, строить планы, внести много как будто полезных предложений, но новое уже воспринимают и усваивают слабо. Часто их показная деловитость оказывается пустой болтовней. Обычно они придерживаются старой, привычной для них рутины и долгое время еще могут сравнительно хорошо справляться со своими профессиональными обязанностями и даже пользуются репутацией хороших работников. Способность к творческой работе снижается или совсем утрачивается. Постепенно круг их интересов суживается, теряется интерес к работе, к семье; они целиком отдаются своей болезненной страсти, на которой сосредоточивают все свои мысли. Другие интересы и заботы отодвигаются на задний план. Больные становятся рассеянными, забывчивыми, нередко испытывают головные боли, физическую слабость и т. п. Они часто страдают бессонницей и для того, чтобы уснуть, на ночь принимают алкоголь. Критика ослабевает.

Лживость — характерная черта многих алкоголиков.

Сравнивая анамнез больных, полученных от близких им людей, с анамнезом, полученным из уст самого больного, мы нередко убеждались в том, что больные грубо искажают действительность при изложении фактов из своей жизни.

Эмоциональная сфера алкоголиков претерпевает ряд характерных изменений, но указания старых авторов на «нравственное огрубение», «этическое вырождение», «притупление более тонких чувств» у алкоголиков несколько односторонни. Иногда алкоголики очень тонко реагируют на плохое и хорошее, проявляют отзывчивость, добросердечность, чуткость и благородство, но, наряду с этим, в состоянии опьянения они могут быть грубыми, бесчеловечными, дикими, жестокими, особенно в своей семье. Больные, которые на работе, в лечебном учреждении производят впечатление воспитанных, скромных, отзывчивых, высококультурных людей, считаются непло-

хими работниками, в семье проявляют себя совершенно в другом свете.

Для иллюстрации приведем выдержку из письма жены алкоголика, имеющего высшее образование, внешне гуманного, культурного человека, который зарекомендовал себя в лечебнице и среди больных как чуткий, отзывчивый, внимательный товарищ. Жена его пишет: «Поверьте, доктор, я измучилась с ним. Шесть лет ежедневно я вижу его пьяным. Когда он бывает пьян, то обращается со мной ужасно грубо, по-зверски. Он выгоняет меня из дому ночью в мороз буквально в одной сорочке и запирает двери. Бьет меня кулаками по голове и лицу. Швыряет в меня чем попало: палками, камнями, молотками, ножами, грозит убить. Но должна сказать, что когда он не пьет, тогда он прекрасный человек».

Алкоголики, будучи в состоянии опьянения грубыми, бездушными, безрассудными, в период воздержания становятся заботливыми, внимательными и проявляют не только интерес к работе, но и повышенную работоспособность, почему многие из них и пользуются репутацией прекрасных работников.

Наряду с этим, имеется группа алкоголиков, которые впитывают все дурное, перенимая от окружающих лишь отрицательные черты. У таких людей грубость становится неотъемлемой чертой характера.

Приведем письмо сестры больного А., страдавшего тяжелым хроническим алкоголизмом, характеризующее поведение такого человека. «Мы, мать и сестра больного А., просим главного врача больницы выдать нам справку о состоянии здоровья больного, так как совместное проживание с ним семьи становится невозможным. Посему мы вынуждены просить соответствующие органы об его изолировании. Если он окажется психически больным, то его должны поместить в соответствующий санаторий или колонию; если же он окажется нормальным, мы подадим на него в суд и пусть он ответит за свои хулиганские поступки, за истязание семьи. В последнее время он угрожает нам и в трезвом виде, а при запое приводит свои угрозы в исполнение. Меня и мать он принимался бить три раза. Мать душил, а я ее отбила. Сколько бы он ни пил, все время ругается, кричит, бросает вещи, стучит к нам в двери, называет площадными именами. Ходит по квартире голым, оправляется в комнате на пол. Угрожает поджечь квартиру, убить нас, сбросить с балкона. Так как комнаты у нас смежные, то мы вынуждены сидеть взаперти, часто без обеда. Помимо нас, в квартире живут еще две семьи, и они тоже не имеют покоя».

Наряду с этим, встречаются лица с инфантильной психикой, которые бывают крайне раздражительны, капризны, малорассудительны. Особенно резко это бросается в глаза в лечебном учреждении. Часто отказ таким больным в свидании

с родственниками или в отпуске в город вызывает у них слезы, плач, нарекания. Они впадают в крайнюю степень возбуждения, требуют выписки, грубят персоналу. Вскоре возбуждение сменяется смирением, они просят простить их, бесконечно извиняются.

С. М. Родионов указывает, что некоторые алкоголики отличаются наивностью суждений, граничащей с детской психикой. И. Н. Маркусевич считает, что алкоголь, введенный в организм хронических алкоголиков, выявляет характерную для них черту—психический инфантилизм, обусловленный параличом задерживающих центров. Как показали исследования Е. М. Жудро, инфантильность психики является следствием торможения—торможением условных реакций, приобретенных на более позднем этапе онтогенетического развития, и растормаживанием условных реакций, образованных на ранних ступенях онтогенеза. Инфантильность психики, легкомыслие, поверхностность суждения, недостаточность критики проходят после длительного лечения. Аффективная сфера алкоголика характеризуется неустойчивостью. У него отмечается резкая смена чувств, повышение аффективной окраски всех переживаний. Алкоголик может убиваться тем горем, в которое он поверг свою семью, тяжело переживать семейные и служебные неприятности, проливать слезы над своей «плачевной судьбой», но тут же, буквально через несколько минут, за кружкой пива или за стопкой водки он будет веселиться, петь, шутить. Наряду с этим, если его «расстроит», он может впасть в ярость, бить посуду, ломать мебель, наносить оскорбления словами и действием.

Присущая многим алкоголикам эйфорическая окраска аффективности позволяет им не замечать того зла, которое они причиняют себе и своей семье. Больные крайне легкомысленны, поверхностно смотрят на жизнь, подчас совершенно не замечая своего морального падения. Алкогольная эйфория может держаться долго, в течение первых 2—3 месяцев воздержания от алкоголя, сменяясь крайней раздражительностью и пониженным настроением, которые охватывают больного, когда он начинает разбираться в своем положении. Нужно сказать, что алкогольная эйфория и легкомыслие многих алкоголиков являются одним из факторов, вызывающих у них рецидивы. Находясь даже в крайне тяжелом положении, алкоголики отличаются тщеславием. Они хвастают своей работоспособностью, количеством романов, своими пьяными похождениями. Эта черта их характера особенно ярко выступает в закрытом лечебном учреждении. Больные бравируют перед своими соседями огромным количеством выпитого ими вина, смакуют разные сорта водок, наливок, ликеров, вин. Отражается это и в их сновидениях. Алкоголик видит во сне, что он покупает вино, ворует его, пьянствует и т. п. Впоследствии после серьезного

психотерапевтического лечения сроком не менее одного месяца изменяется и содержание снов. Больным снится, что они угощают вином, но сами не пьют, что их угощают, но они отказываются от вина. Такие сны являются благоприятным прогностическим признаком.

Одна из характерных черт алкоголика — слабоволие, которое выражается главным образом в болезненной страсти к алкоголю. Несмотря на сохраненный интеллект и подчас ясное понимание недопустимости своего поведения, алкоголик остается верен своей страсти. Допуская прогулы на производстве или являясь на работу в пьяном виде, он дает торжественное обещание администрации и общественным организациям исправиться, но буквально через несколько дней или недель нарушает свою клятву. Выдержка у него отсутствует. Он легко меняет работу. Мы знаем много случаев, когда алкоголик в течение года менял до десятка мест, а нередко менял и профессию. Способность суждения у таких больных ослаблена; они живут настоящим, не задумываясь о будущем. Поступки и стремления алкоголика лишены постоянства вследствие неустойчивости аффектов.

В согласии с другими авторами мы считаем алкогольный юмор специфической чертой алкоголиков. Особенно резко выражен алкогольный юмор, как это установила Е. М. Жудро, при тяжелых формах хронического алкоголизма. Крепелин даже в алкогольном опьянении видит зачатки алкогольного жора. Другие авторы не считают эту черту специфической для алкоголиков, относя ее за счет их характерологических особенностей. Алкоголь, по мнению этих авторов, будто бы играет роль лишь фактора, заостряющего индивидуальные черты характера. Наши наблюдения над большим количеством больных свидетельствуют о том, что алкоголь, в конце концов, нивелирует тип высшей нервной деятельности больных хроническим алкоголизмом, вследствие чего многие алкоголики характерологически очень похожи друг на друга. Некоторые индивидуальные различия имеются лишь в связи с онтогенетическим развитием, полученным образованием, профессией и др.

Падение интеллекта может быть в некоторых случаях настолько значительным, что многие авторы ставят вопрос о ясно выраженном алкогольном слабоумии, хотя специфичность такого оспаривается.

Л. М. Асатиани, проводившая тщательное исследование интеллектуальных функций у хронических алкоголиков, пришла к выводу, что у них отмечается общая картина интеллектуального снижения, включающая расстройство всех интеллектуальных функций с преимущественным поражением внимания и памяти, причем эти расстройства выражены в средней степени.

Ввиду невысокой выраженности интеллектуальных расстройств у алкоголиков Л. М. Асатиани отрицает у них наличие алкогольного слабоумия. Мы наблюдали явления алкогольного слабоумия лишь у очень незначительного числа больных, неоднократно перенесших алкогольные психозы, главным образом у пожилых лиц.

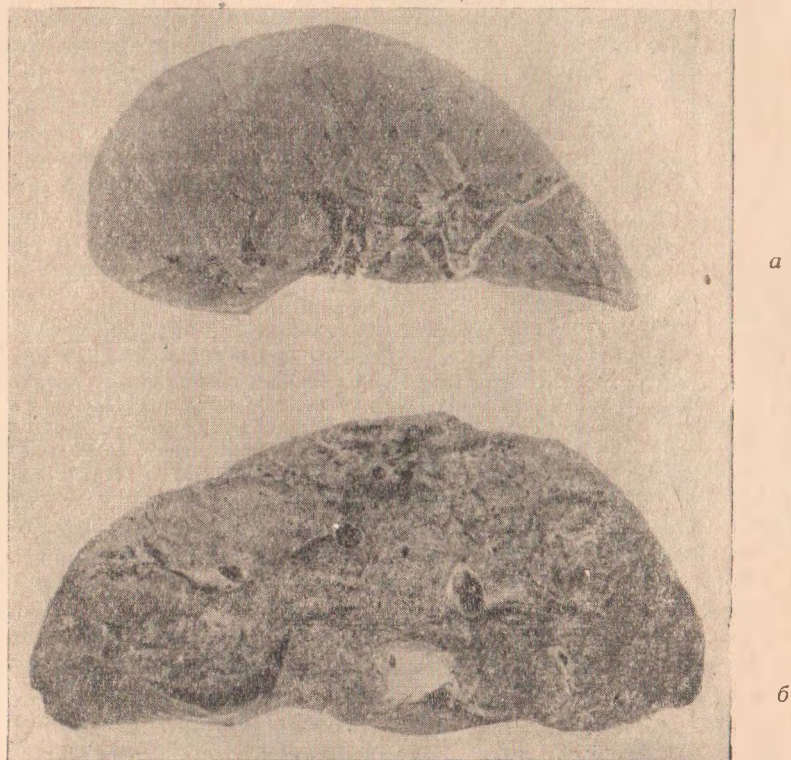


Рис. 7.

а — нормальный вид печени; б — жировое перерождение печени при алкоголизме.

Иногда длительное отравление алкоголем ведет к более глубоким изменениям личности. Такие больные (тяжелыми формами хронического алкоголизма) деградируют и опускаются по общественной лестнице все ниже и ниже, теряют свой прежний облик. Они пьют алкогольные напитки и их суррогаты в любое время и по любому поводу и причиной своего пьянства считают расстройство в связи с неудачно сложившейся жизнью, ссорами, конфликтами на работе и т. п. Некоторые из таких больных крайне грубы, циничны, придираются к мелочам. Они крайне требовательны к домашним, об-

виняют жену (или мужа) в распутстве, цинично бранятся, на глазах у детей вынуждают жену к половому акту, агрессивны, бросают в жену чем попало. На подобного рода алкоголиков падает немало обвинений в хулиганстве, побоях, убийствах (чаще всего жен), в сексуальных правонарушениях. Грубость, эгоцентризм, деспотизм, проявляемый в семье, склонность к разрушительным, агрессивным действиям, аморальное поведение, хвастовство, лживость, переоценка своей личности, своих сил, отсутствие импульса к труду — характерные черты больных этой группы. Наряду с этим, есть другая группа больных, которые в связи с беспробудным пьянством обнаруживают другие характерологические изменения личности: черты полной пассивности, безволия, слабодушия со склонностью к самоунижению, с боязливо робким отношением к жене, родным. Они пытаются стащить из дому последние ценные вещи, деньги, для того чтобы напиться и провести время в грязной прокуренной пивной, в грубой компании собутыльников, перед которыми они изливают душу и со слезами бичуют себя с тем, чтобы потом вернуться домой с повинной головой и безропотно принимать упреки, а иногда и побои жены. В таких случаях, помимо приобретенных характерологических свойств, обычно проявляется значительная степень социальной деградации, обусловленной влиянием соответствующего окружения, с тенденцией к паразитическому образу жизни, нищенству, мелкому воровству и другим правонарушениям, указывающим уже на начинающееся слабоумие. Такие больные погружаются в пассивно-инертное состояние, живут как бы вне времени и пространства, сегодняшним днем, не заглядывая в будущее, компенсируя образовавшуюся душевную пустоту иллюзорными образами прошлого.

К числу важных симптомов алкогольной деградации относится потеря импульса к труду. Это можно отчасти объяснить быстрой функциональной истощаемостью корковых клеток в результате тяжелой алкогольной интоксикации. В таких случаях алкоголики часто становятся прогульщиками, меняют места работы и даже профессию, они теряют вкус к труду, их тяготит даже случайная работа. Они пропивают все свое имущество, затем переходят на иждивение жеп, родственников или просят милостыню, а иногда совершают и антисоциальные поступки с целью добыть средства на вино. Такие больные стремятся попасть в психиатрические больницы, санатории, специальные лечебницы. По выписке из санатория нередко наступает рецидив; больные попадают вновь в лечебницу, а оттуда в колонию и т. д. Психиатрическая больница их не тяготит, и они стремятся пробыть в ней подольше, часто симулируя галлюцинации, соматические заболевания и т. д.

Довольно частым симптомом хронического алкоголизма является подозрительность, недоверчивость. Блейлер считает,

что «сильная аффективность при неясном мышлении порождает у алкоголиков болезненную склонность все относить к себе», что служит одним из факторов алкогольного недоведения. Больному кажется, что если он идет по улице, все на него смотрят, указывают на него пальцами и говорят: «Вот прошел алкоголик, пьяница». Кто-то хочет схватить его сзади, погнаться за ним. Он считает себя лишним, самым плохим человеком. Настроение его понижено. Зачастую у такого больного возникают суицидальные мысли, нередко завершающиеся самоубийством. У 11,4% лечившихся у нас больных отмечались суицидальные попытки, у 25% — суицидальные мысли. Суицидальные попытки совершались главным образом в состоянии опьянения и похмелья (рис. 8).



Рис. 8. Рубцы на передней поверхности шеи после попытки больного хроническим алкоголизмом перерезать себе горло.

Особенно тяжело протекает хронический алкоголизм у женщин, у которых заболевание прогрессирует гораздо скорее мужчин. Это объясняется тем, что алкоголизм у них чаще всего возникает на неполноценной почве — при наличии психопатии, невропатии и других нарушений психики. В качестве примера тяжелых форм хронического алкоголизма я позволю себе привести две истории болезни, представленные нам Е. М. Жудро.

Больной Д., 1908 г. рождения. Никаких жалоб не предъявляет. Отец злоупотреблял спиртными напитками, но никогда не считался алкоголиком. Умер от неизвестного заболевания в 1939 г. Брат отца умер от запоя. В остальном наследственность без патологических отклонений.

Родился в обеспеченной семье первым по счету; вскармливался грудью матери. Рос и развивался нормально. Был спокойным, послушным ребенком. В возрасте 8 лет начал учиться в школе. Учение ему давалось легко — переходил из класса в класс; окончил девятилетку. В 1923 г. поступил в машиностроительный техникум. По характеру оставался спокойным, выдержанным. Техникум окончил в 1926 г. В 1927 г. поступил на завод. С работой успешно справлялся. В 1928 г. поступил на электrozавод в качестве нормировщика. Одновременно учился в вузе. Половая жизнь с 19 лет. В 1928 г.

женился, через год разошелся («не сошелся характером»). В 1929 г. женился вторично. С 1930 г. начал выпивать в компаниях, в связи с семейными событиями, в праздники. Становился веселым («вино действовало нормально, как на всех начинающих»). В 1934 г. окончил институт и перешел на должность старшего инженера. Часто приходилось ездить в командировки, и «там с товарищами научился пить». Выпивал много, до 1,5 л водки в день, но никогда не бывал пьяным; влечения к алкоголю не испытывал. На работе никаких неприятностей не имел. С семьей взаимоотношения были хорошие, он заботился о ней, был внимателен к жене, детям. С 1938 по 1941 г. служил в Советской Армии. Изредка выпивал, но умеренно. В 1941 г. демобилизовался и поступил на работу на завод в качестве начальника цеха. Стал злоупотреблять алкоголем. Будучи физически сильным, не пьянел, если выпивал 0,5 л в день. С 1943 г. начал опохмеляться, «без этого не находил себе места: была ужасная потребность выпить». После даже небольшого количества водки успокаивался и продолжал работать. Перенес 3 раза воспаление легких, скарлатину, корь, малярию, цыngu, болезнь Боткина. В войну был донором. Половая слабость с 1952 г. Венерические заболевания отрицает. Почти все зубы отсутствуют. Характер не изменился («даже в пьяном состоянии был самым мирным человеком, никогда не устраивал никаких драк, мечтал только добраться до постели»); зарплату и вещи никогда не пропивал. Выпивал почти ежедневно. На работе крупных неприятностей не было. С 1947 г., кроме водки, начал употреблять «заместители»; муравьиный спирт, одеколон, валериановые капли по 10—15 флаконов, большие дозы люминала вместе с водкой, жидкость от перхоти. С работы часто увольнялся, пьянствовал; когда не было денег, устраивался на прежнее место, но работал лишь до зарплаты и т. д. Бывали периоды, когда не помнил, как добрался домой («знаю, что был у приятеля, с ним выпивал, а дальше уже не помню»). Но такие «выпадения» бывали не всегда. Стал менее вынослив к алкоголю («жена научилась узнавать, если выпью два раза по 150 г с пивом»). С 1949 г. начал стационаризоваться в психиатрические лечебницы. В 1949 г. при переходе с одной работы на другую врач впервые измерил ему кровяное давление, которое оказалось повышенным. Однако никаких субъективных ощущений он не отмечал и от гипертонии специально не лечился; продолжал пьянствовать. С 1952 г. в состоянии похмелья сильно дрожали руки («стыдно и неловко было смотреть людям в глаза»). Все это проходило после «поправки». Ночью мучили кошмарные сновидения: кусали черные собаки, в испуге убегал от них, в ужасе просыпался и бежал за водкой или в аптеку, чтобы выпить еще. Когда пил, ничего не ел, закусывал «мануфактурой», т. е. обтирал рот рукавом. В январе 1953 г. после очередного пьянства утром внезапно отнялась левая нога и рука. Был стационаризован в Институт имени Склифосовского, а затем в Первую городскую психиатрическую больницу, а оттуда в психиатрическую городскую больницу № 5. В загородной больнице лечился в течение нескольких месяцев, после чего вернулся домой. Чувствовал себя хорошо, «только немножко левые рука и нога были слабее». Продолжал выпивать, не работал. В 1954 г. был направлен в больницу, где находится по настоящее время. 13/IX 1954 г. получил вторую группу инвалидности.

Привлекался по статье 159 Уголовного кодекса за то, что систематически оскорблял членов своей семьи, угрожал им убийством. Находилась на экспертизе в Институте имени В. Сербского.

Сосуды на висках извиты, плотны. Нос резко гиперемирован. Границы сердца расширены влево, тоны глухие, акцент второго тона на аорте. В легких ослабленное везикулярное дыхание. Печень выходит из подреберья на 1 см; артериальное давление 200/120 мм ртутного столба.

Рентгеноскопия. Левый желудочек гипертрофирован, аорта склерозирована.

Нервная система. Анизокория $S > D$, реакция зрачков на свет вялая, слева снижение мышечной силы руки и ноги. Коленные ре-

флексy слева резко повышены, с расширенной зоной. Ахилловы рефлексы снижены. Чувствительные нарушения по полиневритическому типу.

Психическое состояние. Правильно ориентирован в месте и времени, окружающей обстановке. В беседу вступает охотно, сведения о себе, своей прошлой жизни дает бестолково, путано. Сообщает данные, не соответствующие действительности, много лжет. Всячески старается представить себя в выгодном свете, говорит о своей трудовой ценности, о заслугах, материальном благополучии, добропорядочности и т. д.

Не скрывает своего заболевания, но значительно его преуменьшает. Основной причиной алкоголизма считает женщин, которые приглашали его в рестораны. Говорит, что алкоголизм — это не простая блажь, а заболевание («если бы сила воли продавалась в аптеке, то можно было бы наглотаться таблеток и не пить»). В противоалкогольное лечение не верит. В беседе многоречив, речь не совсем внятная (отсутствуют зубы), плоско шутит, называет себя «незаконченным алкоголиком», потому что якобы не пропивает вещей. Без критики цинично рассказывает о прошлых интимных связях, об успехах у женщин. Любит говорить на сексуальные темы, цинично называет вещи своими именами, хвастается половой силой, дистанцию в отношении с врачом не соблюдает. Свое неправильное отношение дома категорически отрицает, винит во всем членов своей семьи, называет их бранными именами. Коснувшись взаимоотношений с женой, начинает громко плакать, причем легко переходит от слез к смеху. Настроение большей частью благодушное, с элементами эйфории. Планы на будущее несерьезны («получу путевку на курорт, буду ухаживать за женщинами, а потом, может быть, работать пойду»). Суждение поверхностное. Запас прошлых сведений, знаний значительно утрачен. Память резко снижена, с трудом запоминает новое. Критика к своему состоянию недостаточная. В отделении целыми днями ничем не занят, ходит по палатам, ведет длительные, бессодержательные разговоры, раздражает окружающих. Каждому старается сообщить, что у его жены было много официальных и неофициальных мужей, с которыми он пил водку. Неряшлив, ложится на постель в костюме, ботинках; при замечании бранится. Иногда пишет жене письмо недопустимо оскорбительного содержания, причем в этих же письмах просит у нее передачу денег и прощения. С персоналом фамильярен, надоедлив, требует к себе особого внимания. Очень любит лекарственные назначения, иногда приходится из процедурного кабинета выводить силой. Постоянно выпрашивает хотя бы каких-нибудь порошков или микстур. Часто сердится, но быстро успокаивается, много ест; иногда бывает в постели неопрятен мочой и калом («не хотелось идти в туалетную»). Жалоб никаких не предъявляет. Обстановкой не тяготится. На свидании с женой был резок, груб, требовал выписки. Объективные сведения получены со слов жены и соседей.

До 1943 г. был исключительно хорошим, отзывчивым человеком, прекрасным работником. Изредка выпивал, но это ни в какой мере не отражалось ни на семье, ни на работе. Последние 12 лет пьет очень много, особенно с 1949 г. Изменился по характеру — стал груб, циничен; пропивает всю заработную плату (если только работает), тащит вещи из дома. Прогуливает, большей частью не работает, нищенствует, окончательно опустился, выгоняет семью из дому, бьет жену, детей, ходит по квартире голый, цинично ругается, «из своей комнаты сделал уборную». Жена подала в суд на него, и он был направлен на принудительное лечение.

Большая Б., 50 лет. Жалуется на тягу к алкоголю, тоску («жалую всех»), тревожный сон, дрожание рук. Отец злоупотреблял алкоголем, умер, отравившись денатуратом. По характеру был ласковый, добрый, отзывчивый человек. Мать 76 лет, жива. Находится в больнице по поводу рака желудка. Отличается суровым характером. Сестра работает. Злобная, суровая, грубая. Брат умер в раннем детстве.

Большая родилась третьей по счету в материально обеспеченной семье. Вскормливалась грудью матери. В детстве болела рахитом. До 5 лет не ходила. Говорить начала во-время. Долгое время страдала эпилепсией. Четырех лет лишилась отца, воспитывалась большей частью у бабушки или тетки. Была тихим, спокойным, послушным ребенком. Восьми лет начала учиться в школе. Отличалась незаурядными способностями, училась хорошо; имела только одну подругу, с которой сохраняла дружеские отношения по настоящее время. В школьные годы увлекалась театром и сама принимала участие в школьных спектаклях. Окончила 7 классов и поступила на работу, сначала в качестве телефонистки, а затем, по окончании курсов кассиров, кассиром в государственный банк. 17 лет вышла замуж. Взаимоотношения с мужем были хорошие. В 18-летнем возрасте родила дочь. Вскоре с мужем разошлась (причину развода скрывает). Алкоголь в этот период употребляла очень редко, только по праздникам. В 1932 г. вторично вышла замуж. В 1935 г. перенесла психическую травму, под влиянием которой «с горя запила». Появились приступы плохого настроения, когда казалось, что цель в жизни потеряна, вокруг темно, некуда скрыться; алкоголь снимал это тяжелое состояние (пьет в день по 0,5 л водки). Часа полтора после выпивки чувствует себя хорошо («на душе блаженно и радостно»). Потом вновь охватывает тоска, для облегчения которой больная опять прибегает к водке; пила подряд от одной до 3 недель. Светлые промежутки бывали до 2 недель. На работу в периоды пьянства не выходила. Часто меняла место службы, пропивала деньги, вещи. С 1937 г. в состоянии опьянения страдает припадками (частоту их установить не удается). Теряет сознание, падает, упускает мочу, но судорог у нее не бывает. После припадка чувствует себя разбитой. В состоянии опьянения видела у себя за столом сидящих людей — гостей, которые ели, пили вино, хвалили ее, а она чувствовала себя в это время «важной персоной». Эти минуты бывали очень приятны. В день могла выпить до 1,5 л водки. В состоянии опьянения бывала очень груба, цинична, абсолютно ни с кем не считалась, в трезвом же состоянии — мягкая, добрая, отзывчивая. В состоянии похмелья вечерами видела зверей; все они были мелкие и быстро двигались, лучше всего это было видно при закрытых глазах, когда появлялись какие-то тени, которые плыли, группировались в фигуры. До 1944 г. выполняла работу кассира, хотя и имела много неприятностей и даже судимость за прогул. В феврале 1944 г. впервые стационарирована в больницу с жалобами на кошмарные сновидения, слабость. В отделении была общительна, держалась несколько развязно, с оттенком ухарства; выполняла трудотерапевтические назначения. Через 19 дней была выписана. По выписке из больницы несколько дней не пила, а затем появилась тяга к алкоголю, начала пьянствовать, продавала вещи, на улице знакоилась с мужчинами, приглашала их к себе, не работала. В июле 1944 г. вторично стационарируется в больницу. Находясь в отделении, все время испытывала тягу к алкоголю. Психотических симптомов не отмечалось. Установка была на длительное пребывание в больнице. Через 31 день больная выписалась. В 1945 и 1946 гг. периодически работала, «но больше пьянствовала». В декабре 1946 г. снова поступила в больницу; перед этим пила больше месяца, не могла устроиться на работу, нищенствовала. В отделении держалась развязно, психотических симптомов не было. Через 22 дня выписалась. В течение месяца чувствовала себя хорошо; устроилась на работу, через некоторое время снова появилась тоска, мысли о ненужности существования. Больная снова запила, в результате чего и была уволена с работы. Она стала продавать вещи и вырученные деньги пропивала, ходила по пивным, пела там романсы ради того, чтобы ей «поднесли водки». В период похмелья и воздержания по ночам плохо спала; лежа с закрытыми глазами, видела всевозможных зверей, кошек, крыс, собак; они ходили вокруг ее кровати, взбирались на нее. Ей становилось страшно, она кричала и старалась прогнать их «словами и молитвой». Иногда видела карликов с длинными бородами. Они кривля-

лись, строили рожи, хохотали, издевались над ней. Видела своего умершего мужа, который приходил к ней на костылях и как только она начинала его звать с хохотом убегал. До апреля 1947 г. периодически пила, затем была переведена в загородную больницу. Здесь испытывала тоску, нестерпимо хотелось выпить. Через 2 недели после выписки снова запила и в сентябре 1947 г. была стационарирована. Настроение было все время пониженное, избирательно общалась, была малозаметна. Больная была настроена на длительное пребывание в больнице. Она утверждала, что ей рано выписываться, демонстративно начинала хромать, говорила с усмешкой о том, что теперь она уже видит крокодилов, а позднее, может быть, увидит еще более громадных животных.

В конце 1947 г. больная выписалась из больницы, чувствовала себя хорошо, приступила к работе, физически очень поправилась. Вновь вышла замуж. Первое время с мужем жила хорошо, дружно, не было никаких ссор. Он разрешил ей изредка выпивать, чем она была очень довольна. Выпивала как будто бы по праздникам, иногда опохмелялась. Через полгода совместной жизни муж больной стал появляться также в нетрезвом виде, часто в сопровождении женщины. Как впоследствии выяснилось, это была его вторая жена, и больная его «выгнала». Стала тосковать, нередко прибегала к алкоголю. Сама обратилась к районному психиатру и была стационарирована. В больнице много и подробно рассказывала о своих личных переживаниях; с первого дня включилась в трудовые процессы. Общалась только с больными, страдающими алкоголизмом. Предъявляла множество жалоб, нецензурно бранилась, конфликтовала с больными. Была выписана через 24 дня. Спустя месяц снова запила, на работу не выходила, пропивала вещи. Дома с родными была груба, ни с кем не считалась, плохо спала по ночам. Диспансером была направлена в больницу. В отделении держала себя развязно, неохотно подчинялась режиму. Через 15 дней была выписана. С работы она была уволена и долго не могла куда-то устроиться. Снова начала пьянствовать, продавала вещи, нищенствовала. Была вновь стационарирована. В больнице держалась развязно, тяготилась отделением, требовала выписки. Выйдя из больницы, пыталась устроиться на работу, но нигде не могла удержаться. Пьянствовала, тащила из дома все, что могла, ходила по пивным, приставала к мужчинам, выпрашивала угощение; получив водку, убегала от них, за что неоднократно бывала бита. Психиатром снова была направлена в больницу, где находилась 21 день. Поступила в состоянии опьянения, была раздражительна, груба, цинична.

По выходе из больницы периодически работала по 3—4 месяца касиршей, а как только запивала, теряла место. Пьянствовала обычно от одной недели до 2 месяцев («пила до тех пор, пока было на что, а затем искала работу и до первой получки работала, а там опять запивала»). В 1952 г. ее перестали принимать на работу. Прошла ВТЭК, получила третью группу инвалидности и начала работать надомницей. Попрежнему пьянствовала, но обходилась без врачебной помощи. В состоянии похмелья видела мышей, карликов, которые шептали ей на ухо: «Пойди еще выпей, пропойца». «Я вставала и говорила себе, что надо еще выпить, если приказывают». В 1955 г. безрезультатно лечилась гипнозом; в лечение не верила. Перед поступлением в больницу пила больше месяца; 18/XI была стационарирована в беспokoйное отделение в состоянии опьянения.

Характеристика больной.

Со слов зятя. Знает больную с 1944 г. Считает ее лживой, грубой. Больная злоупотребляет алкоголем с 1936 г. Пропивает деньги, вещи, ни с кем абсолютно не считается. Последние годы начала вести легкомысленный образ жизни, ходит по пивным, ресторанам, знакомится с мужчинами, выпрашивает угощение, приводит к себе домой. В состоянии опьянения поет песни. Если ее не трогать, — спокойна, если же сделать замечание, — начинает цинично браниться, кричать, вступает в драку. Крайне неустойчива. Издевалась над умирающей матерью, не давала

ей есть, пропивала ее пенсией, вещи. Перед поступлением в больницу пьянствовала, больше месяца почти не спала. 11/XI была направлена в больницу.

Неврологическое состояние. Левая глазная щель уже. Небольшая анизокория $D > S$. Реакция зрачков на свет небольшого объема, конвергенция недостаточная. Движение глаз во все стороны удовлетворительное, горизонтальный нистагмоз при крайних отведениях глаз. При оскале зубов отстает левый угол рта. Язык уклоняется влево. Сухожильные и периостальные рефлексы на руках оживленные. Коленные рефлексы повышены, без четкой разницы сторон. Ахилловы рефлексы живые, брюшные снижены равномерно (обильное отложение жира на животе).

Патологических рефлексов нет. Болезненность нервных стволов на ногах. Положительный симптом Вассермана. Глубокая чувствительность в пальцах ног снижена. Сильный тремор пальцев рук.

Психическое состояние. Сознание ясное, ориентировочные реакции не нарушены. В контакт вступает охотно. Сразу же начала жаловаться на неправильное помещение ее в психиатрическую больницу. Анамнестические сведения сообщала крайне путано, непоследовательно, часто прерывала беседу просьбами дать ей выпить что-нибудь покрепче, а при отказе начинала плакать и отказывалась отвечать на задаваемые вопросы. Однако быстро успокаивалась и смеялась. Уверяла, что когда выпьет немного, то сразу становится веселой, предлагала спеть, потанцевать («Вы ведь за это дадите рюмочку?»). Значительно преуменьшает свое пристрастие к алкоголю, отрицает опохмеление, тягу к спиртному. Говорит, что немного начала выпивать только с военного времени, после смерти мужа. Будучи уличена во лжи, рассмеялась и заявила, что «не к лицу вам, доктор, быть мелочной, разве это имеет значение?». О многих событиях, имевших место в жизни, умалчивает или сообщает заведомо ложные сведения. Старается представить себя в лучшем свете, обвиняет окружающих. Любит поговорить на сексуальные темы, при этом старается подчеркнуть, что она ведет самый скромный образ жизни. Театрально заламывая руки, говорит, что ее надо выписать из больницы, так как у нее умирает мать. Имеющиеся объективные и достоверные сведения о неправильном отношении к матери больная отрицает, причем выраженной реакции возмущения, негодования при этом не дает, с улыбкой, смеясь, уверяет, что к матери была внимательна и нежна. Однако, узнав о смерти матери в больнице, несмотря на все прежние уверения, закричала и сказала:

«Ну, теперь мне никто не будет мешать пьянствовать!»

Запас слов достаточный, интонации живые, речь быстрая, пронизана грубым юмором, иногда прерывается нецензурной бранью. Все суждения больной крайне поверхностны, легкомысленны. Она не думает о будущем, беспечна. Круг ее интересов сужен. Она ничем не интересуется, не строит никаких планов. Легко дает обещание не пить и тут же о нем забывает. С врачом держится развязно, льстит ему, с умильной улыбкой выпрашивает что-нибудь выпить. Получив лекарство, снова начинает назойливо просить о том же.

Общий фон настроения благодушный, с оттенком эйфории. Память ослаблена; из 10 слов могла повторить только два, долго не могла запомнить имени врача. Критика к своему состоянию отсутствует. Об имеющих место (в состоянии похмелья) обманах слуха и зрения говорить не любит и сама о них не рассказывает. В больницу поступила в состоянии опьянения. В приемном покое кричала, нецензурно бранилась. В отделении приставала к персоналу с требованием дать ей водки. В кабинет врача входила в первые дни непричесанная, в растегнутом платье, отказывалась сообщать анамнестические сведения. Достав где-то несколько снотворных порошков, приняла их; 2 дня находилась в состоянии интоксикации, на ногах не стояла, на лице была благодушная улыбка. Говорила что-то невнятное, заплетающимся языком. По выходе из этого

состояния тяга к алкоголю осталась. Общалась только с больными, страдающими алкоголизмом, вела с ними разговоры о водке, нецензурно бранилась, грубила персоналу. Уверяла, что тяготеет пребыванием в больнице, что ее совершенно напрасно помещают в стационар, что она боится больных. Однако быстро освоилась с обстановкой, ходила по отделению с накрашенными губами, пела романсы, была веселой. В присутствии мужчин начинала кокетничать, говорить пошлости, обнажаться. На замечания не обращала внимания. Требовала выписки.

У некоторых алкоголиков возникает болезненная ревность к жене. Если такой алкоголик случайно встретит свою жену с кем-либо из мужчин, у него сейчас же возникает представление, что жена ему изменяет с этим человеком. Он начинает следить за ней, проверяет ее постельные принадлежности. Случайно измятая постель дает ему повод думать о якобы имевшей место измене. Так постепенно развивается бред ревности пьяниц. При наличии галлюцинаций алкоголик при своем приходе слышит удаляющиеся шаги. Постепенно он «убеждается», что жена имеет много связей, изменяет ему с первым попавшимся мужчиной, соседями по квартире, сослуживцами по работе, даже с родными братьями. Дети его похожи на «любовников» жены. В щелочку наблюдая за женой, он видит, как она предается бесстыдному разврату с одним или многими мужчинами. Он слышит голос жены, хвастающейся своими любовными похождениями, своим знанием искусства любви. Жену оскорбляет ей угрожает, делает предупреждения: «исправиться — или смерть». В таких случаях алкоголики иногда совершают над женами жестокие насилия, избивают их, выгоняют из дому, беспрестанно следят за ними, учиняют скандалы воображаемым любовникам, в связи с чем, уходя из дому, запирают жен в комнате на ключ. Беспрестанная слежка, побои, издевательства делают совместную жизнь невозможной, что и приводит к разводам. Иногда такие больные могут совершить тяжелые насилия и даже убийства.

При соответствующем лечении бред ревности обычно проходит или ослабевает (через 6—10 недель). Однако при дифференциальной диагностике следует учитывать, что бред ревности может наблюдаться и у истериков или психически больных вне зависимости от алкоголя. Бред ревности алкоголиков до И. П. Павлова объясняли следующим образом. Повышенная вначале половая сила у больного постепенно угасает вплоть до импотенции, половое же влечение остается попрежнему повышенным. Больной вследствие своего пьянства делается жене безразличным, а зачастую внушает ей отвращение. Между женой и мужем устанавливаются холодные отношения, которые больной вследствие своей подозрительности неправильно истолковывает как охлаждение, вызванное

любовью к другому, что создает благоприятную почву для бредовой интерпретации.

Однако такое объяснение удовлетворить нас не может: нередко бред ревности наблюдается у сексуально здоровых и даже гиперсексуальных алкоголиков. Лишь учение И. П. Павлова дает возможность понять патофизиологическую сущность бреда ревности. В основе бреда, по И. П. Павлову, лежат два физиологических явления — «патологическая инертность и ультрапарадоксальная фаза, существующие то врозь, то выступающие разом, то сменяющие одно другое».

А. Л. Эпштейн большое значение в клинике алкоголизма придает агриппническому синдрому, считая его важнейшим патофизиологическим моментом, который знаменует собой переход от латентного периода к открыто развивающемуся психическому процессу.

Мы находили у многих алкоголиков явления неврастения в тяжелой форме, которая являлась следствием алкоголизма.

На первый план при этом выступает ослабление процессов активного, условного торможения. Больные крайне раздражительны, не могут себя сдерживать, нервничают и расстраиваются до слез из-за пустяков. Отмечается легкая возбудимость, повышенная утомляемость, рассеянность. Память и работоспособность понижаются, настроение становится неустойчивым или пониженным. Сон нарушается, становится недостаточным, поверхностным, тревожным и нередко сопровождается кошмарными сновидениями.

Кроме того, имеются функциональные расстройства со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение, субъективно неприятные ощущения в области сердца, нечистые тона сердца с акцентом на втором тоне, легкая возбудимость вазомоторов. У этих больных со стороны желудочно-кишечного тракта наблюдаются неприятные ощущения и боли в области желудка, отрыжка, усиленное газообразование, расстройство желудочной секреции и т. п. Наряду с этим, отмечается головная боль, болезненные ощущения в различных частях тела, склонность к ипохондрическим идеям. Характерной чертой таких больных является фармакофилия — любовь к лекарствам и лечению. Подобные больные осаждают врачей; не удовлетворяясь амбулаторным лечением они требуют направления в специальные учреждения и санатории и т. п., причем обязательно на длительный срок. Находясь в стационаре, они возмущаются, если им назначают мало процедур. Они требуют назначения хотя бы какого-нибудь лекарства или процедуры, высказывают бесчисленное число жалоб и крайне недовольны, если врачи их часто не осматривают.

Неврастенический синдром проходит постепенно лишь после соответствующего лечения и длительного воздержания от алкоголя.

Среди алкоголиков можно выделить еще одну группу, где на первый план выступает астения; у больных отмечается упадок физических и психических сил, вялость с тенденцией к сонливости, повышенная утомляемость; особенно большое затруднение они испытывают при осуществлении актов, требующих известного напряжения. При этом нередко у них можно наблюдать тревожно-мнительный характер, склонность к ипохондрическим и навязчивым состояниям, значительное понижение работоспособности.

При длительной алкогольной интоксикации к астении присоединяется депрессия, тоска, появляются суицидальные мысли. Больным все кажется бесцветным, поблекшим, ими овладевает отчаяние, тоска и страх. Выражение лица становится печальным, страдальческим. Мышление заторможено, движения замедлены и совершаются с известными усилиями. Иногда больные, находящиеся в таком состоянии, совершают суицидальные попытки. Этот астено-депрессивный синдром в течение 1—2 недель после лишения больных алкоголя претерпевает обратное развитие: тоска, отчаяние, суицидальные мысли проходят и на длительный срок сохраняется лишь астения. Такие больные оправдывают злоупотребление алкоголем стремлением повысить работоспособность, стимулировать себя, избавиться от неуверенности, т. е. употребляют алкоголь как «лекарство», стимулятор, без которого, как им кажется, они ни к чему не пригодны.

Правильное лечение, в частности, длительным лечебным курсом с последующим назначением стимуляторов в виде фен-амина, первитина, восстанавливает их здоровье.

Наконец, следует упомянуть о реактивной форме алкоголизма. Больные в этих случаях прибегают к алкоголю как к источнику забвения в случае тяжелой психической травмы: они пьют «с горя» (смерть близких, развод, несчастная любовь, тяжелые семейные и служебные конфликты). Получая при употреблении алкоголя облегчение душевных страданий, они вначале прибегают к нему как к лекарству, «которое облегчает тоску», не могут без него работать, спать и в конце концов привыкают к алкоголю и становятся алкоголиками. В качестве примера приведем следующие истории болезни.

1. Больной Б., 40 лет, поступил в клинику с жалобами на головные боли, страхи, предчувствие чего-то страшного, тревогу, беспокойство, болезненное влечение к вину.

Дед со стороны матери алкоголик. Рос болезненным ребенком, часто испытывал сильные головные боли. Был робким, застенчивым, боялся детей. Летом часами просиживал один, забившись в дальний угол сада, а зимой никуда не отлучался из дому. Когда спрашивали, что с ним, отвечал: «Ничего, так, досадно». Чтобы развеселить ребенка, вызвать у него подъем, взрослые давали ему деньги на конфеты, орехи, по все это не помогало. В 11-летнем возрасте болел дифтерией, которая протекала очень тяжело. В возрасте 8 лет поступил в школу. Учился хорошо. Окончил рабфак и два курса Литературного института. В юношеские годы избе-

гал людей; когда было тоскливо, пробовал сближаться с ними, но при этом возникали нараставшие конфликты, в основе которых лежал какой-нибудь пустяк. В силу неуживчивости больного окружающие, возможно, действительно относились к нему не вполне хорошо. Через всю жизнь его проходит боязнь общества. В 1935 г., принимая ванну в Кисловодске, сильно испугался: ему показалось, что санитар посмотрел на него «зверскими глазами». Больной выскочил из ванны, так как был убежден, что санитар хочет его убить, и убежал к себе в палату. Часто бывало так, что вдруг какой-нибудь человек начинал внушать ему подозрение. Шаги за его спиной также казались подозрительными. Мерешилось, что обгоняющий человек непременно ударит его по голове. Это ощущение было настолько острым, что больной ускорял шаги, чтобы не дать возможность подозрительному прохожему нагнать себя. Однако наблюдались такие периоды, когда легко думалось, ощущался подъем, легко давалась всякая работа. Подобные периоды бывали то кратковременными, то длились до 3 месяцев. С 17 лет попал в «богемствующую среду»; подражая старшим, приучился там пить виноградное вино. Позже начал пить почти систематически. Пил для того, чтобы стать более развязным, более общительным и разговорчивым, избавиться от заторможенности. Считал, что не сделает ни одного серьезного дела, пока не выпьет. Систематически начал употреблять алкоголь с 1926 г., выпивая в день по 0,5—1 л водки. Постепенно выносливость к вину стала уменьшаться. В настоящее время пьянеет от небольших доз. В состоянии опьянения груб, возбужден, но на другой день не помнит, что он делал в пьяном виде. Абстинентный синдром с 1930 г. Во время похмелья испытывал сильную слабость, дрожание конечностей; казалось, что о нем говорят, насмехаются над ним, боялся показаться на глаза людям, чувствовал, как у него останавливается сердце и наступает смерть. Жалел, что так мало сделал («на полдороге останавливается»), считал, что с ним все кончено. Неоднократно лечился. В больнице был первый раз в 1931 г. После этого не пил в течение 3 лет, но затем вновь начал пить и попадал в больницу повторно несколько раз, причем ремиссии длились 1—2 года. Страх смерти испытывает и в настоящее время, когда льет длительный срок. Однажды увидел, что к окну комнаты подошел инвалид и хотел разбить козылем окно (даже замахнулся). Больной в страхе закричал. На крик прибежала жена, но никого не обнаружила. Иногда во время работы ловил себя на том, что забыл самое обыкновенное слово или имя близкого человека; тогда у него появлялось жуткое чувство страха, что он сходит с ума, и он почти физически ощущал, что у него «мозги испаряются». Страх потерять рассудок был настолько сильный, что больной становился растерянным, испытывал сердцебиение. В это время он бросал работу и уходил туда, где были люди, среди которых страх быстро исчезал. Иногда испытывал непреодолимое желание сделать что-нибудь нелепое, например, дернуть ручку тормоза в метро и поэтому вблизи тормозов не становился. Однажды, будучи на концерте в клубе, слушал прекрасную певицу, скрипача и вдруг самому захотелось «завыть». Больной понимал всю нелепость подобного поступка, но тем не менее чувствовал, что он сделает это, и вынужден был уйти из клуба. В другой раз, будучи на приеме у крупного работника, испытывал сильное желание подставить ему ножку, когда тот проходил мимо него, и т. д.

Больной испытывает двойственное состояние: подъема, взлета, взвинченности и падения, усадка сил и энергии. В периоды подъема жизнь представляется ему ярким солнечным днем, и даже люди кажутся милее, лучше. В такие периоды он оптимистически смотрит на жизнь. Идеи отношения не появляются даже в мыслях, не бывает страхов, навязчивых идей. Больной самоуверен, настойчив, упорен. Такое состояние подъема длится 2—3 недели и сменяется полным упадком сил, тоской. В это время ему кажется, что он «исписался» и больше строчки не напишет. Весь мир полон недоброжелателями, завистниками. Не появляется никаких мыслей, но если он преодолет себя, то выполненная им работа полу-

чается крайне плохой. Больного тянет в кровать; он засыпает, просыпается и вновь засыпает. Жизнь становится противной («все постыло, ничего не радует, ни о чем не хочется думать»). Появляется мысль о самоубийстве; вначале она промелькнет в голове («как тень от небольшого облака»), а потом становится более назойливой. Больной начинает обдумывать способы самоубийства, испытывает желание выбраться из окна, считая эту смерть легкой и быстрой, но находит в себе силы подавить эту мысль. Состояние угнетения длится от нескольких дней до месяца, чаще всего 1—2 недели. Тоска появляется сразу и достигает наивысшей степени в первые дни, затем она постепенно смягчается и проходит. Для поднятия настроения в такие периоды больной обычно прибегает к водке, а в последнее время и к фенамину.

Физическое состояние. Больной среднего роста, ослабленного питания, диспластического телосложения. Отмечаются глуховатые тоны сердца. Легкие в норме. Желудочно-кишечный тракт без особых отклонений от нормы. Симптомов органического поражения нервной системы не отмечается.

Психическое состояние. Сознание ясное, ориентирован правильно. Настроение колеблется почти закономерно: то бывает тоска, то появляется подъем, причем настроение может изменяться даже в течение дня. Стоит его чем-либо расстроить, как появляется тоска, раздражительность. Раздражительность настолько большая, что больной временами даже теряет самообладание и впадает в ярость. В это время он может наругать, поссориться даже с друзьями. Испытывает всевозможные страхи: страх смерти, боязнь совершить что-либо нелепое, страх сойти с ума. Считает, что с ним случится что-то «ужасное», что все окружающие враждебно настроены, устраивают ему «разные гадости». В этой среде нужно быть всегда начеку, «держаться настороже». Зрительные галлюцинации отрицает. Слуховые галлюцинации — в виде окликов. Иногда слышит запах гари. Испытывает болезненное влечение к алкоголю, особенно в периоды пониженного настроения («когда выпьешь, становится будто бы легче на душе, уменьшается раздражительность»).

Как видно из вышеприведенной истории болезни, алкоголизм у больного Б. развился под влиянием расстройства настроения. Алкоголь больной принимал для того, чтобы устранить заторможенность и, как он говорит, «чтобы сделаться более общительным и разговорчивым», а также для поднятия пониженного настроения. Большую роль в развитии алкоголизма в данном случае сыграла неблагоприятная богемствующая среда. В настоящее время, после проведенного лечения, больной спиртных напитков не употребляет и продуктивно работает.

2. Больной Т., 35 лет, повторно поступил в клинику с жалобами на болезненное влечение к алкоголю и суицидальные мысли. По словам больного, хотел повеситься, чтобы «избавить всех от пьяницы».

Отец больного — алкоголик, умер 47 лет от стенокардии. Дед по линии отца также алкоголик. Больной родился недоношенным (8 месяцев). В детстве был слабым, болезненным. В возрасте 9 лет поступил в школу. Учился отлично, окончил девятилетку и три курса электротехнического института. Самостоятельно работает с 27-летнего возраста формовщиком, электромонтером, прорабом, начальником цеха. Болел дважды корью, воспалением легких, тифом, эндокардитом, гонореей. Злоупотреблять алкоголем начал с 1937 г. после смерти отца, утрату которого тяжело переживал; испытывал сильную тоску. Пропил все имущество, оставленное отцом. Вначале пил в компании, затем один. В марте 1938 г. появились зрительные галлюцинации: видел кроликов, зайцев, которые ему

подмигивали, махали ушами. Вначале это забавляло, затем становилось страшно. Он испытывал страх, бросал в них бутылками. Ему казалось, что его должны арестовать, не мог спать. По поводу этой психотической вспышки лечился в клинической больнице в течение 2 месяцев и один месяц в санатории, после чего не пил в течение 4 лет. В 1941 г. начал пить пиво; в течение 1941—1942 гг. как будто соблюдал умеренность в потреблении спиртных напитков, считал себя вылечившимся. Однако в 1943 г. вновь начал злоупотреблять алкоголем, по поводу чего был стационарирован повторно: не пил после лечения в течение 5 месяцев. В 1945 г. был дважды стационарирован в психиатрическую больницу, после чего наступила кратковременная ремиссия на 2—2½ месяца. В 1946 г. был стационарирован в пятый раз. Всегда пьет с горя или под влиянием каких-нибудь неприятных переживаний. Абстинентный синдром с 1937 г. Интолерантность к алкоголю появилась с 1943 г., амнестическая форма опьянения — с 1944 г.

Физическое состояние. Ниже среднего роста, атлетического телосложения. Слизистые розовые, глуховатые тоны сердца, границы которого расширены влево на один палец.

Неврологическое состояние. Зрачки равномерны, хорошо реагируют на свет, конвергенцию и аккомодацию; пателлярные рефлексы и рефлексы ахилловых сухожилий отсутствуют.

Психическое состояние. Сознание ясное, легко вступает в контакт, пытается всегда чем-либо услужить, помочь. Лабильность эмоциональной сферы. Настроение подавленное. Суицидальные мысли. Круг интересов несколько сужен. Память ослаблена. Обманов чувств нет. Критика сохранена. Бредовых идей не высказывает.

В данном случае имеет место реактивная форма алкоголизма. Больной Т. начал пить после смерти любимого отца, утрату которого крайне тяжело и глубоко переживал. Проведенное лечение дало благоприятные результаты: с 1946 г. не употребляет алкогольных напитков, повысил свою квалификацию, работает начальником цеха.

Картина крови и обмен веществ. В выраженных случаях хронического алкоголизма мы отмечаем понижение процента гемоглобина, уменьшение количества эритроцитов до 3 000 000—3 500 000, лейкопению, сменяющуюся в период абстиненции гиперлейкоцитозом, увеличение количества юных и палочкоядерных лейкоцитов. В тяжелых случаях алкоголизма встречаются миелоциты. РОЭ вначале замедлена, затем резко повышается Зуков (Sucow), И. В. Стрельчук]. Значительно нарушается углеводный обмен, вследствие чего происходит неполное сгорание жира, ведущее к увеличению фосфатидов и изменению холестерина обмена.

По нашим данным, как мы уже говорили выше, функция печени у алкоголиков нарушается, но после лишения больных алкоголя постепенно нормализуется. Существенные изменения отмечаются также со стороны электролитов. Содержание калия повышается, содержание кальция понижается, уменьшается также количество хлористого натрия и хлора. Отмечается сдвиг кислотно-щелочного равновесия в сторону ацидоза. Газовый состав крови нарушается — она обедняется кислородом, количество же углекислоты, наоборот, повышается. Сахарная нагрузка дает высокую гипергликемическую кривую.

Уровень сахара в крови отличается крайней лабильностью, диапазон его колебаний весьма значителен — от высоких границ нормы до крайне низких ее пределов. Особенно резкие изменения сахарной кривой отмечаются при изучении суточного содержания сахара. Значительное изменение его у алкоголиков, повидимому, тесно связано с их эмоциональной неустойчивостью, а также с нарушением деятельности поджелудочной железы и печени, что особенно заметно при функциональном испытании печени и поджелудочной железы с помощью сахарной нагрузки.

Значительно нарушается витаминный обмен. Содержание витамина С уменьшается. Снижается и количество витамина В₁, особенно при алкогольных полиневритах, а также витамина РР, недостаток которого обуславливает склонность алкоголиков к заболеванию целлагрой.

Содержание холестерина у большинства алкоголиков снижено и у меньшего числа повышено. Остаточный азот держится в высоких пределах нормы или незначительно повышен. Количество билирубина почти во всех случаях тяжелого хронического алкоголизма повышено, в легких же случаях не отмечается отклонений от нормы. В тяжелых случаях наблюдается уробилиногенурия. Содержание каталазы понижено. Водный баланс нарушен вследствие расстройства функции печени. На пробу с нагрузкой почек алкоголики реагируют, как больные с нарушением липоидного обмена. Изучению обмена веществ в динамическом разрезе посвящен ряд обстоятельных работ, указывающих, что хронический алкоголизм вызывает нарушение углеводного, жирового, белкового, электролитного обмена и др. При воздержании от алкоголя, по нашим наблюдениям, обмен веществ нормализуется в сроки от 2—3 месяцев до года.

О НАРУШЕНИЯХ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ

В лабораториях И. П. Павлова влияние алкоголя на высшую нервную деятельность животных изучалось рядом авторов: И. В. Завадским (1908), А. М. Никифоровским (1910), С. Н. Потехиным (1910), А. А. Линдбергом (1935), М. К. Петровой (1941), В. К. Федоровым (1937, 1948).

Экспериментальными исследованиями высшей нервной деятельности, проведенными на животных вышеупомянутыми авторами и особенно много сделавшей в этом направлении М. К. Петровой, установлено, что уже малые дозы алкоголя ослабляют активное торможение. Соотношение между раздражительным и тормозным процессом нарушается в сторону преобладания раздражительного процесса вследствие ослабления активного торможения. Величина условных рефлексов падает

вследствие ослабления раздражительного процесса. Даже малые дозы алкоголя затрудняют образование новых условных связей. Более глубокое отравление алкоголем значительно снижает величину условных рефлексов, ведет к нарушению закона силовых соотношений, появляются гипнотические фазы (уравнительная, парадоксальная и ультрапарадоксальная). Большие дозы алкоголя ведут к падению величины как условных, так и безусловных рефлексов вследствие распространения торможения с коры на подкорку. М. К. Петрова наблюдала длительное последствие алкоголя у собак; нарушение высшей нервной деятельности сохранялось у них еще в течение многих дней и недель после прекращения введения алкоголя. У некоторых собак появлялся страх, животное боялось всех посторонних, особенно экспериментатора, а у части собак наблюдались явления, сходные с галлюцинациями и иллюзиями у людей. Особенно чувствительными к алкоголю оказались старые собаки с изношенной нервной системой, в течение долгого времени перенапрягаемой трудными заданиями, а также собаки со слабым типом высшей нервной деятельности.

Общие итоги этих исследований показывают, что у собак, подвергавшихся длительной алкоголизации, в первую очередь выступает ослабление тормозного, а затем последовательно и раздражительного процесса, изменение подвижности этих процессов в виде патологической лабильности и инертности их.

Н. И. Красногорский (1935) и Н. Р. Шастин (1941) установили, что у детей прием небольших доз алкоголя вызывает падение величины положительных секреторных и двигательных реакций и ослабление тормозных.

З. Л. Синкевич, изучавшая влияние различных доз алкоголя на взаимодействие между первой и второй сигнальными системами (применялась методика речевого подкрепления, предложенная проф. А. Г. Ивановым-Смоленским, и ассоциативный эксперимент), после введения испытуемым 50 г алкоголя отмечала стимулирующее влияние последнего на деятельность первой сигнальной системы и легкие нарушения во второй сигнальной системе, выражавшиеся в замедлении латентного периода в ассоциативном эксперименте, в ухудшении качества ответов (эхолалические, созвучные, многословные ответы).

Прием больших доз алкоголя в течение нескольких дней вызывал более глубокие изменения как в первой, так и во второй сигнальной системе, причем изменения были тем резче, чем продолжительнее была интоксикация алкоголем. В первой сигнальной системе отмечалось быстрое замыкание условных связей и, наряду с этим, наблюдалась их чрезвычайная неустойчивость, хрупкость; они угасали, несмотря на подкрепление. Условные связи как бы смывались волной запредельного

торможения, т. е. выступала патологическая лабильность раздражительного процесса. Экспериментально воспроизводить активное торможение не представлялось возможным вследствие отсутствия прочной условной связи. На фоне общего глубокого нарушения первой и второй сигнальных систем активное условное внутреннее торможение оказалось нарушенным в наибольшей степени. В деятельности коры мозга господствовало пассивное торможение. Во второй сигнальной системе выступало снижение качества ответов, замена словесных реакций двигательными, мимическими и жестикуляторными. Эти и другие нарушения указывают на растормаживание низших форм реакций при торможении высших речевых процессов. При прекращении интоксикации алкоголем психические функции постепенно возвращались к норме.

Исследование нарушений нейродинамики при хроническом алкоголизме проводилось в лабораториях, руководимых проф. А. Г. Ивановым-Смоленским, с 1946 г. (И. В. Стрельчук, З. Л. Синкевич). Нами было установлено, что у большинства больных хроническим алкоголизмом отмечалось более или менее выраженное замедление образования условных связей. Применявшийся при этом словесный отчет больных свидетельствовал о том, что замыкание во второй сигнальной системе нередко происходило прежде, чем в первой сигнальной системе (со второго-третьего сочетания), но передача его в первую сигнальную систему была затруднена. Часто наблюдалось исчезновение условной реакции в начале каждого опыта. Выпадение ответной реакции при переходах от одного условного раздражителя к другому указывало на нарушение подвижности корковых процессов. Почти у всех испытуемых к концу эксперимента отмечалось удлинение латентного периода и уменьшение величины условных реакций, что, очевидно, было связано с понижением порога функциональной работоспособности корковых клеток и быстрым развитием запредельного торможения. Дифференцировки вырабатывались в ряде случаев с большим трудом, а там, где появлялись, давали резко выраженное последовательное торможение; следовательно, наблюдалась известная недостаточность концентрации процессов активного торможения.

При исследовании вегетативной реактивности путем испытания глазо-сердечного рефлекса (при различных по интенсивности вызывающих его раздражителях) наблюдалась уравнительная, парадоксальная и ультрапарадоксальная фаза, что свидетельствовало о наличии нарушений нервной деятельности и в сфере вегетативных безусловных рефлексов.

Е. М. Жудро у больных тяжелой формой хронического алкоголизма находила резкое замедление образования новых условных связей, ослабление процессов активного торможения, особенно условного тормоза и запаздывающего торможения.

Особенно резко у этих больных нарушалась подвижность корковых процессов.

При исследовании корковой динамики, как показала З. Л. Синкевич, словесный отчет в большинстве случаев неадекватно отражает характер условной реакции исследуемых, что свидетельствует о нарушении взаимодействия корковых сигнальных систем у больных, чем можно объяснить их лживость, частые расхождения между словом и делом.

Наличие у больных хроническим алкоголизмом фазовых явлений, возникающих здесь как выражение охранительного торможения, можно расценивать как прямое показание к применению (по крайней мере при некоторых из этих состояний) терапии сном в качестве одного из ингредиентов комплексного лечения.

З. Л. Синкевич установила, что у значительного числа больных хроническим алкоголизмом, когда они покидают стационар, даже после продолжительного лечения в нем, имеют место стойкие нарушения во взаимодействии первой и второй сигнальных систем. Эти нарушения выступают особенно отчетливо при исследовании отношений между непосредственным условным раздражителем и его словесным обозначением, т. е. в простой динамической структуре. При этом оказалось, что в ряде случаев вместо имеющейся в физиологических условиях элективной иррадиации в простой динамической структуре у страдающих хроническим алкоголизмом выступают отношения элективной отрицательной индукции. Процесс восстановления нарушенных функций (совместной деятельности сигнальных систем) протекает различно в зависимости от специфических особенностей нарушений корковой динамики, которые имеют место в отдельных случаях. Восстановление нарушенного взаимодействия сигнальных систем является одним из благоприятных факторов, предупреждающих возникновение рецидивов данного заболевания. Только лабораторное исследование высшей нервной деятельности может вскрыть те или иные механизмы нарушения совместной деятельности корковых сигнальных систем и обеспечить возможность контроля за эффективностью применяемых терапевтических мероприятий.

Прежде чем перейти к дальнейшему изложению наших данных по изучению нейродинамики у алкоголиков, считаем необходимым дать некоторые пояснения к применяемой нами методике.

В работах по экспериментальному изучению высшей нервной деятельности человека и в особенности взаимодействия сигнальных систем, проведенных главным образом в лаборатории А. Г. Иванова-Смоленского, нашло полное подтверждение известное положение И. М. Сеченова и И. П. Павлова о том, что осуществление так называемых произвольных реак-

ций в нервной системе совершается по условнорефлекторному механизму. При этом было показано, что у человека условные реакции многообразны и качественно различаются между собой.

Совершенно очевидно, что в свете этих данных среди условных реакций человека можно выделить несколько групп, в зависимости от того, какое участие в них принимает та или иная из этих систем.

Если условный раздражитель — непосредственный и ответная реакция на него тоже непосредственная, то такие условные связи обозначаются сокращенно — Н—Н.

В данном исследовании такими реакциями и будут те, при которых испытуемый при виде того или иного предмета таблицы указывает на него. Здесь вид предмета есть условный сигнал, а движение при указывании на него — условная реакция. Если же предлагается посмотреть на предметы, но требуется уже произнести их название, то в таких случаях мы считаем, что имеют место условные реакции, обозначенные, как Н—С (так как условный сигнал — непосредственная, а ответная реакция на него словесная).

Когда же в качестве раздражителя предлагаются слова, произносимые или написанные на карточках, то в таких случаях имеет место словесный раздражитель и ответная реакция тоже словесная (сокращенные обозначения подобных реакций — С—С).

Исследуя таким образом работу и взаимодействие первой и второй сигнальных систем путем изучения корковых связей Н—Н; С—Н; Н—С; С—С, где первой буквой каждой пары по А. Г. Иванову-Смоленскому обозначается воздействие, а второй — характер ответа у хронических алкоголиков, мы нашли следующее: а) корковые связи Н—Н (непосредственный раздражитель — непосредственная реакция), т. е. наиболее ранние связи оставались ненарушенными; корковые связи С—Н (словесный раздражитель, а реакция непосредственная) оказались нарушенными в умеренной степени; корковые связи и Н—С (непосредственный раздражитель — словесная реакция) были нарушены значительно сильнее. Наиболее серьезные нарушения отмечались в корковых связях С—С (словесный раздражитель — словесная реакция). В ассоциативном эксперименте отмечалось, что ассоциации у большинства больных носили эхоталический или стереотипный, персеверирующий характер. Первое говорит о развитом и глубоком торможении. Очевидно вследствие имеющей место склонности к развитию пассивного торможения (в форме запредельного) тормозятся наиболее молодые сложные связи и растормаживаются старые, наиболее простые связи. Второе (персеверация) указывает на инертность раздражительного процесса. В исследовании (З. Л. Синкевич) о влиянии алкоголя на взаимодей-

ствие первой и второй сигнальных систем у здоровых лиц наблюдались случаи, когда принимаемый алкоголь вызывал рвотную реакцию и сон; при этом нарушения корковой динамики либо совсем отсутствовали, либо едва намечались. Эти реакции — рвоту и сон — мы расцениваем как защитные нервные механизмы от вредоносно действующего на корковые клетки алкоголя.

Справедливость такой оценки нашла подтверждение при анализе корковых изменений в тех случаях, когда больные длительно употребляли очень большие дозы алкоголя. Тогда вышеупомянутые защитные реакции нарушались (отсутствовала рвота, резко расстраивался сон). Между тем в корковой динамике наблюдались резкие нарушения.

И. П. Павлов на одной из своих сред (16 октября 1935 г.) фиксировал внимание собравшихся на следующем вопросе. Опытами М. К. Петровой на большом количестве собак и В. К. Федорова на одной собаке при хроническом отравлении животных алкоголем установлено «чрезвычайное» ослабление нервной системы, что нашло выражение в виде гипнотического состояния. Условные рефлексы у них снижались и наступали гипнотические фазы: уравнительная, парадоксальная или ультрапарадоксальная. Летний отдых несколько улучшал состояние этих собак, но не надолго. Их нервная система была настолько ослаблена алкоголем, что даже вне воздействия алкоголя условные рефлексы продолжали падать. На фоне ослабленной деятельности нервной системы и гипнотических фаз привлекает внимание крайне заинтересовавший И. П. Павлова неожиданный факт, который наблюдала М. К. Петрова: прием небольших доз алкоголя, применявшихся непосредственно перед опытом (0,5 г алкоголя в молоке), значительно улучшал состояние нервной системы животных, которая приближалась к норме. В других случаях М. К. Петрова давала большую дозу алкоголя (10 г после опыта) и производила исследование высшей нервной деятельности на другой день. Оказалось, что эта доза, значительно превышавшая предшествующую, также оказывала положительное воздействие на высшую нервную деятельность животных. «Вот теперь и поймите, — говорил И. П. Павлов, — что это значит, каким образом на фоне хронического алкогольного ослабления нервной системы применение дозы остро или даже на расстоянии суток как-то улучшает или восстанавливает нервную деятельность. Приходит в голову выражение „опохмелиться“: это как человек, который накануне здорово выпил и чувствует себя очень плохо до тех пор, пока не пропустит рюмочку. Тогда ему делается лучше. Кто его знает, имеет ли это какую-нибудь связь или нет, но я ничего другого придумать не мог»¹. А. А. Линдберг

¹ Павловские среды, т. III, 1949, стр. 222—224.

и В. К. Федоров на этой же среде подчеркивали, что приемы небольших доз хлоралгидрата у собак, находившихся в хроническом гипнотическом состоянии, приводили к увеличению условных рефлексов и укорочению обычной задержки при взятии пищи. И. П. Павлов подчеркивал, что гипнотическое состояние, гипнотические фазы при алкоголизме являются не болезненным явлением, а физиологической мерой против болезни, защитной реакцией, причем болезнь у собак, хронически отравленных алкоголем, выражается «не этим гипнотическим состоянием, а слабостью раздражительного процесса, для которого все обычные раздражители становятся запредельными»¹. И. П. Павлов далее указывал, что если для нервной системы возникает какая-либо трудность, как только собаку приводят в трудное состояние, то появляется гипнотическое состояние. «Почему трудное состояние нервной системы выражается в одной форме — гипнотическом состоянии?» — спрашивает И. П. Павлов — и отвечает: «Потому, что всякий раз, как наступает трудность для нервной системы, так в виде физиологического лечения выступает тормозной процесс в виде гипнотического состояния... Я попутно заговорил об этом, суть заключается в том — как понимать? Можно понимать так, что маленькие дозы как бы ослабляют действие тормозного процесса, что маленькие дозы прежде всего начинают устранять тормозной процесс. Это хорошее объяснение. Трудно было притти к этой мысли, потому что тут алкоголь, с одной стороны, вызывает гипнотизацию и слабость, а с другой — он же ее лечит»². Эти замечательные предположения И. П. Павлова о нервных механизмах «похмелья», другими словами, об абстинентном синдроме, вполне приемлемы и будут адекватными для объяснения похмелья у больных хроническим алкоголизмом. Путем исследования нейродинамики у больных хроническим алкоголизмом мы убеждаемся в наличии у них гипнотических фаз, уравнивающей, парадоксальной, а также в значительном ослаблении раздражительного процесса, о чем свидетельствует падение величины условной реакции и удлинение латентного периода к концу опыта. Все это говорит о быстрой функциональной истощаемости корковых клеток и о развитии в них запредельного торможения. Нарушается также правильное соотношение между первой и второй сигнальными системами в силу ясно выраженной тормозимости второй сигнальной системы, наличия в ней фазовых явлений; об этом может свидетельствовать увеличение латентного периода ответных речевых реакций при словесном эксперименте, а также появление примитивных, отказных, или эхалалических реакций, т. е. торможение более высоких и растор-

¹ Павловские среды, т. III, 1949, стр. 222—224.

² Там же.

маживание более ранних в онтогенетическом отношении речевых реакций. При лечении хронического алкоголизма дольше всего продолжают оставаться фазовые явления, полное исчезновение которых, как показали наблюдения З. Л. Синкевич, является благоприятным прогностическим признаком. Во время абстиненции — похмелья, как мы об этом уже говорили, усиливаются фазовые явления: прием небольших доз алкоголя ослабляет, рассеивает гипнотические фазы, т. е. снимает явления гипнотического торможения, что клинически выражается в кратковременном улучшении самочувствия больных, снятии пониженного, а нередко тревожно-тоскливого настроения, исчезновении физической слабости, устранении дрожания рук, т. е. временном смягчении синдрома похмелья. Таким образом, больные хроническим алкоголизмом, когда у них появляется абстинентный синдром, делают как бы зависимыми от алкоголя. Испытывая явления абстиненции после того как прекращается действие алкоголя и страдая от этого, они снимают эти явления или смягчают их приемом небольших доз алкоголя. Таким образом, получается порочный круг, что ведет к систематическому употреблению алкоголя, а затем и к проявлению хронического алкоголизма. По нашим наблюдениям, тяжесть абстинентного синдрома коррелирует со степенью нарушений высшей нервной деятельности, а также с тяжестью нарушения обмена веществ. Кроме того, на основе анализа клинической картины и исследования нейродинамики больных, абстинентный синдром мы считаем возможным представить как своеобразное изменение соотношения интероцептивных и экстероцептивных импульсов.

Прием больными алкоголя вызывает специфический поток импульсов, поступающих в кору из внутренней среды организма, измененную в результате воздействия алкоголя. Эти интероцептивные импульсы становятся условными возбудителями приема алкоголя, экстероцептивные раздражения (слухового, зрительного, обонятельного кинестетического анализатора) при таких состояниях отодвигаются, играя второстепенную роль. В физиологических условиях, как видно из работ лабораторий, руководимых К. М. Быковым, ведущую роль играют экстероцептивные раздражения, а интероцептивные раздражения имеют подчиненное, второстепенное значение. Это видно из того, что условные связи, при которых сигналами служат интероцептивные импульсы, отличаются тем, что они медленно вырабатываются и нестойки.

В патологических условиях, при алкогольном похмельном состоянии, они получают исключительное значение и начинают играть основную роль в реакции организма.

Для того чтобы научиться управлять абстинентным синдромом, купировать его, необходимо изучать особенности нервных механизмов, лежащих в основе этого синдрома.

С нашей точки зрения физиологически обоснованный путь подобного изучения должен идти по линии изучения нейродинамики, в частности, соотношения интероцептивных и экстероцептивных импульсов как условных возбудителей при данных состояниях. Этим, конечно, вся нейродинамика абстинентного синдрома не исчерпывается, ибо, наряду с вышеописанными явлениями, наблюдается быстрая истощаемость корковых клеток и развитие в них явлений запредельного охранительного торможения с фазовыми явлениями в мозговой коре, а также нарушение обмена веществ.

ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО АЛКОГОЛИЗМА

Рассматривая хронический алкоголизм в динамике, мы отмечаем ряд клинических особенностей, по которым можно судить о тяжести этого заболевания.

В начале заболевания, хотя таковое иногда крайне трудно установить, алкоголики испытывают лишь болезненное влечение к алкогольным напиткам. При малейшем поводе они напиваются допьяна. Они не мыслят себе приятного времяпровождения или отдыха без алкоголя. Вначале это бывает по праздникам, выходным дням, затем уже в часы, свободные от работы. Часто эти больные ищут забвения в алкоголе при неприятностях и жизненных невзгодах или пьют для вдохновения. Но они пока, как говорят, знают меру. Работоспособность долго не нарушается, а если и снижается, то незначительно. Деградация отсутствует. У большинства больных отмечаются лишь явления неврастенического или астенического синдрома. Такие больные не считают себя алкоголиками и возмущаются, если им говорят об этом заболевании.

При известном усилии воли больные еще могут владеть собой и прекратить прием алкогольных напитков. Иногда достаточно бывает авторитетного указания врача на вред алкоголя, чтобы больной бросил пить на тот или иной срок. Многие называют таких больных привычными алкоголиками.

Второй этап в клинике алкоголизма—появление абстинентного синдрома. Явления абстиненции, по мнению Жислина, возникают быстро, в течение 2—3 недель, обычно после алкогольных эксцессов или постепенно.

С. Г. Жислин абстинентный синдром в основном сводит к нервно-психическим нарушениям, главным образом со стороны вегетативной нервной системы с вестибулярными расстройствами, потливостью, дрожанием, явлениями со стороны сердца и т. п.

Наряду с этим, отмечается ряд серьезных изменений в психической сфере, выражающихся в страстном влечении к опохмелению, в тревожно-параноидной установке мышления больного с тенденцией к обильным несистематизированным идеям

отношения, в депрессивном фоне настроения, расстройстве сна и специфических сновидениях, носящих авантюрный характер и приближающихся к белогорячечным переживаниям.

Наши многочисленные данные полностью подтверждают описанную картину.

У некоторых алкоголиков синдром абстиненции установить не удается. С. Г. Жислин считает, что появление похмелья нередко видоизменяет течение алкоголизма в сторону дипсомании. Переход привычного пьянства в запойное подчеркивали еще старые авторы (Ф. Е. Рыбаков и С. А. Суханов).

Однако такая трактовка дипсомании, как нам кажется, не соответствует действительности; такую форму алкоголизма следует считать не истинной дипсоманией, а псевдодипсоманией, являющейся лишь обострением хронического алкоголизма, на что указывали и Мендельсон, и Рапопорт, и др.

Псевдодипсомания существенно отличается от истинной дипсомании. Необходимо отметить, что расстройства настроения при псевдодипсомании весьма часто отсутствуют, тогда как при дипсомании они всегда налицо. Отмечаются также случаи перехода запойного пьянства в систематическое.

Наконец третьим этапом в клинике алкоголизма является возникновение невыносимости к алкоголю и изменение характера опьянения.

Еще старые авторы отмечали, что хронические алкоголики совсем перестают переносить алкоголь и пьянеют от самого незначительного его количества. Такая невыносимость, повидимому, обуславливается резким ослаблением защитных нервных механизмов, утративших свое действие вследствие длительного отравления алкоголем, повышенной чувствительностью корковых клеток к алкоголю, тяжелым нарушением обмена веществ, а также нарушением окисления алкоголя. Вначале у больных в состоянии опьянения отмечается частичное нарушение сознания: они забывают отдельные эпизоды. В последующем наблюдается своеобразное нарушение сознания при опьянении в виде амнезии периода опьянения, однако ориентировка не нарушается. Больные могут вспомнить, когда и где они начали пить, но что с ними было, они не помнят. Амнезия опьянения находит отчасти свое нейродинамическое объяснение в опытах, проведенных З. Л. Синкевич.

В этих опытах было показано, что в состоянии опьянения после приема больших доз алкоголя условные связи возникают быстро, но после испытания их в течение нескольких раз разрушаются, как бы смываясь волной запредельного торможения.

Наряду с этим, больные, бывшие в состоянии опьянения веселыми, эйфоричными, шутниками, плясунами, становятся грубыми, злобными, агрессивными, склонными к патологиче-

ским аффектам. Эта форма опьянения по своей симптоматике приближается к патологическому опьянению.

Наряду с алкогольными эксцессами, у алкоголиков могут наступать либо спонтанные ремиссии, либо ремиссии после лечения (т. е. воздержание от употребления алкоголя в период от нескольких месяцев до нескольких лет), или же наблюдается полное излечение (т. е. воздержание от употребления алкоголя в течение всей последующей жизни). Во время ремиссии они не только не пьют, но и не испытывают болезненного влечения к алкоголю. Нередко в этом периоде у больных отмечается даже отвращение к алкоголю, однако у преобладающего большинства навсегда сохраняется готовность к рецидиву болезни, причем провоцирующим агентом, вызывающим рецидив, опять-таки является алкоголь.

Нам приходилось наблюдать алкоголиков, у которых даже после 10-летней ремиссии наступали рецидивы алкоголизма буквально от первой рюмки вина. Заглохшее, заторможенное влечение к алкоголю вновь проявляется с неудержимой силой даже после приема незначительного его количества.

Вопрос о рецидивах у алкоголиков представляет большой научный и практический интерес, но он почти не изучен. Специальных исследований по этому вопросу в доступной нам литературе мы не встречали. Наши клинические наблюдения показывают, что алкоголики не могут употреблять спиртные напитки в умеренном количестве. Даже небольшая доза алкоголя способна вновь вызвать болезненное влечение к нему, которое было заторможено во время длительного воздержания.

Хронический алкоголизм развивается тогда, когда образуются условные реакции, связанные с употреблением спиртных напитков, на раздражители как внешней среды (экстероцептивные), так и внутренней (интероцептивные).

Выздоровление, достигнутое в процессе лечения, нейродинамически, очевидно, можно рассматривать двояко: в процессе лечения угашаются условные связи на экстероцептивные раздражители, приводящие к приему алкоголя; угашение при этом происходит путем прямого воздействия через вторую сигнальную систему, когда со стороны врача поступают указания воздержаться от приема алкоголя, изменить в связи с этим свое поведение в определенных жизненных ситуациях, а также путем непрерывного самовнушения. При этом спиртные напитки своим видом, запахом и вкусом связываются с какой-либо вегетативной антиалкогольной реакцией (рвотой или сенсibiliзирующей). Важно не только то, чтобы условные алкогольные связи были угашены на экстероцептивные раздражители, но существенное значение имеет и то обстоятельство, чтобы на те сигналы, которые раньше вызывали тягу к алкоголю, были выработаны какие-то другие условные реакции (например, организация своего быта и развлечений в праздничные и свобод-

ные дни, физический труд, игра на музыкальных инструментах, спорт, прогулки, рыбная ловля, охота и т. п.). Необходимость не только угашения условных реакций на данные раздражители (в виде влечения к алкоголю), но и выработки на них других условных реакций диктуется предпосылкой из данных физиологии высшей нервной деятельности.

Дело в том, что угашенные условные связи, как известно, склонны к самопроизвольному восстановлению; это легко представить, если припомнить классические опыты с «угашением» не только на животных, но и на людях.

Если мы обратимся к какому-нибудь случаю угашения условной реакции у человека, то увидим, что при таких исследованиях условные сигналы дают один за другим, но они не сопровождаются подкреплением. В результате этого данный условный сигнал перестал вызывать ответную реакцию, в коре головного мозга при этом развивается тормозное состояние. Однако если данный опыт прервать и возобновить через несколько часов или дней, то обнаружится, что угашенная условная связь снова восстановлена, т. е. применение условного сигнала влечет обнаружение условной ответной реакции. Углубление угашения достигается в том случае, когда на условный сигнал угасаемой связи вырабатывается другая условная связь. В таком случае угасательное торможение углубляется по механизму отрицательной индукции с более поздней на более раннюю связь. Следует иметь в виду, что поток интероцептивных импульсов, тоже являющихся условными сигналами приема алкоголя, при всех этих процедурах не угашается.

Эти интероцептивные импульсы возникают, если больной выпьет вина. Возможно, что они легко оживляются и при других неблагоприятных условиях.

У большинства больных возникают ремиссии после лечения, самостоятельно или при наличии соответствующей ситуации. Длительность этих ремиссий колеблется в пределах от нескольких недель до нескольких лет. Влечение к алкоголю в этом периоде переходит в латентную форму, ничем не проявляясь или проявляясь во сне. Больным снится, что они покупают спиртные напитки, продают их, или же они видят себя пьяными; иногда им снится, что их угощают алкогольными напитками, но они отказываются. Через 1—2 месяца такие сны уже не повторяются.

Несмотря на длительность ремиссии, продолжающейся иногда свыше 10 лет, алкоголику достаточно выпить вино хотя бы один раз, как у него вновь появляется болезненная страсть к алкоголю: по большей части рецидив бывает настолько тяжелый, что больные становятся неспособными; они пьют до тех пор, пока их не изолируют дома или в больнице. Однако наблюдаются отдельные случаи, когда после многолетней ремиссии (9—10 лет) больные употребляют

спиртные напитки умеренно, как все здоровые люди, не привыкшие к алкоголю.

Мы изучали рецидивы у алкоголиков после длительных ремиссий, а также провели соответствующие экспериментальные исследования на больных, не употреблявших алкоголя длительные сроки и не испытывавших к нему влечения, с целью выяснить патфизиологию рецидивов, т. е. действительно ли принятый алкогольный напиток вызывает вновь болезненное влечение к алкоголю. Для этой цели больным, не испытывавшим влечения к спиртным напиткам, вводили алкоголь через желудочный зонд непосредственно в желудок или внутривенно.

Для иллюстрации приведем несколько историй болезни и протоколы экспериментов.

1. Больной Н., 62 лет, поступил в больницу по поводу рецидива алкоголизма после 12-летнего воздержания от алкоголя.

Развился нормально. В возрасте 8 лет его ушибла копытом лошадь. При этом на несколько часов потерял сознание. Самостоятельно работать начал с 17 лет. Женился 19 лет. С 1903 г. работал на почте и телеграфе в разных должностях. До заболевания был общительным, ни с кем не ссорился, избегал скандалов. Всегда был трудолюбивым, старательным, мягким, добродушным. Пить начал с 25 лет. Вначале пил случайно, но с 30 лет стал злоупотреблять алкоголем. Абстинентный синдром с этого же времени. Амнестическая форма опьянения с 32 лет. В возрасте 33 лет перенес белую горячку, после которой развился хронический галлюциноз, продолжающийся до настоящего времени.

Физическое состояние. Больной среднего роста, удовлетворительного питания, диспластического телосложения, выглядит значительно моложе своих лет. Глухие тоны сердца. Зрачки и зрачковые реакции в норме. Сухожильные и кожные рефлексы без особенностей. Реакция Вассермана и другие серологические реакции отрицательны.

Психическое состояние. Сознание ясное, наплыв слуховых галлюцинаций. К своим галлюцинациям привык, до некоторой степени сознает, что галлюцинирует.

После 12-летней ремиссии под новый год пришел к товарищу, который угостил его вином. Отказаться было неудобно. Выпил одну рюмку, затем вторую, после чего почувствовал сильное желание выпить еще. В результате впал в сильное опьянение. Не помнит, как был доставлен домой. Пил подряд 2 недели, почти ничего не ел. Был доставлен в больницу, где находился в течение месяца. После этого наступила ремиссия, которая длилась год — до тех пор, пока его вновь кто-то угостил вином. Больной не мог больше владеть собой и запил, испытывая непреодолимое влечение к алкоголю. Пил в течение 5 дней. Был повторно положен в больницу на 10 дней, после чего не пьет свыше 7 лет.

Интерес данного случая заключается в том, что, несмотря на 12-летнюю ремиссию, у больного вновь после первой же рюмки выпитого вина появилась болезненная страсть к алкоголю. Вспыхнув с неудержимой силой, она проявилась настолько бурно, что больной безудержно пил в течение 2 недель, стал нетрудоспособным, не выходил на работу.

В период злоупотребления алкоголем слуховые галлюцинации значительно ослабевали, но по прекращении действия алкоголя вновь обострялись.

2. Больной Г., 48 лет. Родился в срок. Развивался нормально, учился хорошо. После окончания школы поступил на производство, работал до 20-летнего возраста. Затем в течение 4 лет учился в консерватории. Работал в оперном театре, затем перешел на эстраду в качестве певца. Половой жизнью живет с 18 лет. Женился 25 лет.

Злоупотреблять алкоголем начал с 1927 г. Ежедневно выпивал 1 л водки. В 1928 г. 2 раза лежал в психиатрической больнице по поводу белой горячки. После беседы с врачом прекратил пить и не пил до 1930 г. В этот период совершенно не испытывал болезненного влечения к вину, угощал лишь других. После двухлетнего воздержания выпил случайно, полагая, что может пить вино нормально. Сразу же после того как выпил первую рюмку, сильно потянуло к вину. Пил подряд 6 дней, был помещен в психиатрическую больницу имени Соловьева, где лежал 2 месяца. По выходе из больницы не пил водки несколько месяцев. Под влиянием личных неприятностей снова начал злоупотреблять вином и опять был помещен в больницу. После выписки из больницы с 1937 г. вина не пил совсем до 24/V 1940 г. В это время испытывал даже отвращение к вину. Иногда лишь снилось, как пьют другие и его угощают. После таких сновидений чувствовал себя нехорошо. В мае 1940 г. произошли неприятности на работе. Пошел в ресторан с товарищами, выпил внакале бокал вина, но так как испытывал сильную потребность выпить еще, выпил 800 г водки и две бутылки красного вина. С этого дня начал пить регулярно, выпивая в день до 1 л водки. Потерял трудоспособность, все время лежал в кровати, ничего не ел, только пил водку и воду. Сон был тяжелый, с кошмарами. Даже во сне видел себя пьющим. Пил до тех пор, пока вновь не был помещен в больницу для алкоголиков.

В данном случае рецидив алкоголизма наступил после трехлетней ремиссии.

Трем больным, находившимся в больнице длительные сроки и не испытывавшим никакого влечения к вину, мы вводили в желудок алкоголь в замаскированном виде. Цель этих исследований заключалась в том, чтобы выяснить, каковы нервные механизмы, лежащие в основе рецидива алкоголизма, и как алкоголь растормаживает патологические условные реакции на него, ибо некоторые авторы неправильно считают, что рецидив у алкоголиков наступает вследствие тяжелого душевного конфликта в связи с нарушением требования врача о воздержании от спиртных напитков.

Для того чтобы больные не знали, что им вводится, мы подкрашивали алкоголь метиленовой синькой. Алкоголь вводился непосредственно в желудок через зонд, причем воронка располагалась на расстоянии 0,75 м от лица больного для того, чтобы он не ощущал его запаха. Больной был убежден в том, что ему вводят лекарство. При этом больному предлагали сообщать о всех ощущениях, связанных с введением «лекарства». Как правило, у всех больных появлялось болезненное влечение к вину буквально через несколько минут после того, как алкоголь поступал в желудок через зонд.

1. Больной Л., 48 лет, находился в больнице с 11/XI 1940 г. по поводу хронического алкогольного галлюциноза. Влечение к алкоголю исчезло еще в начале декабря 1940 г.

Завтракал в 8 часов утра. В 10 часов 43 минуты через желудочный зонд было введено 70 г водки, после чего больному было предложено

прополоскать рот кипяченой водой. Вскоре больной заявил: «Чувствую какое-то разогревание». Слуховые галлюцинации усилились. Голоса начинают ругать («что же это они делают?»). Больной оживился, лицо гиперемировано, выступила испарина. Чувствует себя, «как после 100 г водки», «настроение, как у выпившего». По пищеводу «отдает как бы горьковатым привкусом». Через 2 минуты после введения водки в желудок больной стал испытывать сильное желание выпить вина. Галлюцинации слуха ослабели. Больной слышит голоса: «Они влили ему какого-то спирта, это мы знаем». Писклявый голос говорит: «Не слушай ты никого, надо говорить чистую правду».

Через 22 минуты после введения в желудок алкоголя, как перед выпивкой, «сосет в области желудка и пищевода». Голоса очень далеко, как будто напевают под свист («хотя голоса тихие, но разборчивые»). Больной считает, что он пьян («голоса, как после градусов»). Чувствует согревание головы.

Больной оживленно жестикулирует, многоречив, говорит о себе. Мысленно поет песню, а голоса за ним подтягивают.

Интерес данного случая заключается в том, что у больного после двухмесячного пребывания в больнице алкоголь, введенный непосредственно в желудок, вызвал вновь болезненное влечение к вину, которое в процессе лечения было уже заторможено.

2. Больной Ч., 27 лет, находился в больнице по поводу хронического алкоголизма. После двухмесячного лечения в больнице, когда у него окончательно исчезло влечение к алкоголю, ему было введено через желудочный зонд 60 г водки. Через 5 минут больной стал испытывать головокружение, чувство сосания под ложечкой и желание выпить вина; появилось ощущение теплоты в голове и желудке. Сделался веселее («как будто выпил 100 г водки»). Желание выпить быстро нарастало («хотя бы стопку выпить», «если был бы на воле, то обязательно выпил бы»). Через четверть часа настроение хорошее. Сосет под ложечкой. Желание выпить настолько сильное, что его трудно преодолеть. Через час перестало сосать под ложечкой. Ослабело и желание выпить вина. Самочувствие хорошее. Небольшая слабость и боль в затылочной области.

3. Больной О., 48 лет, поступил в больницу 10/V 1941 г. по поводу обострения хронического алкоголизма. Поступает в больницу в 12-й раз. Ремиссии после лечения кратковременные (3—6 месяцев). Злоупотребляет алкоголем с 20 лет. По словам больного, пьет «все, что попало», «все, что содержит алкоголь». В пьяном виде добродушен, поет песни. Интолерантен к алкоголю. Несколько раз болел белой горячкой. Испытывает болезненную ревность к жене, полагая, что она сожительствует со всеми больными и с мужским медицинским персоналом больницы.

Физическое состояние. Больной очень слаб, лицо бледное, язык обложен. Тоны сердца глухие. Пульс 80 ударов в минуту, слабого наполнения. Печень болезненна, живот втянут. Зрачки широкие, вяло реагируют на свет. Сухожильные рефлексы повышены. Резко выражен тремор пальцев рук.

Психическое состояние. Сознание ясное, ориентирован. Обманов чувств нет. Лабильность эмоциональной сферы, память снижена; болезненное влечение к алкоголю, бессонница, тревога.

Через 14 дней после поступления в больницу состояние больного значительно улучшилось. Сон стал нормальным, исчезла болезненная ревность к жене. Влечение к алкоголю прошло. Больной физически окреп.

28/V (через 18 дней после поступления в больницу) в 12 часов 55 минут через желудочный зонд введено 30 г водки. Через 5 минут больной почувствовал теплоту в желудке («вроде опьянения», «как будто выпил большую дозу кофеина»), заболела голова в области затылка. В желуд-

же и пищеводе «сделалось тепло и хорошо». «Хочется быть молодым, лет двадцати».

Через 10 минут после введения алкоголя появилось непреодолимое влечение к алкоголю; больной просит дать ему выпить чего-либо спиртного, хотя бы денатурату. На вопрос, не хочет ли он молока, больной заявляет: «противно, вырвет», «молока не хочется, а вина хочется». В 13 часов 15 минут начал плакать, заявляя: «Нам, алкоголикам, не верят, а нас надо жалеть». На вопрос, почему он плачет, заявляет: «Эта болезнь, а в нее не верят, все от нас отказываются, а мы страдаем».

В 13 часов 20 минут состояние больного начало улучшаться. В 13 часов 30 минут его отвели в палату, где он вскоре уснул. После непродолжительного сна испытывал уже менее интенсивное влечение к вину.

Аналогичные результаты мы получали и при внутривенном введении алкоголя.

На основании изложенного мы считаем, что алкоголики дают патологическую реакцию на введенный алкоголь. Уже небольшая доза алкоголя вызывает болезненное влечение к нему. Даже после длительной ремиссии (свыше 12 лет) может наступить рецидив алкоголизма. Болезненное влечение к алкоголю возникает и тогда, когда он вводится больным непосредственно в желудок через зонд или внутривенно. Это объясняется тем, что алкоголь оживляет патологические условные связи (вкус, вид и запах вина, воздействие непосредственно через центральную нервную систему, интерорецептивные импульсы и т. п.), которые были заторможены. Ввиду того что у больных алкоголизмом появляется болезненная страсть к алкоголю после приема даже небольших доз его, несмотря на длительность ремиссии, таким больным необходимо в течение всей жизни воздерживаться от употребления алкогольных напитков даже в небольших дозах.

Исключительно редко встречаются алкоголики, которые не дают подобной реакции на алкоголь и умеренно употребляют его известное время, не испытывая после приема даже больших доз вина болезненного влечения к нему; однако рано или поздно у них наступает рецидив хронического алкоголизма.

ПРОГНОЗ И КАТАМНЕЗ

Многие исследователи относятся пессимистически к лечению алкоголиков, считая прогноз в таких случаях неблагоприятным. Однако проведенные исследования указывают, что прогноз при алкоголизме может быть вполне благоприятным, несмотря на частые рецидивы заболевания, которые наблюдаются при любой тяжелой хронической болезни.

Отдаленные результаты лечения алкоголиков почти не изучались. Имеющиеся в литературе отчеты некоторых частных лечебных учреждений для алкоголиков, показывающие высокий процент излечений, требуют критического к ним подхода.

Имеющиеся в литературе данные о результате лечения алкоголиков весьма разнообразны и порой крайне разноречивы.

Гальперин полагает, что амбулаторное лечение алкоголиков дает стойкое излечение в 3—5%, длящееся годами.

Мазур, основываясь на данных московских диспансеров, отмечает стойкое излечение (на протяжении 1—3 лет) у 10% алкоголиков.

А. М. Рапопорт на 200 амбулаторных катamnестически прослеженных больных констатировал у 15,5% ремиссию, длившуюся не менее 1½ лет.

Ф. Е. Рыбаков, изучавший материал московской психиатрической клиники с 1895 по 1901 г., где лечилось 54 алкоголика, катamnез собрал лишь у 26 человек. При этом через разные сроки у них наступал рецидив. Неудовлетворительный результат Ф. Е. Рыбаков объясняет тем, что срок пребывания больных в клинике был недостаточным.

Далее Ф. Е. Рыбаков отмечает, что алкоголиков можно лечить лишь одним гипнозом «амбулаторно», «на ходу». Применяя гипноз, он добивался ремиссии сроком не менее чем на один год почти у 40% алкоголиков, считая эту цифру минимальным показателем излечимости алкоголизма.

При продолжении лечения гипнозом в течение одного года этот процент, по мнению Ф. Е. Рыбакова, должен значительно увеличиться. Карачагин из 26 алкоголиков у 10 (38,5%) добился излечения сроком от 1 года до 10 лет. Токарский, лечивший 600 алкоголиков, считал, что у большинства из них можно добиться успешных результатов.

Наиболее оптимистические выводы сделал Абрамович, который считает, что при продолжительном лечении гипнозом (сроком не менее одного года) можно излечить каждого больного алкоголизмом.

Лемер (Lemere) и Холларен (Hollaren), лечившие 5000 хронических алкоголиков, за последние 14 лет в санатории Шеделя в Сиэтле, собрали катamnестические сведения у 4000 больных. Оказалось, что в 51% случаев они излечились и были здоровы. Эти больные лечились методом выработки рвотной условной реакции на алкоголь с помощью эметина. Значительное расхождение разных авторов в оценке результатов лечения на наш взгляд обусловливается следующими обстоятельствами: высокий процент излечений в некоторых частных лечебных учреждениях приводился, весьма возможно, с чисто рекламной целью, чтобы повысить приток больных в санаторий или амбулаторию; критерий «излечение», «полное выздоровление» и т. п. трактуется не везде одинаково, и не всегда одинаковая продолжительность срока воздержания от алкоголя принимается за критерий излечения. Вполне понятно, что врачи, считающие излечившимися тех больных, которые не употребляли алкоголя всего несколько недель или месяцев по выходе из лечебного учреждения или по окончании срока амбулаторного лечения, получают значительно больший процент так на-

зываемых излечений, чем врачи, которые критерием излечения считают срок воздержания от алкоголя от одного года до нескольких лет. Не у всех больных было заболевание одинаковой тяжести. Нет сомнения, что в более легких случаях алкоголизма — без психопатий, без тяжелой алкогольной дегенерации и без инвалидизации мозга разного рода вредностями (травма, возрастные факторы, сифилис и т. п.) — лечение будет более успешным, чем при тяжелом, осложненном алкоголизме.

Весьма важную роль в дальнейшей судьбе лечившегося играет среда, в которую он возвращается, а также дальнейшее внебольничное наблюдение.

Серьезное значение имеет и авторитет врача. Несомненно, что у высококвалифицированных психиатров, знакомых со спецификой и методами лечения алкоголизма, результат лечения будет значительно лучше, чем у менее опытных врачей.

Анализируя данные старых авторов (Ф. Е. Рыбаков), нельзя не отметить, что ранее стационарное лечение алкоголиков по преимуществу сводилось лишь к изоляции их в условиях клиники. Поэтому не удивительно, что и результаты такого стационарирования были неудовлетворительными.

Мы провели катamnестическое обследование 1000 алкоголиков, лечившихся в Московской психоневрологической больнице с 1930 по 1936 г. Лечение длилось в среднем 1—1½ месяца. Применялась психотерапия, вдухание кислорода, инъекции мышьяка, стрихнина, физиотерапия, трудотерапия и т. п. Большинство больных страдало алкоголизмом в тяжелой форме. Многие из них долгие годы находились на учете в диспансерах и лечились там, но безуспешно. Несмотря на тяжелую болезнь, эти лица большей частью продолжали работать, хотя и совершали прогулы, меняли место работы и т. п. На лечение в больницу они поступали через диспансеры непосредственно из дому. Лишь около 20% больных были уже не работавшими, инвалидами, хотя инвалидность они получали не по поводу алкоголизма, а из-за других заболеваний, сопутствовавших ему (артериосклероз мозга, тяжелые соматические заболевания и т. п.).

В группе больных, где нам удалось собрать катamnестические сведения, у 298 человек ремиссия длилась свыше года. Если мы примем за критерий выздоровления воздержание от алкоголя в течение года, и выше то увидим, что, несмотря на сравнительно короткий срок лечения (1—1½ месяца), удалось добиться хороших результатов у довольно значительной части этих больных (29,8%). Какова же дальнейшая судьба этих людей, у которых ремиссия продолжалась свыше года? В последующем у большинства из них все же наступил рецидив. Однако 40 человек (4%) совершенно не употребляли алкогольных напитков более 10 лет, вплоть до дня катamnестического обследования. Необходимо будет обстоятельно исследо-

вать в дальнейшем эту немногочисленную группу алкоголиков, которые как будто излечились окончательно.

Следует отметить, что у многих больных, которых стационарировали повторно, вновь наблюдались стойкие ремиссии. Поэтому весьма важно подобных больных при рецидиве алкоголизма немедленно стационаризовать хотя бы на короткий срок.

У больных второй группы, хотя и менее многочисленной, включавшей 225 человек (22,5%), ремиссия длилась меньше года.

Рецидив наступил вскоре после выписки из больницы у 36 человек (3,6%). Необходимо отметить, что у части больных после проведенного лечения отмечалось изменение течения алкоголизма: заболевание не прогрессировало, а, наоборот, имело тенденцию к улучшению, трудоспособность не нарушалась. Таких больных оказалось 90 человек (9%).

Современные методы лечения, базирующиеся на основе учения И. П. Павлова, дали возможность значительно повысить число излечений и ремиссий у больных хроническим алкоголизмом. Очевидно, при постепенном привыкании к алкоголю больные могут переносить без видимых тяжелых последствий даже большие его дозы. Нам известно много случаев, когда суточное количество выпиваемой водки равнялось 2—3 л. Эта повышенная выносливость к алкоголю основана, повидимому, не только на более быстром сгорании его в организме и на ускоренном выведении его, а главным образом на повышенной иммунности тканей к алкоголю. Однако прием больших доз алкоголя (1—3 л) без должной адаптации, т. е. без постепенного привыкания к нему, может привести к тяжелому отравлению и смерти. Мы наблюдали несколько случаев смертельного отравления алкоголем у больных, которые по выписке из больницы, отвыкнув от алкоголя, сразу начинали принимать те же большие дозы (1—3 л), к которым раньше они привыкали постепенно.

Рецидивы алкоголизма у большинства протекают тяжело. Больные испытывают трудно преодолимое влечение к алкоголю и поглощают его в больших количествах. В такие дни они почти ничего не едят. При отсутствии водки они пьют ее суррогаты. Во время рецидива больные вследствие тяжелой алкогольной интоксикации теряют трудоспособность, совершают прогулы. Иногда острое отравление алкоголем приводит к смерти.

В случаях тяжелого рецидива алкоголизма весьма важно срочно стационаризовать больного хотя бы на несколько дней. После такого кратковременного стационарирования у многих вновь наступает ремиссия, длящаяся от нескольких месяцев до нескольких лет. Изоляция этих больных и соответствующее лечение на дому могут способствовать купированию рецидива алкоголизма.

Отражается ли длительность употребления алкоголя на прогнозе? Большинство излеченных алкоголиков употребляло алкоголь в среднем от 10 до 25 лет; очевидно, что большая длительность алкогольной интоксикации еще не является критерием для плохого прогноза, равно как и короткий срок злоупотребления алкоголем не может служить опорным пунктом в этом вопросе. Казалось бы, что у лиц, употреблявших алкоголь всего несколько месяцев или 1—2 года, мы вправе были бы ожидать хороших результатов после стационарного лечения. Однако на практике так бывает далеко не всегда. Среди излеченных алкоголиков, имевших длительные ремиссии, встречалось немного лиц с легкими формами алкоголизма, хотя среди алкоголиков, лечившихся в больнице, таких больных было около 5%. Среди описанной группы не было больных, у которых алкоголизм сочетался бы с психическими заболеваниями — шизофренией, циркулярным психозом, эпилепсией и т. п. За небольшим исключением, у всех излеченных были неосложненные формы хронического алкоголизма. Исключением являлись больные с травматической энцефалопатией, составлявшие около 10% в группе больных, у которых лечение дало положительные результаты.

Для иллюстрации приведем краткие выписки из историй болезни выздоровевших алкоголиков, не употреблявших алкоголя свыше 20 лет.

1. Больной Б., 50 лет, поступил в больницу с жалобами на сильную тоску, пугливость, страха и болезненное влечение к алкоголю. Вырос в крестьянской семье. Перенес сыпной тиф, свинцовое и мышьяковое отравление. В возрасте 13 лет уехал в город, где работал в разных мастерских. С 1913 г. по настоящее время работает на фармацевтическом заводе. После отравления свинцом и мышьяком были парезы конечностей и запоры. Женат, детей не имеет. Жена больного страдает, так же как и сосед по квартире, алкоголизмом. Больной начал пить вино с 24 лет. С 25-летнего возраста пьет ежедневно. Лечился по поводу алкоголизма в наркологическом диспансере, но после 4 инъекций стрихнина прекратил лечение из-за боязни уколов. Максимальные перерывы в потреблении алкоголя — 6 дней. Лежал несколько дней в психиатрической больнице имени Кашенко (по поводу алкоголизма); после выписки из больницы вскоре запил. В пьяном виде быстро засыпает. Пьянеет постепенно. Пьет ежедневно по 1 л водки. Опохмеляется утром, выпивая 0,5 л водки, без этого не может работать. В состоянии похмелья отмечается отсутствие аппетита, слабость, потливость, тоскливое настроение. В пьяном виде иногда бывали обморочные состояния. Пропивал домашние вещи. Больной приветлив, общителен, хороший товарищ, веселый, легко сходится с людьми. В пьяном виде груб, раздражителен, злобен, мрачен, упрям, придирчив, иногда дерется.

Находился в больнице с 12/VII по 9/VIII 1930 г., т. е. 28 дней. За этот период у него выровнялось настроение, восстановился сон, аппетит, исчезло болезненное влечение к алкоголю. После лечения в больнице — с 9/VIII 1930 г. по настоящее время не пьет. Ведет большую общественную работу.

Данный случай весьма показателен в том отношении, что, несмотря на неблагоприятное окружение (алкоголизм жены и

соседа по квартире), а также сравнительную тяжесть заболевания, больной вполне излечился и не употребляет алкоголя более 20 лет.

2. Больной С., 38 лет, доставлен в больницу с явлениями белой горячки. При поступлении зрительные галлюцинации (мелкие животные), дезориентирован в окружающем, ориентировка сохранена лишь в отношении своей личности. Сильный тремор рук, страх, бессонница. Через 3 дня после поступления в больницу делириозные явления прошли. Рос и развивался нормально. Учился 2¹/₂ года. С 12 лет служил в городе мальчиком в магазинах, а затем рабочим. С 1915 по 1917 г. был на фронте. В 1917 г. болел воспалением легких. Вино начал пить с 18 лет; приучили пить сослуживцы. Вначале пил изредка, с перерывами до 2 лет. С 1914 по 1922 г. совершенно не пил вина. Последние два года ежедневно пьет водку, самогон, денатурат, политуру и другие суррогаты от 0,5 до 1 л в день. Быстро пьянеет и тут же засыпает. В состоянии похмелья страх, бессонница, плохое самочувствие, отсутствие аппетита, физическая слабость («мучает совесть, что пью, надоела такая жизнь; хочется бросить пить, но мешает компания»).

Больной среднего роста, правильного телосложения, ослабленного питания. Зрачки равноммерны, реакция на свет живая, сухожильные рефлексы нормальные. Положительный симптом Ромберга. Сильный тремор век и рук. Эмоционально неустойчив, слабодушен. Снижение внимания и памяти. Понижение импульса к труду. Обманов чувств и бредовых идей нет.

Находился в больнице почти 2 месяца. За это время значительно окреп. Исчезли галлюцинации, восстановился сон и аппетит. Влечение к алкоголю прошло. Настроение стало хорошим, жизнерадостным.

Диагноз: хронический алкоголизм, белая горячка.

Катамнез. Со дня выписки из больницы, т. е. 18 лет, не пьет; последнее время бросил и курить.

3. Больной С., 37 лет. Развивался нормально, учился хорошо. Окончил сельскую школу. Перенес корь, скарлатину, малярию. Жил в деревне до 11 лет. С 12 лет работал самостоятельно. С 1914 по 1921 г. находился на военной службе, в 1917 г. был контужен. Последние годы работает в типографии. Начал пить вино с 23 лет. Сильно злоупотребляет алкоголем последние 6 лет. Пьет ежедневно по 1 л водки. В состоянии опьянения спокоен, никого не затрагивает, уединяется, быстро засыпает. Опохмеляется в течение последних 2—3 лет. В больницу направлен наркодиспансером.

Больной среднего роста, атлетического телосложения, удовлетворительного питания. В легких сухие хрипы. Отмечается эмоциональная неустойчивость, повышенная раздражительность; психотических явлений не наблюдается. По характеру веселый, общительный, периодически наступает дисфория, длящаяся несколько дней. Умеренное ослабление памяти. За время пребывания в больнице значительно окреп.

Выписан через 40 дней после поступления в хорошем состоянии.

Катамнез. В течение всего периода, т. е. больше 17 лет, совершенно не пьет, повысил свою квалификацию и работает в настоящее время мастером-штамповщиком.

Таким образом, несмотря на несколько неблагоприятный анамнез (контузия), эмоциональную неустойчивость, дисфорию и сравнительную тяжесть алкоголизма, лечение дало хорошие результаты.

Резюмируя все изложенное, можно отметить, что тяжесть алкоголизма, нездоровая среда и плохие бытовые условия не

всегда служат достаточным критерием при постановке прогноза и не всегда у таких больных он бывает плохим.

Описанные нами больные как будто не подавали надежды на излечение, однако у них была достигнута стойкая ремиссия. Несомненно, большое значение в этих случаях имела хорошая установка на лечение и твердое решение покончить со своим болезненным влечением.

Искреннее и твердое желание больного излечиться является фактором, благоприятно сказывающимся на дальнейшей судьбе алкоголика. Еще Рыбаков говорил: «Помещение пьяницы в лечебницу, если только он не душевнобольной, никоим образом не должно носить принудительного порядка». С этим, конечно, нельзя не согласиться, исключая отдельных больных, а также социально опасных алкоголиков, лечение которых должно проводиться в принудительном порядке.

Мы наблюдали, что в тех случаях, когда больных помещали в больницу вопреки их желанию, не всегда получались удовлетворительные результаты. И это вполне понятно, ибо основной метод лечения алкоголиков, исключая терапию антабусом, базируется на психотерапевтическом воздействии при хорошем контакте с больным.

Небезынтересным является еще один пример, который демонстрирует стойкое излечение при вторичном стационарировании больного, несмотря на безуспешность стационарного лечения в той же больнице в первый раз.

Больной С., 32 лет, стационарирован в первый раз 3/VI 1930 г. с жалобами на подавленное настроение, гипногигические галлюцинации. Поступил в больницу по собственному желанию.

Родился в крестьянской семье среднего достатка. Развивался нормально. В детстве «был озорным, ни в чем никому не давал спуска». Окончил сельскую школу в 9-летнем возрасте. Десяти лет был отдан в учение к кустарю-стеклодуву, где работал 3 года. Пить начал с 16-летнего возраста, употребляя суррогаты алкоголя в небольшом количестве. С 1925 г. стал пить по любому поводу: в получку, праздники, выходные дни и т. п., главным образом в компании по вечерам, после работы. С начала 1930 г. пьет ежедневно по 0,5 л водки и немного пива. В состоянии опьянения груб, злобен, ругается, придирчив; пьянеет постепенно, долго не может спать. В состоянии похмелья плохое самочувствие, физическая слабость, потеря аппетита.

Больной среднего роста, ослабленного питания. Отмечается асимметрия лица. Со стороны внутренних органов отклонений от нормы нет. Левая носогубная складка сглажена. Зрачки равномерны, реакция на свет хорошая. Сухожильные рефлексы резко повышены. Тремор век и рук. Больной приветлив, хороший товарищ, веселый, общительный, легко сходится с людьми, но долго не уживается. Припадки отрицает. Грубых нарушений интеллекта нет. Эмоционально неустойчив.

Находился в больнице с 3/VI по 20/VII 1930 г. Выписан в хорошем состоянии. Через 1½ месяца после выписки снова стал пить. Вначале пил умеренно, затем стал ежедневно злоупотреблять алкоголем.

Поступил в больницу повторно 20/X 1933 г. и лечился до 1/XI того же года — всего лишь 11 дней. С тех пор не употребляет алкогольных напитков в течение 19 лет.

Из данного примера видно, что плохой результат лечения, полученный в первый раз, не может служить основанием для плохого прогноза в дальнейшем. Повторное стационарное лечение во многих случаях может дать хороший результат, в чем мы неоднократно убеждались.

С трудом поддаются излечению деградированные алкоголики, на которых психотерапия уже не влияет и которые не осознают своего тяжелого положения, а также те больные, у которых алкоголизм осложнен нервно-психическими заболеваниями. Однако верных критериев для прогноза мы имеем пока недостаточно. Нередко у алкоголиков, которых врачи считают безнадежными, лечение, особенно современными методами терапии, базирующимися на учении И. П. Павлова, дает благоприятные результаты, и, наоборот, больные, кажущиеся излечимыми, иногда трудно поддаются лечению.

Значительный интерес представляет изучение причины смертности у алкоголиков. В этом плане мы изучили 164 случая. При этом непосредственной причиной смерти были следующие заболевания: острое отравление алкоголем — в 40 случаях, туберкулез легких — в 20, болезни сердца — в 16, воспаление легких — в 44, рак — в 4, кровоизлияние в мозг — в 4, другие болезни — в 5 случаях. Причиной смерти 21 больного были несчастные случаи и в 10 случаях другие заболевания.

Как видно из вышеприведенных данных, причины смертности среди алкоголиков отличаются некоторыми особенностями. Чаще всего они умирали от воспаления легких, острого отравления алкоголем, туберкулеза легких, болезней сердца. Это объясняется тем, что заболевания, не имеющие непосредственного отношения к алкоголизму, протекают у алкоголиков тяжелее, чем у лиц непьющих. А. П. Майсюк изучала изменения печени и легких у хронических алкоголиков на основании 436 историй болезни и протоколов вскрытий. Это были исключительно мужчины в возрасте от 30 до 90 лет, лечившиеся в соматической больнице имени Медсантруд. Сопоставляя летальность среди алкоголиков с летальностью среди больных одного и того же возраста и пола, но не пьющих или употребляющих алкоголь умеренно, А. П. Майсюк пришла к неправильному выводу об отсутствии определенного влияния алкоголя на длительность жизни. Наши данные, базирующиеся на большом количестве наблюдений, говорят о том, что летальность среди алкоголиков в 10 раз выше, чем среди людей той же возрастной группы, ведущих трезвый образ жизни. А. П. Майсюк установила, что при хроническом алкоголизме заболевание легких, бывшее основным, явилось причиной смерти 53,8% больных против 33,4% больных контрольной группы, причем крупозная пневмония и обусловленная ею смертность среди алкоголиков наблюдались в 22,8% против 13% в группе непьющих. Спинола (Spinola) указывал, что

от крупозной пневмонии умирало 50% алкоголиков, а среди неалкоголиков — только 10%. Осложнения при крупозной пневмонии у алкоголиков встречались чаще, чем у лиц непьющих. Острые инфекции, по данным А. П. Майсюк, как основное заболевание явились причиной смерти у алкоголиков в 24,3 против 14,8% в группе непьющих. Процент лиц с общим артериосклерозом среди алкоголиков не превышает того же показателя среди непьющих (6,5 против 6,6%). Милиарный туберкулез во всех возрастных группах алкоголиков встречался значительно чаще, чем в группах непьющих (22,2 против 2,6%). Изолированный туберкулез у алкоголиков (кишечника, брюшины, органов мочеотделения) встречался чаще, чем у непьющих (17,8 против 3,6%). Атрофический цирроз печени у алкоголиков имел место в 1,4% случаев, а у непьющих — в 0,8%. Сопутствующие заболевания легких у алкоголиков наблюдаются значительно чаще, чем у непьющих: например, эмфизема легких в 63,8% случаев против 14,1%, туберкулез в 17,1 против 4,5%; бронхит, бронхоэктазия и пневмосклероз отмечаются у 67% алкоголиков, т. е. процент легочных заболеваний у них в 3—4 раза выше, чем у людей, не употреблявших алкоголя. При хроническом алкоголизме вес печени выше, чем в контрольной группе, на 17%, что А. П. Майсюк связывает с ожирением печени, которое наблюдалось в 95,3% случаев. Злокачественные новообразования у алкоголиков, по данным этого же автора, наблюдались вдвое реже, чем в контрольной группе, — 8,7 против 14,9%.

Между тем А. А. Богомолец считал алкоголь одним из факторов, способствующих развитию рака. В изученной нами группе больных алкоголиков мы тоже встречали рак чаще, чем у больных контрольной группы. В группе изученных нами умерших больных алкоголиков у 10% смерть наступила от злокачественных новообразований. По данным А. П. Майсюк, заболевания органов пищеварения в качестве основного заболевания, приведшего к смерти, встречались у алкоголиков реже, чем у непьющих (12,8 против 26,7%). Наши данные значительно расходятся с данными А. П. Майсюк. Это объясняется тем, что мы изучали летальность у тех лиц, у которых алкоголизм был диагностирован в специальной клинике, а Майсюк исследовала патологоанатомический материал на основе историй болезни случаев, где ведущую роль играли соматические заболевания, а алкоголизм являлся сопутствующим заболеванием. Иногда все же встречаются случаи, когда при длительном злоупотреблении алкоголем не поражается ни один важный для жизни орган. Такие алкоголики могут доживать до глубокой старости.

Обращает на себя внимание значительная летальность среди алкоголиков от воспаления легких, причем в ряде случаев, вследствие понижения защитных реакций организма, это за-

болевание у них не поддается воздействию антибиотиков и сульфаниламидных препаратов. Смерть наступает главным образом от слабости сердца, которое у большинства алкоголиков патологически изменено. Почти у 80% алкоголиков (по нашим данным) было обнаружено расширение сердца и миокардиодистрофия; на электрокардиограмме у них отмечаются изменения в миокарде различной степени.

У больных изученной нами группы имела место тяжелая форма хронического алкоголизма. Почти все они (104 человека) употребляли большие дозы алкоголя (водки) — от 1 до 3 л в день — и лишь значительное меньшинство выпивало от 0,5 до 1 л.

Результаты лечения этих больных представляются в следующем виде: немедленно после выписки из больницы наступил рецидив у 21 человека (свыше 20%), а у 49 человек (около 50%) наблюдалась ремиссия длительностью от 3 месяцев до 1 года; у 34 человек установить результаты лечения не удалось.

Как показали наши данные, больные с тяжелыми формами алкоголизма, не поддающиеся излечению или давшие после лечения короткую ремиссию, нередко уже через несколько лет погибали от разного рода заболеваний или острого отравления алкоголем. Смертность у алкоголиков, по нашим данным, в 10 раз, а по Габриэлю — в 6—20 раз выше, чем среди пьющих больных тех же возрастных групп.

Экспериментальными опытами на животных доказано, что под влиянием малых и средних доз алкоголя способность к фагоцитозу понижается.

Длительная алкогольная интоксикация ведет к уменьшению количества лейкоцитов и отрицательно влияет на защитные реакции организма.

В капиталистических странах алкоголики нередко кончают жизнь самоубийством. Эрнст Габриэль (E. Gabriel) (Германия), исследовавший причины смертности алкоголиков, лечившихся в его клинике, установил, что около 20% из них кончали жизнь самоубийством и почти в таком же проценте случаев погибали от туберкулеза и сердечно-сосудистых заболеваний. Самоубийство совершается алкоголиком в пьяном виде, в состоянии депрессии, похмелья или под влиянием психической травмы.

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ

При алкоголизме наблюдается помутнение и утолщение (фиброз) мягкой мозговой оболочки (рис. 9). Данные микроскопического исследования (рис. 9, 10, 11) представлены проф. М. М. Александровской. Изредка встречается геморрагический пахименингит. Часто отмечается гиперемия и отек

мозга. У пожилых алкоголиков мозг уменьшается в объеме и весе, что обуславливается атрофическими процессами. У алкоголиков находили утолщение костей черепа. В центральной нервной системе, а также в периферических нервах отмечаются распространенные дистрофические изменения. В нервных

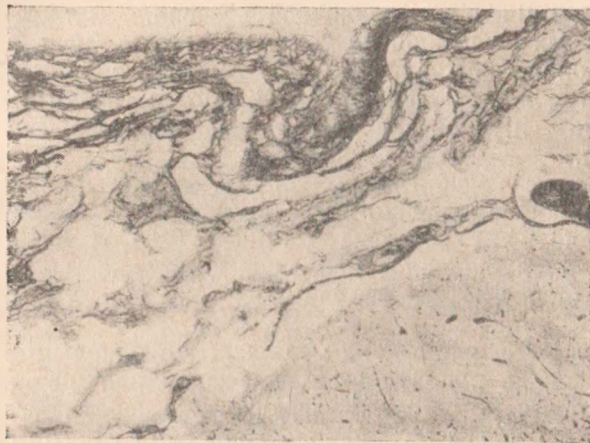


Рис. 9. Фиброз мягкой мозговой оболочки при алкоголизме (окраска по Снесареву).

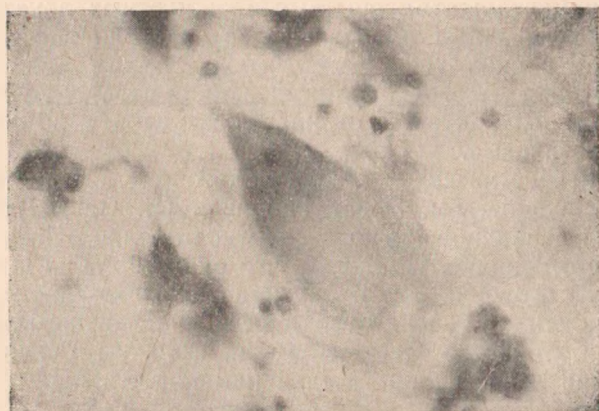


Рис. 10. Набухание, тигролиз бетовских пирамидных клеток в коре большого мозга (окраска тионином).

клетках обнаруживается жировое перерождение, хронические изменения, сморщивание ядра; наблюдается также и размножение глии. Поражение нервных клеток имеет место не только в коре, но и в подкорковых узлах, мозжечке и спинном мозгу.

В стволовой части мозга и в спинном мозгу (в голлевских столбах) наблюдается распад нервных волокон. Вокруг сосудов отмечается значительное скопление продуктов распада. Часть нервных клеток погибает, причем это явление наблюдается в виде островков, расположенных вокруг наиболее пораженных сосудов.

В некоторых нервных клетках наблюдается сморщивание вследствие дегенеративных изменений, вызванных алкогольной интоксикацией.



Рис. 11. Укрупнение и огрубение аргирофильных зернистостей в нервных клетках и по их периферии при алкоголизме.

При хроническом алкоголизме, осложненном пеллагрозными и другими изменениями в обмене веществ, отмечается набухание нервных клеток, тигролиз со смещением их ядер к периферии. При этом определяется также набухание с просветлением тигроидного вещества (рис. 10), тигрелиз бецовских пирамидных клеток в коре большого мозга. Наконец, новейшие окраски на зернистость свидетельствуют об укрупнении, огрубении аргирофильных зернистостей как внутри нервных клеток, так и по их периферии (рис. 11). В тяжелых случаях находят мелкие кровоизлияния в коре, подкорковых образованиях и под эпендимой. При алкогольном слабоумии (Плюминаж, Сантагати и Ферраци) обнаруживают атрофические изменения в коре с запустением и вторичным расширением желудочков. Эти изменения могут быть установлены при жизни с помощью пневмоэнцефалографии.

М. О. Гуревич указывает, что «хроническому алкоголизму» свойственны диффузные изменения, распространенные по всей

нервной системе, и очаговые поражения (местный паренхиматозный распад, глиозные рубцы), кровоизлияния преимущественно расположенные в определенных местах, главным образом под эпендимой, на дне третьего желудочка, в силвиевом водопроводе, а также в согрога *mamillaria*. В периферических нервах отмечаются явления неврита с распадом миэлина и разрушением осевых цилиндров. Сердце, печень и значительно реже почки подвергаются дистрофическим изменениям (жировой инфильтрации) (см. стр. 41). В желудке отмечаются воспалительные явления.

ПРИЧИНЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

Свойство алкоголя вызывать у большинства людей эйфорию, поднимать настроение, заглушать тоску способствовало широкому внедрению его в быт многих народов.

Частое потребление спиртных напитков ведет к постепенному привыканию к ним (аналогично тому, как наблюдается привыкание к табаку, морфину и т. п.).

Однако имеется немало людей, которые в течение всей своей жизни употребляют алкоголь в умеренных дозах без патологического привыкания к нему. Некоторые авторы считают алкоголизм болезнью обмена. Слюс (Sluss) полагает, что у алкоголиков имеется определенный тип обмена. Он указывает, что у многих из них отмечается гипадренкортицизм, что выражается в обилии волос на голове и значительно меньшем количестве их на теле. Облысение у алкоголиков встречается якобы в 8—10 раз реже, чем у лиц непьющих. Согласно этому автору, тип распределения волос на теле обуславливается ролью адреногонадальных стероидов. Однако следует помнить, что нарушение обмена не предшествует алкоголизму и не predisposes к нему, как об этом пишет Слюс, а является следствием его. Дж. Смит (1950) на основе изучения (2 000) больных с острым и хроническим алкоголем пришел к выводу, что алкоголики страдают недостаточностью надпочечных и половых желез. Если гипофиз не производит количества гормонов, достаточного для стимулирования надпочечных и половых желез, то в результате этого появляется тягостное состояние, которое устраняется выпивкой. Тинтера и Ловелл (Tintera и Lovell) также указывают на значение эндокринного фактора в алкоголизме, но они считают, что гипадренкортицизм может возникнуть в результате алкоголизма и поэтому от него можно излечиться с помощью адренкортикальных препаратов.

Гольдфарб и Берман (Goldfarb и Berman) на основе обзора многочисленной литературы, посвященной эндокринной патологии, возникающей на почве чрезмерного потребления алкоголя, приходят к выводу, что следствием алкоголизма является

нарушение функции гипофиза, щитовидной железы и коры надпочечников. Что касается надпочечников и щитовидной железы, то вначале наблюдается повышенная активность их, а за нею следует истощение и дегенерация; в коре надпочечников, по авторам, сразу наступает вторая фаза. Сами авторы установили заметное увеличение лимфоцитов у алкоголиков, что, по их мнению, указывает на понижение функции коры надпочечников.

Нельзя согласиться также с утверждением Вильямса, который влечение к алкоголю объясняет недостатком витаминов и особым унаследованным видом обмена. Вильямс проводит параллель между влечением к алкоголю и наблюдающимся у некоторых лиц влечением к кальцию после паратиреоидэктомии, к сахару у больных диабетом, в этом случае хотя в крови и много сахара, но весь он выделяется с мочой и не утилизируется организмом, поэтому в тканях получается его недостаточность). Однако эта аналогия не выдерживает критики, так как алкоголь не составляет нормальной составной части тканей. Кроме того, физиологическая тяга к наркотическому веществу обуславливается вызываемым им эффектом (эйфория и т. п.), причем опьяняющие вещества наркоманы иногда заменяют другими веществами, иногда совершенно другого химического состава, но с однородным по эффекту действием, например, хлоралгидратом, барбитуратами, и т. п. Тут играет роль не особый тип обмена, наследственно обусловленный, а просто возможность достать то или иное средство. Тот факт, что нередко в нескольких поколениях одной семьи наблюдается алкоголизм, объясняется не модифицированной Вильямсом новой теорией наследственности и не особым типом обмена, а влиянием окружающей среды и окружающей обстановки.

Нужно сказать, что пока еще недостаточно известны причины, почему у одних людей наступает болезненное привыкание к алкогольным напиткам, а у других такое привыкание не развивается. Следует лишь отметить, что среди лиц, у которых алкоголь не вызывает повышенного настроения, не приводит к эйфории, а также среди лиц, у которых он вызывает плохое самочувствие, головную боль и т. п. алкоголиков не встречается. Нет также алкоголиков и среди лиц, тем или иным способом сенсibilизированных к алкоголю.

В этом направлении интересны наблюдения проф. И. Г. Равкина, который отметил, что у лиц, работающих на нитроглицериновом производстве, развивается невыносимость к алкогольным напиткам. После приема алкоголя у них появляется сильная головная боль, плохое самочувствие, неприятные ощущения в области сердца и т. п. Аналогичная картина наблюдается и у работающих с техническим антабусом — тетраэтилтиурамдисульфидом, который применяется в резиновой промышленности как катализатор при вулканизации резины. Алко-

голиками становятся не только слабовольные, но и волевые люди в результате переоценки своих сил; они считают, что могут прекратить потребление алкоголя в любое время, но, привыкнув к алкоголю, часто бывают не в силах от него отказаться.

Некоторую роль в развитии алкоголизма могут играть нервно-психические заболевания, ведущие к быстрой утомляемости, упадку сил, расстройству настроения — депрессии или дисфории (например, травмы головного мозга, реактивные депрессии, депрессии циркулярного характера при циклофрении, астено-депрессивный синдром различного генеза и т. п.).

Многие зарубежные авторы, исходя из аутогенетических теорий наследственности Вейсмана, Менделя и Моргана, основную причину алкоголизма видели в патологической алкогольной наследственности.

Замечательные работы И. В. Мичурина, наметившего пути развития советской биологической науки, сыграли выдающуюся роль в ее непримиримой борьбе с формальной генетикой.

Ошибочные теории Вейсмана, Менделя и Моргана, тормозившие развитие биологической науки, были опровергнуты Т. Д. Лысенко. В своем докладе «О положении в биологической науке», сделанном на сессии Академии сельскохозяйственных наук, Т. Д. Лысенко доказал всю несостоятельность этих теорий.

Наши исследования, проведенные в течение многих лет более чем на 15 000 алкоголиков, показали, что наследственность у них мало чем отличается от наследственности здоровых и не имеет приписываемого ей значения в развитии алкоголизма.

Известную роль в развитии алкоголизма играют половые и возрастные факторы. Так, очень мало алкоголиков встречается среди женщин (в большинстве стран на 10 алкоголиков-мужчин приходится одна женщина), хотя в Англии эта разница между мужчинами и женщинами почти сглаживается.

Только с развитием капиталистического строя алкоголизм превратился в социальное бедствие. Алкоголизм является прямым порождением эксплуататорского общества.

Капиталистическое производство уродует человека и физически, и духовно. Одновременно с ростом производительности труда в капиталистических странах происходит процесс относительного и абсолютного обнищания трудящихся, снижения их жизненного уровня. Трудящийся находится в полной зависимости от предпринимателя, всегда стоит под угрозой увольнения и в любую минуту может попасть в число безработных. У него нет чувства уверенности в завтрашнем дне.

Капиталистическая машина так быстро истощает силы рабочего, что уже в возрасте 40—50 лет он становится обузой для предпринимателя, который выбрасывает его за ворота. В печати неоднократно приводились факты, свидетельствующие

о том, что некоторые предприниматели не принимают на работу лиц старше 40 лет.

Экономическое притеснение и бесправие трудящихся неизбежно вызывают и порождают всевозможные виды угнетения политического и социального характера, приводят к затемнению духовной и нравственной жизни массы, и в этом алкоголь также играет далеко не последнюю роль.

Главной движущей силой роста алкоголизма в капиталистических странах являются социальные факторы. Эксплуатация, общественное неравенство, изнурительный труд, неудовлетворительные жилищные и бытовые условия, плохая пища, тяжелое моральное состояние, беспросветность существования, а также развитие крупнозаводского массового производства алкогольных напитков — все это определяет широкое распространение алкоголизма.

Характерно, что развитие алкоголизма идет параллельно росту обнищания масс и резкому снижению их жизненного уровня.

Пулар-Штрекер (Н. Pullar-Strecker), базируясь на данных проф. Елинека (председателя Комиссии экспертов по статистике алкоголизма при Всемирной организации здравоохранения), приводит показатели развития алкоголизма в 11 странах.

На первом месте в этом отношении стоит Швейцария (1,6‰ от всего взрослого населения), за ней следует Чили и Франция (1,4‰), далее США (0,95—1‰). На последнем месте находится Англия (0,28‰), Финляндия и Норвегия. Италия, Дания, Швеция и Австрия занимают среднее положение.

Разбирая вопрос о степени развития алкоголизма в той или иной стране, автор останавливается на влиянии климата.

Вопросы связи климата с развитием алкоголизма давно привлекали внимание исследователей. Еще в XVIII веке Монтескье утверждал, будто алкоголизм усиливается в направлении от экватора к северу. Однако мы считаем, что попытка связать вопрос распространения алкоголизма такими факторами, как климат, время года и т. п., лишена основания.

Во Франции, по данным Л. Деробера (L. Derobert), в 1950 г. число смертей от алкоголизма было 2362, что составляло 5,6 на 100 000 населения, а в 1951 г. число таких смертей было 2653, что составляло уже 6,2 на 100 000 жителей. Смертность от цирроза печени (развившегося только на почве алкоголизма) в 1950 г. имела место в 6692 случаях, что составляло 16,4 на 100 000 населения, а в 1951 г. соответственно был уже 8341 смертный случай, или 19,6 на 100 000 жителей.

В США в 1951 г. из всех видов заболеваемости алкоголизм и несчастные случаи, связанные с ним, занимали второе место. Это видно из следующих данных:

Сердечные и сосудистые заболевания — 10 000 000 человек; алкоголизм и несчастные случаи, связанные с ним — 8 940 000; артрит и ревматизм — 7 000 000; диабет — 2 000 000; рак — 700 000; венерические болезни — 512 000; туберкулез — 422 000 человек.

Некоторое представление о смертности от алкоголизма дает опубликованная Всемирной организацией здравоохранения статистика смертности в разных странах за 1939—1946 гг. по причинам; в числе прочих причин имеется рубрика «Алкоголизм острый и хронический» в абсолютных числах и в показателях на 100 000 жителей.

Из этих данных, относящихся к 27 странам, видно, что наивысшая смертность от алкоголизма наблюдается в винодельческих странах, в странах Южной Америки, Сальвадоре, Чили, а также в США.

Несомненно, эти официальные данные весьма преуменьшены и не отражают истинного положения вещей, особенно в настоящее время, ибо в странах капитала в послевоенный период отмечается резкий подъем алкоголизма.

Мак Карти (McCarthy) в американском журнале «Паблик хелс» сообщает о том, что на основе соответствующих исследований установлено, что от 50 до 70% лиц, попавших в американские тюрьмы, отбывает в них заключение по делам, в той или иной мере связанным с опьянением. А поскольку это составляет большое финансовое бремя для государства, то органы юстиции некоторых городов, в частности, Лос-Анжелоса, обратились к университетам с просьбой включить в план своих исследований проблему алкоголизма и его лечения. В печати отмечалось, что, хотя эта проблема в США разрабатывается уже в течение ряда лет университетами и институтами, тем не менее до сих пор еще не выяснено, что заставляет людей злоупотреблять алкоголем.

В США много внимания уделяют вопросу изучения и лечения алкоголизма, и несомненно в этом отношении там достигнуты некоторые успехи. Однако в зарубежных странах недоучитывают социальные корни алкоголизма и основное внимание направляют на изучение биологических факторов, между тем как социальные факторы играют в этом случае ведущую роль.

Ф. Энгельс в своей работе «Положение рабочего класса в Англии» вскрыл социальные причины распространения алкоголизма. Энгельс писал: «Усталый и истощенный рабочий возвращается с работы домой. Он приходит в свое неудобное, сырое, непривлекательное и грязное жилище. Ему настоятельно необходимо развлечение, ему нужно что-нибудь, ради чего стоило бы работать, что смягчало бы для него перспективу завтрашнего тяжелого дня... Тело его, ослабленное плохим воздухом и дурной пищей, настоятельно требует какого-нибудь сти-

мула извне... Но. помимо этих скорее физических причин, составляющих рабочего пьянствовать, здесь влияет еще пример большинства, небрежное воспитание, невозможность оградить молодых людей от искушения, во многих случаях прямое влияние предающихся пьянству родителей, которые сами дают водку детям, уверенность, что под влиянием винных паров забудешь на несколько часов нужду и гнет жизни, как и сотни других обстоятельств... Пьянство перестало здесь быть пороком, за которое можно обвинять того, кто им заражен: оно становится необходимым явлением, неизбежным последствием известных условий, влияющих на безвольный объект, — безвольный, по крайней мере, в этих условиях. Пусть за это отвечают те, кто сделал рабочего таким объектом»¹.

Значительную роль в развитии алкоголизма играют капиталистические объединения в промышленности, производящей алкогольные напитки. Эти объединения получают от нее большие прибыли, насаждая пьянство и беззастенчиво рекламируя свою продукцию.

Империалистические державы в лице колонизаторов покоряли первобытные племена при помощи меча, огня, креста и спирта.

Алкогольные напитки используются буржуазией для усиления эксплуатации, порабощения и ослабления сопротивления грядущих колониальных стран.

Вслед за колонизаторами всегда шествовал алкоголь со всеми его ужасами, нищетой, болезнями и смертью.

Для распространения производимых алкогольных напитков империалисты в колониальных и зависимых от них в экономическом отношении странах применяют беспощадные экономические санкции, срывая все попытки ввести запретительную систему. Насильственным образом империалисты внедряют спиртные напитки в Алжире, Индокитае, Марокко, Мадагаскаре и других странах.

Созданный в 1901 г. трест виноделов, основная цель которого заключалась в распространении французских вин в Индокитае, увеличил свои дивиденды за 20 лет в 5¹/₂ раз. Достаточной характеристикой деятельности этого треста является тот факт, что на одну школу в Индокитае в прошлом приходилось 100 заведений для продажи алкогольных напитков.

В свое время глава французского правительства Пуанкаре на банкетах в «неделю виноделия» заверял виноделов Шампани, что во всех торговых договорах, заключенных Францией, будут строго оговорены и соблюдены их интересы. Все эти примеры подтверждают, что алкоголизм является не только

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 3, изд. 1929 г. стр. 395—396.

порождением, но и характерной особенностью эксплуататорского общества.

Развитие капитализма в России, так же как и в других капиталистических странах, сопровождалось непрерывным ростом производства и потребления алкоголя.

Широкому распространению пьянства в царской России особенно способствовало введение казенной винной монополии. Эта монополия, при которой исключительным правом продажи спиртных напитков пользовалось только государство, вводилась постепенно с 1895 г.

В постановлении о монополии царское правительство отмечало, что государственное приготовление и продажа водки позволят «передать этот жесточайший инструмент, которым можно полосовать народное тело и душу, но можно и охранять народ от человеческих слабостей, во власть правительства».

Но это были лишь напыщенные, красивые фразы, так как во все периоды царская казна преследовала лишь одну цель — извлекать максимальную прибыль от продажи спиртных напитков. Бюджет царского правительства справедливо называли пьяным бюджетом, ибо почти $\frac{1}{3}$ всех государственных расходов (около 1 млрд. рублей) покрывалась из сумм, получавшихся от торговли водкой.

В. И. Ленин в статье «Свободная наличность», написанной в 1913 г., ярко показал хищнический, основанный на общенародном разорении характер хозяйничания царской России, для которой водка была главным средством получения свободной наличности.

В. И. Ленин писал: «Всего продала казна за 5 лет (1908—1912 гг.) — 440 $\frac{1}{2}$ миллионов ведер сорокаградусной сивухи». Увеличение прибыли по 42 копейки с ведра дало 185 миллионов рублей»¹.

Учреждение винной монополии привело к дальнейшему росту алкоголизма. Если при акцизной системе с ее кабацким засильем в среднем на душу населения за год количество выпитой водки составляло 0,52 ведра, то после введения винной монополии в 1904 г. на душу населения приходилось 0,54, в 1909—0,58, в 1912—0,62 и в 1913 г.—0,66 ведра водки.

Винная монополия была тем теплым местом, около которого увивались дворяне, чиновники, промышленники.

В 1901 г. в социал-демократическом журнале «Заря» В. И. Ленин опубликовал «Случайные заметки», в которых рассказывал о характерном эпизоде, показывающем стремление дворянства урвать кусок казенного пирога, нажиться на винной монополии. В орловском губернском дворянском собрании обсуждался проект о предоставлении дворянам должностей сборщиков денег с казенных винных лавок. В. И. Ленин

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, изд. 4-е, стр. 564.

отметил, что этот «... орловский эпизод проливает еще некоторый свет и на характер пресловутой питейной монополии. Каких только благ не ждала от нее наша официальная и официозная пресса: и увеличения казенных доходов и улучшения продукта и уменьшения пьянства! А на деле вместо увеличения доходов... запутанность бюджета... Вместо уменьшения пьянства — увеличение числа мест тайной продажи вина, увеличение полицейских доходов с этих мест, открытие винных лавок вопреки воле населения, ходатайствующего о противном, усиление пьянства на улицах. А главное — какое новое гигантское поприще для чиновничьего самодурства и произвола, подхалимства и хищения открывает это создание новой отрасли многомиллионного казенного хозяйства, создание целой армии новых чиновников!»¹.

Показная борьба с пьянством была возложена царским правительством на попечительства о народной трезвости. В губернских и областных центрах этими попечительствами руководили губернаторы, а в уездах — предводители дворянства. Члены попечительств вербовались из высшей бюрократической верхушки, представителей жандармерии, военного, духовного и других ведомств. Естественно, что работа этих попечительств, оторванных от широкой общественности, несмотря на сравнительно большие для того времени средства (свыше 2 млн. рублей), отпускавшиеся для них, оказалась бесплодной.

Потребление водки на душу населения увеличилось с 1900 по 1913 г. на 20%. Одновременно в стране увеличивалось и количество больных алкогольными психозами.

Великая Октябрьская социалистическая революция раскрепостила рабочих и крестьян нашей страны и сделала их хозяевами всех материальных и культурных ценностей. Победа социализма, ликвидация эксплуататорских классов, великая преобразующая сила марксистско-ленинской теории, огромная работа партии по коммунистическому воспитанию масс и творческий труд изменили жизнь и духовный облик советских людей. Социалистическая революция внесла коренные изменения в экономику и быт и навсегда подорвала социальные корни алкоголизма.

Алкоголь является средством капиталистической наживы и органически входит в систему эксплуатации, культивирующей всеобщую продажность и антагонизм между людьми, эгоизм и звериную человеконенавистническую мораль собственника, утверждающего, что человек человеку — волк.

Коренное преобразование нашего общества на социалистических началах, полное освобождение трудящихся от всяческих форм эксплуатации уничтожили ту социальную базу, которая питала развитие алкоголизма.

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 4, стр. 381—382.

Глава III

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО АЛКОГОЛИЗМА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Хронический алкоголизм является заболеванием, лечение которого, особенно в тяжелых его степенях, подчас представляется невозможным. Тем не менее при известном умении, настойчивости и терпении врача, а также при рациональном выборе соответствующих методов лечения можно добиться излечения или ремиссии даже в самых тяжелых случаях заболевания.

Приведем краткий исторический обзор лечения алкоголиков.

В отношении алкоголиков в разные времена применялись меры как репрессивного, так и лечебного воздействия, в зависимости от степени культуры и взгляда на алкоголизм общества того времени.

Китайский император Ву Вонг в 1220 г. до нашей эры издал эдикт, согласно которому все лица, захваченные во время попойки, подвергались смертной казни. Конфуций в V веке и Будда в VI веке до нашей эры категорически воспрещали потребление спиртных напитков. В древней Индии воздержание от алкоголя считалось обязательным не только для касты браминов, но и для других сословий. Браминов, уличенных в пьянстве, заставляли пить из раскаленного металлического сосуда горячее вино, кипяток, коровью мочу или кипящее молоко до наступления смерти. Жена брамина, уличенная в пьянстве, изгонялась из дому, а на лбу ее каленым железом выжигалось изображение сосуда, предназначенного для вина. Лиц, уличенных в пьянстве, поили расплавленным серебром, свинцом или медью. Магомет запрещал пить вино, подвергая нарушавшего запрет свободного человека 40 ударам, а раба 80 ударам палки. Каждый римлянин, заставший жену в пьяном виде, имел право убить ее. В древней Спарте специально напаивали рабов и показывали их юношам, чтобы вну-

нить им страх и отвращение к вину. В Афинах при Драконе опьяневших просто убивали. Солон в первый раз штрафовал архонтов за пьянство, а при вторичном опьянении этих должностных лиц казнили. В Афинах во время Солона пьяństwo считалось состоянием достойным презрения. Карл Великий поступал с пьяницами следующим образом: вначале их наказывали в закрытом помещении, потом публично, а если эти средства не помогали, они подлежали казни. В Англии когда-то существовал обычай надевать на алкоголиков ярмо, а затем водить их по главным улицам города. В Ливерпуле в XIX столетии пробовали публиковать в газетах имена и адреса алкоголиков. В некоторых местах Голландии женщин-алкоголичек привязывали ремнями к сиденью, укрепленному на блоке, и 3 раза погружали в воду. Был известен также способ воздействия на алкоголиков стыдом. Он состоял в том, что охмелевшего человека подвергали общему посрамлению. Так, в Англии матросов, уличенных в пьянстве, одевали в грязные одежды, вешали на них надпись «пьяница» и заставляли выполнять черную работу.

В городе Мексико префект полиции, испробовав все средства борьбы с пьяницами, валяющимися на улице и нарушающими уличное движение, решил прибегнуть к «новому радикальному средству — кинобальзаму». По распоряжению префекта, каждого пьяницу, лежащего на мостовой, а также весь процесс доставки его в вытрезвитель кинооператоры снимали на пленку. Полицейские по специальной картотеке выясняли, первично или повторно доставлялся алкоголик в участок. Если алкоголик доставлялся в участок впервые, ему после вытрезвления демонстрировали на экране звуковую кинохронику, в которой он являлся главным действующим лицом. Протрезвевший алкоголик-нарушитель видел себя в пьяном виде. По мнению изобретателей метода, этого было достаточно, чтобы субъект, снятый в фильме, избегал впредь потребления алкоголя. Если это не помогало, то пьяницу, лежащего на мостовой второй раз, вновь снимали в качестве главного действующего лица в кинохронике и демонстрировали этот фильм уже не только алкоголику-нарушителю, но и его знакомым и родственникам. В тех случаях, когда и эта мера воздействия не давала должного эффекта, хроникальный фильм с новыми похождениями пьяного героя демонстрировался на всех экранах мексиканской столицы. Все расходы по съемке подобных кинофильмов взыскивались с алкоголиков-нарушителей.

Лечением алкоголиков занимались еще в глубокой древности. Многие ученые искали «философский камень», который мог бы исцелять алкоголиков от их недуга. Лечение алкоголиков доходило буквально до абсурда. Массон приводит интересные данные из найденного им сочинения Виртрунга о лечении пьянства 3½ века назад (в 1617 г.). Наряду с разнообразнейшими заболеваниями в этом сочинении описывается и алкоголизм.

Виртрунг считал пьянство самой ужасной болезнью после чумы. Он требовал отнятия у больного алкоголя, чтобы устранить таким образом основную причину болезни. Исходя из

того, что организм насыщен алкоголем, он для его обезвреживания рекомендовал антидот в виде лимонов, горького миндаля, считая, что эти средства «оттягивают действие алкогольных паров от мозга». Виртунг указывает, что в древнее время для лечения пьянства алкоголикам надевали на голову венок из шафрана, фиалок, приписывали также целебные свойства аметисту. Виртунг относился к этим средствам скептически; он советовал вызывать у алкоголиков рвоту, сон, на голову класть компресс из огуречного сока. Наряду с этим он рекомендовал диететическое питание — легкую пищу, цыплят, соус с лимоном и т. д.

Таким образом, еще Виртунг хотя и примитивно, но принципиально правильно подходил к лечению алкоголиков, вводя принцип немедленного отнятия алкоголя, назначая диететическое питание, вызывал рвоту.

По утверждению Керра, один весьма маститый профессор медицины уверял, что он может искоренить влечение к алкоголю в течение одной недели при помощи турецкой бани. В качестве антидота алкоголя он рекомендовал какао. В Германии в свое время предлагали в качестве профилактического средства против алкоголизма сырое мясо. В Англии большое значение среди радикальных средств против алкоголизма придавали вегетарианскому питанию.

Во второй половине XIX столетия один анонимный изобретатель так анонсировал свое средство от алкоголя: «Я могу излечить от пьянства всякого больного, который явится ко мне», указывая, что его средство излечивает, уничтожает потребность в спиртных напитках. Таинственное средство оказалось красной хинной коркой. Этот аферист в короткий срок сумел приобрести широкую популярность. Однако никому никакой пользы его средство не принесло.

Горячо рекомендовали орех кола, содержащий ряд тонизирующих веществ (кофеин, теобромин). Между тем в данном случае он полезен лишь как тонизирующее средство и никакой специфичностью не обладает. Различные настои, микстуры, порошки, предлагавшиеся всевозможными «изобретателями» в качестве средства от алкоголизма, служили им лишь способом обогащения. В капиталистической России алкоголиков лечили разные темные лица, дававшие совет «бесплатно» и тут же за плату отпускавшие бутылочку своего снадобья от пьянства. Видное место при лечении алкоголизма в конце XIX столетия отводилось так называемой богородицкой траве, которую врач Сальватори, впервые описавший дипсоманию, применял в виде настоя (1815), давая 50 г богородицкой травы на 600 г воды. Это лекарство употреблялось по чайной ложке каждые полчаса. Болезненное влечение к алкоголю исчезало будто бы через 13 дней. Средство это не только вызывало рвоту, но и оказывало слабительное действие, и усиливало

диурез. Считалось, что при приеме этого средства повышается аппетит и жажда, которую утоляют кислым питьем. Иногда богородицкую траву настаивали не на воде, а на водке.

Флоринский рекомендовал от запоя настой полыни, корня дягиля, можжевельных ягод. Эти настои давались больным в теплом виде без сахара по 10—15 стаканов в день. Некоторые врачи давали алкоголикам корень переступня, папоротника, копетеня, бузиновой коры и других растворов, настаивая его на алкоголе. Другие врачи советовали подсыпать алкоголикам в водку тошнотворные и рвотные средства (ипекакуану, горечавку и др.). Гуффеланд рекомендовал давать алкоголикам водку с каплей жженого сургуча, указывая, что это средство приводит к исключительным результатам. Он же назначал и так называемые пилюли Гуффеланда, состоявшие из экстракта квасси, полыни и каскарилы.

Польский врач Ян считал, что лечение лимонным соком вызывает отвращение к алкоголю даже у самых застарелых алкоголиков. Курс такого лечения длился 18 дней. Начинают с одного лимона и прибавляют по 1—2—5 лимонов ежедневно, доходя к 9-му дню до 25 лимонов, затем количество лимонов соответственно снижают с таким расчетом, чтобы в 18-й день больной употребил один лимон. Как указывает Ян, при этом лечении нужно применять только свежесжатый лимонный сок. Если больной не может потреблять большого числа лимонов, срок лечения удлиняют до одного месяца, и тогда больному ежедневно дают по 5—7 лимонов.

Испытывая метод Яна на алкоголиках, лечившихся амбулаторно, мы в некоторых случаях добивались положительного результата. Этот метод лечения не утратил интереса и поныне и заслуживает изучения и научного обоснования. Повидимому, лечение лимонным соком может дать известный успех при гиповитаминозах и авитаминозах, наблюдаемых у алкоголиков.

Давно имелись наблюдения, что некоторые съедобные грибы *Coprinus artamentarius* при их употреблении в сочетании с алкоголем дают у многих людей своеобразную картину отравления — бурную вегетативную реакцию с повышением температуры. Эта несовместимость грибов с алкоголем вызвана, повидимому, инактивацией ацетальдегидоксидазы. Эта реакция напоминает антабус-алкогольную реакцию.

Тулуз применял при лечении хронического алкоголизма антиалкогольную сыворотку. Этот препарат был получен из крови лошадей, которым регулярно вводили алкоголь с целью выработать специфические антитела, однако это средство не оправдало возлагавшихся на него надежд.

Для стимуляции организма алкоголиков применялась также аутогемотерапия. Каждые два дня у больного из вены брали 10—20 мл крови и вводили ему ее внутримышечно в ягодичы. Делалось от 10 до 20 подобных инъекций. Не оказывая

непосредственного влияния на степень влечения к алкоголю, аутогемотерапия может быть полезной лишь у больных алкоголизмом, страдающих одновременно различными кожными заболеваниями, в частности фурункулезом.

Заканчивая этот краткий исторический обзор, мы должны подчеркнуть, что привели в нем лишь методы, представляющие интерес в историческом аспекте.

В течение двух последних столетий аптечными фирмами и предприимчивыми дельцами были выпущены на рынок многочисленные патентованные средства. Однако, едва успев появиться, они выходили из употребления. Все это говорит о том, что специфических и надежных средств против алкоголизма не существовало.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО АЛКОГОЛИЗМА

Лечение хронического алкоголизма претерпело значительную эволюцию. Если еще не так давно в терапии этого заболевания господствовал эмпиризм, то в настоящее время изыскиваются и применяются такие средства, которые способны подавить болезненное влечение к алкоголю и вызвать отрицательную реакцию на него. Терапия хронического алкоголизма в значительной мере строится в зависимости от взглядов на существо этого заболевания. Некоторые авторы к этому вопросу подходят односторонне. Так, например, Дж. Смит, Тинтера и Ловелл (Tintera и Lovell) и др. в основе хронического алкоголизма усматривают эндокринную недостаточность, в частности, гипадренкортицизм, и в соответствии с этим рекомендуют проводить лечение алкоголиков адренкортикальным и некоторыми другими гормонами. Указанные предпосылки несомненно представляют известный интерес, но авторы метода не учитывают того обстоятельства, что эндокринные расстройства лишь иногда предшествуют алкоголизму и лишь изредка являются его следствием и лечение одними эндокринными препаратами не может быть эффективным. Другие авторы в основе хронического алкоголизма усматривают расстройство обмена веществ, в котором большую роль играет недостаток витаминов, неправильно полагая, что своеобразное нарушение обмена благоприятствует развитию алкоголизма.

В этой плоскости известный интерес представляют экспериментальные исследования Вильямса, Бери и Берихтера, проведенные на животных.

Материалом для экспериментов служили 150 крыс и 30 мышей. Все животные содержались в отдельных клетках, в которых стояло по два сосуда — один с 10% алкоголем, а другой с водой. Место расположения сосудов ежедневно менялось.

Животные могли пить, сколько им хотелось. Одни животные получали диету А, состоявшую из казеина, декстрозы, растительного масла, с прибавлением витаминов, дрожжей и соли, другие — диету Б того же состава, но с прибавлением большого количества других витаминов и еще некоторых веществ (тиамин, рибофлавин, никотиновая кислота, биотин, холин и др.).

Крысы, находившиеся на диете А, проявляли большую склонность к алкоголю и поглощали его в больших количествах, причем некоторые с первого же дня. Другие животные сначала избегали алкоголя, а потом начинали пить его все чаще и охотнее. Часть животных пила алкоголь только изредка.

Крысы, находившиеся на диете Б, поглощали значительно меньше алкоголя и в отношении максимального потребления его значительно отставали от животных первой группы. При этом определенная разница наблюдалась и между крысами различных штаммов.

Особенно ярко проявлялась реакция крыс различных штаммов на дачу им витаминов с целью подавить у них вкус к алкоголю. Так, крысы штамма О и штамма Н вели себя совершенно различно, когда им давали разные витамины группы В. Таким путем у крыс штамма О удалось без труда снизить поглощение алкоголя до низкого уровня, причем 70% этих животных так и остались на этом уровне потребления, в то время как 30% проявляли определенную тенденцию вернуться к высоким уровням потребления. Однако дачей больших доз витаминов удалось победить у них эту тенденцию.

Совершенно иначе вели себя крысы штамма Н. Из 45 только у трех удалось снизить поглощение алкоголя до низкого уровня. Очень интересны проявлявшиеся крысами индивидуальные различия в отношении различных витаминов, которые давались им для того, чтобы подавить у них стремление к алкоголю.

Одна крыса штамма О совершенно излечилась от своего пристрастия к алкоголю большими приемами витамина В, и, наоборот, другая крыса штамма О, несмотря ни на какие прибавления витаминов, не утрачивала влечения к алкоголю, и только после прибавления к диете льняного масла влечение к алкоголю у нее резко упало. Третья крыса упорно пила алкоголь в течение 7 недель, и только после прибавления к диете 11 витаминов ее стремление к алкоголю снизилось. На приложенных к статье кривых показано, как шло излечение отдельных крыс от алкоголизма. Авторы считают, что при более широкой постановке опытов, при большем вариировании диеты с включением в нее различных аминокислот и минеральных солей возможно достигнуть подавления тяги к алкоголю у 100% лабораторных животных.

Теория алкоголизма, которую авторы выдвигают на основании своих экспериментов, заключается в следующем: особый аппетит, или тяга, к алкоголю, является физиологическим извращением, в основе которого лежит неполностью удовлетворенная пищевая потребность. Непреодолимая тяга к алкоголю развивается у некоторых лиц в результате необычно высокой потребности их организма в некоторых специальных пищевых продуктах, например, в витаминах группы В, которая не удовлетворяется полностью принимаемой ими пищей.

Эксперименты на крысах показывают, что недостаток тех или иных продуктов может прямо или косвенно способствовать развитию влечения к алкоголю. В числе элементов, обладающих способностью подавлять пристрастие к алкоголю, важное место занимают различные витамины группы В, витамины против злокачественной анемии, витамин А и ненасыщенные жирные кислоты (льняное масло). Неспособность организма ассимилировать эти или подобные им продукты, быть может, лежит в основе некоторых случаев алкоголизма.

Таким образом, на основании этих экспериментов можно заключить, что полноценное удовлетворение всех алиментарных потребностей может уничтожить тягу к алкоголю. Но вполне возможно, что неудовлетворение потребности в каком-либо одном элементе может сделать все лечение неэффективным.

Кроме того, ввиду различных способностей к ассимиляции и различной бактериальной флоры в кишечнике, а также индивидуальных различий в типе межклеточного обмена потребность в каком-либо витамине или пищевом продукте может у данного субъекта значительно превышать норму.

Витаминотерапия не раз предлагалась для лечения алкоголизма, но причиной неуспешности ее, по авторам, возможно, было невключение в нее таких витаминов, как витамин против злокачественной анемии и др. Продажные поливитамины часто бывают плохо составлены и совершенно непригодны для данной цели.

Действие очень больших доз алкоголя до сих пор по-настоящему не изучалось. Возможно, что длительная алиментарная недостаточность, связанная с большим поглощением алкоголя, создает необратимые повреждения в организме и что на такой стадии алкоголизма достигнуть излечения путем восполнения алиментарной потребности уже трудно. Однако возможно, что это и не так, и авторы надеются, что фактор надлежащего питания может и тут сыграть роль. Вообще они подчеркивают важность полноценного питания, удовлетворяющего все потребности организма данного индивидуума, начиная с детского возраста, в качестве профилактики алкоголизма.

Большое значение имеет возраст. У тех лиц, которые становятся алкоголиками в молодом возрасте, очевидно, отмечается очень сильная потребность в каком-то пищевом элементе, которую трудно удовлетворить. У тех же, которые становятся алкоголиками в более старшем возрасте, такой резко выраженной алиментарной недостаточности обычно не имеется, и поэтому у них легче подавить эту тягу к алкоголю различными средствами, включая психотерапевтическое воздействие.

Экспериментальные исследования этих авторов хотя и заслуживают внимания, однако данная концепция может быть применима лишь к некоторой незначительной части больных хроническим алкоголизмом.

Наши наблюдения над большим количеством больных твердо убеждают нас в том, что причины алкоголизма многогранны. Алкоголизм может возникать и у совершенно здоровых людей, если они регулярно и систематически принимают алкоголь. Разница состоит лишь в том, что некоторые люди при прочих равных условиях быстрее привыкают к алкоголю (например, лица, перенесшие травму головного мозга, и др., у которых мозговая кора ослаблена). Большую роль в развитии алкоголизма играют также психогенные и социальные факторы.

Вопреки концепциям зарубежных ученых, которые в основе хронического алкоголизма видят то эндокринную недостаточность (Тинтера и Ловелл), то своеобразное нарушение обмена, то наследственную болезнь, в основе которой лежат унаследованные особенности обмена веществ, предрасполагающие к развитию алкоголизма [Смит (Smith), Вильямс, Бери, Беестор и др.], мы считаем, что какого-либо специального предрасположения к алкоголизму не существует. К алкоголю, так же как и к табаку, морфину и другим наркотикам, может привыкнуть любой человек, если он будет его применять систематически в течение длительного времени. В результате длительного потребления алкоголя образуется очень прочная привычка, патологически фиксированные корковые связи, динамический стереотип, с большим трудом поддающийся переделке. Наряду с этим длительное злоупотребление алкоголем вызывает нарушение высшей нервной деятельности и вегетативно-висцеральных функций, тяжесть которых часто коррелирует с тяжестью алкоголизма.

Основная задача, стоящая перед врачами, проводящими лечение алкоголиков, заключается в том, чтобы разрушить эту патологическую связь, переделать стереотип таким образом, чтобы алкоголь вызывал не положительную, а отрицательную реакцию, причем эта реакция должна быть прочной и устойчивой. Наряду с этим необходимо восстановить здоровье больных, расстроенное алкоголем.

Вне зависимости от взглядов на существо алкоголизма большие перспективы имеет лечение алкоголиков, базирующееся на учении И. П. Павлова.

Огромные сдвиги во всех областях медицины, происшедшие за последние десятилетия, перестройка советской медицины на основах учения И. П. Павлова оказали известное влияние и на методику лечения алкоголиков. Разработаны новые, научно обоснованные методы терапии, которые позволяют нам успешно лечить многих алкоголиков и возвращать их к производительному труду.

В большинстве случаев тяжелого алкоголизма больной уже не может без врачебной помощи избавиться от своего заболевания, но в части случаев мы можем встретиться и со спонтанной ремиссией.

В зависимости от тяжести заболевания, алкоголиков можно лечить амбулаторно или в специальных больницах. При амбулаторном лечении алкоголик должен систематически посещать амбулаторию, где ему назначают специальное лечение. Основной задачей при лечении алкоголиков является необходимость приучить их к абсолютному и постоянному воздержанию от алкоголя. Опыт показал, что малейшее количество напитка, содержащего алкоголь, в состоянии пробудить снова влечение к алкоголю, ибо, несмотря на длительную ремиссию, оно часто сохраняется в течение всей жизни. При употреблении даже небольшого количества алкоголя это влечение пробуждается с новой силой и вызывает рецидив алкоголизма. Алкоголикам нужно доказать, что жизнь возможна и без алкоголя и что в ней много других радостей, им следует рекомендовать культурные развлечения — посещение театра, кино, библиотеки, занятия спортом, охотой, рыбной ловлей и т. п.

В более тяжелых случаях больных приходится направлять на стационарное лечение в специальные больницы. Однако желательно избегать принудительного помещения алкоголиков в такие учреждения. Больные должны сами убедиться в том, что пребывание в больнице принесет им только пользу, и только в тяжелых случаях можно прибегнуть к принудительному лечению. Многие алкоголики начинают понимать пользу лечения лишь после длительного пребывания в больнице, а некоторые только после выписки из больницы. Тем не менее нужно всегда иметь в виду, что в стационар следует направлять в основном только тех больных, у которых можно предполагать хороший прогноз, хотя, как уже говорилось, при алкоголизме определить прогноз нередко бывает очень трудно.

В больницах рекомендуется лишать больных алкоголя немедленно, не допуская никакого уменьшения доз. С опасностью возникновения белой горячки это не связано. Как показали многочисленные наблюдения и опыт специальной больницы, среди сравнительно большого количества (свыше

20 000) алкоголиков мы не наблюдали ни одного, у которого возникновение алкогольного делирия можно было бы приписать абстиненции. Согласно данным новейших исследований, белая горячка возникает вследствие тяжелого нарушения функций печени. Мы намеренно подчеркиваем безопасность немедленного отнятия алкоголя, так как этот вопрос немало дебатировался в литературе.

Специфических медикаментов против алкоголизма нет, однако предложено много средств, имеющих большое значение при лечении этого заболевания. Сюда относятся вещества, тонизирующие и активирующие организм, а также снотворные средства. Основное место в лечении алкоголизма должна занимать психотерапия, выработка условной эмоционально отрицательной реакции на алкоголь при помощи рвотных средств, антабуса или в гипнотическом состоянии. В первые дни стационарного или амбулаторного лечения рекомендуется проводить дезинтоксикацию путем назначения слабительных и мочегонных средств, соответствующей диеты. Даются медикаменты, вызывающие сон, улучшающие сердечную деятельность, регулирующие функцию печени, пищеварение и т. п.

В дальнейшем продолжается медикаментозная симптоматическая, общеукрепляющая терапия, проводится психотерапия, физиотерапия, трудотерапия и т. п. Одновременно рекомендуются и социально-профилактические мероприятия, например, устройство на работу (в случае потери ее, что особенно часто наблюдается у алкоголиков). Большую роль в успехе лечения играет семья алкоголика и лица, окружающие его. Чуткость, забота, внимательное отношение к больному могут способствовать его излечению от алкоголизма уже в первоначальных стадиях. Семья должна исключить из быта алкогольные напитки, установить твердый контроль над заработком больного, изолировать его от неподходящей компании и лишь в тех случаях, когда все эти меры не помогают, обратиться к помощи врача.

В процессе лечения нужно внушать алкоголику, что он страдает от алкоголизма не случайно и что решающую роль в развитии его заболевания играет он сам. Нецелесообразно, а подчас и вредно внушать больному, что алкоголизм — болезнь: алкоголики и без того пытаются под предлогом болезни освободиться от ответственности, считая себя невольными в своих поступках и обвиняя в этом кого угодно, но только не себя. Больных нужно дисциплинировать, прививать им трудовые навыки, ибо регулярный труд, правильное и целесообразное распределение досуга, надлежащий режим и дисциплина создают предпосылки для успешного лечения. Алкоголики должны находиться под постоянным длительным врачебным наблюдением, а поэтому после выписки из лечебного учреждения их

следует направлять к психиатрам, невропатологам и пр., которым они должны периодически показываться.

Во время лечения недостаточно только отнять у больного алкоголь — нужно перевоспитать его, искоренить болезненное влечение к спиртным напиткам, укрепить его ослабленное здоровье и научить его бороться с возвратом болезни. В деле борьбы с алкоголизмом немаловажную роль отводили фруктовым сиропам, не способным к брожению. Макс Фишер, настойчиво рекомендуя эти безалкогольные напитки, указывает на их питательность, благодаря содержанию в них фруктового сахара и витаминов.

Блейлер и его сотрудники рекомендовали освежающий безалкогольный напиток Nella типа пива, отличающийся богатой калорийностью.

Перейдем к более детальному описанию методов фармакотерапии, психотерапии, трудотерапии и лечебного питания, применяемых в настоящее время в стационарных лечебных учреждениях, а также во внебольничной сети. Вполне понятно, что нельзя выработать стандарт лечения, применимый для всех алкоголиков, — лечение каждого из них должно сугубо индивидуализироваться. При повторном поступлении больного не следует назначать применявшееся ранее лечение, а, наоборот, нужно пользоваться новыми методами. К сожалению, многие врачи проявляют некоторую односторонность в этом отношении и придерживаются определенного стандарта в терапии, что обычно оказывает отрицательное влияние на больного.

ФАРМАКОТЕРАПИЯ

Развивающуюся часто при немедленном прекращении приема алкоголя бессонницу, явления абстиненции можно купировать следующими средствами:

Rp. Chlorali hydrati 8.0

Aq. destill. 200.0

MDS. По одной столовой ложке на ночь

или

Rp. Paraldehydi 20.0

Aq. destill. 200.0

MDS. По 1—2 столовые ложки утром и вечером

Хлоралгидрат и паральдегид действуют на больных наиболее благоприятно, вызывая сон и смягчая явления абстиненции.

Паральдегид в больших дозах вызывает не только длительный сон, но и уменьшает влечение к алкоголю. Не следует назначать паральдегид при язвах желудка, кишок и при туберкулезе легких вследствие раздражающих свойств как самого препарата, так и его паров. При назначении хлоралгидрата

лицам, страдающим заболеваниями сердца, сосудов и органов дыхания, следует соблюдать осторожность. При отсутствии указанных средств можно давать веронал (0,25—0,5 г).

При наличии фазовых явлений в мозговой коре небольшие или микродозы снотворных действуют на алкоголиков лучше, чем большие или обычные терапевтические дозы. В качестве снотворных рекомендуется амиленгидрат по 2—4 г в желатиновых капсулах или на воде, люминал по 0,1—0,2 г, меминал 0,3—0,5 г, бромурал 0,5 г, амитал-натрий по 0,1—0,3 г, нембутал по 0,1 г. В упорных случаях бессонницы следует назначать люминал с бромуралом или вводить внутривенно 5% бромистый натрий по 5—10 мл в течение 5—10 дней. Чтобы не вызвать привыкания к наркотикам, последние необходимо менять. Применять указанные наркотики нужно осторожно, прибегая к ним лишь в первые дни лечения.

Серьезное внимание следует обратить на сердечно-сосудистую систему. При слабости сердечной деятельности можно давать кардиовален, адонилен, боярышник, гитален, камфору, кофеин, коразол, кордиамин, настойку жень-шеня и др. В более легких случаях с успехом применяют следующую микстуру:

Rp. Sol. natr bromati 3,0 : 200,0
Codeini phosphorici 0,15
Adonileni 3,0
Calcii chlorati 2,0
MDS. По 1 столовой ложке 3 раза в день

Весьма важно в первые же дни провести дезинтоксикацию организма путем урегулирования желудочно-кишечной деятельности (клизмы, слабительное, диета). Благоприятное действие оказывает уротропин, диуретин по 0,5 3 раза в день, с успехом применяют внутривенные вливания 40% раствора уротропина по 4 мл ежедневно или 40% глюкозы по 10—15 мл. Такие вливания способствуют быстрому освобождению организма от токсинов, образующихся вследствие вызванных алкоголем нарушений обмена веществ. Курс лечения (в зависимости от состояния больного) состоит из 10—15 внутривенных вливаний уротропина или глюкозы.

Благоприятное влияние оказывает на алкоголиков фенамин, назначаемый внутрь по 0,01—0,02 г; он способствует стимулированию нервной системы, быстрому купированию абстинентного синдрома и устраняет неглубокую депрессию. Фенамин применяют лишь в сочетании с другими средствами. Обычно его назначают в течение 7—10 дней по утрам. Однако мы наблюдали несколько случаев привыкания к фенамину, поэтому фенаминоманию. Чтобы избежать этого, следует применять этот препарат лишь в течение 7—10 дней. Лечение фен-

амином в амбулаторной практике применяют чаще, чем в стационарах.

Rp. Phenamini 0,005
Sacchari lactici 0,3
M. f. pulv. N. 10
DŚ. По 1—2 порошка по утрам в течение 7—10 дней

Желудочно-кишечные расстройства, носящие катаррально-диспептический характер, а также развивающуюся в первые дни после лишения больных алкоголя повышенную кислотность желудка следует лечить соответствующим диететическим питанием и назначением щелочных минеральных вод (Ессен-туки № 4, 17 и 20, боржоми, нарзан).

При головной боли, а также при неприятных ощущениях в голове, нередко появляющихся в первые дни абстиненции, назначают следующую пропись:

Rp. Pyramidoni 0,3
Phenacetini 0,25
Coffeini natrio-benzoici 0,1
Luminali 0,03
Codeini phosphorici 0,01
M. f. pulv.
D. t. d. N. 12
S. По 1 порошку 1—2 раза в день

Необходимо всеми мерами добиваться в первые же дни восстановления сна и купирования явлений абстиненции, что поднимает авторитет врача и укрепляет веру больного в лечение.

Из успокаивающих средств Рапопорт рекомендует следующее:

Rp. T-rae Nucis vomicae 5,0
T-rae Asoe foetidae 10,0
T-rae Valerianae simplicis 15,0
MDS. По 15 капель 3 раза в день, запивать 1—2 стака-
нами воды

Суть данного средства, по автору, заключается главным образом в T-rae Asoe foetidae как легком наркотике, антиистерическом средстве. Неприятный же его вкус гарантирует выполнение предписания врача — запивать капли большим количеством жидкости (чаем, водой), что ослабляет влечение к алкоголю.

В качестве симптоматического средства, смягчающего депрессию, тонизирующего центральную нервную систему и подавляющего или понижающего до известной степени влечение к алкоголю, мы с успехом применяли следующее:

Rp. Kalii bichromici 0,1
Aq. destill. 10,0
MDS. По 2—4 капли один раз в день на полстакана во-
ды или чая по утрам

Последнее средство нельзя давать одновременно с хлоралгидратом, так как при наличии этих двух веществ в присутствии соляной кислоты в желудочном соке образуется трихлоруксусная кислота. Некоторую роль могут играть средства, внушающие отвращение к вину. Минор рекомендует тинктуру проф. Дана. Она в основном состоит из горечей, рвотных и тошнотворных препаратов. Эта тинктура содержит следующие ингредиенты:

Rp. Apomorphini hydrochlorici 0,015
T-rae Colombo 30,0
T-rae Nucis vomicae 30,0
T-rae Capsiciannui gtt. XII
T-rae Chinae compositae 45,0
MDS. По 30—40 капель перед едой в случае влечения к вину

Эта тинктура больше применима в условиях диспансера. После купирования абстинентных явлений следует приступить к курсовому лечению. Назначают общеукрепляющие и тонизирующие процедуры: подкожные вдувания кислорода, инъекции мышьяка со стрихнином, гравидана, аутогемотерапию. Такое курсовое лечение полезно уже тем, что приучает амбулаторно лечащегося больного к систематическому посещению лечебного учреждения.

Давно отмечается благоприятное влияние стрихнина на алкоголиков, которому многие из исследователей приписывали специфическое антиалкогольное действие. Назначается курс инъекций по 1 мл 0,1% раствора стрихнина в течение 30 дней.

Иногда делают инъекции стрихнина с атропином. В. И. Скворцов подчеркивает, что при назначении алкоголикам Atropini Sulfurici по 0,05 г на 200 мл Aq. destillatae по 2—3 чайные ложечки в день, постепенно увеличивая до 8 ложечек, у больных получается извращенный неприятный вкус от спиртных напитков, сухость полости рта, расстройство зрения от паралича аккомодации, чувство сердцебиения. Кан назначал атропин по 0,0009 в пилюлях. Тувим рекомендовал подливать по 0,001 атропина в водку или вино один раз в день, пока не достигнут желаемого результата. Мы применяем инъекции стрихнина по следующей прописи:

Rp. Sol. Strychnini nitrici 0,1% 1,0
N. 30 in amp.
DS. Подкожно в течение 30 дней

При отсутствии возможности регулярно принимать стрихнин подкожно его назначают в пилюлях:

Rp. Strychnini nitrici 0,02
Extr. et pulv. Liquiritiae q. s.
ut fiat pil. N. 30
DS. По 1 пилюле 2 раза в день

Это средство тонизирует центральную нервную систему, улучшает обмен веществ и питание.

Проводя биохимические исследования крови алкоголиков, мы у большинства установили понижение количества кальция, сахара и хлоридов в сыворотке. Поэтому мы считаем целесообразным применять для терапии этого заболевания кальций и глюкозу.

Кальций и глюкоза вводятся отдельно внутривенно по следующей прописи:

Rp. Sol. Glucosae 40% 100,0
Sterilis!
DS. По 10—15 мл внутривенно ежедневно
Rp. Calcii chlorati 5,0
Aq. destill. 100,0
DS. По 10 мл внутривенно ежедневно

При половых расстройствах функционального характера благоприятное действие оказывает концентрат витамина Е, назначаемый по одной чайной ложке после еды 1—2 раза в день, а также тестостеронпропионат в следующей прописи:

Rp. Methyltestosteroni 0,005
D. t. d. in tabul. N. 24
DS. По 1 таблетке 4 раза в день
Rp. Testosteronpropionat 5% 1,0
in amp. N. 20.
DS. Для подкожных инъекций.
На курс лечения назначается 200 мг

Тонизирует половую функцию втирание в пояснично-крестцовую область позвоночника нижеследующего средства:

Rp. T-rae Nucis vomicae 10,0
Spiritus camphoratus
Spiritus saponatus aa 15,0
Spiritus vini 60,0
MDS. Для втирания в крестцово-поясничную область позвоночника

Одновременно назначают диатермию промежности (в течение 1—2 месяцев), хвойно-соленые ванны, длительное время глицерофосфаты, инъекции пантокрина, настойку жень-шеня и др. Этот метод способствует восстановлению угаснувшей или угасающей половой функции¹.

При понижении в крови содержания хлоридов полезно вводить физиологический раствор хлористого натрия по 100—300 мл подкожно. Исследуя больных, леченных упомянутым способом, мы установили, что кальций, глюкоза и хло-

¹ Описанный метод лечения половых расстройств у алкоголиков дает прекрасные результаты и у больных половой незрелости.

риды быстро выводятся из организма в силу, быть может, нарушений функций регуляторных механизмов. Повидимому, параллельно введению с пищей дефицитных для организма электролитов мы должны также вводить фармакологические или эндокринные препараты, способствующие установлению физиологического равновесия в организме электролитов и тормозящие быстрое исчезновение вводимых электролитов или помогающие регулированию обмена веществ, что требует изучения. Все же, несмотря на быстрое выведение из организма вводимого кальция, сахара и хлоридов, эффект их действия вполне благоприятен: улучшается сон, аппетит, настроение, исчезает физическая слабость.

Лечение кальцием и хлоридами целесообразно проводить лишь в тех случаях, когда биохимические исследования крови обнаруживают понижение количества этих веществ.

Имеются наблюдения, что животный уголь (*Carbo animalis*), принимаемый по 3—4 г в день, может в сочетании с алкоголем вызывать вазомоторные расстройства в виде скоропроходящего покраснения лица, конечностей и сердцебиения, механизмы которого еще не ясны. В этом вопросе необходимо провести соответствующие наблюдения.

И. Г. Равкин наблюдал аналогичную картину после приема никотиновой кислоты и предложил лечить больных хроническим алкоголизмом никотиновой кислотой, которая при приеме больными алкоголя дает реакцию, сходную с таковой при лечении антабусом.

Лечение солями родана. Соли родана употребляют в виде роданистого калия при гипертонической болезни, против артериосклероза, хронического ревматизма, свинки и других заболеваний. Прием этого препарата алкоголиками вызывает отвращение к спиртным напиткам, достигающее до полной невосприимчивости его организма. При лечении хронического алкоголизма этот препарат применяется в дозировке, несколько превышающей обычную. Больным давали по 0,4—0,6 г препарата в день, причем эту порцию разделяли на три приема. Лечение проводили в течение 3 месяцев под контролем крови, чтобы максимальная концентрация роданистого калия не превышала 12—15 мг%. Препарат назначали только в течение 3 недель каждого месяца с тем, чтобы ежемесячно в течение одной недели был обеспечен перерыв. Неприятное чувство к алкоголю наблюдается уже в конце первого месяца, а полное отвращение к нему наступает по истечении 3 месяцев. После этого необходимо продолжать давать препарат, но только в половинной дозе, чтобы поддержать отвращение к спиртным напиткам.

За рубежом лечение алкоголиков иногда проводят опасными и вредными для здоровья методами, например, К. Бауман (*Bauman*) в своей работе «Обзор успехов в психиатрии»

за 1951 г. указывает, что наблюдение над 179 больными хроническим алкоголизмом, подвергшимися операции лоботомии, показало, что 93% из них, вернувшись домой, продолжали пить. Не говоря уже о полной недопустимости и бесполезности проведения столь серьезного хирургического вмешательства по поводу алкоголизма, следует указать, что подобного рода операции могут лишь нанести серьезнейший вред здоровью алкоголика, и без того подорванному пьянством.

ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ

На истощенных, астенизированных больных хроническим алкоголизмом хорошее действие оказывают гипогликемические дозы инсулина, при помощи которых устраняется физическая слабость, астенизация, состояние тревоги, страхи, улучшается сон, исчезают явления тремора. Больные значительно прибавляют в весе, влечение к алкоголю у них ослабевает. Инсулинотерапия оказывает детоксикационное действие и в сомнолектных дозах способствует более быстрому восстановлению здоровья, а также нормализации обмена веществ. Этот метод лечения показан также при тяжелом нарушении обмена веществ, расстройстве функции печени, при алкогольной кахексии и при невротических наслоениях (фобиях и т. д.). Дают инсулин в дробных дозах (от 2—5 до 30 ИЕ), ежедневно повышая дозу на 2—3 ИЕ. Количество инъекций инсулина колеблется в пределах от 20 до 30 и в каждом отдельном случае устанавливается индивидуально.

При наступлении явлений гипогликемии больным нужно давать сахар, обычно через полчаса после введения инсулина. Если возникает гипогликемический шок, немедленно вводят внутривенно глюкозу. Инсулин усиливает также действие апоморфина, применяемого для выработки рвотной реакции на алкоголь.

Ввиду того что некоторые люди отличаются повышенной чувствительностью к инсулину, перед назначением инсулинотерапии следует провести исследование на сахарную нагрузку.

Инсулинотерапия противопоказана при тяжелых органических поражениях головного мозга. Разнообразие приведенных нами фармакологических средств, применяемых при лечении алкоголиков, указывает на то, что совершенных фармакологических средств для лечения алкоголизма пока еще мало. Тем не менее и имеющиеся в нашем распоряжении способствуют быстрому восстановлению здоровья больных. Умело применяя их в сочетании с другими методами терапии, строго индивидуализируя каждый отдельный случай, врач может оказать существенную помощь не только в легких случаях алкоголизма, но и при его тяжелых формах.

ЛЕЧЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Исходя из наших наблюдений, согласно которым у значительного числа больных хроническим алкоголизмом наблюдаются ослабление или угасание половой функции, а также явления преждевременного одряхления, которое мы связывали с нарушением функции эндокринных желез, вызванным алкогольной интоксикацией, мы совместно с П. П. Обнорским в 1933 г., а затем с Н. Е. Дудко и П. П. Довженко в 1934 г. успешно лечили алкоголиков с явлениями преждевременного одряхления гравиданом [специально обработанная по методу А. А. Замкова моча беременных женщин (полигормональный препарат)]. У большинства больных, леченных этим способом, восстанавливалась половая функция, у некоторых отмечалось потемнение волос, улучшение функции сердечно-сосудистой системы. К сожалению, мы вынуждены были прервать наши наблюдения из-за отсутствия препарата. Известно, что алкоголь, поступивший в организм человека, оказывает влияние на гормональную систему. Согласно учению Селье (Selye), острое отравление алкоголем может вызвать адаптационный синдром (Stress) (увеличение поступления адренокортикотропного гормона—АКТГ) гипофиза и кортизона надпочечников. Отсюда становится понятным благоприятные терапевтические результаты, которые получал Смит (J. J. Smith), применяя при остром алкогольном отравлении и при тяжелых алкогольных психозах адренокортикотропный гормон (АКТГ) и кортизон. Однако другие авторы (Фегтлин, Фишбах, Симонс, Полард) считают, что АКТГ оказывает небольшое действие при алкоголизме. Некоторые зарубежные авторы [Гольдштейн и Кидера (Goldstein u. Kiddera)] объясняли возникновение алкоголизма понижением функции надпочечников. В последние годы при лечении хронического алкоголизма многие авторы применяли кортизон. Изучались две группы больных. В первую группу входили молодые мужчины с астенической конституцией, с мягким гладким лицом, отсутствием волосяного покрова на груди, гипотонией и гинекомастией. Для них характерна гипогликемия, понижение функции надпочечников. Эти лица как будто в любом возрасте подвержены алкоголизму. Ко второй группе, по Тинтера и Ловеллу, относятся больные, у которых первично хотя и не имеется нарушений гормональных функций, но на почве злоупотребления алкоголем развиваются вторичные изменения надпочечников, в подавляющем большинстве случаев экзогенной формы (в противоположность ослабленному эндогенному типу). В период воздержания от алкоголя у этих лиц наблюдается гипогликемия. Тинтера и Ловелл рекомендовали при хроническом алкоголизме назначение больших доз экстракта надпочечников. Мы не разделяем оптимистических взглядов на лечение хронического алкоголизма кортизоном.

Положительных результатов при этом виде терапии можно достигнуть лишь при лечении больных с выраженной недостаточностью надпочечников. Нейштадт, Смит и др. получали положительные результаты при лечении больных хроническим алкоголизмом и *delirium tremens* аденокортикотропным гормоном (АКТГ). Результаты этого лечения были еще лучше в сочетании АКТГ с препаратами коры надпочечников.

* * *

Больных, у которых хронический алкоголизм сочетался с гипертонической болезнью, мы успешно лечили предложенной нами следующей микстурой:

Rp. Inf. rad. Valerianae 5,0 : 200,0
Codeini phosphorici 0,15
Coffeini natrio-benzoici 0,5
Luminali 0,3
Spiritus vini 10,0
Natr. bromati 3,0
MDS. по 1 столовой ложке 2 раза в день

Небольшую дозу спирта в данной смеси применяют для растворения люминала, входящего в состав данной микстуры. Сочетание средств, усиливающих раздражительный (кофеин) и тормозной (бром) процессы, что в итоге ведет к восстановлению правильных соотношений между раздражительным и тормозным процессами, со средствами, способствующими восстановлению правильных соотношений между корой и подкоркой (люминал, кодеин, валериана), при длительном применении этого состава ведет к снятию очагов застойного возбуждения в сосудосуживающих центрах коры и подкорки и к нормализации артериального давления, улучшению сна, настроения, исчезновению головных болей и восстановлению работоспособности. В тяжелых случаях гипертонии у хронических алкоголиков мы сочетали прием вышеуказанной микстуры с приемом 1—2 раза в день небольших доз серпазила по 0,3 мг или аминазина в дозе 25 мг, назначавшегося в виде подкожных инъекций или в капсулах, что в большинстве случаев давало положительные стойкие результаты. Подобный курс лечения мы проводили в течение 1—2 месяцев, продолжая затем давать лишь одну микстуру еще в течение 3—4 месяцев.

ЛЕЧЕБНЫЙ СОН¹

Проблема терапии сном с давних пор привлекает внимание клиницистов и на нее всегда возлагались большие надежды, особенно при лечении больных нервно-психическими заболе-

¹ Лечебный сон показан не только при хроническом алкоголизме, но и при алкогольных психозах и других наркоманиях, поэтому мы описали этот метод лечения более детально.

ваниями. Еще в XIX столетии предпринимались попытки лечить хлороформно-эфирным наркозом, который применялся в психиатрической клинике для купирования резкого возбуждения. Однако достигавшееся таким путем кратковременное улучшение было непрочным и после него, по наблюдениям Гринингера, иногда отмечалось даже некоторое ухудшение. С. С. Корсаков правильно указывал, что хлороформный и эфирный наркоз не дает эффекта при лечении психически больных, а является лишь средством, «обуздывающим, к которому прибегают для водворения спокойствия». Интерес к терапии сном возрос в связи с работами Клези (1922), лечившего длительным наркозом с помощью сомнифена больных, страдавших некоторыми нервно-психическими заболеваниями. После того как Клотта и Майер предложили для лечения сном особую смесь, состоящую из наркотиков и сердечных средств, при помощи которой вызывался длительный наркоз, применявшийся с некоторым успехом при лечении шизофрении, число приверженцев длительного сна стало быстро увеличиваться. Однако такого рода терапия сном, не имевшая физиологического обоснования, часто вызывавшая тяжелые осложнения со стороны органов дыхания и кровообращения, которые давали смертность, доходившую до 10%, как и следовало ожидать, зашла в тупик. Лишь учение И. П. Павлова о защитной и целебной роли охранительного торможения, явившееся выдающимся достижением современной физиологии, стало фундаментом, новой научной основой терапии сном. И. П. Павлов впервые в истории науки экспериментально доказал, что в мозговой коре при действии сверхсильных раздражителей вследствие непосильной работы наступает функциональная иммобилизация корковых клеток — запредельное охранительное торможение, которое предохраняет их от повреждения и даже гибели. Охранительное торможение И. П. Павлов рассматривал с двух сторон. С одной стороны, как физиологическое состояние, физиологическую меру самозащиты, а с другой стороны, как патологическое явление, при котором нарушается в той или другой степени нормальная целостная деятельность больших полушарий головного мозга и ближайшей подкорки.

Охранительное торможение предохраняет корковые клетки от деструкции и даже гибели вследствие действия на них различных вредоносных агентов. В качестве примера И. П. Павлов приводит кататоническую форму шизофрении, при которой, несмотря даже на большую длительность заболевания, возможен довольно значительный процент выздоровления. И. П. Павлов проявлял большой интерес к лечению сном и выражал желание, чтобы этот терапевтический метод возможно шире применялся в клинике. Однако, как мы уже видели, в основу применения терапии сном И. П. Павлов положил совершенно новый принцип. Он предложил применять лечение

сном больных шизофренией не при состоянии возбуждения, как это практиковалось раньше, а, наоборот, при тех формах шизофрении (кататоническая, депрессивно-ступорозная и др.), при которых выражено охранительное торможение, в целях углубления этих защитных нервных механизмов.

Впервые лечение длительным сном, базирующееся на павловской концепции охранительного торможения, было применено А. Г. Ивановым-Смоленским в 1935—1936 гг. в психиатрической клинике при лаборатории И. П. Павлова. Как известно, в павловской психиатрической клинике для лечения длительным сном в 1935 г. было организовано специально оборудованное отделение, в котором был введен режим, позволявший обеспечить максимальную тишину и полный покой больных. Здесь применялись внешние агенты, благоприятствующие и содействующие сну: затемнение палат, слабые монотонные ритмичные звуковые раздражители, медленно мигающая на потолке синяя лампочка и др. Все это в значительной мере облегчало усыпление больных и позволяло вызывать сон минимальным количеством снотворных средств.

Учитывая известную опасность длительного наркоза, который в части случаев вызывал угрожающие осложнения со стороны органов кровообращения и дыхания, павловская клиника полностью отказалась от применения длительного наркоза. А. Г. Иванов-Смоленский, исходя из этого, стремился вызвать лишь длительный лечебный сон, возможно более приближающийся к глубокому физиологическому, но, как правило, не переходящий в состояние наркоза, при котором обычно и наблюдались различные осложнения.

Для вызывания длительного наркотического лечебного сна в павловской клинике применялся один из наименее токсических препаратов барбитуровой кислоты — амитал-натрий (барбамил). Препарат назначался per os, ректально, подкожно, интрамускулярно или внутривенно; доза его 0,15; 0,3; 0,5 г вызывала крепкий сон в течение 5—8 и более часов даже после однократного введения. Длительный лечебный сон в павловской клинике проводился от 6 до 7 суток, а в отдельных случаях — от 5 до 8 суток; больные спали в среднем от 22 до 23 часов в сутки, причем ни в одном случае не наблюдалось каких-либо осложнений, кроме кратковременной рвоты на фоне недостаточно углубленного сна.

По своей эффективности длительный лечебный сон не уступал длительному наркозу, однако он обладал тем преимуществом, что не вызывал никаких осложнений, был безвредным. Таким образом, в довоенные годы павловская клиника тщательно разработала лечение шизофрении сном, базирующееся на принципе охранительного торможения.

В годы Великой Отечественной войны, исходя из ярко выраженных явлений охранительного торможения в остром пе-

риоде закрытых травм головного мозга, А. Г. Иванов-Смоленский предложил лечить (и с успехом лечил) больных с этими расстройствами пролонгированным, качественно улучшенным естественным сном до 10—15 часов в сутки на протяжении 10—15 дней и более, иногда в сочетании с круглосуточным постельным режимом. Весь режим отделения перестраивался таким образом, чтобы всячески поощрять охранительное торможение. Эта форма сна была лишена всяких побочных явлений и осложнений, а противопоказания для нее были значительно уже, чем при лечении длительным лечебным сном. Результаты подобного рода терапии были весьма положительны.

В послевоенный период наша клиника продолжала проводить дальнейшие исследования в области лечения сном. Как уже говорилось, от применения сомнифена и клоэтала отказались вследствие их токсичности, обуславливающей тяжелые осложнения при их применении. Препараты группы сульфанов (трионал, сульфонал), согласно данным В. И. Скворцова, при длительном применении могут вызывать тяжелые токсические явления со стороны органов пищеварения, почек и центральной нервной системы и способны кумулироваться. Следовательно, эти средства непригодны для лечения длительным сном. Непригодно для вызывания длительного сна и большинство препаратов барбитуровой кислоты (веронал, люминал и др.) вследствие их кумулятивного, а отчасти и токсического действия. Из них наименее токсичным и безвредным является амитал-натрий (барбамил).

В. И. Скворцов, характеризуя амитал-натрий (барбамил), пишет, что он хорошо выводится из организма, при повторном введении не вызывает явлений кумуляции и не дает никаких последствий, кроме некоторой слабости. Э. А. Асратян на основе своих наблюдений рекомендует для лечения гедонал, считая его безвредным средством, вызывающим сон, приближающийся к естественному. К сожалению, гедонал не лишен токсических свойств. Н. П. Кравков, характеризуя группу уретанов (уретан, гедонал, эйфорин), пишет, что действие самого уретана малонадежно, снотворные этой группы вызывают мочегонное действие, которое может помешать сну. Гедонал, по видимому, больше пригоден, согласно данным Кравкова, для наркоза в хирургической практике, чем для проведения длительного лечебного сна. Исходя из учения И. П. Павлова об охранительном торможении, можно рекомендовать при хроническом алкоголизме лечение сном. Такая терапия в данном случае патогенетически вполне обоснована, так как в мозговой коре больных хроническим алкоголизмом имеются выраженные явления охранительного торможения и лечение сном является поощрением и углублением этих защитных механизмов.

Лечебный пролонгированный сон на 12—18 часов в сутки мы проводим в течение 4—6 дней, а затем продлеваем его до 10 часов в сутки еще в течение одного месяца.

Лечебный сон мы с успехом проводили с помощью следующей снотворной смеси:

Rp. Bromurali 0,25
Luminali 0,05
Barbamyli 0,1
Nembutali 0,09
Pyramidoni 0,15
M. f. pulv. N. 12
DS. По 1 порошку 2 раза в день

Пирамидон в данной смеси потенцирует, усиливает действие снотворных средств. Эта смесь, назначаемая обычно один раз на ночь, вызывает глубокий сон длительностью 8—10 часов. Когда необходимо удлинить сон, эту смесь назначают повторно. Глубокий сон без явлений токсикоза вызывается сочетанием нембутала — 0,15 г с бромуралом — 0,5 г.

Весьма важным фактором при лечении сном является правильный выбор того или иного снотворного средства или сочетание их. В этом вопросе не должно быть никакого шаблона и стандарта, подбор таких средств следует строго индивидуализировать. Необходимо учитывать действие снотворных средств как на экстенсивность, так и на интенсивность сна. Следует применять такие снотворные средства, которые не нарушали бы глубоко обмена веществ и не вызывали токсикоза, ибо при назначении для вызывания длительного сна многих снотворных веществ (люминал, хлоралгидрат, сульфонал и др.) нередко наблюдаются гипертермия, азотемия, ацидоз и пр. и главным образом нарушения со стороны органов кровообращения и дыхания, приводящие к коллапсу, пневмониям и другим тяжелым осложнениям. В этом плане большое значение имеет экспериментальное изучение на животных действия различных снотворных средств, при помощи которых вызывается сон различной глубины и длительности. Хотя подобные исследования ведутся, но они весьма недостаточны по своим масштабам, если учитывать огромное значение терапии сном для всех областей медицины.

А. В. Палладин в своей работе «Обмен веществ в головном мозге» показал, что при наркотическом сне, вызванном медиалом, повышается содержание аденозинтрифосфорной кислоты, накопление которой обеспечивает активность коры мозга. Не уменьшается содержание нуклеиновых кислот, повышается активность некоторых ферментов, снижается расходование углеводов. А. В. Палладин правильно полагает, что во время сна, вызванного медиалом, процессы синтеза преобладают над процессами распада, а это восстанавливает работоспособность мозга. Данное исследование вносит некоторую ясность в

разрешение вопроса о влиянии медуллы на обмен веществ в головном мозге. Весьма важно также строго индивидуализировать дозировку снотворных средств. Наблюдается немало больных с нервно-психическими заболеваниями, у которых обычные фармакологические средства и даже большие дозы снотворных средств вызывают не сон, а лишь оглушение, сонливость, применение же малых доз снотворных средств (в 2—3—4—10—20 раз менее, чем дозы, принятые фармакологией) может вызывать глубокий сон. У большинства больных неврозами нам удавалось вызывать сон некоторыми стимуляторами, в частности, микродозами настойки чилибухи, которую им давали в виде раствора (одна капля этой настойки на 200 г воды) по одной столовой ложке на ночь. Сон, вызываемый этим раствором, длится 8—10 часов и почти ничем не отличается от физиологического. Увеличение дозы настойки в 2—3 раза также вызывает сон, но после него больные отмечали некоторую тяжесть в голове, а иногда головную боль; большие дозы настойки сна уже не вызывали. Указанное средство, повидимому, вызывает сон только у тех больных неврозами, в мозговой коре которых наблюдаются фазовые явления, промежуточные состояния между сном и бодрствованием. Микродозы настойки чилибухи, повидимому, переводят фазовые явления в сонное торможение. Мы изучаем этот вопрос в течение ряда лет. Нервные механизмы, лежащие в основе его терапевтического действия, пока не совсем ясны, но практическая польза этого средства как снотворного несомненна; оно не вызывает ни привыкания к нему, ни отрицательного влияния на организм больного. Недостатком его является то обстоятельство, что микродозы чилибухи не у всех больных вызывают сон; есть больные неврозами, у которых это средство сна не вызывает. Повидимому, это зависит от типологических особенностей больных, а также от тяжести невроза.

Весьма перспективным является лечение алкоголиков длительным гипнотическим сном, которое применяется в руководимой нами клинике в течение нескольких лет. Если загипнотизированного предоставить самому себе, то гипнотический сон, как показали наши наблюдения, спустя некоторое время переходит в физиологический, и больной пробуждается от него через 1—5 часов, как от обыкновенного, естественного сна. Если с больным поддерживать речевой контакт (рапорт), то гипнотический сон может быть удлинен до таких пределов, какие желательны для лечебных целей. Однако учитывая то обстоятельство, что поддерживать длительное время рапорт для врача затруднительно, так как это целиком отрывает его от работы, мы оставляли загипнотизированных в палате под наблюдением медицинских сестер. Когда больные просыпались, их подвергали повторной гипнотизации с таким расчетом, чтобы они спали столько часов, сколько этого требовалось по ме-

дицинским показаниям (от 20 до 22 часов в сутки). У большинства больных гипнотический сон проводился в следующие часы: с 12 до 14 часов дня, с 16 до 18 часов и с 21 до 9 часов (всего 16 часов в сутки). В свободное от сна время больные совершали туалет, принимали пищу, гуляли, читали газеты, книги. Обычно после 4—5 дней такого режима больные уже сами ложились спать в положенные часы и часто засыпали даже без гипноза. Очевидно, сон наступал в определенное время по механизму временной связи. Наряду с этим, нам удавалось достигать пролонгирования ночного сна посредством соотвествующего внушения, проводимого в состоянии гипноза. Мы внушали больным, что они будут спать определенный отрезок времени, соответственно указывая ночные и дневные часы, причем подчеркивали, что с каждым днем сон у них должен все больше углубляться. Обычно подобного рода внушения, проводившиеся в гипнотическом состоянии, у наблюдавшихся нами больных реализовались; они спали в указанные часы, т. е. нам удавалось достигать у них сна продолжительностью до 12—16 часов в сутки.

Длительный гипнотический сон и пролонгированный с помощью гипнотического внушения ночной и дневной сон мы проводили, в зависимости от состояния больного, в течение 5—10 дней и до одного месяца. В тех случаях, когда пациенты были негипнабельными, гипнотический сон у них вызывался с помощью снотворных средств. Для этой цели за один час до проведения гипноза им давали снотворную смесь, состоящую из 0,1 г нембутала, а при отсутствии такового—0,5 г мединала и 0,5 г бромурала и 0,25 г пирамидона; затем на фоне сонного торможения, вызванного этими веществами, мы проводили гипнотизацию. Обычно в первый же день удавалось вызывать неглубокие степени гипнотического сна.

После 3—4 сочетаний подобного рода в дальнейшем гипнотический сон удавалось вызвать уже без применения снотворных средств.

Еще в клинике И. П. Павлова разрабатывался вопрос о комбинировании лечебного сна с различными формами терапии. В послевоенный период были продолжены работы в данном направлении. Наряду с лечебным сном, комбинированным с другими методами лечения, в клинике при наркоманиях применяли лечение пролонгированным сном в сочетании с фенамином и кофеином. Больные спали в сутки по 12—15 часов (обычно с 20 до 10 часов утра). В 11 часов утра они получали один раз в сутки небольшую дозу фенамина (5—10 мг) или же 0,1 г кофеина. Подобного рода лечение пролонгированным сном в сочетании с фенамином или кофеином, применявшееся в течение 5—10 дней, смягчало или устраняло патологические симптомы и содействовало более быстрой нормализации нейродинамики.

В основе данной терапии лежат два взаимодействующих механизма: поощрение и углубление охранительного торможения и стимулирующая терапия. Как показали исследования В. К. Фаддеевой, небольшие дозы фенамина стимулируют вторую сигнальную систему, не вызывая изменений в первой сигнальной системе. Но несколько большие его дозы вызывают запредельное торможение во второй сигнальной системе, повышая возбудимость первой сигнальной системы. Исходя из этого, мы назначили больным микродозы фенамина. Фенамин является антагонистом снотворных средств, стимулирующим, как это показал С. Я. Арбузов, центральную нервную систему. Он, по мнению Н. В. Вершинина, мобилизует не последние запасные силы, а только недостаточно использованные ресурсы и устраняет нежелательные побочные действия снотворных средств. Весьма интересно наблюдение А. В. Палладина, который, изучая действие первитина, находил, что он вызывает усиление обменных процессов в головном мозгу и синтез биохимически и физиологически активного вещества — аденозинтрифосфорной кислоты, накопление которой обеспечивает повышенную активность коры.

З. Л. Синкевич в нашей клинике провела лечение больных хроническим алкоголизмом сном при помощи специально организованного режима. Методика проведения терапии сном сводилась к следующему. С больными проводилась предварительная беседа о значении и преимуществе этого метода лечения, а затем устанавливался нижеследующий режим, к обсуждению которого привлекались больные, подлежащие этому лечению. Сон проводился с 9 часов утра (после завтрака) и с 3 часов дня (после обеда), а обычный ночной сон — с 10 часов вечера. Утром больным предоставлялась возможность спать больше, но до установленного распорядком больницы времени. От больных, курящих табак, требовалось ограничение курения на период лечения сном.

Для проведения сна выбирались небольшие хорошо вентилируемые палаты (на 3—4 человека). Медицинский персонал надлежащим образом инструктировался. Он должен был всячески содействовать лечению сном: бороться за тишину, ограждая покой больных. От больных отделения требовалось соблюдение тишины, что достигалось посредством проведения соответствующих бесед, лекций и пр. В палаты, где проводилось лечение сном, запрещался вход другим больным, как в часы сна, так и вне их.

Наряду с учетом сна, который производился медицинским персоналом, мы требовали от больных, чтобы они проводили регулярный самоучет сна. Лечение сном при помощи специально организованного режима проводилось от 8 до 30 дней в зависимости от состояния больного, причем длительность сна равнялась в среднем 10—15 часам в сутки.

Механизм этой терапии можно объяснить таким образом: ограничение движений, уменьшение поступлений звуковых раздражителей, устранение зрительных раздражений и т. п. создают благоприятный фон для перехода корковых клеток в сонное состояние. Это возникновение сна легко по механизму условной связи приурочивается к тому или иному периоду дня и наступает в определенные часы. Самоучет сна, предварительная разъяснительная работа (беседа, речевая инструкция) с больным приводят к тому, что возникшие во второй сигнальной системе связи также оказывают регулирующее влияние на проведение терапии сном.

Смену больных, которые лечились сном, мы проводили не одновременно, а поочередно, в результате чего вновь поступавший больной включался в обстановку организованного сна. В таких случаях выступает добавочный механизм подражания. Преимущество такого сна заключается в том, что при нем отпадает ряд противопоказаний, отсутствуют осложнения, нет привыкания к снотворным средствам, не требуется специального надзора при медицинском обслуживании.

До лечения сном больные хроническим алкоголизмом спали в среднем от 3 до 7 часов в сутки. После его применения, как это показало соответствующее исследование, у больных нормализовалась нейродинамика, улучшился сон, исчезли патологические симптомы.

При организации надлежащего режима пролонгированный сон, сочетанный с психотерапией, может иметь большие перспективы во многих областях клинической медицины. Лечение таким сном можно сочетать с другими методами лечения.

Мы не будем касаться здесь нервных механизмов лечебного сна и механизмов самого выздоровления, ибо это частично отражено в соответствующей литературе, однако и этот вопрос нуждается в тщательном изучении и дальнейшей разработке.

Перед врачами и физиологами, работающими в области терапии сном, стоит еще много нерешенных задач. К таким задачам в первую очередь относится изыскание таких снотворных средств или снотворных смесей, которые бы были полностью безвредны, не обладали кумулятивным действием даже при длительном их применении и вызывали бы сон различной глубины и длительности. Этот сон должен при этом соответствовать глубокому физиологическому естественному сну и не переходить в наркоз. Необходимо добиться того, чтобы препараты не вызывали привыкания к ним, т. е. были бы надежными, эффективными снотворными средствами, полностью безопасными для здоровья. Необходима дальнейшая разработка различных дифференцированных форм лечения сном в отношении как методики и техники, так и длительности сна. Подлежит изучению терапия сном в сочетании с другими метода-

ми лечения и средствами, в частности, со стимуляторами нервной системы, инсулином, антибиотиками и другими методами лечения. Весьма важным и актуальным вопросом является разработка показаний и противопоказаний для лечения сном.

В серьезной разработке нуждаются условия и режим, в которых проводится лечение сном, а также применение различных условных и безусловных агентов, способствующих наступлению сна, что в итоге может дать возможность проводить лечение сном при минимальном количестве спотворных средств или даже без них с помощью специально организованного режима, сочетанного с психотерапией.

ГРАВИДАНОТЕРАПИЯ

Учитывая свойство гравидана повышать жизненный тонус организма, мы совместно с П. П. Обнорским изучали действие на алкоголиков гравидана, изготовленного по методу А. А. Замкова. Гравидан вводился внутримышечно по 0,5; 3; 10; 15 мл, в зависимости от реакции организма на эти инъекции. Почти у всех больных уже после первых инъекций гравидана смягчались явления абстиненции, улучшалась деятельность сердца и желудочно-кишечного тракта, сон и аппетит, повышалась работоспособность, внимание и память. У многих больных, страдавших на почве алкоголизма половыми неврозами, восстанавливалась половая функция. Гравидан оказывал благотворное действие и на кровяное давление. Пониженное или повышенное кровяное давление в результате применения гравиданотерапии в течение месяца у многих больных приходило почти к норме (П. П. Довженко). Больные, леченные гравиданом, больше прибавляли в весе, чем больные, которым гравидан не назначался. У некоторых алкоголиков, организм которых подвергся преждевременному одряхлению, под его влиянием значительно поднимался жизненный тонус (восстановление половой функции, увеличение веса, улучшение деятельности сердца и т. п.).

Катамнестические обследования больных, леченных гравиданом, дали весьма ободряющие результаты, что позволяет отнести гравидан к группе эффективных биологических средств при лечении хронического алкоголизма.

На основании наблюдений мы установили оптимальную дозу гравидана для алкоголиков в 0,5—3 мл, назначаемую через день. Число инъекций строго индивидуализируется и колеблется от 10 до 30. Желательно повторение курса инъекций гравидана через год. Осложнений при лечении гравиданом мы не наблюдали. Гравидан противопоказан при тяжелых болезнях сердца и почек, при активном туберкулезе, тяжелой гипертонии.

ЛЕЧЕНИЕ ПУТЕМ ВЫРАБОТКИ УСЛОВНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ И РВОТНОЙ РЕАКЦИИ НА АЛКОГОЛЬ ПРИ ПОМОЩИ АПОМОРФИНА, ЭМЕТИНА И ДРУГИХ РВОТНЫХ СРЕДСТВ

При лечении хронического алкоголизма нужно применять такие средства, которые, будучи введены подкожно или непосредственно в желудок, воспрепятствовали бы хорошему самоощущению при приеме алкоголя. Это в свою очередь уничтожает непреодолимое или трудно преодолимое влечение к алкоголю. Задачей является выработка таких условий, при которых первая рюмка алкогольного напитка вызывала бы не положительную, а отрицательную реакцию, т. е. неприятное ощущение, тошноту и даже рвоту.

Это средство должно действовать в течение нескольких дней, чтобы у больного могло закрепиться отвращение к алкоголю. Если больной не получает приятного ощущения от приема алкоголя, а, наоборот, испытывает физическую слабость, тошноту, рвоту и т. п., он будет вынужден исключить все спиртные напитки из своего обихода.

Большое будущее в лечении алкоголизма принадлежит методу, базирующемуся на учении великого русского физиолога И. П. Павлова, т. е. на выработке отрицательного условного рефлекса на алкоголь с помощью рвотных средств.

Н. А. Подкопаев по заданию И. П. Павлова вырабатывал рефлекс на автоматический раздражитель (апоморфин), комбинируя его с тоном определенной высоты. Собаке впрыскивали под кожу небольшую дозу апоморфина и спустя 1—2 минуты в экспериментальной комнате давали в течение некоторого времени тон определенной высоты; во время звучания этого тона собака становилась беспокойной, у нее наступала саливация, тошнотная реакция, а иногда и небольшая рвота в связи с приемом апоморфина.

Когда эти опыты были повторены много раз, то уже одно звучание тона начало вызывать в слабой степени ту же реакцию. В. А. Крылов, проводя серологические исследования в лаборатории, отметил следующее явление. После регулярного ежедневного впрыскивания собакам морфина (у собак при подкожном введении морфина отмечалась рвотная реакция) примерно на 5—6-й день уже при одних только приготовлениях к инъекции возникает такая же картина, как и при впрыскивании морфина: сильная саливация, рвотные движения, рвота и затем сон.

Следовательно, рвота вызывалась уже не самим морфином, действующим через кровь на «рвотный центр», а теми условными раздражителями, которые совпадали по времени с введением морфина. Иногда описанную выше картину вызывало появление экспериментатора или же вынимание и открывание

ящика со шприцем, протирание кожи спиртов, введение под кожу индифферентной жидкости. Чем больше было проведено впрыскиваний морфина, тем менее требовалось перечисленных выше манипуляций, чтобы развилась картина морфинного отравления.

К. М. Быков и Алексеев-Беркман исследовали выделительную функцию почек как в обычных условиях, так и при введении 100 г водопроводной воды, нагретой до температуры тела животного. В дальнейшем было установлено, что, по мере того как возрастало количество опытов с вливанием воды, увеличивалось количество мочи, причем значительный диурез наблюдался сразу же после того, как животное помещали в стойку или делали необходимые приготовления для вливания воды.

Изучая возможность образования условных связей на диурез при применении автоматических гормональных раздражителей, действующих на почки через кровь, К. М. Быков применял питуитрин, который вызывал торможение диуреза. Затем в последующих опытах вместо питуитрина вводился физиологический раствор при наличии водной нагрузки (в желудок вводилось 400 мл воды); при этом отмечалось такое же торможение диуреза, как и после инъекции питуитрина.

Опытами Б. Е. Делова установлено изменение электрокардиограммы у собаки под влиянием большой дозы морфина (0,2 г), введенного под кожу. Частота сердцебиений сокращалась. После 20—30 инъекций морфина уже одна внешняя обстановка, т. е. комплекс раздражений, связанных с введением морфина (без введения последнего), вызывала такие же изменения электрокардиограммы, как и морфин. Сердцебиение замедлялось.

После 100 опытов, в которых гудок сочетался с инъекцией в вену нитроглицерина (данные Е. П. Петровой, сотрудницы К. М. Быкова), уже один гудок вызывал почти такие же изменения в электрокардиограмме, как и введение нитроглицерина.

А. Г. Иванов-Смоленский, сочетая сигнал «зрачки расширяются» с сопровождавшим его затемнением глаз, вырабатывал уже после 11-го такого сочетания расширение зрачков лишь путем словесного воздействия. При словах «зрачки расширяются», сказанных экспериментатором или самим исследуемым, зрачки расширялись.

Л. И. Котляревский вырабатывал у детей условный зрачковый рефлекс на звонок, а также, пользуясь в качестве безусловного рефлекса рефлексом Ашнера, выработал сердечно-сосудистый условный рефлекс в виде замедления пульса на 6—12 ударов в минуту в ответ на звуковой сигнал.

Н. И. Козин, измеряя при упомянутых условиях кровяное давление, выработал условную реакцию в виде повышения его на 10—12 делений в ответ как на непосредственный, так и на словесный раздражитель.

В психиатрической клинике А. Г. Иванова-Смоленского его ученики Ю. А. Поворинский, Т. В. Строкина, Н. Г. Гарцштейн в связи с активной терапией у лечившихся больных шизофренией время от времени заменяли инъекции инсулина и кордиозола инъекциями физиологического раствора и получали изменения, аналогичные тем, которые давали инсулин и кордиол, т. е. образовывался условный рефлекс на эти средства, что позволяло сокращать количество инъекций инсулина и кордиозола.

Объяснение этого явления можно найти в работе И. П. Павлова, который пишет: «Безусловный или хорошо выработанный условный раздражитель, конечно, вызывает деятельное состояние определенного отдела головного мозга. Будем называть этот отдел, по общепринятой терминологии, центром, не связывая, однако, с этим словом представления о точной анатомической обособленности. Очевидно, что к этому центру направляются раздражения, производимые в то же время внешними агентами в клетках коры больших полушарий; путь для этих раздражений именно к этому центру является особенно облегченным, а после нескольких совпадений—проторенным... Если к рефлекторно раздраженному центру направляются раздражения из клеток коры больших полушарий, то тоже самое должно было произойти и в отношении автоматически, внутренними агентами, составом и свойствами крови, раздражаемого центра, что подтвердилось...»¹.

«Внешние раздражения, даже со дня рождения животного направлявшиеся в известный центр, могут быть отклонены от него в направлении к другому центру и связаться с ним, если этот последний центр физиологически сильнее первого. Таким образом, это слияние, соединение раздражений, возникающих в разных пунктах головного мозга, это нервное замыкание и есть первый нервный механизм, с которым мы встречаемся при изучении деятельности коры больших полушарий»².

Приведенные выше опыты Н. А. Подкопаева и В. А. Крылова, К. М. Быкова, А. Г. Иванова-Смоленского и их сотрудников дали основание использовать для лечения алкоголиков выработку условного рвотного рефлекса на алкоголь при помощи рвотных средств.

Вопрос о лечении алкоголиков рвотными средствами не новый. В народной медицине с давних пор применяют различные средства, способствующие появлению рвоты и отвращения к алкоголю.

Проф. Л. М. Минор для этой цели предложил микстуру, включающую рвотные и горькие ингредиенты. Мысль о том, что при лечении алкоголиков следует использовать выработку

¹ И. П. Павлов, Полное собрание трудов, т. 4, 1947, стр. 46.

² Там же.

отрицательного оборонительного рефлекса на различные алкогольные раздражители, высказал еще В. М. Бехтерев, а затем Н. В. Канторович.

И. Ф. Случевский и А. А. Фрикен в 1933 г. в Колмовской психиатрической больнице лечили алкоголиков введением 0,003—0,01 г апоморфина, смешанного с водкой. Если в первые дни рвота не наступала, дозу апоморфина увеличивали до 0,05 г.

После того как устанавливали дозу апоморфина, вызывающую рвоту, апоморфин с водкой назначали еще в течение 10—11 дней. На 21-й день давали водку без апоморфина, и рвота наступала так же, как после приема апоморфина. Если рвота не наступала, делали несколько дней инъекции апоморфина или давали апоморфин с водкой внутрь. Обычно к 21-му дню вырабатывался прочный рвотный рефлекс.

И. Ф. Случевский и А. А. Фрикен получили положительные результаты при лечении по этому методу всего в 7 случаях. Почти аналогичным способом, лечил алкоголиков Ефремов, сочетавший инъекции апоморфина с внушением.

А. Морковников, исходя из многолетнего опыта лечения алкоголиков в специальной лечебнице общества трезвости, базируясь на учении И. П. Павлова, предлагал лечить алкоголиков внушением в сочетании с инъекциями апоморфина. Больному внушалось, что у него появится тошнота при виде спиртного напитка и рвота, если он его выпьет. Затем вводился апоморфин. Через 2 минуты наливали водку так, чтобы больной это видел и чтобы тошнота сочеталась с видом водки; когда наступает тошнота, больному дают глоток водки. А. Морковников не пользовался этим методом, но рекомендовал его, исходя из теоретических предпосылок.

Н. В. Канторович еще в 1929 г. применял для лечения алкоголиков сочетательно-рефлекторный метод терапии. Электрокожные раздражения сочетались с демонстрацией надписей, плакатов, распылением водки и т. д., чем достигалась выработка оборонительного сочетательного рефлекса на алкоголь и алкогольные раздражители.

Мы также свыше 20 лет лечили алкоголиков путем выработки условной рвотной реакции на алкоголь с помощью апоморфина, подкрепляемого внушением наяву, или в последние годы вырабатывали условную рвотную реакцию на алкоголь в гипнотическом состоянии.

Алкоголику вводили 0,25—0,5 мл 1% апоморфина подкожно, после чего давали нюхать употреблявшийся больным алкогольный напиток (водку, коньяк, пиво, вино и пр.), подкрепляя это следующим внушением: «Запах и вкус алкоголя будут у вас всегда вызывать неприятные ощущения, тошноту и рвоту. Вы больше не будете испытывать влечения к спиртным напиткам. Вы больше не сможете пить. Все спиртные на-

питки будут у вас вызывать неприятные, тягостные ощущения, тошноту и рвоту». Так мы повторяли 2—4 минуты. Когда мы видели, что у больного должна наступить рвота (обычно на 7—10-й минуте), мы давали ему 40—100 г водки. После приема водки мы вновь императивно внушали отвращение к водке, вызывая тошноту и рвоту.

Подобное лечение мы проводили ежедневно или через день в течение 20—30 дней.

Объективно отвращение к водке выражалось в неприятных ощущениях, саливации, гримасе отвращения при приеме вина и в рвоте после приема водки даже без инъекции апоморфина, обычно для выработки тошнотной и рвотной реакции на алкоголь было достаточно 15—25 инъекций апоморфина, сочетанных с приемом алкоголя.

У части больных мы вырабатывали условную рвотную реакцию на алкоголь без всяких медикаментов, только при помощи гипноза. У большинства же больных появлялось довольно стойкое чувство отвращения к вину. Они заявляли, что алкоголь им противен — «смотреть неприятно», «попробовал выпить — мутит», «к водке не тянет».

Наряду с успешными результатами, наблюдались и отрицательные. Мы видели даже таких больных, которые находили своеобразное удовольствие в лечении апоморфином. По окончании курса лечения они умоляли сделать им хотя бы еще одну инъекцию. Объясняется это тем, что у некоторых лиц апоморфин не вызывает рвоты, а вызывает лишь состояние опьянения, оканчивающееся 2—3-часовым сном.

Фегтлинг в США и его сотрудники, исходя из учения И. П. Павлова, впрыскивали алкоголикам рвотные средства (эметин). Через 5—6—10 минут больному предлагали посмотреть, понюхать и выпить какой-нибудь алкогольный напиток. Если время было выбрано удачно, у больного сразу же после приема спиртного напитка наступала рвота. Подобные сеансы Фегтлинг повторял ежедневно в течение 7—10 дней. При рецидивах лечение возобновлялось. Рецидивы алкоголизма отмечались примерно в 40% в течение первого года и приблизительно в 20% на протяжении второго года. В дальнейшем, если не проводилось надлежащее лечение, количество рецидивов увеличивалось. Тысячи больных, страдающих алкоголизмом, подвергались лечению по способу Фегтлинга с положительными результатами.

Все перечисленные авторы не учли важнейшего положения И. П. Павлова, а именно, что, «... первое и основное условие для образования данного условного рефлекса—это совпадение во времени действия ранее индифферентного агента с действием безусловного агента, который вызывает определенный безусловный рефлекс. Второе важное условие состоит в следующем. При образовании условного рефлекса индифферентный

агент должен несколько предшествовать действию безусловного раздражителя»¹.

«Если мы сделаем наоборот и сначала начнем действовать безусловным раздражителем, а затем присоединим, индифферентный агент, то условного рефлекса не образуется»,—пишет И. П. Павлов².

И. Ф. Случевский и А. А. Фрикен делали инъекцию апоморфина и сразу или через 3 минуты давали алкоголь, а последние 10 сеансов вообще давали водку, смешанную с апоморфином, что методически неправильно, так как апоморфин изменяет вкус алкоголя.

Н. В. Ефремов давал алкоголь за 3—4 минуты до наступления рвоты. То же отмечается и у других авторов, ибо врачу трудно предугадать, через какой промежуток времени после инъекции апоморфина наступит рвота, тем более что больные реагируют на апоморфин по-разному. Как мы видим, условный раздражитель по времени значительно отставал от безусловного: от 3—4 минут до 7—10 минут, что мешало быстрой выработке условных связей. Ряд авторов, наряду с апоморфином, применял внушение, вследствие чего неясно, за счет чего отнести положительный эффект, ибо положительные результаты лечения часто может давать одно внушение. Кроме того, нужно учесть, что алкоголь для наших больных является неиндифферентным раздражителем, а своего рода мощной условной связью, доминантой, которую следует угасить.

Все указанные авторы, кроме Н. В. Ефремова, не учитывали, что выработанная условная рвотная реакция на алкоголь постепенно ослабевает, и не подкрепляли ее в последующем. Допускаемые погрешности также отражались на результатах лечения. Все это приводило к тому, что у многих больных наступал рецидив. Отношение врачей-практиков к этому ценному методу поколебалось, и разработка его была приостановлена.

Мы поставили перед собой задачу найти более правильную методику лечения хронического алкоголизма посредством выработки условной реакции на алкоголь с помощью апоморфина и других рвотных средств, в частности, эметина, ипекакуаны, сернокислой меди, сернокислого цинка, термописа, различных рвотных смесей и т. п. Для этой цели мы отбирали тяжелых алкоголиков, не поддававшихся другим способам лечения. Методику лечения мы несколько изменили. В основном она сводится к следующему.

Вначале мы находим минимальную дозу апоморфина, хлористоводородного эметина или других рвотных средств, от которых у больных наступает рвота. Нужно подчеркнуть, что эти дозы весьма вариабельны и обуславливаемая ими рвотная

¹ И. П. Павлов, Полное собрание трудов, 1947, т. 4, стр. 37.

² Там же.

реакция зависит от состояния больного, его индивидуальных особенностей, времени дня, фактора утомления, наличия фазовых явлений в мозговой коре. Мы устанавливаем также скрытый период рвотной реакции, который тоже сугубо индивидуален и динамичен.

Минимальная доза апоморфина, способная вызвать рвоту, равняется 0,1 мл 1% апоморфина (подкожно) и 0,03—0,05 мл хлористоводородного эметина (обычно внутрь).

На стол ставят бутылки с водкой, вином и посуду, из которой больной пьет (рюмки, кружки или стопки).

Вначале больному вводят установленную для него минимальную дозу рвотного (апоморфина или эметина). Через определенный срок, установленный в предварительном опыте, перед наступлением тошноты, обычно спустя 4—10 минут, больному дают понюхать, а затем выпить глоток водки. Необходимо, чтобы прием водки предшествовал наступающей в это время тошноте. Затем больному дают в руки стопку или рюмку с алкогольным напитком, которым он злоупотреблял (40—50 г водки, вина или коньяку), и предлагают продолжать нюхать его; когда тошнота резко усилится и больной почувствует приближение рвоты, он должен выпить алкогольный напиток. Обычно сами больные чувствовали наступление рвоты, которая появлялась у них через 1—2 секунды после глотка водки.

После появления тошноты рвота наступает в промежуток времени от 1 до 15 минут. В отдельных случаях рвота наступает непосредственно вслед за тошнотой.

В некоторых случаях спустя 3—4 минуты после инъекции появляется саливация, покраснение лица, чувство жара, головокружение или шум в голове, тошнота; отмечается также раздражение слизистой носа и верхних дыхательных путей, которое постепенно усиливается. У части больных (более пожилого возраста) наблюдается резкая гиперемия лица, а у части (в основном молодого и среднего возраста) — значительное его побледнение. Все тело покрывается потом, иногда настолько обильным, что белье становится влажным. Пульс вначале ускоряется, а перед наступлением рвоты замедляется до 40—50 ударов (в отдельных случаях до 25—30 ударов) в минуту. Кровяное давление обычно снижается и в отдельных случаях падает до 40/20 мм ртутного столба. Вся эта бурная вегетативная реакция заканчивается рвотой, после которой больные испытывают облегчение. Рвота продолжается обычно от 2 до 5 минут, а иногда наступает повторная рвота, продолжающаяся до 25—30 минут. После рвоты наступает сон, длящийся 2—3 часа. В некоторых случаях апоморфин рвоты не вызывает, а дает лишь состояние наркоза — сна; у отдельных мужчин он вызывал сильные эрекции. Учитывая это до сих пор неизвестное нам свойство апоморфина, мы назначали

его в малых дозах для лечения половой слабости, выражавшейся в полном отсутствии эрекций.

У части больных инъекция апоморфина вызывает настолько бурную вегетативную реакцию (брадикардия, ослабление пульса, резкое побледнение лица, чрезвычайная потливость, значительное падение кровяного давления, резкая физическая слабость, коллапс), что для купирования этого состояния приходится прибегать к инъекциям стрихнина, кофеина, камфоры, а иногда и атропина.

Последующие реакции у большинства больных бывают значительно слабее. После 4—7 инъекций апоморфина у больных появляется гримаса отвращения даже при входе в кабинет, где проводится лечение. Уже один вид бутылок, рюмок, стопок, персонала, проводящего лечение, вызывает тягостные ощущения, потливость, покраснение лица, саливацию и пр.

У небольшой части больных во время последующих сеансов уменьшается скрытый период рвотной реакции, но в большинстве случаев он сугубо индивидуален и динамичен, давая колебания от 3 до 35 минут. Бывает и так, что ни апоморфин, ни эметин при последующих реакциях рвоты не вызывает, даже при значительном, постепенном увеличении доз, между тем при повторении прежних начальных малых доз апоморфина возникает рвотная реакция. Такой новый факт, установленный нами, говорит о запредельном торможении рвотного центра, о наличии в нем парадоксальной фазы. Для усиления рвотной реакции за 3—4 минуты до инъекции апоморфина иногда рекомендуется применять инъекцию 20% раствора кофеина. Кофеин потенцирует действие апоморфина, и часто такая комбинация кофеина с апоморфином вызывает рвотную реакцию у тех больных, у которых она угасла. У небольшой части больных рвотная условная реакция на алкоголь вырабатывается довольно быстро; вкус, запах и даже один вид вина вызывают стойкое отвращение и рвотную реакцию. Для иллюстрации приведем две истории болезни.

1. Больной Ш., с 14/V по 30/V 1946 г. лечился вливаниями гипертонических растворов и вдуванием кислорода. С 30/V приступлено к выработке рвотной условной реакции на алкоголь с помощью апоморфина. 30/V введено 0,25 мл 1% солянокислого апоморфина; перед тошнотой и рвотой было дано по 15 г водки; в промежутках между приемами алкоголя больному давали нюхать водку. Вскоре после приема апоморфина у больного появилась головная боль, ухудшилось самочувствие и настроение. Рвота наступила через 10 минут после введения апоморфина. Больной резко побледнел, лицо его покрылось потом. Рвота продолжалась 15 минут; после рвоты появилась слабость; тошнота продолжалась до 31/V. Никакого неприятного чувства больной к водке не испытывал, жалел лишь, что ему дали небольшое ее количество.

1/VI введено 0,5 мл 1% раствора апоморфина. На 3-й минуте появилась саливация, на 5-й минуте — тошнота. Рвота наступила через 10 минут. Перед наступлением тошноты, так же как и рвоты, больной нюхал, а затем выпивал по 30 мл водки. Рвота продолжалась 15 минут. После

второго сеанса разговор о водке был ему уже неприятен. Казалось, что от собеседников пахнет вином, вследствие чего больного «мутило» 2 дня. Спал плохо, настроение подавленное. Испытывает боли в голове и в области сердца.

4/VI утром настроение хорошее. Особенно хорошо чувствовал себя, когда узнал, что лечащий врач уехал — думал, что его не будут лечить апоморфином. В 4 часа дня было введено 0,5 мл 1% раствора солянокислого апоморфина. Спустя 5—6 минут появилось ощущение жара в лице, слабость, в значительном количестве выделялась слюна; больной все время отплевывался. Нюхая водку, почувствовал тошноту. Дан глоток водки, после чего больной продолжал нюхать водку. На 9-й минуте наступила обильная рвота, продолжавшаяся 20 минут. Вечером отмечалось головокружение, слабость, тошнота, отсутствие аппетита. Постоянно чувствовал запах спирта, испытывал тошноту. На другой день, когда утром ему делали инъекции, запах спирта от ваты, которой медицинская сестра протирала ему руку, вызвал тошноту и неприятное самочувствие.

Состояние больного после инъекций апоморфина, сделанных 8/VI, 10/VI и 15/VI, было аналогично предшествующим, но реакция на апоморфин была выражена слабее. По окончании рвоты, длившейся 20—30 минут, плохое самочувствие длилось 1½—2 часа. С каждым сеансом отвращение к водке усиливалось. Общая слабость и боли в голове удерживались по 2—3 дня. Седьмой сеанс, проведенный 20/VI, больной перенес особенно тяжело. Рвота длилась около 2 часов. Отмечалось сильное сердцебиение, затрудненное дыхание. Такое состояние длилось 2 часа. 21/VI и 22/VI наблюдались сильные головные боли, тошнота, упадок сил, раздражительность, двигательное беспокойство — больной не мог найти себе места. Слово «водка» вызывало тошноту и потливость, неприятное самочувствие. Достаточно было больному войти в кабинет, где проводилось лечение, как у него появлялась потливость, покраснение лица, сонливость и тошнота.

26/VI, 28/VI и 30/VI больному давали водку уже без предварительного впрыскивания апоморфина. При этом сразу наступала обильная рвота, спазмы в горле, головная боль, потливость и слабость, т. е. реакция, аналогичная той, что и после инъекций апоморфина. Всего больному было сделано 8 инъекций апоморфина, и 3 раза он получал алкоголь без апоморфина. Последние три пробы показали, что у больного выработалась и упрочилась условная рвотная реакция на алкоголь.

С 20/VI больной стал отмечать ослабление внимания при разговоре. Он пропускал отдельные слова и фразы собеседников, просил их повторить сказанное. Появились головные боли в затылке, потливость, раздражительность, значительные колебания настроения, состояние какой-то неудовлетворенности, неусидчивости. При перемене горизонтального положения на вертикальное в течение нескольких секунд в глазах «все плывет», появлялось головокружение, общая слабость, неустойчивость в ногах. Кожные покровы стали более бледными. Начал избегать лечащего врача. Стал меньше шутить, сделался более серьезным. Больному было назначено лечение гипертоническими растворами (глюкоза и сернокислая магнезия), а также симпатомиметинум в течение 10 дней, который давался от 1 до 10 капель на полстакана воды утром за 2 часа до еды.

10/VII больной был выписан в хорошем состоянии и приступил к работе. Вскоре после выписки из больницы самочувствие его резко улучшилось, появились радужные перспективы на будущее. Настроение было хорошее. Восстановилась энергия, трудоспособность, улучшилась наблюдательность, память. Всякое упоминание о водке, особенно о лечении апоморфином, было неприятно, ухудшалось настроение, появлялась тошнота.

Отмечались лишь частые расстройства со стороны желудка и боли в ногах. Через месяц после выписки из больницы продолжал быть уверенным в себе, в частности, в том, что спиртных напитков употреблять не будет.

Видел следующий сон. Какая-то компания незнакомых людей настойчиво предлагала выпить хотя бы немного водки. Больной отказы-

вался, ссылаясь на то, что у него возникнет рвота. Уговаривавшая больного компания была настолько настойчива, что больной уступил и выпил немного водки. Проснулся с резкой головной болью, как будто после рвоты. Разговор о водке больному неприятен.

До настоящего времени (3 года) не пьет и чувствует себя удовлетворительно.

2. Больной П., 40 лет. Отец больного умер от алкоголизма. Сестры отца — алкоголички. Брат матери — алкоголик, умер в молодом возрасте. Сестра больного — алкоголичка. Злоупотреблял алкоголем в течение 14 лет. С 1945 г. в связи с семейными неприятностями стал еще больше злоупотреблять алкоголем. В марте 1946 г. лег в больницу. После выписки продолжал употреблять спиртные напитки. Поступил в больницу повторно 2/VII 1946 г.

Физическое состояние. Больной среднего роста, атлетического телосложения. Со стороны внутренних органов изменений не отмечается.

Неврологическое состояние. Зрачки равномерны, хорошо реагируют на свет. Сухожильные рефлексы значительно повышены. Красный дермографизм, тремор рук и век. Симптомов органического поражения нервной системы нет.

Психическое состояние. Сознание ясное, несколько эйфоричен, склонен к резонерству. Круг интересов сужен. Склонность к хвастовству, лживости. Алкогольный юмор. Память понижена. Обманов чувств и бредовых идей нет.

7/VIII введено 0,25 мл 1% раствора солянокислого апоморфина. Сразу же появилось ощущение, будто руки и ноги отделились от туловища. Окружающее представилось в желтом свете. Появилось ощущение жара в голове, состояние стало крайне тягостным, ухудшаясь с каждой секундой. Выступил обильный пот, началась тошнота. Больному дан глоток водки и предложено ее нюхать. Появилась обильная саливация. Больной резко побледнел, упал на кушетку. Пульс 40 ударов в минуту. Введен 1 мл стрихнина и кофеина, после чего появился страх смерти. На 10-й минуте наступила рвота, после чего больной почувствовал облегчение. Через 2 часа все тягостные явления прошли. Спал удовлетворительно.

10/VIII, когда больной взял стакан с водкой и понюхал, началась рвота. Введено 0,25 мл 1% раствора апоморфина. Наступило состояние, аналогичное тому, какое он испытал после первой инъекции. Голова отяжелела. Больной жаловался на тошноту, отмечалось обильное потоотделение. После глотка алкоголя сразу появилась рвота. Резкое побледнение лица. Сильное головокружение, тошнота и непрерывная рвота. Кровяное давление со 127/70 упало до 70/40 мм. Брадикардия, пульс 52 удара в минуту. Сделана инъекция кофеина и стрихнина. Рвота с перерывом продолжалась 35 минут. После рвоты больной испытывает резкий озноб, дрожь, как при малярийном приступе. Через 3 часа состояние улучшилось. На другой день самочувствие хорошее.

12/VIII при входе в кабинет на лице больного появилась гримаса отвращения, обильная саливация; он непрерывно сплевывает накопившуюся слюну. Глядя на рюмку, бутылку с водкой, испытывает тошноту. В 2 часа введено 0,25 мл 1% раствора солянокислого апоморфина и дан глоток водки. Больной испытывает чувство опьянения, с трудом различает сидящих против него людей. Перед рвотой дан глоток водки. Отмечено резкое побледнение лица, потливость, головокружение, ослабление пульса, понижение кровяного давления со 115/85 до 60/30 мм. Рвота наступила на 15-й минуте после инъекции. Через 2 часа больной чувствовал себя хорошо.

14/VIII дан глоток водки. На лице гримаса отвращения, рвотные движения, обильная саливация, кашель, чихание, слезотечение. Введено 0,25 мл 1% раствора апоморфина. После инъекции все тело покрылось обильным потом. Первые 2—4 минуты отмечалось сильное покраснение

лица, сменившееся резкой бледностью. Падение пульса, кровяного давления. Руки и ноги отяжсели, язык заплетается, сильная тошнота, головокружение, слабость, рвота, которая наступает обычно на 20-й минуте и длится с перерывами 20—30 минут. После сеанса знобит, появляется дрожь. Впоследствии даже вид вина вызывал у больного тошноту. После 10-го сеанса рвотная реакция наступила уже только от приема водки. Всего больному было сделано 15 инъекций апоморфина.

Из данных анамнеза известно, что больной после выписки из больницы не пьет алкогольных напитков уже 4-й год.

Очевидно, чем сильнее рвота, вызываемая апоморфином, тем быстрее вырабатывается рвотная условная реакция на алкоголь и тем она прочнее. Однако подобная картина наблюдается не всегда. У значительной части больных рвотной условной реакцией на алкоголь от апоморфина не получается, а вырабатывается лишь тошнотная реакция и отвращение к алкоголю. В таких случаях приходится проводить 10—30 сеансов, чтобы добиться положительных результатов. Обычно лишь после 10—20 сеансов у больных появляется саливация, неприятные ощущения, тошнота при виде или при запахе водки, исчезает влечение к ней. Для этих больных характерно следующее обстоятельство: в последующем обычные дозы апоморфина не приводят к рвоте, и количество вводимого апоморфина или эметина приходится постепенно увеличивать. У части больных даже большие дозы апоморфина не вызывают рвоты, а лишь приводят их в состояние оглушения, опьянения.

В таких случаях мы уменьшали дозы апоморфина и проводили инъекции его не ежедневно, а через день или 2 раза в неделю. Это позволило нам добиться рвотной реакции у большинства этих больных за единичными исключениями, когда даже после 20 инъекций апоморфина рвота не наступала. В тех случаях, когда апоморфин не вызывал рвотной реакции, мы давали больным внутрь следующую смесь из ипекакуаны, поваренной и глауберовой соли, касторового масла и рыбьего жира:

Rp. Pulv. rad. Ipecacuanhae 1,0
Natr. chlorati
Natr. sulfurici aa 15,0
Aq. destill. 200,0
Ol. Ricini 30,0
Ol. Jecoris aselli 50,0
MDS. По 1 столовой ложке после приема одного глотка водки

Обычно предварительно мы давали больному глоток водки. У одних больных рвота наступала немедленно после приема этой смеси, у других же смесь вызывала лишь тошноту.

Следует отметить, что в тех случаях, когда не удается выработать рвотной условной реакции на алкоголь, с помощью апоморфина, эметина и рвотных смесей можно все же добиться

ся исчезновения влечения к вину. В начале лечения при приеме водки больные испытывают чувство удовольствия и жалеют лишь о том, что им дали небольшую порцию; после 10—20 сеансов водка вызывает у больных уже отвращение и тошноту. При входе в кабинет, где проводятся инъекции апоморфина, у них появляется саливация. Вино больше не доставляет им удовольствия, они становятся к нему индифферентными. Повидимому, типологические особенности, особый склад нервной системы у этих больных не позволяют выработать у них рвотную условную реакцию на алкоголь. Возможно, что другие рвотные средства, вызывающие более тягостную реакцию, чем апоморфин, дадут и у них положительные результаты.

Следует подчеркнуть необходимость соблюдения известной осторожности при лечении указанным способом больных с травматическими нарушениями центральной нервной системы. У таких лиц прием апоморфина выявляет симптоматику, имевшую место в первые дни после контузии. Например, у одного больного после инъекции апоморфина каждый раз развивался парез правого лицевого нерва центрального типа, амнестическая и моторная афазия, акалькулия, аграфия, правосторонний гемипарез. Такое состояние длилось 3—4 дня. У другого больного после инъекций апоморфина появлялись зрительные галлюцинации (крысы, черви), т. е. воскрешалась симптоматика, бывшая у него при белой горячке. Эти факты указывают, что у алкоголиков с травматическим поражением головного мозга восстановление нарушенных травмой функций непрочное; у них вновь происходит нарушение функций при воздействии таких средств, как апоморфин, что следует иметь в виду.

Противопоказаниями к применению апоморфина мы считаем открытые формы туберкулеза, злокачественные опухоли, тяжелые формы гипотонии и гипертонии, стенокардию, язву желудка и двенадцатиперстной кишки, цирроз печени, поражение почек, тяжелые формы артериосклероза, органические заболевания центральной нервной системы, наличие инородных тел в полости черепа и во внутренних органах, престарелый возраст.

Для купирования коллапса, наблюдаемого иногда после инъекций апоморфина, прежде всего следует придать больному горизонтальное положение, затем при надобности применить инъекции стрихнина, кофеина, атропина, лобелина, искусственное дыхание, обрызгивание головы холодной водой, вдыхание нашатырного спирта и т. п.

При наличии соответствующих показаний и отсутствии противопоказаний осторожное применение солянокислого апоморфина осложнений обычно не вызывает, исключая случаи идиосинкразии у лиц, крайне чувствительных к апоморфину.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ СЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИМИ К АЛКОГОЛЮ ВЕЩЕСТВАМИ

Как мы уже говорили, с давних пор люди пытались найти средство, вызывающее отвращение к алкоголю. В народной медицине для этой цели применялась так называемая кузьмичева трава и многие другие средства. Следует сказать, что при лечении от алкоголизма видное место займут средства, вызывающие отвращение к спиртным напиткам.

И. П. Павлов впервые обратил внимание на значение химического анализатора, приводя следующее наблюдение, базирующееся на опытах Я. Е. Егорова, И. И. Савича и С. П. Хазена.

И. П. Павлов пишет: «Таким образом, тот или другой химический состав крови различался мозговым концом химического анализатора, выражаясь то в повышении, то в понижении возбудимости соответствующей части этого анализатора, когда в кровь избыточно поступала кислота, повышалась возбудимость кислотной части химического анализатора — и организм при встрече с кислотой из внешнего мира энергичными отрицательными двигательными и секреторными рефlekсами исключал в большей или меньшей мере дальнейшее ее поступление. То же самое, конечно, происходит и с пищевыми веществами, выражаясь соответственно в усилении и ослаблении то положительной, то отрицательной реакции на те или другие вещества и в тех или других количествах их.

Итак, химический ротовой анализатор своими концами соединяет две среды: внутреннюю среду организма и внешнюю, регулируя их соотношение и тем обеспечивая нормальный состав организма»¹.

Это замечательное наблюдение И. П. Павлова имеет колоссальное значение для клиницистов. Оно дает ключ к физиологическому пониманию ряда весьма важных биологических процессов. Основываясь на учении И. П. Павлова о химическом анализаторе, больным необходимо давать такие средства, которые в соединении с алкоголем вызывали бы сенсibilизацию организма даже к малым дозам спиртных напитков.

Многие авторы дали описание картины сенсibilизации к алкоголю после приема алкоголя с цианамидом. Некоторые рабочие на производстве, где изготавливается цианамид, прекращали употреблять алкоголь вследствие резко повышенной чувствительности к нему.

Аналогичные случаи описаны после приема алкоголя с грибами *Corpinus armentarius*. Весьма обнадеживающие результаты дали также эксперименты, проведенные в биологиче-

¹ И. П. Павлов, Лекции о работе больших полушарий головного мозга, 1937, стр. 152.

ской лаборатории медицинского факультета в Копенгагене с диэтилтиурамидсульфидом $(C_2H_5)NC(S)SSC(S)N(C_2H_5OH)$. Если после приема 0,5—1,5 г тетраэтилтиурамдисульфида больной выпивал хотя бы небольшое количество алкоголя, он отмечал ощущение жара в лице с последующим покраснением кожи не только лица, но иногда и шеи, груди, рук и даже живота; затем расширялись сосуды склеры, появлялось сердцебиение, ощущение удушья. После приема больших доз алкоголя наблюдалась тошнота и рвота. Все эти симптомы сопровождались головной болью и другими тягостными ощущениями.

Тетраэтилтиурамдисульфид, или антабус, впервые был испытан Мартенсенем и Ларсенем в 1947—1948 гг. на 83 алкоголиках; лечение дало эффект в 74 случаях и лишь в 9 случаях результаты были отрицательные вследствие отказа больных от продолжения лечения.

Антабус под названием дисульфирама в настоящее время включен в Международную фармакопею. Он применяется уже 8 лет. В двух скандинавских журналах помещены работы, подводящие итоги его применения. Мартенсен и Ларсен отмечает, что в Дании у него не было ни одного смертного случая на 2000 леченных им больных и единственным, серьезным противопоказанием к применению этого препарата является, по его мнению, сердечная декомпенсация. Сейчас он рекомендует применять его в маленьких дозах и даже допускает дачу одной маленькой дозы в любой момент для вытрезвления и успокоения больных в стадии острого опьянения.

В Финляндии Лейнеберг применял его у 533 больных; успешный результат был получен у 191 больного, т. е. в 36% случаев. Автор считает, что результаты были бы лучше в условиях госпитализации, но 90% его больных лечились амбулаторно.

Оба вышеупомянутых автора возражают против предъявления всем больным стандартного требования полной абстиненции. Они допускают возможность постепенного улучшения, несмотря на рецидивы.

Из Швеции сообщают о правах, которыми там пользуются советы трезвости. Они имеют право требовать, с одной стороны, взятие алкоголика под стражу, а с другой — помещения его в один из специальных государственных пансионатов, где он может подвергнуться лечению дисульфирамом параллельно с общим терапевтическим и психотерапевтическим воздействием.

В США Гофф и Маккион применяли дисульфирам 530 алкоголикам, прошедшим в 1953 г. через университетскую клинику в штате Виргиния, и получили успешный результат в 78% случаев против 47,8% случаев в группе больных (232 человека), леченных обычными способами. В обеих группах лучшие результаты были достигнуты при лечении мужчин.

Несколько работ посвящено сравнению результатов лечения дисульфирамом и апоморфином. Два швейцарских врача сообщают о результатах лечения апоморфином 500 больных, остававшихся под их наблюдением в течение продолжительного времени (от 17 месяцев до 5 лет). Они утверждают, что в 31% случаев успех был полный, в 15% было достигнуто социальное излечение, у 40% наблюдались рецидивы—у большинства в течение первых 6 месяцев; о 14% они не могли получить сведений. По мнению авторов, апоморфин обладает свойством восстанавливать гуморальное равновесие и снимать чувство тоски, а следовательно, он обладает и биологическим действием, а в сочетании с дисульфирамом в значительном проценте случаев содействует социальному возрождению больного. Английские авторы рекомендуют применять дисульфирам слабавольным молодым пьяницам, а апоморфин—хроническим алкоголикам. Почти все авторы сходятся в том, что в руках опытного врача дисульфирам является ценным методом терапии, предпочтительно в комбинации с психотерапией и другими методами лечения. Итак, приблизительно в течение 8 лет в психиатрической практике как в СССР, так и за рубежом применяют лечение хронического алкоголизма антабусом. За это время антабусом лечились десятки тысяч больных хроническим алкоголизмом, опубликовано очень много работ, посвященных антабусотерапии, и накопился достаточный опыт, позволяющий нам дать надлежащую оценку этому способу лечения.

Алкоголь-антабусная реакция, которая наблюдается у больных, проходящих курс лечения антабусом, после приема ими алкоголя, вызывается в основном резким увеличением ацетальдегида в крови. Процесс окисления алкоголя в организме человека изучен еще недостаточно. Антабус нарушает нормальный ход окисления алкоголя, задерживая его в фазе ацетальдегида в организме человека; в частности, при этом задерживается окисление в печени после того как ацетальдегид образовался в результате нормального окисления алкоголя. Можно считать установленным, что антабус влияет на энзимное окисление алкоголя, задерживая его в фазе ацетальдегида.

Окисление ацетальдегида происходит в печени. Экспериментальными исследованиями доказано, что у кроликов, перфузированная печень которых была предварительно обработана антабусом, количество ацетальдегида в крови увеличивалось в 30 раз по сравнению с нормой (Киельгард, 1949). Антабус влияет на разложение ацетальдегида только после того как он образовался в результате окисления алкоголя.

Судьба антабуса в организме еще недостаточно изучена. Антабус всасывается главным образом в желудочно-кишечном тракте и лишь частично, около $\frac{1}{3}$ препарата, выделяется с испражнениями. Выделение его из организма происходит

очень медленно; доза антабуса в 1 г достаточна для того, чтобы выявить алкоголь-антабусную реакцию в случае приема большим количеством алкоголя даже через 5 дней после приема антабуса.

Где откладывается антабус в организме после его всасывания, пока неизвестно. Этот препарат обладает кумулятивным действием вследствие замедленного выделения из организма. В результате кумулятивного действия антабуса может вызывать токсикозы различной выраженности — от легких до тяжелых, причем иногда эти токсикозы проявляются в виде делириозного состояния.

Свойства антабуса сенсibilизировать организм человека к алкоголю, а также задерживать окисление алкоголя в организме человека на фазе ацетальдегида, вызывающего весьма тягостную отрицательную реакцию, послужили основанием использовать его в качестве лечебного средства при хроническом алкоголизме. Интенсивность алкоголь-антабусной реакции, наблюдаемой у больных после приема алкоголя, зависит от количества принимаемого антабуса, количества даваемого больному алкоголя, а также от индивидуальной реакции. В свое время, наряду с легкими токсическими реакциями, наступающими после приема алкоголя, мы описывали весьма тяжелые реакции, которые сопровождались падением кровяного давления и другими расстройствами у больных с поздними последствиями травматического поражения головного мозга.

Указанные тяжелые алкоголь-антабусные реакции зависели от двух причин, которые не учитывались нами на первых этапах этой работы: 1) при испытании реакции на алкоголь у больных, принимавших антабус, мы давали сравнительно большие дозы (100—200 мл) 40° алкоголя; 2) не имея достаточного опыта, ошибочно допускали применение антабусной терапии у алкоголиков, имевших в анамнезе травму головного мозга, страдавших сосудистыми заболеваниями и др.

Христенсен (Christiansen), указывая на работы Нильсена, рассматривавшего ацетальдегид как сильное симпатомиметическое средство, поставил опыты на трех группах собак, которым он вводил параллельно ацетальдегид и такое заведомо симпатомиметическое средство, как эпинефрин, и изучал действие антабуса на кровяное давление и дыхание. Опыты показали, что ацетальдегид является, во-первых, таким же симпатомиметическим средством, как эпинефрин, но оказывает свое действие в гораздо меньших дозах, и, во-вторых, что действие антабуса на ацетальдегид и эпинефрин выражается в удлинении фазы расширения сосудов с резким падением кровяного давления (что соответствует в известной мере клиническим симптомам, наблюдаемым у человека после введения антабуса и алкоголя). По мнению автора, действие антабуса заключается в изменении реакции специфических симпатомиметических рецепторных клеток организма на симпатомиметические

свойства ацетальдегида и эпинефрина. Таким образом, существовавшее ранее мнение о полной безвредности антабуса для организма человека не подтвердилось.

Токсическое действие антабуса может проявиться даже без применения алкоголя, ибо данный препарат содержит две тиокарбаминовые группы, которые входят в состав относительно токсичных дериватов тиомочевины. В печени кроликов, которым давали в больших дозах антабус, находили дегенеративные изменения. У части больных хроническим алкоголизмом, принимавших антабус, отмечали следующие побочные явления (повидимому, в значительной мере зависящие от кумулятивного действия препарата): значительную утомляемость, головные боли, сонливость, а в редких случаях расстройство сна, резкое повышение, а иногда и понижение аппетита, плохой вкус во рту, своеобразный запах выдыхаемого больным воздуха, сердцебиение, боли в области сердца, сыпь, повышение или понижение потенции. Отдельные больные обладают весьма повышенной чувствительностью к антабусу; этим лицам приходится прерывать лечение.

Существовавшее убеждение в полной безвредности антабуса, а также в том, что этот препарат является радикальным, специфическим средством против хронического алкоголизма, привело к чрезвычайно широкому применению его без учета противопоказаний. За рубежом за весьма короткий срок (1949—1955) насчитывалось уже свыше нескольких десятков тысяч больных хроническим алкоголизмом, лечившихся антабусом. Широкое применение антабуса в зарубежных странах не только в стационарных условиях, но главным образом в амбулаторной практике, на дому, без надлежащего врачебного контроля, а нередко по личной инициативе больных или их родственников приводило к ряду тяжелых осложнений.

Описаны случаи судорожных припадков, инсультов и даже летальных исходов, возникавших в результате неправильного применения этого препарата. Зольмс в своей работе приводит 10 таких случаев. Так, им был прослежен случай, когда 50-летний алкоголик, страдавший гипертонической болезнью, циррозом печени, алкогольным полиневритом, перенесший несколько лет назад пределириозное состояние и операцию по поводу рака гортани, принимал в течение недели по 1 г антабуса в день. На 9-й день после выпитого вина наступил коллапс, а через 5 часов смерть. Якобсон и Мартенсен и Ларсен (1949) описали 60-летнего больного хроническим алкоголизмом, принимавшего антабус в период очередного запоя и погибшего во время комы. Шиллер и Зольмс наблюдали 57-летнего алкоголика, страдавшего гипертонической болезнью и артериосклерозом мозга. Принимая антабус амбулаторно, он одновременно злоупотреблял алкоголем. Последнее обусловило смерть от кровоизлияния в мозг. Глуд (Дания, 1949) опи-

сал 2 больных диабетом, принимавших антабус и погибших от диабетической комы. Фуртандо (Португалия, 1950) описал 49-летнего больного хроническим алкоголизмом, у которого был констатирован амнестический синдром, дизартрия, сильное увеличение печени. Незадолго до начала лечения больной перенес белую горячку. Антабус принимал по 0,5—0,75 г в день. Первый пробный прием алкоголя дал слабую реакцию, однако после второго приема больной погиб от коллапса. Джонс (из Канады) наблюдал 29-летнего больного, страдавшего тяжелым неврозом, умеренной гипертонией и хроническим алкоголизмом, принявшего 5,5 г антабуса в течение 4 дней и умершего после первого пробного приема вина; в Дании были зарегистрированы 2 случая смерти больных хроническим алкоголизмом, погибших от коллапса. Эти лица в течение 3 и 6 месяцев принимали регулярно антабус; Зольмс также наблюдал одного хронического алкоголика 42 лет, который принял в течение 4 дней 6,5 г антабуса, а на 5-й день выпил 200 мл красного вина. Реакция была средней силы, но через 23 часа после нее неожиданно развился коллапс и наступила смерть. Можно думать, что в последних трех случаях имело место токсическое поражение дыхательного центра или миокарда.

Считая антабусную терапию хронического алкоголизма способом, не совсем безопасным для здоровья больных, о чем красноречиво говорят приведенные выше факты токсического действия препарата, мы соблюдаем осторожность при его применении.

Антабус следует применять лишь в некоторых случаях, например, когда другие активные методы уже исчерпаны, и только под строгим врачебным наблюдением преимущественно в стационарных условиях и, разумеется, при отсутствии медицинских противопоказаний.

Противопоказанием для лечения антабусом мы считаем наличие следующих заболеваний: злокачественные опухоли, тяжелое заболевание миокарда, кардиосклероз, коронарная недостаточность и прочие болезни сосудов, гипертоническая болезнь, заболевание печени, почек, кровеносных органов, желез внутренней секреции (базедова болезнь, диабет, эндокринопатия и пр.), бронхиальная астма, туберкулез, выраженная эмфизема легких, язвенная болезнь, травматические повреждения головного мозга, органическое заболевание центральной нервной системы, эпилепсия, тяжелые неврозы, а также возраст старше 50 лет и беременность (опасность отравления плода) ¹.

¹ Заболевания миокарда, эмфизема легких, гипертоническая болезнь, артериосклероз, алкогольный гепатит, травматическая энцефалопатия являются относительным противопоказанием.

Методы лечения антабусом нами коренным образом изменены. Мы воздерживаемся от применения больших доз антабуса и назначаем перерывы в его приемах; при алкогольных пробах мы даем только очень маленькие дозы алкоголя. Лечение проводим под строгим врачебным контролем.

В целях профилактики осложнений, прежде чем назначить лечение антабусом, мы делаем тщательный отбор больных и назначаем их на рентгенологическое исследование органов грудной клетки, электрокардиографию, исследование глазного дна и т. д.

Испытание реакции у больных на алкоголь (после нескольких дней приема антабуса) мы проводим под строгим врачебным контролем и преимущественно в стационарных условиях. Дозы 40° алкоголя при этом не превышают 30—50 г.

Перед началом лечения необходимо установить, нет ли у больного идиосинкразии к антабусу, для чего мы даем ему вначале 0,5 г препарата и через 3—4 часа предлагаем принять 30—50 г 40° алкоголя, а затем, в зависимости от тяжести наступающей реакции, то увеличиваем, то уменьшаем первоначальную дозу препарата. Ни в коем случае нельзя допускать передозировки препарата. Следует прекратить лечение антабусом у тех больных, которые очень плохо переносят его, отмечают загрудинные боли, боли в области сердца, сонливость, сильную утомляемость и пр.

При отсутствии медицинских противопоказаний антабус назначают больным по 0,5 г 2 раза в день в течение 3 дней; на 4-й день через 2 часа после приема антабуса больному дают 30—50 г 40° водки. Если алкоголь-антабусная реакция отсутствует или слабо выражена, больному добавляют еще 15—30 г водки. В последующие дни количество принимаемого антабуса снижают и дают по 0,25 г или 0,15 г в течение 2 месяцев; при этом один раз вместо антабуса назначают индифферентные вещества, которые по механизму условной связи вызывают реакцию на алкоголь, аналогичную антабусу. Антабус больным дают по вышеуказанной схеме с последующей пробой на алкоголь с таким расчетом, чтобы было проведено от 3 до 15 проб, в зависимости от их выраженности, для выработки отрицательной реакции на алкоголь и сенсibilизации к нему. Обычно через 7—10 минут после принятия алкоголя возникает гиперемия лица, шеи, верхней части груди, которая постепенно усиливается. Особенно характерна резкая гиперемия конъюнктивы и склер глаз, что ведет к нерезко выраженному экзофтальму.

Лечение осложнений, которые могут возникнуть, после приема алкоголя (коллапс, резкое угнетение деятельности органов дыхания и кровообращения и пр.), сводится к ингаляции чистого кислорода, подкожному введению коразола, камфоры, кофеина, внутривенному вливанию глюкозы с аскор-

биновой кислотой, подкожному введению физиологического раствора; при угрозе паралича дыхания применяют искусственное дыхание, лобелин, цититон, ингаляцию смеси 95 частей кислорода с 5 частями углекислоты. При сильных болях в сердце, обусловленных спазмом коронарных сосудов, назначают валидол, капли Зеленина, нитроглицерин.

За рубежом, чтобы устранить токсическую реакцию, внутривенно вводят небольшие дозы хлористого железа или комбинацию его с аскорбиновой кислотой.

Уровень ацетальдегида при этом не понижается. Вводимые препараты оказывают противодействие антабусу в его отрицательном влиянии на кровяное давление и т. д.: легко входя в соединение с солями тяжелых металлов, антабус образует с ними нерастворимые соединения. В результате этого токсическая реакция ослабляется, но задерживающее влияние антабуса на окисление ацетальдегида остается в силе.

В целях профилактики рецидивов алкоголизма выработанную при помощи антабуса отрицательную реакцию на алкоголь следует подкреплять, назначая больным 0,05 г антабуса один раз в день еще в течение 1—3 месяцев с одно-двухдневным перерывом в неделю.

Следует отметить, что в тех случаях, когда лечение антабусом сочетается с психотерапией или с пролонгированным гипнотическим сном, физиотерапией и пр., результаты лечения хронического алкоголизма получаются лучше, чем при лечении только одним антабусом.

У лиц, принимавших антабус во время алкоголь-антабусной реакции, почти всегда можно отметить довольно яркое проявление защитных реакций организма. Эти реакции обнаруживаются в виде учащенного дыхания (а следовательно, и усиленного выведения с выдыхаемым воздухом ацетальдегида), потливости, полиурии, тошноты и рвоты, что в свою очередь также способствует большему выделению образовавшегося в организме ацетальдегида. Наступающую сонливость, а также глубокий сон в течение нескольких часов после этой реакции следует рассматривать как охранительное торможение, ограждающее клетки мозговой коры от токсического воздействия ацетальдегида.

Ценность принципа, положенного в основу лечения антабусом хронических алкоголиков, заключается в выработке тягостной отрицательной реакции при приеме даже небольших доз любого алкогольного напитка, так как у лиц, принимавших антабус, происходит перестройка внутренней среды организма и в корне изменяется реакция на алкоголь, происходит переделка динамического стереотипа, переделка положительных реакций (на алкоголь) на отрицательные.

Антабус видоизменяет вкусовые свойства алкоголя, качество опьянения. Алкоголь больше не вызывает удовольствия,

веселья, а, наоборот, способствует образованию тягостных, отрицательных реакций. Таким образом, у больных, лечащихся антабусом, после нескольких алкогольных проб образуется выраженный отрицательный условный рефлекс на алкоголь. Мы наблюдали случаи, когда больные не принимали антабуса около года и, несмотря на это, прием любого алкогольного напитка вызывал у них характерную реакцию. Это заставляло их в дальнейшем воздерживаться от употребления спиртных напитков.

В отдельных случаях в начале лечения появляется алкогольная эйфория, причем 15—30 г 40° алкоголя вызывают такое опьянение, какое больной обычно испытывал при приеме 100—200 г водки. У большинства больных при первой же алкогольной пробе, а у других лишь впоследствии наблюдается изменение реакции на алкоголь. Алкогольные напитки становятся неприятными на вкус, в картине опьянения уже отсутствует характерная алкогольная эйфория. Чувство опьянения неприятно больному, оно сопровождается тягостными субъективными ощущениями, головной болью, одышкой, болезненными ощущениями в области сердца, затруднением дыхания. Больные как бы испытывают недостаток кислорода во вдыхаемом ими воздухе и чувствуют себя так, как будто на них надет противогаз или же они находятся на большой высоте и дышат разреженным воздухом. Они ощущают шум в голове, пульсацию сосудов. Чувство тошноты нередко продолжительное и заканчивается рвотой с последующим сном в течение 1—2 часов, после которого наступает улучшение, и неприятные явления исчезают бесследно.

Кровяное давление у большинства наблюдаемых больных понижалось, особенно резко падало диастолическое давление — до 40—20 мм ртутного столба, в то время как систолическое кровяное давление понижалось не так значительно, а в некоторых случаях даже повышалось или оставалось без особых изменений. Диастолическое кровяное давление начинало падать через 10—20 минут, достигая минимума через 1 час после приема алкоголя, а затем обычно возвращалось через 1—1½ часа к исходной величине (рис. 12, 13). Падение кровяного давления является одним из наиболее опасных проявлений, наблюдаемых у больных после приема алкоголя, так как оно может привести к коллапсу, если им не управлять и не принимать надлежащих мер к его регуляции. Поэтому после введения больным алкоголя мы измеряем у них кровяное давление каждые 10—20 минут и при выраженной тенденции к значительному падению его принимаем срочные меры.

У некоторых больных кровяное давление после приема алкоголя не изменялось.

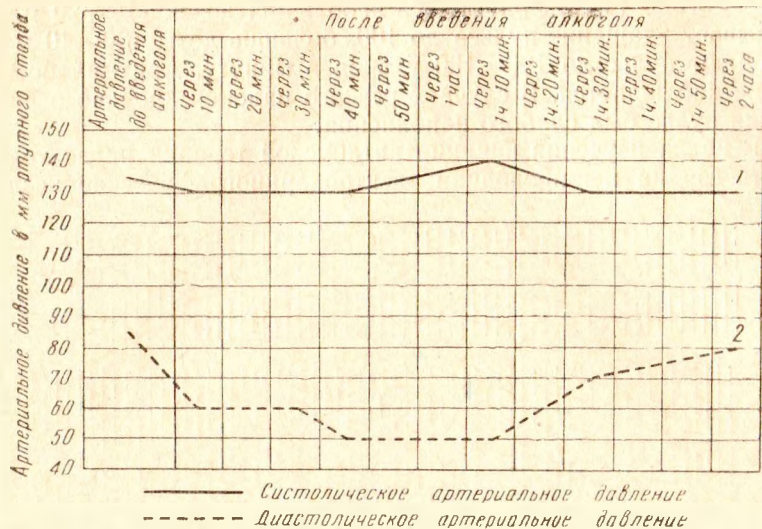


Рис. 12. Изменение артериального давления во время антабус-алкогольной реакции.

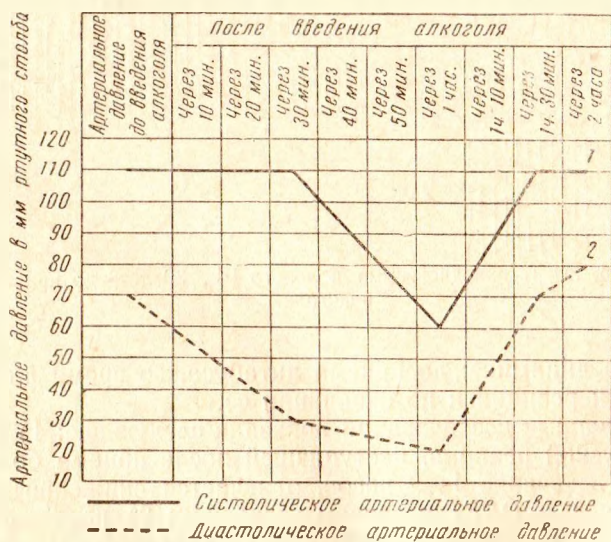


Рис. 13. Изменение артериального давления во время алкоголь-антабусной реакции.

Алкоголь (40°), принятый в небольших дозах (15—20 мл), вызывает учащение пульса до 100, большие дозы (30—40 мл) учащают пульс до 120—130 ударов в минуту. Аритмий обычно не наблюдается. В случаях резкого падения кровяного давления пульс был слабого наполнения.

В целях изучения влияния антабусной терапии на деятельность сердца мы проводили электрокардиографические исследова-

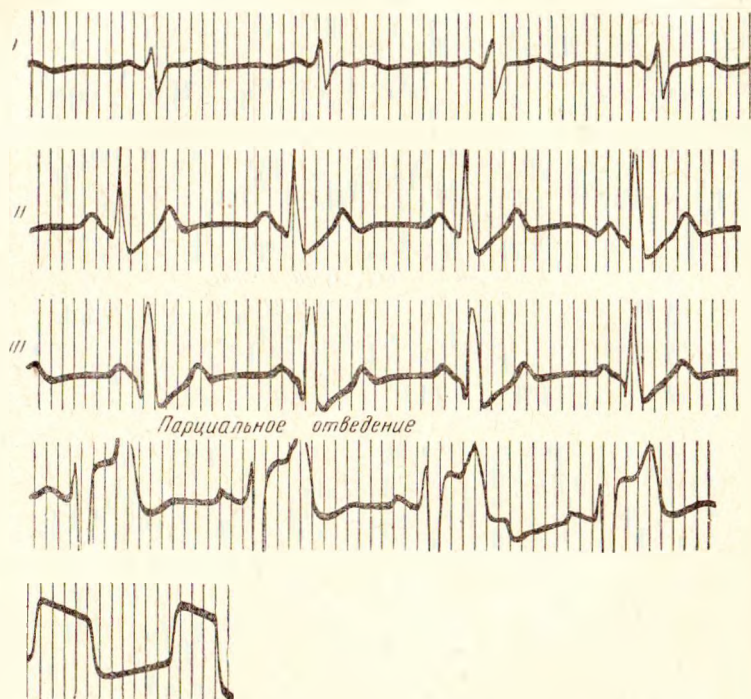


Рис. 14. Электрокардиограмма больного Ш., 30 лет, до принятия алкоголя.

дования в динамике: до приема антабуса, во время алкоголь-антабусной реакции и по окончании ее.

Проведенные исследования показали следующее: 1) во время антабусной реакции, наступившей после приема больными алкоголя в течение 1—2 часов, отмечается снижение вольтажа зубцов *T* и *QRST* в первом отведении; 2) после антабусной реакции снижение вольтажа иногда распространяется на грудные отделы *CF₂* и *CF₄* (рис. 14, 15 и 16).

Эти данные свидетельствуют о появлении ангиоспастических явлений в коронарной системе во время алкоголь-антабусной реакции, а также после нее. Отмеченные нами изменения были кратковременны (от получаса до 3 часов).

В качестве примера вышеизложенного приведем электрокардиограммы больного Ш., 30 лет, принимавшего антабус по нашей схеме: первая электрокардиограмма снята до приема больным алкоголя, вторая — через 30 минут после приема 30 г 40° алкоголя и третья — через 2 часа после приема 30 г 40° алкоголя.

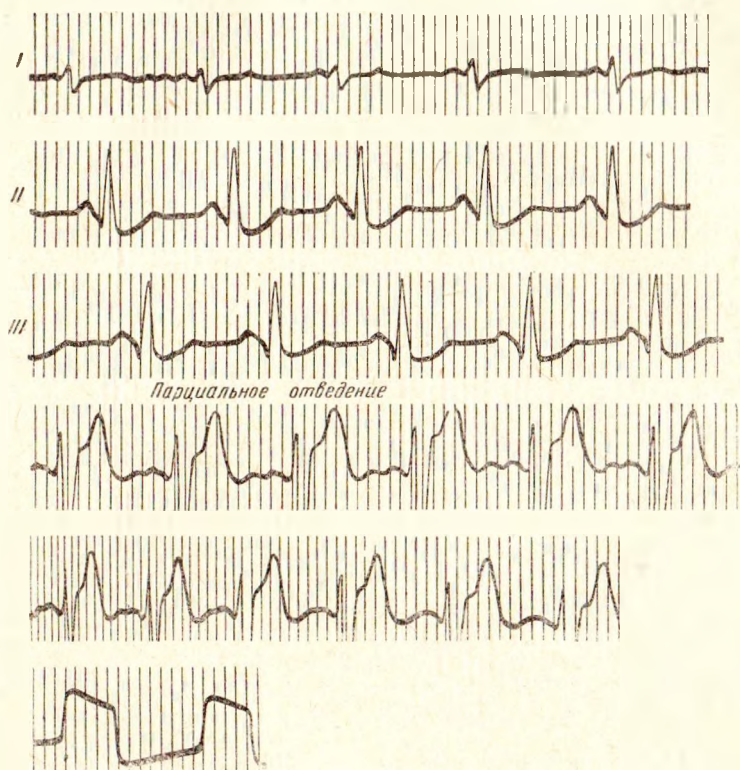


Рис. 15. Электрокардиограмма больного Ш. через 30 минут после приема 30 мл 40° алкоголя.

Прием антабуса в указанных дозах даже в течение длительного времени на электрокардиограмме не отражается (если в организм не поступает алкоголя).

Видимо, ацетальдегид, образовавшийся во время реакции, расширяет сосуды кожных покровов, на коронарные же сосуды действует в противоположном направлении, приводя к появлению в них некоторых скоро проходящих спастических явлений. В этом аспекте понятны боли в области сердца, на которые жалуются некоторые больные.

Дыхание во время токсической реакции учащенное, прерывистое.

Дальнейшее изучение нервных механизмов терапевтического воздействия антабуса позволит уточнить показания и противопоказания и усовершенствовать методику лечения этим препаратом.

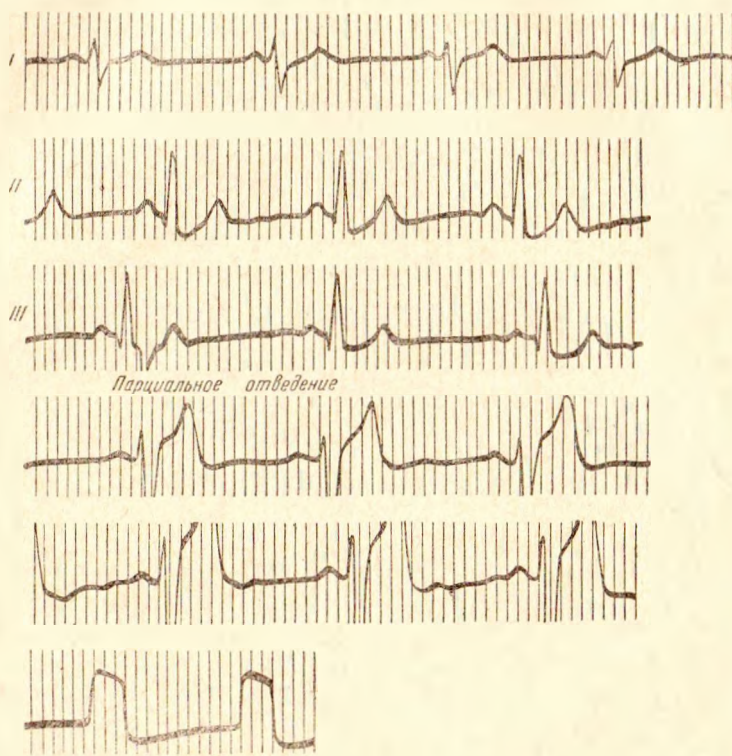


Рис. 16. Электрокардиограмма больного Ш. через 2 часа после приема 30 мл 40° алкоголя.

Весьма необходимо, чтобы наша фармацевтическая промышленность выработала препарат, сходный в принципе по своему действию с антабусом, но свободный от его токсических побочных отрицательных свойств, иногда являющихся причиной грозных осложнений, что дало бы возможность ввести этот препарат в широкую практику и успешно лечить им алкоголиков даже амбулаторно. Соответствующая работа в этом направлении ведется.

Изыскание безвредных средств, сенсibiliзирующих организм к алкоголю, в настоящее время является одной из актуальных задач медицины.

Кислородная терапия впервые стала применяться при асфиксии, отравлении, поражении отравляющими веществами. Лечение алкоголиков кислородом в Советском Союзе применялось Л. М. Розенштейном, Т. М. Богомоловой и Рязановой в клинике проф. В. А. Гиляровского в 1923 г. Впоследствии метод лечения кислородом нашел широкое распространение в московских наркодиспансерах и в других невро-психиатрических учреждениях нашей страны. Кислород применяют при лечении алкоголиков, исходя из его свойств вызывать эйфорию и улучшать обмен веществ, благодаря чему больные легче переносят лишение их алкоголя, что особенно важно при амбулаторном лечении.

По нашим данным, кислород, введенный алкоголиками под кожу, повышает процент гемоглобина, увеличивает количество эритроцитов, каталазы, вызывает некоторую эйфорию, улучшает сон и способствует дезинтоксикации организма. Смородинцева и Лифшиц при подкожном введении кислорода алкоголикам установили повышение сухого остатка и резервной щелочности крови.

Г. А. Курашкевич и П. Г. Смирнов на основе своих наблюдений считают, что кислород, введенный подкожно, вызывает изменения вегетативных рефлексов. Эти изменения сводятся в основном к возбуждению вегетативных рефлексов ваготонического характера: клиностатического, глазо-сердечного, и приводят к торможению вегетативных симпатикотонических рефлексов.

Кровяное давление снижается. По наблюдениям Г. А. Курашкевича и П. Г. Смирнова, вегетативные рефлексы как ваготонические, так и симпатикотонические, находившиеся в состоянии возбудимости при первых вдуваниях, возбуждаются еще больше. Но это явление длится недолго. В конце лечения рефлексы нормализуются.

Противопоказаниями к вдуванию кислорода служат: status thymico-lymphaticus, гипертония, тяжелые поражения сердечной мышцы и сосудов, активный туберкулез, частые припадки эпилепсии.

Осложнения при вдувании кислорода наблюдаются крайне редко. В лечебнице для острого алкоголизма за десятилетие среди 15 000 больных, которым применялось многократное вдувание кислорода, нам пришлось наблюдать летальный исход лишь у двух, причем один из этих больных в течение 2 недель перед смертью успешно переносил вдувание. Секция обнаружила у одного больного status thymico-lymphaticus, а у другого — резкую дегенерацию сердечной мышцы и общий выраженный склероз сосудов. В одном случае после вдувания кислорода наблюдался коллапс с кратковременной потерей

зрения (у больного, которому кислород вводился под кожу многократно), которое через час восстановилось.

Глинчиков описал нагноение после вдувания кислорода. Мы таких осложнений не встречали.

При оксигенотерапии необходимо соблюдать известные предосторожности: вводить иглу без присоединения аппарата, начинать вдвухание при условии, если в игле нет крови. Кислород следует вдвухать медленно, из специально сконструированного аппарата, назначая вначале небольшие дозы (30—50 см³) и повышая их постепенно. Это позволит избежать осложнений.

ПСИХОТЕРАПИЯ

Психотерапия с давних пор является наиболее распространенным методом лечения алкоголиков.

Наиболее благоприятные результаты дает гипнотерапия, при помощи которой даже в амбулаторных условиях можно достигнуть исключительного успеха. Большинство авторов (В. М. Бехтерев, Ф. Е. Рыбаков, Синапи, Успенский, И. Н. Введенский, К. И. Платонов, А. М. Рапопорт, А. Форель и др.) добивалось успешного лечения алкоголиков (от 40 до 90%) путем гипнотерапии.

Согласно советскому законодательству, проводить гипнотерапию разрешается лишь в лечебных учреждениях. Если гипнотерапии подвергается женщина, желательно присутствие третьего лица, чтобы гарантировать врача от возможных ложных обвинений.

Наряду с гипнотерапией, весьма благоприятные результаты дают различные виды речевой терапии.

Современные взгляды на гипноз базируются на учении И. П. Павлова, который внес ясность в сущность гипноза и дал ему правильное физиологическое объяснение.

Ценные исследования в деле изучения гипноза провели В. М. Бехтерев, Токарский, А. А. Певницкий, В. Я. Данилевский, К. И. Платонов, В. В. Срезневский, Ю. В. Каннабих, Е. К. Краснушкин, Мясищев, Ю. А. Поворинский, В. Е. Рожнов и др.

До И. П. Павлова существовало много теорий гипноза, в основном базировавшихся на идеалистических и метафизических концепциях. Заслуга подлинного научного физиологического понимания гипнотических явлений принадлежит И. П. Павлову, вскрывшему нервные механизмы гипноза и давшему ему подлинное материалистическое обоснование. Большой вклад в дело развития идей И. П. Павлова в данном направлении внесли его ученики: А. Г. Иванов-Смоленский, Б. Н. Бирман, а также Ю. А. Поворинский и др.

«Иррадиация тормозного процесса при слабом его напряжении, — пишет И. П. Павлов, — есть то, что называется гип-

нозом, и при пищевых условных рефлексах характерно обнаруживается в обоих компонентах — секреторном и двигательном»¹.

Известно, что И. П. Павлов рассматривал гипноз как частичный сон. «Частичный сон есть, очевидно, то, что называется гипнозом. На собаках можно было изучить различные степени как экстенсивности, так и интенсивности гипноза, в конце концов переходящего в полный сон, если не было достаточных возбуждающих влияний»².

Торможение при гипнозе охватывает не полностью всю мозговую кору, как это наблюдается в глубоком естественном физиологическом сне, а лишь часть ее, причем в ней остаются в то же время в бодрственном состоянии «сторожевые пункты», по И. П. Павлову обуславливающие рапорт между гипнотизером и гипнотизируемым главным образом через вторую сигнальную систему. Однако в некоторых случаях подобного рода «сторожевые пункты» могут иметь место и при естественном сне.

Развивая свою концепцию о гипнозе, И. П. Павлов говорит, что «...гипноз — это есть, конечно, тот же сон. По сущности своей он от сна не отличается, а отличается только по частным особенностям, тем, например, что это есть очень медленно наступающий сон, т. е. сон, который ограничивается сперва очень маленьким, узким районом, а потом, все расширяясь и расширяясь, доходит до того, наконец, что с больших полушарий доходит до подкорки, оставляя нетронутыми лишь центры дыхания, сердцебиения и т. д., хотя и их в известной мере ослабляет»³.

И. П. Павлов указывал на известные отличия между гипнотическим состоянием у человека и животных, обуславливаемые наличием у человека второй сигнальной системы. Таким образом, разрешив экспериментальным путем ряд вопросов, касающихся нервных механизмов гипноза, И. П. Павлов поставил ряд новых вопросов, требующих дальнейшего изучения и разработки. К таким еще недостаточно изученным вопросам относится также и вопрос о наиболее эффективных приемах гипнотизации в свете учения о первой и второй сигнальных системах.

До И. П. Павлова различные проявления гипноза обычно сводили к трем степеням: а) состояние сонливости (сомноленция) с затруднением открывания глаз, но в то же время пациент в этой степени гипноза еще может оказывать сопротивление словесному внушению и сохраняет так называемые про-

¹ И. П. Павлов, Полное собрание сочинений, т. 3, кн. 2, 1951, стр. 330.

² И. П. Павлов, Полное собрание трудов, том III, 1949, стр. 398.

³ И. П. Павлов, Полное собрание сочинений, т. 3, кн. 2, 1951, стр. 413.

извольные движения; б) легкий сон, гипотаксия, при котором приводятся в исполнение внушения и наступает катаlepsия, автоматизм, часто аналгезия, а также утрата произвольных движений, однако при всех этих явлениях не наступает амнезии; в) сомнамбулизм — наиболее глубокая степень гипноза, при которой наблюдаются явления, аналогичные таковым при гипотаксии, но, наряду с этим, данная степень гипноза характеризуется амнезией по пробуждении и послегипнотическими явлениями. В. М. Бехтерев соответственно различал малый, средний и глубокий гипноз.

Восприимчивость к гипнозу даже у здоровых лиц неодинакова, а у больных различными невро-психическими заболеваниями она колеблется в широких пределах.

Больных, страдающих выраженными психозами, многих больных неврозами считали совершенно не поддающимися гипнотическому воздействию. По этому поводу известный советский психотерапевт Ю. В. Каннабих писал: «...так называемые психоневротики, а среди них особенно истерики..., психопаты и другие „пограничники“, обнаруживают либо крайне повышенную степень внушаемости и податливости к гипнозу (однако в большинстве случаев внушаемости избирательной, т. е. ограничивающейся данным врачом), либо полную невосприимчивость». Особенно невосприимчивыми к гипнозу обычно считали больных психастенией и навязчивым неврозом.

Степень восприимчивости к гипнозу связывали с возрастом, полагая, что более молодые люди поддаются гипнотическому воздействию легче, чем люди зрелого и преклонного возраста (Ю. В. Каннабих, А. Форель и др.).

Большую роль в вызывании гипнотического состояния придавали авторитету (для пациента) гипнотизера, так как описывалось немало лиц, не поддававшихся гипнотическому воздействию у одних врачей и успешно гипнотизируемых другими врачами. Так, например, известный врач-гипнолог П. В. Каптерев придавал личности гипнотизера решающее значение, неправильно полагая, что развивающийся гипнотическое состояние есть своеобразное реагирование пациента на личность гипнотизера, на его индивидуальные особенности. Он фактически пытался возродить в замаскированном виде развенчанные и опровергнутые взгляды Месмера, подчеркивая, что в основе гипнотического влияния лежит физико-химическое действие, какая-то особая энергия, исходящая от гипнотизера, наивно аргументируя это тем, что каждый рисует, но не каждый художник, каждый говорит, но не каждый оратор, так и в отношении влияния на людей: «каждый влияет, но не каждый гипнотизер». Свое суждение по этому вопросу П. В. Каптерев подкреплял личными наблюдениями. Он утверждал, что если гипнотизера будет отделять от гипнотизируемого плотная портьера, то влияние его на большинство гипнотизируемых исчезнет. В этом

случае момент психопатологический остается, «исключается лишь физико-химическое влияние гипнотизера и в результате— у гипнотизируемого гипнотическое состояние не развивается».

Сторонники идеалистического учения Фрейда, в частности, Ференси и др., вместо научно обоснованного объяснения восприимчивости к гипнозу приходят к ложным фантастическим выводам, неправильно полагая, что в основе внушаемости лежит «инфантильно-сексуальная установка», которая будто бы была свойственна в отношении кого-либо из родителей и теперь повторяется в отношении гипнотизера, причем внушаемость и гипнотизация будто бы легко наступают лишь в тех случаях, когда гипнотизеру присущи какие-либо свойства и особенности, напоминающие «инфантильную ситуацию». Они ошибочно считали, что в этих случаях гипнотизер воспринимается то в роли строгого отца, слова которого всегда вызывали покорность, то в роли матери, достигавшей послушания ребенка иными, мягкими способами воздействия. Вместо того чтобы объяснить внушаемость и гипноз с научно обоснованных павловских позиций, идеалистическая психоаналитическая школа извращает основную сущность вопроса фантастическими лженаучными домыслами.

Существуют всевозможные способы гипнотизирования и некоторые из них применялись с древних времен. Еще в глубокой древности гипноз вызывали созерцанием блестящих кристаллов, сосудов. Люиз для гипнотизирования применял быстро вращающееся зеркало, Аубри — так называемую магнезиальную лампу, Гаффе — вибрирующую каску. Знаменитый врач Цельз указывал еще, что можно усыпить человека нежным поглаживанием кожи. Делались попытки вызывать гипнотическое состояние тепловыми раздражениями (И. А. Бергер). Шамборд и Лабордо вызывали гипноз легким почесыванием кожи в области шеи. Многие авторы, в частности, Мольте, указывали на появление чувства сонливости в тех случаях, когда руками дотрагивались до кожи лба пациента, поглаживая ее.

Многие вызывали гипнотическое состояние посредством так называемых магнетических, или месмерических, пассов, т. е. поглаживанием руками от головы до ног, а также путем легкого движения рук на некотором расстоянии от тела больного. Чигаев, Шарко и др. вызывали гипноз при помощи вибрационных процедур. У больных истерией гипнотическое состояние наступало при громких звуках тамтама, а также при внезапном освещении друммондовым светом (Шарко).

Гипноз вызывали также применением различных монотонных звуковых раздражений: некоторые дикие племена для этой цели пользовались звуками «волшебного барабана», монотонным ритмом песен и т. п. В настоящее время для этой цели используют звуки метронома, шум индукционного молотка, тиканье часов. Иногда для вызывания гипноза применяли комби-

нированный метод месмерических пассивов и поглаживания, фиксируя взгляд больного на каком-либо блестящем предмете. А. Р. Николаев рекомендует проводить гипнотизацию пассивами вдоль тела, но не руками, а синей электрической лампочкой. П. В. Каптерев, не понимая физиологической сущности гипноза, считал, что никаких особых приемов, которые вызывали бы гипнотическое состояние, не существует и что все имеющиеся приемы гипнотизации являются не чем иным, как буторией, и всю сущность гипнотизации сводил лишь к непосредственному влиянию одного человека (гипнотизера) на другого (пациента). Весьма распространенным методом гипнотизации является фиксационно-словесный метод, когда взгляд пациента фиксируют на каком-либо блестящем предмете или на своих глазах, одновременно проводя словесное внушение гипнотического сна (Берггейм, Левенфельд, Моль и др.). В. М. Бехтерев совместно с Михайловым и Гореловым в 1912—1913 гг. в Противоалкогольном институте, а затем А. Г. Иванов-Смоленский в 1918—1921 гг. в Патолого-рефлексологическом институте вызывали гипнотический сон посредством фиксации взгляда пациента на синей или зеленой электрической лампочке, которая горела на стене, при одновременном звучании метронома.

Большой теоретический и практический интерес представляют работы А. Г. Иванова-Смоленского, сделавшего важное наблюдение (1927—1928), касающееся методики вызывания условного гипнотического сна. Он помещал больного в полумрачную комнату и укладывал на кушетку; над серединой кушетки висела блоковая угольная электрическая лампа, снабженная сильным полусферическим рефлектором, в котором включался свет зеленой лампочки. Больной не мог видеть врача, который находился в соседней комнате и наблюдал за ним через небольшое отверстие, проделанное в стене.

Давая резкий электрический звонок в течение 30 секунд, лампу с рефлектором приводили в маятникообразное качание вдоль всего тела больного от головы к ногам и обратно. Качания производились почти беззвучно, медленно, в темпе около 20—30 качаний в минуту. Зеленая лампочка накалялась и рефлектор, нагреваясь, давал тепловую волну значительной силы. Звонок звучал еще 10—15 секунд, совпадая, таким образом, во времени со свето-тепловыми колебаниями. После 4—5 таких сеансов больной засыпал уже на 15—20-й секунде звучания звонка. Звонок, бывший вначале индифферентным раздражителем, после 4—5-кратного совпадения во времени с безусловным гипногенным раздражителем приобретал способность вызывать гипнотический сон. Таким образом, при помощи безусловных агентов сна (монотонные зрительные раздражения, ритмичнотепловой раздражитель) вырабатывался условный гипнотический сон.

Таким образом, существующие приемы гипнотизации, которые применялись чисто эмпирически, случайно, без должной дифференциации и в самом разнообразном сочетании, можно разделить на четыре группы.

К первой группе относятся приемы гипнотического воздействия, сводящиеся в основном к однообразным зрительным раздражителям в виде длительной фиксации взгляда на небольших блестящих предметах: врачебном молоточке, кристаллах, вращающихся зеркалах, специально сконструированных металлических или стеклянных шарах и т. п. Сюда же относится применение монотонных звуковых раздражителей (стук метронома, тиканье часов, шум текущей воды или индукционного молотка, однообразная мелодия и др.), воздействие посредством однообразно повторяющихся слабых раздражений кожи и в виде так называемых магнетических пассов, ведущих свое начало от Месмера и других сторонников «животного магнетизма», легкое поглаживание, производимое руками вдоль всего тела, путем легких прикосновений к нему или на некотором расстоянии от него, различные вибрационные процедуры, ритмические легкие почесывания кожи и т. п.

Как видно из сказанного выше, однообразные, длительное время ритмически повторяющиеся слуховые и кожные раздражения проводились без словесного воздействия, без словесного внушения и гипнотическое состояние вызывалось в основном путем воздействия зрительных, слуховых или кожных раздражений.

Ко второй группе относится словесное внушение гипнотического сна. Обычно в этих случаях больному многократно повторяют слова, относящиеся к физиологическим актам сонного состояния, т. е. достигают гипнотического сна путем словесного внушения.

Третий способ гипнотизации — это одновременное применение словесного воздействия в сочетании с фиксацией блестящих предметов или «пассов».

Наконец, четвертый способ гипнотизации, близко примыкающий к первому, это — способ вызывания гипнотического условного сна, разработанный А. Г. Ивановым-Смоленским. Этот способ убедительно опроверг реакционные взгляды психоаналитиков (Ференси и др.) и воззрения тех гипнологов, которые утверждали, что гипноз является результатом непосредственного влияния одного человека на другого и что различные способы гипнотизации являются лишь бутафорией (П. В. Каптерев). Кроме того, здесь четко и ясно показана возможность вызывания условного гипнотического сна при помощи такого условного раздражителя (резкого звонка), который по своему характеру не мог являться гипногенным фактором. Таким образом, А. Г. Иванов-Смоленский доказал, что «любой внешний агент путем сочетания во времени с безусловными стиму-

лами сна может быть сделан условным снотворным сигналом».

И. П. Павлов, касаясь способов гипнотизирования, писал: «Прежде всего идет вопрос об условиях, вызывающих гипнотические состояния. У животных, как мы это уже знаем, они наступают более или менее медленно при слабых и средних однообразно и продолжительно повторяющихся раздражениях (обыкновенный случай при наших опытах), быстро — при сильных раздражениях (случай давнего гипноза животных). При этом непосредственно действующие раздражители как слабые, так и сильные, могут быть сигнализируемы другими раздражениями, являющимися условными по отношению к первым... Процедура гипнотизирования людей вполне воспроизводит описанные условия у животных. Ранний классический способ гипнотизирования — это так называемые пассы, т. е. слабые, однообразно повторяющиеся раздражения кожи, как в наших опытах. Теперь постоянно применяющийся способ — повторяющиеся слова (к тому же произносимые в минорном однообразном тоне), описывающие физиологические акты сонного состояния. Эти слова суть, конечно, условные раздражители, у всех нас прочно связанные с сонным состоянием и потому его вызывающие. На этом основании может гипнотизировать и гипнотизирует все, что в прошлом совпадало несколько раз с сонным состоянием. Это все аналоги цепных отрицательных рефлексов (Ю. В. Фольборта), подобных цепным условным положительным рефлексам, т. е. рефлексам разных порядков, описанным в третьей лекции. Наконец, гипнотизирование истеричных, по Шарко, достигается сильными неожиданными раздражителями, как в старом способе гипнотизирования животных. Конечно, при этом могут действовать также и физически слабые раздражители, сигнализирующие сильные, т. е. сделавшиеся в силу совпадения во времени условными по отношению к сильным. Как у животных, так и у людей большинство гипнотизирующих приемов тем скорее и вернее приводит к цели, чем они чаще применяются»¹.

Мы изучали наиболее эффективные способы гипнотизации больных, а также особенности тех больных, которые трудно поддаются гипнотическому воздействию, стремясь установить причину их негипнабельности и пытаясь найти наиболее правильные пути для их успешной гипнотизации.

Как известно, имеется ряд больных с невро-психическими заболеваниями (особенно алкоголики), применение гипноза у которых может дать существенные терапевтические результаты. Между тем негипнабельность таких больных препятствует применению этого ценного метода лечения. Проводя соответствующие исследования, мы убедились в том, что больные,

¹ И. П. Павлов, Полное собрание трудов, т. 4, 1947, стр. 334, 335

которые считались не поддающимися гипнотическому воздействию, с успехом подвергались гипнотизации, если в отношении их применялся соответствующий адекватный прием гипнотизации с учетом характерных для данных больных соотношений между первой и второй сигнальными системами. Как показал опыт, гипнотическое состояние лучше всего вызывалось через ту сигнальную систему, которая у исследованных нами больных наиболее легко тормозилась.

Наши экспериментально-клинические исследования показали, что у хронических алкоголиков более тормозима вторая сигнальная система. Исходя из этого, мы проводили им гипнотизацию главным образом посредством словесного внушения, т. е. воздействия на вторую сигнальную систему. Приведу следующие примеры.

1. Больной Т., 52 лет, поступил в клинику на излечение с 11/III 1953 г. Злоупотребляет алкоголем с 34-летнего возраста. Со стороны внутренних органов отмечается расширение сердца влево. Кровяное давление 160/100 мм. Со стороны нервно-психической сферы отмечается тремор пальцев вытянутых рук. Настроение пониженное, астенизировано, вял, замкнут. Испытывает патологическое влечение к алкоголю. Критика к своему заболеванию сохранена.

Больному была начата гипнотерапия. Во время гипнотизации, проводившейся 23/III 1953 г. в течение 30 минут путем словесного внушения, т. е. воздействия на вторую сигнальную систему, больной быстро был погружен в гипнотическое состояние с явлениями каталепсии и аналгезии. Проводившиеся на второй день попытки подвергнуть его гипнотизации путем применения звуковых и световых раздражителей (звуки метронома, фиксация взгляда на горящей синей лампочке) не вызвали гипнотического сна. При речевом отчете больной подчеркивает, что звуки метронома раздражают его и противодействуют развитию гипнотического сна.

2. Больной К., 54 лет, поступил в клинику 12/III 1953 г. Самостоятельно работает с 12-летнего возраста. Имеет законченное высшее образование. Злоупотребляет алкоголем с 1948 г. Принимает алкогольные напитки периодами, с кратковременными светлыми промежутками. Со стороны внутренних органов отмечается увеличение и болезненность печени при ее пальпации, со стороны нервно-психической сферы — несколько вялая реакция зрачков на свет. Астенизирован. Настроение подавленное. Испытывает болезненное влечение к алкоголю. Отмечается быстрая утомляемость, снижение памяти, лабильность эмоциональной сферы. Галлюцинации и бредовые идеи отрицает.

28/III 1953 г. в 11 часов 30 минут утра больной был подвергнут гипнотизации посредством словесного воздействия; в 11 часов 45 минут уже находился в состоянии глубокого гипнотического сна. После лечебного словесного внушения, направленного на устранение имевшихся в картине заболевания патологических симптомов, в 12 часов 15 минут был выведен из гипнотического состояния.

3. Больной Х., 50 лет, поступил в клинику повторно 15/I 1953 г., где находился на излечении по 28/III 1953 г. Самостоятельно работает с 12-летнего возраста, вначале учеником-слесарем, а с 27-летнего возраста механиком. В 1934 г. упал с паровоза. В течение 1½ суток был без сознания. С 25-летнего возраста начал употреблять алкогольные напитки. С 1932 г. абстинентный синдром и амнезия периода опьянения. В 1951 г. первично стационарировался в нашу клинику, принял курс специального лечения (выработка отрицательной условной реакции на алкоголь в гипнотическом состоянии) и с тех пор алкогольных напитков не принимает. Поступил

повторно в клинику в связи с появившейся у него раздражительностью, головными болями и расстройством сна, а также для подкрепления ранее выработанной отрицательной реакции на алкоголь. Со стороны внутренних органов отмечаются глухие тоны сердца, равномерное расширение границ; печень увеличена, но безболезненна. Со стороны нервно-психической сферы грубых отклонений от нормы не отмечается.

С лечебной целью больному 19/I 1953 г. в 11 часов 30 минут дня была проведена гипнотизация посредством словесного воздействия. Через 12 минут после начала сеанса наступило глубокое гипнотическое состояние. После соответствующего лечебного словесного внушения в 12 часов 30 минут гипнотерапевтический сеанс был окончен.

В подавляющем числе случаев попытки подвергнуть больных хроническим алкоголизмом гипнотизации путем применения звуковых, зрительных и кожных раздражителей (звуки метронома, фиксация взгляда на горящей синей лампочке, пазлы и т. д.) были неудачны и лишь у некоторых больных вызвали незначительно выраженную сонливость. Все эти больные при речевом отчете подчеркивали, что звуки метронома, так же как и другие посторонние звуки, например, скрип дверей, только раздражали их и противодействовали развитию гипнотического сна. Некоторые больные, прислушиваясь к ритмичным звукам приглушенного метронома, испытывали настолько сильное раздражение и возбуждение, что им хотелось уйти из зала, где проводился гипнотический сеанс. Все они заявляли, что под влиянием словесного внушения они скорее впадают в гипнотический сон, особенно если врач произносит слова внушения тихим голосом.

Для иллюстрации приведу следующее наблюдение.

Больной Н., 43 лет, поступил в клинику 3/II 1953 г. по поводу хронического алкоголизма. Со стороны внутренних органов и нервно-психической сферы грубых отклонений от нормы не отмечается.

16/III 1953 г. с лечебной целью была проведена гипнотизация посредством воздействия на вторую сигнальную систему путем словесного внушения в течение 30 минут. К концу сеанса наблюдались явления гипнотического сна средней степени. На следующий день этому же больному была проведена гипнотизация в течение 30 минут посредством воздействия на первую сигнальную систему путем применения зрительного (фиксация взгляда на горящей синей лампочке) и слухового (ритмичные звуки приглушенного метронома) раздражителей. Этим путем гипнотического сна у данного больного вызвать не удалось. При речевом отчете больной подчеркивал, что звуки метронома мешали ему спать и крайне раздражали его. Он заявил, что на него действует «усыпляющим образом» только словесное внушение, проводимое тихим голосом.

Подобного рода явления мы наблюдали у большинства гипнотизируемых нами больных хроническим алкоголизмом.

Приведем нижеследующие факты, когда посредством воздействия на первую и вторую сигнальные системы в отдельности вызвать гипнотический сон не удавалось, в то время как при совместном воздействии на первую и вторую сигнальные системы быстро наступал гипнотический сон. В этих случаях заметного преобладания какой-либо из корковых сигнальных систем не отмечалось.

Больной А., 42 лет, поступил в клинику 6/III 1953 г. Злоупотребляет алкоголем с 1942 г. Абстинентный синдром с 1946 г. Амнезия периода опьянения с 1950 г. В 1952 г. отмечались гипнагогические галлюцинации. Заметных отклонений со стороны перво-психической сферы не отмечается.

28/III 1953 г. в 11 часов в течение 30 минут подвергался путем словесного воздействия гипнотизации, которая не увенчалась успехом. Больной менял позу, двигался, открывал глаза, вздыхал, морщил лоб. В тот же день в 12 часов был подвергнут повторному гипнотическому воздействию путем применения звукового приглушенного ритмичного раздражителя (метроном) в сочетании с фиксацией взгляда на светящейся синей лампочке (в течение 45 минут), и в этом случае положительного эффекта не получилось. На следующий день была сделана попытка вызвать гипнотическое состояние путем совместного применения словесного воздействия и ритмического звукового раздражителя, которая дала положительные результаты, — больной погрузился в гипнотический сон на 10-й минуте сеанса.

Исследование нейродинамики у данного больного по двигательной методике с речевым подкреплением (А. Г. Иванова-Смоленского) показало, что замыкательная функция у него была нарушена незначительно, условная двигательная реакция образовалась лишь на шестом сочетании. Активное торможение не нарушено (дифференцировочное торможение образовалось со второго сочетания и быстро упрочилось). Передача из первой сигнальной системы во вторую несколько затруднена. Исследование взаимодействия между первой и второй сигнальными системами проводилось по специально выработанной методике. В наших случаях было проведено лабораторное исследование взаимодействия сигнальных систем, построенное на основе выделения указанных выше видов условных связей по схеме А. Г. Иванова-Смоленского, где первой буквой каждой пары обозначалось воздействие раздражителя непосредственного или словесного, а второй буквой отмечалась форма ответа. Мы исследовали корковые маршруты: Н — Н (непосредственное воздействие и непосредственный ответ); Н — С (непосредственное воздействие и словесный ответ); С — Н (словесное воздействие и непосредственный ответ) и С — С (словесное воздействие и словесный ответ).

Если в первых трех парах корковых маршрутов отклонений от нормы не наблюдалось, то незначительные нарушения отмечались лишь в движении корковых процессов по маршруту С — С. Корковые связи между словом слышимым, видимым и произнесенным отличались неточностью (50% правильно воспроизведенных речевых реакций против 70—100% наблюдаемых у здоровых людей). Как видно, здесь не отмечалось заметного преобладания первой сигнальной системы над второй, исключая некоторые нарушения в наиболее молодом в эволюционном отношении корковом маршруте С — С.

Больной Г., 57 лет, поступил 20/III 1953 г. в клинику. Злоупотребляет алкоголем с 1953 г. С того же времени появился абстинентный синдром. Психических нарушений не было. В 1916 г. получил ранение в руку и голову, после чего в течение года у него отмечался тремор головы.

В 1944 г. перенес контузию головы с потерей сознания, длившейся в течение нескольких часов. После контузии наступил паралич левой руки и ноги. Лечился в госпитале. Со стороны нервно-психической сферы грубых отклонений от нормы не отмечается. Диагноз: остаточные явления травматической энцефалопатии, осложненной хроническим алкоголизмом.

Исследование корковой динамики до гипнотического сна показало, что замыкательная функция у этого больного не была нарушена, активное торможение было ослаблено (дифференцировка выработалась лишь после 10-го сочетания). Передача из первой сигнальной системы во вторую несколько затруднена. Движение корковых процессов по маршрутам Н—Н, Н—С, С—Н совершенно не уклонялось от нормы. Лишь по маршруту С—С корковые связи отличались некоторой хрупкостью, непрочностью. Данные исследования нейродинамики указывали на то, что заметных нарушений в движении корковых процессов у этого больного, за исключением нарушений в корковом маршруте С—С, не наблюдалось.

23/III 1953 г. в 11 часов с лечебной целью в течение 30 минут подвергался гипнотизации путем словесного воздействия, которая не увенчалась успехом. Больной часто менял позу, двигался, открывал глаза. В тот же день в 12 часов был подвергнут повторному гипнотическому воздействию путем применения приглушенного ритмичного звукового раздражителя (метроном) в сочетании с фиксацией взгляда на светящейся синей лампочке в течение 45 минут. Таким способом вызвать гипнотическое состояние также не удалось. На следующий день, 24/III 1953 г., в 11 часов утра была сделана попытка вызвать у больных гипнотическое состояние путем совместного применения словесного воздействия и ритмического звукового раздражителя, которая дала положительные результаты: больной через 8 минут после начала сеанса погрузился в гипнотический сон, при котором наблюдались явления катаlepsии, аналгезии и др.

Если раньше мы наблюдали от 20 до 30% больных, не поддававшихся гипнотическому воздействию, несмотря на многократно и длительное время проводившуюся им гипнотизацию, то в настоящее время, при дифференцированном гипнотерапевтическом воздействии, основанном на учении И. П. Павлова о двух сигнальных системах, нам приходится встречаться лишь с единичными случаями, когда все же не удается вызвать гипнотический сон. Эти единичные случаи мы продолжаем изучать.

Но и у таких больных все же удавалось вызвать гипнотический сон как бы на безусловном подкреплении. Для этой цели мы за час до гипнотического сеанса давали больному снотворную смесь, состоящую из 0,15 г нембутала, 0,3 г бромурала, 0,25 г медаминала, 0,25 г пирамидона и затем на фоне начинающегося сонного торможения, вызванного этими средствами, проводили гипнотизацию, при которой обычно с первого или второго раза удавалось добиваться легких степеней гипнотического сна. После 3—5 подобного рода сочетаний в дальнейшем удавалось вызвать гипнотический сон без применения снотворных средств, т. е. словесное внушение сна приобретало свойство энергичного снотворного условного раздражителя.

Наши экспериментально-клинические исследования, проведенные у больных неврозом навязчивых состояний, психастенией, алкогольной интоксикацией, истерией, показали, что среди

них почти нет таких лиц, которые не поддавались бы гипнотическому воздействию. Правильно физиологически обоснованная методика гипнотизации в свете учения о первой и второй сигнальных системах даст возможность уже не слепо, т. е. случайно, чисто эмпирическим путем, применять тот или иной метод гипнотерапии (часто при этом безуспешно), а применять его сознательно, учитывая особенности первой и второй сигнальных систем. Экспериментально устанавливая, какая из них более тормозима, мы путем применения соответствующего адекватного воздействия на более тормозимую сигнальную систему почти всегда добивались полного успеха гипнотизации. На основании экспериментальных исследований известно, что у больных истерией, травматическими поражениями головного мозга, вторая сигнальная система более тормозима, а поэтому вполне естественно, что у них легче достигнуть гипнотического сна, воздействуя на вторую сигнальную систему, а у больных психастениями более тормозима первая сигнальная система, а поэтому их следует гипнотизировать путем воздействия на первую сигнальную систему. В этом мы смогли убедиться на наших многочисленных опытах, проведенных в этом аспекте.

Все приемы гипнотизации мы свели к пяти физиологически обоснованным способам.

Первый способ гипнотизации — это вызывание гипнотического состояния путем воздействия на первую сигнальную систему посредством применения различного рода зрительных раздражителей (фиксация взгляда на разного рода небольших предметах: свет синей лампочки, врачебный молоточек, блестящие и неблестящие небольшие предметы и т. п.), звуковых раздражителей (ритмичные звуки приглушенного метронома и др.), кожных раздражителей (так называемые «магнетические пассы» легкое ритмическое поглаживание кожи лица и т. п.).

Как показал наш опыт, более быстрое гипнотическое состояние достигается путем одновременного воздействия на зрительный, звуковой и кожный анализаторы. Данный способ гипнотизации дает успех у тех больных, у которых первая сигнальная система более тормозима.

Второй способ гипнотизации — это способ сочетанного воздействия на вторую и первую сигнальные системы путем применения словесного внушения (подчеркивание физиологических явлений, наблюдаемых при засыпании), сочетанного с воздействием звукового или светового раздражителя (метроном, фиксация взгляда на светящейся синей лампочке и т. д.).

Третий способ гипнотизации — это вызывание гипнотического сна посредством только воздействия на вторую сигнальную систему при помощи словесного воздействия (подчеркивание физиологических явлений, наблюдаемых при состоянии сонливости и засыпания). Этот способ гипнотизации показан у тех

больных, у которых вторая сигнальная система более слаба, а следовательно, и более тормозима.

Четвертый способ — это вызывание условного гипнотического сна по способу, описанному А. Г. Ивановым-Смоленским.

Пятый способ — это вызывание гипнотического сна на безусловном подкреплении (при помощи снотворных средств).

У большинства изучавшихся нами больных мы вызывали гипнотическое состояние, воздействуя только на вторую сигнальную систему. Применение с лечебной целью совершенно безвредного и безопасного гипнотического сна вместо медикаментозного, более широкое применение гипнотерапии несомненно пробудит интерес широких кругов врачей к гипнозу, особенно к способам, методике и технике гипнотизации.

Поскольку гипнотическое состояние, по И. П. Павлову, является физиологическим состоянием и гипнотические фазы наблюдаются в норме у каждого человека при переходе его от состояния бодрствования в состояние сна, исходя из этого можно полагать, что таких людей (исключая душевно-больных), у которых с лечебной целью не удалось бы вызвать гипнотическое состояние, не существует. Физиологически обоснованные способы гипнотизации в свете учения о первой и второй сигнальных системах несомненно будут содействовать более успешной гипнотизации, проводимой с лечебной целью. Необходимо лишь помнить, что гипноз противопоказан у тех больных, у которых алкоголизм сочетается с психическими заболеваниями, в частности, с шизофренией, при которой нередко бредовые идеи концентрируются вокруг гипноза и гипнотического воздействия на них. Гипнотизация и гипнотический сон должны применяться только при соответствующих медицинских показаниях, только в лечебных целях и только в лечебных учреждениях.

ГИПНОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ

Лечение алкоголиков гипнозом в России стали применять в конце XIX века и особенно в XX веке (А. А. Токарский, Ф. Е. Рыбаков, В. М. Бехтерев, К. И. Платонов, И. Н. Введенский, В. Е. Рожнов, А. Н. Зимин и др.).

В амбулаторной практике уже при первом посещении больного выясняют его установки на лечение и общее состояние здоровья. Если больной искренно намерен лечиться, то применение гипноза следует начать с первого же дня.

Если больной находится в состоянии опьянения, ему предлагают явиться на прием на следующий день в трезвом виде, чтобы подтвердить этим свое желание вылечиться. Необходимо подчеркнуть при этом, что прекратить употребление спиртных напитков да еще с помощью врача вполне возможно.

Первые две недели гипнотерапию применяют через день, а затем промежуток между сеансами постепенно удлиняют и

в течение последующих трех месяцев проводят сеансы один раз в неделю; далее гипнотерапию можно проводить на протяжении еще одного года раз в 2 недели, а в последующие годы (в течение 3—5 лет) раз в 3 месяца. Внушение должно быть убедительным, простым, без высокопарных, напыщенных фраз и запугивания. Нужно внушать больному, что он будет равнодушен к вину, а затем у него появится отвращение, тошнота и рвота в связи с приемом вина.

В своей практике мы поступаем следующим образом. Успокаиваем больного, подчеркиваем, что гипнотизация совершенно безвредна, что гипноз — физиологическое состояние, свойственное всем здоровым людям, объясняем ему, что волнение и беспокойство, испытываемые перед гипнозом, затрудняют, а иногда и гротиводействуют засыпанию. Мы рекомендуем больному расстегнуть пояс, воротник, принять удобную позу или лечь на диван. Желательно проводить гипноз в тихой комнате, куда возможно меньше проникает внешний шум. Температура помещения не должна быть ниже 15° и выше 22°. Свет в комнате должен быть мягким, рассеянным, чтобы источник его находился позади гипнотизируемого, а не против него. Мы успокаиваем больного и убеждаем его в том, что у него появится спокойный, благотворный сон, восстанавливающий здоровье. Затем предлагаем ему кратковременно фиксировать взгляд на глазах врача или на врачебном молоточке. Мы говорим спокойно, ровным, тихим голосом: «В ваших глазах появляется тяжесть, ваши веки тяжелеют, тяжесть в них усиливается, веки безудержно опускаются книзу. Ваши веки закрываются, и вы их не можете больше открыть. Ваши веки слиплись». Если больной век не смыкает, то после 2—3-минутной фиксации мы велим ему закрыть глаза и затем говорим: «У вас постепенно нарастает сонливость, появляется тяжесть в руках, ногах, руки и ноги ваши цепенеют, они становятся неподвижными, вы ничего, кроме моих слов, не слышите, сонливость усиливается, углубляется. Вам приятно, спокойно, хорошо. Вас ничто не беспокоит. Вам сильно хочется спать. Дремота усиливается. Сердечная деятельность правильная. Дыхание ровное, спокойное. Вы погружаетесь в сон все больше и больше. Сон усиливается и углубляется, нарастает. Спите! Спите глубже и крепче!». Подобное словесное внушение мы проводили в течение 5—15 минут. Как правило, большинство больных погружается в гипнотический сон с первого же сеанса, а остальная часть из них находится в легком гипнотическом состоянии (рис. 19). Затем после погружения больных в гипнотический сон проводят словесное внушение, при котором кратко, но убедительно указывают на вред, который причиняет данному больному алкоголь, а затем внушают отвращение к алкогольным напиткам и отсутствие к ним желания.

Дегипнотизация не представляет никаких затруднений.

Больному внушают, что после пробуждения боли в голове, усталости и тяжести в руках и ногах он испытывать не будет, а наоборот, будет чувствовать себя бодрым, здоровым, полным энергии и сил. Затем больному приказывают при счете «три» проснуться. Будить сразу, без предварительной подготовки, не следует, так как при этом бывают неприятные явления в виде головной боли, слабости, сердцебиения и т. п.

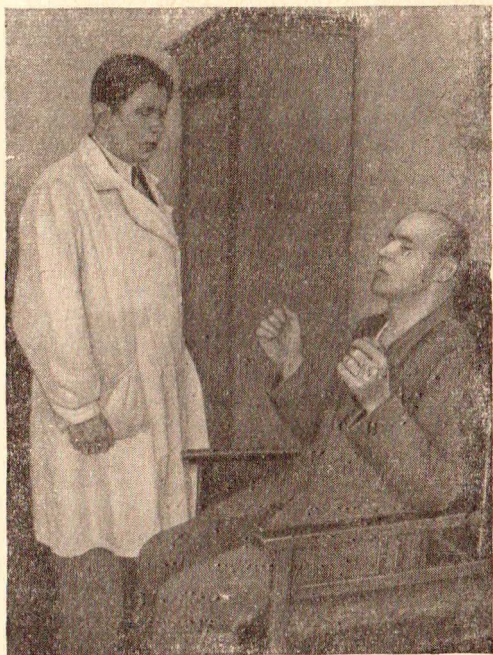


Рис. 17. Катаlepsия в гипнотическом состоянии.

Если после пробуждения у больного отмечается слабость, головная боль, тяжесть во всем теле, ему велят закрыть глаза и внушают наяву следующее: «Головная боль, тяжесть в теле у вас проходят, вы себя чувствуете прекрасно, бодрым, здоровым, голова перестала болеть, тяжесть в теле прошла. Вы чувствуете себя хорошо». После этого велят открыть глаза. Подобного внушения наяву достаточно для устранения упомянутых выше явлений, наблюдаемых у некоторых лиц после гипнотизации. Иногда больные после гипноза сразу не просыпаются. В таких случаях их окликают, повелительно приказывают проснуться, повторяя это внушение несколько раз. У сомнамбул при пробуждении следует соблюдать осторожность.

После пробуждения за такими больными надо наблюдать, так как у них может наступить лишь частичное пробуждение и возврат сомнамбулизма.

При осложнении гипноза, когда наступает истерический сомнамбулизм и истерическая летаргия, когда рапорт обычно нарушен или отсутствует, пробуждение затрудняется. В таких случаях надо восстановить рапорт, и тогда пробуждение достигается без всяких трудностей.

ВЫРАБОТКА ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТОШНОТНОЙ И РВОТНОЙ РЕАКЦИИ НА АЛКОГОЛЬ В ГИПНОТИЧЕСКОМ СНЕ ПРИ ПОМОЩИ РЕЧЕВОГО ПОДКРЕПЛЕНИЯ

В последние годы мы с успехом применяли предложенную нами методику выработки условной эмоционально-отрицательной реакции и рвотного условного рефлекса на алкоголь в гипнотическом состоянии. Мы давали алкоголикам нюхать водку или же предлагали пробовать ее, внушая при этом отвращение к алкоголю. Сомнамбулы крайне живо реагируют на такие внушения: на их лице появляется гримаса отвращения, происходит обильное выделение слюны, возникает тошнота и даже рвота.

В проведенных нами соответствующих исследованиях мы показали, что в гипнотическом состоянии при помощи речевого подкрепления возможно образование условного рефлекса в виде той или другой вегетативной реакции, а в интересующих нас случаях—рвотной реакции различной силы и длительности.

В данном случае особенно ценным является то обстоятельство, что при помощи слова мы могли управлять такой реакцией, то вызывая ее, то усиливая или ослабляя и прекращая ее. Влияние словесного воздействия на вегетативно-висцеральные функции, на обмен веществ известно давно. В этом аспекте проведены интересные исследования Тарханова, В. М. Бехтерева, К. И. Платонова, А. О. Долина, Ю. А. Поворинского. Нужно отметить, что в разработанном нами способе речь идет не о кратковременном, быстро преходящем эффекте, а об образовании прочных условных реакций, возникающих и укрепляющихся в ряде последовательных гипнотических сеансов, которые сохраняются, не угасая в течение длительного срока,—от 6 месяцев до 3—5 лет. Необходимой предпосылкой для образования вегетативной условной реакции является знание словесного обозначения, названия этой вегетативной функции. В целях профилактики угасания выработанной условной рвотной реакции на алкоголь с помощью словесного внушения необходимо ее подкреплять, спустя полгода, 1 год, 1½ года, 2 года, т. е. каждые полгода. Если это по каким-либо причинам сделать не удастся, подкрепление можно проводить один раз в год. Для выработки прочной отрицательной рвотной реакции

на алкоголь с помощью речевого подкрепления необходимо провести не менее 20—30 гипнотических сеансов.

При этом необходимо погрузить больного в глубокий гипнотический сон, в парадоксальную фазу, которая, по И. П. Павлову, характеризуется тем, что позволяет внушить загипнотизированному «...все противоположное действительности и вызывать реакцию, прямо противоположную действительным раздражениям: сладкий вкус вместо горького, необыкновенные зрительные раздражения вместо самого обыкновенного и т. д.»¹.

Клинически парадоксальная фаза характеризуется каталепсией, анестезией и различными вкусовыми, слуховыми, зрительными, обонятельными и осязательными ощущениями, появляющимися у больного в результате внушения.

После погружения больного в парадоксальную фазу гипнотического сна ему дают нюхать водку или другой алкогольный напиток, которым злоупотребляет больной, подчеркивая при этом, что запах алкоголя ему неприятен, вызывает у него тошноту. Затем больному вводят в рот чайную ложку водки и велют ее проглотить, подчеркивая, что вкус водки или вина вызывает у него тошноту, которая нарастает и переходит в сильную рвотную реакцию. Многократно подчеркивается, что рвота от принятого алкоголя усиливается, нарастает. Обычно, как правило, после приема алкоголя на лице больного появляется гримаса отвращения, у него возникают кашлевые движения, наступает тошнота, а затем наступает рвотная реакция. Лицо обычно гиперемизировано, отмечается обильная саливация и выделение слизи. Пульс учащается, лицо и тело покрываются потом, т. е. мы наблюдаем те же вегетативные реакции, что и после приема рвотных средств. При слабой рвотной реакции мы усиливаем ее с помощью речевого подкрепления, а при сильной — ослабляем. Если некоторые больные во время рвотного акта пробуждаются, то после прекращения рвотной реакции их вновь усыпляют.

Критерием упрочения рвотной условной реакции является появление тошнотной и рвотной реакции после приема алкоголя уже в состоянии бодрствования, без погружения в гипнотический сон.

Приведем пример.

Больной М., 48 лет. В 1943 г. перенес контузию головы с потерей сознания. Алкоголем злоупотребляет с 1945 г. С того же года — абстинентный синдром и амнестическая форма опьянения. После трехлетнего злоупотребления алкоголем (в 1948 г.) появились эпилептиформные припадки. Плохо спит, лишился аппетита. Органических отклонений со стороны центральной нервной системы не отмечается. Со стороны сердца — глухие тоны. Печень увеличена на 2 пальца. Настроение подавленное: больного преследуют мысли о самоубийстве; иногда он видит разных чудовищ и при этом испытывает страх, страдает бессонницей. Отмечалась тревожно-параноидная установка мышления. В 1949 г. поступил на

¹ И. П. Павлов, Полное собрание трудов, т. IV, 1947, стр. 338.

лечение в клиническую психоневрологическую больницу № 6 Мосгорздравотдела. Вначале ему проводили лечебный гипнотический сон, и он в течение 10 дней спал по 12—16 часов в сутки, а затем в течение 20 дней по 10 часов. После улучшения общего состояния, исчезновения галлюцинаций и тоски было приступлено к выработке эмоционально-отрицательной и рвотной реакции на алкоголь в гипнотическом сне. С помощью речевого подкрепления (по вышеописанному способу) у больного после введения в рот алкоголя наступила бурная рвотная реакция. В некоторых случаях ему даже не удавалось проглотить ни одной чайной ложки алкоголя. После курса лечения, проведенного в течение месяца, у больного образовалась и упрочилась рвотная условная реакция на алкоголь, которая наступала уже и в состоянии бодрствования, без гипноза.

Через 3 года, в 1952 г., возник кратковременный рецидив алкоголизма (в течение нескольких дней вместо водки пил красное вино). Это можно объяснить тем, что в течение 2 лет выработанная рвотная условная реакция на алкоголь не подкреплялась. После проведенного в 1952 г. кратковременного повторного курса лечения больной чувствует себя здоровым, алкоголя не употребляет. Эпилептиформные припадки прошли, функция сердца и печени пришла в норму. Больной прекрасно себя чувствует, хорошо выглядит и успешно работает.

Лечение путем выработки условной эмоционально-отрицательной и рвотной реакции на алкоголь в гипнозе мы провели с хорошим результатом более чем у 300 больных хроническим алкоголизмом.

Положительной особенностью метода является возможность выработать при помощи его более прочный и устойчивый отрицательный рефлекс на алкоголь, чем при помощи рвотных средств. Данный метод можно применять как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Противопоказанием к нему служит лишь язвенная болезнь.

Коллективная гипнотерапия алкоголиков. В условиях амбулаторий и стационаров можно применять предложенный В. М. Бехтеревым метод коллективного гипноза.

Больные размещаются в креслах, на скамьях, стульях таким образом, чтобы между ними можно было свободно ходить для проверки гипнотического состояния. Предварительно им кратко рассказывают, какой вред наносит организму алкоголь.

Беседа-лекция должна быть убедительной, иначе она не окажет воздействия на слушателей. Непосредственно перед сеансом гипноза больным объясняют, каким путем достигается гипнотическое состояние. Больные закрывают глаза и сосредотачиваются на мысли о сне. Далее им внушают гипнотический сон. При проверке наступившего состояния гипноза врач обходит ряды больных и вызывает у них каталепсию, оставляя их в таком состоянии на время всего сеанса. Затем проводится внушение. По пробуждении больные получают инструкцию для осуществления методики самовнушения, которое каждый из них должен проводить ежедневно, по несколько раз перед сном, находясь в постели с закрытыми глазами и утром перед вставанием. Весьма значительных успехов в деле проведения кол-

лективной гипнотерапии алкоголиков достиг А. Н. Зимин (рис. 18).

Этот автор пользуется следующим методом. С больными, назначенными на гипноз, предварительно проводят 2—3 беседы-лекции с демонстрацией разработанных автором схем-рисунков, а также препаратов пораженных алкоголем органов.

Лекции излагаются с психотерапевтическим уклоном. В «формулах» внушения частично повторяются элементы речевой терапии, взятые из предварительно проведенных лекций.

Первому гипнотическому сеансу предпосылается краткое содержание сущности гипноза.

После каждого сеанса проводят непродолжительные (в течение 3—5 минут) легкие гимнастические упражнения.

В отличие от способа коллективной гипнотерапии В. М. Бехтерева, который сеанс гипноза проводил 20 минут, мы проводим такой сеанс в течение 1—1½ часов. Таким образом, курс лечения состоит не из 3—6 сеансов, как у Бехтерева, а из 20—30. Это позволяет нам, наряду со словесным внушением, использовать в гипнозе и целебные свойства гипнотического сна, благотворно влияющего на нервно-психическую сферу больного.

В вопросе гипнотерапии мы не разделяем взглядов ряда авторов (А. А. Токарский и др.), которые считают излишними какие бы то ни было вспомогательные средства — например, фармакотерапию, физиотерапию и т. п., заявляя, что состояние здоровья их больных быстро улучшалось под влиянием только одной гипнотерапии.

Мы в своей практике применяем лишь комбинированное лечение.

Внушение наяву. У больных хроническим алкоголизмом можно с успехом проводить словесное внушение, не прибегая к вызыванию гипнотического сна. Больному закрывают глаза и властно говорят ему, что веки у него слиплись, и он не может их открыть, или поднимают его руки и говорят, что он больше не может опустить их, и т. п.

В таком же состоянии ему внушают отвращение к алкоголю. Внушение наяву при закрытых глазах, без вызывания гипнотического состояния целесообразно применять, если больные хотят лечиться гипнозом, но почему-либо не поддаются ему. В таких случаях необходимо подчеркивать, что внушение наяву оказывает такое же влияние, как и внушение в гипнотическом состоянии.

Самовнушение. Известную пользу может принести самовнушение. Самовнушение особенно целесообразно применять, например, в тех случаях, когда алкоголик в силу неблагоприятных обстоятельств не может подвергаться систематическому лечению в амбулатории и стационаре. Больного убеждают в том, что он сам может проводить себе внушение. Про-

водится ряд подготовительных опытов, благодаря которым больной убеждается в силе внушения. Затем ему внушают отвращение к алкогольным напиткам, хорошее самочувствие, бодрость, веру в излечение. Самовнушение нужно проводить с учетом индивидуальных особенностей больного.

При лечении этим методом для фиксации внимания можно давать больным табличку с такими словами: «Алкогольных на-



Рис. 18. Коллективная гипнотерапия.

питков я никогда принимать не буду. Водка, вино, пиво, коньяк, наливки и другие спиртные напитки мне неприятны. С каждым днем отвращение к алкоголю у меня нарастает. Мое здоровье с каждым днем улучшится. Я здоров, я совершенно здоров».

Речевая терапия¹. Все виды психотерапии следует отнести к речевой терапии. При речевой терапии требуется правильный подход к алкоголикам без излишнего резонерства, создание подлинного психотерапевтического контакта, что является одним из важных условий успешного лечения. Рапопорт справедливо отмечает, что активный интерес, сердечный подход, здоровый оптимизм — вот то основное, что должен встре-

¹ Термин, впервые введенный А. Г. Ивановым-Смоленским.

тить больной у врача-психотерапевта. Спокойный, участливый тон должен сохраняться и в дальнейших беседах. Больному необходимо объяснить нервные механизмы привыкания к алкоголю, ознакомить его с основными факторами, играющими роль в развитии алкоголизма. Необходимо разубедить больного в том, что его заболевание будто бы предрешено, являясь своего рода фатумом, с которым бесполезно бороться. Наоборот, нужно доказать ему, что алкоголизм — болезнь, вызванная ошибочным поведением больного при тех или иных неблагоприятно для него сложившихся обстоятельствах, подчеркнуть роль примера окружающих, роль бытовых моментов и т. п.

В целях профилактики рецидивов необходимо ознакомить больных с механизмом их возникновения. Нужно разъяснить ему, что возможность рецидива сохраняется чрезвычайно долго и провоцирующим фактором, вызывающим его, является опять-таки алкоголь, ввиду чего больной постоянно должен воздерживаться от употребления спиртных напитков.

ФИЗИОТЕРАПИЯ

При терапии хронического алкоголизма как амбулаторно, так и в стационарах с успехом применяют физиотерапию: токи д'Арсонваля, статическое электричество (франклинизация) и пр. Особенно благотворно действует на алкоголиков фототерапия в виде ультрафиолетовых лучей.

Алкоголикам назначают общее облучение кварцем. Курс лечения состоит из 10—20 облучений. Горелка должна находиться на расстоянии 70 см от облучаемой части тела.

Начинают облучение с 3 минут, первые 10 сеансов прибавляют по одной минуте, а с 11-го сеанса добавляют по 2 минуты. В течение 19-го и 20-го сеанса облучают по 10 минут как переднюю, так и заднюю поверхность тела.

Противопоказаниями к фототерапии служат лихорадочные состояния, кровотечения и склонность к ним, активные формы туберкулеза, злокачественные опухоли, декомпенсированные пороки сердца с склонностью к геморрагиям, злокачественная анемия, старческая дряхлость, выраженная гипертония, грудная жаба, тяжелые формы органических поражений центральной нервной системы.

Токи д'Арсонваля применяют в виде общей или местной дарсонвализации. Общая дарсонвализация оказывает благотворное влияние на нервную систему, уменьшая ее возбудимость, а также способствует нормализации кровяного давления как у алкоголиков с гипертонией, так и у алкоголиков с гипотонией. Местную дарсонвализацию назначают алкоголикам, страдающим головными болями, невралгиями и т. п., ибо она понижает все виды чувствительности, в том числе и боле-

вую. Местная дарсонвализация противопоказана при идиосинкразии к этому виду лечения. Общая дарсонвализация противопоказана при стенокардии, аневризме аорты, тяжелых сердечно-сосудистых неврозах.

С успехом применяют у алкоголиков статическое электричество.

Из других электропроцедур в соответствующих случаях применяют гальванический воротник по Щербаку. Четырехкамерные ванны благотворно влияют на алкоголиков при болях в конечностях, неправильно трактуемых как ревматические. Эти боли зависят от алкогольных невритических расстройств, от перерождения периферических веточек чувствительных нервов. Нередко после 10—15 четырехкамерных ванн они уменьшаются или проходят. При атеросклерозе хорошие результаты дает ионизация с иодистым калием по Бургиньону, чеснок внутрь попеременно с микродозами иода. Другие электропроцедуры применяются в зависимости от медицинских показаний.

ГИДРОТЕРАПИЯ

Из гидротерапевтических процедур наиболее полезными для алкоголиков считаются хвойно-соленые ванны температуры 35—36° длительностью 10—15 минут, назначаемые обычно ежедневно. Подобные ванны, особенно если они проводятся перед сном, улучшают сон, действуют успокаивающим образом на центральную нервную систему, оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Весьма полезны ежедневные обтирания всего тела следующим составом: 3 столовые ложки столового уксуса, одна столовая ложка хвойного экстракта, 3 столовые ложки поваренной соли и одна столовая ложка одеколона, растворенные в 3 л воды комнатной температуры. Этим составом смачивают половину полотенца из грубой ткани и последовательно вытирают все тело сначала мокрой половиной, а затем сухой. Эти процедуры желательно проводить по утрам.

Рекомендуются также прохладные души, обливание водой температуры 30—32°. Весьма благоприятно действует на алкоголиков с ослабленной половой функцией (при отсутствии грубых сосудистых расстройств) душ Шарко и циркулярный душ. Полезно также купание в море или реке, полуванны с обливанием. Особенно благотворное влияние гидротерапия оказывает на вегетативную нервную систему, регулируя ее функции.

ФИЗКУЛЬТУРА

Физкультура должна найти широкое применение при лечении алкоголиков как в стационарах, так и в диспансерах. Физкультура благотворно действует на обмен веществ. Больные

должны систематически заниматься врачебной гимнастикой. В зависимости от физического состояния, больных распределяют по группам и проводят с ними тот или иной вид физкультурных упражнений. Мы обычно рекомендуем больным утреннюю физкультурную зарядку в течение 5—10 минут.

Врачебную гимнастику следует сочетать со спортом. Помимо того, должны систематически проводиться различные экскурсии.

В физкультурные занятия мы включаем ходьбу, бег, гимнастику, дыхательную гимнастику. Из игр рекомендуется волейбол, городки, крокет, теннис, зимой — лыжный спорт, коньки, летом — гребля, купание, рыбная ловля и т. д. При лечении алкоголиков должны широко использоваться также солнце, воздух и вода. Физкультуру у алкоголиков мы должны проводить с таким расчетом, чтобы поднять их жизненный тонус, насытить физкультуру эмоционально радостным содержанием, пробудить у больных интерес к физкультурным упражнениям и спорту.

Нужно помнить, что пребывание в коллективе активизирует, тонизирует больных, отвлекает их от болезненных мыслей, поэтому гимнастику и другие упражнения следует проводить коллективно, в группе и лишь при невозможности осуществить это — индивидуально.

Утреннюю зарядку целесообразно проводить под ритмическую музыку, которая положительно влияет на эмоциональную сферу больных.

КУЛЬТТЕРАПИЯ

Культтерапия как в стационарах, так и в диспансерах является неотъемлемой частью лечебной работы, одним из важных методов активной терапии больных алкоголизмом.

Основные задачи культуры следующие:

1) пробудить или восстановить угашенный у больных интерес к культурным развлечениям: театру, радио, кино, музыке, книгам, газетам, лекциям, работе в кружках, в библиотеке и т. п.;

2) привить больным антиалкогольные навыки;

3) втянуть больных в активную культурно-общественную работу.

Культтерапию следует строить с таким расчетом, чтобы вызвать активный интерес к ней самого больного. Например, нельзя рекомендовать музыку больному, который плохо переносит ее, которого она раздражает. Больного необходимо заинтересовать таким видом культурного развлечения, к которому он испытывает интерес. Следовательно, требуется индивидуальный подход к нему.

Мы проводим культу терапию среди алкоголиков примерно следующим образом. При собирании анамнеза мы выявляем

отношение больного к культурным развлечениям, а затем при первых же беседах стараемся разъяснить ему, что именно в алкоголе он старался искать для себя источник веселья, что ему были подчас мало знакомы разные виды развлечений, позволяющих приятно провести досуг и значительно обогащающих познания человека.

При выявлении у больного пробуждающегося интереса к какому-либо виду культурных развлечений нужно этот интерес всячески развивать с тем, чтобы больной по окончании лечения в дальнейшем самостоятельно заполнял свой досуг разумными развлечениями, чтобы у него появилось желание повысить свои знания, свою квалификацию и т. д.

Больных, у которых культурные запросы приблизительно одинаковы, целесообразно объединять в группы; под руководством компетентных лиц они должны посещать театры, кино, концерты, музеи, картинные галереи, библиотеки и т. д. Такие экскурсии углубляют у больных активный интерес к культурным развлечениям.

Необходимо разъяснить больным, что при неприятностях и невзгодах не следует стараться одурманивать себя алкоголем; успокоение нужно искать не в алкоголе, а в разумных развлечениях (музыка, радио, кино, театр, хорошая книга, спорт, физкультура, творческая работа).

Умело проводимая культтерапия может принести большую пользу в деле восстановления здоровья алкоголиков. Для проведения культтерапии должен существовать штат культтерапевтов, затейников-массовиков или педагогов. Культтерапия, которая применяется в некоторых лечебных учреждениях для алкоголиков, а также в нервно-психиатрических стационарах, неудовлетворительна; часто она проводится людьми, не имеющими достаточной подготовки и опыта в этой области.

Массовая культработа в лечебных учреждениях для алкоголиков особенно целесообразна, поскольку она заполняет досуг больных, отвлекает их от еще не заглухнувшего влечения к алкоголю, пробуждает в них хорошие моральные качества. Должны быть организованы самостоятельные кружки: музыкальный, хоровой, сценический, литературный, шахматно-шашечный, фотокружок и т. д. Следует также уделять серьезное внимание антиалкогольному просвещению. С этой целью мы обычно проводим цикл лекций на следующие темы: 1) алкоголь и здоровье; 2) хронический алкоголизм и его профилактика; 3) алкогольные психозы и их лечение; 4) алкоголизм и производительность труда; 5) алкоголизм и семья; 6) алкоголизм и венерические болезни; 7) алкоголизм и туберкулез; 8) алкоголизм и преступность; 9) нервные болезни и их профилактика; 10) борьба с алкоголизмом; рецидивы алкоголизма и их предупреждение и др.

Эти лекции должны проводиться врачами-специалистами, основываться на конкретном материале и быть достаточно популярно изложенными.

Желательно, чтобы культурная работа среди алкоголиков проводилась по определенному плану, выработанному совместно с активом из состава больных.

ТРУДОТЕРАПИЯ

Большинство алкоголиков в отличие от психически больных уже через несколько дней после стационарирования проявляет интерес к какому-либо труду. Часть алкоголиков в периоды воздержания от алкоголя нередко являются хорошими производственниками, давая высокую производительность труда и хорошее качество работы и проявляя подлинный производственный энтузиазм. Естественно, что, попадая в лечебное учреждение, они тяготеют к безделью.

Трудотерапия как лечебный фактор, комбинированный с другими методами лечения, играет большую роль при лечении алкоголизма и должна строиться так, чтобы все свободное время больного было целесообразно использовано. Больные получают моральное удовлетворение от сознания, что на время лечения они не исключены из трудовой жизни.

Каждому больному трудотерапию назначают с таким расчетом, чтобы она не вызывала неудовлетворенности, безразличия или отвращения к труду. Поэтому, назначая трудотерапию, врач должен считаться со специальностью больного и влечением его к той или иной работе. Трудотерапию весьма полезно сочетать с культурной терапией.

За больными, которым назначена трудотерапия, устанавливают динамическое наблюдение с учетом характера воздействия труда на здоровье. Наряду с субъективными данными о проводимой трудотерапии, следует учитывать и объективные данные, например, результаты исследования высшей нервной деятельности, кровяного давления, морфологического состава крови, биохимии крови. При этом труд назначают и дозируют в зависимости от состояния здоровья больных.

Первые 3—4 дня поступившие в стационар алкоголики должны соблюдать постельный режим, особенно при наличии у них тяжелых сдвигов со стороны нервно-психической сферы и явлений абстинентного синдрома. Когда похмельные симптомы смягчаются, что наступает обычно на 3—5-й день, целесообразно назначать больным трудотерапию. Последняя должна занимать от одного до 7 часов. Даже больным с ослабленным сердцем и повышенным или пониженным кровяным давлением можно назначать трудовые процессы. Вначале больные выполняют их в течение одного часа. В дальнейшем длительность их постепенно повышают, разумеется, контролируя

деятельность сердца и кровяного давления. При этом учитывают субъективные ощущения больного.

В стационарах для алкоголиков необходимо проводить лекции и беседы, разъясняющие вопросы трудотерапии, и сравнивать результаты, достигнутые у больных, которым назначалась трудотерапия, с результатами, полученными у больных, не подвергавшихся этому методу лечения.

Следует отметить, что неработающие больные тормозят процесс своего выздоровления. Отдельные лица указывают, что они пришли лечиться, а не работать и что работать они успеют. Таким больным нужно разъяснять, что труд, сочетающийся с другими активными методами лечения, является мощным фактором, способствующим восстановлению их здоровья. Такие беседы оздоравливают атмосферу в стационаре и создают установку на лечение трудом. Что касается видов труда, рекомендуемых для алкоголиков, то наиболее благотворно на них влияет физический труд, связанный с активными движениями.

При диспансерах и при стационарах, в которых производится лечение алкоголиков, рекомендуется развертывать лечебно-производственные мастерские, где больные, находящиеся на излечении, могут заниматься трудовой терапией. Производство в таких мастерских должно быть несложным, чтобы больные, не имеющие квалификации, могли быстро его освоить (столярная, сапожная, слесарно-механическая, штамповочная, матрачная, игрушечная, картонажная, выпилочная и другие мастерские).

Каждой мастерской должен руководить специалист-инструктор, который обучает больных производственным процессам. Обычно такое обучение проводится не только инструктором, но и больным, имеющим определенную квалификацию. При этом мы отмечали, что больные довольно быстро осваивали несложные процессы столярного, слесарного, сапожного и переплетного дела, причем у большинства из них пробуждалось желание работать как можно лучше. Выписавшись из стационара, такие больные часто совершенствовали свои знания и приобретали квалификацию слесаря, токаря, столяра и т. д.

Если развернуть трудотерапию в лечебном учреждении почему-либо нельзя, ее можно проводить на соседних фабриках, заводах, в мастерских, совхозах и колхозах. Больных следует объединять в бригады под руководством бригадира из числа больных.

Больные, находившиеся в московской нервно-психиатрической лечебнице для острого алкоголизма, работали на соседнем деревообделочном заводе под руководством бригадиров из числа своих же товарищей, без надзора со стороны медицинского персонала. Работа проходила вполне успешно. Боль-

ные гордились оказанным им доверием и вполне оправдывали его. Правда, имели место и такие случаи, когда отдельные больные пытались отлучиться с завода для того, чтобы приобрести алкоголь, но обычно они получали решительный отпор со стороны своих товарищей.

Весьма важно учитывать состояние психики каждого больного. При направлении на трудотерапию врач должен назначить больному такую работу, при выполнении которой он мог бы тренировать свои ослабленные психические функции: волю, внимание, память и т. д. Такая тренировка если полностью и не устраняет болезненных симптомов, то во всяком случае дает значительное улучшение.

У большинства алкоголиков наблюдается склонность работать в столярной мастерской. Некоторые квалифицированные рабочие не проявляют желания работать в области своей специальности, а охотно работают по другой, новой для них специальности. Никогда не следует уговаривать больных работать по не интересующей их специальности, ибо это оказывает лишь отрицательное влияние. Трудотерапию надо строить так, чтобы больные получали моральное удовлетворение.

Среди алкоголиков встречаются такие, которые работают «запоем». Четыре часа трудотерапии их не удовлетворяют, они рвутся к работе, заявляя: «Если я работаю, то работа отвлекает меня от влечения к алкоголю, вызывая здоровое рабочее настроение, а без работы я себя плохо чувствую». Конечно, в этих случаях приходится считаться с желанием больного и назначать ему работу в большей дозе, чем прочим больным.

Из состава больных выделяются бригады, руководимые бригадирами, вербуемыми из числа больных, имеющих квалификацию. Инструктора мастерских дают бригадирам задания по работе. Выполненная за день работа учитывается инструкторами и бригадирами.

Медицинское наблюдение осуществляется лечащими врачами.

Считаем необходимым вкратце остановиться на трудотерапии в наркоприемниках и колониях для алкоголиков. Наркоприемники предназначены для оказания помощи при остром отравлении алкоголем и состоят из отделения для вытрезвления, где больные находятся от нескольких часов до суток, и стационарного отделения для повторного кратковременного стационарирования больных хроническим алкоголизмом. В отделении для вытрезвления трудотерапии нецелесообразна ввиду того, что туда доставляются больные с острой алкогольной интоксикацией и нередко в возбужденном состоянии. Что касается стационаров при наркоприемниках, где больной находится 5—10—15 дней, то там трудотерапия, наряду с другими активными методами лечения, безусловно, осуществима и

целесообразна. Трудовые процессы можно проводить или в самом стационаре, или в небольшой мастерской закрытого типа.

Вполне осуществима и полезна трудотерапия для алкоголиков, лечащихся амбулаторно в диспансерах, но в силу своей болезни потерявших связь с производством, ибо трудотерапия спасает их от окончательной деградации и поддерживает как морально, так и материально. Таких больных необходимо направлять в лечебно-производственные мастерские. Что касается больных, не имеющих квалификации, то их нужно приучить к несложному квалифицированному труду с таким расчетом, чтобы они могли его усвоить за короткий срок.

Во главе мастерских должен стоять врач-психиатр, который тщательно отбирает направляемых туда больных из числа алкоголиков, излеченных в условиях диспансера, но потерявших работу из-за пьянства, при наличии у них серьезной установки на лечение.

Больным перед направлением в мастерские следует разъяснить, что при пьянстве в мастерской или при появлении на работе в нетрезвом виде, а также в состоянии похмелья они будут немедленно выписаны. Мастерские существуют на хозяйственном расчете. Здесь не должна иметь место уравниловка, зарплата строго дифференцируется. Срок работы в таких лечебно-производственных мастерских колеблется в пределах от 2 до 6 месяцев.

Параллельно с работой в мастерских больные должны лечиться в диспансерах.

Важно, чтобы в процессе лечения в лечебно-производственных мастерских больные были устроены на постоянную соответствующую их квалификации работу. Наряду с этим, необходимо оздоравливать социально-бытовые условия больных, вовлекать их в общественно-культурную работу, прививать им антиалкогольные навыки. При правильной постановке дела подобные лечебно-производственные мастерские вполне рентабельны, полезны и являются большим подспорьем в деле лечения алкоголизма.

ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ

Лечебное питание является весьма важным разделом терапии алкоголизма. Между тем вопросы диететического питания алкоголиков почти не разрабатывались, и врачи-психиатры уделяли им мало внимания.

Часто наблюдаемый у алкоголиков резкий упадок питания, авитаминоз и гиповитаминоз, нарушение обмена веществ, соматические заболевания, полиневриты, болезни сердца, печени, желудочно-кишечного тракта и т. п. можно успешно лечить путем назначения соответствующего пищевого режима, сочетая его с другими методами лечения.

При назначении диеты необходимо учитывать, кроме заболелания, индивидуальные особенности больных (пищевая анафилаксия). Ввиду отсутствия точных данных о нормах питания для алкоголиков, мы исходим в приводимых ниже нормах из средних норм, установленных физиологами.

Несмотря на дискуссионность вопроса о количестве пищевых веществ, необходимых организму, все же на основе имеющихся физиологических исследований можно считать за норму суточной потребности человека следующий пищевой рацион: 121 г белка, 59 г жиров, 510 г углеводов, что составляет 3135 калорий. Это стандарт для человека среднего роста, ведущего деятельный образ жизни.

При расчете суточного белкового рациона необходимо учитывать степень усвояемости белков. Животные белки, родственные по своему строению белкам человеческого организма, являются наиболее полноценными, растительные же белки значительно ниже по своей биологической ценности. Полноценными называются те белки, которые содержат все аминокислоты, могут покрыть полностью потребности взрослого организма и поддерживать рост молодого; к ним относятся главным образом белки животного происхождения.

Хлебные злаки, корни и корнеплоды, за исключением картофеля, содержат неполноценные белки. Белки животного происхождения должны составлять не менее $\frac{1}{3}$ всего белкового рациона. Жирам животного происхождения, несмотря на возражения некоторых авторов, все-таки следует отдать предпочтение перед растительными жирами вследствие их лучшей усвояемости, содержания витамина А и некоторых липоидов. Последние два фактора способствуют повышению сопротивляемости организма инфекции. Основное количество калорий в пищевом рационе человека приходится на углеводы, большинство которых имеет растительное происхождение, за исключением молочного сахара и гликогена. Углеводы употребляются в виде полисахаридов (крахмал) или дисахаридов (тростниковый, молочный и свекловичный сахар).

Углеводы в большом количестве находятся в различных фруктах и овощах, богатых также витаминами и минеральными солями. Питательные вещества при сгорании в организме дают следующее количество калорий: 1 г белка — 4,1 калории, 1 г жира — 9,3, 1 г углеводов — 4,1 калории.

Что касается минеральных солей, то важно не только абсолютное их количество в организме, но и их соотношения. Минеральные соли содержатся в продуктах животного и растительного происхождения, а также в воде.

При составлении пищевого рациона следует помнить о необходимости введения в организм достаточного количества минеральных солей и витаминов. Суточное количество воды, по-

требное для взрослого человека, составляет около 2,5 л, куда входит также вода, содержащаяся в пищевых продуктах.

Пища алкоголиков должна быть разнообразной и особенно богатой витаминами. У больных хроническими заболеваниями однообразная пища в течение продолжительного времени легко может вызвать потерю аппетита и отвращение к еде, авитаминоз или преавитаминозное состояние (падение работоспособности, общая слабость, плохой вкус во рту и ряд симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта), запор или понос.

Рубнер считает, что при строгом соблюдении постельного режима суточная потребность среднего человека в пище на 1 кг веса составляет 24—30 калорий, при обычно постельном режиме — 30—34, при образе жизни без физической работы — 34—40, при средней работе — 40—45 и при тяжелой работе — 45—60 калорий.

Нормы питания для алкоголиков мы вывели на основе полученных нами данных об обмене веществ у алкоголиков. Под лечебным питанием следует подразумевать рациональный пищевой режим, при котором в организм вводятся в достаточном количестве дефицитные для него в данный период пищевые вещества, одновременно щадящие желудочно-кишечный тракт, который у алкоголиков поражен в той или иной степени. Как указывалось выше, исследованиями установлено, что у алкоголиков нарушен углеводный, витаминный, солевой и газовый обмен. Правильно построенный пищевой режим способствует быстрому восстановлению нормального обмена веществ. Мы считаем нужным оговориться, что параллельно с введением в организм в достаточном количестве недостающих пищевых веществ необходимо воздействовать и на центры, регулирующие обмен веществ.

Наши наблюдения показали, что, несмотря на избыточное введение с пищей в организм солей кальция, хлоридов, углеводов, последние усиленно из него выводятся, чем, возможно, и объясняется нарушение обмена веществ. Все же, несмотря на усиленное выведение из организма дефицитных для него веществ, лечебное питание, сочетающееся с другими методами лечения, может принести известную пользу.

Больные должны получать пищу, богатую витаминами, углеводами, солями кальция, хлоридами и железом. Первые 5—6 дней ввиду катарральных явлений со стороны желудка и кишечника лучше назначать больным диету. В эти дни можно давать им в обильном количестве сладкий чай, молочные продукты (молоко, масло, сыр), кисель, рисовую молочную кашу, мясной бульон. По истечении 5—6 дней переходят к общей лечебной диете для алкоголиков. Больные должны есть понемногу, в определенные часы, причем целесообразнее всего принимать пищу 4 раза в день.

Ниже приводится примерный суточный набор продуктов, рекомендуемый нами для алкоголиков. Однако следует помнить, что пищевой режим надо строго индивидуализировать в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей больного.

Проект нормальной диеты для алкоголиков

№ п.п.	Наименование продуктов	Вес нетто в г	Белок в г	Жиры в г	Угле- воды в г	Кало- рии	Вес брутто в г
1	Молоко	200,0	6,24	6,98	9,88	131,00	200
2	Масло сливочное	45,0	0,44	37,79	0,27	354,32	45
3	» животное	15,0	0,25	12,59	0,08	113,11	15
4	Сметана	45,0	1,89	11,23	0,78	115,23	45
5	Творог	20,0	2,83	0,11	0,23	13,59	20
6	Яйца	60,0	7,30	6,91	0,33	95,46	60
7	Масло растительное	5,0	—	4,65	—	43,29	5
8	Мясо	80,0	15,65	4,20	0,53	105,39	112
9	Куры	40,0	7,54	1,94	0,43	50,67	60
10	Рыба	40,0	7,53	0,11	—	31,95	68 судак
11	Колбаса	20,0	2,69	2,84	0,8	40,74	20
12	Хлеб черный	210,0	12,16	0,97	117,75	543,54	210
13	» белый	150,0	8,23	0,93	59,0	284,59	150
14	Сухари	15,0	1,11	0,32	10,79	51,85	15
15	Мука пшеничная	50,0	5,05	0,34	35,79	170,56	50
16	» картофельная	2,0	0,01	—	1,45	6,02	2
17	Рис	20,0	1,3	0,23	14,34	66,3	20
18	Пшено, перловая крупа	10,0	0,74	0,19	6,24	30,32	10
19	Манная крупа	15,0	1,2	0,12	11,05	51,33	15
20	Гречневая »	10,0	0,8	0,16	6,44	31,16	10
21	Макароны	15,0	1,39	0,08	10,9	51,48	15
22	Сахар	90,0	—	—	85,06	348,74	90
23	Горох зеленый	5,0	0,97	0,16	2,52	15,77	—
24	Брюква	20,0	0,14	0,03	1,11	5,38	25
25	Капуста свежая	180,0	1,99	0,27	7,45	41,18	283
26	Морковь	80,0	0,57	0,2	5,94	28,56	100
27	Капуста брусельская	15,0	0,17	0,02	0,62	3,43	20
28	Салат	15,0	0,15	0,03	0,29	2,1	20
29	Лук	10,0	0,11	0,01	0,89	4,16	11
30	Кабачки	65,0	0,7	0,04	2,01	11,6	80
31	Баклажаны	30,0	0,26	0,04	1,17	6,27	37
32	Укроп и петрушка	5,0	0,01	—	0,1	0,82	6
33	Помидоры	50,0	0,30	0,08	1,63	8,72	55
34	Коренья	30,0	0,21	0,51	15,28	68,25	37
35	Щавель	25,0	0,39	0,1	0,7	5,44	30
36	Шпинат	20,0	0,48	0,08	0,59	5,18	25
37	Огурцы свежие и соленые	30,0	0,22	0,03	0,54	3,35	50
38	Картофель	200,0	2,78	0,38	37,15	167,28	280
39	Репка	5,0	0,04	0,01	0,28	1,35	6
40	Капуста	30,0	0,33	0,05	1,24	6,86	40
41	Свекла	50,0	0,75	0,04	4,75	22,94	62
42	Капуста квашеная	5,0	0,04	0,02	0,14	0,89	7
43	Фасоль	3,0	0,58	0,1	0,51	9,46	3
44	Груши сушеные	1,0	0,22	0,02	0,31	2,39	1
45	Тыква	20,0	0,22	0,01	0,61	3,52	25

№ п/п	Наименование продуктов	Вес нетто в г	Белок в г	Жиры в г	Угле- воды в г	Кало- рии	Вес брутто в г
46	Лимон и мандарин	10,0	0,08	—	0,55	2,55	21
47	Ягоды	15,0	0,04	—	9,65	2,83	16
48	Яблоки	80,0	0,22	—	8,74	36,41	80
49	Вишня	10,0	0,08	0,04	0,92	4,41	11
50	Брусника	2,0	—	—	0,14	0,58	2
51	Сухие фрукты	20,0	0,42	—	11,37	48,13	20
52	Груша	35,0	0,08	—	2,96	12,52	38
53	Чернослив	5,0	0,1	0,02	3,41	14,58	6
54	Виноград	6,0	0,04	—	0,82	3,54	7
55	Дыня	20,0	0,12	0,02	1,14	5,37	22
56	Кофе	5,0	—	—	—	—	5,0
57	Чай	1,0	—	—	—	—	1,0
58	Какао	2,0	0,27	0,56	0,53	8,55	2,0
59	Ваниль	—	—	—	—	—	—
60	Уксус	—	—	—	—	—	—
61	Варенье	15,0	—	—	7,69	31,49	15
Всего . . .		—	97,33	95,55	496,89	3326,20	—

Мы придерживаемся следующего расписания: завтрак дается в 8 часов утра, обед в 1 час дня, полдник в 5 часов дня, ужин в 7 часов вечера.

Полезны мясо и рыба всех видов, яйца, мучнистые вещества, всевозможные каши, молоко, сливочное масло и сметана. На 10—12-й день после стационарирования можно постепенно назначать больным вареные овощи — капусту, морковь, картофель, бобы и т. д. Если овощи плохо или совсем не перевариваются (контроль кала!), следует от них воздержаться или вводить их в небольших количествах в виде пюре.

Весьма полезны фрукты, ягоды: яблоки, груши, сливы, вишни, черешни, земляника, черника, в сыром виде. Зимой полезно давать овощные и фруктовые соки: томатный, сливовый, яблочный, виноградный, а также чай из шиповника, который богат витаминами.

Из напитков можно рекомендовать чай, желудочный кофе, кефир, кумыс. Пищевой режим должен строиться таким образом, чтобы первые 5—10 дней больной получал не менее 2500—3000 калорий, а в последующем — от 3500 до 4500 калорий. Необходимо помнить, что часто вследствие интоксикации алкоголем и связанного с этим недоедания организм больного истощается, и уже через несколько дней после отнятия алкоголя у него появляется чрезвычайно большой аппетит, ввиду чего он нуждается в усиленном питании. Даже в тех случаях, когда больной получает ежедневно от 3000 до 3500 калорий, мы все же наблюдаем у него значительную прибавку в весе (на 2—5 кг).

Глава IV

ЗАПОЙ (ДИПСОМАНИЯ)

Запой впервые описан в 1817 г. в Москве врачом Сальватори. Гуфеланд в 1819 г. предложил эту форму алкоголизма называть дипсоманией.

Синдром запоя выражается в непреодолимом страстном влечении к алкоголю и в расстройстве настроения. Часто запой предшествует повышенная утомляемость, плохой сон, беспокойство, чувство страха. И. Н. Введенский описал случаи дипсомании, когда первым предвестником болезни были обонятельные галлюцинации (запах алкоголя). Е. М. Жудро наблюдала у дипсоманов перед запоем появление своеобразных переживаний, напоминающих галлюцинаторные, во время которых больным ярко и образно представлялись картины выпивки, питейные заведения, собутыльники, водка, бутылки, некоторые из них ощущали вкус водки, даже слюни текли. Все это сопровождалось сильным влечением к алкоголю. Изменение настроения не во всех случаях выражается одинаково, однако у большинства больных появляется гнетущая тоска, их все раздражает, все становится им противно, ими овладевает жуткое, невыносимое состояние, аффективная напряженность, нередко чувство страха.

Влечение к алкоголю бывает настолько сильным, что больные, несмотря ни на какие препятствия, запивают и пьют до тяжелой степени опьянения. Алкоголь поглощается в самых разнообразных видах и в огромных количествах — от 1 до 2—4 л. Чаще всего больные пьют водку. Если такой нет, они пьют вино, пиво, наливки, денатурированный спирт, сырец, одеколон, политуру, муравьиный спирт и пр. Нередко, если у них под руками нет никакого алкоголя, они пьют даже керосин.

Во время запоя больные бросают работу, все свои дела, чуждаются людей, легко вступают в ссоры, скандалят. Они теряют аппетит и почти ничего не едят. Язык густо обложен; губы трескаются, приобретают малиново-цианотичную окрас-

ку. Лицо гиперемировано, одутловато. Сон нарушается. Если больные находятся вне дома и больницы, они пропивают все свои деньги, одежду и остаются часто в одном белье.

Подобное состояние длится от 2 до 8 дней. Наблюдаются и более длительные приступы запоя — до 2 недель, а изредка до одного месяца. Приступ запоя кончается так же внезапно, как и начинается. Постепенного снижения доз алкоголя, как это наблюдается при ложном запое или хроническом алкоголизме, не наблюдается. Алкоголь становится противным, настроение больных улучшается. Запой нередко кончается длительным сном. Иногда отмечается частичная амнезия периода запоя. Больных мучают угрызения совести по поводу их «отвратительного пьянства». Они клянутся больше не пить, дают торжественные обещания и питают на этот счет самые благие намерения. Однако через некоторый промежуток времени, исчисляемый неделями, месяцами или даже годами, наступает повторный приступ дипсомании. В светлые промежутки больные ведут обычно трезвый образ жизни и алкогольных напитков не потребляют. В части случаев промежутки между запойными приступами сокращаются, и запойное пьянство может переходить в хронический алкоголизм. Одновременно у части алкоголиков систематическое пьянство может переходить в запойное. В этих случаях нужно думать не об истинной, а о ложной дипсомании.

Причина дипсомании еще окончательно не выяснена, и взгляды на этот счет крайне противоречивы. С. С. Корсаков относил дипсоманию к периодическим психозам, характеризующимся односторонним импульсивным влечением. С. С. Корсаков различал три вида дипсомании: а) ложную, когда имеет место периодическая меланхолия, при которой больной пьет вино лишь для того, чтобы заглушить тоску; б) дипсоманию как выражение дегенерации, проявляющейся в непреодолимом влечении к спиртным напиткам; в) дипсоманию, являющуюся следствием длительного привычного употребления вина, т. е. переход привычного алкоголизма в запойный. Крепелин, Гаупп, Ашаффенбург связывают истинную дипсоманию с эпилепсией, относя ее к кругу эпилептических заболеваний. В. П. Осипов считает, что в основе дипсомании лежит циклофрения. Блейлер указывает, что среди запойных алкоголиков попадаются и шизофреники.

М. О. Гуревич и М. Я. Серейский подчеркивают, что большинство дипсоманов страдает психопатиями или эпилепсией. Наряду с этим, встречаются и лица, страдающие маниакально-депрессивным психозом. В. А. Гиляровский считает, что дипсомания возникает на почве психической дегенерации, наступившей вследствие длительного употребления алкоголя. С. С. Корсаков и впоследствии С. Г. Жислин и П. Г. Земель указывали на переход привычного пьянства в запойное, придавая при

этом значение абстинентному синдрому. Бинсвангер (Binswanger) неправильно считает, что запой возникает лишь у наследственно предрасположенных дегенеративных лиц. В своей практике мы встречали дипсоманию главным образом у тяжелых алкоголиков и у алкоголиков-травматиков, а также дипсоманию, сочетанную с тяжелыми неврозами и психопатиями.

Приступы запоя часто возникают в связи с травмой головного мозга.

Возникает это заболевание в зрелом возрасте — в 30—40 лет. Описаны случаи начала заболевания и в более раннем, даже юношеском возрасте.

Дипсомания является довольно редким заболеванием. Согласно нашим данным, она составляет 3% алкогольных заболеваний, а в настоящее время встречается еще реже.

Течение. При длительном существовании болезни промежутки между запоями во многих случаях сокращаются, и запойные приступы сменяются систематическим пьянством со всеми симптомами хронического алкоголизма. Иногда во время запоя или вскоре после него больные кончают жизнь самоубийством. В части случаев наблюдается выздоровление.

Дифференциальный диагноз. Диагностика дипсоманий не встречает затруднений. Расстройство настроения, безудержное влечение к вину и удовлетворение этого влечения, несмотря ни на какие препятствия, внезапное начало запоя и такой же конец, контрастная разница в поведении в периоды запоя и в промежутках между ними не дают повода смешивать это заболевание с хроническим алкоголизмом или псевдодипсоманией.

В светлые промежутки дипсоманы не пьют и ведут нормальный образ жизни; трудоспособность их восстанавливается. Несмотря на ясно выраженную клиническую картину дипсомании, многие врачи не распознают ее, направляя в лечебницу больных хроническим алкоголизмом с диагнозом дипсомании, хотя они таковой никогда не страдали.

Лечение. Каждый больной дипсоманией должен подвергаться тщательному лечению, ибо в противном случае заболевание может прогрессировать, переходя в хронический алкоголизм. В тех случаях, когда мы вправе предполагать эпилепсию, рекомендуются препараты люминала в дробных дозах, сромистые препараты, аутогемотерапия и протеинотерапия. Больные должны вести правильный образ жизни, не допуская никаких излишеств, избегая переутомления. Большую роль может сыграть лечебное питание, витаминотерапия. Когда у больных появляются предвестники запоя, рекомендуется их стационаризовать в условиях лечебного учреждения.

В некоторых случаях запоя хороших результатов удавалось достигнуть с помощью лечебного сна и инсулинотерапии.

Инсулин назначают по 5—20 ИЕ ежедневно в течение 2—3 недель. Лечебный сон по 12—15 часов в сутки проводится в течение 3—5 дней. При этом утром делают инъекции инсулина, после чего назначают пролонгированный сон.

Одновременно в пищевой рацион рекомендуется ежедневно вводить по 200—300 г сахара.

Лечебный сон вне зависимости от этиологии запоя проводят с помощью амитал-натрия, нембутала, бромурала, паральдегида и т. п. В этот же период показано вливание 40% раствора глюкозы по 10 мл и 40% раствора уротропина по 4—5 мл ежедневно в течение 8—10 дней. Больным назначают десятиминутные теплые (37°) солено-хвойные ванны и общее облучение кварцем.

В тех случаях, когда дипсомания является следствием хронического алкоголизма, ее лечат, как хронический алкоголизм.

Глава V

АЛКОГОЛЬНАЯ ЭПИЛЕПСИЯ

Алкогольную эпилепсию описал впервые Магнус Гусс (Magnus Huss) в монографии о хроническом алкоголизме. С. С. Корсаков описывал алкогольную эпилепсию как одно из проявлений алкогольной дегенерации потаторов, подчеркивая, что, наряду с припадками эпилепсии, бывают припадки головокружения, обмороки. Крепелин, Братц, Блейлер, М. О. Гуревич, М. Я. Серейский, С. Г. Жислин считают алкогольную эпилепсию самостоятельным заболеванием, развивающимся на почве хронического алкоголизма. Бинсвангер, Гауерс и др. воздерживаются от суждения о связи алкоголя с алкогольной эпилепсией. Несмотря на противоречия во взглядах относительно алкогольной эпилепсии, почти все исследователи приходят к выводу, что алкоголь является одним из самых сильнодействующих средств, провоцирующих судорожный припадок.

Алкогольная эпилепсия обычно развивается у больных алкоголизмом в тяжелой степени, т. е. у лиц, употребляющих большие дозы алкоголя в течение длительного срока.

Основную роль в этиологии алкогольной эпилепсии играет алкоголь, но, наряду с этим, имеют значение и другие дополнительные, но не обязательные факторы. К их числу относятся травмы, хронические инфекционные болезни, например, малярия, физическое истощение вследствие ненормального питания, психическая травма, а также резкое нарушение обмена веществ, вызванное алкоголем. К алкогольной эпилепсии следует также отнести припадки, сопровождающие почти в $\frac{1}{3}$ случаев белую горячку, а также припадки, наблюдаемые при корсаковском психозе.

Алкогольная эпилепсия есть разновидность симптоматических, токсических эпилепсий. Обычно по прекращении пьянства она проходит.

Нам в специальной клинике редко приходилось наблюдать развитие алкогольной эпилепсии после 6—7 дней воздержания от алкоголя. Некоторые авторы (Братц) считают, что алко-

гольная эпилепсия может проявляться в промежутке до 2 недель после воздержания от алкоголя. Припадки наблюдаются главным образом после приема значительных доз алкоголя, в несколько раз превышающих привычную дозу.

Клиническая картина. В состоянии опьянения или похмелья, часто после предшествующего алкогольного эксцесса, у больных появляются эпилептиформные припадки. С. Г. Жислин считает, что припадки развиваются главным образом в состоянии похмелья. Бонгеффер указывает, что припадки развиваются главным образом после опьянения. В. А. Гиляровский отмечает судорожные припадки у алкоголиков при опьянении, считая их судорожной формой реакции нервной системы на отравление. Согласно нашим наблюдениям, алкогольно-эпилептиформные припадки развиваются у большого числа алкоголиков при опьянении и у несколько меньшего числа в состоянии похмелья. Братц подчеркивает, что первые припадки развиваются во время опьянения, а затем они могут не зависеть от такового, появляясь и по прекращении опьянения, но не позже 14-го дня после приема алкоголя. Мы наблюдали эпилептиформные припадки у алкоголиков, находившихся в состоянии опьянения. Эти припадки протекали, то как настоящие эпилептиформные, то в виде обмороков, сопровождаясь незначительными судорогами, то в виде децеребрационной ригидности, описанной Д. С. Футером. Атипичность таких припадков можно объяснить наркотизирующим влиянием алкоголя на кору мозга. В состоянии похмелья припадки обычно возникают без предшествующей ауры. Больные без крика, часто со стоном падают как подкошенные и теряют сознание. Лицо вначале бледнеет, но вскоре приобретает цианотичный оттенок. Тело покрывается холодным потом, конечности холодеют, зрачки расширяются и не реагируют на свет. Сухожильные рефлексы отсутствуют. Судороги выражены несколько слабее, чем при genuинной эпилепсии. В начале припадка отмечаются тонические судороги, длящиеся 20—40 секунд и переходящие в клонические. Дыхание неровное, нередко хрипящее. Изо рта выступает пена. Нередко большой прикусывает язык. Пульс учащается. Непроизвольное мочеиспускание и дефекация большей частью происходят во время припадков в пьяном виде. В состоянии похмелья они встречаются редко.

Эпилептический припадок длится 3—5 минут и переходит в сон, который бывает особенно глубоким и длительным при опьянении. У алкоголиков после припадков, наступивших в трезвом состоянии или в состоянии похмелья, отмечается сонливость или кратковременный сон в течение 20—30 минут. По пробуждении больные о припадке не помнят. Припадки могут повторяться даже в течение дня, но это бывает редко.

В редких случаях может развиваться и настоящий status epilepticus. Изучая несколько сот больных алкогольной эпилепсией, мы отмечали status epilepticus лишь у двух, причем у одного больного, наряду с алкоголизмом, в анамнезе имелась травма головного мозга.

Течение алкогольной эпилепсии доброкачественное. Она не дает эпилептических изменений личности, слабоумия, сумеречных состояний и т. д. В случаях алкогольной эпилепсии прогноз благоприятный при условии абсолютного воздержания от алкоголя. Однако у лиц, продолжающих злоупотреблять алкоголем, припадки не прекращаются. Они появляются как в состоянии опьянения и похмелья, так и в трезвом виде.

Припадки бывают редко, но протекают крайне тяжело. С. Г. Жислин разделяет алкогольную эпилепсию на четыре группы: 1) алкогольные эпилептические припадки, которыми сопровождается белая горячка; 2) припадки, возникающие в состоянии опьянения или похмелья; 3) припадки, развивающиеся исключительно в состоянии похмелья; наряду с этим, отмечаются также припадки в светлые промежутки, вне всякой зависимости от приема алкоголя; эти случаи относятся к эпилептической болезни с доброкачественным течением; 4) случаи комбинации симптоматической эпилепсии при органическом поражении головного мозга с алкогольной интоксикацией.

Однако настоящей алкогольной эпилепсией можно назвать лишь две первые группы, что подчеркивает также и С. Г. Жислин. Две другие формы эпилепсии представляют интерес лишь постольку, поскольку отражают влияние алкоголя на течение этих эпилепсий и являются иллюстрацией того, как добавочные вредные факторы в виде алкоголя провоцируют эпилепсию, находившуюся в латентном состоянии.

Алкогольная эпилепсия характеризуется типичными эпилептиформными припадками, при которых часто можно проследить ауру, клонические и тонические судороги, прикусывание языка, недержание мочи и кала с последующими сном и амнезией.

При сочетании алкогольной и других эпилепсий эпилептические симптомы сохраняются и после длительного воздержания от алкоголя, в то время как алкогольная эпилепсия при воздержании от алкоголя вскоре проходит. Братц по этому поводу категорически заявляет, что «никогда не бывает припадка, если больного на продолжительное время лишить алкоголя».

Дифференциальный диагноз может представлять некоторые затруднения. Иногда доброкачественно протекающая эпилептическая болезнь может дать повод к смешению ее с алкогольной эпилепсией. В период злоупотребления алкоголем подобная эпилепсия может обостряться, в светлые же промежутки она переходит в латентную форму, почему и создается впечат-

ление, будто причиной этой эпилепсии является алкоголь. Однако при тщательном исследовании таких больных можно установить, что припадки или намеки на сумеречные состояния наблюдались у них еще в раннем детстве. Некоторую трудность может представить диагностика эпилепсии у лиц, страдающих органическим заболеванием центральной нервной системы и злоупотребляющих алкогольными напитками. Алкоголь, конечно, может вызвать органические изменения в мозгу, обуславливающие возникновение припадков. Однако нет никакого основания относить эти припадки к алкогольной эпилепсии. Органические изменения центральной нервной системы вызываются также многочисленными факторами — инфекцией, возрастными изменениями, травмами и т. п. У таких больных эпилептиформные припадки продолжаются и по прекращении приема алкоголя. При постановке диагноза следует всегда учитывать, что в случаях алкогольной эпилепсии отсутствует характерная эпилептическая деградация, вязкость, злобность, раздражительность, характерное слабоумие, сумеречные состояния, припадки в виде *petit mal*. Кроме того, при алкогольной эпилепсии после прекращения потребления алкоголя припадки вскоре (не позже 2 недель) прекращаются.

Обмен веществ и изменения в картине крови. Во время и после припадка при алкогольной эпилепсии мы обнаруживали гипогликемию, понижение содержания аскорбиновой кислоты, снижение в крови количества холестерина, кислорода и повышение углекислоты. Содержание остаточного азота оставалось в пределах нормы, в то время как при эпилептической болезни отмечается задержка азота. Понижение сахара в крови зависит, повидимому, от нарушения функций поджелудочной железы, а также от расстройства функции печени, являющейся своего рода углеводным депо. Очевидно, недостаток сахара обуславливает тяжелое расстройство клеточного обмена, а это расстройство в свою очередь ведет к появлению патологических продуктов межклеточного обмена, вызывающих судороги.

Тяжелые изменения отмечаются также в крови. Количество гемоглобина и эритроцитов снижается. В тех случаях, когда припадки возникают в состоянии похмелья, наблюдается гиперлейкоцитоз. У больных, потребляющих огромные дозы алкоголя, отмечается лейкопения, причем припадки у них наступают в основном при опьянении. После припадка лейкоцитоз всегда выражен больше, чем до припадка. У части больных отмечается ядерный распад. Нередко обнаруживаются также миелоциты, отсутствующие в норме. Число юных лейкоцитов увеличивается от 1 до 90%. Возрастает и количество палочко-ядерных лейкоцитов, колеблющееся между 6 и 17%. Число лимфоцитов в отдельных случаях увеличивается до 50%. Отмечается гипоеозинофилия. РОЭ в большинстве случаев

вначале понижается, затем, через 5—6 дней после припадка, снова повышается.

Из приведенной картины крови видно, что при алкогольной эпилепсии в организме больных имеются какие-то токсины.

Наличие значительного числа юных нейтрофильных лейкоцитов указывает на регенеративный сдвиг в крови. При эпилептической болезни в тех случаях, когда приступ заканчивается смертью, по данным Баклушинского, эозинофилы во время приступа отсутствуют, число лейкоцитов уменьшается в 4—5 раз, а количество гемоглобина и эритроцитов снижается буквально за несколько часов. При обычных эпилептиформных приступах количество эритроцитов снижается перед припадком, эритроциты изменяют форму, принимая в тяжелых случаях неправильные очертания — грушевидную форму с зазубренными краями или форму тутовой ягоды. Лимфоциты и одноядерные лейкоциты к началу приступа достигают максимума. К концу приступа развивается лейкоцитоз. Обратное развитие патологических сдвигов в крови после припадка генуинной эпилепсии заканчивается в течение 20 часов. В гемограммах больных эпилептической болезнью и алкогольной эпилепсией наблюдается очень много общего, а именно лейкопения, гипоеозинофилия до припадка и гиперлейкоцитоз после припадка. Однако между ними имеется и существенная разница; например, при эпилептической болезни обратное развитие патологического сдвига гемограммы заканчивается за 20 часов, тогда как при алкогольной эпилепсии этот срок удлиняется до 2—3 месяцев. В случаях эпилептической болезни гиперлейкоцитоз обусловлен увеличением числа нейтрофилов и лимфоцитов, тогда как при алкогольной эпилепсии это увеличение идет за счет юных и палочкоядерных форм и частично лимфоцитов. Форма эритроцитов при алкогольной эпилепсии в противовес эпилептической болезни не меняется, зато количество их уменьшается во много раз больше, чем при эпилептической болезни. Мы наблюдали, что артериальное кровяное давление до припадка алкогольной эпилепсии бывает понижено, а после припадка — повышено.

Лечение. Радикальным средством в борьбе с алкогольной эпилепсией является немедленное лишение больных алкоголя. Из симптоматических средств вначале можно давать препараты брома, дифенин, люминал. Уже одной такой меры, как прекращение употребления алкоголя, достаточно для излечения алкогольной эпилепсии. Больным навсегда категорически воспрещается употреблять спиртные напитки.

Больных алкогольной эпилепсией лечат в последующем так же, как и больных хроническим алкоголизмом. При развитии *status epilepticus*, который может возникать у алкоголиков в основном с органическим поражением центральной нервной системы, необходимо принимать серьезные меры, так как без

должного вмешательства это состояние нередко заканчивается смертью.

В таких случаях назначают клизмы из барбамилы, или из хлоралгидрата; внутривенно вводят бромистый натрий, хлористый кальций, сернокислую магнезию, дают сердечные средства; иногда полезна спинномозговая пункция с выпусканьем 15—20 мл ликвора. В тяжелых, почти безнадежных случаях status epilepticus, наблюдавшихся в нашей практике, удавалось спасти больных путем введения им *per os* или посредством клизмы 30—40° алкоголя в количестве 100—200 мл с одно-временными внутривенными вливаниями 40% раствора глюкозы по 10—20 мл. Механизм действия алкоголя и глюкозы в таких случаях не вполне ясен, однако эффект достигается исключительный. Ф. Ф. Детенгоф отмечает благоприятное воздействие на эпилептический статус ацетилхолина.

Rp. Acetylcholini hydrochlorici 0,1
Aq. destill. 10,0
MDS. По 5 мл внутримышечно в ягодицу

Н. И. Репин рекомендует внутривенное введение 20 мл свежеприготовленного 0,1% марганцовокислого калия.

Глава VI

БЕЛАЯ ГОРЯЧКА

Белая горячка представляет собой остро протекающий психоз, развивающийся главным образом у лиц, злоупотребляющих алкоголем. Алкогольная этиология белой горячки до последнего времени всеми признавалась как незыблемая истина. Лишь в последние годы на основании изучения сравнительно обширного материала стали отрицать исключительно алкогольную этиологию белой горячки. Это заболевание может наблюдаться также при хроническом отравлении снотворными средствами (паральдегидом, вероналом, хлоралгидратом и др.).

Белая горячка наблюдается как у лиц, длительно злоупотребляющих алкоголем, так и у сравнительно молодых людей, употребляющих алкоголь в течение лишь нескольких лет.

Приступ белой горячки часто провоцируется добавочными вредностями; к таковым относятся всевозможные инфекционные заболевания, воспаление легких, заболевания желудочно-кишечного тракта, психические и физические травмы и т. п. Предполагали, что белая горячка может возникнуть в результате внезапного лишения больного алкоголя; однако большой практический опыт и стационаров для алкоголиков, и психиатрических больниц, где больных лишают алкоголя сразу, не дает никаких оснований опасаться абстинентного делирия, чего так опасаются некоторые врачи.

В специальной лечебнице для алкоголиков, где за период с 1930 по 1952 г. лечилось свыше 20 000 человек, мы не наблюдали ни одного случая белой горячки, вызванного прекращением употребления алкоголя.

Патогенез белой горячки, как и других алкогольных психозов, еще недостаточно ясен. Белая горячка является токсическим психозом, но о характере вызывающих ее токсинов мы знаем очень мало. Однако можно с полной уверенностью сказать, что эти токсины появляются только после длительного злоупотребления алкоголем. Некоторые авторы, например, Герц (Herz), причиной белой горячки считали острую почеч-

ную недостаточность. Частое совпадение белой горячки с инфекционными заболеваниями давало повод Якобсону (Jacobson), Долькен (Dollken), Эльсгольц (Elsholz) предполагать ее инфекционную сущность. Тулуз указывал, что причину белой горячки следует искать в энцефалите, вирус которого еще неизвестен; Бонгеффер (Bonhoeffer) и Якобсон основную роль отводили кишечному яду. Крепелин, видя в белой горячке метаалкогольное заболевание, сравнивает ее с диабетической комой и предполагает в таких случаях отравление продуктами неправильного обмена веществ. Бострем (Bostroem), Бинсвангер (Binsvanger) приписывают большую роль нарушению дезинтоксикационной функции печени вследствие воздействия на нее алкоголя. Некоторые авторы усматривают в белой горячке простое обострение хронического алкоголизма [Розе (Rose) и др.], другие предполагают, что при хронической интоксикации алкоголем образуется особый токсин, вызывающий белую горячку, причем противоядием опять-таки является алкоголь, и объясняют таким образом возникновение абстинентного делирия.

Полиш (Pohlisch), Зуков (Sucov), Бюхлер (Büchler) считают, что существует переход от хронического алкоголизма к белой горячке, которая является его завершением, ибо при *delirium tremens* организм отказывается выполнять предъявляемые к нему требования. Шредер (Schreder), Мэрло (Meerlo), Бострем полагают, что индивидуальное предрасположение к белой горячке следует приписать главным образом центральной нервной системе, конституции и наследственности. Однако проведенные в этом плане исследования Полиша этого не подтвердили, не подтверждают взглядов этих авторов и наши наблюдения. С другой стороны, некоторые авторы, например, Якобсон, полагают, что, наряду с изменениями, вызванными алкоголем, существует еще другой фактор, который образует так называемый токсический плюс, подкрепляя это положение тем фактом, что большое количество *delirium tremens* осложняется различными болезнями (пневмония, плеврит, травма, острые тяжелые заболевания и т. п.).

Полиш показал, что тяжелое нарушение обмена веществ (альбуминурия, уробилинурия, повышение ацетона в плазме крови, индиканемия, билирубинемия, увеличение кетоновых тел) обуславливает *delirium tremens*. В меньшей степени он находил эти нарушения и при хроническом алкоголизме, белая же горячка является «вершиной» хронического алкоголизма. Большую роль в патогенезе алкогольных психозов отводят авитаминозу, особенно дефициту витаминов комплекса В.

Проводя ряд биохимических исследований при белой горячке, мы совместно с Е. В. Афанасьевой (1934) в дистиллятах крови, мочи и спинномозговой жидкости обнаружили значительное содержание редуцирующего вещества, отлича-

шегося от алкоголя тем, что оно перегонялось при более низкой температуре и давало почти все реакции, характерные для альдегидов. Альдегидоподобные вещества нам удалось обнаружить как в выраженных случаях белой горячки, так и у тяжелых алкоголиков в первые 1—2 дня после лишения их алкоголя и при остром алкогольном галлюцинозе. Очевидно, в некоторых случаях у хронических алкоголиков нарушается окисление алкоголя. Эти недоокисленные продукты, особенно ацетальдегид, будучи токсичнее, чем алкоголь, достигнув известной концентрации, в сочетании с каким-то еще другим неизвестным нам токсином могут вызывать тот или иной алкогольный психоз.

Уместно вспомнить, что, по мнению Кравкова, альдегиды обладают очень высокой токсичностью, являясь одним из самых ядовитых соединений жирного ряда. Лекок (1954) указывает, что в патогенезе алкогольных психозов играет роль повышение содержания пировиноградной кислоты в крови, которая образуется при этом не только за счет распада алкоголя, но и вследствие нарушения углеводного обмена, обусловленного нарушением функции печени. Лекок полагает, что количество пировиноградной кислоты при алкогольных психозах может превышать 20 мг^г/о в крови, которая в норме не превышает 3—6,5 мг^г/о.

Нейродинамику у больных белой горячкой изучала М. И. Середина, которая обнаружила фазовые явления как в первой, так и во второй сигнальной системе, в зрительном и слуховом анализаторах. При словесном эксперименте у всех больных отмечалась эхолалия, т. е. наиболее элементарная словесная связь, связь слова с самим собой, что свидетельствовало о глубоко разлитом торможении во второй сигнальной системе. Наличие фазовых явлений в первой сигнальной системе и глубокое разлитое торможение во второй ведут к тому, что последняя утрачивает свой контроль, свое регулирующее влияние на первую сигнальную систему. Двигательный анализатор при этом не заторможен, как в физиологическом сне, а находится в полубодствующем состоянии и в своей деятельности почти полностью подчинен первой сигнальной системе, что клинически выражается в галлюцинаторном поведении, — поступках, высказываниях больных. Это торможение является следствием тяжелой алкогольной интоксикации и имеет характер охранительного. Особенно глубоко и длительно оно захватывает более молодую в эволюционном отношении вторую сигнальную систему.

Клиническая картина. Белой горячке часто предшествуют продромальные явления, которые удерживаются от нескольких недель до нескольких месяцев. Больные становятся беспокойными, пугливыми, легко раздражаются. Настроение тоскливое, нередко появляется немотивированный страх. Осо-

бенно значительны нарушения сна. Сон становится беспокойным, укорачивается. Сновидения кошмарные, яркие; больным снятся лошади, верблюды, звери, движущиеся, как в калейдоскопе, или набрасывающиеся на них, чудовища, не существующие в природе. Под влиянием таких сновидений больные в испуге просыпаются, кричат, пытаются бежать.

Отмечается понижение или полная потеря аппетита, тяжесть в голове или головная боль. Тремор рук усиливается. Кровяное давление несколько повышается. У части больных появляется понос или запор. С. Г. Жислин указывает на эмоциональное и психомоторное оживление, некоторую эйфоричность, которые сменяют общий депрессивный фон и однообразную тревожную окраску настроения в состоянии похмелья.

За 2—5 дней перед началом белой горячки все описанные продромальные явления нарастают. В этот период у больных нередко появляется отвращение к алкоголю, вследствие чего они прекращают пить. Описаны случаи, когда потребление алкоголя не прерывалось и в разгар белой горячки. Однако, наблюдая большое количество больных, мы ни разу не видели, чтобы в этот период они потребляли большие количества алкоголя. Белая горячка может возникнуть и без продромальных явлений, внезапно, обычно в ночное время, а иногда при абсолютной бессоннице.

Симптомокомплекс этого заболевания в основном сводится к затемнению сознания, зрительным и в меньшей степени к слуховым и осязательным галлюцинациям, полной дезориентировке в месте и времени при сохранности ориентировки относительно своей личности, к бреду, сильному дрожанию, атаксии, резко выраженному беспокойству, отвлекаемости, своеобразному страху в сочетании с юмором, бессоннице и ряду вегетативных расстройств. Больные не только дезориентированы, но и ложно ориентированы. Больницу они принимают за общежитие, пивную — ресторан и т. п., персонал больницы и соседей по койке — за своих друзей, знакомых или за лиц, которые под видом больных шпионят, следят за ними и пр. Сознание личности сохраняется. Даже во время самых причудливых делириантных переживаний больные правильно отвечают, кто они, называют свое имя, отчество, профессию, говорят свой адрес и т. д.

Центральное место в картине белой горячки занимают своеобразные галлюцинации, главным образом зрительные (рис. 19). Галлюцинации воспринимаются больным то как реальная действительность, то как искусственные изображения, напоминающие кинематографические. Видения обычно бывают множественными, обнаруживающими большую подвижность и склонность к уменьшению. Больные видят паутина, проволоку, нити, пыль, хлопья, струи газов или воды, шарики, монеты, искры, тени, кружки, бутылки, рюмки и т. п. Особенно

часто они видят различных животных: крыс, мышей, зайцев, кошек, собак, быков, коз, обезьян. Им представляются куры, утки, гуси, рыбы, змеи, черви, пауки, клопы, тараканы и т. д. Часто больные видят нереальные, сказочные существа: чертей, смерть, скелеты, разного рода уродов, рожи, колдунов, леших

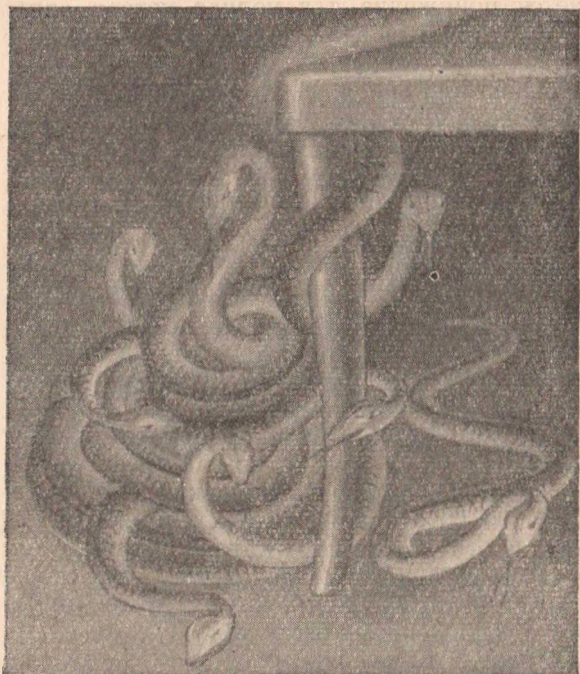


Рис. 19. Зрительные галлюцинации при белой горячке. Больному представилось много змей, свившихся в клубок возле стула.

или чудовищ. Все это оживленно движется, изменяется, принимая причудливые формы, хотя окраска этих кажущихся существ и предметов не так ярко выражена (рис. 21, 22).

В свое время в Москве шла картина «Человек-невидимка». Смотревшие эту картину алкоголики при заболевании белой горячкой в галлюцинаторных переживаниях видели много людей-невидимок.

Кажущиеся предметы, люди, животные, насекомые и т. д. исчезают, расплываются и видоизменяются: то змея с горящими глазами движется на больного и, не доползая до него, превращается в уродца, который корчит рожи; уродцы дразнят, пляшут, то увеличиваясь, то уменьшаясь, и вдруг исчезают через раздвинувшиеся стены. Потолки раздвигаются, лягушки



Рис. 20. Зрительные галлюцинации при белой горячке.



Рис. 21. Зрительные галлюцинации. Рожа вылезала из-под кровати.

прыгают, куры летают, толпы народа пляшут или угрожают больному. Все движется, изменяется, как в кино.

Иногда больным представляются толпы народа, сражения, движущиеся войска, окровавленные головы, отрубленные части тела, покойники, маскарад, балетные представления, ярмарки, драки и т. п. Нередко им кажется, что их помещение окружают, на них наставлены сотни револьверных дул, лес



Рис. 22. Зрительные галлюцинации. Чудовище вылезало из-под пола.

штыков, в комнату врываются незнакомые люди, избивают их прикладами, плетями и снова исчезают. Около койки им роют могилу. Собираются распилить их тело деревянной пилой. Во дворе они видят эшафот и приготовления к их казни. Больным кажется, что их окружают злоумышленники, которые завели их в ловушку с тем, чтобы пропустить на фарш через мясорубку или сварить из них мыло.

Жену больного насилует банда. Толпа людей шарахается от ужаса при виде его изрубленных детей. В соседней комнате четвертуют его родственников. Он слышит их стоны и крики о помощи. Пол шатается, стены раздвигаются, потолок валится и т. п.

Д. С. Озерецковский наблюдал алкоголика, который, буду-

чи слепым в течение 25 лет, внезапно «прозрел», заболев белой горячкой. Ему мерещились черти и всякие живые существа.

Наряду со зрительными галлюцинациями, но в значительно меньшей степени встречаются и слуховые галлюцинации.

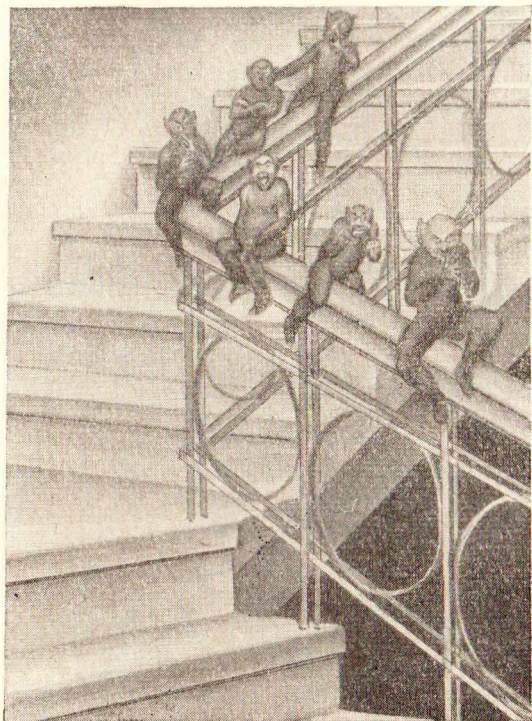


Рис. 23. Зрительные галлюцинации. Маленькие уродцы не пускали на лестницу, дразнились и насмехались над больным.

Больные слышат шорох, шипение, треск, гудение, чириканье птиц, музыку, пение, шум, крик, иногда пронзительный, пальбу, лязг оружия, звон колоколов. Иногда слышатся голоса, речь, стоны, крик, которые больной воспринимает непосредственно как натуральные или как передаваемые по радио. Голоса обычно угрожающего характера, то бранящие, то укоряющие. Голоса называют больного вредителем, дураком, негодяем, пьяницей, вором, убийцей, растратчиком. Они угрожают взять его, убить, кастрировать. Голоса кричат, что он преступник, что его надо казнить. Ему зачитывают смертный приговор¹.

¹ Рисунки с 19 по 23 нарисованы художником С., перенесшим белую горячку.

Больные слышат стоны и крики людей, которых насилюют, режут, подвергают инквизиции. В некоторых случаях отмечаются обонятельные галлюцинации: больные ощущают запах

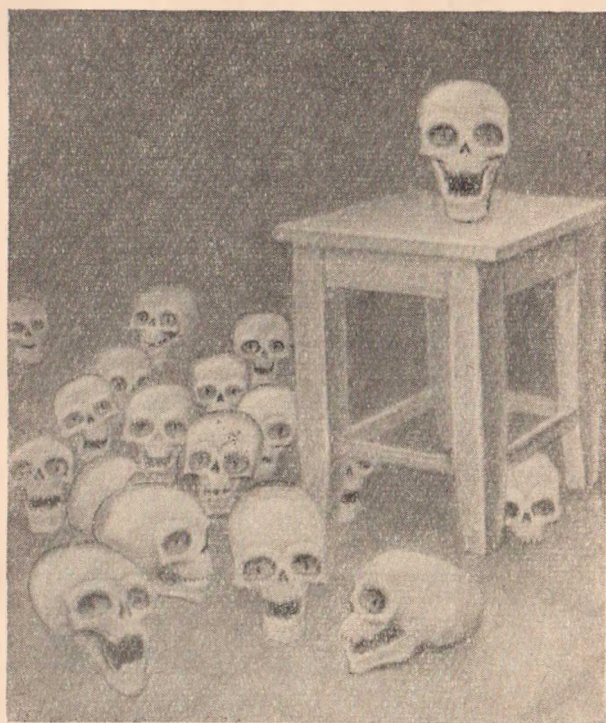


Рис. 24. Зрительные галлюцинации. Больному казались как бы ожившие черепа, которые насмехались над ним.

горящей серы, удушливых газов и т. п. Встречаются и вкусовые галлюцинации, и галлюцинации кинестетических ощущений. Больному кажется, что под ним качается постель, что она поднимается в воздух, пол шатается, стены нависают и т. п. Отмечаются и осязательные галлюцинации, которые иногда можно объяснить наличием у них невритических парестезий. Больному кажется, что их мучают паразиты, в тело их вонзают острые предметы, проволоку, их обрызгивают водой, окуривают газами и т. п. Галлюцинации отдельных чувств легко переплетаются между собой, например, больной не только видит мелких зверей, насекомых и т. п., но и осязает их. Он обороняется от галлюцинаторных образов, нападающих на него, ловит их, дерется с ними, взывает о помощи.

Наряду с галлюцинациями отмечаются обильные иллюзорные восприятия, чаще зрительные (рис. 27).

Больные не узнают окружающих, читают неверно, продуцируя нелепости, или вставляют неверные слова, до некоторой степени ассоциативно связанные с неверно прочитанным словом. При белой горячке почти всегда удается внушить больному обманы чувств. Если сказать, что ему в руки положен клубок и приказать размотать его, то больной до тех пор будет это делать, пока в силу присущей ему большой отвлекаемости не переключится на другие галлюцинаторные переживания.

В. М. Бехтереву удавалось вызывать стойкие зрительные и слуховые галлюцинации даже после окончания белой горячки, заставляя больных всматриваться в блестящие предметы или прислушиваться к работе индукционного аппарата (симптом Бехтерева).

При надавливании на глазные яблоки при закрытых глазах больные видят то, что им внушают: зверей, людей, насекомых и т. д. (симптом Липмана). Этот симптом обнаруживается как до развития белой горячки, так и в делириозном, и в постделириозном состоянии.

Если больному вручить лист белой, совершенно чистой бумаги и спросить, что он видит на ней, он называет отдельные буквы, фразы, числа и даже целые картины. Если включить телефон и предложить больному поговорить, то он долго говорит с воображаемыми друзьями. Обычно содержание разговора относится к событиям, внушающим ему опасения (за жену, семью и т. п.), или же к профессиональным занятиям больного.

Мы вызывали обильные зрительные галлюцинации, заставляя больного пристально смотреть в зеркало, причем содержа-



Рис. 25. Зрительная иллюзия. Электрическая лампочка на потолке казалась ожившей, похожей на фигуру человека.

ние этих галлюцинаций удавалось внушать в желаемом направлении.

Такие обманы чувств легко удается вызывать благодаря исключительно высокой внушаемости больных, находящихся в делириозном состоянии.

Нередко достаточно бывает лишь спросить больного о том, что он чувствует, видит и слышит, чтобы вызвать у него целый ряд соответствующих обманов восприятий.

Обманы чувств у таких больных не прибавляются к картине окружающей обстановки, а как бы вытесняют ее.

Е. Крепелин подчеркивает, что сочетание разнообразнейших обманов чувств, образующих беспорядочную цепь делириозных переживаний, и представляет основную особенность белой горячки. Он пишет: «Процессы протекают совершенно как во сне, только, повидимому, несравненно ярче, так как сознание затемнено лишь умеренно, между тем как обманы обладают, очевидно, высшей чувствительной ясностью».

Восприятие больных белой горячкой резко расстраивается. Нередко они не обращают внимания на цвет и вместо видимого предмета называют другой. Объясняется это тем, что, несмотря на правильное узнавание предмета, вместо него в сознании больного появляется другой, быстро ассоциирующийся с воспринятым образом. Запоминание слов, цифр резко понижено.

Определение промежутков времени резко нарушено, так же как и ориентировка в месте и времени.

Течение мыслей несколько нарушено, хотя спутанности не отмечается. Наблюдается крайняя отвлекаемость. Достаточно отвлечения внимания больного случайным впечатлением, как ход мыслей прерывается и направляется по иному пути. Больные не замечают элементарных противоречий. Критика отсутствует, что особенно подчеркивается при наличии нелепых галлюцинаций.

Так, больной может уверять, что жену его насиловали разбойники, распороли ей живот, дважды отрубили голову, причем тут же он заявляет, что слышит ее голос. У больных совершенно отсутствует способность быстро ориентироваться и разобраться в сложной ситуации. Память на данные события обычно не нарушается и ранее приобретенные знания не утрачиваются. Значительно расстраивается память на события ближайшего прошлого. Переживания делириозного периода они вспоминают лишь частично, порядок переживания во времени исчезает из памяти. Нередко возникают также конfabуляции: больные часто рассказывают о том, чего с ними никогда не было.

Аффективные проявления соответствуют переживаемому бреду. Вследствие этого настроение больного в большинстве случаев тревожное, пугливое. Специфической чертой со сторо-

ны аффективной сферы считается сочетание своеобразного юмора со страхом.

Несмотря на то, что галлюцинаторные переживания не столько занимают, сколько мучают больных, настроение их часто носит эйфорическую окраску. В соответствии с быстрой сменой делириозных переживаний изменяется и настроение.

Под влиянием смертельного страха больные вызывают о помощи, а через несколько мгновений, уже под наплывом забавных, смешных галлюцинаторных образов, смеются и гримасничают. Иногда под влиянием переживаний (страх и др.) больные могут совершать опасные нападения или попытки к самоубийству. Это всегда необходимо иметь в виду.

Поведение больных при белой горячке чрезвычайно характерно. На первый план выступает большое беспокойство. Они не могут сидеть на одном месте или лежать в кровати; их много раз укладывают в кровать, но они тут же вскакивают. Поведение больных обычно адекватно галлюцинаторным переживаниям: то они ловят кур, цыплят, то гоняют собак. Моторика их крайне оживлена. Все время они чем-то заняты, разговаривают с галлюцинаторными образами. Нередко наблюдается бред профессиональных занятий, при котором больные занимаются привычным для них делом: мясники рубят, развешивают, отпускают покупателям мясо; фармацевты готовят лекарства; сапожники чинят сапоги; столяры строгают и т. п. Вследствие измененного состояния сознания и из-за наличия галлюцинаций больные не в состоянии заняться чем-нибудь, находясь во власти галлюцинаторных образов, они осторожно переступают через воображаемую проволоку, тянут изо рта нити, сбрасывают с себя насекомых. В других случаях они возятся с одеждой, непрерывно завязывают узелки или проделяют с ней различные манипуляции, причем рубашку могут надевать как брюки. Нередко в порыве страха они ломаются в дверь, пытаются бежать или выбивают стекла и выбрасываются из окна.

Нам приходилось наблюдать случаи, когда больные с поразительной ловкостью, как акробаты, вскакивали на подоконник и убежали через фрамуги окон.

Охваченные сильнейшим двигательным беспокойством, больные говорят мало. Бредовые идеи при белой горячке тесно связаны с галлюцинациями, о чем можно судить по отдельным высказываниям больных. Так, иногда больному кажется, что его преследуют, хотят заманить в ловушку, уничтожить, подвергнуть мучительной казни и т. п. Однако этот бред носит отрывочный характер, ибо систематизации его не отмечается. Бредовые идеи величия, ипохондрический бред и интерпретивный бред не свойственны белой горячке. Галлюцинаторные

переживания больные воспринимают как реальную действительность.

В начале заболевания больные с бредовыми идеями преследования, утратившие критическое отношение к своему состоянию, нередко просят защиты у милиции. Иногда же, вооружившись чем-либо, они баррикадируются у себя в комнате, прячась от мнимых преследователей, выскакивают в окно, спрыгивают на ходу с трамвая, бросаются в реку, под поезд и т. д.

Один больной, испугавшись врача, пришедшего его освидетельствовать, тут же застрелился у него на глазах. Поэтому при осмотре таких больных на дому всегда следует соблюдать сугубую осторожность.

Наиболее характерным физическим симптомом при белой горячке является резко выраженное дрожание расставленных пальцев рук, которое может распространяться и на другие части тела (конечности, голову, язык и т. п.). При движении дрожание усиливается. Движения иногда могут нарушаться и носить атактический характер. Почерк больного дрожащий, неуверенный, с угловатыми нажимами, малоразборчивый, строки неровные. У некоторых больных белой горячкой отмечаются эпилептиформные припадки, часто наблюдающиеся в разгаре болезни или же появляющиеся за 1—2 дня до ее начала.

Иногда наблюдаются и более резко выраженные очаговые явления: парез п. *facialis*, гемипарез, которые очень быстро проходят. Нередко отмечается диплопия, парезы глазных мышц.

Кровяное давление значительно повышается, достигая 170—200 мм ртутного столба. После глубокого сна кровяное давление быстро снижается до низких границ, а через 2—3 недели приходит к норме.

Сон при белой горячке, как правило, отсутствует в течение всего периода болезни. Психическое состояние больных ночью значительно ухудшается, они становятся более беспокойными, тревожными: страх и галлюцинаторные переживания ночью достигают своего апогея.

Температура при белой горячке часто повышается и колеблется от 37,3° до 40°. Очень высокая температура обычно наблюдается в тяжелых случаях заболевания. Температура достигает максимума на 1—2-й день болезни, а затем довольно быстро падает. Пульс всегда учащен. При резком возбуждении число сердечных сокращений даже при нормальной температуре может достигать 120—150 в минуту.

Со стороны сердца ничего специфического не отмечается за исключением характерных для алкоголя изменений в виде глухих или нечистых тонов, а также некоторого его расширения.

Питание может нарушаться. Вес больных, перенесших белую горячку, всегда падает. Удельный вес мочи повышается,

количество ее уменьшается; иногда в моче находят белок. У больных наблюдаются то запор, то понос.

Обмен веществ. Согласно нашим данным, в крови больных белой горячкой отмечается гиперлейкоцитоз. Количество билирубина увеличено. Изредка увеличивается и содержание остаточного азота. Содержание каталазы повышено. В крови и спинномозговой жидкости скапливается значительное количество недоокисленных продуктов алкоголя. Функция печени нарушается, что особенно сказывается при углеводной нагрузке.

Расстройство функции печени можно обнаружить уже задолго до развития белой горячки; отмечается разница лишь в интенсивности нарушений.

Бострем находил при белой горячке уробилиноген в моче; повидимому, это указывает на остро наступающее поражение печени, вследствие чего прекращается нейтрализация ядов, обусловленных хроническим алкоголизмом. В крови больных многие авторы (Полиш, Бострем) обнаруживали индикан, ацетонемию, билирубин. Билирубинемия рассматривается ими как симптом поражения печени, существовавшего задолго до появления белой горячки.

Течение. Белая горячка длится от 2 до 5 дней. После критического сна обычно наступает выздоровление. Наряду с этим, встречаются случаи белой горячки, длящейся до 2 недель. Если белая горячка затягивается сверх 10 дней, это указывает на возможность перехода ее в корсаковский психоз или другие затяжные алкогольные психозы. В последнее время белая горячка несколько изменила свое течение и большей частью носит абортивный характер. У алкоголиков, злоупотреблявших суррогатами алкоголя (денатурат), белая горячка имеет ряд специфических особенностей (Меггендорфер). Эти больные значительно оглушены, у них отсутствует эмоциональная живость и моторное возбуждение. Аффект страха выражен незначительно или же совсем не отмечается. Больные апатичны, галлюцинаторные образы их однообразны. Белая горячка у алкоголиков, злоупотреблявших денатуратом, часто принимает злокачественную форму, затягивается на многие недели и в части случаев приводит к смерти. Иногда же она переходит в корсаковский психоз. Большинство случаев заканчивается выздоровлением. Долькен (Döllken) описал белую горячку без делирия (*delirium sine delirio*). При этой форме болезни наблюдается весь симптомокомплекс белой горячки, кроме бреда и галлюцинаций. Эта разновидность заболевания протекает крайне быстро и заканчивается литически.

Маньян приводит описание тяжелой лихорадочной формы белой горячки, протекающей при наличии высокой температуры (40—41°). У таких больных отмечается глубокое помрачение сознания, ориентировка грубо нарушается; они прико-

ваны к кровати, движения их неkoordinированы, часто наблюдаются судорожные подергивания мышц.

Нередко отмечаются парезы глазных мышц, тугоподвижность затылка. Чаще всего эта форма белой горячки заканчивается летальным исходом, и лишь в редких случаях наступает медленное выздоровление. Нам пришлось наблюдать 2 случая белой горячки с молниеносным течением, окончившихся смертью менее чем за одни сутки. На секции был обнаружен резкий отек головного мозга.

Известны случаи хронического течения делирия, когда после острого периода продолжают бредовые идеи, зрительные, слуховые и тактильные галлюцинации. Ориентировка восстанавливается, аффект страха смягчается или проходит полностью. Эта форма белой горячки развивается большей частью у лиц с инвалидизированной центральной нервной системой в результате какого-либо дополнительного вредного воздействия.

Встречаются также осложнения со стороны сердца в виде острой функциональной недостаточности. Реже отмечаются заболевания почек.

Патологическая анатомия. У больных, погибших от белой горячки, отмечается довольно значительная гиперемия сосудов оболочек мозга и дегенеративные изменения волокон радиального слоя центральных извилин. Часты точечные кровоизлияния, которые относятся за счет дегенерации сосудов мозга. Наблюдается также венозный застой.

При микроскопическом исследовании в нервных клетках отмечается хроматолиз, разбухание. Наряду с этим, в мозгу и других органах обнаруживаются явления, характерные для хронического алкоголизма.

Дифференциальный диагноз. Диагностика белой горячки не представляет особых затруднений. Достаточно несколько раз видеть таких больных, чтобы запомнить картину этого заболевания: характерный тремор, наплыв преимущественно зрительных, а также слуховых и осязательных галлюцинаций, которые часто причудливо переплетаются между собой, множественность галлюцинаторных образов, их подвижность.

Эмоциональная оживленность, аффект страха в сочетании с юмором, сохранность ориентировки относительно своей личности и дезориентировка в окружающем и во времени, бессонница, повышенная температура, отвлекаемость и высокая внушаемость, бред профессиональных занятий, а также алкоголизм в анамнезе говорят о наличии белой горячки. Иногда ее можно принять за делирий при инфекционном заболевании. Однако в последнем случае не наблюдается такого психомоторного возбуждения, как при белой горячке, и нет алкоголизма в анамнезе.

Алкогольный галлюциноз отличается от белой горячки тем, что он протекает при ясном сознании больного и с преобладанием слуховых галлюцинаций. Температура не повышается. Продолжительность болезни больше, чем при белой горячке. При аменции более глубоко нарушается сознание, ориентировка вплоть до дезориентировки относительно своей личности, причем отсутствует характерное дрожание.

Эпилептические психозы сопровождаются глубоким помрачением сознания, резко выраженным психомоторным возбуждением и агрессивностью.

Прогноз. Прогноз при белой горячке всегда следует ставить с известной осторожностью, поскольку не исключена возможность злокачественного ее течения, а также тяжелые осложнения со стороны сердца или легких.

О тяжести заболевания можно судить по большой смертности, которая колеблется, по разным авторам, в пределах от 0,20 до 40%. Согласно данным Маньяна, смертность при белой горячке равнялась 30—40%. По статистике Клемперера (Klemperer), охватывающей 50 больных, леченных алкоголем и строфантом в венской психиатрической клинике, смертность от белой горячки выражалась 32%. Бонгеффер на основании материала в 1000 случаев *delirium tremens* указывает, что смертность от этого заболевания была равна 9%.

Другие авторы приводят другие цифры: Кирхгоф — 20%, Крепелин — 3,4%, Блейлер (в неосложненных случаях) — 1—2%, Флексиг — менее 1%, наконец, Докен на 120 больных не наблюдал ни одного смертного случая. В изученных нами 1149 случаях белой горячки смертность равнялась 0,4%.

Эти значительные расхождения в цифрах смертности, по-видимому, объясняются тем, что у авторов были неодинаковые по тяжести заболевания больные и не везде проводилось надлежащее лечение.

Вполне понятно, что более тяжелые случаи белой горячки, осложняющейся иногда воспалением легких, которые алкоголики переносят чрезвычайно тяжело, а также острой недостаточностью сердечной деятельности, дают больший процент смертности, чем легкие, иногда даже abortивные случаи *delirium tremens*. Наряду с этим, решающее влияние на исход заболевания в таких случаях оказывает правильно организованный уход и лечение. Можно полагать, что в специальных лечебницах, приспособленных для лечения больных белой горячкой, процент смертности ниже, чем в общепсихиатрических больницах. Наконец, сама методика лечения также сказывается на исходе даже самой тяжелой формы белой горячки. К сожалению, упомянутые выше авторы, приводящие высокий процент смертности, за исключением Клемперера, не указывают способов лечения, которыми пользовались их больные. Примечательным тем, что неудовлетворительная методика лечения белой

горячки может давать высокий процент смертности, служит статистика смертности больных, леченных внутривенными влияниями сомнифена.

При правильном лечении и хорошем уходе в неосложненных случаях белой горячки почти всегда можно достигнуть положительных результатов. В настоящее время современные методы лечения, базирующиеся на учении И. П. Павлова, позволяют быстро излечивать белую горячку и почти полностью ликвидировать смертность от нее.

Лечение. С давних пор делались попытки найти радикальное средство, которое могло бы купировать белую горячку. Некоторые авторы не допускают никаких вмешательств при белой горячке, ошибочно считая, что это заболевание пройдет само собой через несколько дней. По их мнению, при отсутствии осложнений больной нуждается только в надзоре.

С. С. Корсаков рекомендовал при белой горячке возможно скорее вызывать сон с помощью хлоралгидрата, паральдегида и одновременно назначать сердечные средства.

Как уже отмечалось выше, часть авторов неправильно предполагает, что внезапное лишение хронических алкоголиков спиртных напитков вызывает *delirium tremens* и что противо-ядием от белой горячки является тот же алкоголь. При разного рода соматических заболеваниях, травмах и операциях некоторые врачи продолжают давать алкоголикам алкоголь.

Брюэль и Лекок (Brüel и Lecoq) рекомендуют проводить лечение алкогольных психозов кюрэтилом. Кюрэтил — это стерильный 25% раствор этилового алкоголя в изотоническом растворе с добавлением печеночной вытяжки (без протеина и гистамина). Кюрэтил вводят больным в течение 7—10 дней в общем количестве 700 мл при постепенном снижении дозы: первая доза равна 150—200 мл, а последняя — 50 мл. Однако надежды, возлагавшиеся на кюрэтил, не оправдались. При применении этого метода лечения не исключена опасность осложнений в виде развития артритов и тромбоза. Данный метод лечения базируется на ошибочных суждениях Лекока и Брюэля о том, что наиболее частой причиной белой горячки является резкое лишение больного алкоголя. Об ошибочности такого мнения можно судить из наблюдений Мореля и Шиферли (F. Morel и Schifferli) в психиатрической клинике «Бель Эр» в Женеве. Из 667 больных, поступивших в данную клинику в состоянии белой горячки, только в отношении 126, или 19%, авторам удалось установить, при каких обстоятельствах у них развилось заболевание белой горячкой. Оказалось, что лишь у 16 человек возникла белая горячка после нескольких дней (2—15) абсолютного воздержания от алкоголя. Остальные 110 продолжали пить сверх меры вплоть до самого момента возникновения белой горячки. Наши наблюдения, проведенные свы-

ше чем над 1500 больными белой горячкой, также опровергают ошибочное суждение Лекока, Брюэля и других авторов, придерживающихся данной точки зрения. Ни в одном случае мы не могли отметить развития белой горячки, явившейся следствием внезапного лишения алкоголя. Брюэль и Лекок полагают, что белая горячка при их методе лечения длится всего лишь 7 дней. Между тем клиницисты прекрасно знают, что белая горячка изменила свое течение, она стала значительно мягче и приступы ее стали короче. Мы наблюдали многих больных с abortивным течением заболевания, когда оно длилось всего 1—2 суток.

О том, что алкоголь при белой горячке не помогает, может свидетельствовать высокая смертность от этого заболевания в венской психиатрической больнице, где таких больных лечат алкоголем и сердечными средствами. Наконец, работы многочисленных авторов, изучавших обмен веществ, убедительно доказывают, что введение алкоголя усиливает поражение печени, развивающееся на почве хронического алкоголизма.

Следовательно, лечение алкоголем больных белой горячкой не имеет научного обоснования, являясь вредным для здоровья больных.

Чтобы смягчить течение белой горячки и вызвать сон, с давних пор применяют снотворные средства, но в силу малой восприимчивости таких больных к наркотикам приходится применять их в дозах, превышающих в несколько раз обычные терапевтические, что уже может оказывать отрицательное действие. Часто, несмотря на прием больших доз этих наркотиков, вызвать сон все-таки не удается. Для вызывания сна при белой горячке применяют хлоралгидрат и паральдегид.

Проф. Е. К. Краснушкин рекомендовал применять при состояниях возбуждения и, в частности, для лечения белой горячки следующую смесь:

Rp. Natrii bromati

Chlorali hydrati aa 15,0

T-rae Valerianae simplicis 20,0

Pantoponi 0,1

Luminali 0,5

Adonileni 5,0

Aq. destill. 500,0

MDS. По 50—100 г в клизме или 2—3 ложки внутрь

Сочетание сердечных и снотворных средств в данной смеси вызывает глубокий сон и в то же время предупреждает отрицательное действие наркотиков на сердечно-сосудистую систему. Смесь Краснушкина может купировать белую горячку в течение нескольких часов. После глубокого сна, длящегося 8—15 часов, больные просыпаются и признаков белой горячки больше не проявляется (С. П. Родионов, Л. А. Скрицкая, Л. Н. Пятницкая).

Е. А. Попов и В. В. Наумова рекомендуют для купирования белой горячки люминал в следующей прописи:

Rp. Luminali 0,4
Spiritus vini 20,0
Aq. destill. 200,0
MDS. Принять в течение часа

Спирт якобы обеспечивает быстрое всасывание люминала в кишечнике и усиливает его снотворное действие. Е. А. Попов и В. В. Наумова указывают, что больной, выпивший раствор люминала, засыпает через 30—60 минут и по истечении многих часов сна делириозных явлений уже не обнаруживается.

Проверяя способ, предложенный Е. А. Поповым, мы могли отметить его успешное действие лишь в сравнительно нетяжелых абортивных случаях белой горячки.

Следует учитывать, что люминал в больших дозах влияет угнетающим образом на дыхательный центр, а потому этот способ лечения противопоказан в тех случаях белой горячки, когда деятельность сердца нарушена, или при начинающемся воспалении легких во избежание их отека.

Во многих случаях мы получили прекрасные результаты при назначении амитал-натрия *per os* или в клизме в дозе от 0,4 до 0,8; после введения этого средства вскоре наступает сон и выздоровление. Однако амитал-натрий следует назначать осторожно, особенно при соматических заболеваниях. В частности, он противопоказан при болезни почек.

Вообще наркотики при белой горячке надо применять с большой осторожностью ввиду того, что могут возникнуть опасные осложнения со стороны сердца и т. д. Некоторые авторитетные клиницисты считают хлоралгидрат безопасным средством, но его также следовало бы применять очень осторожно. Ввиду вредного влияния наркотиков при белой горячке от применения их во многих психиатрических клиниках и специальных больницах отказались. Крепелин рекомендует при белой горячке наперстянку и кофеин.

А. М. Рапопорт допускает в наиболее тяжелых случаях белой горячки алкоголь в замаскированном виде, например, в виде *Liq. ferri albuminati*, основываясь на том предположении, что противоядием против токсина, вызывающего белую горячку, является алкоголь.

Блейлер рекомендует при белой горячке лишь постельный режим, хороший надзор и молочную пищу, назначая больным от 1 до 3 л молока в день; наряду с этим, больному дается обычная пища. Молоко, по Блейлеру, улучшает диурез и способствует выведению ядов из организма. Снотворные Блейлер неправильно считает мало эффективными или совсем бесполезными. Сердечные он назначает при угрозе коллапса.

Многие авторы советуют удалять токсические продукты, циркулирующие при белой горячке в ликворе, путем люмбаль-

ной пункции с последующей заменой удаленного ликвора раствором бромистого натрия.

Клостер купировал белую горячку внутривенным вливанием 20—70 мг витамина В₁. С. Кату и Пуку в случаях значительного авитаминоза удавалось прекращать белую горячку посредством инъекций 250—500 мг аскорбиновой кислоты в сочетании с витамином В₁.

Предпринимались попытки лечить белую горячку большими дозами стрихнина.

В тяжело протекающих случаях белой горячки при нарушении функции почек рекомендуют кровопускание с последующим вливанием физиологического раствора. Серьезного внимания заслуживает применение лечебного питания, которое сводится к назначению больших количеств жидкости — молока, кофе, чая и безалкогольных напитков (минеральные воды, нарзан, эссенуки, боржоми, морс и т. д.). Пища должна быть богата углеводами и бедна жирами и белками. Штек (Steck) с целью профилактики дает каждому больному ежедневно 10—15 капель дигиталиса; в зависимости от течения делирия, он применяет корамин, кардиазол и как тонизирующее средство стрихнин. Е. Клемперер рекомендует инсулин в качестве средства, смягчающего течение делирия и сокращающего его продолжительность до 2 дней. Больному дают утром 5—10 ИЕ инсулина, через час эту дозу повторяют, затем еще через час дают 60 г растворенного сахара. Если после первой инъекции инсулина обнаруживаются гипогликемические явления, сахар можно дать тотчас же. Вечером дают 2 раза по 10 ИЕ инсулина с интервалом в один час, а через час, если этого требуют клинические явления, немедленно дают 60 г сахара.

Можно дать еще раз 5—10 ИЕ инсулина, но при этом за больным следует установить строгое наблюдение, чтобы предупредить гипогликемические явления. С профилактической целью рекомендуется внутривенное введение 10—20% раствора глюкозы по 10—20 г, после чего угрожающие симптомы мгновенно исчезают. Лечение инсулином в случае надобности может быть повторено на другой день, но, по Штеку, оно часто бывает излишним. Штек, применявший лечение инсулином и дехолином, считает, что оно изменяет в корне всю терапию белой горячки, причем показал, что при лечении инсулином речь идет не только о влиянии на функцию печени. Применение инсулина при других состояниях возбуждения подтвердило общеуспокаивающее действие этого препарата, объясняющееся снижением сахара в крови и воздействием на блуждающий нерв, что выражается в заметном замедлении пульса.

Некоторое время при белой горячке мы с успехом применяли медленное внутривенное введение пентотала; можно также вводить его внутримышечно. Весьма благотворно при белой горячке влияют средства, действующие первично на кору голов-

ного мозга и подкорковые узлы, в частности, сочетание люминала с бромуралом, вероналом и кофеином.

Rp. Luminali 0,2
Bromurali 0,5
Veronali 0,3
Colfeini nátrio-benzoici 0,1
M. f. pulv. D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку через 4—5 часов, до наступления сна
(до 2—3 порошков)

М. И. Середина достигала быстрого излечения больных белой горячкой посредством полуторасуточного лечебного сна, вызываемого снотворной смесью А. Г. Иванова-Смоленского:

Rp. Barbamyli 0,1
Medinali 0,25
Bromurali 0,3
Pyramidoni 0,25
M. f. pulv. D. t. d. N. 6
S. По 1 порошку на ночь

Де Кринис лечил больных белой горячкой дехолином (желчегонное средство). Дехолин вводили в виде 20% раствора внутривенно по 10 мл в течение 3 дней. По утрам рекомендуется давать карлсбадскую соль, которая способствует дезинтоксикационной терапии. Параллельно с этим назначают углеводную диету.

Лечение дехолином как будто имеет то преимущество перед лечением инсулином, что не требует особых мер предосторожности.

Наряду с инсулинотерапией, блестящих результатов при лечении белой горячки можно добиться путем применения неспецифической терапии, поднимающей тонус и жизнедеятельность организма. Известно, что неспецифические факторы стимулируют клетки к повышенной жизнедеятельности, мобилизуют их резервные силы. В результате неспецифическая терапия превращается в специфическую.

Из средств неспецифической терапии можно применять аутогемотерапию, протеинотерапию, а также гравидан, изготовляемый по методу Замкова.

Довольно благоприятный результат при белой горячке дает гравидан. Он содержит соли, мочевины, небольшой процент белка и гормоны. Из гормонов в моче беременных пока найдены пролактин, гормон кровообращения — каликреин, фолликулин, гормон роста, гормон, оказывающий действие на мышечный тонус, миокантин и т. п. В гравидане содержатся также парагормоны и эндоферменты.

Правильно применяя гравидан при белой горячке, можно добиться купирования ее в течение 1—2 дней, а иногда и в течение нескольких часов. Применять гравидан надо подкожно в больших дозах — по 3—5 мл повторно (по 10—12 мл в сутки). Часто повторные дозы бывают излишни, так как нередко уже

после одной-двух инъекций наступает критический сон. Иногда до наступления сна отмечается изменение окраски галлюцинаций, которые вместо устрашающих становятся «доброжелательными», «жалеющими» больного; эффект страха при этом смягчается.

Часто галлюцинации исчезают еще до наступления критического сна. Случаи белой горячки со злокачественным течением гравиданотерапии не поддаются.

Гравидан противопоказан при острой сердечной слабости, хронически протекающих воспалительных процессах, злокачественных опухолях, туберкулезе в активной форме.

В последнее время Камерер и Эттингер из Страсбурга сообщают об успешном лечении тяжелой формы белой горячки ларгактилем или хлорпромазином или 4500 RP (аналог советского препарата аминазина), который в последнее время применяют при маниакальном возбуждении, параноидной форме шизофрении и других патологических состояниях. Эти авторы настолько удовлетворены этим методом лечения, что считают применение других средств, за исключением стрихнина и витамина В₁, в том числе и снотворных, излишним. Мы наблюдали весьма благоприятные результаты при лечении белой горячки аминазином, назначаемым внутримышечно по 1—2 мл 2,5% его раствора 4 раза в день. Бахер К. В. успешно лечил белую горячку витамином В₁₂, назначая его по одной тысяче гамм в сутки. Он рекомендует давать этот витамин для профилактики алкогольных психозов при несчастных случаях и после хирургических операций у алкоголиков в дозах 48—333 гамма.

Резюмируя изложенное, мы видим, что терапия при белой горячке имеет целью поддержать сердечную деятельность, вызвать сон, нормализовать обмен и поддержать силы больного.

При правильном лечении и уходе можно добиться полной ликвидации летальности от белой горячки, быстрого выздоровления больных и профилактики перехода ее в хронические алкогольные психозы.

Глава VII

ОСТРЫЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЛЛЮЦИНОЗ

Острый алкогольный галлюциноз, по нашим наблюдениям, встречается чаще, чем белая горячка. Другие авторы, наоборот, чаще наблюдали белую горячку.

Соотношение частоты алкогольного галлюциноза и белой горячки, по Крепелину, равно 1 : 3, по Блейлеру — 1 : 44, по Шредеру — 1 : 20.

Алкогольный галлюциноз почти всегда начинается после алкогольного эксцесса; в редких случаях белая горячка при ее завершении переходит в алкогольный галлюциноз.

В литературе нет указаний на то, что алкогольный галлюциноз развивается в период, когда больные не пьют длительные сроки, как это нередко наблюдается с белой горячкой, вспыхивающей во время какого-либо инфекционного или тяжелого соматического заболевания, после того как больные длительное время не употребляли алкоголя.

С. Г. Жислин считает алкогольный галлюциноз «похмельем, осложненным галлюцинаторно-бредовой реакцией».

Полиш в $\frac{2}{3}$ случаев алкогольного галлюциноза, катамнестически им прослеженных, находил перекос выраженную шизофреническую деградацию, а в остальных случаях — шизофреническую наследственность и наличие психопатических черт характера шизондного круга.

Крепелин считает алкогольный галлюциноз и белую горячку разновидностью одного и того же страдания. Вернике же, наоборот, рассматривает алкогольный галлюциноз как самостоятельное заболевание. Попытки Полиша и Вольфенсбергера объяснить алкогольный галлюциноз шизоидной конституцией или шизофреническим отягощением оказались несостоятельными.

Патогенез алкогольного галлюциноза настоящим образом еще не выяснен. Видимо, одной алкогольной интоксикации для образования алкогольного галлюциноза еще недостаточно. Для этого нужно сочетание нескольких вредностей, действующ-

щих в одном и том же направлении. К таким вредностям относятся травмы головы, заболевания органов слуха, перенесенные в детстве органические заболевания центральной нервной системы, психическая травма, истощение и т. п.

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а. Симптомокомплекс острого алкогольного галлюциноза состоит из слуховых галлюцинаций, аффекта страха и бредовой интерпретации.

Заболевание начинается внезапно или с кратковременных предвестников в виде беспокойства, головокружения, головной боли, подавленного настроения и т. п. Оно вспыхивает обычно вечером или ночью. Больным овладевает сильное беспокойство, он то совсем не может заснуть, то в страхе, обливаясь потом, просыпается после кратковременного сна. Он слышит вначале, шум, звон, треск, шопот, шорохи, крики, отдельные слова и наконец голоса. Голоса обычно говорят о больном в третьем лице и никогда не обращаются к нему непосредственно. Голосов бывает много, они то тихие, то громкие, доходящие до рева. Все голоса говорят вместе, переплетаясь, спорят между собой, ругаются. Они воспринимаются больным извне, как будто раздаются за стеной.

Голоса принадлежат близким родственникам, знакомым, сослуживцам или посторонним лицам.

Содержание галлюцинаций носит неприятную окраску. Голоса угрожают смертной казнью, обвиняют в тяжчайших преступлениях, бранят, ругают: «возьми его», «дурак», «пьяница», «вор», «жулик», «убийца», «старый развратник», «забрать его в милицию», «он без паспорта», «вот он, вот она», «взять его», «он воровал документы», «документы у него подложные», «растратчик», «пех обокрал», «лентяй, лодырь», «прогульщик», «беги, беги», «не уйдешь, везде найдем», «нас много, не спрячемся», «с ума сойдешь», «сумасшедший», «смерть ему», «обдерем его, как липку», «кожу драть будем полосами», «руки, ноги отрубим, а труп зароем в саду», «повесить его», «застрелить его».

Голоса совещаются, спорят, беседуют между собой, обсуждают, как его уничтожить, каким способом казнить, причем больной является свидетелем этого разговора, а иногда и участником его.

«Теперь он от нас не уйдет», «возьмем его», «застрелим», «обождем немного», «резать его деревянной пилой», «под поезд его», «он сам утопится», «жаль умерщвлять его, возьмем его в тюрьму». Голоса могут иногда носить забавный, насмешливый характер. Они знают все события жизни больного, высмеивают его, делают циничные, оскорбительные замечания по поводу важнейших этапов его жизни. Иногда голоса информируют о его близких: «дети зарезаны», «жену три дня насилуют в подвале», «отрубили ей голову». Наряду с этим, больной слышит крики, стоны жены, детей, родных.

В части случаев голоса носят ритмический характер, синхроничный пульсу или внешним слуховым раздражениям.

Обманы чувств других органов выражены в меньшей степени. Зрительные обманы появляются главным образом в темноте или при закрытых глазах. Больной видит преследующих его лиц, черные тени, зарево, искры, пятна, пауков и т. п. (рис. 26). Заговорщики крадутся за ним, не спускают с него глаз.

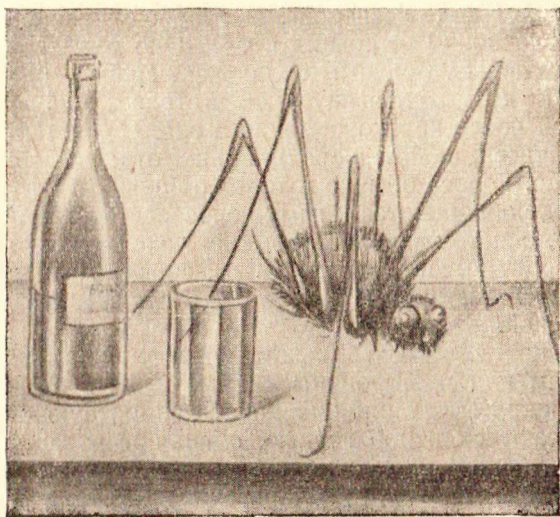


Рис. 26. Зрительные галлюцинации.

Смерть с оскаленными зубами, с косой направляется к нему. Больной видит лица родственников знакомых, чертей. Зрительные галлюцинации иногда напоминают таковые при белой горячке (рис. 27). В этих случаях иногда приходится думать о смешанных формах.

Крепелин полагает, что здесь речь идет об иллюзорном или бредовом толковании реальных восприятий. Встречаются также тактильные галлюцинации: больным кажется, что их чем-то обрызгивают.

Обонятельные, вкусовые и тактильные галлюцинации мы на нашем материале при чистых формах алкогольного галлюциноза встречали крайне редко.

Крепелин подчеркивает, что в некоторых случаях больным кажется, что их электризуют, накачивают воздух в легкие или огонь в задний проход; изо рта вылетают ракеты, выходит дым. Пища имеет странный вкус — она отравлена.

Блейлер неправильно отмечает, что в тех случаях, когда имеются обонятельные, вкусовые и особенно осязательные гал-

люцинации, в основе их лежит шизофрения. Почти всегда имеются бредовые идеи обвинения, преследования. Больные считают, что их ждет что-то ужасное, им готовят казнь, строят эшафот, их обвиняют в убийстве, изнасиловании, поджоге, краже и т. п. Все приготовлено для их казни. Сейчас их заберут. Живыми закопают в землю.



Рис. 27. Зрительные галлюцинации.

Все на них подозрительно смотрят, перемигиваются, шепчутся, указывают на них. Иногда во время обхода больные обращаются к врачу с мольбой о помощи. Никаким убеждениям и уговорам они не поддаются.

Бред не носит систематизированного характера. Он вытекает из галлюцинаций и адекватен им.

Иногда бредовые идеи и галлюцинации имеют фантастическое содержание, напоминающее переживания больных при белой горячке. Ориентировка у больных не нарушена.

Алкогольный галлюциноз обычно протекает на фоне довольно ясного сознания, существенно отличаясь этим от белой горячки. Лишь при тщательном исследовании отмечается некоторая оглушенность и неясность. Все же критического отношения к своей болезни, особенно в начале заболевания, не бы-

васт. Больные смотрят на высказываемые предположения об их болезни, как на коварный метод, проделку преследователей, желающих, помню всех преступлений, приписать им еще и сумасшествие. Однако на 2—3-й день и позже многие больные могут осознать свою болезнь и часто сами обращаются за медицинской помощью.

Настроение больных носит тревожный характер: почти всегда на первый план выступает аффект страха. Во многих случаях отмечается своеобразное сочетание страха с юмором. Несмотря на страх, достигающий иногда значительной степени, больные внешне ведут себя спокойно, как будто покоряются судьбе. В первые дни развития заболевания, находясь под влиянием бреда, они «не видят выхода из создавшегося положения» или по приказанию и совету «голосов» совершают суицидальные попытки.

Возможность внушения галлюцинаций при остром алкогольном галлюцинозе, в противовес белой горячке, обычно отсутствует. Равным образом больных невозможно переубедить и в их бредовой интерпретации. Наоборот, они сами пытаются доказать другим справедливость своего суждения по этому вопросу. Однако при подостром и хроническом алкогольном галлюцинозе внушаемость слуховых и обонятельных галлюцинаций весьма значительна.

Поведение больных на первый взгляд почти нормальное. Внешне они спокойны. Однако при постоянном наблюдении можно заметить, как они прислушиваются к «голосам», пытаются с ними говорить. До помещения в больницу некоторые из них стараются скрыться от «преследователей» или баррикадируют комнату, построив целую систему сигнализации.

В больнице общее поведение больных правильное. Они подчиняются установленному режиму. Однако нередко в порыве страха такие больные совершают бегство даже из лечебного учреждения, поэтому необходимо устанавливать за ними строгий надзор.

До помещения в стационар больные, спасаясь от мнимых врагов, запасаются всевозможным оружием, чтобы «как можно дороже продать свою жизнь». Другие, наоборот, не ожидая нападения, сами превращаются в агрессоров, нападая на во-ображаемых врагов. Иногда по целым дням и ночам они «караулят» у своей двери, вооружившись топором, холодным оружием, в ожидании «врагов». Иногда, доведенные до отчаяния, они обращаются в милицию с просьбой о защите от врагов или же сами «сдаются», упрасывая скорее «кончить» с ними, «привести приговор в исполнение».

Память не расстраивается. Конфабуляций почти не наблюдается. Во время и после перенесенного заболевания больные подробно рассказывают о своих болезненных переживаниях. Даже в хронических случаях алкогольного галлюциноза, для-

щегося десятками лет, обычно сохраняется удовлетворительная память.

Физические симптомы при алкогольном галлюцинозе не имеют ничего специфического. Наряду с признаками хронического алкоголизма в виде тремора рук, повышенной чувствительности мышц и нервов при давлении, усиленной потливости, характерных изменений со стороны внутренних органов и т. п., отмечается расстройство сна. Сон становится поверхностным, тревожным, кратковременным: в остром периоде он длится 1—3 часа. Нередко отмечается головокружение, шум, звон в ушах, зависящие от повышения кровяного давления. Вес больного в остром периоде болезни падает.

Обмен веществ и картина крови. При алкогольном галлюцинозе находят билирубинемия, нарушение углеводного обмена, функций печени и поджелудочной железы. В большинстве случаев повышается РОЭ. В крови — лейкопения, сменяющаяся гиперлейкоцитозом. Отмечается сдвиг формулы крови влево, понижение содержания гемоглобина, кислорода, повышение количества углекислоты. При острых алкогольных галлюцинозах все эти явления обратимы. В случаях хронического галлюциноза они носят стационарный характер.

Течение. Течение заболевания в основном острое. Различают острую, подострую и хроническую форму. Первая длится от нескольких дней до нескольких недель, вторая — 2—3 месяца. Хронический алкогольный галлюциноз длится годами, чаще всего в течение всей жизни. У одного и того же больного могут наблюдаться повторные приступы алкогольного галлюциноза. В корсаковский психоз это заболевание никогда не переходит. В подострых случаях у больных исчезает аффект страха, они привыкают к галлюцинациям и могут относиться к ним критически. Бред выражен в меньшей степени или даже может отсутствовать. Заканчивается болезнь литически. Страх и бред смягчаются к концу галлюцинаций или проходят еще раньше.

Голоса постепенно становятся тише, невнятными, переходят в неясный шепот и наконец исчезают. Иногда выздоровление наступает внезапно, после глубокого сна. Можно надеяться на быстрое течение в тех случаях, когда картина алкогольного галлюциноза приближается к картине белой горячки.

В неблагоприятно протекающих случаях состояние остается стационарным, обостряясь при новых алкогольных эксцессах. При длительном воздержании от алкоголя обманы чувств постепенно ослабевают вплоть до полного исчезновения с тем, чтобы вновь вспыхнуть при алкогольном эксцессе.

Этиология. Причины острого алкогольного галлюциноза не выяснены. Еще не установлено, почему одни алкоголики заболевают белой горячкой, другие — галлюцинозом, третьи — корсаковским психозом, так как при всех этих заболеваниях

едва ли имеются существенные различия в злоупотреблении алкоголем.

Крепелин считает, что белая горячка и алкогольный галлюциноз являются до известной степени различными эквивалентами одного и того же заболевания.

Некоторые авторы предполагают, что у алкоголиков образуется в организме ряд различных ядов, из которых каждый может вызвать специфическую для него картину болезни.

Бонгеффер высказывает предположение, что алкогольный галлюциноз развивается главным образом у таких алкоголиков, у которых особенно возбудима область акустических восприятий и представлений. Однако с предположением Бонгеффера нельзя согласиться, ибо если бы оно соответствовало действительности, то мы не наблюдали бы у одних и тех же лиц белую горячку и алкогольный галлюциноз, что встречается не так уж редко. Кроме того, и акустическая возбудимость не всегда бывает налицо.

Д и а г н о з. Распознавание заболевания часто представляет известные трудности при отграничении его от шизофрении. От белой горячки алкогольный галлюциноз отличается тем, что он протекает при ясном сознании, при правильной ориентировке, с преобладанием слуховых галлюцинаций, при наличии бреда и при отсутствии внушаемости. Эмоциональная живость больных, доступность, проскальзывающий временами юмор, отсутствие галлюцинаций обоняния и вкуса, отсутствие аутизма, негативизма, разорванности мышления, нелепых поступков, немотивированного поведения служат отличительными симптомами алкогольного галлюциноза от шизофрении.

И. Н. Виш указывает на возможность возникновения алкогольного галлюциноза на почве шизофрении. Как он отмечает, симптомокомплекс алкогольных психозов у шизофреников имеет ряд особенностей: «бледность, замедленный темп делиранных переживаний, малая отвлекаемость, склонность к систематизации, акцент на акустической сфере, недостаточный аффективный потенциал, запаздывание критической оценки болезненных переживаний». Может встречаться сочетание алкогольного галлюциноза и шизофрении, что следует иметь в виду при дифференциальном диагнозе.

Л е ч е н и е. При остром течении заболевания больных необходимо немедленно стационарировать в психиатрическую больницу, учитывая их склонность к самоубийству и возможность нападения на окружающих.

Регулирование сна, деятельности желудочно-кишечного тракта, правильное питание, постельный режим, организация соответствующего надзора — вот основные условия лечения этих больных.

В настоящее время имеются эффективные средства, непосредственно воздействующие на течение заболевания, неко-

торую пользу может принести инсулин. Сочетанный с лечебным сном инсулин применяют по 10—20 ИЕ в течение 8—10 дней. В целях профилактики гипогликемического шока больным необходимо давать не менее 200 г сахара или глюкозы. В качестве снотворных рекомендуется эвипан по 0,25—0,5 г на ночь, амитал-натрий, люминал, веронал, хлоралгидрат, бромурал, смесь А. Г. Иванова-Смоленского и др. Благоприятно влияет на больных лечение аминазином. Аминазин назначают в виде 2½% раствора по 1—2 мл 2—4 раза в день в течение 3—5 дней.

Наряду с этим больным делают теплые индифферентные ванны в 35—36° в течение 10—15 минут, а также подкожное вдувание кислорода. После исчезновения острых явлений приступают к лечению хронического алкоголизма.

Глава VIII

ХРОНИЧЕСКИЙ АЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЛЛЮЦИНОЗ

Хронический алкогольный галлюциноз является сравнительно редким заболеванием. Из 1256 больных алкогольным галлюцинозом, лечившихся в специальной больнице, лишь у 26 был диагностирован хронический алкогольный галлюциноз. В большинстве случаев это заболевание начинается как острый алкогольный галлюциноз, реже как белая горячка и еще реже как атипичный алкогольный психоз. Начальная стадия хронического алкогольного галлюциноза характеризуется необычайной яркостью как зрительных, так и слуховых галлюцинаций. Эта стадия заболевания длится 1—2 недели. Если заболевание протекало, как белая горячка, то обычно на 3—5—7-й день у больных проясняется сознание, проходит или значительно ослабевает чувство страха, зрительные галлюцинации исчезают или почти сходят на нет; слуховые галлюцинации, бывшие вначале на втором месте, постепенно усиливаются, принимают характер наплыва и в дальнейшем занимают в картине заболевания основное место. Переход острого алкогольного галлюциноза в хронический происходит постепенно и незаметно; иногда острая стадия как бы отсутствует и заболевание сразу принимает хроническое течение. Зрительные галлюцинации, бывшие здесь на втором плане, проходят, бред у большинства исчезает, он остается лишь при параноидных формах хронического алкогольного галлюциноза, напоминая бред острого периода.

Хронический алкогольный галлюциноз, в зависимости от клинической картины, мы разделяем на четыре группы: а) хронический алкогольный галлюциноз без бреда; б) хронический алкогольный галлюциноз с нестойким бредовым включением; в) параноидная форма хронического алкогольного галлюциноза; г) комбинированные формы хронического алкогольного галлюциноза.

Наиболее частой формой является вербальный галлюциноз без бреда. Клиническая картина этого галлюциноза сводится в основном к следующему: еще задолго до заболевания боль-

ные переносят один или несколько приступов острого алкогольного психоза (белой горячки, острого алкогольного галлюциноза). За несколько дней до начала заболевания больные прекращают употреблять алкоголь. В продромальной стадии у них появляется тревога, резкое беспокойство, расстройство сна. Засыпая, они слышат, что кто-то к ним подкрадывается, хочет схватить их и т. д.; они в страхе вскакивают, кричат. Больные теряют аппетит, жалуются на шум и боли в голове; вскоре проявляются обильные слуховые галлюцинации. Содержание слуховых галлюцинаций неприятное, угрожающее; голоса ругают, угрожают, обвиняют, пугают, зловеще комментируют поведение больного, насмеваются над ним, спорят между собой, каким способом лучше погубить его. Они угрожающе кричат: «мы тебя разорвем, мы тебе покажем, как пьянствовать», «вот он, вот он пошел, хватай его и быстро придуши» и т. п. Другие голоса жалеют больного, защищают его, заявляя: «он парень хороший, не следует его убивать», «это жена довела его до этого», «это водка его загубила». Содержание галлюцинаций вызывает страх и ужас у больных, причем слуховые галлюцинации тесно связаны с их мышлением. Иногда больные слышат голоса, приказывающие им покончить с собой. Слуховые галлюцинации в начальном периоде заболевания отличаются яркой эмоциональной окраской, вследствие чего больные воспринимают их как реальную действительность. На втором плане стоят зрительные галлюцинации: больные видят пауков, мух, кошек, собак, тени, разных страшилищ, не существующих в природе, чертей и т. п. (рис. 28 и 29). В начальном периоде имеют место также кинестетические, осязательные галлюцинации, бред преследования, бред отношения — больных преследуют соседи, сослуживцы, какие-то незнакомые лица и т. п. Сознание обычно не нарушается, однако на высоте галлюцинаторных переживаний оно может быть несколько затемнено. Больные всегда чувствуют перемену, которая с ними произошла. Нередко уже на второй день заболевания догадываются, что они «помешались», и самостоятельно обращаются к врачу за помощью. Настроение обычно боязливое, тревожное. Они испытывают сильный страх. Под влиянием галлюцинаций устрашающего и угрожающего характера больные нередко совершают суицидальные попытки. Поведение больных внешне спокойное, иногда же они переговариваются с голосами, убегают из дому, обращаются в органы милиции за защитой. Через 3—7 дней страх у больных уменьшается, зрительные, осязательные, кинестетические галлюцинации исчезают, остаются лишь слуховые галлюцинации, причем голоса становятся уже не такими грозными. Больной начинает к ним привыкать, бред прекращается сразу или постепенно бледнеет. Все это происходит в течение первого месяца, а у некоторых буквально в течение нескольких дней.

Такова клиническая картина начального периода заболевания. В дальнейшем основным симптомом хронического алкогольного галлюциноза является наплыв слуховых галлюцинаций при ясном сознании. Больные беспрестанно слышат голоса, принадлежащие мужчинам, женщинам, детям, иногда они слышат знакомые песни. В редких случаях слуховые галлюцинации ограничиваются постоянным щебетанием различных птиц. Содержание галлюцинаций большей частью неприятное. Голоса угрожают, пугают, насмеваются над больным, коммен-



Рис. 28. Зрительные галлюцинации.

тируют его поступки, делают предсказания, иногда приказывают, ругают. Обычно, как и в начальном периоде, имеются две группы голосов: одна — враждебная, другая — сочувствующая больному. Неприятные голоса часто носят ритмический характер, например басом, а доброжелательные голоса — женщинам или детям. Не успеет больной проснуться, как голоса уже начинают разговор.

1. Больной Ч., которого мы наблюдали, заявлял, что голоса даже будят его, крича: «довольно спать, нам скучно, а ты все спишь, давай поговорим». После этого голоса беспрестанно ведут о нем разговоры или обращаются непосредственно к нему. Голоса часто носят ритмический характер, например: «уйди, уйди», «будет, будет», «не надо, не надо».

2. Больной М. в течение буквально нескольких минут во время беседы с врачом слышал следующее: «мы тебе покажем, как пить водку и

ханжу», «подлец, такой сильный, а не хочет работать; пьянствовать, гулять захотел», «зот ты погуляешь», «сейчас придем, придем, мы тебе покажем, как гулять, мы тебя доведем до конца, доведем до слез, до пота доведем», «на Канатке¹ мест нет», «в Столбовую¹ отправлю, там будешь березу пилить, корни корчевать, а потом в реку прыгнешь, мы тогда возьмем тебя в работу», «допился, допился, подлец, и покурить нет», «не ложись спать, все равно не дам», «загрызу, загрызу, руку откушу, загрызу», «ишь, лодырь, развалился и не слышит».



Рис. 29. Зрительные галлюцинации.

Слуховые галлюцинации черпаются из реальной действительности и связаны с направлением мыслей больного и той ситуацией, в которой он находится. Не успеет больной о чем-либо подумать, как голоса ему уже говорят об этом. На что бы больной ни взглянул, что бы больной ни захотел сделать, голоса сейчас же ему говорят об этом. Например, больной ест яблоко, а голоса ему говорят: «яблоко есть нельзя»; пьет кипяченую воду — они уже твердят другое: «не пей кипяченой воды, а пей сырую, она тебе полезнее». Если больной слушался голосов и выпивал сырую воду, голоса кричали: «спровоцировали, а сырой воды тебе совсем нельзя пить, ты свою кровушку застудил». Если больной читает, голоса перебивают, путают, повторяют за ним, читают «впереди» него, а иногда, наоборот, просят: «читай, читай». Больные никогда не скрывают от врачей своих галлюцинаций, однако могут скрывать наличие

¹ Местности, где находятся психиатрические больницы.

их от родственников, сослуживцев, но не из-за мотивов бредового порядка, а потому, что боятся, как бы их не приняли за «ненормальных». Галлюцинации то возникают спонтанно, то вызываются слуховыми раздражителями. Интенсивность слуховых галлюцинаций часто адекватна силе слухового раздражителя; например, когда больной слышит гудок паровоза, голоса орут, при писке комара голоса пищат. Слуховые галлюцинации почти всегда воспринимаются больными с большой ясностью, так что иногда больные не отличают голосов галлюцинаций от естественных. Находившийся под нашим наблюдением больной Ч. не сдал экзамена, несмотря на то, что хорошо знал предмет. На экзамене нереальные голоса сливались с голосом экзаменатора, в результате чего он отвечал невпопад; вместо ответов на вопросы преподавателя отвечал на вопросы голосов галлюцинаций.

Другой больной на вопрос, как он отличает галлюцинации слуха от естественных голосов отвечал, что отличить их ему очень трудно, однако он знает, что когда его сильно ругают и распекают, то это галлюцинация. Больные слышат голоса в углах, за форточкой, за стеной, из-под пола, за ушами и т. п.

Наплыв слуховых галлюцинаций, как это показали исследования М. И. Серединой, стоит в прямой зависимости от явлений застойного инертного возбуждения во второй сигнальной системе. Не исключается возможность одновременного существования явлений застойного возбуждения и наличия гипнотических фаз во второй сигнальной системе. Усиление галлюцинаций при нагрузке на вторую сигнальную систему (чтение книг, беседа и т. д.) следует объяснить суммацией возбуждения во второй сигнальной системе. Очаг патологического возбуждения, лежащий в основе вербального галлюциноза, по принципу доминанты притягивает на себя все падающие на вторую сигнальную систему раздражения и тем самым обуславливает усиление и оживление галлюцинаторного синдрома.

Зрительные галлюцинации наблюдаются редко, главным образом в темноте и при закрытых глазах (гипнагогические). Обычно они отмечаются лишь в первые дни поступления в больницу после запоя в тех случаях хронического алкогольного галлюциноза, начальная стадия которых протекала, как белая горячка. Больным мерещатся насекомые, фигуры, животные. Еще реже отмечаются обонятельные галлюцинации; при этом больные ощущают различные запахи, пища их плохо пахнет. Если же это подкрепляется голосами, которые заставляют есть, предупреждая, что пища отравлена, тогда у больных можно отметить временный отказ от пищи, причем это бывает лишь эпизодически.

Очень редко встречаются другого рода галлюцинации. Бреда у основной массы этих больных не отмечается. Они по-

нимают, что они больны, и довольно критически относятся к своему заболеванию. Поведение больных правильное, спокойное. Предоставленные самим себе, они прислушиваются к голосам галлюцинаций, мысленно беседуют с ними. Больные обнаруживают достаточную эмоциональную живость, а также и сохранность интеллекта. Они вежливы, корректны, бодро и охотно отвечают на вопросы, сами являясь активными собеседниками. У большинства больных речь складная, язык выразительный и достаточно богатый, интонации живые.

В первые месяцы заболевания больные очень тяжело реагируют на галлюцинации. В связи с этим настроение у них неустойчивое. Днем на работе они чувствуют себя более или менее удовлетворительно, вечером же, оставшись наедине с собой, особенно в тихой обстановке, испытывают страх. Иногда у больных под влиянием галлюцинаций возникают суицидальные мысли и попытки. Голоса сообщают больному, что ему так или иначе придется погибнуть, что лучше самому покончить с собой, причем говорят, что сделать это крайне легко. Все же суицидальные попытки больные совершают редко, несмотря на то, что страдания, причиняемые им постоянными голосами, довольно значительны.

Спустя полгода или год после начала заболевания больные привыкают к слуховым галлюцинациям и перестают их бояться. Лишь иногда они испытывают повышенную пугливость и страх по ночам вследствие усиления галлюцинаций, поэтому они спят ночью при зажженном свете, накрывают голову подушкой, затыкают уши ватой, чтобы не слышать голосов.

Отношение больных к внешнему миру не меняется, несмотря на беспрестанные галлюцинации неприятного содержания. Они вполне доступны, естественны, контактны, причем в контакт часто вступают по своей инициативе, откровенны, словоохотливы. Память больных обычно не отклоняется от нормы, трудоспособность не нарушается. Все больные продолжают работать по своей специальности. Заболевание этой формой носит стационарный характер и не прогрессирует. Иногда оно длится многие годы, не приводя к слабоумию и снижению личности. Однако следует отметить, что состояние больных может значительно колебаться в зависимости от употребления алкоголя. После алкогольных эксцессов голоса усиливаются, причем на первый план выступают устрашающие и угрожающие голоса, которые становятся более грозными и зловещими. Наряду с этим в период злоупотребления алкоголем могут появляться и другие галлюцинации, усиливается страх, появляется бессонница, вследствие чего в такие промежутки больных иногда приходится помещать на некоторое время в психиатрическую больницу. Вскоре после того как больной перестает употреблять алкоголь, обострение галлюциноза проходит

и восстанавливается прежнее состояние. Встречается такая форма хронического алкогольного галлюциноза, при которой отмечается бред, сопровождающий основной галлюцинаторный синдром. Этот своеобразный бред отличается от обычного тем, что он поддается в известной мере коррекции и никогда не носит нелепого характера. А. Г. Иванов-Смоленский, следуя указаниям И. П. Павлова, считает причиной галлюцинаций местное патологическое возбуждение в мозговой коре, причем в тех случаях, где это возбуждение сосредоточивается в символических корковых проекциях — во второй сигнальной системе, галлюцинации носят вербальный характер, принимая форму беседующих с больным «голосов», «звучащих мыслей» и т. п. Однако, наряду с этим, Иванов-Смоленский допускает, что галлюцинаторные явления, особенно онероидного характера, могут возникать и на фоне состояний, промежуточных между бодрствованием и сном (например, при так называемой ультрапарадоксальной фазе), т. е. на фоне сноподобного торможения коры.

Более редкой формой хронического алкогольного галлюциноза является та, при которой имеются параноидные образования, стоящие ближе к первичному бреду, чем к интерпретативному. В этих случаях имеется более диффузный бред отношения и преследования, отмечается также тенденция к систематизации бреда. После начального периода заболевания бред обычно не блекнет, а, наоборот, имеет тенденцию к некоторому прогрессированию. Коррекция бреда почти невозможна, однако и здесь бред не носит нелепого характера. Наконец, следует упомянуть о рецидивирующей форме алкогольного галлюциноза, обострение которого появляется только после алкогольных эксцессов и длится по 6—7 дней, причем постепенно продолжительность этих приступов увеличивается. В год бывает до 10 подобных обострений и более. Обострения рецидивирующего галлюциноза наблюдаются обычно после кратковременных периодов опьянения. Характерной клинической особенностью для всех видов хронического алкогольного галлюциноза является описанная нами высокая внушаемость содержания галлюцинаций. Следует лишь сказать больному, что он слышит те или иные голоса, как он немедленно начинает их слышать. Подобная внушаемость отмечается также в отношении осязательных и обонятельных галлюцинаций. Например, врач заявляет больному: «Вы слышите голоса о вине», — и больной слышит: «вино вызывает алкоголизм, оно к хорошему не приводит, если выпить много, а ты пьешь много, а ты денатурат пьешь». Врач говорит: «Вы ощущаете запах вина», — и больной действительно начинает ощущать запах вина и т. п.

Течение хронического алкогольного галлюциноза отличается стационарным характером. В части случаев при полном

воздержании от алкоголя с годами отмечается некоторое ослабление галлюцинаторного синдрома, но спонтанно он никогда не затухает. Иногда наблюдается обострение симптомов галлюциноза, зависящее от алкогольных эксцессов, причем клиническая картина этих обострений напоминает острый период болезни.

У большинства таких больных отмечаются нерезко выраженные изменения личности, характерные для алкоголиков: чрезмерная лабильность и подвижность эмоциональной сферы, некоторая поверхностность суждений, юмор алкоголиков и др. Но даже спустя многие годы после начала заболевания обычно не обнаруживаются каких-либо выраженных признаков интеллектуального снижения.

Однако в ряде случаев, несмотря на относительную сохранность формальных способностей, отмечается некоторое снижение психической активности. Последнее, по нашему мнению, обусловлено не столько непосредственно деструктивным процессом, сколько быстрой функциональной истощаемостью корковых клеток. У такого рода больных отмечается непрерывная фиксация внимания на объектах галлюцинаторного мира. Их доминирующие переживания заключаются в непрерывной борьбе с голосами и тревожными мыслями, которые возникают в связи с устрашающими и угрожающими или насмешливыми голосами.

От этих переживаний зависит соответствующая окраска аффективной сферы больного. Все остальное нередко отходит на задний план.

Следовательно, психика таких больных характеризуется теми дефектами, которые неизменно возникают на почве односторонней направленности сознания на определенный круг явлений, имеющих отношение только к аффективной стороне личности больного.

Такого рода направленность не может не привести к некоторому психическому оскудению, выражающемуся в понижении реактивности в отношении объектов реального мира и особенно психической активности в ее обычных проявлениях.

Таким образом, некоторое ослабление психических функций, возникающее на этой почве, отчасти носит вторичный характер. Ни в одном случае, по нашим наблюдениям, хронический алкогольный галлюциноз не заканчивается грубыми изменениями психики в виде деменции, корсаковского психоза и пр. Многие авторы хронический алкогольный галлюциноз относили к шизофрении, что мы считаем в корне неправильным, ввиду глубокого различия в их клиническом симптомокомплексе и картине исходных состояний. Основным этиологическим фактором хронического алкогольного галлюциноза является алкоголь. Среди дополнительных факторов первое место занимает травма головного мозга. Этот фактор следует

признать одним из наиболее способствующих хроническому течению алкогольного галлюциноза. Некоторую вспомогательную роль при этом могут играть также хронические заболевания органов слуха. Характерологические особенности больных не играют той роли в возникновении заболевания, какую им приписывает большинство зарубежных авторов. Несомненную роль в патогенезе хронических алкогольных галлюцинозов играет фактор дебильности, обусловленный травмами, перенесенными в детском возрасте, или другими органическими заболеваниями мозга. Престарелый возраст также способствует хроническому течению заболевания. У изученных нами больных отмечалось нередко сочетание указанных патогенетических факторов. Особое значение в патогенезе хронических алкогольных галлюцинозов имеет нарушение обмена веществ, которое, согласно нашим данным, может наблюдаться даже спустя многие годы после отказа от алкоголя. При хроническом алкогольном галлюцинозе нарушается функция печени, доказательством чего служит характерная сахарная кривая после сахарной нагрузки. Почти у всех больных отмечается стойкая билирубинемия, большая лабильность суточных колебаний сахара и пр.

Лечение. Наши данные о лечении больных хроническим алкогольным галлюцинозом показывают, что при этом тяжелом заболевании в ряде случаев можно добиться значительных успехов. Иногда даже однократное введение сернокислого атропина, адреналина, сернокислой магнезии, фенамина, кофеина, люминала, амитал-натрия, аминазина и др. значительно ослабляет или на некоторый срок устраняет галлюцинации при хроническом алкогольном галлюцинозе. Систематическое лечение атропином, сернокислой магнезией в сочетании с глюкозой, микродозами иода и брома, а также диатермия УВЧ головы позволяли нам в отдельных случаях добиваться полного излечения. Само понятие «хроник» должно подвергнуться пересмотру. Больные, считавшиеся неизлечимыми хрониками, при соответствующей строго индивидуальной терапии излечивались, и галлюцинаторный синдром у них не наблюдался в течение ряда лет. Однако в некоторых случаях хронического алкогольного галлюциноза лечение не дает надлежащего успеха.

Обычно мы проводили лечение больных хроническим алкогольным галлюцинозом по следующей схеме: вначале применялась дезинтоксикационная терапия с назначением внутривенно по 10 мл 40% раствора глюкозы в сочетании с 4 мл 40% раствора уротропина в течение 10 дней. Затем проводился курс инъекций (1:1000) Sol. Atropini sulf. по 0,25—0,5—1 мл в течение 1 месяца. Одновременно мы назначали УВЧ терапию головы (лобной, затылочной, височной области), начиная от 5 до 20 минут в течение 20 дней. В после-

дующем проводили внутривенное вливание 40% раствора Magnesiaе sulfurici по 4 мл в сочетании с 40% раствором глюкозы по 10 мл в течение 15 дней и в течение полугода давали микроиод по следующей прописи:

Rp. Jodi puri 0,03
Natrii jodati 0,5
Aq. destillatae 200,0
MDS. По 1 столовой ложке 2 раза в день после еды

Глава IX

АЛКОГОЛЬНЫЙ БРЕД (АЛКОГОЛЬНЫЙ ПАРАНОИД)

Алкогольный бред представляет собой остро, подостро или хронически протекающий психоз, основным симптомом которого является бред (ближе стоящий к первичному бреду), бредовая интерпретация окружающего, тревога, страх и психомоторное беспокойство в остром периоде.

До настоящего времени многие иностранные авторы необоснованно относят алкогольный бред к заболеваниям шизофренического круга. Блейлер высказал предположение, что вообще около 10% всех алкогольных психозов имеет шизофреническую этиологию.

Алкогольный бред, как правило, возникает после систематической алкогольной интоксикации; в большинстве случаев развитию бреда способствует истощение, нервное перенапряжение и бессонница, появляющаяся в период абстиненции.

При заболевании алкогольным бредом, видимо, не играет роли ни длительность алкоголизма, ни возраст больного, однако мы не встречали больных с алкогольным бредом, которые злоупотребляли бы алкоголем менее 2 лет.

Клиническая картина. Алкогольный бред возникает большей частью внезапно, в некоторых же случаях развивается постепенно.

В начальном периоде заболевания могут наблюдаться зрительные и слуховые галлюцинации угрожающего характера (больные видят крыс, мышей, страшных чудовищ и пр.) и в редких случаях отмечаются обонятельные галлюцинации, расстройства сознания.

Основным же признаком заболевания является наличие бредовых идей преследования или ревности, содержание которых черпается из бредовой интерпретации окружающего. В очень редких случаях в развитии бреда известную роль играют галлюцинации, которые, впрочем, в клинической картине болезни занимают незначительное место.

Алкогольный бред является первичным, не возникает из галлюцинаций, как при алкогольном галлюцинозе и большей

частью носит систематизированный характер. Больному кажется, что он совершил тяжелое преступление, что за ним следят, его ожидают страшные мучения, он обречен, его казнят. В страхе он вскакивает, пытается убежать, кричит: «Убивают!», «Режут!» и пр. Больной убежден в том, что вместе с ним погибнет и его семья.

На вопрос врача о самочувствии больной отвечает: «Вам все известно», подчеркивая этим свою обреченность и то, что о его «делах» знает не только врач, но и все окружающие. Больной испытывает тревогу, страх. Он замечает, что окружающие подозрительно перемигиваются, подают знаки, все взоры устремлены на него.

Нередко больные считают, что их хотят отравить и для этой цели в пищу подкладывают различные яды; в связи с этим часто наблюдается отказ от пищи.

Во многих случаях поведение больных может представлять большую опасность как для них самих, так и для окружающих. Приведем пример.

У больного С. после 15-летнего злоупотребления алкоголем развился бред преследования. Ему казалось, что его и его семью должны подвергнуть жестоким пыткам, поэтому он предложил жене взять сына, пойти на железнодорожную линию и всем троим броситься под поезд. Никаким уговорам и разубеждениям жены больной не поддавался. Однажды он взобрался на подоконник в своей комнате (шестой этаж) и не слезал оттуда, несмотря на уговоры жены. Был вызван врач, которому больной в страхе заявил, что он с минуту на минуту «ждет над собой и своей семей расправы». Врачу удалось снять больного с подоконника. Была вызвана машина для перевозки больного в психиатрическую больницу. Однако вскоре после ухода врача, больной, улучив момент, схватил своего любимого двухлетнего сына и выбросил его из окна, а затем выбросился сам.

Данный случай указывает на необходимость срочного помещения таких больных в психиатрическую больницу и тщательного надзора за ними до стационарирования (рис. 32).

По окончании острого периода заболевания, большей частью кратковременного (3—4 недели), алкогольный бред постепенно теряет свою аффективную насыщенность. Больные становятся спокойными, «примиряются со своей участью». Страх ослабевает. Вскоре может появиться критика к своему состоянию и наступает выздоровление.

Подобные случаи близки к описанному проф. С. Г. Жислинным алкогольному варианту ситуационного параиоиды. В большинстве случаев алкогольный бред в дальнейшем затягивается на несколько месяцев, иногда принимая хроническое течение. Для иллюстрации приведем следующий пример.

Больной Я., 43 лет, поступил в клиническую нервно-психиатрическую больницу 9/III 1949 г. в состоянии психомоторного возбуждения.

Алкогольные напитки употребляет с 16 лет. В 1930 г. появился абстинентный синдром. С этого времени употреблял алкоголь почти ежедневно. С 1937 г. стал пить запоем каждые 2—3 месяца; с 1945 г. —

амнестическая форма опьянения. Особенно злоупотреблял алкоголем с сентября 1948 г. В конце февраля 1949 г. стал плохо себя чувствовать. Болела голова, появилась бессонница, не спал пять ночей подряд. 7/III 1949 г. ночью возникли зрительные, слуховые и обонятельные галлюцинации, которые продолжались и в последующее время. Видел много крыс, мышей, швырял в них разными предметами, слышал крики, шум голосов,

казалось, что от хлеба чем-то пахнет, боялся есть. Говорил жене, что она хочет его отравить, зарубить топором, боялся ложиться спать, плакал, высказывал бредовые идеи самообвинения. Был помещен в больницу.

Физическое состояние. Среднего роста, питание понижено, желтушная окраска кожи. Сердечные тоны приглушены, легкие без отклонений от нормы. Печень несколько увеличена и болезненна.

Неврологическое состояние. Зрачки равnomерны, реакция на свет удовлетворительная, конвергенция обоих глазных яблок достаточная. Сухожильные рефлексы равnomерные. Тремор пальцев рук. Симптом Ромберга отрицательный.

Психическое состояние. В первые дни пребывания в больнице дезориентирован в месте и времени, возбужден, громко зовет на помощь жену, утверждает, что его должны здесь убить. Отмечаются слуховые галлюцинации: слышит голоса больных, медицинского персонала, которые его всячески бранят. Часто больной закрывает глаза и в течение 10—15 минут находится в неподвижном состоянии. Когда эти явления прошли, боль-



Рис. 30. Порезы тела, нанесенные больным самому себе под влиянием бредовых идей

ной объяснил, что он хотел увидеть свою жену («она то появлялась, то исчезала»).

В дальнейшем зрительные и слуховые галлюцинации исчезли, на первый план выступили бредовые идеи отношения, преследования и самообвинения («он совершил какое-то ужасное преступление, его подозревают в шпионаже, пропил казенные вещи, воровал продукты, его хотят уничтожить») и т. п.

Ко всем лечебным мероприятиям относился со страхом, категорически отказывался от лечения инсулином («недостойн», «не заработал»). Весь день проводил в постели, в трудовые процессы втянуть его не удалось.

В таком состоянии был назначен длительный лечебный амитал-натриевый сон в течение 7 дней. В первый день лечения больной усиленно отказывался от порошков, но потом подчинился. Спал по 18—20 часов в

сутки. Спустя 3—4 дня по окончании лечения состояние больного ухудшилось: обострились бредовые идеи отношения, преследования, особенно усилились идеи самообвинения. Все время думал о своих проступках, ожидал наказания.

Постепенно состояние больного улучшалось, он начал работать в столярной мастерской, стал мягче, доступнее, бредовые идеи прошли, восстановилась работоспособность. Затем больной был переведен в дневной стационар, и вскоре выписан в хорошем состоянии.

До настоящего времени остается неясным, почему в одних случаях у больных возникает бред, в других — белая горячка, в третьих — алкогольный галлюциноз.

Этот вопрос заслуживает тщательного изучения. Повидимому, известную роль в развитии того или другого заболевания играют типологические индивидуальные особенности больного, склад его характера, тип мышления (образный, вербальный или смешанный), состояние его эндокринно-вегетативной системы и т. п.

Правильное объяснение бреда, в том числе и алкогольного, можно найти, исходя из материалистических физиологических воззрений.

И. П. Павлов, указывая, «что область бреда является, может быть, наиболее трудной и сложной для физиологического объяснения», считал, что «в основании бреда лежат два физиологических явления — патологическая инертность и ультрапарадоксальная фаза — то существующие врозь, то выступающие разом, то сменяющие одно другое».

При этом, как указывал И. П. Павлов, речь идет не о топографически обоснованных очагах, а об очагах, представляющих собой единую физиологическую систему, которые когда-то в предыдущей жизни связывались в единое «на основе совместного участия в определенном акте».

М. И. Середина, исследуя больных алкогольным бредом по рече-двигательной методике проф. Иванова-Смоленского, находила у них инертность раздражительного процесса и фазовые явления, что полностью подтверждает теоретические предпосылки И. П. Павлова.

Дифференциальный диагноз. Большие трудности представляет отграничение алкогольного бреда в остром периоде от параноидных синдромов острой шизофрении, тем более что в последнем случае, как это подчеркивает О. В. Кербинов, отсутствует шизофреническая потусторонность и мистика. Бредовые идеи связаны со средой, окружающей больного. Однако бредовые идеи при шизофренном параноиде отличаются большей диффузностью и полиморфностью (бредовые идеи преследования, воздействия, отношения, бред греховности, ущерба и т. д.).

При дифференциальном диагнозе прежде всего необходимо выяснить, из какого заболевания выкристаллизовывается параноидный синдром. Алкогольный бред возникает на почве

хронического алкоголизма, причем обычно обострение последнего предшествует бреду. Алкогольный бред не носит столь полиморфного, диффузного характера, как при шизофрении, а ограничивается в основном бредом преследования или ревности.

Если бред при шизофрении все же часто трансформируется и носит нелепый характер, то алкогольный бред всегда вытекает из понятных связей и зависит от окружающей ситуации. Кроме того, алкогольный бред не носит замысловатого характера, он конструктивно прост и всегда затрагивает аффективную сферу больных.

Эмоциональная живость, алкогольный юмор, отсутствие характерного для шизофрении нарушения мышления, контактность, доступность, более или менее выраженная естественность поведения, в большинстве случаев благоприятное течение заболевания позволяют ограничивать алкогольный бред от шизофрении.

При дифференциальном диагнозе следует также иметь в виду изредка возникающие параноидные состояния у больных с органическим поражением головного мозга. В этих случаях при психопатологических картинах, сходных с алкогольным бредом, следует учитывать органическую основу, на которой развиваются параноидные симптомы.

Лечение. При современных методах активной терапии алкогольный бред почти всегда излечим. Все больные подлежат немедленному помещению в психиатрическую больницу для специального лечения. Если заболевание затягивается дольше чем на один месяц, то при отсутствии противопоказаний больным назначают 9—10-дневный прерывистый амитал-натриевый сон. Больные должны спать не менее 20 часов в сутки. Будить их не следует; они принимают пищу и отправляют естественные надобности во время пробуждения от сна. Вначале больным дают по 0,2 г амитал-натрия, если же через 2 часа они не засыпают, то дозу амитал-натрия повышают до 0,3—0,4 г. Прием амитал-натрия повторяют после того, как больные просыпаются. Суточную дозу можно доводить до 2—4 г. Противопоказанием к применению амитал-натрия являются заболевания почек, тяжелые заболевания печени и сердечная декомпенсация.

Длительный лечебный сон можно сочетать с инсулинотерапией. Инсулин вводят в количестве 2—40 единиц, причем каждый день добавляют по 2—3 единицы. Лечебный сон и инсулинотерапия должны проводиться под строгим врачебным контролем. Перед инсулинотерапией всегда следует провести исследование на сахарную нагрузку. В легких случаях алкогольного бреда можно ограничиться симптоматической терапией в виде внутривенных вливаний 5 мг 40% уротропина в сочетании с 10—15 мл 40% глюкозы. Такие вливания проводят еже-

дневно или через день в течение 10 дней. На ночь назначают снотворные (нембутал, хлоралгидрат, сонбутал и др.). Внутримышечно вводят по 50—60 мг витамина В₁ в течение 10—15 дней.

В последнее время придают большое значение введению больным комплекса витаминов В, в том числе и витамина В₁₂. Хорошие результаты мы наблюдали от применения аминазина. Внутрь назначают бромиды, глицерофосфаты. Из физиотерапевтических процедур показаны УВЧ терапия области головы от 5 до 10 минут и хвойно-солевые ванны температуры 36°, продолжительностью 10—15 минут.

Глава X

КОРСАКОВСКИЙ ПСИХОЗ

В своей блестящей диссертации «Об алкогольном параличе» (1887) С. С. Корсаков впервые описал своеобразный психоз у алкоголиков, характеризующийся расстройством памяти на текущие и недавние события при сравнительно хорошо сохранившейся памяти на давно свершившиеся события, ретроградной амнезией, склонностью к конфабуляциям и наличием алкогольного полиневрита.

С. С. Корсаков назвал это заболевание полиневритическим психозом. В последующем С. С. Корсаков и его ученики, а также и другие исследователи углубили и уточнили учение об этом заболевании, подчеркивая, что оно может развиваться не только в связи с алкоголизмом, но и при других инфекциях и интоксикациях.

С. С. Корсаков полагал, что причиной полиневритического психоза являются вызывающие полиневрит токсины, которые влияют одновременно и на головной мозг; расширив границы происхождения этого заболевания, он назвал его в последующем токсической церебропатией.

В 1897 г. на Международном конгрессе врачей, состоявшемся в Москве, по предложению берлинского профессора Жоли этому заболеванию было присвоено наименование корсаковского симптомокомплекса; этим подчеркивалась его неспецифичность, ибо Жоли и его единомышленники возражали против нозологической самостоятельности заболевания. В мировой литературе эти возражения в основном сводятся к тому, что симптомокомплекс, подобный корсаковскому психозу, может встретиться не только при различных интоксикациях, но и при органических заболеваниях головного мозга, например, при опухолях мозга, травмах, старческом слабоумии, прогрессивном параличе, артериосклерозе и др., протекающих без полиневрита, и что наблюдаются характерные расстройства памяти на почве токсемии, но без полиневрита; наряду с этим при токсемиях может возникнуть целый ряд психозов, причем

между ними и корсаковским психозом могут встречаться переходные формы.

Исходя из этого, некоторые авторы свели корсаковский психоз к синдрому, свойственному многим органическим заболеваниям нервной системы. С другой стороны, по мнению некоторых авторов, например, М. О. Гуревича, нозологическая самостоятельность корсаковского психоза обоснована больше, чем других психозов (например, шизофрении), вследствие наличия при нем определенной этиологии, симптоматологии, течения, прогноза, исхода и патологической анатомии, т. е. всех тех требований, которые мы предъявляем к нозологической единице.

Ценные исследования, посвященные корсаковскому психозу, провели Т. А. Гейер, И. Н. Введенский, Л. М. Розенштейн, П. М. Зиновьев, В. А. Гиляровский и др.

В настоящее время название «корсаковский психоз» (в отличие от корсаковского синдрома, который может встречаться и при других заболеваниях) сохранено за теми случаями, которые имеют алкогольную этиологию и наиболее выраженную клиническую картину, описанную Корсаковым.

Корсаковский психоз развивается обычно у тяжелых алкоголиков после долголетнего злоупотребления алкогольными напитками, причем в анамнезе у этих больных нередко имеется белая горячка, гастриты, гепатиты и т. п. У многих из них Корсаков отмечал невропатическое предрасположение, алкоголизм или нервные болезни у родителей. Мы наблюдали развитие корсаковского синдрома у лиц, длительное время злоупотреблявших денатурированным спиртом. Возраст таких больных обычно старше 30 лет, хотя встречаются среди них и более молодые люди. Гарейзо описал семилетнего мальчика, у которого в результате злоупотребления спиртными напитками развился типичный корсаковский психоз, впоследствии излеченный. Женщины в большей степени подвержены заболеванию корсаковским психозом, чем мужчины. Маршан и Куртуа, наблюдавшие 550 женщин-алкоголичек, обнаружили более чем в 10% случаев корсаковский психоз. Среди 1700 мужчин-алкоголиков этот психоз они встретили только у 4%. По материалам московской лечебницы для алкоголиков, у мужчин корсаковский психоз встречается чрезвычайно редко.

Клиническая картина. Еще задолго до полного развития корсаковского психоза (1—2 года) появляется ряд предвестников — парестезии, боли в ногах ноющего характера и ломота. В ночное время отмечаются судороги в икроножных мышцах. Походка становится шаткой, неуверенной, особенно в состоянии похмелья. Появляется головная боль, головокружение, потемнение или «искры» в глазах. Психика этих больных заметно изменяется. Круг интересов суживается, психический уровень несколько снижается. Появляется беспокойст-

во, тревога, безотчетный страх, нарушается сон, беспокоят кошмары. В редких случаях подобные продромальные явления переходят постепенно в корсаковский психоз. Чаще всего такой переход связывается с каким-либо добавочным фактором в виде травмы, истощающего соматического заболевания, особенно колитов, заболеваний печени и т. п.

Начальный период корсаковского психоза во многих случаях протекает, как белая горячка. У больных нарушается сознание, они не понимают, где находятся, не ориентируются во времени, испытывают зрительные и в меньшей степени слуховые галлюцинации. Больным мерещатся крысы, собаки, кошки, крокодилы, чудовища, ящерицы, черти, обезьяны, птицы, мухи, пауки, разные чудовища (рис. 28, 29). Они слышат голоса, которые их ругают или угрожают.

Больные почти не спят или спят очень мало. Постепенно сознание проясняется, блекнут или совсем исчезают галлюцинаторные явления и на первый план выступает типичное расстройство запоминания, касающееся текущих и недавних событий, а также вырисовывается ретроградная амнезия, простирающаяся подчас на несколько лет. Больные забывают, что они женаты, имеют детей и т. п.

Однако профессиональные навыки, особенно простые, автоматические, могут до известной степени сохраняться. Мы наблюдали одного механика, который, страдая корсаковским психозом, забыл название всех частей хорошо известного ему мотора, но когда он брал отдельную деталь в руки и ошупывал ее, он догадывался, для чего она предназначена. Приведем описание основных психических расстройств в изложении самого Корсакова.

«Обыкновенно из разговора с такими больными можно заключить, что память их глубоко страдает: большей частью они сейчас же позабывают то, что с ними сделалось, забывают, кто у них только что был, то, что они больны, и т. д. Но это не у всех; у других хотя память и слабеет, но далеко не в такой степени».

«Когда эта форма наиболее характерно выражена, то можно заметить, что почти исключительно расстроена память недавнего; впечатления недавнего времени как будто исчезают через самое короткое время, тогда как впечатления давнишние вспоминают довольно хорошо; при этом сообразительность, остроумие, находчивость больного остаются в значительной степени. Так, например, больной не может вспомнить, пообедал он или нет, хотя только что убрали со стола, а между тем играет хорошо в преферанс, в шашки. При этом он действует предусмотрительно, наперед видит последствия опрометчивого хода своего противника и может вести игру, руководствуясь во все время одним планом. Если все партнеры сидят на своих местах, он хорошо представляет себе ход игры, но когда слу-

чайно пересядут, он не в состоянии продолжать игру. Только что убрали шашки или карты, все следы игры скрыли, он позабывает об игре и говорит, что давно не играл. То же самое относительно лиц: больной узнает их, если видел до заболевания, рассуждает, делает свои замечания, часто остроумные и довольно находчивые, по поводу того, что он слышал от этих лиц; может поддержать разговор, довольно интересный, а чуть голько ушли от него, он готов уверять, что у него никого не было. Если лицо, с которым он говорил минуты за две до данной минуты, снова войдет и спросит, видел ли он его, больной отвечает: „Нет, кажется, не видел”».

«Имен лиц, которых он не знал до начала болезни, он не в состоянии запомнить, а каждый раз эти лица являются для больного как бы совершенно незнакомыми. Вообще память ограничивается только тем, что было до начала болезни; то же, что было после начала болезни, больной совершенно не помнит. Контраст полнейшей амнезии относительно недавнего и сравнительной стойкости памяти давнего поразительный».

«Если долго говорить с больным, то поражающая с первого раза его находчивость, остроумие, окажутся очень небольшими: 1) окажется, что для своих рассуждений больной пользуется исключительно старым, давно накопленным материалом; впечатления же нового времени почти не входят в состав его мышления; 2) и из старого-то у больного возникают по преимуществу рутинные комбинации, давно заученные фразы; 3) круг идей среди которых вращается мышление больного, делается крайне узок, и в этих узких рамках большей частью совершаются все однообразные комбинации».

«Такие больные очень монотонны; мышление их большей частью вызывается не внутренней потребностью, а внешними впечатлениями: начнут с ними говорить — он начинает говорить, увидит вещь — сделает свое замечание, но сам ничем не интересуется. Из данной посылки, впрочем, больные могут делать верные умозаключения, чем и объясняется довольно искусная игра в шашки и карты, когда на столе положение шашек и запись дают возможность больному сразу определить свое положение в данную минуту, не прибегая к воспоминаниям».

«У этих больных все одни и те же как бы заученные комбинации, но жизненности, вдохновения нет и следа. Интересов решительно, никаких нет, кроме интересов физических: поесть, попить, поспать, покурить. К своему положению больные относятся большей частью поверхностно, хладнокровно. Многие из них понимают, что у них памяти нет, но не придают этому серьезного значения. Удивившись, например, что он забыл, что только что он со мной виделся, больной говорит, что, впрочем, всегда у него память была не особенно хороша, и больше об

этом не думает. Мучительного процесса неудающегося воспоминания, которое бывает у здоровых людей, у них обыкновенно не существует».

«Все переживаемые события не представляются в сознании в определенной временной перспективе, иногда эта перспектива времени существует, но она очень неглубока, т. е. все давнишние представления кажутся гораздо ближе к настоящему, чем они на самом деле».

«Иногда у таких больных бывает много ложных воспоминаний (псевдореминисценции) вследствие чего они рассказывают небылицы о своем времяпровождении — о небывалых поездках, помещениях, смешивают незнакомых лиц со знакомыми».

Это описание, принадлежащее самому С. С. Корсакову, несмотря на наличие большого числа исследований по данному вопросу, является непревзойденным. Наряду с указанными выше формами, Корсаков описал более тяжелое течение этого заболевания, когда, наряду с расстройством памяти, отмечается крайняя вялость, апатия или спутанность сознания, бред, беспокойство. Как видно из всего изложенного, основным симптомом заболевания у больных является резкое расстройство способности запоминания и репродукции.

Параллельно с этим наблюдается ретроградная амнезия, т. е. выпадение из памяти некоторого промежутка времени, предшествовавшего заболеванию. Однако ученики С. С. Корсакова высказывали большие сомнения относительно ретроградной амнезии, в частности, В. Н. Сербский отрицал ретроградную амнезию при корсаковском психозе. Вследствие грубых нарушений памяти ее провалы больными не осознаются, они не доходят до сознания и заполняются конфабуляциями и бредовыми построениями. М. О. Гуревич и М. Я. Серейский подчеркивают, что эти конфабуляции можно суггестивно направлять в ту или иную сторону. Однако расстройства памяти не всегда бывают так серьезны, как это кажется на первый взгляд. При известной упражняемости больные могут еще кое-что запомнить. В части случаев память хотя и расстраивается, но у больных все же могут удерживаться эмоционально окрашенные впечатления, они способны иногда вспоминать некоторые факты из своей жизни — как из давнего прошлого, так и касающиеся ближайших событий. Сознание у больных сравнительно ясное, и по первому впечатлению, производимому, ими, трудно себе представить тяжесть их заболевания. Способность ассоциировать представления расстраивается. Активное внимание почти не изменяется, ориентировка же значительно нарушена.

В окружающем больные ориентируются с трудом, «главным образом по догадке». В. А. Гиляровский подчеркивает, что когда больного помещают в лечебное учреждение, он быстро

догадывается, что имеет дело с врачами, медицинским персоналом и т. п., причем если спросить его, где он находится, то он обычно называет какое-нибудь учреждение, знакомое ему по прежнему опыту. Ориентировка во времени значительно расстраивается. Больной не может правильно назвать число, месяц и год. Он не может себе представить, как долго находится в больнице, не может вспомнить, когда произошло то или иное событие — сейчас или год назад.

Л. М. Розенштейн подчеркивает, что у больных все же сохраняется способность воспроизведения. Например, больной не может вспомнить имя своего врача или кого-либо из окружающих, но если при перечислении различных произвольных имен вставить нужное ему имя, больной почти безошибочно узнает его.

В последнее время подчеркивается, что при корсаковском психозе не только расстраивается память, но и изменяется вся психика в целом.

Интеллект снижается. Больные теряют инициативу, тупеют. Суждение их ослабевает. Они часто становятся нетрудоспособными вследствие грубых расстройств памяти и не могут выполнять свои профессиональные обязанности. В. А. Гиляровский говорит об известном огрубении психики, о некотором ослаблении психического тонуса. Крепелин также указывает на тяжелые нарушения интеллекта, не зависящие от расстройства памяти. Эти больные становятся «психически неповоротливыми», ребячливыми, непонятливыми. Нередко отмечаются бредовые идеи преследования, отравления и т. п. При наличии явлений слабоумия могут также возникать нелепые идеи или идеи величия. В тяжелых случаях больные перестают заботиться о себе, неподвижно лежат в постели, неряшливы, не умываются, ибо считают, что уже привели себя в порядок. Обычно такие больные тихо лежат, лицо их сохраняет спокойное выражение, мимика вялая, взгляд устремлен в одну точку. Если к ним не обращаются, они самостоятельно в разговор не вступают. Мышление их, повидимому, ничем не занято, и нужен какой-то внешний стимул, чаще всего в виде разговора, чтобы заставить их мысль работать. Наряду с этим бывают ажитированные больные, особенно те, у которых отмечаются иллюзии зрения или парестезии, причиняющие им беспокойство. Наблюдаются также ступорозные больные, в основе заболевания которых лежит тяжелое органическое поражение мозга.

Со стороны нервной системы на первый план выступают явления алкогольного полиневрита различной интенсивности. В различных частях тела отмечаются боли и парестезии, выраженные в той или иной степени. Парестезии в основном сводятся к ощущению ползания мурашек, присутствия чего-то постороннего в конечностях; эти ощущения в разгар заболевания сменяются чувством холода и давящей боли в конечно-

стях. Больным кажется, что конечности их забинтованы. Нервные стволы и мышцы болезненны при надавливании. Расстройство кожной чувствительности — по дистальному типу. Сухожильные рефлексы часто исчезают или ослаблены, но иногда отмечается их повышение. Кожные рефлексы сохраняются долгое время, иногда наблюдается мышечная атрофия с контрактурами. Симптом Ромберга положительный. Отмечается атаксия, дрожание пальцев рук, шаткая походка, иногда паралич глазных нервов.

Нередко бывают выражены трофические и сосудодвигательные расстройства в виде общего похудания, дряблости, отеков. Внешний вид больных значительно изменяется, появляются одутловатость и обрюзглость.

Для примера приведем одну историю болезни.

Больной Д., 40 лет, жалуется на боли в руках и ногах. Отец больного алкоголик. Больной родился в срок, развивался правильно. В дошкольном возрасте перенес корь, ветряную оспу, паратиф. По характеру был общительным, но упрямым и настойчивым. Учиться начал с 9 лет, окончил 5 классов железнодорожного училища, причем учился хорошо. В возрасте 16 лет поступил в фельдшерскую школу, которую окончил в 1917 г. В 1923 г. окончил медицинский институт. С 1923 г. работал хирургом в Башкирии, а с 1932 г. — в Московской области. По словам товарищей, проявлял себя способным хирургом. В 1934 г. уехал в бухту Ногаево, где пробыл до 1937 г. В 1921 г. болел сыпным тифом, давшим осложнение со стороны мозга; при этом отмечалось содружественное косоглазие. В 1926 г. перенес малярию в тяжелой форме. В 1934 г. болел острым суставным ревматизмом, в 1936 г. — колитом.

Злоупотреблять алкоголем начал с 1926 г. Пил водку, вино, разведенный спирт. С 1927 г. абстинентный синдром. Постепенно дозы алкоголя начал увеличивать, выпивая по 0,5—1—1,5—2 л водки в день.

В 1934 г. перенес белую горячку, по поводу чего лечился в психиатрической больнице. С 1934 по 1938 г. употреблял алкоголь систематически, но все же умеренно. С января 1938 г., находясь в отпуску, начал снова злоупотреблять алкоголем. Почти ежедневно выпивал по 0,75—1,5 л водки. Жена больного характеризует его до заболевания как веселого, общительного, отзывчивого человека, увлекавшегося своей работой. С марта 1938 г. у больного появилась утомляемость, раздражительность. В конце апреля перенес грипп с повышением температуры, жаловался на двоение в глазах. В начале мая отмечалось кратковременное значительное повышение температуры, напоминавшее малярийный приступ. С 3/V у больного обнаружили явления язвенного стоматита. Он перестал принимать пищу, пил лишь воду, резко ослабел и был помещен в местную терапевтическую больницу. Там была установлена картина язвенного стоматита и дерматита кожи мошонки. По вечерам держалась субфебрильная температура. Отмечено повышение РОЭ (40 мм в час), умеренный гиперлейкоцитоз (9400).

С 14/V появились зрительные галлюцинации: больной видел входящих в комнату людей, сидящего на абакуре сотрудника больницы; он вскакивал с кровати, провозглашал тосты за жену и других лиц. Не спал, был беспокоен. Удовлетворительно ориентировался в окружающей обстановке, но неправильно ориентировался во времени. Неверно называл число и месяц, путал даты прошлых событий, жаловался на головную боль, головокружение. Временами нарушалось сознание, не узнавал жены и окружающих. Ввиду выявившегося психического расстройства был переведен 22/V в психиатрическую клинику.

Физическое состояние. Кожа и слизистые покровы бледны, лицо одутловато. Язык обложен. При пальпации живота отмечается болезненность по ходу тонких кишок. Печень увеличена и болезненна при пальпации. Запоры, чередующиеся с частыми поносами. Сердце не увеличено, тоны сердца значительно приглушены, пульс не учащен, удовлетворительного наполнения.

Неврологическое состояние. Пателлярные рефлексы и рефлексы с ахиллова сухожилия отсутствуют. Резкая болезненность нервных стволов. Болевая чувствительность понижена, больше к периферии (на ногах).

Психическое состояние. В первые дни пребывания в клинике сознание неясное. В дальнейшем больной обнаруживает понимание своего болезненного состояния и адекватно переживает его. Ориентировка во времени и месте нарушена; на вопросы, какое число, месяц, год, отвечает неправильно. В течение всего дня на вопрос, который час, называет только утренние часы: 10—11 часов. На вопрос, в каком городе находится, всегда называет Уфу или Самару. Если спрашивают, сколько времени находится в клинике, всегда отвечает, что один день. Охотно вступает в контакт, всегда старается удержать у себя врача, подчеркивая, что ему скучно без собеседника. К окружающим обращается только с просьбой дать закурить или принести ему спиртные напитки.

Вначале отмечались зрительные галлюцинации: видел красноармейцев, чистящих винтовки, лошадей, различные фронтовые картины. Активное внимание понижено, интересы ограничиваются физиологическими потребностями, причем по мере удаления в прошлое амнезия выражена слабее.

Легко вспоминает, подробно и в хронологическом порядке о своем раннем детстве и школьных годах. Часто датирует одним временем два несовместимых (по времени) события, не замечая этого противоречия. Например, окончание фельдшерской школы и медицинского института относит к 1917 г. При напоминании отдельных событий радуется заполнению пробелов памяти. Заполняет пробелы в памяти конфабуляциями. Так, на вопрос врача, видел ли он его, отвечает, что был с ним знаком и работал вместе в Уфимской больнице. Боль и ломоту в ногах пытается объяснить совершенными им прогулками и путешествиями. Забывая о своем полиневрите, пытается производить быстрые движения, тут же прекращает их и заявляет окружающим о своих болезненных ощущениях. При затруднениях в ответе из-за расстройства памяти проявляет большую изворотливость, отделяясь от прямого ответа шуточной или общей фразой. Беседуя с женой, предпочитает больше задавать вопросы, чем отвечать на них, или отвечать на вопросы вопросами. Только что происшедшие события относит к более или менее отдаленным; так, через полчаса после произведенной пункции на вопрос, сделана ли ему пункция, отвечает, что сделана несколько дней назад. Жалуется, что очень долго тянется день. Текущие события при непосредственной репродукции воспроизводятся, но через короткие промежутки времени забываются. Так, например, больной много раз в день здоровается с врачом, заявляя, что видит его сегодня в первый раз. При этом обнаруживается, что те или иные быстро забытые восприятия он продуцирует в дальнейшем, но в искаженной хронологической последовательности. Забывая имя и отчество врача, догадывается об этом при назывании его инициалов. Производит беззвучное движение губами и как бы пытается вспомнить искомую моторную форму для произнесения спрошенного у него имени.

Запас знаний и представлений, полученных больным в более близком прошлом, оказывается в значительной степени утраченным при требовании восстановить их спонтанно. На специальные же вопросы из области врачебных знаний, приобретенных много лет назад, дает правильные ответы. Настроение неустойчивое, временами апатичен; при этом проскальзывает живая эмоция с депрессивным оттенком, которую он связывает со своим тяжелым заболеванием.

Часто бывает благодушен, склонен к юмору, причем шутки носят плоский характер. Безинициативен, аспонтанен. Оставаясь в одиночестве, быстро засыпает. В беседе с врачом выявляется быстрая истощаемость; при этом амнестические нарушения резко усиливаются.

В дальнейшем состояние больного постепенно улучшалось. Он стал более точно ориентироваться во времени, улучшилась память, часто вспоминает мелкие факты из своей жизни, а также из жизни больницы. Через 5½ месяцев состояние больного улучшилось, и он был выписан.

Изучая нейродинамику больных тяжелой формой корсаковского психоза, мы установили, что замыкание условной связи у них затруднено, как на раздражитель первой, так и на раздражитель второй сигнальной системы. После образования условной связи она отличается крайней непрочностью. Обобщение получается только на самый близкий раздражитель. На отдельные раздражители зрительного анализатора не только нет обобщения, но и крайне затруднена выработка условной связи. В простой динамической структуре между непосредственным раздражителем и обозначающим его словом не только нет связи по механизму элективной иррадиации, но даже, очевидно, существует торможение, так как после выработки условной связи на слово условная связь на непосредственный раздражитель не замыкается, и наоборот. Кроме того, в ряде случаев на слово «нажмите» больной не дает даже основной реакции. После выработки условной связи на слово тормозится ранее выработанная условная связь на непосредственный раздражитель. Появляется иногда своеобразная парадоксальная фаза, когда больной не отвечает двигательной реакцией на слово, а двигательная реакция появляется лишь в паузах, т. е. на след словесного раздражителя. Особенно резкие нарушения отмечаются в корковом маршруте С—С и менее всего нарушается связь в корковом маршруте Н—Н¹. В легких случаях корсаковского психоза нарушения корковой динамики менее выражены. Исследования в этой области мы продолжаем. Обычно у всех больных корсаковским психозом затормаживаются наиболее молодые в онтогенетическом развитии условные связи. Условные связи, имеющие отношение к профессии больного, являются наиболее прочными. Вследствие быстрой функциональной истощаемости корковых клеток больные при беседе быстро устают и у них развивается запредельное охранительное торможение, переходящее в сонное торможение.

Течение и прогноз. Если клиника корсаковского психоза изучена прекрасно, то катамнез этих больных, исход заболевания выяснены еще недостаточно. Представляет интерес случай корсаковского психоза, приводимый И. Г. Равкиным и описанный в 1925 г. Л. М. Розенштейном.

¹ Подробное описание явлений, обозначаемых, как маршруты Н—Н и С—С дано выше (см. стр. 69).

Больная С. В возрасте 16 лет появился корсаковский психоз, причем диагноз полиневритического психоза установил сам Корсаков. В 55-летнем возрасте, т. е. спустя 39 лет после начала заболевания, у больной обнаружилось резкое расстройство памяти по корсаковскому типу и полиневритические явления. В этом случае следовало ожидать слабоумия вследствие указанных выше дефектов памяти, граничащих с полным ее отсутствием. Однако, несмотря на почти сорокалетнюю давность заболевания, у больной не наблюдалось слабоумия. Она почти все время работала, хорошо справляясь со своими обязанностями, правильно ориентировалась в окружающей обстановке, отличалась находчивостью и настолько компенсировала свой дефект памяти, что окружающие считали ее здоровой. Однако прежде чем указать свой адрес и телефон, больная должна была посмотреть в записную книжку.

Мы катанестически проследили на протяжении от 3 до 12 лет 8 больных корсаковским психозом. У всех у них заболевание носит регрессиентный характер. У 2 больных трудоспособность настолько восстановилась, что они вернулись к несложной работе; у двух оказалась стойкая инвалидность без дальнейшего ухудшения заболевания, причем в одном случае алкоголизм сочетался с травмой; у 4 больных отмечалось заметное улучшение.

Корсаковский психоз имеет обычно хроническое течение. Ступорозная форма всегда протекает остро. В легких случаях возможно выздоровление без заметных дефектов. В течение года или меньшего периода все явления постепенно сглаживаются, восстанавливается память. Таким образом, болезнь имеет тенденцию скорее к регрессиентному, чем к прогрессиентному течению. Быстрее всего проходят полиневритические явления. В молодом возрасте шансов на выздоровление больше, чем в пожилом. Некоторые больные становятся слабоумными вследствие органического поражения головного мозга. Корсаковский психоз, протекающий злокачественно, обычно заканчивается через 1—2 года смертью вследствие геморрагического пахименингита или полиоэнцефалита и других случайных причин. Прогноз всегда следует ставить с осторожностью, так как даже в благоприятно протекающих случаях дефекты памяти остаются в течение длительного времени.

Патологическая анатомия. Наряду с изменениями, характерными для хронического алкоголизма, при корсаковском психозе находят диффузную гибель клеток коры мозга. Поражение клеток бывает наиболее выражено во втором и третьем корковом слое.

Нервные волокна на различном протяжении обнаруживают картины распада, особенно резко выраженного в области центральных извилин и распространяющегося до сонопа радиативной и внутренней капсулы.

Гампер (Gampfer) считает, что поражение локализуется главным образом в стволовой части мозга, причем процесс этот не воспалительный, на что еще ранее указывал Бонгеф-

фер. Во всех случаях корсаковского психоза Гампер находил поражение мамиллярных телец, а в резко выраженных случаях — их атрофию. Он подчеркивает, что во всех изученных им случаях корсаковского психоза имелось избирательное поражение мозга, в основном центров вегетативной нервной системы.

Однако одним поражением мамиллярных телец нельзя объяснить амнестический синдром, как это упрощенно делает Гампер, ибо при корсаковском психозе поражаются сложные синтетические функции, связанные с корой мозга.

Значительные изменения наблюдаются также и в спинном мозгу, где на значительном расстоянии отмечается исчезновение волокон, особенно в столбах Голля. Альцгеймер (Alzheimer) находил при корсаковском психозе настоящие энцефалитические фокусы, в которых все клетки сосудистой стенки интенсивно разрастаются и дают начало отросткам сосудов и большим фибробластам. Иногда наблюдаются и другие изменения сосудов, в частности, их гиалиновое перерождение. В результате поражения сосудов появляются мелкие кровоизлияния.

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з. Диагностика корсаковского психоза не вызывает особых затруднений. Однако в ряде случаев, особенно при корсаковском синдроме, наблюдаемом при других заболеваниях, могут встречаться известные трудности.

От корсаковского синдрома травматической этиологии корсаковский психоз отличается тем, что при первом наблюдается острое начало, а также быстрое развитие синдрома, при втором же амнестические нарушения развиваются постепенно.

Однако уже сама травма головного мозга может явиться результатом начавшегося корсаковского психоза. Ясность в этот вопрос вносит анамнез. От прогрессивного паралича корсаковский психоз отличается прежде всего анамнезом. В последнем случае в анамнезе имеется алкоголизм, а при прогрессивном параличе — сифилис и положительная реакция Вассермана в ликворе. Далее при прогрессивном параличе отмечается общая потеря памяти, паралитические инсульты с преходящими параличами, рефлекторная неподвижность зрачков, расстройство речи, медленное развитие болезни.

При артериосклерозе на первый план выступают мозговые очаговые явления.

Л е ч е н и е. Больные корсаковским психозом подлежат стационарному лечению по крайней мере в течение острого периода.

Воздержание от алкоголя уже само по себе является оздоровляющим фактором, что без стационарирования трудно осуществить. Кроме того, возбуждение, нарушение ориентировки и

грубые расстройства памяти инвалидизируют больного и лишают его возможности следить за собой.

В начале заболевания при делириозных явлениях применяют такое же лечение, как при белой горячке. Весьма обнадеживающие результаты дает инсулинотерапия¹, сочетанная с лечебным сном, при своевременном назначении которых, по видимому, исключается возможность перехода белой горячки в корсаковский психоз. В связи с работами, подчеркивающими значительное нарушение витаминного обмена при корсаковском психозе, рекомендуются витамины В₁ В₂ В₆ и В₁₂.

Витамины, особенно витамин В₁₂, благоприятно влияют на полиневритические явления, которые после витаминотерапии быстро исчезают. Большую пользу при атрофии мышц, параличах и т. п. может принести массаж, гимнастика, фарадизация.

В качестве общеукрепляющего средства рекомендуется общее облучение кварцем. Известную роль может сыграть дезинтоксикация, что особенно важно в первые дни. Это достигается при помощи внутривенного введения гипертонических растворов глюкозы и сернокислой магнезии. Для улучшения памяти нужно применять ряд упражнений. О целесообразности таких упражнений говорит Грегор, который подобным образом добивался некоторого улучшения памяти и запоминания.

Необходимо тщательно следить за соматическим состоянием больных, в частности, предупреждать пролежни. Длительное пребывание в постели у наиболее слабых больных может привести к ряду серьезных трофических изменений в виде трудно заживающих пролежней. Кожа больных должна содержаться в чистоте. Подвергающиеся давлению части тела следует регулярно обтирать винным спиртом, смазывать камфорным спиртом и хотя бы раз в декаду облучать кварцем.

¹ При наличии грубых органических изменений инсулинотерапия не дает эффекта.

Г л а в а X I

АЛКОГОЛЬНЫЙ ПСЕВДОПАРАЛИЧ

Алкогольный псевдопаралич получил свое название ввиду сходства с прогрессивным параличом. Однако в этиологическом отношении между этими заболеваниями нет ничего общего. Алкогольный псевдопаралич встречается у лиц, длительное время злоупотреблявших алкоголем и особенно суррогатами алкоголя, в частности, денатурированным спиртом. Из 12 больных алкогольным псевдопараличом, наблюдавшихся нами, у семи отмечалось длительное злоупотребление денатурированным спиртом.

Алкогольный псевдопаралич развивается главным образом у истощенных алкоголиков с резким расстройством питания, нарушением обмена веществ при наличии гиповитаминоза или авитаминоза, однако он может развиваться и у алкоголиков с **внатуршенным питанием.**

Крепелин указывал, что в большинстве случаев алкогольный псевдопаралич представляет собой сочетание хронического алкоголизма с прогрессивным параличом, либо с сифилитическими или артериосклеротическими заболеваниями сосудов.

Мы не разделяем этой точки зрения. В случаях, о которых упоминает Крепелин, следует говорить о сочетании хронического алкоголизма с прогрессивным параличом, артериосклерозом головного мозга и т. д., но не об алкогольном псевдопараличе.

К л и н и ч е с к а я к а р т и н а. Еще задолго до появления алкогольного псевдопаралича у больного наблюдаются эпилептиформные припадки, один или несколько приступов белой горячки или острого алкогольного галлюциноза. Больные плохо справляются с работой, быстро утомляются. Лица, занимающиеся интеллектуальным трудом, поражают окружающих необычайной рассеянностью, забывчивостью; срочные дела они не могут выполнить во-время, нуждаются в неоднократных напоминаниях, причем свою несостоятельность оправдывают разного рода отговорками. В конце концов, они теряют трудоспособность и вынуждены лечь в больницу.

Иногда больные выглядят истощенными, однако во многих случаях питание их может и не нарушаться. Отмечаются глухие тоны сердца, ослабление его функциональной способности, болезненность при пальпации печени ввиду алкогольного гепатита, катарр желудочно-кишечного тракта, т. е. выраженные изменения внутренних органов, характерные для алкоголизма.

У таких больных в тяжелых случаях наблюдается мышечная гипертония, патологические хватательные рефлексы, вялая реакция зрачков на свет, расстройство речи, быстрая

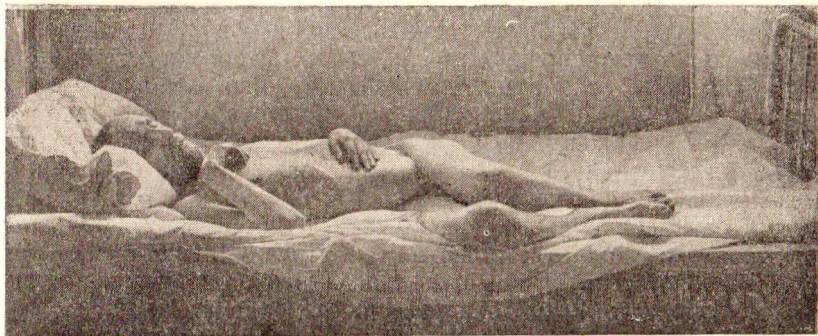


Рис. 31. Больной алкогольным псевдопараличом.

истощаемость, боли в конечностях. В легких случаях и в случаях средней тяжести зрачковые реакции не нарушаются, отмечается лишь изменение сухожильных рефлексов (то повышение, то понижение, а иногда и полное их отсутствие), полиневритические явления, парестезии, тремор пальцев рук, иногда незначительные расстройства речи. В крови отмечается билирубинемия, резкая лабильность сахарной кривой, иногда значительно выраженная гипогликемия. У одного больного алкогольным псевдопараличом, сопровождавшимся эпилептиформными припадками, мы обнаружили падение сахара в крови до 48 мг%. Количество холестерина снижается. Отмечается ядерный распад, сдвиг формулы крови влево, падение гемоглобина, нарушение витаминного обмена — понижение содержания витаминов С, В₁, РР (рис. 31).

Со стороны психики у большинства больных отмечается оглушенность, быстрая истощаемость вследствие повышенной функциональной истощаемости корковых клеток и наступления явлений запредельно-охранительного торможения. Несколько минут больные правильно отвечают на вопросы, неплохо считают, затем начинают что-то бормотать, высказывать неудовольствие, что им «не дают покоя разными вопросами да рас-

спросами», стараются ускользнуть от ответов, допускают грубые ошибки в счете; наконец истощаемость доходит до столь высоких пределов, что больные просто перестают отвечать на вопросы и вообще слушать собеседника. Устремив взгляд в одну точку, они впадают в состояние сонливости.

Картина заболевания, повидимому, сводится к резко выраженной истощаемости психики и функциональной слабости клеток коры головного мозга с развитием явлений запредельного охранительного торможения в результате длительной интоксикации алкоголем.

Наряду с этим наблюдаются зрительные и слуховые галлюцинации, но галлюцинаторные образы однообразны и носят малоподвижный характер. Больные производят впечатление оглушенных, погруженных в себя, заторможенных. Их эмоциональная сфера отличается крайней неустойчивостью. В силу резко выраженной функциональной истощаемости корковых клеток они ни к чему не проявляют интереса, не оживляются при виде близких людей, не высказывают никаких желаний, безразлично относятся к лечению. Комбинаторные способности у них резко ослаблены, ассоциативные процессы затруднены, латентный период ответной словесной реакции удлинен. Ассоциации носят примитивный, а иногда и эхололический характер. Критика до некоторой степени сохранена. Иногда появляются бредовые идеи ревности, величия или преследования. Однако они непрочны и не носят систематического характера. Память может резко расстраиваться, причем нередко имеют место конфабуляции. В некоторых случаях алкогольный псевдопаралич в силу ярко выраженных бредовых идей величия и значительного нарушения критики весьма напоминает прогрессирующий паралич.

Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з. От прогрессирующего паралича алкогольный псевдопаралич отличается течением. Это заболевание, достигнув вершины своего развития, в дальнейшем не прогрессирует, а, наоборот, имеет тенденцию к обратному развитию, заканчиваясь нередко выздоровлением или улучшением. В наиболее злокачественно протекающих случаях болезнь приводит к смерти. В отличие от прогрессирующего паралича плеоцитоз отсутствует, серологические реакции отрицательные. От инсульта алкогольный паралич отличается постепенным развитием расстройств речи (при инсульте речевое расстройство наступает сразу). Известные затруднения возникают при дифференцировании алкогольного псевдопаралича от артериосклеротических расстройств, когда, наряду с полиневритическими нарушениями, на первый план выступают очаговые симптомы, гемиплегия, афазические, агностические и апрактические явления.

Л е ч е н и е. Рекомендуются немедленная дезинтоксикация, осуществляемая путем внутривенного введения растворов глю-

козы и уротропина. Показаны тонизирующие средства, стрихнин, мышьяк, глицерофосфаты. В больших дозах должны вводиться комплекс витаминов В и витамин С. Иногда наблюдается улучшение в результате применения никотиновой кислоты (назначается внутрь по 0,02—0,05 г 2 раза в день). Показан также патогенетически обоснованный лечебный сон.

Пища больных должна быть богата витаминами. Фрукты, овощи, овощные соки должны занимать в рационе больного первое место. Благоприятно действует вливание глюкозы, хлористого кальция, общее облучение кварцем. Кроме того, по показаниям применяют и остальные методы, рекомендуемые при хроническом алкоголизме.

Глава XII

ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ МОРФИНОМ

Острое отравление морфином проявляется то немедленно, то через полчаса-час и больше, в зависимости от способа его введения (внутривенно, подкожно, внутрь и т. п.), а также от дозировок.

Минимальная смертельная доза морфина для взрослого равна 0,2 г, средняя — 0,3—0,5 г.

После приема токсической дозы морфина вначале отмечается возбуждение, эйфория, чувство жара во всем теле, сухость во рту, краснота кожи, затем появляется головокружение, резкая слабость, головная боль, шум в ушах, сильное потоотделение, частые позывы на мочеиспускание, все нарастающая сонливость и другие признаки отравления. Вскоре больные впадают в коматозное состояние. Дыхание крайне замедляется, едва ощущается (до 3—5 дыхательных движений в минуту). Сердечная деятельность вначале возбуждается, а затем резко падает вплоть до наступления паралича сердца. Зрачки суживаются, появляется цианоз, нередко выступает сыпь. Отмечается гипотермия, глюкозурия, альбуминурия.

Отравление морфином выявляется значительно быстрее при подкожном введении препарата. Вскоре после введения морфина наступает бессознательное состояние.

В некоторых случаях после приема смертельных доз морфина агония может затягиваться, появляется кровавый понос, задержка мочи, цианоз. В части случаев перед смертью наблюдаются тонические или клонические судороги, которые можно частично объяснить обеднением крови кислородом и повышением в ней содержания углекислоты, а также раздражающим действием морфина на мозг.

При внутривенном вливании смертельных доз морфина смерть может наступить немедленно.

Течение. В благоприятно протекающих случаях коматозное состояние переходит в глубокий сон, продолжающийся от 24 до 36 часов. Одновременно исчезают и конвульсии. Пос-

ле пробуждения больные испытывают головную боль, головокружение, слабость; наблюдается рвота, вялость кишечника (запор), причем расстройство кишечника может удерживаться длительное время.

В случаях с летальным исходом кома становится глубокой, пульс почти не прощупывается, дыхание делается незаметным и крайне замедленным. Смерть наступает вследствие паралича дыхания.

При отравлении морфином прогноз следует ставить осторожно, ибо описаны случаи, когда смерть наступала после того, как больной уже вышел из коматозного состояния и считался поправившимся. Причиной смерти в таких случаях был повторный коллапс, обусловленный отеком легких.

Даже после выздоровления могут возникнуть тяжелые осложнения в виде потери зрения, речи, параличей и т. д.

В части случаев, когда смерть явно вызвана морфином (внутривенное вливание), никаких патологических изменений не находят. В большинстве случаев отмечается резкое переполнение кровью мозговых оболочек и пазух, гиперемия легких: кровь жидкая и имеет темную окраску.

Важнейшее правило при лечении отравлений: *bis dat qui cito dat* (кто скоро действует, тот вдвойне успевает).

Физиологическим противоядием морфина по праву считается атропин, оказывающий возбуждающее действие на дыхательный центр, ослабляющий тонус блуждающего нерва и поддерживающий сердечную деятельность. Назначают атропин по 0,001 г под кожу каждые два часа, в зависимости от тяжести состояния (до 3—4 раз). В последнее время усиленно рекомендуется в качестве средства, возбуждающего дыхательный центр, цититон или 1% раствор лобелина (по 1 мл подкожно). Последний аналогично атропину также можно вводить повторно, но соблюдая осторожность, чтобы не вызвать перераздражения. Наряду с этим применяют общевозбуждающее лечение: черный кофе, кофени и камфора под кожу, эфир, аммиак, холодные обливания головы, вдыхание смеси кислорода с углекислотой.

Если кожные покровы на ощупь холодные и температура у больного понижена, рекомендуется растирание, горячие бутылки, согревание в теплой постели. Учитывая, что 40—70% морфина довольно длительное время выделяются слизистой оболочкой желудка и кишечника, независимо от способа введения морфина, необходимо несколько раз промыть желудок 0,25—0,5% раствором танина или марганцовокислого калия (1 : 2500), чтобы перевести алкалоид в трудно растворимое соединение. Одновременно нужно опорожнить мочевой пузырь путем катетеризации. Весьма полезно произвести искусственное дыхание, причем даже в тех случаях, когда дыхание почти прекратилось. Некоторую пользу может принести вдыхание

кислорода под повышенным давлением. Внутрь дают 0,4% раствор марганцовокислого калия (по одной чайной ложке каждые 15—30 минут). Рвотные средства противопоказаны.

ХРОНИЧЕСКОЕ ОТРАВЛЕНИЕ МОРФИНОМ (МОРФИНИЗМ)

Морфинизм, героинизм и опиомания имеют большое распространение в капиталистических странах. Безработица, нужда, отсутствие перспектив у трудящихся капиталистических стран способствуют развитию наркоманий.

В СССР оздоровление труда и быта, ликвидация безработицы, неуклонный рост материального и культурного уровня трудящихся, соответствующее законодательство, карающее сбыт наркотиков, привели к почти полной ликвидации наркоманий. Морфиномания стала в СССР редким заболеванием. По данным московских нервно-психиатрических диспансеров и психиатрических больниц, в 1949 г. морфинизм снизился в 20 раз по сравнению с 1933 г.

Этиология. Каждый человек, принимающий длительное время морфин, может стать морфинистом. Разница лишь в том, что у одних лиц это заболевание наступает быстрее, а у других — медленнее.

На материале, охватывающем 180 больных, мы нашли, что 108 больным (60%) морфин был назначен врачами для уменьшения болей, вызванных в 43 случаях ранениями и контузиями и в 65 — различными хроническими заболеваниями, причинявшими резкие боли (тяжелые невралгии, холециститы, камни почек, спайки после операции, язвенная болезнь, деформирующий артрит, радикулиты и т. п.). Эти больные привыкли к морфину и в дальнейшем делали себе инъекции морфина сами. Лишь 72 больных (40%) начали принимать морфин под влиянием товарищей или по собственной инициативе. Известную роль в развитии морфинизма играет также профессия. Лица, которым знакомы свойства морфина и которым легко его достать, нередко прибегают к нему для «поднятия» умственной и физической деятельности и в конце концов становятся морфинистами.

Значительную роль в развитии морфинизма играет также индивидуальная реакция на морфин. У некоторых лиц уже первый прием или первая инъекция морфина вызывает приятное возбуждение, веселое настроение, чувство легкости, иногда лишь вначале повышает умственную деятельность и т. п. Чаще всего именно у таких лиц и развивается морфинизм. Лица, испытывающие идиосинкразию к морфину, у которых даже после небольшой его дозы появляется головокружение, тошнота, слабость, сонливость и т. п., редко становятся морфинистами.

Классификация морфинизма. В 1935 г. мы предложили следующую классификацию морфинизма: 1) привычный морфинизм, 2) морфиномания, 3) морфинодипсомания, 4) морфинизм в сочетании с другими психическими заболеваниями, 5) морфинный делирий.

Привычный морфинизм. Обычно больные начинают принимать морфин или желая вызвать искусственную эйфорию, или для того, чтобы успокоить физическую боль. В последнем случае больные вначале принимают морфин по предписанию врача, а в дальнейшем — самостоятельно. Систематическое употребление морфина в течение ряда месяцев и лет вызывает привыкание к нему. К этой группе можно отнести больных, страдающих хроническими заболеваниями, причиняющими сильные боли. По излечении от этих болезней большинство таких больных прекращает употребление морфина.

Морфиномания. Под морфиноманией нужно понимать сильное влечение к морфину, развивающееся у лиц с психопатическими чертами характера, значительными колебаниями настроения, неустойчивостью, быстрой истощаемостью. Эти лица обращаются к морфину или для того, чтобы ослабить имеющиеся у них боли, или как к источнику эйфории, быстро привыкают к нему и становятся наркоманами в полном смысле этого слова.

Такие больные дают менее благоприятный прогноз, чем привычные морфинисты, ибо у них навсегда сохраняется готовность к рецидиву.

Морфинодипсомания. Это состояние, характеризующееся влечением к морфину, возникает периодически (подобно дипсомании).

Сочетание морфинизма с другими психическими заболеваниями. Сюда относятся случаи морфинизма у лиц, страдающих алкоголизмом, психозом, эпилепсией, органическим заболеванием центральной нервной системы и т. п.

Морфинный делирий. Состояние морфинного делирия возникает в период абстиненции у тяжелых морфинистов, принимавших большие дозы наркотика. Привычный морфинизм и морфиноманию целесообразно разделить на три стадии: компенсированную, субкомпенсированную и декомпенсированную.

Компенсированная форма — наиболее легкая. Больные сохраняют трудоспособность. Со стороны нервной системы отмечается лишь неврастенический синдром. Соматическое состояние без особых отклонений от нормы. Абстиненция протекает легко. Дозы морфина небольшие — от 0,01 до 0,05 г. Нередко такие больные самостоятельно прекращают прием морфина.

Субкомпенсированная форма наблюдается у больных, принимающих морфин свыше года. Трудоспособность у таких лиц снижена, они истощены. Отмечается незначительная деградация личности. Абстиненция протекает тяжело. Самостоятельно прекращать прием морфина больные не могут. Критика сохранена. Принимаемые дозы наркотика колеблются в пределах от 0,1 до 1 г.

Декомпенсированная форма характеризуется резко выраженной деградацией личности. Полная утрата трудоспособности, значительно выраженное физическое истощение. Угасание *libido* и потенции. Абстиненция достигает резких степеней, при которых может возникнуть морфинный делирий. Критика к своему заболеванию недостаточна. Больные принимают морфин свыше 5—10 лет в количестве от 0,3 до 5—10 г и более.

Разумеется, такое деление морфинизма на компенсированную, субкомпенсированную и декомпенсированную форму носит сугубо условный характер. Поскольку одна форма без заметных границ переходит в другую, данная классификация оправдывается лишь желанием дать некоторые опорные пункты врачам-практикам в смысле постановки прогноза.

Компенсированная форма дает наибольшее число излечений. При субкомпенсированной форме морфинизма также можно добиться излечения в известном числе случаев. При декомпенсированном морфинизме прогноз менее благоприятный.

Физиологическое действие морфина. Введенный в небольших дозах (0,01 г) морфин притупляет ощущение боли вследствие угнетения соответствующих областей коры головного мозга, воспринимающих болевую чувствительность, и, наряду с этим, вызывает эйфорию, субъективно приятное чувство покоя и довольства. Морфин вызывает такое же приятное чувство, какое наблюдается в период возбуждения при алкогольном опьянении. Настроение изменяется, мрачный человек становится веселым, молчаливый — словоохотливым, робкий — смелым. Сознание собственного достоинства возрастает.

Все тяжелые переживания и гнетущее настроение сглаживаются. Интеллектуальные функции в эйфорическом периоде не только не подавляются, но даже, наоборот, возбуждаются. Двигательные функции подавляются вследствие тормозного состояния двигательных зон коры головного мозга.

У человека появляется потребность принять спокойное положение, он избегает лишних движений. Подобное состояние и эйфория, в зависимости от индивидуальных качеств личности, ведут к иллюзорным ощущениям, самосозерцанию.

Морфинное опьянение вызывает приятные сновидения в виде быстро сменяющихся фантастических картин. Тело находится в состоянии приятного покоя, сладостной истомы. В этих

наркотических свойствах наркотика и скрывается опасность возникновения морфинизма.

Уже одно сглаживание болезненных ощущений, тягостного, подавленного настроения может привести к глубокому сну. Морфин влияет также на сосудодвигательный центр и центр блуждающего нерва. В эйфорическом периоде он вызывает расширение кожных сосудов лица и шеи. Сердечная деятельность несколько учащается. В дальнейшем кровь из расширенных кожных сосудов отливает в расширенные сосуды внутренних органов; кровяное давление падает вследствие понижения тонуса сосудодвигательного центра. Кожные покровы становятся бледными, слегка цианотичными, холодными. Центр блуждающих нервов тонизируется морфином.

Вскоре после некоторого учащения сердечной деятельности наблюдается постепенное замедление ее, нередко сопровождающееся аритмией. Зрачки суживаются, но при конвульсиях и глубокой асфиксии сужение зрачков может сменяться их расширением.

Клиническая картина. Под морфинизмом подразумевают сумму всех клинических явлений, вызываемых постоянным употреблением морфина, которые с прекращением приема последнего нередко постепенно проходят.

Морфинисты в значительном числе случаев являются психопатами и быстро привыкают к морфину. Уже первые инъекции, сделанные случайно, из подражания, любопытства или по назначению врача, пробуждают у них влечение к искусственной эйфории, вызываемой с помощью этого наркотика. Такие больные еще с детства испытывают беспричинную тоску, отличаются неустойчивым настроением. Если в таких случаях присоединяется еще психическая травма, они быстро теряют равновесие вследствие присущей им чрезмерной чувствительности и ранимости. Некоторые авторы описывали морфинистов как мягких, слабовольных, истеричных, склонных к фантастике, псевдологии, упрямых, более чувствительных, чем к алкоголю. Но нужно отметить, что среди морфинистов встречаются и психически вполне полноценные люди.

Развивается морфинизм постепенно после того, как по тому или иному поводу был применен морфин.

Полученный в результате первоначального введения морфина эффект — устранение физически и психически тягостных ощущений, появление приятного состояния, довольства, покоя — нередко побуждает к повторному введению наркотика, особенно в тех случаях, когда болезненные явления не прекращаются.

Таким образом постепенно и вырабатывается привычка к морфину, переходящая в болезненное влечение. Решающую роль в развитии морфинизма играет самостоятельное вприскивание больными наркотиков.

Они запасаются шприцами, ампулками препарата и т. п. Иногда они получают морфин по подложным рецептам или же достают его у других морфинистов. Имеются случаи, когда, для того чтобы достать морфин, больные совершают ограбление аптек. Мы знали одного больного, который в те периоды жизни, когда он не мог приобрести морфин, симулировал желчно-каменную болезнь, падал в людных местах, «корчась от боли», скорая помощь доставляла его в больницу, где он и получал от медицинского персонала нужный ему наркотик для «утоления болей».

Если не удается достать морфин, морфинисты принимают все, что может вызвать состояние легкого наркоза: опийную настойку, доверовы порошки, белладонну, веронал, люминал хлоралгидрат и т. п.

Инъекции морфинисты часто делают без всяких предосторожностей, не стерилизуя игл и шприца, иногда просто через одежду. Нам известен случай, когда морфинист С. впрыснул себе в уборной 5 г 1% морфина и умер на месте от воздушной эмболии. Этот больной в темноте, торопясь и не проверив шприца, ввел себе в вену вместе с раствором морфина воздух. Больные делают растворы морфина часто на глаз где-нибудь в уборной, беря для этого нестерильную воду. В результате этого в местах инъекции образуются плотные инфильтраты, абсцессы, иногда даже флегмоны, оставляющие рубцы (см. рис. 33). Кожа становится пигментированной. В таких случаях иногда бывает достаточно простого осмотра, чтобы безошибочно поставить диагноз. При длительном потреблении морфина прежние дозы перестают действовать вследствие привыкания к наркотику и притупления к нему чувствительности организма, а также повышенного сгорания морфина в организме. Поэтому больные вынуждены постепенно повышать применяемые дозы.

Дозы морфина, принимаемые морфинистами, колеблются в пределах от нескольких сантиграммов до нескольких граммов в сутки. В литературе известны случаи, когда дневная доза достигала 12 и даже 14 г морфина.

На материале, охватывающем 180 случаев, мы установили, что в 21 случае доза морфина составляла 0,1 г, в 43 случаях — 0,2—0,3, в 48 случаях — 0,3—0,5, в 42 случаях — 0,6—1, в 13 случаях — 1—2, в 10 случаях — 2—3 г и в 3 случаях точно установлена не была.

Начало заболевания морфинизмом приходится в основном на период между 30—40 годами.

На своем материале мы получили следующие данные о начале морфинизма: до 10 лет морфинизм наблюдался в одном случае, в возрасте 10—20 лет — в 14, 20—25 лет — в 22, 26—30 лет — в 14, 30—35 лет — в 52, 35—40 лет — в 43, свыше 40 лет — в 34 случаях.

У морфинистов отмечается постоянное чередование подъема настроения после приема наркотиков и явлений угнетения, подавленности, ипохондричности, упадка сил по прекращении действия морфина. Постепенно у больных ухудшается память. Они становятся крайне лживыми, рассказывают о себе всевозможные небылицы, стараются придать себе определенный «ореол». Поступая в лечебные учреждения, они клянутся в искренности намерения избавиться от своей мании, дают торжественные клятвы, что они «разбили шприц, вылили морфин, взорвали все мосты, соединяющие их с морфином». Однако тут же, на приеме или в больнице, у них обнаруживают изрядные запасы морфина в складках одежды, полых палках, папиросах, конфетах, переплетах книг и т. д. Они пропитывают раствором морфина апельсины и другие фрукты, удаляют содержимое яиц, заполняя их концентрированным раствором морфина. Некоторые ухитряются прятать морфин в резиновых мешочках в прямую кишку.

Характер больных меняется, они делаются крайне нервными, раздражительными. М. Я. Серейский считает, что наркотики нивелируют характер в сторону его шизоидизации, когда наряду с раздражительностью появляется замкнутость, апатия. Но это, по нашим данным, у морфинистов наблюдается редко. Воля больных ослабевает, и лишь в поисках наркотика они обнаруживают большое упорство.

Больные становятся вялыми, теряют инициативу, чувство собственного достоинства, манкируют своими обязанностями. Круг их интересов суживается и ограничивается лишь добыванием наркотика. Больные крайне запускают себя, неделями не моются, не меняют белья, спят в грязной постели, перестают заботиться о семье. Работоспособность падает, физические силы истощаются. Нередко в период абстиненции появляется гнетущая тоска, суицидальные мысли и тенденции.

Шварц, проследивший судьбу морфинистов, указывает, что 25% из них кончают жизнь самоубийством.

Со стороны нервной системы наиболее постоянны и резко выражены расстройства вегетативной нервной системы. Отмечается усиленное потоотделение, расстройство сердечной и дыхательной деятельности, вазомоторные расстройства. Часто бывают сердцебиения, астматические приступы, пульс становится аритмичным. Кровяное давление понижается. Остальные неврологические симптомы разнообразны и менее постоянны. Наблюдаются парестезии — ощущение жара, холода, онемения, бывают боли. Рефлекторная возбудимость понижена. Речь у морфинистов затруднена, походка неуверенная, шатающаяся, иногда имеет место положительный симптом Ромберга. Расстройства координации нередко не устраняются и при повторном приеме морфина. Сон почти всегда нарушен. Больные часами лежат не засыпая, занятые своими болезненными

фантастическими переживаниями. Иногда при засыпании возникают гипнагогические галлюцинации. Днем больными овладевает крайняя слабость, усталость, сонливость, которую они не могут преодолеть даже на работе, и тут же у всех на глазах засыпают. Половое влечение и потенция понижены или полностью угасают. Мы наблюдали одного 45-летнего морфиниста, приученного к морфину матерью с 9-летнего возраста.

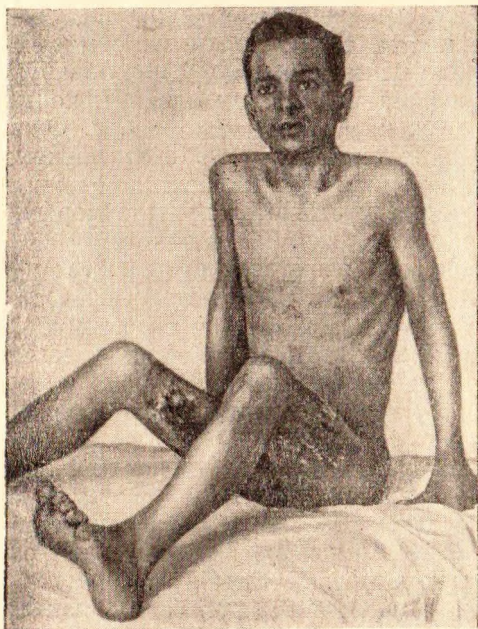


Рис. 32. Морфинная кахексия.

У этого больного в течение всей жизни отсутствовало половое влечение и потенция, не было также и эрекций. Очевидно, морфин резко угнетает, даже парализует половую сферу. Общий вид морфинистов крайне изменчив. Вскоре после приема морфина они оживляются, глаза у них блестят, щеки краснеют, движения ускорены, речь возбуждена. Через несколько часов тот же больной становится вялым; тусклый взгляд его устремлен в одну точку, зрачки узкие, моторика замедлена. Лицо блекнет, принимая цианотичный оттенок. Он с трудом передвигается и производит впечатление сильно усталого человека. Отмечается упадок питания, иногда доходящий до крайнего истощения (рис. 32). В более редких случаях питание остается удовлетворительным. У тяжелых морфинистов с годами развивается маразм. Тело покрывается абсцессами, инфильтратами; места многочисленных инъекций пигментированы, кожа при-

обретает сероватый оттенок (рис. 33). Пищеварение нарушается. Язык обложен, аппетит понижен, иногда появляется отвращение к пище.

Абстинентный синдром. Морфинная абстиненция наблюдается как в период лишения больных морфина в лечебном учреждении, так и в промежутки между инъекциями морфина, когда действие впрыснутой дозы ослабевает или исчезает. Сущность состоит в том, что каждая доза морфина дей-

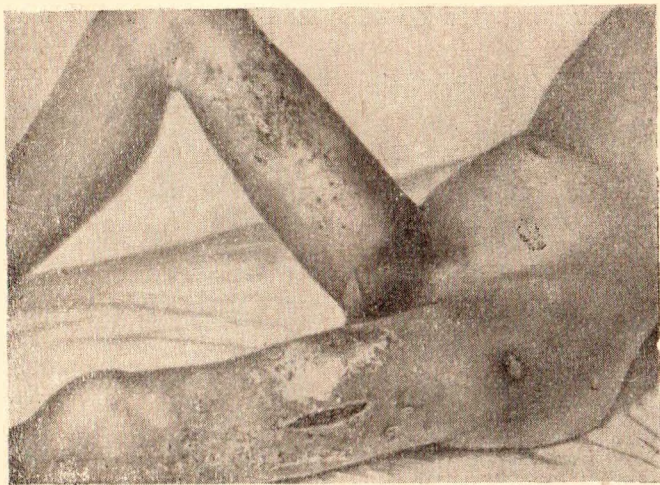


Рис. 33. Инфильтраты, абсцессы, рубцы, пигментация при морфинизме.

ствует лишь определенное время. По ослаблении или прекращении действия наркотика, если своевременно не будет введена новая доза, наступают явления морфинного голодания, или абстиненция.

Морфинная абстиненция является решающим фактором в развитии морфинизма. Больные, у которых абстиненция ярко выражена, являются уже до известной степени рабами своей страсти. Морфин они принимают не для вызывания эйфории, которая в этом периоде выражена уже незначительно или даже отсутствует, а для того, чтобы подавить абстиненцию, быть работоспособными. Явления абстиненции возникают также при уменьшении доз морфина и в зависимости от степени этого снижения достигают различной интенсивности. Тяжесть абстиненции зависит от количества принявшего морфина, а также от длительности его применения. Однако встречаются случаи, когда, несмотря на длительное применение больших доз морфина, абстиненция протекает сравнительно нетяжело. У морфинистов, лечавшихся повторно, абстиненция протекает

мягче. При немедленном отнятии морфина абстиненция выражается более бурно, чем при постепенном его отнятии (рис. 34 и 35).

При абстиненции особенно резко проявляются вегетативные расстройства: сердцебиение, потливость, гиперсекреция слизистых, зевота, чихание, кашель. Пульс становится частым и слабым. Зрачки расширяются. Голос делается хриплым, тембр его изменяется. В период абстиненции обостряются уже имеющиеся заболевания. Если больной страдал астмой, приступы ее учащаются, становятся более тяжелыми; невралгия в этот пе-



Рис. 34, 35. Морфинная абстиненция.

риод резко усиливается. В костях и мышцах появляются мозжащие, тянущие боли, иногда носящие характер щекотаний, что крайне мучительно для больных.

Больным овладевает сильное беспокойство. Он находится в постоянном движении, кричит, стонет, ворочается в постели, бегаёт по палате, упраскивает персонал дать морфин или что-нибудь заменяющее его; иногда больной буквально врывается к сестрам, врачам, умоляя сделать хотя бы один укол морфина. В различных частях тела появляются парестезии. Отмечается потеря аппетита, тошнота, рвота, урчание и боли в животе, понос. У женщин возобновляется угасшая менструальная функция, что сопровождается болями и обильными кровотечениями. Походка становится неуверенной, атактической, руки дрожат. Вес больных падает. Некоторые авторы наблюдали в период абстиненции коллапс. Пульс становится частым, сла-

бым, аритмичным. Тело покрывается холодным потом. Больной бледнеет, сразу притихает и внезапно впадает в бессознательное состояние. В специальной больнице, где практикуется в основном быстрое или немедленное отнятие морфина, мы за 19 лет наблюдали коллапс лишь у 2 больных.

Почти у всех больных отмечается упорная бессонница, которая долго длится после исчезновения других абстинентных явлений.

Страсть к морфину и ко всем лекарствам возрастает. В этом периоде больным свойственна фармакофилия, т. е. влечение к лекарствам. Они умоляют дать им хотя бы опийную настойку, доверов порошок, белладонну, иноземцевы капли, бром, люминал, веронал, валериану и т. п. Из средств, не относящихся к наркотическим, особенно часто просят кофеин. Они подговаривают других больных выпрашивать для себя лекарство с тем, чтобы потом передать его им. Часто они совершают своеобразный обмен, давая за снотворные различные продукты, папиросы, книги и т. д.

Обман, подкуп, ложь, воровство — все пускается в ход с целью раздобыть наркотик или что-либо заменяющее его.

Больные настоятельно требуют выписки их из больницы, заявляя, что раздумали лечиться, что у них много неотложных дел и т. п. Если же их не выписывают, объявляют голодовку, нарушают режим, нападают на персонал, бьют посуду, окна, становясь крайне агрессивными. Наряду с этим появляется апатия, тоска, нередко страх, суицидальные тенденции.

Очень редко при тяжелом морфинизме наблюдается кратковременное делириозное состояние, отличающееся от алкогольного делирия более глубоким нарушением сознания и менее яркими галлюцинаторными переживаниями, отсутствием общего оживления, юмора алкоголиков и внушаемости. Возбуждение иногда достигает резкой степени, по поводу чего больных приходится изолировать и подвергать такому же лечению, как больных белой горячкой. Морфинный делирий обычно длится всего несколько часов, но иногда дольше.

Эрленмейер указывает, что при абстиненции могут возникнуть и другие психозы, то кратковременные, то затяжные — до нескольких месяцев. Описывался также синдром, подобный корсаковскому, на почве морфинизма. Нам ни разу не пришлось встречать такую форму заболевания среди довольно большого числа стационарировавшихся морфинистов.

В. А. Горовой-Шалтан отмечал, что при резко выраженной абстиненции могут возникать тяжелые эпилептиформные припадки, кома, трофические расстройства, корсаковский симптомокомплекс.

Абстинентный синдром у морфинистов является следствием лишения организма привычного раздражителя. Марм объяснял этот синдром последствием отравления оксидиморфином, ука-

зывая, что у морфинистов морфин отчасти окисляется в оксидморфин. Впрыскивая оксидморфин собакам, он вызывал абстинентный синдром, который немедленно исчезал после введения морфина.

Марм считает, что оксидморфин в организме морфинистов продолжает оказывать действие и после того, как действие морфина ослабевает или прекращается. Таким образом, противоядием для оксидморфина является будто бы морфин, с чем нельзя согласиться.

По мнению Гитцига, так называемый морфинный голод объясняется повышенным содержанием соляной кислоты в желудочном содержимом. Путем выкачивания содержимого желудка и промывания его карлсбадской солью, по данным Гитцига, устранялись не только гастрические, но и другие симптомы абстиненции.

С этим автором нельзя согласиться. Морфинное отравление вызывает тяжелое нарушение обмена веществ. В организме морфинистов образуются продукты неправильного обмена, действие которых проявляется лишь с устранением наркотизирующего влияния морфина, являющегося, повидимому, антидотом этих продуктов.

Лишение морфина сказывается также на вегетативной нервной системе. При абстиненции нарушается равновесие между симпатической и парасимпатической нервной системой.

Картина крови и обмен веществ. При морфинизме во многих случаях находят повышение числа эритроцитов при нормальном содержании гемоглобина или его понижении. Нередко отмечается лейкоцитоз.

В период абстиненции вначале наблюдается увеличение числа нейтрофилов при одновременном снижении числа эритроцитов и эозинофилов. Затем число эозинофилов нарастает, впоследствии же развивается лимфоцитоз, а количество эозинофилов снова уменьшается.

Наступающую в разгаре абстиненции эозинофилию Рештель считает выражением аллергического, анафилактического процесса в организме. РОЭ вначале понижена, в абстинентном же периоде она повышается.

Обратное развитие патологических процессов в крови у морфинистов происходит в течение 2—4 месяцев. Количество кальция в сыворотке крови уменьшается, в то время как содержание калия увеличивается. Кислород в крови снижается. Количество углекислоты повышено. Содержание хлоридов и а-талазы понижается. Сахарный обмен нарушен. Содержание сахара в крови уменьшается, достигая низких количеств в абстинентном периоде. Шавров отмечает накопление в организме ацетоновых тел.

Течение и прогноз. Морфинизм может длиться десятки лет. Вначале морфинисты пытаются лечиться, причем

зачастую после лечения бывает длительная или кратковременная ремиссия. Относительно эффективности лечения морфинистов взгляды расходятся. По данным Крепелина, число излечений при морфинизме не превышает 6—8%. Шредер указывает на неблагоприятный прогноз при морфинизме. По Левенштейну, рецидивы встречаются более чем в 65%.

Буркхот считал, что прогноз при морфинизме крайне неблагоприятен и число рецидивов достигает 97%. Шварц, основываясь на данных клиники Charité с 1917 по 1924 г., полагает, что можно излечить свыше 42% морфинистов.

Кан подчеркивает, что излечение морфинистов до сих пор было редкостью. Дензауэр и Рит, обследовавшие 646 морфинистов, из которых 250 совсем не лечились, у 28,6% установили ремиссию свыше года. На нашем материале у 180 морфинистов, лечившихся в психиатрических больницах с 1930 по 1940 г., ремиссия свыше года наблюдалась в 19%; в 18% рецидив наступил через 3 месяца, а в остальных случаях — сразу или вскоре после выписки из больницы.

Успех лечения зависит от срока пребывания больных в лечебных учреждениях, а также от методов лечения. Мы глубоко убеждены в том, что плохие результаты лечения морфинистов, как и алкоголиков, зависят от недостаточного срока лечения. Чем дольше длится лечение, тем больше шансов на выздоровление. Минимальным сроком лечения морфинистов надо считать 6 месяцев, ибо лишь в эти сроки устраняются имеющиеся нарушения в нейродинамике.

Однако по исчезновении явлений абстиненции больные считают себя выздоровевшими, и их не удается удержать в лечебных учреждениях. Между тем у морфинистов уже вскоре после выписки из больницы, иногда даже в ее стенах, т. е. через 2 недели, через 1—3—6 месяцев и до года после отнятия морфина, может появиться своеобразный синдром, напоминающий абстиненцию. Клинически он проявляется в резкой слабости, беспричинной раздражительности, тоске, бессоннице, треморе, парестезиях, зябкости, похолодании конечностей, болезненных ощущениях в различных органах. В конце концов это состояние переходит в страстное влечение к морфину. Сон расстраивается. Физическая слабость часто бывает настолько сильно выражена, что больные становятся неработоспособными. Иногда определенная обстановка, пение, музыка, шприцы и т. п. способствует растормаживанию заглушенных условных рефлексов, связанных с употреблением морфина и эйфорией, что может привести к появлению влечения к морфину и наступлению рецидива заболевания.

Приведем краткую выдержку из истории болезни.

Больной Г., 42 лет. Отец алкоголик, один брат самоубийца, другой умер от алкоголизма, третий брат алкоголик.

Больной развивался нормально. Учился блестяще. По характеру вспыльчивый, раздражительный, склонный к значительным колебаниям настроения. Телосложение диспластическое. Со стороны соматической сферы уклонений от нормы не отмечалось. Морфин начал принимать с 37 лет из-за желания поднять дух. Кроме морфина, принимал кокаин, опий, гашиш, пантопон. Средняя суточная доза морфина не превышала 0,3—0,4 г. Морфин «снял усталость», «разгонял тоску», «создавал рабочее настроение». Поступил в больницу 30/1 1932 г. Морфин был отнят немедленно. Абстиненция длилась 5—6 дней. Постепенно больной окреп, влечение к морфину исчезло. Был выписан 26/II 1932 г. по собственному желанию ввиду срочных дел. Через 2 дня после выписки появилось резкое влечение к морфину. Возникла физическая слабость, апатия, бессонница, потеря работоспособности; одновременно наблюдалась гиперестезия. Данный синдром продержался около суток и после короткого сна исчез.

Впоследствии аналогичное состояние появлялось через 1—3—4—5 месяцев и длилось от нескольких часов до 12 суток. На 6-м месяце после выписки наступил рецидив. В дальнейшем больной погиб от сепсиса, так как делал себе инъекции не стерильными иглами.

Этот синдром мы называем псевдоабстиненцией.

Псевдоабстинентный синдром бывает выражен в различных степенях: от легкой — рудиментарной — до тяжелой степени, напоминающей настоящую абстиненцию. Многие наблюдательные больные называют это состояние «психической абстиненцией». Можно считать, что псевдоабстиненция является тяжелым испытанием для наркомана.

Учитывая, что псевдоабстинентный синдром может проявиться на протяжении длительного срока (до 1 года), мы считаем целесообразным больных-морфинистов подвергать длительному стационарному лечению и последующему диспансерному наблюдению. Результат лечения тогда будет во много раз лучше, чем при кратковременном пребывании больных в стационаре (1—1½ месяца).

Срок лечения и выписки из больницы является очень серьезным моментом в жизни каждого морфиниста. Следует всегда иметь в виду, что ощущение бесконтрольности, возврат в старую обстановку, с которой связаны воспоминания о морфине, порой недостаточная уверенность в собственных силах, трудности в работе, к тому же пессимизм окружающих, не верящих в возможность излечения, порождают большое число рецидивов вскоре же после выписки больных, особенно в тех случаях, когда они еще не окрепли физически и психически, когда не произошло угашения условных связей в отношении морфина и к тому же еще есть возможность возникновения псевдоабстинентного синдрома.

При длительном систематическом лечении в большинстве случаев можно добиться излечения или хорошей ремиссии. Пессимизм, существующий в этом вопросе, не имеет под собой серьезной почвы.

Разумеется, у тяжелых психопатов и больных, злоупотреблявших морфином в течение десятков лет, лечение менее эф-

фективно, чем у лиц без психопатического отягощения и принимавших морфин сравнительно недолго.

Лечение. При лечении морфинизма минимальное время отводится деморфинизации. Все же остальное время уделяется восстановлению здоровья больных и углубленной психотерапии. При выборе метода деморфинизации необходимо считаться с физическим состоянием больного. У физически крепких больных рекомендуется отнимать морфин сразу. Истощенных больных, а также лиц с тяжелым поражением сердечной мышцы, во избежание коллапса следует лишать морфина постепенно, в течение 4—5 дней. Существует четыре способа отнятия морфина: постепенное отвыкание, внезапное лишение, быстрое лишение, лишение морфина в амитал-натриевом сне.

Постепенное отвыкание. Вводимую в организм дозу морфина постепенно уменьшают. Степень уменьшения соотнобразуется с явлениями абстиненции. Чем сильнее выражена абстиненция, тем меньше убавляют количество морфина и тем дольше продолжается деморфинизация. Этот метод лечения может проводиться в любой обстановке: на дому, в больнице и т. п. Многие больные иногда самостоятельно снижают до известной степени количество принимаемого морфина. Большим недостатком данного метода является длительность его применения. При этом способе абстиненция протекает мягче, но зато тянется более длительное время. Кроме того, время, которое должно быть затрачено на восстановление сил больного, нерационально используется на постепенное отвыкание. Этот метод применяют редко — лишь у больных с тяжелыми заболеваниями, крайне истощенных и т. п.

Внезапное лишение. Этот способ применим лишь в условиях лечебного учреждения. Больного лишают морфина немедленно по поступлении в больницу. Абстинентный синдром достигает значительной силы, но длится недолго — 3—4 дня, после чего постепенно наступает полное успокоение. Этот метод имеет больше всего сторонников вследствие того, что абстиненция купируется в кратчайший срок, и уже через 3—4 дня можно приступать к лечению морфинизма. Недостатком метода внезапного лишения морфина является возможность развития у тяжелых соматических больных коллапса, а также делирия. Этот метод без всякого вреда для здоровья можно с успехом применять у сравнительно здоровых физически лиц.

Быстрое отнятие морфина. Этот способ более мягкий, чем предыдущий. Больного лишают морфина не сразу, но быстро, что исключает возможность неприятных осложнений, наблюдающихся при внезапном снятии морфина. Деморфинизация длится от 3 до 10 дней и зависит от дозы, срока применения морфина, а также соматического состояния больного.

Больных, принимавших 0,3—0,5 г морфина, лишают его в течение 3—4 дней, принимавших же 1—3 г — в течение 8—10 дней. Абстинентный синдром бывает иногда довольно сильно выражен, но не так резко, как при внезапном отнятии морфина.

При поступлении больного необходимо сразу составить расписание деморфинизации в течение срока, устанавливаемого согласно соответствующим показаниям, указывая дозировку и часы инъекций. Не следует допускать никаких отклонений от этого расписания, ибо в период деморфинизации больные становятся крайне назойливыми, изводят врачей, требуя чтобы инъекцию морфина им сделали раньше установленного по расписанию часа. Иногда больные обманывают врача и утверждают, что им забыли сделать инъекцию. Дневную дозу морфина следует разделить на 3—4 раза с таким расчетом, чтобы последняя доза вводилась перед ночным сном (в 10—10¹/₂ часов вечера).

Привычную дозу нужно с первого же дня уменьшить в 3—4 раза. При этом следует учитывать, что больные склонны преувеличивать принимаемые ими дозы морфина, а потому мы в своей практике давали ¹/₅ называемой ими дозы, т. е. в среднем не более 0,1 г морфина, постепенно снижая дозу на ¹/₄ в день. Лечение должно проводиться в условиях, исключающих снабжение больных морфином, вследствие чего за ними устанавливается строжайший надзор.

Для лечения морфинной абстиненции, возникающей в период деморфинизации, предложено значительное количество средств, краткий обзор которых мы приводим ниже.

В свое время предлагались так называемые заменяющие средства, которые оказывают физиологическое действие, аналогичное таковому морфина: предлагали алкоголь, дионин, кокаин, героин, гиосцин, люминал, веронал, а также многочисленные патентованные средства, содержащие морфин или его дериваты. Однако применение этих средств зиждется на глубоком заблуждении и является серьезной врачебной ошибкой, представляющей большую опасность, ибо, отвыкнув от морфина, больные привыкают к «заменителю» и становятся кокаиниками, героинистами, алкоголиками, кодеинистами и т. п. Комбинируя эти яды, они причиняют еще больший ущерб своему здоровью и в конце концов вновь переходят к приему морфина.

Согласно исследованиям Гитцига, в период наркотизации у морфинистов отсутствует в желудке соляная кислота, что объясняется наркотизирующим влиянием морфина на секреторные железы желудка, выделяющие соляную кислоту. Вследствие отсутствия соляной кислоты нервы желудка якобы отвыкают от ее влияния и становятся крайне чувствительными к ней. По прекращении приема морфина, наоборот, наблюдает-

ся гиперсекреция соляной кислоты, которая настолько возбуждает и раздражает нервы желудка, что они дают соответствующую реакцию в виде абстинентного синдрома. Исходя из этих соображений, Гитциг предлагает во время деморфинизации регулярно промывать желудок после пробного завтрака, чтобы удалить из него морфин, который, согласно данным Альта, на 50% выделяется желудком; во время повышения кислотности он предлагает промывать желудок раствором карлсбадской соли для нейтрализации соляной кислоты, чтобы уменьшить ее возбуждающее действие на нервы желудка. Выкачивание содержимого желудка проводилось по утрам после пробного завтрака. Желудок промывали карлсбадской солью в течение двух последних дней впрыскивания морфина и на протяжении 4 дней после прекращения его введения. При этом способе лечения якобы не только исчезали гастритические явления, но и почти отсутствовала абстиненция.

В первые дни лечения, когда снижаются дозы морфина, Гитциг рекомендует назначать больным соляную кислоту.

Эрленмейер видоизменил метод Гитцига и назначал для нейтрализации чрезмерно кислого содержимого желудка крепкие щелочные воды (фахингенскую воду) по 1 л и больше в течение дня (по одному стакану несколько раз в день). При этом способе, испробованном на 14 больных, отмечалось не только отсутствие гастритических симптомов, но и облегчение течения абстинентного синдрома. Не вполне устранялись лишь вазомоторные явления и бессонница. Зрачки оставались суженными. Но период абстиненции был более коротким, чем обычно.

Закель и др. с успехом лечили абстинентный синдром инсулином, указывая, что инсулин устраняет абстиненцию благодаря достижению равновесия вегетативной нервной системы. Параллельно с инсулином больным назначали виноградный сахар. Инсулин вводился по 10—20 ИЕ ежедневно в течение 8—10 дней; одновременно больным давали сахар или глюкозу. В случаях гипогликемического шока глюкоза вводилась внутривенно.

М. Я. Серейский указывает, что явления абстиненции смягчаются при внутривенном введении 20—40 ИЕ инсулина (мы считаем, что предварительно надо сделать исследование на сахарную нагрузку).

Гиршляф предложил антиморфинную сыворотку, однако она не оправдала возлагавшихся на нее надежд.

В. А. Горовой-Шалтан рекомендовал лечить морфинную абстиненцию антитиреоидином, который, по его данным, при абстиненции предупреждает рвоту, судороги, поносы. В своей практике мы этим препаратом при лечении морфиноманов не пользовались и поэтому воздерживаемся от суждения по этому поводу.

С заметным успехом при морфинном синдроме мы давно уже применяем внутривенное вливание 10% раствора хлористого кальция (по 5—10 мл) в сочетании с 40% глюкозой (по 10 мл) утром и вечером в течение 6—8 дней. Одновременно мы назначаем при этом сердечные средства: кофеин, адонилен и др.

Необходимо иметь в виду, что морфинисты часто имеют особое пристрастие к кофеину, поэтому последний надо давать лишь в крайних случаях при наличии соответствующих показаний. Весьма полезно в этот же период проводить кислородные вдувания (по 350—500 см³), а также давать в обильном количестве щелочные воды: эссенуки № 4 или боржом. В тяжелых случаях иногда неплохое действие оказывает подожное введение физиологического раствора (по 500—700 мл).

В период морфинной абстиненции широко применяют различные симптоматические средства. При коллаптоидном состоянии или коллапсе, что бывает лишь в исключительно редких случаях, необходимо, не теряя ни минуты, немедленно сделать инъекцию морфина в дозе 0,01—0,025 г и при отсутствии улучшения повторить ее через 30—40 минут. Если больной находится в состоянии тяжелого коллапса, наряду с морфином уместно применять адреналин, эфир, искусственное дыхание, а также средства, сильно раздражающие кожу.

Наиболее трудна борьба с бессонницей. В таких случаях обычно назначают хлоралгидрат, паральдегид, веронал, сульфонал и т. п., а также большие дозы брома. Нужно иметь в виду, что морфинисты привыкают к различным снотворным средствам, а поэтому последние, если в них имеется крайняя потребность, следует менять.

При стойкой бессоннице мы применяем длительные теплые ванны перед сном, так как все снотворные в обычных дозах на морфинистов не действуют.

Еще в довоенные годы в отдельных случаях морфинной абстиненции мы пытались применить лечение сном, а с 1948 г. длительный лечебный сон морфинистам стали применять систематически, особенно при явлениях тяжелой морфинной абстиненции. С 1948—1951 гг. деморфинизация в амитал-натриевом сне была нами проведена группе морфинистов из 22 человек. По возрасту эти больные распределялись следующим образом: от 21 года до 30 лет — 7 человек, от 31 года до 40 лет — 9, от 41 года до 50 лет — 6 человек.

По длительности употребления 12 человек принимали морфин в течение 2—5 лет и 10 человек — в течение 5—10 лет.

Все они начали принимать морфин для того, чтобы облегчить и устранить болевые и другие ощущения, вызванные у них различными заболеваниями. В дальнейшем они постепенно втянулись и привыкли к морфину и уже не могли без него обходиться.

Попытки прекратить приемы морфина или уменьшить дозы неизменно вызвали у них тяжелые явления абстиненции с обострением болевого синдрома и других тяжелых ощущений.

В частности, у 2 больных поводом для инъекций морфина были частые приступы бронхиальной астмы, у 6 больных — жестокие боли, вызванные тяжелыми ранениями (голова, грудь, живот, конечности и др.), у 5 больных — боли, вызванные язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, у 4 больных — боли при желчнокаменной и почечнокаменной болезни. Наконец, 5 больных начали принимать морфин для устранения затянувшейся реактивной депрессии, для снятия или смягчения угнетенного настроения. Все эти лица принимали в среднем от 0,3 до 5 г морфина в сутки в виде подкожных инъекций его 1—2% раствора.

У изученных нами больных наблюдалась патологическая лабильность эмоциональной сферы с преобладанием пониженного настроения или дисфорией, повышенная раздражительность, утомляемость, истощаемость, понижение памяти, внимания, импульса к труду. Тяжелая картина морфинной абстиненции лишала их возможности оставаться в психиатрических больницах, куда они обращались, пытаясь избавиться от своего недуга. После поступления в больницу, в период морфинной абстиненции, сон у больных нарушался, в основном наблюдалась бессонница, пульс учащался до 100, делался слабым, кровяное давление понижалось, дыхание учащалось, становилось поверхностным, иногда отмечалась одышка, появлялась головная боль, рвота, понос, сухой кашель, насморк, отмечалась резкая физическая слабость, повышенная раздражительность, нетерпеливость, подавленное настроение или дисфория. Больные жаловались на сильные боли в руках, туловище, ногах, заявляли, что их мучает кашель, что у них болит живот, «крутит», «ломает», что им очень тяжело, то знобит, то холодно. Они стонали, а некоторые из них иногда заявляли: «Я так измотался, живой нитки на мне нет», «Все силы истощились», «Хоть веревку бери и давься». Они настойчиво требовали выписки из больницы, ссылаясь на то, что они не рассчитали своих сил.

Следует отметить, что у изучавшихся нами морфинистов во время абстиненции действительно резко обострялись явления имевшегося до того соматического заболевания и усиливались вызываемые им боли, что значительно утяжеляло их состояние. Нарушения корковой динамики при морфинизме до сих пор не изучались.

У всех 22 наших больных-морфинистов мы исследовали состояние корковой динамики с помощью речевого подкрепления по методу проф. А. Г. Иванова-Смоленского. При этом вначале нейродинамическое исследование проводилось в течение нескольких первых дней после поступления больных в клинику

(до лечения сном), затем после проведения у них амитал-натриевого сна. У всех изученных нами морфинистов при экспериментальном исследовании корковой динамики до лечения сном отмечалось понижение замыкательной функции, т. е. замедление образования новых связей в мозговой коре, которые возникали обычно только после 5—30-го сочетания. Латентный период условной реакции у большинства больных был увеличен и колебался в пределах от 0,4 до 5 секунд и выше. К концу эксперимента величина двигательной реакции обычно падала и значительно увеличивался ее латентный период, что, очевидно, было связано с понижением функциональной работоспособности, повышенной истощаемостью клеток коры головного мозга и с быстрым развитием явлений запредельного торможения.

Применение многочисленных синтетических раздражителей в ряде случаев показало, что дифференцировка на них не вырабатывалась или образовывалась с большим трудом, что свидетельствовало о недостаточности процессов активного торможения, которые к тому же были склонны к иррадации (большое последовательное торможение). У всех больных, как правило, мы обнаружили при экспериментальном исследовании фазовые явления. Величина двигательной реакции на слабые и сильные раздражители была в подобных случаях одинакова или была выражена на слабые раздражители гораздо больше, чем на сильные, т. е. у больных отмечалась уравнивательная и парадоксальная фаза, состояния, промежуточные между бодрствованием и сном.

Следовательно, как показал опыт, тормозной процесс в мозговой коре у морфоманов значительно преобладал над раздражительным. Подобное преобладание вполне естественно понимать как выражение охранительного торможения со стороны высших отделов нервной системы, а отсюда вытекает показание для проведения патогенетически обоснованной терапии сном.

Применение этого метода в данном случае, кроме того, было показано и потому, что оно позволяло гуманизировать лечение морфинизма и давало возможность проводить весь тяжелый абстинентный период в глубоком сне, избавляя больных от мучительных страданий, а также от могущего наступить у них в период отнятия морфина грозного осложнения — коллапса или обострения имевшихся тяжелых соматических заболеваний. Как мы уже отмечали, коллапс при морфинной абстиненции обычно возникает внезапно, без всяких предвестников, и его иногда трудно предусмотреть.

Описанные в литературе отдельные смертные случаи при денаркотизации морфинистов, повидимому, являлись следствием внезапно возникшего у больных коллапса. Наряду с этим, лечение сном предупреждает развитие морфинных делириев и других психических расстройств.

Морфинисты, которым назначался лечебный сон, тщательно обследовались терапевтом: им проводились анализы крови, мочи, рентгеноскопия грудной клетки, измерялось кровяное давление и проверялась выносливость к амитал-натрию. При отсутствии медицинских противопоказаний больным очищали кишечник, назначали ванну, затем их помещали в затемненную комнату. Перед дачей амитал-натрия им измеряли температуру, пульс, дыхание, кровяное давление, удаляли съемные протезы. Вначале давали внутрь 0,2 г амитал-натрия. Если больной не засыпал, то первоначальную дозу амитал-натрия давали через 2 часа и в последующем назначали повторно ту же дозу по мере пробуждения (через 3—4 часа).

Обычно для поддержания сна в течение 18—22 часов в сутки больным давали от 1 до 3 г амитал-натрия в сутки. Такое количество препарата они получали в течение 5—10 дней, а затем постепенно, в течение 3—4 дней, оно снижалось (например, с 3 до 2 г, с 1 до 0,5 г в сутки).

Во время проведения амитал-натриевого сна больные ни на одну минуту не должны оставаться одни: около них постоянно должна дежурить опытная медицинская сестра и должен осуществляться регулярный врачебный контроль. На каждого больного, подвергавшегося амитал-натриевому сну, вели протокол, в котором каждый час отмечалось общее состояние больного, глубина сна, характер пульса и дыхания, артериального давления, температура и т. д., обозначалось количество принимаемого амитал-натрия, а также отмечались часы приема пищи, мочеиспускания, дефекации. В туалетную комнату и обратно больные сопровождалась персоналом или же пользовались мочеиспускником, подкладным судном. Кормление больных также проводилось медицинским персоналом.

Во время амитал-натриевого сна у больных часто отмечались следующие изменения: некоторое понижение кровяного давления, замедление пульса, более глубокое и ровное дыхание. Температура тела, как правило, не повышалась. Исключением в этом отношении явились 2 больных, у которых к 9-му дню амитал-натриевого сна отмечалась гипертермия. Вес у многих больных был стабилен или нарастал, аппетит резко повышался, в то время как при морфинной абстиненции отмечалось полное отсутствие аппетита. У одного больного отмечалась задержка мочи, которая исчезла после применения грелок. Иногда отмечалось похолодание конечностей; в таких случаях к конечностям прикладывались грелки. При пробуждении больные не требовали морфина, а просили дать им еще заснуть. Абстинентный синдром протекал значительно легче.

В результате терапии сном больные успокаивались, настроение их улучшалось. Значительно смягчался или устранялся болевой синдром, возникавший в результате имевшегося соматического заболевания и отчасти послуживший причиной

морфинизма. У больных затухали и другие явления, свойственные абстиненции: не было рвоты, поноса, мучительных мозжащих болей в костях и мышцах, болезненного влечения к морфину и т. п. После окончания лечения длительным наркотическим сном они вели себя совершенно упорядоченно. Никаких осложнений у леченных нами больных мы не наблюдали. Для иллюстрации приведем следующие случаи.

Больной Б., 36 лет, поступил в клиническую нервно-психиатрическую больницу 12/IV 1949 г. с жалобами на болезненное влечение к морфину и сильные боли в области живота.

Больной развивался правильно; учиться начал с 8 лет. После окончания вуза работал инженером. В 1941 г. ушел на фронт. В 1942 г. получил тяжелую контузию головы с потерей сознания, вследствие чего 7½ месяцев лечился в госпитале; после выздоровления вновь вернулся на фронт. В 1943 г. — тяжелое ранение живота с повреждением кишечника. Многократно оперировался по поводу непроходимости кишечника в связи с образовавшимися спайками. В 1947 г. удалено 2/3 кишечника. В дальнейшем очень частые госпитализации в хирургические и терапевтические клиники в связи с тяжелым болевым синдромом, напоминавшим картину острого живота. Лечение сводилось главным образом к инъекциям морфина. Даже после выписки из клиники к больному приезжали врачи на дом и делали инъекции 2% морфина в дозе 1—2 мл до 3—5 раз в сутки. Мучительный болевой синдром проявлялся снова как только прекращалось действие морфина. Это заставляло врачей прибегать к повторным инъекциям морфина и в конце концов привело больного к патологическому привыканию к наркотику. Больной неоднократно обращался за помощью в различные авторитетные лечебные учреждения. Но все попытки должного эффекта не давали. Проявление же болевого синдрома каждый раз заставляло врачей вновь назначать ему морфин. Таким образом, больной регулярно принимает морфин с 1943 г., а последний год — ежедневно в количестве от 0,1 до 0,3 г в сутки.

Физическое состояние. Больной среднего роста, резко истощен. Многочисленные рубцы в области живота (после ранений и операций). Сердце и легкие без видимых патологических отклонений. Кровяное давление 130/60 мм. Резкая болезненность при пальпации живота. Живот вздут. Стул жидкий, учащенный, резкие боли в животе.

Неврологическое состояние. Зрачки равномерно сужены, ограниченно реагируют на свет. Сухожильные рефлексы повышены. Болезненность нервных стволов при пальпации. Красный разлитой стойкий дермографизм. Тремор рук и век в сильной степени. Повышенная потливость. Инвертированный глазо-сердечный рефлекс. Анализы крови и мочи без патологических отклонений.

Психическое состояние. Больной эмоционально неустойчив, преобладает депрессивно-дисфорическое настроение. Отмечается повышенная раздражительность, мнительность, обидчивость, утомляемость. Из-за повышенной утомляемости не может читать. Вследствие тяжелых болей в животе постоянно стонет, требует сделать ему инъекцию морфина. Критика к своему заболеванию сохранена. Память понижена. Охотно соглашается на любые терапевтические и операционные мероприятия, лишь бы облегчили его страдания.

С согласия больного и его родственников ему была проведена деморфинизация в амитал-натриевом сне. Больной спал в сутки от 18 до 22 часов в течение 5 дней и по 15 часов в среднем в последующие 7 дней. Сон был глубоким, спокойным. Лишение морфина протекало безболезненно. В дни лечения сном не отмечалось и болевых явлений в животе. После проведенной терапии сном боли в области живота не повторялись, исчезло и влечение к морфину. Физически окреп, спокойнее относился к

своему будущему; заявил, что за последние 6 лет «впервые вздохнул, как здоровый человек». Был выписан в хорошем состоянии.

Катамнестическое наблюдение показало, что после лечения больной в течение 1 года 4 месяцев воздерживался от морфина и чувствовал себя хорошо. Болей не испытывал, работал. Лишь спустя 1 год 4 месяца после погрешности в диете у него вновь проявился болевой синдром, напомнивший картину острого живота, что заставило врачей прибегнуть к помощи морфина и привело к рецидиву заболевания.

Интерес данного случая заключается в том, что терапией сном безболезненно позволила провести деморфинизацию у тяжелого соматического больного морфиниста и одновременно благотворно воздействовать на болевой синдром, который его не беспокоил в течение 1 года 4 месяцев.

Приведем другой случай.

Больной К., 38 лет. Поступил в клинику 16/IX 1949 г. по поводу морфинизма.

Развивался правильно, успешно учился, окончил Механический институт и работал инженером. В 16-летнем возрасте заболел туберкулезом легких. В 1944 г. перенес контузию головы с потерей сознания, после чего в течение 45 дней отмечалось значительное нарушение слуха; 4 месяца не мог говорить. В 1945 г. появились мучительные приступы бронхиальной астмы, для устранения которых в госпитале ему начали делать инъекции 2% раствора морфина в дозе до 8 мл в сутки. С этого времени больной не прекращал инъекций морфина, постепенно все увеличивал его дозы, ибо стоило ему на 1—2 дня прекратить приемы наркотика, как сейчас же возникали тяжелые приступы бронхиальной астмы, что и побуждало его вновь прибегать к морфину. Перед поступлением в клинику больной ежедневно применял по 30 мл 2% раствора морфина.

Физическое состояние. Больной пониженного питания. Артериальное давление 125/70 мм: тоны сердца чистые, пульс 90 ударов в минуту. Рентгеноскопия грудной клетки: слева в нижнем легочном поле обызвествленный очаг. Корни легких с петрификатами желез. Диафрагма вяло экскурсирует. Сердечно-сосудистая тень в пределах нормы.

Неврологическое состояние. Ослабление конвергенции глазных яблок. Повышение сухожильных рефлексов. Лабильность вазомоторов.

Психическое состояние. Подавленное настроение, повышенная утомляемость, раздражительность, плохой сон. Вследствие большой слабости все время лежит в постели. Жалуется на мучительные тянущие боли в различных частях тела. Стонет, просит облегчить его страдания, сделав ему инъекцию морфина.

При исследовании корковой динамики у больного К. отмечался короткий латентный период условной реакции, колебавшийся от 2 до 15 секунд. Величина условной реакции была невелика, причем на слабый звонок она была равна или выше, чем на сильный, т. е. наблюдались фазовые явления в виде уравнительной или парадоксальной фазы. После шестидневного амитал-натриевого сна (больной спал в сутки от 15 до 22 часов) вышеуказанные нарушения в корковой динамике были устранены.

Абстиненция у этого больного во сне протекала почти незаметно для него. После терапии сном наряду с нормализацией корковой динамики исчезло болезненное влечение к морфину, значительно улучшилось общее состояние, выровнялось настроение, исчезла слабость, прошли боли, нормализовался сон. За время пребывания в клинике, с 18/VIII по 16/IX 1949 г., приступов бронхиальной астмы не отмечалось. Больной в хорошем состоянии был выписан на работу с восстановленной трудоспособностью.

Исследуя корковую динамику у изучавшихся нами больных морфинизмом после лечебного амитал-натриевого сна, мы отмечали обычно полное восстановление корковых функций, их нормализацию. У части больных эта нормализация наступала быстро, а у других больных восстановление нарушенных функций корковой динамики наступало только на 20—30-й день после начала лечения.

У больных морфинизмом после лечения сном сокращался латентный период условной реакции, увеличивалась сила двигательной реакции, исчезали фазовые явления.

К указанному о лечении больных морфинистов нужно добавить, что после применения амитал-натриевого сна мы проводили психотерапию, стимулирующую терапию и применяли физические методы лечения.

Несмотря на то, что вышеуказанным способом мы лечили сравнительно небольшую группу больных морфинизмом и с момента окончания их лечения прошел еще недостаточно большой срок, этот метод мы считаем одним из наиболее эффективных и гуманных, потому что абстиненция укорачивается, протекает безболезненно во сне, и не наблюдается тяжелых осложнений, о чем мы говорили выше. В тяжелых случаях морфинизма лечебный сон можно сочетать с инсулином.

У наших больных морфинизм в большинстве случаев развивался на фоне тяжелого соматического заболевания, сопровождавшегося интенсивным болевым синдромом. Неоднократные попытки лечить этих больных другими способами не давали успеха ввиду резкого обострения болевого синдрома в период абстиненции.

Применение лечебного сна, как видно из приведенных примеров, облегчило основную задачу врача — провести деморфинизацию, а при наличии болевого синдрома значительно смягчало или на известный срок устраняло боли и несомненно положительно влияло на общую эффективность лечения.

После купирования абстиненции приступают к общеукрепляющему лечению. Как тонизирующее средство с успехом можно применять аутогемотерапию, гравидан по 2—3 мл через день в течение месяца, стрихнин, мышьяк, железо, глицерофосфаты первитин, фенамин, витамины.

Лекарственные средства следует назначать на срок не больше одного месяца. Необходимо постепенно отучать больных от лекарств, используя к концу лечения лишь физиотерапию, трудотерапию, лечебное питание и т. п.

Из физических методов лечения благотворное влияние на больных оказывают хвойные ванны (температуры 36°), тепловатые души. В качестве общеукрепляющего средства можно применять и общее облучение кварцем. При головных болях и неврастеническом синдроме показано статическое электричество, местная и общая дарсонвализация. После того как прой-

дет период абстиненции и больные несколько окрепнут, полезно проводить трудотерапию на свежем воздухе по 3—4 часа в день.

Серьезное внимание следует уделять питанию больных. В первые дни пища должна быть легкой, не раздражающей. Полезны слизистые супы, пюре из овощей, куриное мясо, молоко, кисель, крепкий черный кофе, сахар, сладкие блюда (крем). В период выздоровления рекомендуется пища, богатая углеводами и витаминами. Пищевой рацион должен включать не меньше 4000 калорий, из них не менее 1200 калорий должно приходиться на углеводы. Хорошо также назначать овощные и фруктовые соки (томатный, морковный, сливовый, вишневый, апельсиновый), а также сок шиповника или витамин С в концентрированном виде.

Параллельно с лечением морфинизма необходимо лечить заболевания, приведшие больных к морфинизму, чтобы исключить необходимость приема морфина в дальнейшем.

Больных нужно предостерегать от применения после выписки даже терапевтических доз наркотиков.

Нам приходилось наблюдать много случаев, когда у морфинистов наступал рецидив по вине врачей, которые, не учитывая особенностей заболевания больных, назначали им опий или морфин даже при незначительных желудочно-кишечных расстройствах или соматических заболеваниях, сопровождавшихся болями.

После приема нескольких, а часто даже одной терапевтической дозы у больных вновь проявлялось неудержимое влечение к морфину и наступал рецидив. Нужно помнить, что готовность к рецидиву у морфинистов сохраняется на долгое время, иногда в течение всей их жизни, и что провоцирующим фактором, вызывающим рецидив, является первая же инъекция морфина. Поэтому необходимо, чтобы врачи при выписке морфинистов из лечебного учреждения разъясняли им, что применение каких бы то ни было препаратов опия или морфина для них категорически противопоказано.

После выписки больной первое время должен оставаться на попечении семьи. Ни в коем случае не следует оставлять его одного. Больные должны порвать всякие связи со своими друзьями-морфинистами. Сразу же после лечения им нужно рекомендовать включиться в трудовую жизнь.

После выписки из лечебного учреждения больные должны не менее 2 лет находиться под наблюдением врачей-специалистов диспансера. Большую пользу при дальнейшем амбулаторном лечении может принести гидротерапия, электротерапия, а также психотерапия. Фармакологические средства при амбулаторном лечении нужно назначать лишь в случаях явной необходимости. При возникновении псевдоабстинентного синдрома последний купируется теплыми ваннами, вливаниями хлористого кальция или гипнозом.

Г л а в а XIII

ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ОПИЕМ

Острое отравление опиём вследствие медленного его всасывания развивается постепенно. Появляется резкая слабость, головокружение, шум в ушах, тошнота и даже рвота. Нередко отмечаются кожные явления — сильный зуд, разного рода сыпи. Лицо становится багрово-красным. Наконец, наступает сильная сонливость или глубокий сон. Зрачки делаются узкими, величиной с булавочную головку, не реагируют на свет. Дыхание крайне замедляется, до трех-четырех дыхательных движений в минуту, становится поверхностным. Иногда оно носит характер чейн-стоксова. Пульс малый, еле прощупывается. Лицо становится бледным, с цианотичным оттенком. Временами состояние больных как будто улучшается, но затем наступает резкое ухудшение, которое может закончиться смертью. Смерть при остром отравлении опиём наступает вследствие паралича дыхания.

Лечение. В основном опий выделяется желудком, по этому следует проводить многократное промывание последнего взвесью животного угля (1 столовая ложка животного угля на 100 мл 10—30% раствора сульфата магнезии), чтобы адсорбировать опий животным углем и возможно скорее удалить его из организма. Одновременно подкожно вводят атропин 1 : 1000 по 1 мл, лобелин в виде 1% раствора по 0,5—1 мл. В тяжелых случаях отравления применяют медленное введение лобелина внутривенно. Назначают также сердечные средства (кардиазол, камфора, кофеин, дигален), грелки, средства, раздражающие кожу, растирания, холодные обливания водой, нашатырный спирт и т. п. Внутрь дают таннин (по 0,1—0,3 г повторно до 2 г в день), который вступает с алкалоидами в трудно растворимые соединения.

Ф. И. Юников, Бернштейн и др. рекомендуют внутривенные вливания $Kal\ hypermanganici$, промывание желудка и клизмы из марганцовокислого калия (1 : 2000).

ХРОНИЧЕСКОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ОПИЕМ

Курение опия. Вскоре после нескольких затяжек опиум наступает эйфория. Опиоманы в этот период погружаются в мир грез и причудливых переживаний. Общее состояние их оживляется, они испытывают безграничное довольство. Через некоторое время (30—40 минут) после приема опия эйфорическая фаза сменяется сонливостью, дремотой. Опиоманы в этом состоянии испытывают приятную истому. Мысли превращаются в яркие образы, которые быстро сменяются один другим. Курильщиками опия овладевает лень, нежелание двигаться, все тело их постепенно тяжелеет. Руки беспомощно свисают, веки смыкаются, фантастические образы быстро сменяются, как в калейдоскопе, причем сознание глубоко не нарушается. Восприятия нарушаются. Внешние раздражители, как, например, разговор окружающих, тиканье часов, стук и т. п., хотя и воспринимаются, но больному кажется, что их слышит кто-то другой. Постепенно появляется чувство невесомости. Затем внешние раздражения и впечатления уже не воспринимаются, внешний мир исчезает, остается лишь мир внутренних, мир грез и полного покоя.

При пробуждении отмечается резкая бледность лица, веки наполовину опущены, зрачки узкие, рефлексы понижены.

У начинающих опиоманов после курения первых трубок опия появляется сильная головная боль, головокружение, тошнота, боль в желудке, рвота и даже обморочные состояния.

Привыкание к опию происходит в течение нескольких недель или даже месяцев.

Со временем опиоманы вынуждены повышать количество опия вследствие привыкания, аналогичного привыкания к морфину.

Эйфория опиомана со временем бледнеет. Опиоманы в дальнейшем принимают опий уже не для вызывания эйфории, а с целью подавить абстиненцию, которая бурно развивается при лишении их привычного возбудителя.

Постепенно больные деградируют, опускаются. Круг их интересов суживается. Все помыслы и желания концентрируются вокруг опия и средств на его приобретение. Память больных слабеет. Появляется неустойчивость эмоциональной сферы. Характер больных изменяется, они становятся более замкнутыми, нелюдимыми. Их перестает интересовать семья, работа. Они не следят за собой, ходят небрежно одетые, грязные, физическое состояние больных нарушается, резко падает питание, потенция. У женщин прекращаются менструации. Отмечается резкое исхудание, гастрические и сердечные расстройства, боли в мышцах. В конце концов опиоман медленно погибает. Иногда смерть наступает совершенно неожиданно как следствие тяжелой интоксикации.

Абстинентный синдром почти аналогичен таковому при морфинизме. У больных, лишенных опия, возникает резкая физическая слабость, двигательное беспокойство, тянущие неопределенные боли, преимущественно в конечностях, чувство страха, раздражительность, явления со стороны желудочно-кишечного тракта (запор или поносы, нередко кровавые), рвота, невралгические боли, одышка, бессонница и т. п.

По характеру применения опия различают курильщиков и опиофагов. Курят опий из особых трубок, причем многие выкуривают в день свыше 100 трубок опия.

Опиофаги применяют опий через рот, проглатывая его в виде комков или шариков.

Описаны случаи, когда больные принимали по 250 г опия и даже больше, т. е. количество, которое превышает максимальную дозу, допускаемую Фармакопеей, в 750 раз.

Лечение. Лечение опиоманов ничем не отличается от лечения морфинистов. Обычно опий отнимают у больных сразу. Постепенное отнятие опия допускается лишь у ослабленных, истощенных больных. При тяжелых явлениях абстиненции сразу же нужно назначать сердечные средства. Как и при морфинизме, необходимо делать промывание желудка раствором карлсбадской соли; внутрь назначают крепкие щелочные воды. Значительную пользу может принести инсулинотерапия. Инсулин дают до 20 ИЕ в сутки. Одновременно с инъекциями инсулина рекомендуется вводить внутривенно по 20 мл 40% глюкозы.

Хорошо действует также вливание 10% раствора хлористого кальция, вводимого повторно по 5—10 мл.

При двигательном беспокойстве хорошо действуют тепловатые ванны. В качестве снотворных пользуются барбамиллом, люминалом, нембуталом и другими препаратами. В тяжелых случаях можно лишить больных опия в амитал-натриевом сне, аналогично тому, как это делается при морфинизме.

Иногда бывает очень трудно бороться с кровавым или профузным поносом, развивающимся у больных в период абстиненции. В таких случаях может принести некоторую пользу соответствующая диета, клизмы из таннальбина, сульфамидные препараты, диатермия живота. Если никакие средства не помогают и больному угрожает смерть от истощения и интоксикации вследствие сильнейшего поноса, приходится опять возвращаться к даче опия и отнимать его затем постепенно в течение 7—10 дней. После купирования абстинентного синдрома у больных на фоне полного здоровья может часто возникать псевдоабстинентный синдром, аналогичный таковому у морфинистов, который длится от нескольких часов до суток.

Купировав абстинентный синдром, приступают к следующему периоду лечения, имеющему целью поднять общее пита-

ние больных, восстановить здоровье, затормозить условные рефлексы, образовавшиеся в связи с приемом опия, и побороть влечение к нему. Все это достигается путем длительной изоляции больных в условиях закрытого лечебного учреждения на срок не менее 2—3 месяцев.

Кратковременное пребывание больных в больнице обычно не даёт должного эффекта даже в тех случаях, когда больные уже перенесли абстиненцию и сравнительно неплохо себя чувствуют. Рецидив наступает во время одного из ближайших приступов псевдоабстиненции вследствие того, что больные еще не успели побороть влечение к опию.

По выходе из лечебного учреждения больные должны твердо придерживаться указанных им правил не применять ни в коем случае опия или его производных, даже в особых случаях (боли, желудочно-кишечные заболевания и т. п.). Следует также указать на необходимость исключения из их обихода снотворных и алкоголя, так как некоторые больные, прекращая прием опия, становятся алкоголиками, эфироманами и т. п.

Глава XIV

ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ КОКАИНОМ

Кокаин — алкалоид, добываемый из растения *Erythroxylon* соса — кустарника, произрастающего в Южной Америке и считавшегося в древние времена священным растением.

Алкалоид кокаин был извлечен в 1859 г. Еще с древних времен было известно эйфоризирующее и анестезирующее влияние кокаина. Действие кокаина на условные рефлексы у собак изучал И. В. Завадский, нашедший сходство его влияния с кофеином. В части случаев кокаин давал повышенные условные рефлексы без предварительной стадии их понижения, в других случаях вызывал понижение условных рефлексов, а затем их повышение. И. Н. Журавлев установил, что кокаин в малых и средних дозах вызывает повышение условных и безусловных рефлексов и ведет к растормаживанию отрицательных условных рефлексов. Дальнейшее увеличение дозы (до известного предела) кокаина ведет к соответствующему нарастанию вышеизложенных явлений, причем указанные изменения нарастают почти пропорционально величине дозы кокаина, сменяясь в последующем при переходе к токсическим дозам кокаина уменьшением величины положительных условных рефлексов. И. Н. Журавлев полагает, что кокаин вначале ослабляет процессы торможения с почти одновременным усилением процессов возбуждения, а затем процесс возбуждения угнетается.

При отравлении кокаином наблюдается расширение зрачков, побледнение лица, сильная слабость, головокружение, одышка, судороги, тахикардия, неправильный пульс, обморочное состояние, зависящее от сужения и спазма сосудов мозга. В части случаев наступает психомоторное возбуждение с расстройством сознания. У лиц, чувствительных к кокаину, а также при приеме его в токсических дозах обморок достигает глубокой степени. Отмечается резкое расстройство кровообращения и дыхательной функции. Может наступить смерть от паралича дыхания, а в части случаев и от паралича сердца.

Иногда перед смертью бывает резкое двигательное возбуждение, обильные зрительные и тактильные галлюцинации. Одновременно отмечается ярко выраженный бред, сменяющийся сумеречным состоянием. Наряду с этим наблюдаются резко выраженные клонические и тонические судороги. Если больные выживают, они жалуются на головную боль, головокружения, сильную слабость.

Лечение. При обмороках благотворное действие оказывает вдыхание амилнитрита (по 6—10 капель), расширяющего сосуды. При наличии судорог успешно применяется вдыхание эфира и хлороформа.

Хорошие результаты получаются при внутривенном вливании 10% раствора хлористого кальция в дозе 5—10 мл или 10% глюконата кальция. При явлениях сердечной слабости рекомендуется подкожное введение кофеина, камфоры, кардиозола, а также подкожные инъекции этилового спирта, оказывающего рефлекторное действие на сердце и дыхательный центр. Наряду с этим, известную пользу может принести обливание грудной клетки и головы холодной водой, вдыхание нашатырного спирта, растирание тела и т. п. При упадке дыхательной и сердечной деятельности показано вдыхание кислорода, искусственное дыхание, вдыхание смеси кислорода с добавлением 6—10% углекислоты, являющейся естественным возбудителем дыхательного центра, инъекции лобелина и пр.

ХРОНИЧЕСКОЕ ОТРАВЛЕНИЕ КОКАИНОМ (КОКАИНИЗМ)

После приема первых доз кокаина вначале появляется легкое головокружение, незначительная боль в голове, сменяющаяся вскоре повышением интеллектуальной деятельности и приятным самочувствием. В этом периоде ощущается необыкновенное воодушевление, повышается работоспособность. Речь оживляется. Больные беспрестанно говорят. Характерным симптомом кокаинизма является полиграфия. Больные бесконечно пишут письма, заявления с бесконечными рассуждениями и повторениями. Как и в начальных стадиях, при хроническом кокаинизме облегчается течение ассоциаций. У большинства больных наблюдается повышенная активность, стремление к деятельности. Они перебегают с места на место, иногда убегают из дому. Подобное возбуждение длится часа два, сменяясь упадком сил, апатией, подавленным состоянием. Некоторые из них испытывают чувство невесомости. Им кажется, что тело их делается необычайно легким, что они летают по воздуху. Появляются иллюзии и галлюцинации, преимущественно зрительного и слухового характера, нередко сопровождаемые страхом.

К кокаину привыкают довольно быстро. Вскоре после приема первых доз появляется абстинентный синдром — сильная

слабость, головная боль, неприятные ощущения в различных частях тела. Настроение подавленное. Нередко больные ощущают тоску или испытывают возбуждение. Иногда же бывает обморочное состояние.

Все это заставляет больных прибегать к повторным приемам кокаина. Постепенно дозу кокаина приходится во много раз увеличивать, так как привычная доза уже не дает нужного эффекта — не устраняет явлений абстиненции, не дает эйфории. В течение нескольких месяцев больные доходят до 5—10 г кокаина, который вводят подкожно или внутривенно; иногда больные нюхают кокаин.

При длительном употреблении кокаина наблюдаются более тяжелые психические изменения. Эмоциональная сфера больных становится крайне неустойчивой. Круг интересов суживается. Больные запускают свои личные и служебные дела. Работа их тяготит. Память постепенно падает. Эмоциональная отзывчивость отсутствует, они безразлично относятся к чужим страданиям, становятся черствыми, эгоистичными. Все их интересы сосредоточены на кокаине.

Кокаиноманы делаются мнительными, подозрительными, вспыльчивыми до гнева, мелочными, крайне раздражительными. Они становятся небрежными, неряшливыми, неделями не моются, не меняют белья.

Наряду с психическими изменениями, отмечается ряд физических явлений: зрачки расширяются, реакция зрачков на свет понижается, глаза приобретают своеобразный блеск, появляется сухость во рту, шум в ушах, сердцебиение.

Общее питание больных падает. Они выглядят гораздо старше своих лет. Кожа бледная, мышцы дряблые, выражение лица вялое. Походка неуверенная. Обращает на себя внимание крайняя слабость больных. Аппетит неравномерный; временами наступает анорексия, сменяющаяся булимией. Диурез повышен. Нередко появляется сердцебиение, во время которого пульс значительно ускоряется. Артериальное давление лабильно, причем нередко отмечается его падение. Иногда наступает головокружение и полуобморочное состояние. Весьма характерны также различные парестезии: больным кажется, что под кожей заложены кристаллы кокаина, ползают черви, жучки, микробы, вши, клопы (симптом Маньяна).

На приведенном ниже снимке (рис. 36) изображен больной-кокаинист, сделавший себе резекцию ногтевого ложа на пальцах обеих рук вследствие того, что он ощущал под ногтями крайне раздражавшее его ползание жучков.

У лиц, вводящих кокаин подкожно или внутривенно, отмечаются многочисленные абсцессы, инфильтраты, рубцы, пигментация и т. п., как при морфинизме. После заживления абсцессов появляется темная пигментация. В тех случаях, когда больные нюхают кокаин, часто наблюдается прободение носо-

вой перегородки. Абсцессы иногда протекают очень тяжело и долго не заживают. Иногда развивается сепсис, заканчивающийся летальным исходом.

Сон всегда нарушен, часто отмечается бессонница, вследствие чего больные вынуждены прибегать к другим наркотикам. Потенция падает вплоть до полной импотенции, несмотря



Рис. 36. Тяжелые повреждения пальцев рук, нанесенные себе кокаином под влиянием осязательных галлюцинаций.

на то, что вначале половое влечение значительно повышается. У женщин половое влечение в начале заболевания значительно усиливается, в связи с чем часто отмечаются половые извращения.

Сухость в горле заставляет больных поглощать много жидкостей. Питание с течением времени все больше нарушается и, наконец, наступает полный маразм. Смерть нередко наступает от паралича дыхания или коллапса.

Немало кокаинистов кончает жизнь самоубийством.

Прогноз при кокаинизме не всегда благоприятный. Однако процент выздоровлений все же выше, чем при морфинизме.

На почве кокаинизма может возникать своеобразная картина кокаинного психоза, или кокаинного делирия, имеющая значительное сходство с алкогольным делирием. После незна-

чительных продромальных явлений, выражающихся в повышенной подозрительности, беспокойстве, сильной раздражительности, внезапно появляются галлюцинации — зрительные, слуховые, тактильные и т. п.

Больной слышит угрозы, брань, разговор в виде диалогов, комментирующих все его поступки и самые сокровенные тайны его прошлой жизни. Ему представляется масса мелких подвижных образов (микропсия) в виде крыс, червей, жуков, змей и т. п.

Наряду с обманами чувств появляется бред преследования. Больным кажется, что их окружают, за ними следят, при помощи особых приборов читают их мысли, действуют на них электричеством, гипнозом. Им строят разные козни, обвиняют в преступлениях, квартира их окружена. Нередко такие больные приходят в отделение милиции и просят защиты, «сдаются». Но бывает, что они совершают агрессивные поступки, нападая на воображаемых противников, или, потеряв надежду на «спасение», кончают жизнь самоубийством.

Иногда у кокаинистов развивается бред ревности, подкрепляемый соответствующими галлюцинациями, галлюцинаторными голосами, говорящими о непристойном поведении жены. Им кажется, что жена многозначительно переглядывается с другими мужчинами, делает им намеки, получает от них любовные письма, что она находится в связи со многими мужчинами, что она покраснела, смутилась при виде внезапно вошедшего мужа и т. п. Подобный бред может привести к агрессивным действиям как против жены, так и против ее мнимых любовников. Несмотря на наличие обильных галлюцинаций, ориентировка у больных сохраняется, хотя окружающая их обстановка во время кокаинного психоза кажется им несколько изменившейся. Временами может наступать некоторое кратковременное затемнение сознания. Но резких нарушений сознания не бывает. Больные могут подробно рассказать о своих переживаниях, однако критика в отношении своей болезни теряется. Нарушается и связность ассоциаций. Больные отвергают всякое подозрение насчет их психической болезни и, наоборот, сами иногда пытаются доказать ненормальность того или другого лица из окружающих.

Нередко больные пытаются скрыть свое состояние и неохотно отвечают на вопросы. Настроение их неустойчивое — то злобно-раздражительное, то подавленное, депрессивное.

На высоте развития кокаинового психоза больные становятся суетливыми, беспокойными, временами отмечается речевое и моторное возбуждение.

Кокаинный психоз непродолжителен. После лишения больных кокаина делириозные явления исчезают через несколько дней. Бредовые идеи претерпевают обратное развитие в течение нескольких недель и даже месяцев.

У кокаинистов может встречаться синдром, подобный корсаковскому, с характерным расстройством запоминания, повышенной раздражительностью, суетливостью и нарушением координации, аналогичным таковому при опьянении. Сон расстраивается. Потенция угасает. Отмечается общая слабость. После отнятия у них кокаина описанные расстройства, а также расстройство запоминания в довольно короткие сроки подвергаются обратному развитию.

Лечение. Учитывая, что абстинентный синдром при лишении больных кокаина выражен незначительно, рекомендуется отнимать кокаин сразу, не допуская никакого уменьшения доз или замены кокаина другими наркотиками. Лишь у резко ослабленных кокаинистов, у больных в состоянии маразма возможно постепенное отнятие кокаина — в течение 2—3 дней.

Лечение кокаинистов должно проводиться в специальных лечебных учреждениях. Режим должен быть таким же, как и при лечении морфинистов. Нужно учесть, что больные всевозможными путями пытаются обмануть бдительность медицинского персонала или вступить с кем-либо в контакт с целью доставления им наркотика.

Зачастую больные пытаются пронести в больницу запасы кокаина под видом зубного порошка, в полых палках, в крышках чемоданов, складках одежды, в яйцах, содержимое которых удалено и заполнено концентрированным раствором кокаина, в конфетах, папиросах, булках и т. п. Поэтому при приеме больных в лечебное учреждение следует их тщательно проверять.

Отнимая у больного кокаин, нужно одновременно в профилактических целях назначать им сердечные средства: кофеин, адонилен, смесь ландышевых и валериановых капель и т. п. При появлении обморочных состояний показано немедленное подкожное введение камфоры, кофеина.

Благотворно влияет внутривенное вливание хлористого кальция, глюкозы, значительно смягчающих абстиненцию. В первые дни абстиненции рекомендуются теплые ванны температуры 36°, назначаемые обычно на ночь. При упорной бессоннице применяется амитал-натрий (по 0,2—0,5 г), люминал, веронал и др.

Снотворные необходимо менять, учитывая возможность привыкания к ним. Больше 5—6 дней давать их не рекомендуется. Наряду с изложенным, можно с первых же дней назначить общетонизирующее лечение: инъекции стрихнина, препараты железа, глицерофосфаты. Благотворно влияет на больных подкожное вдувание кислорода по 500—800 см³. Курс состоит из 15—20 вдуваний. Из физиотерапевтических методов показано общее облучение кварцем.

Большое внимание следует уделять также питанию больных. Пища должна быть разнообразной, хорошо переваривас-

мой, богатой витаминами и углеводами. После купирования абстинентного синдрома показана трудотерапия на свежем воздухе, дозируемая в зависимости от состояния больного.

Решающая роль в лечении кокаинизма, как и других наркоманий, принадлежит психотерапии, гипнотерапии и др. Срок лечения больных от 3 до 9 месяцев. Чем длительнее лечение, тем больше шансов на выздоровление. Кокаиноманов следует предостерегать от употребления других наркотиков, в частности, алкоголя и морфина, ибо они могут быстро привыкнуть к ним. Больным категорически воспрещаются всякие «эксперименты» над собой в отношении кокаина. Многие, выходя из лечебного учреждения, хотят убедиться в том, какое влияние окажет на них кокаин после лечения. Обычно такой «эксперимент» заканчивается рецидивом.

Иногда больные, отвыкнув в процессе лечения от кокаина и начав по выходе из больницы принимать прежние большие дозы этого наркотика, погибают от острого отравления.

Глава XV

ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ГАШИШЕМ

При курении гашиша, как и при действии других наркотиков, различают две фазы: стадию возбуждения и стадию угнетения. Вскоре после приема гашиша появляется незначительное головокружение и своеобразный вкус, отдаленно напоминающий камфору. По телу разливается приятная теплота, ощущается прилив сил, особая легкость, интеллектуальное возбуждение, возникают яркие иллюзии, все окружающее принимает яркую окраску. Через 10—20 секунд после курения гашиша пульс учащается, кровяное давление нередко повышается на 10—15 мм ртутного столба.

Эмоциональная сфера оживляется. Сфигмограмма, снятая в это время, напоминает таковую после введения адреналина, на пальцах появляются капельки пота, исчезающие через 1—2 минуты.

В начале испытывается безотчетное состояние довольства. Опьяневший находится в постоянном движении, суетится, потягивается всеми членами. Ему хочется петь, плясать, поднимать огромные тяжести. Мысли бегут, как у маниака, все быстрее и быстрее, рождаясь и исчезая вне всякой ассоциативной связи. Значительно выражено речевое возбуждение. Больной говорит с аффектацией, доходя до иступления, и удивляется, что другие не разделяют его настроения, возмущается, что окружающие очень медленно думают, двигаются и т. п. Однако все его усилия, направленные на то, чтобы передать свои мысли, тщетны. Фантазия не знает никаких пределов. Все переживания, все эмоции гипертрофируются. Гашишисты тут же переходят от слез к безудержному смеху. Самолюбие взвинчивается до крайних пределов. Чувство времени и пространства извращается. Опьяненным гашишем минута кажется годами, часы — веками. Весьма причудливы иллюзии зрения. Идущему по лестнице кажется, что она простирается до облаков. Самый ничтожный шум воспринимается, как бурный плеск волн, грохот водопадов. Память во время опьянения остается

ненарушенной, что существенно отличает этот вид опьянения от алкогольного.

Анциферов следующим образом описывает процесс восприятия внешних раздражений у гашишистов: «Восприятия внешних раздражений становятся особенно яркими; появляются иллюзорные и галлюцинаторные переживания; воспринятый внешний образ начинает менять свои очертания, краски, он становится то причудливо смешным, то нелепо страшным. Человеческие лица иногда воспринимаются, как маски, сменяющиеся часто с необычайной быстротой».

Однако это состояние длится недолго и постепенно вытесняется чувством страха, ощущением нереальности испытываемых переживаний; собственное тело кажется чем-то посторонним. Способность объединять восприятия в одно целое нарушается. Возникает характерное общее ощущение нереальной действительности. Лица людей кажутся неподвижными, как у мертвецов. Сложные восприятия карикатурно искажаются. Наплыв мыслей сменяется общей растерянностью, сопровождающейся страхом сойти с ума. Мышление становится нелогичным, нет единой направленности мышления.

Эмоциональная сфера крайне неустойчива. У части лиц появляется значительное половое возбуждение. Для опьянения гашишем характерны колебания сознания. Опьяневший то как будто протрезвляется, то снова глубоко погружается в иллюзорные переживания. У некоторых больных могут появляться нестойкие бредовые идеи преследования. Постепенно состояние опьянения нарастает. Ощущается сильное сердцебиение, тоска, беспокойство, головная боль. Тело холодеет, покрывается потом. Дыхание затрудняется, наступает сильная слабость. Координация движений нарушается. Наконец опьяневшие погружаются в глубокий тяжелый сон.

ХРОНИЧЕСКОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ГАШИШЕМ

Хронический гашишизм развивается медленно. Психические изменения нарастают постепенно, с колебаниями, быстро подвергаясь обратному развитию после прекращения злоупотребления гашишем. Выносливость к гашишу постепенно утрачивается. При этом больные начинают пьянеть уже от самых небольших доз. Психические изменения особенно заметно выражены в эмоциональной сфере. Понижается интерес к окружающему и к себе, появляется сильная раздражительность, резкая импульсивность. Больные небрежны, движения их замедлены. Трудоспособность понижена.

Психозы при хроническом отравлении гашишем, по мнению А. К. Стрелюхина, протекают по типу делирия со спутанностью, а некоторые — по типу органического заболевания, напоминающего дементную форму прогрессивного паралича и

длится он от 1 до 3 месяцев. После отнятия гашиша психотические явления могут постепенно пройти и в состоянии больных наступит улучшение.

У лиц, злоупотребляющих гашишем, отмечается снижение критики, ослабление памяти. Иногда встречается даже явное слабоумие. Наряду с этим могут наблюдаться шизофреноподобные симптомы, бред преследования, идеи отношения, слуховые галлюцинации. Зрачки у больных обычно сужены, реакция на свет вялая, сухожильные рефлексы изменены, отмечается дизартрия.

Кожа приобретает желтый оттенок, что турецкие авторы считают специфическим признаком гашишизма.

Лечение. Лишать больных гашиша следует немедленно. Абстиненция при хроническом гашишизме незначительная и выражается в головной боли, расстройстве сна, пугливости, повышенной нервности, раздражительности, плаксивости, неприятных ощущениях в сердце и «пустоты» в грудной клетке, потливости, снижении аппетита и т. п. Для купирования абстиненции назначают снотворные средства — бромурал, барбитамил, люминал и т. п. Сразу же следует приступить к общеукрепляющему лечению. Больным назначают подкожные вдувания кислорода до 350—400 см³ через день в течение 1—2 месяцев. Внутрь дают фенамин, первитин, стрихнин, препараты железа, глицерофосфаты, мышьяк, препараты брома, валериановые капли и т. п. Из физиотерапевтических процедур применяют хвойные ванны, гальванический воротник, общее облучение кварцем. Истощенным больным показано усиленное питание. Пища должна быть богатой витаминами.

Основную роль в лечении гашишизма отводят психотерапии (гипноз, речевая терапия и т. п.). В легких случаях лечение проводят амбулаторно; более тяжелых больных надо стационаризовать.

Глава XVI

ЭФИРОМАНИЯ

Эфиромания — редкое заболевание, встречающееся главным образом у лиц, близко соприкасающихся с эфиром. Применяется эфир внутрь или в виде ингаляций. Большей частью эфиромания развивается у алкоголиков. В некоторых случаях алкоголизм чередуется с эфироманией, а иногда встречается и в сочетании с ней.

Эфироманы вдыхают от 30 до 500 см³ чистого эфира в сутки. Обычно за один прием они вдыхают 3—5 см³ эфира, после чего наступает состояние эйфории. Основным в эфирной эйфории является быстрое чередование радужных картин своеобразного веселья. После 5—8 ингаляций эфирной эйфории уже не наступает, а появляется состояние опьянения, похожее на алкогольное, но отличающееся от него тем, что больные не испытывают желания двигаться, петь, веселиться, а, наоборот, стремятся к полному покою и одиночеству.

При вдыхании 15—20 см³ эфира наступает усталость, сонливость и поверхностный сон, сопровождающийся грезами. Через 3—4 часа эфирное опьянение проходит. Больные, проснувшись, вновь вдыхают эфир, вызывая повторную эйфорию и т. д.

Эфирное опьянение может быть всегда прервано путем прекращения ингаляций эфира.

В течение 1—2 суток после прекращения ингаляций эфира от эфироманов ощущается запах эфира.

При применении эфира внутрь опьянение наступает постепенно, но может быть прервано с такой же быстротой, как и при ингаляции.

Одним из характерных симптомов эфирного опьянения является грезоподобное состояние. Реальный мир исчезает, больные погружаются в мир грез и видений. С течением времени эфироманы теряют трудоспособность, аппетит исчезает, питание падает, половое влечение отсутствует. Отмечается лабильность эмоциональной сферы, повышенная нервность,

раздражительность, понижение памяти, страх, подозрительность, пугливость, расстройство сна.

Иногда возникает бред, напоминающий таковой у алкоголиков, а также бредовые идеи ревности.

По прекращении приема эфира появляется легкая абстиненция, выражающаяся в угнетенном состоянии, болезненном влечении к эфиру, расстройстве сна, чрезмерной усталости. Эта абстиненция кратковременна и проходит через 5—6 дней после прекращения вдыханий эфира.

Деградация эфироманов происходит по типу алкогольной, но она выражена значительно слабее.

Диагностика эфиромании не представляет затруднений: запах эфира при дыхании, воспаленные красные глаза, постоянный насморк, бронхит, апатия позволяют распознавать заболевание.

Л е ч е н и е. Эфироманов, как и алкоголиков, следует лишать эфира сразу.

Абстинентный синдром ликвидируется в течение нескольких дней. Он купируется снотворными (хлоралгидрат, люминал, паральдегид), которые не следует давать больше 2—3 дней во избежание привыкания к ним. Катарральные явления со стороны слизистых оболочек часто проходят без всякого лечения. Очевидно, здесь играет роль устранение этиологического фактора.

Эфироманов лечат в основном так же, как и алкоголиков. Следует предостерегать эфироманов от алкоголизма, опасность развития которого у них существует.

Г л а в а XVII

ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ПРЕПАРАТАМИ БАРБИТУРОВОЙ КИСЛОТЫ

(веронал, люминал, амитал-натрий, мединал, ноктал, эвипан,
фанодорм и др.)

Острое отравление вероналом, мединалом, люминалом, нембуталом, амитал-натрием, эвипаном, фанодормом и другими производными барбитуровой кислоты дает одну и ту же клиническую картину. Отравление препаратами барбитуровой кислоты чаще всего наблюдается у алкоголиков и других наркоманов. Эти средства более доступны населению вследствие того, что они применяются от бессонницы. Принятые в очень больших дозах, они могут дать картину острого отравления. Смертельная доза препаратов барбитуровой кислоты колеблется в пределах от 5 до 20 г в зависимости от индивидуальной чувствительности к этим средствам. Вскоре после приема больших токсических доз препаратов барбитуровой кислоты наступает оглушение или более глубокое нарушение сознания, беспокойство, делириозное, аментивное или маниакальное состояние, которое заканчивается сном, переходящим в глубокую кому. Зрачки резко суживаются и не реагируют на свет, сухожильные рефлексy ослабевают или исчезают, возникает атактическая походка. Кровяное давление падает. Появляется кожная сыпь и отеки, крапивница, цианоз. Больной испытывает крайнюю слабость. Дыхание носит характер чейн-стокова. Отмечаются явления токсической нефропатии, гематопорфирурии, гематопорфирурии и т. д. Больные погибают от паралича дыхательного центра. В более легких случаях отравления препаратами барбитуровой кислоты кома сменяется длительным сном, и больные медленно пробуждаются.

При тяжелом отравлении препаратами барбитуровой кислоты развивается глубокое и разлитое торможение, которое охватывает не только кору мозга, но и нижележащие отделы центральной нервной системы. Клинически это проявляется в полной утрате сознания, общей арефлексии, отсутствии воз-

будимости и растормаживании примитивных рудиментарных рефлексов, а также в более или менее длительном угнетении вегетативных функций (нарушение дыхания — типа Чейн-Стокса, Биотта, ослабление пульса и т. д.).

Раньше всего от разлитого глубокого торможения освобождаются подкорковые области. Когда торможение начинает ослабевать, исчезают рудиментарные и патологические рефлексы и восстанавливаются вначале оборонительные, а затем (еще в неполной мере) ориентировочные безусловные рефлексы, причем оборонительные реакции значительно повышаются.

Усиление защитных оборонительных рефлексов сопровождается повышением сухожильных рефлексов, что объясняется явлениями положительной индукции после глубокого торможения подкорковых двигательных областей. Позже, когда полностью восстанавливается ориентировочный рефлекс, нормализуются оборонительные реакции, а также вегетативные функции. Позднее всего от глубокого торможения освобождаются наиболее реактивные и ранимые корковые клетки.

Вначале из состояния торможения выходит первая, а затем вторая сигнальная система как наиболее молодая в эволюционном отношении. Больные постепенно начинают правильно показывать и подавать названные им предметы, но вследствие торможения речевых реакций, нарушения связей между первой и второй сигнальными системами, еще не отвечают на вопросы, не могут вступать в речевой контакт с окружающими.

При изучении динамики освобождения от торможения второй сигнальной системы в ее взаимодействии с первой удастся проследить, что прежде всего восстанавливаются наиболее старые в онтогенетическом отношении словесные реакции и ассоциации. На первом этапе восстановления больные могут правильно назвать свое имя, фамилию, хорошо известные им привычные предметы. Однако отмечается затруднение в подыскании соответствующих слов, названий менее знакомых предметов и др. Больные могут показать, что делать с данным предметом, обозначить это действие соответствующими словами, однако правильно назвать предмет они не могут вследствие нарушения передачи из первой сигнальной системы во вторую. Позднее всего от торможения освобождаются словесные реакции и ассоциации, приобретенные на более поздних ступенях онтогенетического развития. В дальнейшем, при освобождении от разлитого торможения всей коры восстанавливаются нормальные соотношения между первой и второй сигнальной системой.

Почти во всех случаях отравления отмечается гипертермия, температура иногда достигает 39°. После острого отравления нередко отмечается горизонтальный и вертикальный нистагм, появляющийся спонтанно или при движении глаз, а также параличи наружных мышц глаз.

Лечение. При остром отравлении барбитуратами необходимо немедленно обезвредить еще не всосавшийся яд посредством удаления его из желудочно-кишечного тракта адсорбцией, окислением, осаждением и по возможности нейтрализацией. Если яд уже всосался, следует принять все меры для лечения токсикоза и поддерживать сердечную деятельность больного, чтобы его организм мог сопротивляться интоксикации. Очень важно также предупредить осложнения.

Больному возможно раньше делают промывание желудка, соблюдая известную предосторожность, ибо в тех случаях, когда отсутствует глоточный рефлекс, можно ошибочно ввести зонд в дыхательное горло, что приводит к весьма печальным последствиям — асфиксии, аспирационной пневмонии и др.

Желудок обычно промывают раствором марганцовокислого калия 1 : 2500 или 0,25% взвеси животного угля (*carbo animalis*). Около 70% барбитуратов выделяется с мочой, а некоторое количество — с калом. Поэтому, чтобы ускорить выделение барбитуратов из организма, удаляют при помощи катетера мочу и делают промывание кишечника.

Внутривенно вводят 0,25—0,5% раствор бикарбоната натрия в количестве 0,5—1 л. Стрихнин по праву считается одним из активнейших средств, действующих противоположно барбитуратам. Терапевтическую дозу стрихнина определяют, исходя из состояния больного в данный момент (0,1% *Sol. Strychnini nitrici*).

Ввиду необходимости быстрого воздействия, стрихнин следует вводить внутривенно.

При появлении стрихнинной интоксикации (гиперестезия, судороги, ригидность мышц) дозы стрихнина уменьшают до 0,001 г на одну инъекцию. В случаях повышенной чувствительности организма к стрихнину применяют внутривенные вливания 100 мл 15—30% алкоголя каждые 2 часа, не превышая 150 мл общего количества чистого алкоголя.

Не являясь сторонниками применения чрезвычайно больших доз стрихнина, которые сами по себе могут дать дополнительную картину стрихнинной интоксикации, мы рекомендуем применять стрихнин при коме, вызванной барбитуратами, внутривенно по 0,001—0,003 г каждые 3—4 часа. При повышенной чувствительности организма к стрихнину рекомендуется отменять его немедленно.

Довольно благоприятные результаты при коме, вызванной барбитуратами, дает коразол, который обычно вводят под кожу в виде 10% раствора по 1—3 мл.

Райфенштейн и др. усиленно рекомендуют лечить острое отравление барбитуратами пикротоксином. Больным в состоянии комы они вводили по 0,006 г пикротоксина через различные промежутки времени с таким расчетом, чтобы больной за 12 часов получил 0,06 г пикротоксина. Через 2—3 минуты

после каждой инъекции наблюдалось временное ослабление комы и повышение чувствительности, а затем кома возобновлялась; в дальнейшем больной выходил из состояния комы и сознание его прояснялось. Пикртоксин вводился внутривенно под контролем врача; при появлении подергивания губ пикртоксин начинали вводить через большие промежутки времени.

Своего опыта по применению пикртоксина мы не имеем, но в современной иностранной литературе о нем имеются прекрасные отзывы.

Для поддержания общего состояния организма проводится симптоматическое лечение; вводят подкожно камфору, кофеин, назначают витамин В₆, кордиамин, кладут грелки к ногам. В случаях резкого падения кровяного давления вводят адреналин. При расстройстве дыхания назначают лобелин. Иногда применяют кровопускание, выпуская 300—400 г крови. Если кома продолжается долго и состояние больного ухудшается, можно сделать переливание крови. Под кожу вводят кислород (300—400 см³), внутривенно—глюкозу. Применяют также вдыхание кислорода с углекислотой, искусственное дыхание, согревание всего тела и т. п.

Следует помнить, что здесь дана лишь схема лечения острого отравления барбитуратами и что лечение каждого больного должно строго индивидуализироваться.

ХРОНИЧЕСКОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ПРЕПАРАТАМИ БАРБИТУРОВОЙ КИСЛОТЫ

Хроническое отравление препаратами барбитуровой кислоты (вероналом, люминалом и др.) обычно сочетается с другими наркоманиями и редко бывает самостоятельным заболеванием. Часто алкоголики прибегают к вероналу и люминалу как к средству, вызывающему опьянение. Часть морфиноманов в период ремиссии, борясь с бессонницей, которая может у них появляться во время псевдоабстиненции, прибегает к вероналу, люминалу и другим барбитуратам и постепенно привыкает к ним.

Выраженные невротики, больные с вяло текущими формами психических заболеваний при наличии стойкой бессонницы также длительно злоупотребляют барбитуратами.

Клиническая картина отравления препаратами барбитуровой кислоты напоминает изменения при тяжелых органических поражениях центральной нервной системы.

Мимика при хроническом отравлении препаратами барбитуровой кислоты становится вялой, выражение лица апатичным. Взгляд бессмысленный, неподвижный. Зрачки узкие, на свет реагируют вяло, или совсем не реагируют.

Речь монотонная, невнятная, неясная, скандированная. Говорят больные медленно, долго подбирают слова, часто употребляя их невольно, неловко поправляясь. Почерк изменяется и немного напоминает почерк больных при белой горячке. Руки дрожат, походка неуверенная, напоминает атактическую. Моторика заторможенная. Иногда наблюдается расстройство глотания. Со стороны психики отмечается апатия, расстройство внимания. Больные кажутся крайне утомленными, лица у них изможденные, бледные; они испытывают постоянную сонливость. Круг интересов суживается. Мышление становится поверхностным. Больные делают крайне лживыми, аморальными и тупыми, замкнутыми, раздражительными. Контакт с ними затруднен. Память больных значительно снижается. В некоторых случаях при хроническом отравлении препаратами барбитуровой кислоты наблюдаются настоящие психозы с бредом преследования, дезориентировкой, галлюцинациями зрения и слуха.

Делирий, вызванный барбитуратами, отличается от алкогольного отсутствием характерного дрожания и бреда профессиональных занятий.

Лечение таких больных можно проводить лишь в больничных учреждениях. Резко выраженной абстиненции при лишении веронала не наблюдалось, а поэтому рекомендуется лишать больных этого наркотика немедленно.

При лишении люминала, веронала и других производных барбитуровой кислоты может наступить бредовое состояние, бессонница.

В случаях бессонницы в течение нескольких дней можно ограничиться большими дозами брома с тем, чтобы в дальнейшем приучать больных обходиться без всяких лекарств. Большую пользу приносят длительные теплые ванны, назначаемые перед сном. Применяется лечение стрихнином, вдывание кислорода, фенамин, первитин, глицерофосфаты, препараты лимоника, витамины В₁, С, РР и др.

Решающая роль отводится психотерапии. Наряду с этим, надо лечить и основную болезнь или сопутствующую наркоманию.

ХРОНИЧЕСКОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ФЕНАМИНОМ, ПЕРВИТИНОМ

Лица, принимающие фенамин и первитин в качестве стимуляторов нервной системы, привыкают к ним аналогично тому, как привыкают к наркотикам. Такого рода больные прибегают к фенамину, чтобы повысить работоспособность и свой психический тонус. Исследования В. К. Фаддеевой указывают на то, что малые дозы фенамина стимулируют корковые сигнальные системы, а большие после кратковременного периода повышенной возбудимости вызывают в коре больших полушарий явления глубокого стойкого запредельного торможения.

Даже временное злоупотребление фенамином в период экзаменов и т. д. при неправильном образе жизни и питании может привести к срыву нервной системы. Имеется много указаний на тяжелые психические расстройства, вызванные злоупотреблением фенамином. У тех больных, которых нам приходилось наблюдать (больные принимали ежедневно в течение 5—6 лет по 0,2—0,4 г фенамина), отмечались резко выраженные бредовые идеи отношения, воздействия, сопровождавшиеся яркими слуховыми и в меньшей степени зрительными галлюцинациями, настроение у таких больных тревожное, подавленное. Один наш больной К. по бредовым мотивам боялся ночевать у себя на квартире, а ночевал на кладбище.

Наблюдались случаи внезапной смерти после приема очень больших доз фенамина или первитина.

Лечение лиц, злоупотребляющих фенамином и в основном первитином, сводится к прекращению дальнейшего поступления в организм этого вещества, что достигается путем стационарирования больных. Основную роль отводят патогенетически обоснованной сонной терапии, а также психотерапии.

КОФЕИНИЗМ (ТЕИЗМ)

Кофе и чай содержат один алкалоид — кофеин. Кофеин необходимо рассматривать как стимулятор нервной системы, обладающий возбуждающим действием. Сотрудниками И. П. Павлова доказано стимулирующее влияние кофеина на раздражительный процесс (М. К. Петрова, М. А. Усиевич и др.). После приема кофеина отмечается гиперемия лица, блеск глаз, лицо делается оживленным, пульс учащается. Длительное злоупотребление большими дозами кофеина (принимаемого в виде порошка или большого количества чашек крепкого кофе или чая) ведет к тяжелым нарушениям со стороны нервно-психической сферы и внутренних органов. Часто при кофеинизме и теизме наблюдаются головные боли, головокружение, расстройство сна, кошмарные сновидения, ведущие к внезапному пробуждению. Нередко отмечаются невралгии тройничного нерва, межреберные невралгии и др. В мышцах бывают неприятные ощущения, судороги икроножных мышц. Почти у всех больных наблюдается мелкое дрожание пальцев рук, распространяющееся иногда на язык, губы, мышцы лица. Болевая чувствительность обычно повышена. Сухожильные рефлексы слегка повышены. Настроение делается неустойчивым, чаще преобладает грустное. Мышление у больных несколько замедлено. Характер их изменяется, они становятся нерешительными, внушаемыми, боязливыми, мнительными. Наблюдается сердцебиение, аритмия и учащение пульса, сопровождающиеся иногда тревогой и страхом. Часто бывает вазомоторное расстройство.

Кофеинизм нередко ведет к развитию общего атеросклероза. Функция органов пищеварения нарушается, теряется аппетит, особенно в отношении мясной пищи, язык обложен, нередко бывает тошнота и рвота. Запор может перемежаться с поносом и сопровождаться геморроидальными явлениями.

Известно, что кофе задерживает менструальную функцию. У мужчин кофеинизм ведет к понижению половой функции. Часто больные жалуются на зуд, нередко бывают дерматиты, а также сыпь типа крапивницы. В тяжелых степенях кофеинизма может развиваться кахексия. В зависимости от тяжести заболевания различают легкую, среднюю и тяжелую степень кофеинизма. При легкой степени отмечается лишь сердцебиение, невралгия, расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, зуд и другие нарушения.

Лечение кофеинизма должно быть направлено на прекращение употребления кофе или препаратов кофеина. Прекращение приема кофеина может вызвать иногда бессонницу, тоску, сердцебиение, головные боли, физическую слабость. Но эти явления проходят в короткие сроки. Хорошие результаты дает психотерапия. Больным назначают хвойно-солевые ванны, подкожное вдувание кислорода, препараты брома, глицерофосфаты. Весьма существенным фактором является регулирование сна. Для этой цели больным назначают на ночь амитал-натрий, нембутал, фанодорм, минал, бромурал.

Благотворно на больных действуют бромистые препараты в сочетании с фосфорнокислым кодеином и валериановой настойкой, которые регулируют нарушенные функции высшей нервной деятельности и расстройство со стороны органов кровообращения.

Г л а в а XVIII

ОСТРОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ТАБАКОМ

Основным алкалоидом табака является никотин. Количество никотина в различных табаках содержится в дозе от 2 до 7%.

Никотин весьма ядовитое вещество. Капля никотина, введенная в конъюнктиву белой мыши или воробья, убивает их молниеносно. Наряду с никотином в табаке содержатся вредные вещества, возникающие в процессе его сгорания. Табачный дым содержит синильную кислоту, никотин, никотилин, никотинин, пиридин, формол, окись углерода и др. Токсичность табачного дыма колеблется в зависимости от сорта табака и способа его приготовления. Влияние никотина на высшую нервную деятельность животных изучалось И. Н. Журавлевым и А. А. Новиковой. Малые дозы никотина вызывали повышение раздражительного и ослабление тормозного процесса. Средние дозы никотина вели к появлению фазовых состояний (уравнительная и парадоксальная фаза). Дальнейшее увеличение дозы никотина вело к углублению тормозного процесса, вплоть до исчезновения пищевых условных рефлексов. А. А. Новикова правильно объясняет это появлением запредельного торможения. И. Н. Журавлев в основе действия никотина видит угнетение процессов возбуждения. Н. И. Красногорский, изучавший влияние курения табака на высшую нервную деятельность детей, пришел к выводу, что никотин у детей оказывает возбуждающее действие на условнорефлекторную деятельность.

Табак является сосудистым ядом, способствующим развитию артерносклероза сосудов, гипертонической болезни и т. д. Отравление табаком развивается у лиц, длительное время злоупотребляющих курением табака, жеванием или нюханием его.

Острое отравление табаком наблюдается после выкуривания без привычки большого количества табака или после умышленного отравления его настойкой. Клиническая картина

отравления табаком обусловлена его основным действующим началом — никотином. Она выражается в тошноте, рвоте, головокружении, сильной головной боли. У больных наступает сильное беспокойство, нарушается координация движений. Появляется общая слабость, слюнотечение, резкое побледнение лица, чувство сжатия и теплоты в желудке, пищеводе, гортани, позывы на мочеиспускание и дефекацию. При тяжелых отравлениях рвота многократно повторяется, возникает шум в ушах, упорная головная боль; зрачки суживаются, тело покрывается холодным потом. Отмечается оглушенность, затемнение сознания, судороги, припадки. Наконец больные впадают в обморочное состояние. Смерть наступает в результате паралича дыхательного центра при явлениях потери сознания, аритмии, резкого понижения чувствительности; зрачки расширенные или неравномерные. Иногда при отравлении табаком наблюдается сравнительно удовлетворительное самочувствие, но дыхание чрезвычайно замедлено.

Лечение. При отравлении табаком делают промывание желудка, дают танин. Антидотом табака считают атропин, назначаемый в виде 0,1% раствора подкожно по 1 мл. В случае необходимости инъекции атропина можно делать повторно. Наряду с этим вводят камфору, кофеин, кардиазол, применяют искусственное дыхание.

ХРОНИЧЕСКОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ТАБАКОМ

При хроническом отравлении табаком наблюдаются изменения почти во всем организме, но больше всего поражаются пищеварительные органы, органы кровообращения, дыхания и нервная система. Нарушение деятельности пищеварительного тракта у привычных курильщиков выражается в понижении аппетита, диспептических явлениях, запорах, сменяющихся поносами, эпигастральных болях. Иногда у курильщиков табака бывают боли, напоминающие боли при язве желудка. Ряд исследователей указывает на курение табака как на один из этиологических факторов круглой язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Органы кровообращения также претерпевают ряд патологических сдвигов. Особенно часто встречаются ангиноподобные боли, появляющиеся обычно по почам и достигающие иногда большой силы, давая повод к смешению их с грудной жабой. При этом объективно у больных отмечаются экстрасистолы, респираторная аритмия или длительная брадикардия. Во многих случаях аорта бывает уплотненной, расширенной. Кровяное давление, особенно у молодых лиц, повышено на 10—50 мм ртутного столба, причем повышение это значительно колеблется. В свое время много говорилось о «табачном склерозе», «табачном сердце». У большинства курильщиков таких тяжелых сдвигов не отмечается и обнаруживаются

лишь функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы. Вначале появляется учащение сердечной деятельности, которое может переходить в привычную тахикардию. Наряду с этим отмечаются неприятные ощущения в области сердца. Николай и Штегелин проводили измерение пульса ежедневно в течение года по нескольку раз в день при различных ситуациях; на протяжении одного полугодия больные курили, в течение второго — табака не употребляли. Эти авторы установили, что в первое полугодие пульс был в среднем на 7—8 ударов в минуту чаще, чем во второе.

Павлинский, проводивший исследование в 2000 случаев грудной жабы, установил, что основной причиной ее развития в 42% было курение табака.

Наблюдаются также различные нервные явления, интенсивность которых зависит от индивидуальных качеств, а также от степени табачной интоксикации. Наряду с неврастеническим синдромом могут наблюдаться различные невралгии, периодическая потливость.

Иногда возникают явления, напоминающие спинную сухотку: приступообразные боли, ослабление зрения, сужение зрачков, двигательная атаксия, нередко отсутствие пателлярных рефлексов, рвота и т. п. Иногда встречается амблиопия, начинающаяся с быстрого утомления зрения при чтении, мелькания и ощущения давления в глазах.

Описаны случаи, когда у лиц, сильно злоупотреблявших табаком, развивались судорожные припадки.

Явления со стороны сердечно-сосудистой системы нередко сопровождаются нарушением дыхания вплоть до бронхиальной астмы. Наряду с этим отмечается раздражение слизистых оболочек, ларингиты, фарингиты, бронхиты, конъюнктивиты и др. Курение табака снижает сопротивляемость инфекциям и при наличии других неблагоприятных факторов способствует развитию туберкулеза.

В литературе указываются случаи ослабления половой функции у курильщиков табака. Отрицательное влияние табака на половую функцию связывается с угнетающим влиянием никотина на спинной мозг.

Более серьезные изменения отмечаются в половой сфере женщин. У женщин при длительном отравлении табаком, вследствие его способности вызывать спазм гладкой мускулатуры, часто наблюдаются выкидыши, нарушение менструальной функции и т. п.

При лишении больных табака появляется абстиненция, отчасти напоминающая морфиную и другие виды абстиненции.

Никотинная абстиненция. В первые дни никотиновой абстиненции отмечается некоторое повышение утомляемости, сильное влечение к табаку. У части больных имеет место апатия, депрессия, тоска, беспричинные слезы, сильная раз-

дражительность, нервность и т. п. Одним из важнейших психических симптомов при никотинной абстиненции Раппопорт считает вялость, рассеянность, расстройство внимания, сосредоточения и т. п. Сон становится поверхностным, тревожным. Иногда может появляться повышенная сонливость или полная бессонница. Наблюдается также двигательное возбуждение. Больные все время находятся в движении, ходят по комнате из угла в угол, сильно жестикулируют, беспрестанно жуют, независимо от аппетита. Они жалуются на головокружение, шум в ушах, иногда головную боль. Раппопорт связывает эти явления с изменением кровенаполнения мозга. Наряду с этим, появляется физическая слабость, разбитость, вялость, которая, возможно, зависит от снижения тонуса сердечной деятельности. Отмечаются сердцебиение, боли в сердце, аритмия. Абстинентные явления будут нам понятны, если мы вспомним опыты Березина на изолированном сердце, который установил, что «при повторном длительном пропуске никотина сердце настолько привыкает к нему, что без него работает хуже, а при нем вновь устанавливает свою прежнюю деятельность».

Почти у всех курильщиков после лишения табака повышается аппетит. У меньшинства из них отмечаются боли в области желудка, поносы, сухость во рту, усиленная саливация и т. п. Изредка наблюдается повышенная потливость, раздражение дыхательных путей и т. п.

Интенсивность абстинентных явлений у курильщиков табака различна. В части случаев абстиненция совсем не отмечается. Более тяжелая абстиненция, по Раппопорту, наблюдается при истерии, эпилепсии и при лабильности вегетативной нервной системы.

В возрасте от 18 до 25 лет абстиненция протекает более бурно. Раппопорт и Лахман объясняют никотинную абстиненцию падением тонуса парасимпатической нервной системы вследствие того, что действие табака на организм человека сводится в основном к хроническому повышению этого тонуса. Лишение привычного возбудителя ведет к падению тонуса.

Учитывая изложенное, Раппопорт предложил лечить никотинную абстиненцию назначением в первые дни пилокарпина для восстановления нарушенного вегетативного равновесия.

Лечение. Лечение курильщиков является самой трудной задачей в области наркологии, тем не менее во многих случаях можно добиться успеха. Курение необходимо прекратить немедленно, не допуская уменьшения количества выкуриваемых папирос, курения «без затяжки» и т. д. Исключения допустимы, как и при других наркоманиях, у истощенных больных и больных с тяжелыми сердечными расстройствами. Постепенное уменьшение количества выкуриваемых папирос, а также переход на «гигиенические мундштуки», «обезникотиненный» та-

бак и т. п. не дают никакого результата, так как все равно сохраняется привычка курить. Хотя вначале курят меньше, но тенденция к снижению количества выкуриваемых папирос держится недолго, и больной вскоре вновь возвращается к своим прежним «нормам» или даже превышает их. Употребление «обезникотипенного» табака не имеет смысла, так как никотин, хотя и в меньшем количестве, но продолжает поступать в организм.

Развивающуюся по прекращении курения абстиненцию Раппопорт рекомендует лечить пилокарпином в небольших дозах, поднимающим тонус парасимпатической нервной системы. Пилокарпин представляет собой алкалоид, родственный по действию никотину, и при отнятии последнего может сыграть компенсирующую роль. Наряду с пилокарпином, в зависимости от выраженности абстинентных явлений, показаны успокаивающие, снотворные, болеутоляющие, сердечные и т. п. Пилокарпин назначают в следующей прописи:

Rp. Pilocarpini hydrochlorici 0,05

Aq. destill. 200,0

MDS. По 1 столовой ложке 3—4 раза в день

При астенической реакции, когда после прекращения курения наступает вялость, сонливость, к этой микстуре добавляют кофеин, а при возбуждении, расстройствах сна и т. п. — бром и кодеин.

Иногда применяют смазывание слизистой рта и глотки средствами, оказывающими прижигающее или вяжущее действие. Для этой цели пользуются 0,5—1% раствором азотно-кислого серебра, полуторахлористым железом, 5% раствором протаргола и т. п. После смазывания слизистой рта этими средствами курильщик «не ощущает вкуса от папирос» или испытывает неприятные ощущения, вплоть до тошноты, в течение 1—2 часов. Влечение к табаку при этом все же сохраняется. Можно с успехом сочетать прием внутрь пилокарпина (подавляющего до известной меры влечение к табаку и смягчающего абстиненцию) с упомянутыми вяжущими средствами. Подобное лечение нужно проводить в течение 7—10 дней, т. е. до исчезновения абстиненции.

Огромную роль при лечении курильщиков играет психотерапия. Во многих случаях большую пользу может привести и систематически проводимая гипнотерапия.

Курильщики должны помнить, что по окончании лечения им совершенно нельзя курить, ибо после выкуривания первой же папиросы наступает рецидив. Влечение к табаку, уже до известной степени подавленное, вспыхивает с прежней силой, и курильщик вновь начинает курить.

Следует указать курильщику, что, прекращая курение, он тем самым укрепляет свою волю, дисциплинирует себя и на-

рядом с этим оздоравливает свой организм. Надо вкратце ознакомить курильщика с влиянием табака на центральную нервную систему и внутренние органы. Необходимо всеми мерами укреплять желание курильщика прекратить курение, на конкретном примере показать ему вред, приносимый табаком, но делать это нужно осторожно, избегая иатрогении. В тех случаях, когда курильщика направляют на лечение терапевты, фтизиатры, кардиологи, ото-ларингологи, окулисты и когда он знает, что имеющееся у него заболевание вызвано курением, нужно заострить на этом внимание больного, указав ему, что нередко такие заболевания проходят вскоре после прекращения курения.

В Московских диспансерах широко применялась коллективная психотерапия для групп в 10—30 человек. В первой беседе подчеркивается, что пришедшие лечиться давно уже думали прекратить курение, что само желание их лечиться уже является залогом того, что они оставят курение и что общими усилиями каждого из них в отдельности, сочетающимися с усилиями врача, им, наконец, удастся осуществить свое желание. Указывается, что лечение возможно лишь при строгом выполнении указаний врача. В первой же беседе больным объясняют вредное действие табака на организм человека. Важно подкрепить беседу соответствующим иллюстративным материалом (рисунки, картины, диапозитивы, диапозитивные кинофильмы и т. п.).

После беседы присутствующим рекомендуется немедленно прекратить курение, назначая для купирования абстиненции пилокарпин.

Во время следующей беседы объясняется механизм привыкания к табаку, а также освещаются абстинентные явления на основе опроса и разбора отдельных случаев. Больных предупреждают, что бросить курение нелегко, но что при серьезном подходе к этому вопросу успех лечения будет обеспечен. Параллельно с этим проводится коллективное внушение с целью вызвать у больных безразличие к табаку, подавить влечение к нему.

Наряду с этим желательно проводить детальное медицинское исследование больных, назначая им, в зависимости от состояния здоровья, дополнительное лечение для повышения тонуса нервной системы: стрихнин, первитин, фенамин и др. Само собой разумеется, что назначать те или иные средства можно лишь при отсутствии соответствующих противопоказаний.

Лечение курильщиков табака проводится в амбулаторных условиях. Однако в случаях, не поддающихся излечению в этих условиях, желательно стационарирование в закрытых лечебных учреждениях. К сожалению, нигде в мире таких учреждений нет, хотя нужда в них большая.

В тех случаях, когда не удастся добиться прекращения курения табака, рекомендуется как паллиатив ограничение курения и максимальное обезвреживание табачного дыма. С этой целью при курении папирос следует применять разного рода мундштуки; трубки необходимо часто чистить и вкладывать в них ватный тампон, смоченный полутораклористым железом, благодаря чему вдыхаемый дым в значительной мере освобождается от никотина и т. д.

Ю. А. Поворинский разработал поэтапный метод лечения табакокурения. Первый этап — знакомство с личностью и типом нервной системы курильщика, регистрация раздражителей, вызывающая потребность в курении условнорефлекторным путем. Второй этап — изучение абстинентного синдрома и разрушение автоматизма курения табака посредством разъединения привычных ассоциаций, т. е. растормаживанием прочно закрепленных условных реакций. Врач на первых этапах лечения преодолевает представление у больного о трудности отвыкания от курения. В беседах с курильщиком его внимание направляется к тому моменту, когда цель будет достигнута и тяга к табаку будет преодолена. На третьем этапе проводятся сеансы внушения. Однако Ю. А. Поворинский не придает решающей роли внушению. Во время внушения подводится итог работы, которая была проделана пациентом над собой с помощью врача. Наряду с психотерапией Ю. А. Поворинский рекомендует лекарственное и физическое лечение.

Глава XIX

БОРЬБА С НАРКОМАНИЯМИ

Еще в глубокую старину предпринимались различные меры против употребления алкогольных напитков. Лицам, злоупотреблявшим алкогольными напитками, грозили строгими наказаниями и даже смертью. У египтян, а затем и у римлян перед пирующими ставили скелет. Император Домициан приказал истребить половину виноградников в Риме и запретить в провинциях дальнейшее насаждение виноградной лозы. Все это делалось с той целью, чтобы сократить сырье для добывания вина.

В средние века пьяных подвергали публичному телесному наказанию, ссылали их, отрезали у них уши, вливали в горло расплавленный свинец, кипящее молоко и т. п. Но, несмотря на жестокие меры, угрозы, наказания, все эти мероприятия не давали успеха, не оказывали серьезного влияния на уменьшение пьянства, потому что они делались отдельными лицами без поддержки самого народа. Лишь после многих неудач и долгой борьбы, когда появилось общее сознание чрезвычайной важности искоренения пьянства, стали намечаться более эффективные пути борьбы с этим злом.

Долгие годы алкоголь, разбавленный водой, под названием *Aqua vitae* применялся в качестве лечебного средства. Лишь в XVI веке водка вошла в широкий обиход и употребление в качестве напитка. Вначале водка была дорогим напитком, который был доступен лишь богатым зажиточным слоям населения, а затем, когда были открыты простые и дешевые способы добывания ее, она быстро и широко вошла в употребление и вытеснила мед, виноградные вина и др.

Первые попытки борьбы с пьянством в Европе были приняты в VI веке в Англии. В то время Гольдон Мудрый издал декрет, в котором указывалось, что «каждый монах, напившийся до того, что не в состоянии будет петь во время службы, будет оставаться без ужина».

В 1736 г. там была сделана уже более серьезная попытка борьбы с пьянством. После того как в английский парламент

поступила петиция значительного количества мировых судей, в которой они просили обратить серьезное внимание на чрезмерное пьянство среди населения и принять строгие меры против него, был издан закон, так называемый *gin act*, установивший очень высокий налог на водку, за нарушение которого накладывали штраф или даже подвергали телесному наказанию. Однако таким путем пьянство ослаблено не было. Вследствие высоких налогов на водку по всей стране широко возникла нелегальная продажа ее. Даже в аптеках, где спирт разрешали продавать лишь для медицинских целей, принялись широко изготовлять водку. Значительно увеличилась преступность. За нарушение «*gin act*» пострадало много людей, но пьянство не только не уменьшилось, а все более и более увеличивалось.

Провал «*gin act*» вынудил английское правительство отменить его и перейти к умеренному обложению вина. В 1830 г. в Англии был издан пивной закон «*Beer act*», всячески поощрявший пивоварение, так как этой мерой предлагалось уменьшить потребление и производство крепких спиртных напитков. Водки после этого стали пить как будто меньше, но стали пить много пива.

Применялись в Англии также и меры по упорядочению лечения алкоголиков. Так, например, в 1879 и 1888 гг. был принят закон, известный как «Акт о привычных алкоголиках», регулировавший помещение и лечение алкоголиков в специальных учреждениях.

Значительную работу в деле борьбы с алкоголизмом в Англии проделали общества трезвости, которые оказывали известное влияние в организации культурно-просветительных мероприятий, открытия дешевых чайных и столовых, а также оказывали влияние на правительство в деле разработки различных мероприятий по борьбе с алкоголизмом.

Карательные мероприятия против алкоголиков, господствовавшие в древнее время и средние века, были заменены лечебными мероприятиями в связи с изменением в половине XIX века взглядов на индивидуальный алкоголизм, который начали рассматривать не как порок, за который следует наказывать, а как нервно-психическое заболевание.

Первое лечебное учреждение для лечения алкоголиков было организовано в США в 1850 г. в Бимгемптоне в штате Нью-Йорк.

Вследствие того что не все алкоголики высказывали желание добровольно лечиться, возник вопрос об их принудительном лечении. Во многих странах по этому поводу существует специальное законодательство, дающее право в принудительном порядке помещать алкоголиков для лечения.

В 1874 г. американские женщины восстали против кабаков и организовали крестовый поход против пьянства и каба-

ков. Движение это началось в Глэгсборе в штате Огайо. Женщины написали воззвание к владельцам кабаков. Они объезжали кабаки, для того чтобы прочесть при звоне церковных колоколов, сопровождаемом пением псалмов и огромной толпой любопытных, это воззвание. Они требовали от кабатчиков бросить свое вредное занятие. Когда перепуганные кабатчики закрывали свои кабаки, не допуская к себе непрошенных гостей, женщины располагались лагерем у их заведений и не пускали в них посетителей, умоляя их подписать обет воздержания от алкоголя. Одновременно они продолжали убеждать кабатчиков оставить свою профессию. При этом не переставая звонили колокола, читались молитвы, пелись псалмы. Иногда такая осада кабака длилась неделями. Когда измученный кабатчик сдавался, совершался своеобразный ритуал — выливание вина из бочек в канавы.

Это движение распространилось и по другим штатам, но когда блокада кабаков прекратилась, кабатчики вновь принялись за свое дело. Временами женщины в США устраивали целые процессии, демонстрации против пьянства, собирая для этой цели маленьких детей 2—3 лет. Тысячи малышей выводились на демонстрацию с повешенными на них плакатами «Отцы и матери! Обращаемся к Вам, боритесь за воспрещение спиртных напитков: нас бьют наши пьяные отцы и матери».

Антиалкогольное движение среди женщин сыграло свою положительную роль; оно оживило работу старых обществ трезвости как в США, так и в других странах.

В последующие годы в США обратились к крайнему средству борьбы с алкоголизмом — полному запрещению производства и продажи алкогольных напитков.

Впервые запретительная система была введена в 1855 г. в штате Нью-Гемпшире, в 1869 г. в Вермонте и т. д. Наконец, в 1917 г. Конгресс США принял законопроект о введении «сухого закона», т. е. запрещении продажи и производства спиртных напитков во всех 48 штатах. «Сухой закон» вошел в силу в 1919 г. Но уже спустя непродолжительное время возникло тайное производство алкоголя и контрабандный ввоз его, о размерах которого можно судить по нижеприводимым данным.

	1922 г.	1923 г.	1924 г.
Обнаружено в США тайных аппаратов для винокурения	8 313	12 219	10 392
То же для пивоварения	81 640	124 401	124 720
Конфисковано спиртных напитков в галлонах в переводе на чистый спирт	382 390	457 365	1 627 734

Американские исследователи утверждают, что число конфискованного алкоголя составляло лишь около 10% всех произведенных спиртных напитков.

В США был создан настоящий контрабандный флот, занимавшийся перевозкой контрабандного спирта.

Смертность от алкоголизма в Нью-Йорке, снизившаяся в 1920 г. до 13 на 100 000 населения по соотношению со смертностью до введения сухого закона, уже в 1925 г. достигла 86% уровня до введения запретительной системы. Провал «сухого закона» в США был настолько ясен, что в 1932 г. конгресс США принял решение об его отмене. Как оказалось, одни запретительные меры без поддержки широких масс трудящихся оказались неэффективными.

Во Франции после войны были отменены все ограничения для производства и потребления алкоголя. Среднегодовое потребление различных спиртных напитков на душу населения во Франции в период с 1928 по 1932 г. составляло 20,64 л в пересчете на абсолютный алкоголь. Это самый высокий в мире показатель потребления алкоголя.

Смертность от алкоголизма, главным образом от белой горячки, во Франции растет. Число таких случаев смерти с 232 в 1944 г. поднялось до 1302 в 1948 г.

Смертность от цирроза печени, преимущественно алкогольного, поднялась во Франции с 2939 в 1944 г. до 4396 в 1948 г.

Повысилось также число алкогольных психозов. По официальным данным, в 1950 г. из 15 032 человек, принятых в психиатрические больницы, 3648, т. е. 25%, составляли больные алкогольными психозами.

Международное бюро по борьбе с алкоголизмом опубликовало сведения о среднегодовом душевом потреблении алкоголя в переводе на спирт в период с 1928 по 1932 г. Согласно этим данным, во Франции на душу населения приходилось 20,64 л абсолютного алкоголя, в Испании — 15,83, Италии — 11,80, Швейцарии — 10,53, Греции — 8,02, Бельгии — 7,83, Чехословакии — 6,5, Австрии — 5,84, Великобритании — 5,12, Венгрии — 4,89, Германии — 4,56, США — 4,09, Швеции — 3,49, Румынии — 3,36, Австралии — 2,88, Канаде — 2,46, Новой Зеландии — 2,37, Дании — 2,37, Норвегии — 2,11, в СССР — 1,04.

Таким образом, в нашей стране на душу населения приходилось меньше всего выпитого алкоголя.

Это сопоставление является неопровержимым подтверждением того, что успешная борьба с алкоголизмом, т. е. уничтожение его как социального явления, возможна только с ликвидацией капиталистического строя.

В Швеции в целях ограничения сильно развитого пьянства был введен ряд ограничительных мероприятий. В 1865 г. по инициативе городского управления Готтеборга была принята так называемая готтеборгская система, по которой монопольная продажа спиртных напитков принадлежала городским управам. Последние передавали это право акционерной компании, в основу деятельности которой были положены преиму-

щественно филантропические цели, так как доходы от продажи спиртных напитков приносили всего лишь 5—6% прибыли на затраченный капитал, а остальные доходы сдавались государству и общине. При готтеборгской системе открывалось такое количество питейных заведений, которое определялось лишь настоящей необходимостью. Питейные заведения работали только определенные часы—по будним дням, а по воскресным и праздничным дням они закрывались.

В этих питейных заведениях продавались различные кушанья, преимущественно горячие. Вследствие того что заведующие питейными заведениями должны были все деньги, вырученные от продажи алкогольных напитков, сдавать государству, а оставлять лишь 5% от этой суммы, а также всю выручку от продажи безалкогольных напитков, пищевых продуктов, кофе и пр., естественно, они были заинтересованы в продаже последних. Готтеборгская система вначале дала некоторые положительные результаты в деле уменьшения пьянства. Так, например, в Готтеборге перед введением этой системы было 72 кабака; акционерная же компания, начав свою деятельность с 36 мест продажи алкогольных напитков, постепенно сократила ее (к 1885 г.) до 19. Количество выпитого алкоголя на душу населения составляло в 1875 г. 33,2 л, а в 1892 г.— 6,4 л. Уменьшилось также число пьяных и больных алкоголизмом.

Аналогичная картина наблюдалась и в других городах Швеции. Однако готтеборгская система носила чисто формальный характер, ибо она не боролась с самим злом, не препятствовала злоупотреблению вином, а лишь регулировала торговлю алкогольными напитками с чисто внешней стороны, так как не устранялись социальные корни пьянства, вследствие чего эта система являлась лишь слабым паллиативом.

Так как готтеборгская система оказалась несостоятельной и алкоголизм в Швеции вновь начал расти, в 1914 г. там была введена так называемая система Братта, при которой продажа водки производилась только по карточкам. Карточки выдавались главе семьи, который в месяц мог бы приобрести 4 л водки на семью.

В начале введения этой системы потребление спиртных напитков снизилось на 30%, а затем вновь стало расти, что видно из следующих данных: в 1922 г. был выдан 1 млн. карточек, дающих право приобрести водку, а в 1946 г. число выданных карточек увеличилось до 1,7 млн.

Количество алкоголиков в Швеции с 31 300 в 1938 г. увеличилось до 43 000 в 1946 г. Соответственно возрастало и количество задержанного контрабандного алкоголя с 91 076 л в 1922 г. до 191 022 л в 1923 г. Вначале падение, а затем рост потребления алкоголя свидетельствуют о том, что все мероприятия, применявшиеся в капиталистических странах по борьбе с алкоголизмом оказались мало эффективными.

В капиталистических странах существует большой разрыв между законодательными мероприятиями и практикой борьбы с наркоманиями. Производство наркотиков там находится в руках промышленных монополистов, заинтересованных в распространении наркотических средств, являющихся предметом их обогащения, а также служащих целям усыпления и одурманивания масс.

До некоторой степени на положение дела проливает свет следующий факт.

Проведенное нью-йоркским генеральным прокурором¹ расследование торговли наркотиками показало, что большой процент покупателей наркотиков — кокаина, героина, амфетамина, маригуаны — вербуются среди подростков — учеников и учениц средних школ. Некоторые начинают курить папиросы из маригуаны уже с 12—13 лет. Их продают им ученики старших классов. Было обнаружено несколько кондитерских, где такая продажа происходит по окончании занятий в школе и во время большой перемены. Был указан один 17-летний юноша, который зарабатывал таким путем иногда до 300—400 долларов в день. Существует целая система приучивания детей к наркотикам: сначала им дают их бесплатно, потом за маленькую цену, а когда мальчик или девочка привыкнет, цена повышается. И несчастные жертвы идут на все — на голод, кражи, проституцию — чтобы добыть денег. Считают, что не менее 0,5% всех нью-йоркских детей отравляется наркотиками, при этом потребление наркотиков все возрастает: если в 1946 г. по соответствующей статье было арестовано в Нью-Йорке 712 человек (из них 33 молодых людей от 16 до 21 года), то в 1950 г. число таких арестованных поднялось уже до 2482, из которых около 1/4 было в возрасте от 16 до 21 года.

Несчастье этой молодежи еще усугубляется тем, что по американским законам сознавшиеся в потреблении наркотиков, подлежат не лечению, а обязательному заключению в тюрьму, и это многих удерживает от обращения за помощью. Дознанием установлено, что полиция Нью-Йорка также замешана в этом деле: некоторые из ее чинов поддерживали за взятки торговлю наркотиками. Одна наркоманка указала до 40 баров, кафетериев, кондитерских и др., где она приобретала наркотики. По сведениям Сенатской комиссии по расследованию преступности, в Вашингтоне и Чикаго происходит то же самое, только в несколько меньших размерах, чем в Нью-Йорке. Предполагается организация обследования на этот счет в общегосударственном масштабе.

В России первые попытки бороться с алкоголизмом были предприняты в 1652 г. на Соборе о кабаках, где по совету па-

¹ По сообщению журнала «Lancet», 1951, № 6669, июнь 23, стр. 1356—1357.

триарха Никона было постановлено «...продавать по одной чарке человеку, а больше той указанной чарки одному человеку не продавать, и на кружечных дворах и близко от двора питухам (т. е. пьяницам) сидеть и питье давать им не велено... Ни в долг ни под заклад вина не отпускать». Во время постов, по воскресеньям, средам и пятницам вино совсем не отпускатось, а в остальные дни продажа водки начиналась только «после обедни и прекращалась за 1 час до вечерни».

Однако спустя всего лишь 7 лет царская грамота предписывала головам и целовальникам (повидимому под влиянием финансовой нужды) совершенно обратное: «Великого государя казне учинить прибыль и питухов с кружечного двора не отгонять».

В 50—60-х годах XIX столетия в России возникли общества трезвости, составлявшие мирские приговоры, в которых членам этого общества предписывалось не употреблять спиртных напитков, или же члены общества давали священникам в церкви зарок не пить, причем нарушителей наказывало само общество. Откупщики кабаков повели борьбу с этим движением, убыточным для них, и нашли себе поддержку со стороны властей, что привело к закрытию обществ трезвости.

Эти общества трезвости вновь возникли в конце XIX века, они издавали специальные журналы, принимали участие в организации народных домов, содействовали развитию народного образования, устраивали народные развлечения, чайные, дешевые столовые.

Однако никакие добровольные общества по борьбе с пьянством не могли добиться успеха, потому что бороться необходимо было не с отдельными кабатчиками или откупщиками и торговцами алкоголем, а с патогонной системой, жестокой эксплуатацией трудящихся, с капиталистическим строем.

Существовавшие в дореволюционной России попечительства о народной трезвости носили лишь показной характер борьбы правительства с пьянством. Это были бюрократические учреждения, в которые входили реакционеры разных мастей.

В губернских попечительствах о народной трезвости обязательно председательствовал губернатор. В эти попечительства входили представители высшей бюрократической администрации города, цензовой, выборной и по назначению, например, представители, а чаще всего руководители жандармерии, предводители дворянства и высшие чиновники, управляющие отдельными правительственными учреждениями, представители от духовенства, военного и учебного ведомства, купечества, всего числом в 25 человек.

Уездные попечительства о народной трезвости были под председательством уездного предводителя дворянства и комплектовались таким же образом, как и губернские.

К началу первой мировой войны (1914) существовало 69 губернских, 8 областных, 639 уездных и окружных, 2 столичных и 6 особых, независимых от губернских попечительств о народной трезвости. Председателям этих попечительств предоставлялось право приглашать (с 1904 г.) для работы в них частных лиц из местных деятелей по борьбе с алкоголизмом. Были почетные члены и члены-соревнователи. Так, например, почетными членами Московского столичного попечительства о народной трезвости в 1902 г. состояли такие реакционеры, как московский митрополит Владимир, министр финансов С. Ю. Витте, государственный секретарь Коковцев и др.

Женщины фактически устранялись от работы в этих попечительствах и допускались лишь в качестве членов-соревнователей. Надзор за состоянием питейной торговли осуществлялся особым участковым попечителем.

Подобного рода бюрократический состав попечительства говорил о том, что правительство лишь маскировалось, делая вид, что оно борется за народную трезвость, в чем фактически усматривалась угроза финансовому благополучию страны, так как почти $\frac{1}{3}$ часть доходов государства зависела от продажи водки.

Местные общественные деятели, принимавшие участие в борьбе с алкоголизмом, были лишены возможности проводить свои идеи, так как они не имели права голоса и были весьма малочисленны. Так, например, в последние годы на 14 634 обязательных члена было лишь 337 приглашенных местных деятелей. Спрашивается, что могла предпринять эта горстка людей, составлявшая лишь 2,3% в деле борьбы с алкоголизмом.

Попечительства же о народной трезвости выполняли лишь волю, продиктованную свыше. Как состав этих попечительств, так и их содержание зависели от правительства.

Царское правительство отпускало в 1911 г. 2 782 000 рублей на работу попечительств о народной трезвости, львиную долю из которых получали столичные попечительства (петербургское 1 177 000 рублей, московское — 1 115 000 рублей). Общая же сумма, отпущенная на содержание учреждений попечительств, составляла 4 974 000 рублей, что равнялось лишь 0,83% чистой прибыли с винной монополии и 0,63% валового дохода за 1911 г.

Правительство в лице попечительств о народной трезвости якобы стремилось заполнить досуг населения, открывая чайные, столовые, библиотеки, читальни, организуя всевозможные народные увеселения, хоры, оркестры и т. п. Однако польза от этих чигален и библиотек была весьма относительная, так как большинство населения было безграмотно. Даже министр финансов подчеркивал, что «...при нашей безграмотности библиотеки и читальни служат только для небольшой части населения».

Дело в этих библиотеках было поставлено чрезвычайно плохо. Даже грамотному человеку делать в них было нечего, так как читальни обеспечивались особым видом литературы. Нужная, настоящая литература была изъята из них особыми стараниями цензуры и жандармского корпуса. О чисто формальной и показной работе попечительств о народной трезвости свидетельствует даже та в достаточной мере прикрашенная оценка, которую дал ей государственный контроль в объяснительной записке к отчету за 1909 г.: «Пятнадцатилетний опыт существования попечительств убеждает, что широко поставленные задачи оказались для них невыполнимыми».

Была только отчасти вскрыта и причина, которая, по мнению государственного контроля, «...кроется в самой организации попечительств... официальные представители разных ведомств едва ли могут представлять живую силу в борьбе с пьянством».

Попечительства о народной трезвости и православное духовенство монополизировали антиалкогольную пропаганду, ведя ее в религиозно-трезвенническом духе. Но эта литература не находила себе спроса. Так, например, журнал «Вестник попечительств о народной трезвости» прекратил свое существование в 1906 г.; двухнедельный религиозно-нравственный журнал «Друг трезвости» существовал лишь короткое время, «Трезвость и бережливость» перестал выходить с 1905 г. Наиболее долго просуществовал «Всероссийский вестник трезвости» (до 1912 г.) и «В борьбе за трезвость» (до 1914 г.).

Попечительства о народной трезвости организовывали в Петербурге и Москве амбулатории для лечения алкоголиков, что несомненно являлось положительной стороной их деятельности.

Работа попечительств о народной трезвости, лишенная общественной поддержки и общественной самодеятельности, не дала эффекта. Алкоголизм рос. Отпускаявшиеся царским правительством ежегодно большие субсидии на содержание попечительств о народной трезвости были малопродуктивной затратой народных денег. Царское правительство лишь делало вид, что борется с алкоголизмом, на самом же деле оно всячески поощряло и насаждало пьянство.

В противовес показным попечительствам о народной трезвости большую и плодотворную работу по борьбе с пьянством проделала русская прогрессивная общественность.

Русское общество охранения народного здоровья, при котором была создана постоянная комиссия по борьбе с алкоголизмом, издавшая свои труды под редакцией проф. Нижегородцева в XII томах (за период с 1898 по 1913 г.), несомненно внесло известный вклад в дело борьбы с пьянством.

Особое значение имели созываемые по инициативе комиссии по борьбе с алкоголизмом Всероссийские съезды по борь-

бе с алкоголизмом. Первый съезд происходил в Петербурге с 27 декабря 1909 г. по 6 января 1910 г. К участию в съездах привлекалось большое число делегатов от врачей, педагогов, обществ трезвости, печати, рабочих организаций, духовенства, чиновников Министерства финансов и др.

Первый Всероссийский съезд по борьбе с пьянством приветствовал и наш великий писатель Л. Н. Толстой, который в своем письме от 4 декабря 1909 г. на имя члена организационного комитета Д. Н. Бородина писал: «Дмитрий Николаевич, очень рад буду содействовать, чем могу, вашему прекрасному намерению. Чем больше я вижу зло, происходящее от пьянства (а вижу я это зло в ужасных размерах), и чем чаще мне приходится говорить об этом зле с страдающими от него... Избавится от него человек не тогда, когда он будет лишен возможности пить, а тогда, когда он не станет пить, хотя бы перед ним в его комнате стояло бы вино и он слышал его запах и ему стоило бы только протянуть руку...».

На первом съезде по борьбе с пьянством было заслушано много научных докладов, посвященных проблеме алкоголизма.

Известная работа по борьбе с пьянством велась и в Государственной думе. В 1907 г. за подписью 39 членов Государственной думы была подана петиция об образовании комиссии по выработке мер к прекращению пьянства, по изысканию других источников дохода взамен получаемых от продажи водки, для того, чтобы система налогов с населения через спиртные напитки, начиная с 1909 г., больше не применялась. В дополнение к этому проекту 7 декабря 1907 г. 31 членом Государственной думы был внесен законопроект, сводившийся к тому, чтобы уничтожить мелкую посуду ($1/200$, $1/100$ и $1/40$ ведра) и продавать водку на вынос в посуде размером не менее одной бутылки; предоставить сельским обществам право воспрещать на их территории открытие казенных и частных питейных заведений и закрывать существующие по приговорам обществ; сократить время торговли спиртными напитками.

Как и следовало ожидать, началась обычная волокита с прохождением этого законопроекта по различным инстанциям.

Дважды этот уже исправленный законопроект обсуждался в Государственном совете — первый раз в 1911 г. и второй раз в 1914 г., когда, наконец, был принят и вновь направлен в Государственную думу нового созыва. Но дума не успела рассмотреть его вследствие начавшейся первой мировой войны.

Как видно из вышеизложенного, проводившиеся меры борьбы с алкоголизмом результатов не давали.

Во время запрета продажи алкогольных напитков в период первой мировой войны с 1914 г. начало развиваться потребление суррогатов алкоголя, приготавливавшихся из денатуриро-

ванного спирта (ханжи), а также таких спиртосодержащих жидкостей, как одеколон, политура, лак, киндербальзам, а иногда и древесного метилового спирта, вызывавшего слепоту и смертельные отравления. Затем стало быстро возрастать самогонокурение. По данным ЦСУ СССР, опубликованным в 1929 г., общее производство самогона лишь на территории РСФСР в 1927 г. превысило 50 млн. ведер. Крайне вредное действие самогона, а также подрыв самогонокурением народной экономики побудили правительство РСФСР принять очень строгие запретительные законы.

По законодательству УССР неразрешенное приготовление и потребление спирта влекло за собой возможность предания суду военного трибунала и грозило применением высшей меры социальной защиты. Однако ничто не останавливало быстро возраставшее самогонокурение, которое приняло характер крупнейшего общественного зла. Советское правительство в 1922 г. вынуждено было разрешить продажу водки крепостью 20°. В 1924 г. было разрешено изготовление и продажа 30° водки, названной «русской горькой», и, наконец, в октябре 1925 г. — 40° водки.

Разрушение капиталистических порядков и построение социализма в нашей стране, господство социалистической идеологии и огромная воспитательная работа, которую вела и ведет Коммунистическая партия, в корне изменили духовный облик советских людей. Новый облик советского человека находит свое выражение в высоком уровне культуры, быта и духовных запросов народов нашей страны.

Моральный облик советского человека характеризуют его материалистическое мировоззрение, беззаветная любовь к социалистической родине, преданность великому делу строительства коммунизма, интернационалистическая идеология, коллективизм, активно-творческое отношение к жизни, любовь к труду, высокое чувство гражданского достоинства, сознание своего общественного долга и последовательное соблюдение норм социалистического общежития. Эти замечательные человеческие качества определяются всем строем советской жизни.

Мы имеем такие возможности развития личности и всего человеческого общества, каких еще не знала история.

В. И. Ленин писал, что социализм обеспечивает возможность «...втянуть действительно большинство трудящихся на арену такой работы, где они могут проявить себя, развернуть свои способности, обнаружить таланты, которых в народе — непочатый родник и которые капитализм мямл, давил, душил тысячами и миллионами»¹. И действительно, все мы видим и радуемся тому, что социалистический строй пробудил силы народа, открыл для миллионов советских людей безграничный

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 26, стр. 367.

простор для вдохновенного творческого труда, для учебы и работы во всех областях науки, техники, искусства и культуры.

В этой связи весьма показательны данные о росте культурного уровня советских людей, об их тяге к знаниям и массовом характере этих явлений, имеющих прямое отношение к вопросам борьбы с алкоголизмом. Известно, что чем выше культурный уровень людей, чем лучше удовлетворяются их духовные запросы, тем меньше бывает хулиганства, пьянства и других позорных явлений.

Прежде всего следует отметить, что СССР является страной всеобщей грамотности, достигшей высокого уровня социалистической культуры. Вся наша молодежь и миллионы взрослых людей учатся. Учатся в школах, в вузах, на предприятиях, в колхозах. На Коломенском паровозостроительном заводе имени Куйбышева учится каждый второй рабочий. На этом заводе имеется вечерний техникум, школа рабочей молодежи, широкая сеть курсов. Только за послевоенные годы на курсах обучено свыше 30 000 рабочих и служащих этого завода. На московском заводе «Красный пролетарий» за последние годы специальную производственную подготовку получили 90% рабочих основных цехов. Эти примеры типичны для большинства советских предприятий. Подсчитано, что в СССР только в различных звеньях системы повышения квалификации ежегодно обучается 9 млн. рабочих, служащих, колхозников.

Лишь по линии профсоюзов в клубах и красных уголках в настоящее время работают 123 000 кружков художественной самодеятельности, в которых занимается свыше 2 млн. человек, а всего в СССР насчитывается около 350 000 таких кружков и участвует в них более 5 млн. человек.

Все это свидетельствует о колоссальном росте культурного уровня советских людей, об оздоровлении труда и быта, о подъеме материального положения трудящихся и дает положительные результаты в борьбе с алкоголизмом.

В СССР, в противовес капиталистическим странам, резко снизилось число алкогольных заболеваний. Если в дореволюционной России в пределах нынешней территории РСФСР в 1913 г. в психиатрические больницы поступало 19,7% больных, страдающих алкогольными психозами и наркоманиями (по отношению ко всем поступлениям), то в РСФСР в 1939 г. этот процент был равен 13,6, а в 1947 г. — 7,2.

В перво-психиатрические диспансеры Москвы с каждым годом обращается все меньше и меньше первично больных с алкогольными психозами. В 1930 г. на 100 000 населения количество их составило 18, в 1934 г. — 11, в 1938 г. — 8, в 1940 г. — 6 и в 1947 г. — 2 человека.

Однако мы не должны успокаиваться на достигнутом, так как из-за бытовых предрассудков и живучести капиталистических пережитков у нас все еще есть пьяницы, есть лица, став-

шие больными в результате злоупотребления алкоголем. Советская общественность не мирится с тем, что ведомства, занимающиеся вопросами культуры и здравоохранения, недостаточно уделяют внимания разъяснению вреда алкоголизма.

Наша советская общественность не может мириться с пьянством. Как мы уже отмечали, эту борьбу нельзя вести только применением запретительных мер. Главное в борьбе за здоровый быт и уничтожение пьянства — это привлечение внимания общественности к вопросам алкоголизма, проведение широкой разъяснительной работы.

Долг каждого медицинского работника — показать советским людям, какой вред наносит организму злоупотребление алкоголем, разъяснить им огромный вред алкоголизма для всего нашего общества. Лекции и беседы на эти темы должны быть наглядными и убедительными; организуя их, надо широко использовать примеры из местной жизни, различные статистические материалы, плакаты, диапозитивы, кинофильмы.

Наши общественные организации не должны самоустраиваться от борьбы с алкоголизмом и спокойно созерцать, как пьяницы наносят вред своему здоровью, разлагают быт, семью, наносят ущерб обществу, производству. Умелая инициативная борьба с алкоголизмом, и не в порядке кампании, а постоянная и систематическая, является прямым долгом всех общественных организаций, всех работников культуры и здравоохранения.

Общественные организации должны заботиться о наиболее полном обеспечении трудящихся всякого рода культурными мероприятиями, учреждениями о правильном использовании досуга. Наши клубы, читальни, библиотеки, кинотеатры должны строить свою работу таким образом, чтобы привлечь максимальное число трудящихся, включить их в активную общественную работу, развивать и культивировать высокие моральные качества советского человека.

Правильно и с любовью организованный культурный досуг трудящихся, широкий охват трудящихся физкультурой и спортом; вовлечение их в работу кружков художественной самодеятельности, естественно, будут содействовать успешной борьбе с пьянством.

Особенно важно мобилизовать нашу молодежь на борьбу за здоровый быт.

Нельзя мириться с алкоголизмом, так как он задевает интересы общества и семьи, ведет к снижению творческой активности и трудовой дисциплины части наших людей, является причиной многих аморальных поступков, позорящих честь и достоинство советского человека.

В. И. Ленин в беседе с Кларой Цеткин говорил, что пролетариат как восходящий класс не нуждается в опьянении, которое оглушало бы его или возбуждало, что ему нужна яс-

ность, ясность и еще раз ясность. Коммунистическое воспитание трудящихся направлено на искоренение всех пережитков капиталистического прошлого и в том числе такого вредного пережитка, как пьянство.

Одной из важнейших задач органов здравоохранения является надлежащая организация специальных больниц, лечебно-трудовых колоний, диспансеров для лечения тех лиц, которые вследствие длительного злоупотребления спиртными напитками стали больными людьми.

Что касается наркоманий, то в капиталистических странах законы о борьбе с ними направлены не против монополистов—производителей и распространителей наркотиков, а только против мелких распространителей и потребителей их. Делались попытки организовать борьбу с наркоманиями в международном масштабе, для чего в 1909 г. в Шанхае и в 1911 г. в Гааге созывались международные конференции по борьбе с курением опия, не давшие, однако, конкретных результатов.

Совершенно противоположная картина имеет место в СССР, где законодательным путем регулируется производство наркотических веществ и гарантируется их использование исключительно для медицинских и научных целей.

Постановлением ЦИК и Совнаркома СССР от 23 мая 1928 г. в пределах СССР воспрещена свободная продажа кокаина, его солей, морфина, героина, дионина, их солей и пентона. В инструкции Наркомздрава СССР о продаже наркотических веществ указывается, что отпуск наркотиков из аптек производится исключительно по рецептам врачей на специальных бланках.

Кроме того, законодательством предусматривается решительная борьба с нелегальной торговлей наркотиками. Согласно ст. 104 Уголовного кодекса, запрещается производство, хранение и сбыт кокаина, морфина, эфира и других наркотических веществ без надлежащего на то разрешения. Действия, носящие характер промысла, а равно и содержание притонов, где производится сбыт или потребление перечисленных в указанной статье веществ, строго караются законом.

Глава XX

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕРВНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ АЛКОГОЛИЗМОМ И ДРУГИМИ НАРКОМАНИЯМИ

В царской России надлежащей больничной и внебольничной помощи алкоголикам и другим наркоманам почти не существовало. Имелись лишь единичные амбулатории, содержавшиеся на средства благотворительных обществ.

Существовал также противоалкогольный институт с небольшим количеством стационарных коек и амбулаторией в Петербурге.

Этот институт был организован акад. В. М. Бехтеревым.

В период первой мировой войны все эти учреждения были свернуты.

Только в 1923 г. начинает развиваться наркологическая помощь в Москве, а затем и в других городах СССР.

Вначале организовывались специальные наркопункты при тубдиспансерах, где алкоголики лечились амбулаторно, но затем возникли самостоятельные наркодиспансеры.

В 1928 г. в Ленинграде, а после реорганизации нервно-психиатрической помощи в 1932 г. и в Москве после объединения функций наркодиспансеров и районных психиатров амбулаторная помощь алкоголикам оказывается в системе нервно-психиатрических диспансеров специалистами-наркологами, психиатрами или психоневрологами.

С нашей точки зрения нервно-психиатрическая сеть для алкоголиков и наркоманов должна иметь следующие звенья: 1) по внебольничному сектору в системе поликлиник и диспансеров: а) пункты, обслуживаемые врачами-психиатрами и невропатологами, наркологами; б) лечебно-производственные мастерские; 2) по больничному сектору: а) специальные больницы или отделения для лечения алкоголиков и наркоманов в психиатрических или соматических больницах; б) трудовые психоневрологические колонии для длительного лечения; в) такие же колонии для лиц, нуждающихся в принудительном ле-

чении (со специальным надзором); г) наркоприемники как вспомогательные лечебные учреждения.

Параллельно с лечебной деятельностью эти учреждения должны также проводить профилактическую работу.

С нашей точки зрения весьма целесообразна организация научно-исследовательского института, который проводил бы физиологические, терапевтические, клинические, профилактические исследования, в области алкоголизма, а также осуществлял бы научно-методическое руководство противоалкогольными лечебно-профилактическими учреждениями.

Ниже приводятся задачи, которые стоят перед каждым из указанных звеньев нервно-психиатрической сети для алкоголиков и наркоманов.

Наркологическая работа врача в поликлинике или диспансере

Наркологическую работу в диспансерах и поликлиниках проводят врачи-психиатры, психоневрологи или наркологи.

Задачи, стоящие перед врачом, ведущим наркологическую работу, обширны. Они должны включать комплекс мероприятий социального и лечебного характера, направленный на профилактику наркоманий, лечение заболевших и трудоустройство алкоголиков и наркоманов, особенно инвалидизированных. Врач, ведущий наркологическую работу в районе, должен являться консультантом для врачей разных специальностей этого района.

Он ведет амбулаторный прием и лечение алкоголиков, наркоманов и курильщиков, а в случае необходимости направляет их в соответствующие стационары. Нарколог должен широко пользоваться в своей работе консультацией врачей-соматиков для выявления соматических заболеваний у наркоманов, проводя необходимые лабораторные и рентгенологические исследования и т. п. В своей лечебной работе нарколог должен максимально использовать всевозможные активные методы лечения (выработка отрицательной и рвотной условной реакции на алкоголь, психотерапия, физиотерапия, культуротерапия, трудотерапия, фармакотерапия и т. д.). Все алкоголики и наркоманы должны быть взяты на учет по специальной схеме, в которой должно быть подробно отражено как само заболевание, так и социально-бытовые условия больного, и данные динамического наблюдения за ним. Необходимо также выявлять ранние случаи наркоманий, которые часто ускользают из поля зрения врача, ввиду не критического отношения как самих больных, так и их родственников к «невинной привычке» в виде частого потребления алкоголя при любом, даже незначительном поводе, что постепенно принимает систематический характер.

Кроме легких форм алкоголизма, нарколог лечит также более тяжело больных, подающих надежду на излечение в условиях диспансера. Курабильных наркоманов, алкоголиков, не поддающихся лечению в условиях диспансера, а также больных с алкогольными психозами (белая горячка, алкогольная эпилепсия, алкогольный галлюциноз, корсаковский психоз) следует направлять в психоневрологические больницы или соответствующие отделения соматических больниц, или же в специализированные противоалкогольные психиатрические больницы. При остром отравлении алкоголем, когда больные не могут сразу приступить к лечению в диспансере, а также при повторных обострениях хронического алкоголизма больных следует направлять в наркоприемники для кратковременного стационарирования и последующего соответствующего лечения.

После проведенного курса лечения алкоголики должны находиться под наблюдением диспансера в течение ряда лет и являться в диспансер регулярно каждые 1—2 месяца, так как готовность к рецидиву у них сохраняется чрезвычайно долго.

Серьезное внимание должен уделять врач-нарколог оздоровлению социально-бытовых условий больного. Необходимо выявить причины, способствовавшие развитию наркомании, разъяснить их больному и по возможности устранить их, оздоровить бытовые условия больных. Большое значение имеет трудоустройство больных в тех случаях, когда это необходимо.

Врач-нарколог обязан сочетать лечебную работу с профилактической. Он должен установить в своем районе размеры и формы алкоголизма и выяснить формы борьбы с ним. Для проведения профилактической работы нужно использовать советскую общественность, с которой необходимо поддерживать тесную связь, втягивая ее в наркологическую работу. Необходимо также учитывать все моменты, связанные с усиленным потреблением наркотических веществ: правонарушения, заболеваемость наркоманиями и смертность от них, прогулы, несчастные случаи, производственный брак, аварийность. Для борьбы с алкоголизмом следует использовать кино, лекции, беседы, радио, выставки, плакаты, лозунги, консультации, цеховые газеты и газеты-многотиражки. Лекции и доклады следует иллюстрировать диапозитивами или другими наглядными пособиями. Необходимо заботиться о том, чтобы библиотеки школ, клубов, библиотеки-передвижки имели научно-популярную и художественную противоалкогольную литературу.

Жены и родственники наркоманов также должны привлекаться к противонаркотической работе и являться активными помощниками врача-нарколога в деле восстановления здоровья больных путем организации здорового быта, создания нормальных условий в семье. Крайне важна непосредственная связь с предприятиями района через их лечебные организации (поликлиники и др.). Они должны способствовать выявлению

наркоманов и привлечению их к лечению, а также принимать участие в оздоровительной противонаркотической работе.

Серьезное внимание следует уделять антиалкогольному воспитанию молодежи. Для этого нужно поддерживать связь с педагогами своего района, чтобы при посредстве их вести противоалкогольную работу.

Специализированные психоневрологические больницы для алкоголиков и наркоманов

Лечебницы для алкоголиков и наркоманов должны строиться по типу закрытых нервно-психиатрических стационаров.

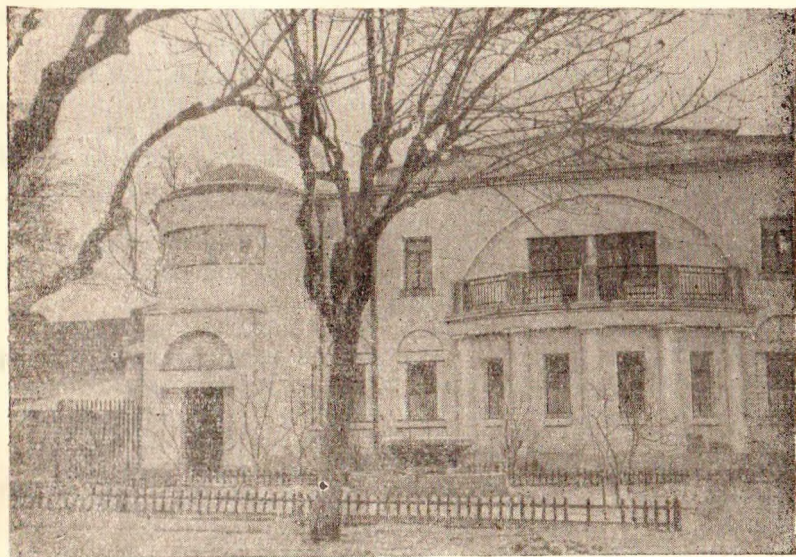


Рис. 37. Больница для лечения алкоголиков.

Весьма важно создать условия, при которых отсутствовала бы малейшая возможность проникновения в лечебницу алкогольных напитков и других наркотических средств (рис. 37).

В такие лечебницы должны направляться алкоголики и наркоманы без тяжелой психической деградации, тяжелой психопатии и психических заболеваний (неалкогольной этиологии), у которых возможно излечение или длительная ремиссия. Лечебницы должны также обслуживать больных с алкогольными психозами (белая горячка, алкогольный галлюциноз, алкогольная эпилепсия, корсаковский психоз и т. д.). Они должны состоять из двух отделений: приемного и санаторного типа.

Все больные поступают в приемное отделение (с режимом,

подобным режиму отделений для острых больных в психиатрических больницах). Через 1—2 недели по миновании острого периода, курабельные больные переводятся в санаторное отделение, где и заканчивают курс лечения в течение 1—2 месяцев. Срок пребывания больных в такого рода лечебницах устанавливается в каждом отдельном случае. Трудно излечимые больные, если это необходимо, направляются в трудовые колонии.

Морфинистов и опиофагов целесообразно на время острого периода помещать в специальные отделения, ибо, как показал опыт Московской нервно-психиатрической больницы (для алкоголиков), подобные больные в период абстиненции весьма беспокойны, нарушают режим приемного отделения и вызывают нарекания со стороны остальных больных.

Лечебницы должны располагать необходимыми подсобными отделениями, как-то: лабораторией — клиническая, биохимическая, электрофизиологическая, патофизиологии высшей нервной деятельности, различные мастерские для трудотерапии, гидротерапевтический и физиотерапевтический кабинеты, аптека и помещение для проведения массовой культработы (лекции, кино, вечера самодеятельности, различные постановки, концерты, занятия кружков и т. п.).

Серьезное внимание нужно уделять вопросу питания. Учитывая нарушение обмена веществ у наркоманов, следует организовать лечебное питание для больных.

Персонал для лечебницы должен подбираться из непьющих, ибо алкоголизм отдельных сотрудников весьма отрицательно влияет на больных. Кроме того, в этих условиях не исключена возможность передачи наркотиков больным. Штатное количество коек лечебницы должно составлять от 100 до 250 в зависимости от потребности обслуживаемого района.

Помимо лечебно-профилактической работы, лечебницы должны проводить также научную работу.

Весьма важно, чтобы больные по выписке из лечебницы поддерживали с ней письменную связь, а еще лучше живую, что крайне полезно для лиц с не вполне устойчивой психической сферой. Для этой цели такие больницы должны иметь закрытые амбулатории. Необходимо организовать из выздоровевших больных общественный актив и проводить хотя бы раз в год с психотерапевтической целью собрания выздоровевших больных, что имеет большое воспитательное и психопрофилактическое значение.

Лечебно-трудовые колонии для алкоголиков и наркоманов

Трудовые колонии предназначаются для таких больных-алкоголиков и наркоманов, у которых имеется тяжелая форма алкоголизма и которые уже нуждаются в длительном лечении.

Трудовые колонии следует развешивать от 150 до 200 коек и больше. Они должны состоять из ряда изолированных отделений на 20—30 человек каждое. Это позволяет целесообразно распределить больных, устранить влияние деградированных субъектов и предупредить конфликты, которые весьма часто возникают среди алкоголиков.

Весьма важно «асоциальных» алкоголиков распределять равномерно между больными с правильной и серьезной установкой на лечение. Это создает благоприятную обстановку для перевоспитания таких больных.

В трудовых колониях должен быть установлен соответствующий режим дня. Значительную роль здесь приобретает трудотерапия, которая приучает больных к систематическому регулярному труду. В трудовой колонии больные приобретают ту или иную квалификацию (столяра, токаря, слесаря, сапожника и т. п.); кроме того, они получают возможность переквалифицироваться в тех случаях, когда это необходимо. Не следует лишь забывать, что трудотерапия не должна вытеснять другие методы лечения и что одновременно с трудотерапией должен быть максимально использован весь арсенал активных методов лечения (физиотерапия, психотерапия, культуротерапия и т. д.).

Необходимо занять весь день больного целесообразной работой, так как по истечении нескольких недель пребывания в колонии при наличии свободного времени и при отсутствии каких-либо занятий больные заполняют время постоянными ненужными разговорами, смакуя свои бывшие пьяные похождения, вредно индуцируют других больных, становятся недисциплинированными, раздражительными, часто проявляют неустойчивость настроения, со склонностью к аффективным вспышкам, которые могут причинить много неприятностей как больным, так и персоналу.

Срок пребывания больного в трудовой колонии устанавливается комиссией компетентных врачей на основании динамического наблюдения за его состоянием в среднем от 3 месяцев до одного года.

В колонии обязательно должно иметься подсобное хозяйство (молочная ферма, совхоз), а также различные мастерские. При правильной постановке дела такая трудовая колония может существовать на хозрасчете.

Колония для трудно излечимых, деградированных алкоголиков

Для принудительного лечения лиц, представляющих социальную опасность и добровольно не желающих подвергнуться лечению, а также для трудно излечимых, деградированных алкоголиков необходимо организовать специальные колонии с

трудовым режимом и с особым надзором. Основной задачей этих колоний является приспособление больных к трудовой деятельности, ибо вне колонии они нередко становятся асоциальными или деградируют и погибают от алкоголизма.

Колонии для таких алкоголиков должны строиться на 200—300 человек. Учитывая длительное, а может быть, и пожизненное пребывание больных в колонии, необходимо создать в ней такие условия, которые не тяготили бы больных и обеспечивали им должный надзор. В колонии должны иметься отдельные помещения, корпуса на 30—50—75 человек каждый. Корпус должен быть разделен на 10—15 палат; в каждой из них следует помещать от 2—3 до 5 человек, учитывая их индивидуальные особенности.

Колония должна иметь производственные мастерские, а также участок земли в 300—500 га и молочную ферму, где в качестве рабочей силы надо использовать больных.

В колониях необходимо также особенно хорошо организовать культработу, чтобы свой досуг больные могли заполнить культурными развлечениями. Политучеба, лекции, радио, кино, кружковая работа, физкультура, спектакли, концерты, вечера самодеятельности должны занимать определенное место в жизни больных.

Необходимо подчеркнуть, что в колониях следует создать такие условия и надзор, которые полностью исключали бы возможность передачи больным спиртных напитков и обеспечивали надлежащий режим.

Для неустойчивых больных следует организовать небольшое отделение, где устанавливается соответствующий режим. Необходимо также создать отделение для соматических больных.

При надлежащей организации колонии, при правильном сочетании трудовых процессов и лечебных мероприятий, при настойчивой работе опытного медицинского персонала в направлении перевоспитания больных не исключена возможность излечения таких больных, которые иногда считаются неизлечимыми.

Отделения для алкоголиков при психиатрических и соматических больницах

В тех случаях, когда исключена возможность организовать специальные учреждения для алкоголиков, мы считаем целесообразным в качестве временного мероприятия прибегнуть к организации отделений или палат для алкоголиков при психиатрических и соматических больницах. Такие отделения и палаты предназначаются для больных с острыми алкогольными психозами и для нуждающихся в купировании приступов

запой и последующем лечении. Руководить отделением должен врач-психиатр. Режим в отделении — закрытый.

Наркоприемники

Наркоприемники должны состоять из отделения для вытрезвления и отделения для кратковременного стационарирования.

Основная задача наркоприемника — вытрезвление лиц, находящихся в состоянии тяжелого алкогольного опьянения, а также лечебная помощь алкоголикам, нуждающимся в кратковременном стационарировании, преимущественно алкоголикам, уже лечившимся ранее в стационарах (рецидивирующие, без явлений резкой деградации — курабильные).

Наркоприемники призваны также обеспечивать своевременную изоляцию в условиях лечебного учреждения лиц, представляющих в состоянии опьянения социальную опасность для общества.

Режим в наркоприемниках должен соответствовать режиму отделений для возбужденных больных в психиатрических лечебницах.

О п е к а

В исключительных случаях целесообразно устанавливать частичную опеку над заработком алкоголика, а также над его движимым имуществом. Необходимо привлекать в качестве опекунов непьющих трудящихся, которые могли бы благотворно влиять на алкоголиков в отношении их перевоспитания и прививать им противоалкогольные навыки.

Опекун должен также заботиться о соответствующем лечении и трудоустройстве опекаемого, так как алкоголики часто теряют связь с производством и остаются без работы. Опекуну поручается получать заработок больного, чтобы целесообразно производить расходы как на содержание самого больного, так и на содержание его семьи.

Такая частичная опека должна применяться и в отношении деградированных алкоголиков, многократно и безуспешно лечившихся, при условии, если будет доказано, что они систематически пропивают свой заработок или пенсию, лишая семью средств к существованию. В случаях, когда алкоголики понуждают своих детей к правонарушению, нищенству или же если устанавливается полная безнадзорность детей алкоголиков (алкоголизм обоих родителей), желательно через суд временно лишать таких лиц прав отцовства. Частичная опека при правильной постановке дела даст положительные результаты.

ЛИТЕРАТУРА

а) Русская

- Алексеев П. Алкоголизм, 1898.
- Азарх М. Е. и Глазов В. А. Углеводный обмен при алкогольных психозах и у хронических алкоголиков, Невропатология и психиатрия, 1930, № 5.
- Анцыферов Л. В. Гашишизм в Средней Азии, Ташкент, 1936.
- Арбузов С. Я. Антагонизм фенамина, коразола и их смеси по отношению к метиловому и этиловому спиртам и этиленгликолю, Физиологический журнал СССР, 1952, XXXVIII, № 3.
- Арбузов С. Я. Современные представления о механизме действия наркотиков и стимуляторов нервной системы, Л., 1955.
- Арбузов С. Я. Антагонизм и синергизм между наркотиками и симпатомиметическими аминами в действии на центральную нервную систему позвоночных животных, Физиологический журнал СССР, М., 1946, XXXII, № 6.
- Архангелова С. Л. К диагностике алкогольного опьянения, Лабораторная практика, 1934, № 9.
- Асатиани Л. М. Об алкогольном слабоумии. Диссертация, Тбилиси, 1947.
- Барсук А. Л. Краткое руководство по психиатрии для участковых врачей, 1945.
- Бергер И. А. Невро-психическая заболеваемость и проблема борьбы с алкоголизмом на заводе «Пролетарский труд». Сборник «Психогигиенические и неврологические исследования», М., 1928.
- Бергер И. А. Организация невро-психиатрической помощи, М., 1942.
- Бехтерев В. М. Гипноз, внушение и психотерапия и их лечебное значение. СПб, 1911.
- Бехтерев В. М. Коллективная гипнотерапия.
- Бирман Б. Н. Экспериментальный сон. Материалы к вопросу о нервном механизме сна нормального и гипнотического, Л., 1925.
- Блейлер Е. Психиатрия. Руководство, Берлин, 1920.
- Богомолова Т. М. Лечение наркоманов подкожным вдуванием кислорода. Московский медицинский журнал, 1935, № 10.
- Бодэ, Лечение пьянства, 1906.
- Бондарев П. Г. Изменение автоматических нервных узлов и мышцы сердца под влиянием алкоголя, Юрьев, 1897.
- Буль П. И. Техника врачебного гипноза, М., 1955.
- Бурхардт. Хроническое отравление морфием, 1882.
- Быков К. М. Кора головного мозга и внутренние органы, М., 1952.
- Введенский И. Н. Обонятельные галлюцинации среди предвестников дипсоманического приступа. Современная психиатрия, М., 1912.
- Введенский И. Н. Когда начинать гипнотическое лечение алкоголиков. Современная психиатрия, 1913 г., М.
- Введенский И. Н. Опыт принудительной трезвости, М., 1915.

- Виш И. М. К вопросу об алкогольных психозах у шизофреников. Труды психиатрической клиники Воронежского медицинского института, 1934, в. 1.
- Владычко С. Д. Влияние табачного дыма на нервную систему и организм вообще, СПб, 1909.
- Влассак К. Р. Алкоголизм, М., 1928.
- Вопросы алкоголизма, под общей редакцией акад. Бехтерева, СПб, в. 1, 1913.
- Ганнушкин П. Б. Клиника психопатии, М., 1933.
- Гейер Т. А. Эволюция учения о корсаковском психозе. Сборник «50 лет психиатрической клиники имени С. С. Корсакова», М., 1949.
- Гиляровский В. А. Психиатрия, М., 1942.
- Гиляровский В. А. Психиатрия (руководство для врачей и студентов), М., 1955.
- Горовой-Шалтан А. О патогенезе морфинной абстиненции. Диссертация, Л., 1943.
- Григорьев Ю. Г. К вопросу о первичных изменениях функционального состояния коры больших полушарий человека при лучевом воздействии. Вестник рентгенологии и радиологии, 1954, № 5.
- Гуревич М. О. Учебник психиатрии, М., 1949.
- Давыдовский И. В. Морфологические и функциональные изменения прочих тканей и органов у хронических алкоголиков, БМЭ, т. 1, 1928.
- Дембо Л. И. Очерк деятельности Комиссии по вопросу об алкоголизме, СПб, 1913.
- Дейчман, Алкоголизм, БСЭ, 1950.
- Детенгоф Ф. Ф. Терапия неврозов и психозов, Ташкент, 1955.
- Довженко П. П. Сдвиги в сердечно-сосудистой системе у алкоголиков под влиянием гравиданотерапии. Бюллетень Института урогравиданотерапии, 1934, № 2.
- Ефремов Д. И. О методике апоморфинного лечения алкоголиков. Труды Ленинградской психиатрической больницы имени Кашенко, Л., 1935.
- Ефремов Н. В. Практическое применение реакции Рапопорта. Проблемы наркологии, 1934.
- Железников Н. П. Трудотерапия при амбулаторном лечении алкоголиков. Сборник проблемы психиатрии и психопатологии, М., 1935.
- Жислин С. Г. Шизоидные и синтонные алкоголики. Вопросы наркологии, 1928.
- Жислин С. Г. Клиника алкогольных расстройств. Труды психиатрической клиники Воронежского медицинского института, в. 1, 1934.
- Жислин С. Г. Об алкогольных расстройствах, Воронеж, 1935.
- Жислин С. Г. Об алкогольной эпилепсии. Проблемы теоретической и практической медицины, сборник VIII — Эпилепсия, М., 1938.
- Жислин С. Г. К структуре и психопатологии алкогольного галлюциноза. Труды Московской психиатрической больницы, 1939.
- Жислин С. Г. Об острых паранондах, М., 1940.
- Жислин С. Г. и Каневская Ф. О. К вопросу о клинике похмелья. Проблемы наркологии, 1934.
- Жудро Е. М. О нарушениях нейродинамики при тяжелых формах хронического алкоголизма. Тезисы докладов конференции молодых научных работников ЦИЭТИН, М., 1956.
- Журавлев И. Н. Влияние стрихнина, кокаина и никотина на условные и безусловные пищевые слюноотделительные рефлексы. Диссертация, 1943.
- Завадский И. В. Кофеин, алкоголь, морфин. Труды Общества русских врачей, СПб, 1908.
- Закусов В. В. Фармакология нервной системы, М., 1953.
- Затуловский М. И. Судебнопсихиатрическая оценка состояния опьянения. Проблемы судебной психиатрии, Сборник V, 1949.

- Збарский Б. И., Иванов И. И., Мордашов С. Р. Биологическая химия, 1956.
- Земель П. Г. К вопросу о механизме запойных приступов. Труды психиатрической клиники Воронежского медицинского института, 1934.
- Зеневич Г. В. Опыт амбулаторного лечения алкоголиков. Врачебная газета, 1930, № 10.
- Иванов-Смоленский А. Г. Основные проблемы патологической физиологии высшей нервной деятельности человека, Медгиз, 1933.
- Иванов-Смоленский А. Г. Учение о высшей нервной деятельности за последние тридцать пять лет. Журнал высшей нервной деятельности имени И. П. Павлова, 1952, т. II, в. 5.
- Иванов-Смоленский А. Г. Экспериментальные и клинические исследования в области охранительного торможения и длительного лечебного сна. Журнал высшей нервной деятельности имени И. П. Павлова, 1951, т. I, в. 3.
- Иванов-Смоленский А. Г. Исследование совместной работы и взаимодействия первой и второй сигнальных систем применительно к задачам медицины. Журнал высшей нервной деятельности имени И. П. Павлова, 1953, т. III, в. 4.
- Иванов-Смоленский А. Г. Основные формы условно- и безусловно-рефлекторной деятельности человека и анатомический их субстрат. Журнал невропатологии и психиатрии имени С. С. Корсакова, 1928, № 3.
- Иванов-Смоленский А. Г. Очерки патофизиологии высшей нервной деятельности (по данным И. П. Павлова и его школы), изд. 2-е, М., 1952.
- Иванов-Смоленский А. Г. Опыт механизации гипнотического воздействия. Врачебное дело, 1928, № 3.
- Иванов-Смоленский А. Г. Опыт экспериментального словесного воздействия на вегетативную нервную деятельность человека. Бюллетень Всесоюзного института экспериментальной медицины, 1935, № 1.
- Исторический очерк борьбы с пьянством на основе исследований П. Алексеева «О пьянстве» и других авторов, СПб, 1909.
- Канель В. Я. Алкоголизм и борьба с ним, М., 1914.
- Каппабих Ю. В. Место гипноза в системе психотерапии. Современная невропатология и психиатрия, 1934.
- Каппабих Ю. В. Гипнотизм, БМЭ, т. 7, 1929.
- Канторович Н. В. Опыт сочетательно-рефлекторной терапии алкоголизма. Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы, сборник III, 1929.
- Канторович Н. В. и Осовский И. А., Классификация алкоголизма, Советская врачебная газета, 1933, № 22.
- Каптерев П. В. Гипнотизм, М., 1909.
- Картамышев А. М. Гипноз и внушение в терапии кожных болезней, М., 1953.
- Кербиов О. В. Острая шизофрения, М., 1949.
- Корсаков С. С. Об алкогольном параличе, М., 1887.
- Корсаков С. С. Курс психиатрии, М., 1913.
- Красногорский Н. И. Развитие учения о физиологической деятельности мозга у детей (алкоголь, бром, никотин, хлоралгидрат), 1935.
- Краснушкин Е. К. Неврозы и психоневрозы. В кн.: Учебник нервных болезней, под ред. М. Б. Кроля, М. С. Маргулиса и Н. И. Пропера, М., 1937.
- Краснушкин Е. К. Проблема динамики изменчивости психопатий. Сборник «50 лет психиатрической клиники имени С. С. Корсакова», М., 1940.
- Крылов В. А. Условный рефлекс на морфин. Физиологический журнал СССР, 1936, XXI, № 5—6, 825.

- Крылов В. А. Условный рефлекс на апоморфин. Фармакология и токсикология, 1939, 2, № 1—3, т. 33.
- Кузнецова Р. М. и Егорова Н. И. Опыт лечения апоморфином хронических алкоголиков. Труды Ташкентской психиатрической больницы, Ташкент, 1935.
- Курашкевич Г. А. и Смирнов В. Результаты оксигенотерапии у алкоголиков и влияние ее на вегетативные рефлексы. Советская психоневрология, Харьков, 1934.
- Кутанин М. П. Хронический кокаинизм, 1915.
- Ластовецкий В. В. Гашизм (к вопросу об острых интоксикационных психозах). Труды Ташкентского медицинского института, т. I, в. 1.
- Линдберг А. А. Доклады Академии наук СССР. Алкоголь, 1935.
- Липманович А. С. и Субботник С. И. Алкоголизм в этиологии артериосклероза. Клиническая медицина, 1935, № 6.
- Лысенко Т. Д. Агробиология, М., 1948.
- Майсюк А. П. К вопросу о психологическом и органопатологическом профиле алкоголика. Архив патологии, 1948, № 1.
- Малкин П. Ф. и Яновская А. Е. Лечение инсулиновой гипогликемией некоторых атипичных и затянувшихся алкогольных психозов. Труды Свердловского государственного медицинского института, сборник I, 1941.
- Маслов Е. В. и Стрелюхин А. К. Шизофреноподобные картины при остром и хроническом отравлении гашишем. Невропатология и психиатрия, 1937, т. VI, № 4.
- Мендельсон А. Л. Лечение алкоголизма в амбулаториях СПб, Попечительства о народной трезвости. Труды I Всероссийского съезда по борьбе с пьянством, 1910.
- Минор Л. С. Краткая терапия нервных болезней, М., 1910.
- Морковников А. Лечение алкоголизма комбинацией внушения с выработкой условного рефлекса рвоты от глотка спиртных напитков. Советская врачебная газета, 1934, № 10.
- Москвичев О. Быт и нравы за рубежом. «Кинобальзам», Вечерняя Москва, 2/IV 1941.
- Мясников А. Л. Болезни печени, 1949.
- Несмелов Ф. Я. Алкогольный тупик, Харьков, 1931.
- Никифоровский П. М. Фармакология условных рефлексов как метод их изучения. Диссертация, СПб, 1910.
- Николаев А. Р. Теория и практика гипноза в физиологическом освещении.
- Новикова А. А. (Фадеева), Никотин. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, 1940, № 1, 34.
- Овчаренко П. П. и Неймер Л. С. Апоморфин в практике наркоприемников-вырешителей и действие его при остром опьянении. Советская врачебная газета, 1932, № 21, 22.
- Окмянский К. О. Патологоанатомические изменения нервных узлов сердца при остром отравлении алкоголем у животных. Диссертация, 1901.
- Осипов В. П. Частное учение о душевных болезнях, 1926.
- Павлов И. П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных, 1938.
- Павлов И. П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга. Полное собрание трудов, т. IV, Изд. Академии наук СССР, 1937.
- Павловские среды. 1949, т. III.
- Певницкий А. А. К вопросу об амбулаторном лечении алкоголиков. Оттиск из журнала «Русское общество народного здоровья», 1904.
- Певницкий А. А. Лечение алкоголиков по данным двухлетнего опыта в амбулатории клиники акад. Бехтерева. Оттиск из журнала «Обозрение психиатрии», 1905.

- Петрова М. К. Влияние хронического применения алкоголя на высшую нервную деятельность собак, различных по силе нервной системы. Труды физиологической лаборатории имени И. П. Павлова, т. XII, 1945.
- Платонов К. И. Слово как физиологический и лечебный фактор (к физиологии психотерапии), 1930.
- Поворинский Ю. А. Условная реакция на инсулин. Труды Центрального психоневрологического института, II, 1938.
- Поворинский Ю. А. Психотерапия табакокурения. Тезисы научно-практической конференции по вопросам психотерапии, М., 1956.
- Попов Е. А. и Наумова В. В. О патогенезе и лечении белой горячки. Советская психоневрология, 1935, № 4, 5.
- Равкин И. Г. К патогенезу корсаковского синдрома. Сборник «50 лет психиатрической клиники имени С. С. Корсакова», М., 1940.
- Равкин И. Г. Амбулаторное лечение больных с невро-психическими заболеваниями, Медгиз, 1956.
- Рапопорт А. М. Кокаинизм и преступность. Московский медицинский журнал, 1926, № 1.
- Рапопорт А. М. Табак и его влияние на организм, 1929.
- Рапопорт А. М. К диагностике алкогольных заболеваний. Советская невропатология, М., 1934.
- Рапопорт А. М. Опиум как социальная проблема, БМЭ, 1932.
- Рапопорт А. М. Наркомания, БМЭ, 1932.
- Рапопорт А. М. Табакокурение, БМЭ, 1932.
- Рапопорт А. М. Диагностика алкогольного опьянения, 1934.
- Рапопорт А. М. Об основных задачах советской наркологии. Проблемы наркологии, 1934.
- Рапопорт А. М. К методике и практике алкогольной терапии. Проблемы наркологии, 1934.
- Рапопорт А. М. и Лахман З. М. О никотиновой абстиненции у человека в связи с терапией табакокурения. Проблемы наркологии, М., 1934.
- Родионов С. М. Психологические особенности хронического алкоголизма и его течение. Проблемы наркологии, 1934, М.
- Рожнов В. Е. Гипноз в медицине. М., 1954.
- Розенштейн Л. М. Об алкогольном опьянении и привыкании. Оттиск из журнала «Невропатология и психиатрия», 1916, М.
- Рыбаков Ф. Е. О лечении пьянства гипнотизмом. Врачебная газета, 1898, т. XIX.
- Рыбаков Ф. Е. Принципы современного лечения алкоголиков, 1905.
- Рыбаков Ф. Е. Душевные болезни, М., 1917.
- Самойлова З. Г. Влияние фармакологических и токсикологических веществ на условнорефлекторную деятельность. Журнал высшей нервной деятельности имени И. П. Павлова, 1952, т. II, в. 2.
- Светлов В. С. Внимание, психическая работоспособность и ассоциации у страдающих хроническим алкоголизмом. Диссертация, 1916.
- Сербский В. Руководство к изучению психических болезней, М., 1906.
- Середина М. И. О нарушении совместной деятельности первой и второй сигнальных систем при хроническом алкогольном галлюцинозе. Журнал высшей нервной деятельности имени И. П. Павлова, 1953, т. III, в. 6.
- Середина М. И. Экспериментально-клинические исследования совместной деятельности первой и второй сигнальных систем при алкогольном делирии. Журнал высшей нервной деятельности имени И. П. Павлова, 1953, т. III, в. 1.
- Серейский М. Я. Конституция наркоманов. Труды психиатрической клиники I МГУ, М., 1926.
- Серейский М. Я. Корсаковский психоз в свете современной клиники. Сборник «50 лет психиатрической клиники имени С. С. Корсакова», 1940.

- Серейский М. Я. Стимуляторы нервной системы, М., 1943.
- Серейский М. Я. Терапия психических заболеваний, М., 1949.
- Синкевич З. Л. О некоторых нарушениях взаимодействия первой и второй сигнальных систем при хроническом алкоголизме. Журнал высшей нервной деятельности имени И. П. Павлова, 1951, т. I, в. 4.
- Синкевич З. Л. О некоторых нарушениях совместной деятельности первой и второй сигнальных систем при хроническом алкоголизме. Труды Института высшей нервной деятельности, серия патофизиологическая, т. I, 1955.
- Скворцов В. Г. Гашиш, БМЭ, 1929.
- Скворцов В. Г. Курс фармакологии, М., 1943.
- Соколов В. Пьянство, его лечение простыми народными средствами, М., 1909.
- Случевский И. Ф. и Случевская Л. Б. О влиянии конституциональных факторов на апоморфинное лечение алкоголизма. Труды Ленинградской психиатрической больницы имени Кащенко, Л., 1935.
- Случевский И. Ф. и Фрикен А. А. Об апоморфинном лечении хронического алкоголизма. Советская врачебная газета, 1933, № 12.
- Стрельчук И. В. К вопросу о явлении морфинной абстиненции. Проблемы наркологии, 1934, М.
- Стрельчук И. В. Алкоголизм — вреднейший пережиток прошлого. Госполитиздат, 1954.
- Стрельчук И. В. Алкоголизм и борьба с ним. Изд. «Знание», 1954.
- Стрельчук И. В. О нарушениях нейродинамики у хронических алкоголиков. Рефераты научно-исследовательских работ Академии медицинских наук, Медико-биологические науки, 1949, № 7.
- Стрельчук И. В. К вопросу об обмене веществ у алкоголиков. Проблемы наркологии, 1934, М.
- Стрельчук И. В. Организация внебольничной помощи алкоголикам. В кн.: Методика психоневрологической работы в районе, 1934.
- Стрельчук И. В. и Обнорский П. П. Гравиданотерапия в борьбе с наркоманией. Бюллетень Института урогравиданотерапии, 1934, № 1.
- Стрельчук И. В. и Афанасьева Е. В. Некоторые биохимические замечания по поводу белой горячки и хронического алкоголизма. Проблемы наркологии, 1934, М.
- Стрельчук И. В. и Прядько Н. Ф. К вопросу о желудочной секреции у алкоголиков. Проблемы наркологии, 1934, М.
- Стрельчук И. В. К методике и практике трудотерапии в лечебных учреждениях для алкоголиков. Проблемы психиатрии и психопатологии, 1935, М.
- Стрельчук И. В., Обнорский П. П., Дудко Н. Е. и др. Гравидан и проблема борьбы с преждевременным одряхлением при алкогольной и морфинной интоксикации. Бюллетень Института урогравиданотерапии, 1935, № 2.
- Стрельчук И. В. Алкогольная эпилепсия. Проблемы эпилепсии, 1937, М.
- Стрельчук И. В. Активные методы лечения алкоголиков. Вопросы социальной и клинической психоневрологии, 1936, № 2.
- Стрельчук И. В. К вопросу об окислении алкоголя при алкогольных заболеваниях. Советская психоневрология, 1939, № 3.
- Стрельчук И. В. Хронические алкогольные галлюцинозы, М., 1947.
- Стрельчук И. В. О применении лечебного сна в клинике. Военно-медицинский журнал, 1954, № 2.
- Стрельчук И. В. Охранительное торможение и лечебный сон в психиатрии и невропатологии. Журнал высшей нервной деятельности имени И. П. Павлова, 1952, т. II, в. 4.
- Стрельчук И. В. Опыт применения длительного лечебного сна и влияние его на высшую нервную деятельность при морфинизме.

- Журнал высшей нервной деятельности имени И. П. Павлова, 1951, т. 1, в. 3.
- Стрельчук И. В. Терапевтические условные связи при хроническом алкоголизме. Журнал высшей нервной деятельности имени И. П. Павлова, 1951, № 1, в. II.
- Стрельчук И. В. Опыт дифференцированного гипнотерапевтического воздействия в свете учения И. П. Павлова. Журнал высшей нервной деятельности, 1953, т. III, в. 3.
- Стрельчук И. В. Лечение алкоголиков антабусом. Журнал невропатологии и психиатрии, 1951.
- Стрельчук И. В. Дальнейшие наблюдения за лечением хронического алкоголизма антабусом (тетраэтилтиурамдисульфидом). Журнал невропатологии и психиатрии имени С. С. Корсакова, 1952.
- Стрелюхин А. К. Общая симптоматология острого гашишного отравления. Труды Туркменского государственного научно-исследовательского института неврологии и психиатрии, Ашхабад, т. I, 1936.
- Стрелюхин А. К. К вопросу о психозах на почве хронического гашишизма. Труды Туркменского медицинского института, т. I, в. I, 1937.
- Стрелюхин А. К. и Маслов Е. Шизофреноподобные картины при остром и хроническом отравлении гашишем. Невропатология и психиатрия, 1937, т. VI, в. 4.
- Строкина Т. В. Тезисы доклада 9-го совещания по физиологическим проблемам, посвященного памяти акад. И. П. Павлова, 1941.
- Строкина Т. В. Условные и безусловные реакции при инсулиношочковой терапии. Диссертация, М., 1953.
- Суханов С. А. Об отношении хронического алкоголизма к запойному пьянству. Отдельный оттиск из «Медицинского обозрения», 1906, № 23—24.
- Тареев Е. М. Внутренние болезни, М., 1951.
- Труды Комиссии по вопросу об алкоголизме, в. I—IX, 1899—1908.
- Судебная психиатрия. Юриздат, 1949.
- Тувим Р. И. О лечении брюшнотифозных больных атропином и о применении атропина при наркотизации алкоголиков. Врачебная газета, 1930, № 15, стр. 1131.
- Фаддеева В. К. Фенамин. Журнал высшей нервной деятельности имени И. П. Павлова, 1951, т. I, № 6.
- Фаддеева В. К. Экспериментальное исследование влияния фенамина на работу высших отделов центральной нервной системы. Диссертация, М., 1953.
- Футер Д. С. Децеребрационная ригидность у человека, Медгиз, 1946.
- Эпштейн А. Я. Агриппинический синдром у алкоголиков. Сборник трудов № 1 Ленинградской психиатрической больницы, 1934.
- Удинцева Н. В. К клинике и терапии хронического алкоголизма методом выработки условного рефлекса. Автореферат канд. диссертации, 1954.
- Эрленмейер и Соль Е. П. Морфинизм и его лечение. 1899.
- Юников Ф. И. Лечение отравлений морфием и опиум растворами марганцовокислого калия. Врачебное дело, 1927, № 9.

б) Переводная

- Иозль. Лечение наркоманий (перевод). М., 1930.
- Левенфельд. Гипноз и его техника (с предисловием проф. Платонова), 1928.
- Маньян В. Алкоголизм. Различные формы алкоголического бреда и их лечение, 1877.
- Моль. Гипнотизм, 1909, СПб.
- Ослер Вильям. Руководство по внутренней медицине, Л., 1928.
- Форель А. Гипнотизм или внушение и психотерапия, Л., 1928.

а) Иностранная литература

- Alcoholism a public health problem. Chronicle of the World Health Organization, 1951, v. 5, No. 9, p. 231—235.
- Allen B. E. a. Prout C. T., Alcoholism. В кн.: Progress in neurology and psychiatry. New York, 1950, v. 5, p. 513—524.
- Bacher K. B., Vitamin B₁₂ zur Behandlung des Alcohol delirs. Münch. med. Wschr., 1954, N. 51, S. 1901—1903.
- Barl C. u. Ornstein L., Betrachtungen über einige humorale Störungen beim chronischen Alkoholismus. Bull. Soc. roum. Neur. etc., 1934, Bd. 15, S. 148—152. Ref.: Zbl. ges. Neurol u. Psychiat., 1935, Bd. 77, S. 694—694.
- Beerstecher F., Maximum consumption of ethyl alcohol. Science, 1950, v. 112, N. 2907, p. 312—313.
- Binswanger H., Zur funktionellen Pathologie der Leber beim Delirium-tremens Alcoholicum. Klin. Wschr., 1932, Bd. 11, August 6, S. 1339—1341.
- Bleyer B., Diemair W. u. Fischer, «Hella» ein alkoholfreies Kalorienreiches Erfrischungsgetränk mit Biercharacter. Münch. med. Wschr., 1932, S. 1634—1636.
- Bonhoeffer K., Die alkoholischen Geistesstörungen, 1906.
- Bowman K. M., Alcoholism. Am. J. Psychiat., 1954, v. 110, N. 7, p. 519—521.
- Bowman K. M., Review of psychiatric progress. Alcohol. Geriatrics, 1951, Am. J. Psychiat., 1952, v. 108, N. 7, p. 529—552 (Bibl. 13 refs.).
- Bratz E., Behandlung des Alkoholismus. Allg. Ztschr. f. Psychiat., 1933, Bd. 99, S. 202—218.
- Council on pharmacy and chemistry. Antabus (disulfiram) in treatment of alcoholism, J. A. M. A., 1952, Bd. 149, 3, p. 275—277.
- Christensen J. A., Mechanism of action of tetraethylthiuram disulfide in alcoholism; iron as antidote for TETD — alcohol-reaction. Quart. J. Studies on Alcohol, 1951, N. 12, p. 30—39.
- Dalgren K. G., On death-rates and causes of death in alcohol addicts. Acta psychiat. et neurol. Scanav., 1951, v. 26, p. 297—311.
- Debrousse J. Y., L'examen systématique du fond d'oeil dans le traitement de l'alcoolisme par le disulfure de tetra-ethyl-thiourame. Semaine d. hôp. de Paris, 1950, N. 79, Octobre 26, p. 4132—4133.
- Deniver P. et Jean P., Le contrôle de l'alcoolisme. Hyg. ment., 1952, N. 1, p. 1—28.
- Detoxication of drunkenness. Brit. med. J., 1954, N. 4885, p. 464.
- Dijon H., Alcoolisme et accidents de la circulation. Semaine méd., 1953, N. 28, p. 439—440.
- Dijon H., Les ravages de l'alcoolisme. Semaine méd., 1956, N. 28, p. 440—440.
- Drug addiction in America. Lancet, 1951, No. 6669, June 23, p. 1356—1357.
- Cibbins R. J., Alcoholism in Ontario; Survey of an Ontario country. Quart. J. Studies on Alcohol, 1954, 15, p. 47—62.
- Hoff H., Der akute und chronische Alkoholismus. Med. Klin., 1954, N. 36, S. 1425—1429; N. 37, S. 1461—1466.
- Jacobsen E., Die Behandlung von Alkoholismus mit Antabus; Prinzip und vorläufige Resultate. Dtsch. Wschr., 1950, Mai 12, S. 646—648.
- Kiemperer E., Die Behandlung der Delirium-tremens mit Insulin. Psychiat. neurol. Wschr., 1932, März 5, S. 117; März, 12, S. 134.
- Koch R., Alkohol und Verkehrsgefährdung. D. Gesundheitsw., 1953, No. 23, S. 682—687.
- Kraepelin E. u. Lange, Der Alkoholismus. В кн.: Psychiatrie, 9. Aufl., Leipzig, 1927, Bd. 2, S. 346—588.
- Lamache A., Davost, Choberre et Delalande, La sénilité précoce des alcooliques. Bull. Acad. nation. de méd., 1952, v. 136, No. 1—2, p. 31.

- Lecoq Raoul Le rôle de l'alcool, glucosé hépatisé (Curéthyl) dans le traitement de l'alcoolisme chronique. *Schweiz. med. Wschr.*, 1949, N. 48, S. 1152—1154.
- Lecoq R., Considerations sur le rôle par la derveva pyruviques dans les syndromes à l'alcoolisme chronique. *Presse méd.*, 1954.
- Lemere F. a. O'Hollaren P., Thiopental U. S. P. (Pentothal) treatment of alcoholism. *Arch. Neurol. a. Psychiat.*, 1950, v. 63, No. 4, p. 579—585.
- McCarthy R. G., Public health approach to control of alcoholism. *Am. J. Publ. Health.*, 1950, No. 40, November, p. 1412—1417.
- Magnan V., *De l'alcoolisme*, Paris, 1874.
- Magnus Hus., *Chronische Alkoholkrankheit oder Alcoholismus chronicus*, 1852.
- Marchand L. et Courtois A., La psychose aigue de Korsakoff des alcooliques. *Rev. neurol.*, 1934, N. 41, pt. 2, p. 425—453.
- Martensen-Larsen O., Treatment of alcoholism with a sensitising drug. *Lancet*, 1948, December 25, N. 6539, p. 1004—1005.
- Meggendorfer F., Intoxikations psychosen. B KH.: Bumke O. *Handbuch der Geisteskrankheiten*. Bd. 7, S. 151—400.
- Morel F. et Schifferli P., Le traitement de l'alcoolisme par la méthode dite de Bruel et Lecoq. *Schweiz. med. Wschr.*, 1949, N. 8, S. 161—162.
- Newman H. W., Alcohol injected intravenously; some psychological and psychopathological effects in man. *Am. J. Psychiat.*, 1935, v. 35, N. 91, May, p. 1343—1352.
- Pohlisch R., Die Klinik des Alkoholismus. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, 1933, Bd. 99, S. 193—202.
- Pullar-Strecker H., Facts and figures on alcoholism. *Lancet*, 1952, March 15, N. 6707, p. 555—557.
- Pluvinage M. R., Les atrophies cérébrales des alcooliques. *Presse méd.*, 1954, N. 39, p. 858.
- Seelert H., Zur Frage der Entwicklungsbedingungen des pathologischen Rauschen. *Mnschr. Psychiat.*, 1933, Bd. 86, S. 191—196.
- Smith J. J., The endocrine basis and hormonal therapy of alcoholism. *New York State J. Med.*, 1950, v. 50, N. 7, p. 1704—1706.
- Solms H., Gefahren bei der Behandlung der chronischen Trunksucht mit Antabus-Medik. *Wien. med. Wschr.*, 1950, N. 33/34, S. 589—592.
- Solms H., Synopsis der Zwischenfälle und ihre Verhütung bei der Antabusbehandlung des chronischen Alkoholismus. *Schweiz. med. Wschr.*, 1951, N. 15, April 14, S. 343—348 (Lit. 45).
- Steck H., Die Behandlung des Delirium-tremens. *Schweiz. med. Wschr.*, 1936, N. 66, S. 68—70.
- Thuillier J., Le problème thérapeutique actuel de l'alcoolisme chronique. *Semaine d. hôp.*, 1953, N. 15, p. 767—771. Traitement du delirium tremens par la chlorpromazine. *Presse méd.*, 1954, N. 59, Septembre 14, p. 1212.
- Triboulet H. et Mignot, L'alcoolisme. B KH.: Roger G. H. et aut *Nouveau traité de médecine*, 1925, fasc. 6, Intoxications, p. 257—357.
- Williams R. J., Berry L. J. a. Beerstecher E., Genetotropic diseases: alcoholism. *Texas Rep. on biol. a. med.*, 1950, v. 8, N. 2, p. 238—256.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие к третьему изданию	3
Предисловие ко второму изданию	4
Предисловие к первому изданию	4
Глава I. Острое отравление алкоголем	7
Патологическое опьянение	22
Отравление метиловым спиртом	30
Глава II. Хронический алкоголизм	33
О нарушениях высшей нервной деятельности при хроническом алкоголизме	65
Течение хронического алкоголизма	73
Прогноз и катамнез	80
Патологическая анатомия	89
Причины и распространение алкоголизма	92
Глава III. Лечение хронического алкоголизма	100
Исторический обзор	100
Современные методы лечения хронического алкоголизма	104
Фармакотерапия	110
Инсулинотерапия	116
Лечение гормональными препаратами	117
Лечебный сон	118
Гравиданотерапия	127
Лечение путем выработки условной эмоционально-отрицательной и рвотной реакции на алкоголь при помощи апоморфина, эметина и других рвотных средств	128
Лечение больных хроническим алкоголизмом сенситизирующими к алкоголю веществами	140
Оксигенотерапия	153
Психотерапия	154
Гипнотерапия больных хроническим алкоголизмом	166
Выработка отрицательной тошнотной и рвотной реакции на алкоголь в гипнотическом сне при помощи речевого подкрепления	169
Физиотерапия	174
Гидротерапия	175
Физкультура	175
Культуротерапия	176
Трудотерапия	178
Лечебное питание	181
Глава IV. Запой (дипсомания)	186
Глава V. Алкогольная эпилепсия	190
Глава VI. Белая горячка	196

Глава VII. Острый алкогольный галлюциноз	218
Глава VIII. Хронический алкогольный галлюциноз	226
Глава IX. Алкогольный бред (Алкогольный параноид)	236
Глава X. Корсаковский психоз	242
Глава XI. Алкогольный псевдопаралич	254
Глава XII. Острое отравление морфином	258
Хроническое отравление морфином (морфинизм)	260
Глава XIII. Острое отравление опиум	284
Хроническое отравление опиум	285
Глава XIV. Острое отравление кокаином	288
Хроническое отравление кокаином (кокаинизм)	289
Глава XV. Острое отравление гашишем	295
Хроническое отравление гашишем	296
Глава XVI. ЭФИРОМАНИЯ	298
Глава XVII. Острое отравление препаратами барбитуровой кислоты (веронал, люминал, амитал-натрий, мединал, ноктал, эвипан, фонодорм и др.)	300
Хроническое отравление препаратами барбитуровой кислоты	303
Хроническое отравление фенамином, первитином	304
Кофеинизм (теизм)	305
Глава XVIII. Острое отравление табаком	307
Хроническое отравление табаком	308
Глава XIX. Борьба с наркоманиями	314
Глава XX. Организация нервно-психиатрической помощи больным алкоголизмом и другими наркоманиями	328
Литература	336

ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
10	19 сверху	1870 г.	1780 г.
141	2 сверху	диэтилтиурамид-сульфидом	диэтилтиурамди-сульфидом
157	1 сверху	психопатологи-ческий	психологический
157	19 снизу	(И. А. Бергер)	(Бергер)
185	11 снизу	кумыс	простоквашу

Иван Васильевич Стрельчук

КЛИНИКА И ЛЕЧЕНИЕ НАРКОМАНИИ

Редактор *А. Н. Зимин*

Техн. редактор *Ю. С. Бельчикова*

Корректор *О. В. Соколова*

Переплет художника *С. Н. Новского*

Сдано в набор 21/VI—1956 г.

Подписано к печати 22/XI—1956 г.

формат бумаги $60 \times 92/16 = 10,88$ бум. л.

21,75 уч.-изд. л. Тираж. 10 000 экз.

Т 10641

МБ 57

Медгиз, Москва, Петровка, 12
Заказ 639 3-я тип. Медгиза,

Москва, Солянка, 14

Цена 10 р. 85 к.

Переплет 1 р.